Husebø
Klaschik

Palliativmedizin

Grundlagen und Praxis

4. Auflage

- Schmerztherapie
- Gesprächsführung
- Ethik

Springer

S. Husebø

E. Klaschik

Palliativmedizin

4., aktualisierte Auflage

S. Husebø
E. Klaschik

Palliativmedizin

4., aktualisierte Auflage

Mit 27 Abbildungen
und 43 Tabellen

Mit Beiträgen von
K. E. Clemens
B. Sandgathe-Husebø
B. Zernikow, S. Friedrichsdorf, W. Henkel

Bearbeitet von B. Jaspers

Springer

Dr. med. Stein Husbø
Krokeideveien 453
5047 Fana
Norwegen

Prof. Dr. med. E. Klaschik
Malteser Krankenhaus
Abteilung für Anästhesiologie
Intensivmedizin und Schmerztherapie
Von-Hompesch-Straße 1
53123 Bonn

ISBN-10 3-540-29888-6 Springer Medizin Verlag Heidelberg
ISBN-13 978-3-540-29888-5 Springer Medizin Verlag Heidelberg

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.

Springer Medizin Verlag
springer.com
© Springer Medizin Verlag Heidelberg 2006
Printed in Germany

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutzgesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Produkthaftung: Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen kann vom Verlag keine Gewähr übernommen werden. Derartige Angaben müssen vom jeweiligen Anwender im Einzelfall anhand anderer Literaturstellen auf ihre Richtigkeit überprüft werden.

Planung: Dr. Sabine Höschele
Projektmanagement: Lindrun Weber
Einbandgestaltung: deblik Berlin
SPIN 1135 7513
Satz: TypoStudio Tobias Schaedla, Heidelberg
Druck: Stürtz GmbH, Würzburg
Gedruckt auf säurefreiem Papier 2111 – 5 4 3 2 1 0

Vorwort zur 4. Auflage

Im Jahr 1997 erschien die erste Auflage dieses Buches und seitdem war eine Überarbeitung alle drei Jahre notwendig, weil die Entwicklung der Palliativmedizin in Deutschland und in den anderen europäischen Ländern mit unverminderter Dynamik anhält. Der Anstieg der Anzahl von Palliativstationen und Hospizen ist dabei nur der von außen sichtbare Fortschritt; darüber hinaus gab und gibt es politische Aktivitäten, die Palliativmedizin zu stärken, so zum Beispiel die Empfehlungen der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages für Ethik und Recht der modernen Medizin in ihrem Zwischenbericht Palliativmedizin und Hospizarbeit, die Rahmenprogramme zur Weiterentwicklung der Palliativmedizin in einzelnen Bundesländern oder die Aufnahme des Ziels, Palliativmedizin und Hospizarbeit zu fördern, in den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung. Die Deutsche Krebshilfe hat im Jahre 2006 ein neues Förderprogramm für den universitären und außeruniversitären Bereich ausgeschrieben. Die Kostenträger machen erste zaghafte Versuche, die Palliativmedizin im Rahmen der integrierten Versorgung in das Gesundheitssystem einzubinden. Die akademische Anerkennung wächst durch die Einrichtung von Professuren für Palliativmedizin; nach Bonn wurden diese auch in Aachen, Köln und München besetzt, Göttingen und Jena werden bald folgen. In einigen Universitäten ist Palliativmedizin zum Pflichtlehr- und -prüfungsfach geworden.

Die im Jahre 2003 von der Bundesärztekammer verabschiedete Musterweiterbildungsordnung ist inzwischen in fast allen Bundesländern umgesetzt worden. Seitdem kann die Zusatzweiterbildung für Palliativmedizin erworben werden. Diese erfolgreiche Entwicklung darf nicht darüber hinweg täuschen, dass wir sowohl von einer flächendeckenden ambulanten und stationären Palliativversorgung als auch von ausreichenden, qualifizierten Aus-, Fort- und Weiterbildung noch weit entfernt sind. Dies zu erarbeiten und die geforderte Qualität zu erfüllen, sind die Herausforderungen für die Zukunft.

Die Überarbeitung für diese Auflage wäre nicht möglich gewesen ohne die immense Hilfe unserer wissenschaftlichen Mitarbeiterin Frau Birgit Jaspers, die nicht nur die umfangreiche Korrekturarbeit bewältigt, sondern auch wesentlich an der Aktualisierung dieses Buches mitgewirkt hat. Dafür

möchten wir uns bei ihr ganz besonders herzlich bedanken. Ein weiterer Dank geht an Frau Dr. K.E. Clemens für ihre Hilfe bei der Bearbeitung der Neuauflage.

Wir hoffen, dass wir mit dieser vierten Auflage der gegenwärtigen Entwicklung der Palliativmedizin gerecht werden und freuen uns über das bisherige Interesse an diesem Buch.

Stein Husebø, Eberhard Klaschik
im Frühjahr 2006

Vorwort zur 3. Auflage

Die Palliativmedizin hat im deutschsprachigen Raum in den letzten fünf Jahren erfreuliche Fortschritte gemacht. Dies betrifft sowohl die praktische Umsetzung der verschiedenen Organisationsformen im ambulanten wie stationären Bereich als auch die Anzahl der Publikationen aus der Themenvielfalt der Palliativmedizin, die Fortbildungsaktivitäten und die Akzeptanz aus berufspolitischer und allgemeinpolitischer Sicht. Problematisch bleibt die Finanzierung durch die Kostenträger. Kaum bahnen sich erste Fortschritte an, droht durch die Einführung des neuen Vergütungssystems alles wieder in Frage gestellt zu werden.

Es besteht kein Zweifel daran, dass wir in den letzten Jahren unser Augenmerk (zu) stark auf den nicht heilbaren Tumorpatienten und die Industrieländer gerichtet haben. Folgerichtig war deswegen die Aufnahme des Themas »Palliativmedizin in der Geriatrie« in der 2. Auflage dieses Buches.

Mit der 3. Auflage erweitern wir unseren Blick für die palliativmedizinische Versorgung, indem wir zwei weitere Problembereiche integrieren. Frau Clemens bringt ihre jahrelangen Erfahrungen aus Projekten im südlichen Afrika ein und unterstreicht die vorrangige Bedeutung der Palliativmedizin in den Entwicklungsländern.

B. Zernikow und sein Team zeigen eindrucksvoll die Defizite in der schmerztherapeutischen und palliativmedizinischen Versorgung im pädiatrischen Bereich. Beide neuen Beiträge bieten aber auch Vorschläge für eine zukünftig bessere Betreuung.

Wir hoffen, dass die umfangreiche überarbeitete 3. Auflage mit der gleichen Zustimmung wie die ersten beiden aufgenommen wird. Über konstruktive Kritik und Anregungen freuen wir uns.

S. Husebø
Bergen

E. Klaschik
Bonn

im Sommer 2003

Vorwort zur 2. Auflage

Die 1. Auflage dieses Buches ist gut bei den Lesern angekommen; leider war sie schnell vergriffen. Diese 2. Auflage ist um ein Kapitel erweitert worden: Bettina Sandgathe Husebø hat mit dem Kapitel »Palliativmedizin in der Geriatrie« eine wichtige Ergänzung zum Wissen über die palliativmedizinische Versorgung alter Menschen beigetragen. Dieser Fachbereich hat bislang unter Ärzten und Pflegepersonal wie allgemein in der Gesellschaft wenig Beachtung gefunden.

In den letzten Jahren haben die Fortschritte in der Palliativmedizin noch nicht zu den erwünschten und notwendigen Veränderungen in der Versorgung der Alten geführt. Wer mehr erfahren möchte über die Reife, die Qualität und die Ethik unserer Gesellschaft, sollte ein paar Tage als Besucher oder noch besser als Bewohner in einem nahe gelegenen Pflegeheim verbringen.

Weltweit ist eine zunehmende generelle Kritik an der Hospizbewegung und der Palliativmedizin wahrnehmbar, da die Hauptaufmerksamkeit während der letzten Jahrzehnte fast ausschließlich auf das Leiden der Tumorpatienten gerichtet war. Die wachsende Anzahl alter, schwer kranker und sterbender Patienten blieb dabei unberücksichtigt. Zwei Drittel aller Sterbenden sind älter als 75 Jahre. Von ihnen sterben vierzig Prozent mit einer Tumorerkrankung. Die Mehrzahl aller alten Patienten hat ein chronisches Leiden. In ihrer letzten Lebensphase leben und sterben Menschen häufig unter Bedingungen, die menschenunwürdig sind. Sie erhalten eine inkompetente medizinische und pflegerische Versorgung, weit weg von Hospizen, Palliativstationen oder »Palliative Care«.

Wie wir bereits in der 1. Auflage unterstrichen haben, wird die zentrale Aufgabe der kommenden Jahre eine flächendeckende palliativmedizinische Versorgung aller schwer kranken Patienten sein, unabhängig von ihrer Diagnose, ihrem Alter und der Versorgungseinrichtung, in der sie sich befinden.

In dieser 2. Auflage sind weiterhin Ergänzungen und Änderungen in den Kapiteln Palliativmedizin, Ethik, Schmerztherapie und Symptomkontrolle vorgenommen worden. Die neuen Grundsätze der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung wurden in das Ethikkapitel integriert.

Wir hoffen, dass auch diese 2. Auflage bei den Lesern ein reges Interesse findet.

Stein Husebø, Eberhard Klaschik
im Frühjahr 2000

Vorwort zur 1. Auflage

Liebe Leserin, lieber Leser!
Am Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre wurden wir beide auf die moderne Hospizbewegung aufmerksam. Aus Erfahrungen in der Hospizarbeit in Großbritannien und Kanada ergaben sich neue Konzepte zur Behandlung und Betreuung schwerkranker Krebspatienten, wodurch Hoffnung und Linderung ihrer Leiden möglich wurden. Die dahinter stehenden Gedanken erschienen uns wichtig und vertiefenswert. Auch wir wollten in Skandinavien und Deutschland für eine bessere Lebensqualität unserer Patienten eintreten.

Es ist wohl kein Zufall, dass wir Anästhesisten ein besonderes Interesse an Intensivmedizin und Schmerztherapie haben. In der Schmerztherapie sehen wir, wie viel für leidende Patienten getan werden kann. In der Intensivmedizin werden wir mit großen und kleinen ethischen, psychosozialen und kommunikativen Fragen konfrontiert.

In den vergangenen Jahren hat die Hospizbewegung bedeutenden Einfluss gewonnen. Wir finden immer mehr Hospizinitiativen, Hospize und Palliativstationen in fast allen Ländern der Erde. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass der Hospizidee und der Palliativmedizin ein bedeutender Platz in der modernen Medizin eingeräumt werden muss, was sich auch in der weltweit zunehmenden Zahl wissenschaftlicher Publikationen und in mehr Lehrstühlen für Palliativmedizin widerspiegelt.

Die Patientengruppe, um die es hier geht, weist drei besondere Merkmale auf:

- Erstens *ist sie die größte aller Patientengruppen (... jeder Mensch muss sterben).*
- Zweitens *konnte in einer Reihe von Untersuchungen gezeigt werden, dass es kaum ein wichtigeres Thema für den einzelnen Menschen gibt als ein menschenwürdiges Sterben.*
- Drittens *gibt es keine Gruppe von Patienten, die schwächer und verletzbarer ist als die der Schwerkranken und Sterbenden; sie haben keine Kraft mehr, sich zur Wehr zu setzen.*

Gute Palliativmedizin und Hospizarbeit ist nicht möglich ohne menschliche *und* fachliche Kompetenz und ohne eine multidisziplinäre Zusammenarbeit der einzelnen Berufsgruppen. Diese Patienten brauchen fast täglich ärztliche

Präsenz und Behandlung, sie brauchen Pflege, Verständnis, physische und psychische Stimulanz, Seelsorge, Nähe wie Distanz.

Es gibt also wichtige Gründe, um die Fortschritte und Innovationen in der Palliativmedizin *allen* Patienten zugänglich zu machen.

Dies wird sich nur ermöglichen lassen, wenn *jeder* Arzt und *jede* Krankenschwester, *jeder*, der beruflich schwer kranke und sterbende Patienten betreut, eine gründliche Ausbildung und Praxis in der Palliativmedizin erhält. Heute sind wir in Deutschland weit von diesem Ziel entfernt. Zwar gibt es bei uns eine steigende Zahl an Hospizinitiativen, Hospizen und Palliativstationen. Es gibt aber wenig Studentenunterricht und wenige Weiterbildungsprogramme und – verglichen mit anderen Ländern wie Großbritannien oder Skandinavien – kaum Forschung oder Publikationen zu diesen Themen. Langsam deutet sich jedoch eine Verbesserung an, und wir freuen uns über die positive Entwicklung auf diesem Gebiet in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz.

An einigen Weiterbildungs- und Fortbildungsveranstaltungen haben wir als Vortragende teilnehmen dürfen. Das Interesse und der Enthusiasmus der Zuhörer ist enorm, und das berechtigt zu Hoffnung für die Zukunft. Für uns war es besonders erfreulich zu sehen, mit welcher Begeisterung die Medizinstudenten dieses Thema aufnahmen. Nur wenn es uns gelingt, diesen Fachbereich kompetent in die reguläre Medizinerausbildung zu integrieren, kann jeder Patient bei jedem Arzt entsprechendes Wissen und Können erwarten, und dies muss unser Ziel für die nahe Zukunft sein.

Die Studenten fragten uns unter anderem, wo sie mehr über Palliativmedizin erfahren und lesen können. Es gibt im deutschsprachigen Raum nur wenig medizinische Fachliteratur zu diesem Thema. Das dabei entstandene Vorlesungskompendium ist Vorläufer zu diesem Buch, in dem wir uns inhaltlich und thematisch weitgehend an die Vorlesungen halten. Ein wichtiges Anliegen bei der Gestaltung dieses Buches ist es, durch zahlreiche Literaturangaben zu weiterem Studium, zur Vertiefung der Kenntnisse und zu weiterer Forschung anzuregen.

Dieses Buch ist kein vollständiges Lehrbuch für Palliativmedizin. Wichtige Themen wie z. B. Chemo-, Hormon- oder Strahlentherapie bei Tumorpatienten werden bei uns nur oberflächlich erwähnt. Viele andere Bereiche hätten einen größeren Raum verdient. Wir haben uns bemüht, ein Buch mit Anregungen für die Praxis zu schreiben, in dem empfindliche und schwierige Themen nicht ausgespart sind. Wieweit uns das gelungen ist, bleibt dem Urteil des Lesers vorbehalten ...

Die Definitionen, Beschreibungen und Begriffe auf diesem Gebiet sind nicht leicht zu überschauen. Wir sprechen von Hospizen, von Hospizinitiativen, Hospizbewegung, Hospizpflege, Hospizkonzept und Hospizidee. Wir sprechen von Palliativstationen, palliativer Pflege, Behandlung, Betreuung, Fürsorge, Krankengymnastik und Seelsorge und haben zusätzlich den Begriff Palliativmedizin eingeführt. Dabei sind diese Begriffe für ein klares Verständnis und zum Erreichen gemeinsamer Ziele wichtig. Auf englisch gibt es die Begriffe »hospice care« und »palliative care«. Für die Engländer ist die Verständigung einfacher, da »care« sowohl Behandlung wie auch Pflege und Fürsorge bedeuten kann.

International hat man sich darauf geeinigt, dass »palliative care« und »hospice care« gleichzusetzen sind. Der Begriff Palliativmedizin (»palliative medicine«) scheint sich jetzt – mit der zunehmenden Akzeptanz und Aufnahme des Fachgebietes an den Universitäten – allgemein durchzusetzen.

Palliativmedizin wird in Zukunft mit aller Wahrscheinlichkeit der Überbegriff für alle oben genannten Facetten sein, da nur die wissenschaftlich dokumentierten Erfahrungen eine breite Zustimmung bei den Ärzten finden wird. Die Verallgemeinerung dieser Bezeichnung bedeutet keineswegs eine Abwertung der »weichen« Teile des Hospizkonzeptes wie Pflege, psychosoziale Betreuung und Seelsorge. Ganz im Gegenteil: es bedeutet eine akademische und wissenschaftliche Anerkennung auch dieser Gebiete.

Wir möchten einen großen Dank an unsere Lehrer und Vorbilder zum Ausdruck bringen. Es sind v. a. die Patienten, die uns zeigen, wie wichtig das Leben in einer aussichtslosen Lage ist; wieviel Hoffnung, Qualitätsorientierung und Geduld bedeuten und wie lohnend es ist, sich um die Schwerkranken kümmern zu dürfen.

Dank sei auch unseren Familien gesagt, die im letzten Jahr viel Geduld und Fürsorge für uns aufgebracht und uns nach Kräften unterstützt haben.

Ohne die großzügige Förderung der Deutschen Krebshilfe, die S. B. Husebø als Gastwissenschaftler nach Deutschland geholt hat, wäre das Buch kaum möglich gewesen. Der Springer-Verlag hat von Anfang an mit großem Einsatz, vielerlei Bemühungen und guter Zusammenarbeit die Publikation realisiert. Die Firma Mundipharma hat dieses Projekt sowie zahlreiche Fortbildungsveranstaltungen beispielhaft unterstützt.

Stein B. Husebø, Eberhard Klaschik
im Herbst 1997

Persönliche Anmerkung von S. Husebø:
Ich bin Norweger und denke hin und wieder, dass mein mündliches Deutsch schon ganz passabel ist. Durch dieses Buchprojekt habe ich jedoch unendlich viel mehr über die ebenso schöne wie auch komplizierte deutsche Sprache gelernt. Ohne die liebevollen und geduldigen Bemühungen und Hilfen meines Schwiegervaters Dr. phil. Günter Sandgathe, meines Freundes Eberhard Klaschik und meiner Frau Bettina bei der Sprachkorrektur hätte ich meine Beiträge nicht verfassen können. Dafür möchte ich herzlichen Dank sagen!

Foreword/Geleitwort

Hospice and palliative care are now recognised internationally, but far too many patients still fail to receive its benefits. Much of the ground work has been researched, developed and demonstrated but all countries need access to the publications which will spread the knowledge.

Every patient needs appropriate and individualised treatment throughout the course of illness. Not all can be cured and all will eventually die. How that happens is not only important for their dignity as individuals but also as members of a family network. A life ended with much unfinished business or uncontrolled suffering has not been met with due respect and does not leave good memories. To accept that life is ending can give value, freedom and hope. Openness and the respectful sharing of bad news can lead to creativity and the healing of relationships. Those of us who have travelled alongside many people at the end of their life's journey have seen not merely endurance and courage, but much growth through loss.

All this calls for great competence in the analysis and relief of the various forms of suffering that make up the Total Pain of a terminal illness. Much evidence-based therapy is available and is presented in this compassionate, practical and challenging book. »Efficiency is very comforting,« said one family member. It is indeed comforting, both to the patient, familiy members and to the staff team caring for them. The past decades have seen much learning of psychological, social and spiritual as well as physical needs. This book, the fruit of years of experience, brings understanding and help to all those who set out to give the best, most appropriate and personal care to those facing the end of life. Here is medical challenge, reward and personal hope in the possibilities of the human being whose final needs and potential demand our attention.

Dame Cicely Saunders
Chairman,
St. Christopher's Hospice, London

Foreword/Geleitwort

Nothing would have greater impact on curbing the pain and suffering of cancer patients and the terminally ill than the ability to implement the impressive knowledge gained in palliative medicine.

We can prevent much suffering in the incurable and the dying. Nevertheless, in Germany and elsewhere, there is widespread failure to apply the available knowledge adequately, resulting in much avoidable and thus unacceptable suffering.

This book makes an important contribution towards solving the problem. Education of health professionals, policy makers and the general public, together with establishment of drug availability and clear policies, costs relatively little but has a great effect and constitutes a necessary foundation for measures towards rational, effective implementation. »Palliativmedizin« is especially welcome as it is the first comprehensive textbook in German to address the first point mentioned above, namely education. It not only details methods for controlling pain but also covers the important subjects of ethics, communication and psycho-social aspects, all essential to good palliative care. Both authors are eminently well qualified. Dr. Stein Husebø has broad experience in practical ethics and decision-making and is a strong advocate of the importance of hope and death as a part of life, and Dr. Eberhard Klaschik has developed, and heads, one of Germany's first and best palliative care centres.

The World Health Organisation initiated the first international consensus on drugs as the mainstay of cancer pain relief, resulting in the WHO three-step pain ladder, and produced clear policies and recommendations regarding the rational implementation of existing knowledge. The standards and norms established are now accepted globally. The World Bank has recommended pain relief as one of the cost-effective priorities in cancer management.

Today, failure to offer a cancer patient adequate pain control is unethical. The old adage, »To sometimes cure, often relieve, and always comfort« remains valid. This volume represents an important contribution to the eradication of a major cause of pain and suffering and the positive acceptance of the unavoidable necessity of death.

Jan Stjernswärd, MD, PhD, FRCP(Edin)

Inhaltsverzeichnis

1 Palliativmedizin ... 1
E. Klaschik

1.1 Was ist Palliativmedizin? ... 2
1.2 Entwicklung und Stand der Palliativmedizin in Europa ... 4
1.2.1 Deutschland ... 5
1.2.2 Frankreich ... 9
1.2.3 Großbritannien ... 11
1.2.4 Niederlande ... 12
1.2.5 Norwegen ... 13
1.2.6 Österreich ... 15
1.2.7 Polen ... 16
1.2.8 Schweden ... 17
1.2.9 Schweiz ... 18
1.2.10 Spanien ... 19
1.3 Kommunikation und Ethik ... 22
1.4 Organisationsformen der Palliativmedizin ... 23
1.4.1 Ambulante Dienste ... 23
1.4.2 Tageshospize ... 26
1.4.3 Stationäre Einrichtungen ... 27
1.5 Ausbildung und Standard ... 33
1.6 Zukunft der Palliativmedizin in Deutschland ... 36
1.7 Abschließende Bewertung ... 38

2 Ethik ... 43
S. Husebø

2.1 Autonomie oder Paternalismus? ... 43
2.1.1 Ethik und Moral ... 45
2.1.2 Der Helfer muss zuerst knien vor dem, dem er helfen möchte ... 49
2.2 Sterbenlassen – passive Sterbehilfe ... 55
2.2.1 Gibt es Situationen, in denen der Tod nicht mehr der Feind des Patienten ist? ... 55
2.2.2 Entscheidungen über Behandlungsabbruch ... 63
2.2.3 Passive Sterbehilfe – Klinische Beurteilung und Definition ... 68
2.2.4 Wann sollen wir eine das Sterben verlängernde Therapie einstellen? ... 70

2.2.5 Wann sollen wir die lebenserhaltende Therapie nicht einstellen? 72
2.2.6 Wenn die Entscheidung besonders schwer fällt, sollte man sich Zeit lassen 74
2.2.7 Wie soll eine Therapie eingestellt werden? 75
2.3 Aktive Sterbehilfe (Euthanasie) 84
2.3.1 Argumente, die für eine aktive Sterbehilfe sprechen könnten 85
2.3.2 Argumente, die gegen aktive Sterbehilfe sprechen.....87
2.3.3 Die Erfahrungen in den Niederlanden 90
2.3.4 Aktive Sterbehilfe oder Palliativmedizin? Die neue Entwicklung in Europa und deren Konsequenzen.....95
2.3.5 Ärztliche Beihilfe zum Suizid 105
2.3.6 Indirekte Sterbehilfe 107
2.3.7 Der Wunsch (?), getötet zu werden 110
2.3.8 Was bedeuten Begriffe wie »unwürdig«, »unerträglich« und »friedvoll«? . 113
2.3.9 Zusammenfassung: Respekt vor dem Leben und vor dem Sterben – aber nicht töten..... 118
2.4 Palliativmedizin und aktive Lebenshilfe – die Alternative zur Euthanasie.....120
2.5 Grundsätze der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung – 2004.....123
2.6 Schwerkranke und Sterbende – Richtlinien für ethische Entscheidungen angesichts des Abbruchs oder im Hinblich auf das Nichteinleiten lebensverlängernder Therapiemaßnahmen.....128

3 Kommunikation.....143
S. Husebø
3.1 Kommunikation – Hintergründe.....143
3.2 Sollen wir den Patienten vor der Wahrheit schützen?.....145
3.2.1 Wie wird heute über bösartige Erkrankung informiert?..... 146
3.2.2 Wieviel Information und Offenheit wollen die Patienten?..... 150
3.2.3 Ist es besser für den Patienten, wenn wir ihn vor unangenehmen Wahrheiten schützen? 152
3.3 Warum sind Aufklärungsgespräche so schwierig? 154
3.3.1 Wir schützen uns vor etwas, das für uns unerträglich ist..... 155
3.3.2 Es fehlt uns an Fachkenntnissen über die Reaktionen von Patienten... 156
3.3.3 Es fällt uns schwer, eine Niederlage zuzugeben 158
3.3.4 Es fehlt uns an Ausbildung, Erfahrung und guten Vorbildern 159

3.3.5 Wir haben Erfahrung mit Aufklärungsgesprächen, die schwere Folgen hatten ... 160
3.3.6 Es ist nicht jedermanns Sache, sich mit gefühlsmäßigen Reaktionen auseinanderzusetzen ... 162
3.3.7 Wir möchten nicht sterben ... 163
3.4 Das schwierige Gespräch ... 164
3.4.1 Praktische Grundlagen ... 164
3.4.2 Vorbereitung ... 164
3.4.3 Inhalt ... 165
3.4.4 Der Rahmen ... 168
3.4.5 Die Bereitschaft ... 171
3.4.6 Was wurde nicht angesprochen? ... 176
3.5 Es ist schwer zu sterben ... 177
3.5.1 Es ist schwer, über den eigenen Schatten zu springen ... 178
3.5.2 Die Lebensgeschichte und die Wertsysteme des Patienten sind grundlegende Voraussetzungen für die Kommunikation ... 179
3.5.3 Für schwierige Gedankenprozesse brauchen Patient und Arzt Zeit ... 179
3.5.4 Ein Gespräch, in dem die Teilnehmer Befürchtungen und Gefühle äußern dürfen ... 180
3.5.5 Ein früheres, brutales Aufklärungsgespräch oder eine fehlende Aufklärung können die Ursache für Leugnen und Verdrängung sein ... 182
3.5.6 Ich werde bald gesund und gehe dann nach Hause ... 182
3.6 »Wie lange habe ich noch, Herr Doktor?« ... 183
3.7 »Ihr Kind ist tot.« ... 187
3.7.1 Höfliches und respektvolles Benehmen ... 189
3.7.2 Ein ungestörter Raum ... 189
3.7.3 Information teilen ... 189
3.7.4 Die Botschaft im richtigen Moment verständlich erklären ... 189
3.7.5 Gefühle und Ohnmacht zulassen ... 190
3.8 »Ja, Sie haben Krebs.« ... 190
3.8.1 Welche Geschichte hat der Patient? ... 193
3.8.2 Gemeinsames Gespräch mit der wichtigsten Bezugsperson ... 194
3.8.3 Die Krankenschwester nimmt an dem Gespräch teil ... 194
3.8.4 Höflichkeit und Menschlichkeit ... 195
3.8.5 Offenheit und nicht alles auf einmal ... 195
3.8.6 Die Lage der Kinder ... 196
3.8.7 Wiederholung ... 197

4 Schmerztherapie und Symptomkontrolle in der Palliativmedizin ... 203
E. Klaschik
4.1 Häufigkeit von Schmerzen bei Patienten mit Tumorerkrankungen ... 203
4.2 Ursachen von Schmerzen bei Tumorpatienten ... 203
4.3 Pathophysiologie der Schmerzen ... 205
4.4 Ursachen einer unzureichenden Schmerztherapie ... 206
4.5 Einschätzung der Schmerzintensität ... 207
4.6 Schmerztherapie ... 208
4.6.1 Kausale Schmerztherapie ... 208
4.6.2 Symptomatische Schmerztherapie ... 209
4.7 Arzneimittel ... 219
4.7.1 Nichtopioidanalgetika ... 219
4.7.2 Opioidanalgetika ... 226
4.7.3 Adjuvante Substanzen ... 259
4.8 Exemplarische Therapiepläne ... 271
4.9 Strahlentherapie in der Palliativmedizin ... 276
4.10 Symptomkontrolle ... 276
4.10.1 Dyspnoe ... 276
4.10.2 Übelkeit und Erbrechen ... 279
4.10.3 Obstipation ... 284
4.10.4 Obstruktion ... 288
4.10.5 Flüssigkeitssubstitution in der Finalphase ... 290
4.10.6 Hyperkalzämie ... 293
4.10.7 Schmerztherapie und Symptomkontrolle bei Sterbenden ... 293

5 Psychosoziale Fragen ... 309
S. Husebø
5.1 Familie und Umfeld ... 309
5.2 Sollen wir immer einen »Strohhalm« anbieten? ... 316
5.3 Zu Hause oder im Krankenhaus? ... 322
5.4 Trauer ... 325
5.4.1 Stadien der Trauer ... 326
5.4.2 Der Sinn des Trauerns ... 329
5.4.3 Vorbereitende Trauer – Trauer vor dem Tod ... 329
5.4.4 Pathologische Trauer – starke Trauer ... 331

5.4.5 Trauerarbeit – Aufgaben für Ärzte und das Krankenpflegepersonal ... 333
5.5 Die Rolle der Kinder ... 334
5.5.1 Trauer bei Kindern ... 338
5.5.2 Aufgaben der Ärzte und des Krankenpflegepersonals bei nicht heilbarer Krankheit oder beim Todesfall in der Familie mit Kindern ... 341
5.5.3 Aufgaben der Eltern bei nicht heilbarer Krankheit und beim Todesfall in der Familie mit Kindern ... 343
5.5.4 Aufgaben der Schule bei nicht heilbarer Krankheit und beim Todesfall in der Familie eines Schülers ... 344
5.6 Angst, Depression, delirantes Syndrom und Verwirrtheitszustände ... 346
5.6.1 Angst ... 346
5.6.2 Depression ... 349
5.6.3 Delirantes Syndrom und Verwirrtheit bei Patienten mit fortgeschrittener Erkrankung ... 350
5.7 Suizid bei schwerkranken Patienten ... 352
5.8 Nähe – Distanz und Sexualität ... 354
5.8.1 Physische Nähe ... 355
5.8.2 Psychische Nähe ... 357
5.8.3 Sexualität ... 359
5.9 Seelsorge ... 360
5.10 Der Augenblick des Todes – und die Rechte der Sterbenden ... 365

6 Palliativmedizin in der Geriatrie ... 379
B. Sandgathe Husebø
6.1 Sterben im hohen Alter – früher und heute ... 379
6.2 Palliativmedizin für alte Menschen – ein Projekt in Norwegen ... 385
6.3 Palliativmedizin für alte Patienten – die Praxis ... 394
6.3.1 Schmerzerfassung bei Demenz ... 395
6.4 Palliative Care in einem Pflegeheim – eine Zweiklassenmedizin? ... 399
6.5 Palliativstation kontra Pflegeheim ... 401
6.6 Ethische Entscheidungen am Lebensende ... 405
6.7 Kommunikation ... 408
6.8 Aktive Lebenshilfe ... 411

7 Palliativmedizin im Kindesalter ... 417
B. Zernikow, S. Friedrichsdorf, W. Henkel
7.1 Einleitung ... 417
7.1.1 Geschichte der Palliativmedizin für Kinder ... 417
7.1.2 Definition der pädiatrischen Palliativmedizin ... 418
7.1.3 Die ACT-Charta für Kinder mit lebensbedrohlichen oder terminalen Erkrankungen und ihre Familien ... 420
7.1.4 Epidemiologie in der pädiatrischen Palliativmedizin ... 421
7.1.5 Ethik in der pädiatrischen Palliativmedizin ... 422
7.1.6 Kommunikation in der pädiatrischen Palliativmedizin ... 427
7.1.7 Todesvorstellungen von Kindern und deren Bedeutung für die Kommunikation ... 431
7.2 Status Quo der Palliativmedizin in der Pädiatrie ... 437
7.3 Umfassende Palliativversorgung ... 438
7.3.1 Anforderungen an ein Kinderhospiz/Kinderpalliativzentrum ... 438
7.4 Therapie von Symptomen in der Lebensendphase ... 439
7.4.1 Symptome in der Lebensendphase ... 439
7.4.2 Erfassung der Symptome und Bedürfnisse des Kindes ... 441
7.4.3 Schmerztherapie ... 441
7.4.4 Therapie von nicht schmerzassoziierten Symptomen ... 467
7.5 Palliativmedizin für Kinder und Erwachsene im Vergleich ... 474

8 Palliativmedizin in den Entwicklungsländern ... 483
K.E. Clemens
8.1 Lage des Gesundheits- und Sozialwesens in den Entwicklungsländern ... 484
8.2 Probleme der Gesundheitssysteme ... 490
8.3 Die Rolle der Palliativmedizin ... 492
8.4 Die Rolle der Aus- und Fortbildung ... 497
8.5 Stand und Stellenwert der Palliativmedizin in den Entwicklungsländern ... 499
8.5.1 Sub-Sahara-Afrika ... 499
8.5.2 Lateinamerika ... 501
8.5.3 Südostasien ... 502

9 Die Rolle des Arztes ... 507
S. Husebø
9.1 Wenn Ärzte an ihre Grenzen stoßen ... 507
9.2 Der ärztliche Alltag ... 509
9.3 Der hilflose Helfer ... 511
9.4 Quantität oder Qualität – das falsche Konzept? ... 514
9.5 Empathie und Menschlichkeit ... 520
9.6 Weg aus der Misere – die Gesundheit des Arztes ... 523
9.6.1 Fachliche Kompetenz ... 524
9.6.2 Eigene Reaktionen und Gefühle verstehen und zulassen ... 524
9.6.3 Die eigene Verwundbarkeit – und Empathie ... 525
9.6.4 Die eigene Sterblichkeit ... 527
9.6.5 Kollegialität ... 528
9.6.6 Zu Hause – Das Leben – Liebe ... 530
9.7 Hoffnung ... 532
9.7.1 Heute hat Ihr Arzt Ihnen vermittelt, dass Sie schwer krank sind ... 534
9.7.2 Ein Beispiel ... 536

Empfohlene Literatur ... 543

Stichwortverzeichnis ... 549

Autorenverzeichnis

Dr. K.E. Clemens
Malteser Krankenhaus
Bonn-Hardtberg
Universität Bonn
Von Hompesch-Straße 1
53123 Bonn

Dr. S.J. Friedrichsdorf
Medical Director
Pain & Palliative Care
Children's Hospitals and Clinics
of Minnesota
2525 Chicago Avenue South
Minneapolis, MN 55404

W. Henkel
Stiftungsinstitut für Kinder-
schmerztherapie und Pädiatrische
Palliativmedizin
Vestische Kinder- und Jugendklinik
Universität Witten/Herdecke
Postfach 1351
45711 Datteln

Dr. S. Husebø
Universität Wien
Krokeideveien 453
N-5047 Fana
Norwegen

Prof. Dr. E. Klaschik
Malteser Krankenhaus
Bonn-Hardtberg
Universität Bonn
Von Hompesch-Straße 1
53123 Bonn

Dr. B. Sandgathe Husebø
Rode Kors Sykehjem
Ellerhusensvei 35
N-5035 Bergen
Norwegen

Priv.-Doz. Dr. B. Zernikow
Stiftungsinstitut für Kinder-
schmerztherapie und Pädiatrische
Palliativmedizin
Vestische Kinder- und Jugendklinik
Universität Witten/Herdecke
Postfach 1351
45711 Datteln

Dr. med. Stein Husebø, geb. 1944
Medizinstudium in Graz und Lübeck

1982 Leiter des ersten norwegischen Teams für Schmerztherapie und Palliativmedizin, Universitätskrankenhaus Bergen, Norwegen
1984 Leitender Redakteur der *Skandinavischen Zeitschrift für Palliativmedizin*
1988 Gründungsmitglied und erster Präsident der *Skandinavischen Gesellschaft für Palliativmedizin*
1989 Gründungsmitglied der *Europäischen Gesellschaft für Palliativmedizin*
1990 Chefarzt für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie an der Universitätsklinik Bergen
1995 Gastwissenschaftler in Bonn, gefördert von der *Deutschen Krebshilfe*
1998 Gastprofessur an der Universität Wien
1998 Leiter eines nationalen Projekts im Rote-Kreuz-Geriatriezentrum, Bergen, »Palliativmedizin für alte Menschen«
2000 Deutscher Schmerzpreis
2003 Gastprofessor an der IFF, Fakultät für interdisziplinäre Forschung und Fortbildung der Universität Klagenfurt/Wien.
2003 Leiter des europäischen Projekts: »Würde für die schwächsten Alten«

Prof. Dr. med. Eberhard Klaschik, geb. 1943
Medizinstudium in Mainz, Kiel und Köln

1983 Mitarbeit auf der ersten Palliativstation in Deutschland in Köln
seit 1984 Chefarzt für Anästhesie, Intensivmedizin, Palliativmedizin und Schmerztherapie am Malteser Krankenhaus Bonn-Hardtberg
1990 Eröffnung der Palliativstation, Malteser Krankenhaus Bonn-Hardtberg, und Aufbau eines Hausbetreuungsdienstes mit Förderung der *Deutschen Krebshilfe*
1994 Gründungsmitglied und Sekretär der *Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin*

seit 1998 Präsident der *Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin*
1999 Eröffnung des Zentrums für Palliativmedizin, Malteser Krankenhaus Bonn-Hardtberg
1999 Erste Professur für Palliativmedizin in Deutschland an der Universität Bonn
2003 bis 2005 Mitglied der Enquete-Kommission *Ethik und Recht der modernen Medizin* des Deutschen Bundestages (Sachverständiger), 15. Legislaturperiode
2004 Deutscher Schmerzpreis
2004 Berufung in den Fachausschuss »Versorgungsmaßnahmen und -forschung mit gesundheits-/strukturpolitischer Ausrichtung« der *Deutschen Krebshilfe*
2006 Mitglied des Gutachtergremiums des Schwerpunktprogramms »Palliativmedizin« der *Deutschen Krebshilfe*

Dr. med. Bettina Sandgathe Husebø, geb. 1959
Medizinstudium in Aachen und Bonn
1990 Mitarbeiterin auf der Palliativstation und des Hausbetreuungsdienstes im Malteser Krankenhaus Bonn-Hardtberg
1996 Oberärztin für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie, Malteser Krankenhaus Bonn-Hardtberg
1997 Chefärztin im Rote-Kreuz-Geriatriezentrum Bergen, dem größten Geriatriezentrum und Pflegeheim in Norwegen;
Mitarbeiterin im nationalen norwegischen Projekt »Palliativmedizin für alte Menschen«
2000 Eröffnung der ersten Palliativstation in einem norwegischen Pflegeheim: Rote Kreuz Pflegeheim, Bergen
2002 Nationale Auszeichnung durch das norwegische Gesundheitsministerium
2001 bis 2005 Mitarbeiterin im nationalen Zentrum für Palliative Care, Universität Bergen
2004 PhD-Stipendiat, Universität Bergen, zum Thema: Schmerzerfassung bei Demenz

Dr. med. Katri Elina Clemens, geb. 1964
Medizinstudium in Bonn

1997 bis 2000 Medizinische Beraterin Johanniter-Unfallhilfe e.V., Bundesgeschäftsstelle.
Aufbau und Leitung eines Tuberkulose-Bekämpfungsprojekts in Namibia

seit 1998 Mitarbeiterin in der Abteilung für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Palliativmedizin und Schmerztherapie, Malteser Krankenhaus Bonn-Hardtberg

1999 Vorstandsmitglied der *International Association for Hospice and Palliative Care* (IAHPC)

seit 1999 Aufbau einer Medizinischen Fakultät an der Universität Namibia

seit 2004 Mitglied Advisory Board Forschungsprojekt Schmerzfreies Krankenhaus

seit 2005 Lehr- und Forschungsstelle Zentrum für Palliativmedizin Malteser Krankenhaus Bonn-Hardtberg

seit 2005 Lehrbeauftragte am Lehrstuhl für Palliativmedizin, Universität Bonn

Priv.-Doz. Dr. med. Boris Zernikow, geb. 1964
Medizinstudium in Münster und Boston
Stipendium: Cusanuswerk

1993 Facharztweiterbildung mit kinderonkologischem Schwerpunkt in Bonn, Datteln und Münster

seit 1998 Projektleiter mehrerer bundesweiter Qualitätssicherungsprojekte mit Schwerpunkt Kinderonkologie

2001 Herausgeber und Mitautor von »Schmerztherapie bei Kindern«, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York

2001 Initiator und Gründungsmitglied von *Eigenes Leben. Hilfen für Kinder mit Schmerzen oder lebensverkürzenden Erkrankungen e.V.*

2006 Chefarzt des Vodafone Stiftungsinstituts für Kinderschmerztherapie und Pädiatrische Palliativmedizin (inklusive Kinderschmerzambulanz), Vestische Kinder- und Jugendklinik, Universität Witten/Herdecke
Erster deutscher Konsiliararzt für Kinderschmerztherapie und Pädiatrische Palliativmedizin an der Abteilung für Pädiatrische Hämatologie/Onkologie des Universitätsklinikums Münster

1 Palliativmedizin

E. Klaschik

Krebs ist ein weltweites Problem. Pro Jahr sterben 4–5 Mio. Menschen an den Folgen ihrer Tumorerkrankung; in Deutschland sind dies jährlich ca. 220.000 Menschen, d. h. 25% aller Todesfälle gehen zu Lasten eines Karzinoms [32, 35].

Von den jährlich 350.000 Neuerkrankungen an Krebs in Deutschland können bislang nur 45% durch primäre chirurgische, strahlentherapeutische oder chemotherapeutische Behandlungsstrategien geheilt werden [13]. Weitere 15% der primär behandelten Patienten erleiden ein inkurables Erkrankungsrezidiv [13].

Eine Zunahme der Krebsinzidenz um 35–40% ist in den westeuropäischen Ländern bis zum Jahr 2010 zu erwarten [10]. In den letzten 20–30 Jahren haben neue Behandlungsmöglichkeiten die Aussicht auf Heilung für viele Krebskrankheiten nicht gebessert [3]. Diese Gesamtentwicklung verpflichtet uns zur Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten für die Behandlung von schwerkranken Tumorpatienten, die keine Aussicht auf Heilung haben und bei denen erfahrungsgemäß behandlungsbedürftige Schmerzen auftreten sowie andere körperliche Symptome, Lebenskrisen, Angst und Leiden im Mittelpunkt der letzten Monate und Tage stehen können [31]. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) räumt deswegen der Palliativmedizin höchste Priorität ein [33].

Die Palliativmedizin wird häufig als eine neue medizinische Disziplin beschrieben. Das ist sie nicht. Sie ist wahrscheinlich die älteste überhaupt, denn früher gab es bei fast keiner Erkrankung einen kurativen Ansatz. Neu sind viele medizinische und wissenschaftliche Erkenntnisse in der Schmerztherapie und Symptomkontrolle sowie über elementare Bedürfnisse Schwerstkranker und Sterbender. Wiederentdeckt wurden Kommunikation, Ethik, Mitmenschlichkeit, Teamarbeit und die ganzheitliche Umsorgung des Menschen [37].

Während der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde die Betreuung von Patienten in der Terminalphase zunehmend vernachlässigt. Gründe für diese Entwicklung waren sowohl Veränderungen von Haltungen in der Gesellschaft als auch die Überbetonung der technisierten Medizin als Ausdruck eines Glaubens an die Segnungen rein naturwissenschaftlich begründeten Denkens und Handelns.

Anfang der 1960er Jahre kam es zu einer Gegenbewegung, an der zwei Ärztinnen – Elisabeth Kübler-Ross und Cicely Saunders – entscheidenden Anteil hatten. Die Arbeit von Elisabeth Kübler-Ross war bahnbrechend für eine neue Kultur der Kommunikation mit Sterbenden [21], und Cicely Saunders gründete 1967 mit dem St. Christopher's Hospice das erste Hospiz der modernen Hospizbewegung [30], in welchem sie im Sommer 2005 mit 87 Jahren nach langem Krebsleiden verstarb.

Die Hospizidee ist der zentrale Ausgangspunkt für die Hospizbewegung und die Palliativmedizin. Sie ist eine die gesamte Gesellschaft beeinflussende Bewegung; dazu gehört

- ein neuer Umgang mit Leben, Sterben und Tod,
- ein neuer mitmenschlicher Umgang durch Wiedereinbindung von Familie, Freunden und weiterem sozialem Umfeld (z. B. Nachbarschaftshilfe),
- der Respekt vor der Autonomie und der Würde Schwerstkranker und Sterbender.

Eine von dieser Bewegung getragene Behandlung, Betreuung und Begleitung kann überall realisiert werden, sei es zu Hause, im Altenheim, im Krankenhaus, auf einer Palliativstation oder im Hospiz.

1.1 Was ist Palliativmedizin?

Definition

Die 1994 gegründete Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin umschreibt in Anlehnung an die Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Palliativmedizin als Behandlung von Patienten mit einer nicht heilbaren, progredienten und fortgeschrittenen Erkrankung und begrenzter Lebenserwartung, für die das Hauptziel der Begleitung die Erhaltung bzw. das Erreichen der bestmöglichen Lebensqualität ist.

Diese Definition beschränkt die palliativmedizinischen Behandlungsmöglichkeiten nicht nur auf bösartige Krankheiten, in der Praxis jedoch haben viele Patientengruppen, etwa mit chronischen Leiden oder Behinderungen, kaum Zugang zu palliativmedizinischer Expertise. Konflikte mit den Verantwortungsbereichen, z. B. von Kardiologen, Pulmonologen und Geriatern, die sich ja ebenfalls mit unheilbaren Leiden befassen [8, 9], treten aber aufgrund eines zunehmend kooperationsorientierten Selbstverständnisses der Disziplinen immer seltener auf.

Obwohl die Linderung von Leiden die Aufgabe aller Ärzte war und ist, ganz gleich welche Ursache dazu geführt hat oder wie weit die Erkrankungen fortgeschritten sind, zielt die Palliativmedizin ganz klar auf die Linderung von Leiden ab, und zwar inklusive der Terminal- und Finalphase, wenn sich das Augenmerk der Behandlung ganz auf die Schaffung von Lebensqualität richtet und nicht mehr auf die Verlängerung des Lebens [8].

Es ist die Einstellung gegenüber der Symptomkontrolle, die die Palliativmedizin von der klassischen Medizin unterscheidet. *Die Befreiung oder Linderung von Symptomen wird zum alles überragenden Mittelpunkt der Therapie* [37]. Als weiteres wichtiges Element gilt die Kommunikation mit dem schwerkranken oder sterbenden Patienten und seinen Angehörigen.

Aufrichtigkeit bei der Mitteilung »schlechter Nachrichten« und Hilfestellung für die Trauerarbeit sind hierfür Beispiele. Die Rehabilitation des Kranken als dritter Baustein soll schließlich ein – an den verbliebenen Fähigkeiten gemessen – »normales« Leben, z. B. die Pflege sozialer Kontakte und die Ausübung lieb gewonnener Gewohnheiten, ermöglichen [37].

Palliativmedizin schließt Chemotherapie, Strahlentherapie und/oder operative Therapie nicht aus. Voraussetzung ist aber, dass die Vorteile dieser Maßnahmen größer sind als deren potentielle Nachteile [18, 33].

Zusammenfassend aus dem bisher Dargestellten ist Palliativmedizin ein Gesamtkonzept mit folgendem Inhalt:

- Exzellente Schmerz- und Symptomkontrolle.
- Integration der psychischen, sozialen und seelsorgerischen Bedürfnisse der Patienten, der Angehörigen und des Behandlungsteams sowohl während der Erkrankung des Patienten als auch bei seinem Sterben und in der Zeit danach.
- Akzeptanz des Sterbens als Teil des Lebens. Sterben ist ein natürlicher Prozess, und der Tod soll weder beschleunigt noch hinausgezögert werden. Palliativmedizin ist eine eindeutige Absage an aktive Sterbehilfe.
- Kompetenz in Kommunikation und Ethik.

Aufgabe und Ziel der Palliativmedizin ist es, die individuell notwendige Unterstützung anzubieten, damit der Patient die bestmögliche Lebensqualität in seiner ihm verbleibenden Lebenszeit erreichen kann. Dies wird ermöglicht durch die Kooperation kompetenter palliativmedizinischer und hospizlicher Einrichtungen mit Hausärzten, Sozialstationen und Krankenhausstationen, sodass eine optimale Behandlung rund um die Uhr überall dort gesichert werden kann, wo diese Patienten betreut werden. Der Patient soll selbst entscheiden können, ob er zu Hause oder in stationären Einrichtungen versorgt werden will.

Die Integration dieser Themen in die medizinische Lehre und Forschung ist eine Hauptaufgabe für die kommenden Jahre [5].

1.2 Entwicklung und Stand der Palliativmedizin in Europa

Das St. Christopher's Hospice in London gilt als Ausgangspunkt der modernen Hospizbewegung (1967). Die Hospizidee breitete sich in Großbritannien rasch aus, und viele andere Länder schlossen sich dieser Bewegung an. Im Jahr 1974 wurde das erste Hospital-Support-Team im St. Louis Hospital in New York etabliert und 1975 wurde die weltweit erste Palliativstation am Royal Victoria Hospital (Kanada) eröffnet. Belfour Mount, der Gründer dieses Palliative-Care-Service, benutzte als erster in diesem Zusammenhang das Wort »palliativ«. Dieser Palliative-Care-Service bot auch gleichzeitig einen Hausbetreuungsdienst und ein Hospital-Consulting-Team an, d. h. einen Krankenhaus-Konsiliardienst. Ebenfalls 1975 wurde in Sheffield (Großbritannien) im St. Louis Hospice das erste Day-Care-Centre auf den Weg gebracht. Die oben dargestellte Entwicklung zeigt, dass Hospice Care oder Palliative Care nicht auf eine spezielle Einrichtung beschränkt ist, sondern dass das Anliegen der Hospizidee in vielfältiger Weise verwirklicht werden kann. Inzwischen hat sich die Hospizidee in über 80 Ländern der Welt ausgebreitet. Sie ist der gemeinsame Nenner von Hospizbewegung und Palliativmedizin, und Palliativmedizin ist durch die Integration der Hospizidee in die Schulmedizin entstanden.

Während in Großbritannien bereits kurze Zeit nach Eröffnung des ersten Hospizes die Hospizidee zu einer Bewegung wurde, dauerte es in fast allen

europäischen Ländern bis zum Ende der 1980er Jahre bzw. Anfang der 1990er Jahre, ehe sich aus Einzelinitiativen eine konzertierte Dynamik entwickelte. 1989 wurde die European Association for Palliative Care (EAPC) gegründet, die 2004 bereits mehr als 50.000 kollektive Mitglieder [26, 11] zählen konnte.

Nach wie vor ist es schwierig, zuverlässige Daten aus den verschiedenen Ländern Europas zu erhalten. In vielen Ländern gibt es keine zentrale Informationsstelle zur Erfassung hospizlicher oder palliativmedizinischer Einrichtungen, was die Erhebung nationaler Daten extrem erschwert oder gar unmöglich macht. Verschiedene Projekte, so z. B. das International Oberservatory on End of Life Care der Universität Lancaster (Großbritannien) oder die EAPC Taskforce on Palliative Care Development in Europe, widmen sich der koordinierten Erhebung verlässlicher Angaben [11]. Die folgenden Aussagen beruhen auf Angaben aus der Literatur, einer Umfrage, die wir in der 2. Hälfte des Jahres 2002 durchgeführt haben, und den Ergebnissen eines umfassenden investigativen Gutachtens im Auftrag der Enquete-Kommission Ethik und Recht der modernden Medizin zum Stand des Jahres 2004 in verschiedenen europäischen Ländern [16].

1.2.1 Deutschland

Schon Ende der 1960er Jahre bestanden erste Kontakte zu den britischen Hospizen, und zwar durch Seelsorger und Ärzte. Es dauerte aber bis Anfang der 1980er Jahre, ehe die erste stationäre Verwirklichung der Hospizidee in Form einer Palliativstation umgesetzt wurde. Erst gegen Ende der 1980er/Beginn der 1990er Jahre wurde aus den zaghaften Versuchen eine Bewegung. Die Entwicklung der Palliativmedizin und Hospizidee in Deutschland wurde entscheidend gefördert zunächst durch die Deutsche Krebshilfe, später auch durch kirchliche, karitative und politische Gremien, aber auch durch die pharmazeutische Industrie.

Die 1980er Jahre wurden durch zwei Entwicklungen geprägt: Zum einen kam es zur Gründung zahlreicher Initiativen, zur Förderung stationärer und ambulanter Hospiz- und Palliativeinrichtungen, u. a. in Bonn, Hannover, München, Recklinghausen, Stuttgart. Im Jahr 1990 gab es aber noch nicht mehr als 3 Palliativstationen und 3 stationäre Hospize (Tab. 1.1). Zum anderen zeigten sich weitgehend unabhängig voneinander ablaufende Entwicklungen in der Hospizbewegung und der Palliativmedizin.

Tab. 1.1. Palliativstationen und Hospize in Deutschland

	Palliativstationen	Hospize
1983	1	0
1986	1	1
1990	3	3
1993	18	11
1996	28	30
1999	55	65
2002	74	99
2004	106	129
2005	116	131

Die Gründe dafür sind vielfältig. So war die Hospizbewegung, besonders dann, wenn Hospizinitiativen von ehrenamtlichen Laien auf den Weg gebracht wurden, hauptsächlich an psychosozialem und pflegerischem Engagement interessiert, wohingegen aus palliativmedizinischer Sicht immer wieder die unzureichende ärztliche Präsenz in den deutschen Hospizen bemängelt wurde. Erschwerend für die Zusammenarbeit kam hinzu, dass lange Zeit in der inhaltlichen und praktischen Gestaltung der Hospizarbeit keine Einigkeit bestand. Heute werden Qualitätsanforderungen an Hospizeinrichtungen z. B. im § 39a SGB V formuliert, aber auch eigene Standards sind längst erarbeitet worden. Für die Palliativmedizin wurden hingegen schon frühzeitig Qualtitätskriterien bezüglich Personalstruktur sowie Definitionen von Zielen und Aufgaben entwickelt. Dazu gehört z. B., dass alle Patienten, die auf einer Palliativstation aufgenommen werden, die Kriterien einer Krankenbehandlungsbedürftigkeit erfüllen müssen. Es werden ausschließlich Patienten mit einer nicht heilbaren und progredienten Erkrankung und mit einer begrenzten Lebenserwartung behandelt. Um die Arbeit auf einer Palliativstation leisten zu können, muss im Krankenpflegebereich ein Stellenplan von 1,4:1 (Krankenpflege zu Patient) und einer Arztstelle für 8–10 Betten berücksichtigt werden. Zum interdisziplinären Team gehören weiterhin Physiotherapeuten, Sozialarbeiter, Psychologen oder Seelsorger sowie Ehrenamtliche.

Im Jahr 1994 wurde auf der Grundlage international anerkannter Zielsetzungen der Palliativmedizin die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin gegründet, die von 1996 bis 2005 nationale Kongresse in Köln, Berlin, Göttingen, München, Bonn und Aachen durchführte. Seit dem Jahr 2000 erscheint die Zeitschrift für Palliativmedizin, und durch die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin wird der Förderpreis für Palliativmedizin vergeben. Die erste Professur für Palliativmedizin wurde zum Wintersemester 1999/2000 an der Universität Bonn eingerichtet, eine weitere 4 Jahre später in Aachen; die dritte wurde 2004 in Köln eingerichtet; Lehrstühle in München, Göttingen und Jena werden in Kürze realisiert.

Obwohl die Palliativmedizin in Deutschland seit Anfang der 1980er Jahre praktiziert wird und seit Anfang der 1990er Jahre erhebliche Fortschritte gemacht hat, hatten wir Anfang 2006 mit 11 Palliativ- und 15 Hospizbetten pro 1 Mio. Einwohner weiterhin eine Unterversorgung. Nur 3–4% der Patienten, die an Krebserkrankungen sterben bzw. sterben werden, können auf Palliativstationen betreut werden. Hochrechnungen haben ergeben, dass aber ca. 17–18% nicht heilbarer Tumorpatienten eine vorübergehende stationäre Behandlung auf solchen Stationen benötigen.

Die stationäre Versorgung dieser Patientengruppe wird im Besonderen an den deutschen Universitäten vernachlässigt. Von den 116 Palliativstationen, die wir derzeit in Deutschland haben, sind nur 8 an Universitäten angegliedert. Zu der derzeit absolut zu niedrigen Bettenzahl im Palliativbereich kommt eine inhomogene Verteilung dieser Betten hinzu. Beispielhaft sei das Land Nordrhein-Westfalen genannt, wo die Bettenverteilung in den Landkreisen zwischen 0 und 45 Betten pro 1 Mio. Einwohner variiert (◘ Abb. 1.1). Wenn Leiden in Zukunft umfassend gelindert und Palliativmedizin als Lebensperspektive und als Alternative zu aktiver Sterbehilfe betrachtet werden soll, dann muss ein flächendeckendes palliativmedizinisches Versorgungsnetzwerk aufgebaut werden [29].

Die 2002 im Bundestag verabschiedete neue Approbationsordnung für Ärzte enthält zwar erstmalig den Begriff Palliativmedizin; die Disziplin ist aber leider nicht als Pflichtlehr- und -prüfungsfach berücksichtigt worden, sondern nur als optionales Fach. Damit ist eine große Chance vertan worden, die zukünftige Arztgeneration in der Universitätsausbildung obligatorisch mit den Grundprinzipien der Palliativmedizin vertraut zu machen. Dennoch bieten mittlerweile nicht wenige Universitäten palliativmedizinische Inhalte für Medizinstudenten an. In Aachen, Bonn, Göttingen, Jena,

Köln und München ist Palliativmedizin durch eine Selbstverpflichtung der Fakultät obligatorisches Lehr- und Prüfungsfach.

- Im Jahr 2003 hat die Bundesärztekammer eine neue (Muster-)Weiterbildungsordnung verabschiedet. Zum einen wurde Palliativmedizin als Weiterbildungsinhalt in die Weiterbildungsordnung mehrerer patientennaher Gebiete, wie z. B. Innere Medizin und Allgemeinmedizin, Gynäkologie und Urologie usw. integiert. Zum anderen wurde Palliativmedizin erstmals als eigenständige Zusatzweiterbildung anerkannt, wie es u. a. die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin empfohlen und beantragt hatte. Die Zusatzweiterbildung Palliativmedizin umfasst in Ergänzung zu einer Facharztkompetenz die Behandlung und Begleitung von Patienten mit einer inkurablen, weit fortgeschrittenen und fortschreitenden Erkrankung mit dem Ziel, unter Einbeziehung des sozialen Umfelds die

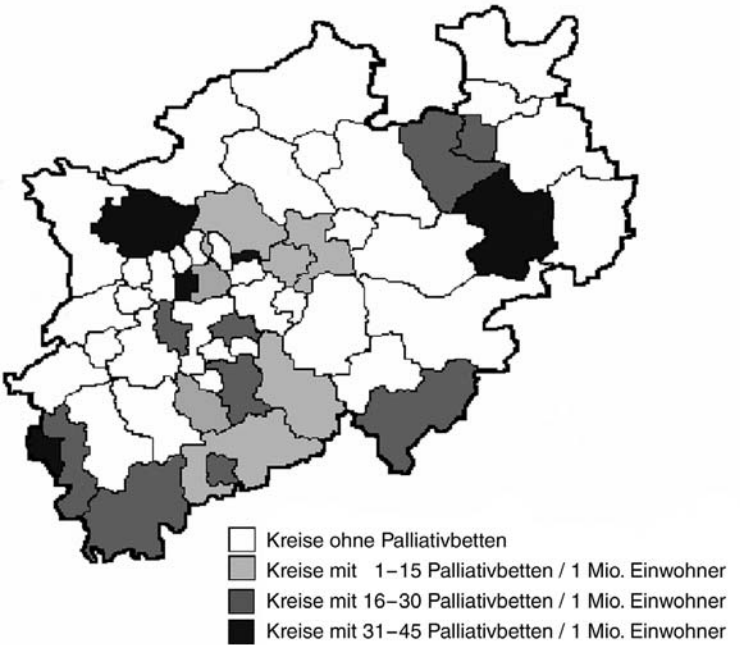


Abb. 1.1. Palliativbetten in NRW 2005

bestmögliche Lebensqualität zu erreichen und sicherzustellen. Voraussetzung zur Prüfung sind
- 12 Monate Tätigkeit bei einem Weiterbildungsbefugten oder anteilig ersetzbar durch 120 Stunden Fallseminare einschließlich Supervision sowie
- 40 Stunden Kursweiterbildung in Palliativmedizin.

Nicht zuletzt wegen der immer wieder aufflackernden Diskussion um eine Legalisierung der aktiven Sterbehilfe muss mit der Förderung der Palliativmedizin eine Alternative entwickelt werden, die für unsere Patienten eine Lebensperspektive aufzeigt. Hierzu hat die Enquete-Kommission Ethik und Recht der modernen Medizin der 15. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages in ihrem Zwischenbericht »Palliativmedizin und Hospizarbeit« vom 22.06.2005 eindeutig aufgerufen und dementsprechend weitreichende Empfehlungen ausgesprochen [7].

1.2.2 Frankreich

Wie in Deutschland begann die Palliativmedizin in Frankreich zunächst zögerlich Ende der 1970er Jahre mit der öffentlichen Debatte um den als unwürdig erachteten Umgang mit Sterben und Tod in Krankenhäusern.

Die erste Palliativstation wurde 1987 in Paris eröffnet, und der erste innerkrankenhäusliche Konsiliardienst nahm 1984 ebenfalls in Paris seine Arbeit auf. Entscheidende Förderung erhielt die Palliativmedizin 1991 durch das Krankenhausreformgesetz, in dem die Palliativmedizin neben der Prävention und Heilung zur dritten Aufgabe der öffentlichen Krankenhäuser erklärt wurde. 1998 bzw. 1999 entwickelte das Gesundheitsministerium jeweils einen Dreijahresplan zur Förderung der Schmerztherapie und der Palliativmedizin. Im Sommer 1999 wurde das Palliativpflegegesetz im französischen Parlament verabschiedet. Dieses Gesetz hält fest, dass
- jeder Patient ein Anrecht auf Palliativpflege hat;
- Krankenhäuser verpflichtet sind, den Zugang zur Schmerztherapie und Palliativmedizin zu ermöglichen;
- jeder Arbeitnehmer ein Anrecht auf einen dreimonatigen unbezahlten Urlaub zur Sterbebegleitung von Verwandten ersten Grades und in seinem Haushalt lebender Personen hat.

Im Jahr 2004 gab es in Frankreich:

- 122 Palliativstationen mit insgesamt 1040 Betten; sie sind in der Organisationsstruktur den deutschen Palliativstationen ähnlich;
- 265 v. a. innerkrankenhäuslich tätige Konsiliardienste (Equipes Mobiles de Soins Palliatifs), die über palliativmedizinische Expertise verfügen;
- 30 Netzwerke aus multiprofessionellen, palliativmedizinisch und psychologisch geschulten Teams (Réseaux de Soins Palliatifs). Sie nehmen eine koordinierende Funktion zwischen Krankenhaus, der häuslichen Krankenpflege, dem Hausarzt und anderen ambulanten Diensten in der Versorgung eines Patienten ein.

Neben diesen palliativmedizinisch spezialisierten Diensten gibt es nach dem Krankenhausreformgesetz eine Hausbetreuung für schwerkranke Patienten, deren Mitarbeiter aber nicht speziell für die Palliativpflege und Schmerzbehandlung geschult wurden (Hospitalisation à Domicile). Darüber hinaus gibt es verschiedene Hospizinitiativen (Associations de Soins Palliatifs), deren Aufgaben von Öffentlichkeitsarbeit bis zur palliativmedizinischen Betreuung von Patienten reichen können.

Palliativmedizin ist in Frankreich kein eigenständiges Fachgebiet, und es gibt keine Lehrstühle für Palliativmedizin an den französischen Universitäten. Obwohl das Bildungsministerium 1995 ein Dekret erlassen hat, das den Universitäten Vorlesungen in Palliativmedizin im Rahmen des Medizinstudiums auferlegt, ist die Umsetzung je nach Universität sehr unterschiedlich. Landesweit bieten aber seit 2004 alle Universitäten Module in Schmerztherapie und Palliativmedizin an; die Inhalte dieser Unterrichtseinheiten sind prüfungsrelevant. Als berufsbegleitende interdisziplinäre Fortbildung bieten 24 Universitäten ein »Diplôme Interuniversitaire de Soins Palliatifs« an; zugelassen werden praktizierende Ärzte, Sozialarbeiter, Psychologen, Krankenschwestern und Hilfsschwestern. Für die Anstellung in palliativmedizinischen Strukturen ist ein solches Diplom erwünscht [16].

Im Jahr 2002 hatte das Gesundheitsministerium einen weiteren Vierjahresplan zur Förderung der Palliativmedizin verabschiedet mit u. a. folgenden Zielen:

- freie Entscheidung des Patienten, an welchem Ort er die letzten Lebenstage verbringen möchte;
- gezielte Förderung der Hausbetreuung;

- flächendeckende, qualitativ einheitliche palliativmedizinische stationäre Versorgung in ganz Frankreich mit Ausbau der Versorgungsstrukturen; über 11 Mio. Euro wurden für diesen Zweck bewilligt;
- Öffentlichkeitsarbeit mit Aufklärung über die Zielsetzung der Palliativmedizin.

1.2.3 Großbritannien

Das St. Christopher's Hospice in London wird weltweit als das erste Hospiz der modernen Hospizbewegung angesehen. 1967 nahm es die ersten Patienten auf. Die Hospizbewegung entwickelte sich in Großbritannien von diesem Zeitpunkt an sehr rasch in den unterschiedlichen Organisationsformen, sei es stationär, teilstationär oder ambulant. Daten aus dem Jahr 2005 besagen Folgendes:

Es gibt 220 Palliative Care Units (Hospize und Palliativstationen) mit insgesamt 3.156 Betten, zusätzlich 33 Kinderhospize mit insgesamt 255 Betten [14]. Die meisten größeren Palliative Care Units bieten stationäre, teilstationäre und ambulante Versorgung an.

Fast 18% der Menschen, die an Krebs sterben, werden in Hospizen – Palliativstationen – betreut. Die durchschnittliche Liegedauer in englischen Palliative Care Units beträgt 13 Tage. Inzwischen werden 41 000 neue Patienten pro Jahr bei ca. 58.000 Aufnahmen betreut.

Der erste Hausbetreuungsdienst wurde 1969 in London vom St. Christopher's Hospice ins Leben gerufen. Heute gibt es 358 Hausbetreuungsdienste und 104 Hospice-at-Home-Dienste im ganzen Land. Rund 155.000 Patienten werden pro Jahr vom ambulanten Dienst (mit)betreut. Die ambulante Versorgung ist ein wichtiges politisches Ziel [15].

Das erste Hospital-Palliative-Care-Team wurde 1976 etabliert. 1980 gab es 9, 1990 40 und 2005 293 solcher Teams.

Neben den klassischen Hospizen und Palliativstationen entwickelte sich großes Interesse an Palliativmedizin in Pflegeheimen; die Qualität der Versorgung variiert beträchtlich.

Alle medizinischen Fakultäten unterrichten die Studenten in Palliativmedzin, wobei die Curricula unterschiedlich sind. Im Schnitt beträgt die Unterrichtszeit 20 Stunden.

Seit 1987 ist die Palliativmedizin ein eigenständiges Fachgebiet, und es besteht ein großes Angebot für die Aus-, Weiter- und Fortbildung.

Zur Zeit gibt es 11 Lehrstühle und mehrere Fachzeitschriften für Palliativmedizin [16].

1.2.4 Niederlande

Bis 1995 gab es in den Niederlanden nur Einzelinitiativen, die die Palliativmedizin vorantrieben. Innenpolitische Kritik an der Euthanasiepraxis hatte die niederländische Regierung dazu veranlasst, mehr Gewicht auf die Entwicklung der Palliativmedizin zu legen. Dabei wurde Wert darauf gelegt, die Hospizidee eher in bestehenden Einrichtungen fest zu verankern, anstatt neue Einrichtungen zu schaffen. Weiterhin wurden 6 akademische Zentren (»centres for the development of palliative care in the terminal phase«) benannt (Nijmegen, Rotterdam, Amsterdam, Maastricht, Utrecht, Gronijngen) und im Rahmen eines Sechsjahresprogramms finanziell unterstützt, um die Palliativmedizin in den Niederlanden voranzutreiben.

Jedes Zentrum konzentrierte sich dabei auf bestimmte Aspekte, so auf den Ausbau von Beratungsteams, die Einrichtung spezieller Einheiten für palliativmedizinische Betreuung von Patienten in der terminalen Phase in Pflegeheimen oder die Auseinandersetzung mit ethischen Fragen. Seit Abschluss des Programms wird die Arbeit dieser Zentren von den 9 regionalen Krebszentren (Integrale Kankercentra) weitergeführt [16].

In der praktischen Umsetzung der Hospizidee verfolgt die niederländische Regierung die Strategie, Patienten, die nicht bis zum Tod zu Hause versorgt werden können, in bestehende Alten- und Pflegeeinrichtungen aufzunehmen und nicht eigene Hospize einzurichten. Trotzdem gibt es verschiedene Formen der Umsetzung stationärer Hospize. Im Jahr 2004 gab es 28 so genannte »High-Care-Hospize« (insgesamt 181 Betten), eigenständige Institutionen, die über ärztliches und pflegerisches Palliativfachpersonal verfügen. Als weitere Umsetzung hospizlicher stationärer Versorgung gibt es die »Fast-wie-zu-Hause-Häuser« oder »Low-Care-Hospize«; diese haben 4–5 Betten in Wohnhäusern und werden durch Hausärzte der Patienten, häusliche Krankenpflegedienste und Ehrenamtliche betreut. Im Jahr 2004 waren es 33 Einrichtungen mit insgesamt 105 Betten. Sowohl in Pflege- (58 Units mit insgesamt 226 Betten) wie in Altenheimen (35 Units mit insgesamt 81 Betten)

wurden in den letzten Jahren kleine Einheiten für Palliativpflege für Patienten in der terminalen Phase eingerichtet. In Krankenhäusern sind nur 3 Palliativstationen mit insgesamt 19 Betten angesiedelt, weil deren Einrichtung politisch eine geringere Priorität hat als die der anderen Organisationsformen. Bei einer Bedarfsanalyse hatte das Gesundheitsministerium den Bedarf an stationärer palliativmedizinischer bzw. -pflegerischer Versorgung auf 572 Betten für das Jahr 2005 berechnet. Da zzt. 613 Betten (ohne Kinderhospize) bestehen, kann dieser Bedarf rein rechnerisch als gedeckt gelten, wenngleich eine flächendeckende und regional bedarfsgerechte Versorgung nicht in allen Teilen des Landes realisiert wurde.

Bisher wurden 3 Lehrstühle für Palliativmedizin eingerichtet (Rotterdam als Gastprofessur (»visiting chair«), Nijmegen und Amsterdam). Palliativmedizin ist in den Niederlanden kein eigenständiges Fachgebiet, wird aber an einigen Universitäten unterrichtet, allerdings ohne einheitliches Curriculum.

Im Jahr 1996 wurde das »Network Palliative Care for Terminal Patients of the Netherlands« gegründet, das Mitglied der EACP ist. Mit Förderung der Regierung wurde »Stichting Agora« eingerichtet, ein nationales Informationszentrum für Palliative Care [16].

Im Gegensatz zu allen anderen Palliativgesellschaften hat die Niederländische Palliativgesellschaft sich nicht eindeutig gegen die Euthanasie ausgesprochen. Sie geht bisher davon aus, dass Palliativmedizin und Euthanasie sich nicht gegenseitig ausschließen. In dieser Hinsicht unterscheidet sich die Einstellung der Niederländer – und auch der Belgier – von allen anderen europäischen Ländern in einem wesentlichen Punkt. Das Ministerium für Gesundheit hofft, dass die Weiterentwicklung der Palliativmedizin die Anzahl der Euthanasiefälle verringern wird.

1.2.5 Norwegen

Norwegen hat sich frühzeitig der Palliativmedizin zugewendet und von Anfang an den größten Wert auf Aus- und Fortbildung gelegt. Seit 1984 erhalten alle norwegischen Studenten im Studium die Grundprinzipien der Palliativmedizin vermittelt; mittlerweile ist Palliativmedizin an allen Universitäten des Landes Pflichtlehr- und -prüfungsfach, allerdings nach unterschiedlichen Curricula. Seit 1994 gibt es einen Lehrstuhl für Palliativmedizin, weitere sollen eingerichtet werden. Im Rahmen von Allgemeinmedizin (12 Lehrstühle)

und Pflegewissenschaften (5 Lehrstühle) wird aber ebenfalls Palliativmedizin gelehrt, die auch in diesen Bereichen obligatorisch in der Ausbildung verankert ist.

Seit 1984 müssen alle approbierten Ärzte Fortbildungen in Palliativmedizin nachweisen. Für Fachärzte der Allgemeinmedizin besteht die Verpflichtung, ihren »Facharzt aufzufrischen«, d. h. alle 5 Jahre eine insgesamt 200-stündige Fortbildungseinheit zu absolvieren. Der palliativmedizinische Anteil dieser Fortbildungsmaßnahme umfasst 20 Stunden. Weiterhin gibt es seit dem Wintersemester 2003/2004 den Nordic Spezialist Course in Palliative Medicine, ein multinationales Fortbildungsdiplom. Beteiligt sind Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden. Diese Kooperation wird als Meilenstein auf dem Weg zur Implementierung eines Facharztes für Palliativmedizin in den beteiligten Ländern verstanden [16].

Ein weiterer Schwerpunkt des »norwegischen Weges« war die Einführung von Support-Teams zur Unterstützung der ambulanten und stationären Versorgung. Von 1981 bis 1996 stieg die Anzahl dieser Hospital/Home-Supportteams auf 211 an; aktuellere Angaben sind nicht verfügbar [16]. Da der Schwerpunkt im ambulanten Bereich und auf Konsiliarteams liegt, wurde als konsequente Folge der norwegischen Entwicklung der Palliativmedizin die erste Palliativstation erst 1995 eröffnet.

Zwar bestehen an allen Universitätskrankenhäusern in Norwegen kleine Palliativzentren mit Ärzten, Krankenpflegepersonal und Vertretern anderer relevanter Berufsgruppen. Sie sind aber alle unterschiedlich strukturiert. Während einige über ambulante oder Konsiliardienste für die Gemeinde oder innerhalb des Krankenhauses verfügen, sind andere hauptsächlich mit dem Aufbau eines Netzwerkes für palliativmedizinische Versorgung in ihrer Region beschäftigt. Die umfassend ausgestattete Palliativstation an der Universitätsklinik Trondheim ist bisher die einzige ihrer Art geblieben. Für die Einrichtung von Palliativstationen an anderen Universitätskliniken bestehen Pläne und sind teils auch Anträge zur Finanzierung bei der Regierung eingereicht worden. Mit Regierungsgeldern im Rahmen des Norwegian Cancer Plans (1999–2003) wurden aber 4 so genannte Centres of Excellence eingerichtet, welche für die 5 Gesundheitsregionen in Norwegen (Westnorwegen – Bergen; Zentralnorwegen – Trondheim; Ost- und Südnorwegen – Oslo; Nordnorwegen – Tromsø) zuständig sind. Ihre Aufgaben sind: Forschung, Lehre sowie Koordinierung, Förderung und Entwicklung von palliativmedizinischen Versorgungsstrukturen in ihrer Region [16].

Die norwegische Einstellung zur Palliativmedizin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

- Palliativmedizin für alle, mit Schwerpunkt im ambulanten Bereich;
- Kenntnisse in Palliativmedizin für alle Ärzte;
- Einbindung von Angehörigen in die Betreuung.

1.2.6 Österreich

Die Hospizbewegung und die Palliativmedizin haben sich in Österreich erst spät entwickelt. Das erste Hospiz wurde 1991 in Wien eröffnet. In den letzten Jahren haben die Hospizbewegung und die Palliativmedizin eine enorme Entwicklung durchgemacht. 2004 gab es 19 Palliativstationen, 2 Hospize, 2 Tageshospize, 14 mobile Palliativ-Teams und 111 ehrenamtliche Teams und 11 palliativmedizinische Konsiliardienste [16]. Zwei Projekte zur Palliativversorgung in der Steiermark und in Vorarlberg können als Modell für die Zukunft in Österreich angesehen werden, da sie ein umfassendes Konzept von der Regelversorgung bis zu spezialisierten Einrichtungen vorsehen.

Der Dachverband Hospiz Österreich wurde 1993 gegründet: Er fasst die palliativen und hospizlichen Angebote zusammen und vertritt die Interessen von Hospizinitiativen. 1999 wurde die Österreichische Palliativgesellschaft gegründet, die zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin die Zeitschrift für Palliativmedizin herausgibt [2, 22]. Inzwischen gibt es in Österreich ein intensives Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebot.

Palliativmedizin ist in Österreich kein eigenständiges Fachgebiet, und es gibt bisher keinen Lehrstuhl für Palliativmedizin. An den 4 medizinischen Fakultäten gibt es aber einzelne Veranstaltungen zu palliativmedizinischen Themen. Weiterhin hat das Institut für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung der Universitäten Klagenfurt, Wien, Innsbruck und Graz (IFF) einen Lehr- und Forschungsschwerpunkt Palliative Care und Organisations-Ethik etabliert. Im österreichischen Krankenanstaltenplan (ÖKAP) 2000 war die Einführung von Palliativstationen und bis zum Jahr 2005 die Einrichtung von mindestens 275 Palliativbetten in Akutkrankenhäusern vorgesehen [27], im ÖKAP 2003 waren bereits 338 Palliativbetten vorgesehen, das wären 42 Betten pro 1 Mio. Einwohner, realisiert waren davon im Jahr 2004 24 Bet-

ten pro 1 Mio. Einwohner. Für die Begleitung schwerstkranker und sterbender Angehöriger wurde im Jahr 2002 eine so genannte Familienhospizkarenz implementiert. Auf entsprechenden Antrag kann Pflegenden/Betreuenden eine Minderung der Arbeitszeit bis zur Freistellung bei weiter bestehender Kranken- und Rentenversicherung für bis zu 3, bei gesondertem Verlängerungsantrag bis zu 6 Monate bewilligt werden. Für einkommensschwache Haushalte ist diese Regelung aus finanziellen Gründen aber in der Regel nicht tragbar [16]. Trotz der erfreulichen Dynamik im Hospiz- und Palliativbereich ist man in Österreich von einer flächendeckenden Versorgung weit entfernt.

1.2.7 Polen

Polen hat sich sehr frühzeitig mit der Hospizidee und der Palliativmedizin auseinandergesetzt. Die Polnische Gesellschaft für Palliativmedizin wurde 1989 gegründet. Im Jahr 2004 gab es mit insgesamt 803 Betten in Palliativstationen und Hospizen eine Versorgungsrate von 21 Betten pro 1 Mio. Einwohner. Für die häusliche Versorgung standen 282 Dienste (7,38 Dienste pro 1 Mio. Einwohner) zur Verfügung. Palliativmedizin ist ein eigenständiges Fachgebiet, bisher wurden 6 Lehrstühle für Palliativmedizin eingerichtet. Elf der 12 medizinischen Fakultäten bieten palliativmedizinischen Unterricht an, an den meisten Fakultäten ist dieser Teil der Ausbildung obligatorisch und Prüfungsgegenstand. Auch in pflegerischen Ausbildungen wurde Palliativmedizin verankert.

Die Entscheidungsträger im polnischen Gesundheitssystem haben ein hohes Interesse an einer weiteren Förderung der Palliativmedizin. Im Jahr 2003 wurde ein neues Gesetz über die Gesundheitsversorgung erlassen, das die Sicherstellung von Palliative Care fordert und regelt, dass der Nationale Gesundheitsfond im Regelfall auch in nichtstaatlichen Einrichtungen Kosten zu tragen hat, dort allerdings nur 60%. Der Entwicklungsstand der Hospizarbeit in Polen gilt als vorbildlich für Osteuropa, wenngleich eine flächendeckende Versorgung noch nicht erreicht werden konnte. So genannte Beacons of Palliative Care, am ehesten als Kompetenzzentren mit Multiplikatoreneffekt zu bezeichnende Einrichtungen, bestehen in Warschau und Poznan. Auch im Bereich der pädriatischen Palliativversorgung ist Polen für den osteuropäischen Raum federführend [16].

1.2.8 Schweden

Die Palliativmedizin begann in Schweden in den 1970er Jahren, hat aber seit Anfang der 1990er Jahre nach Expertenauskünften eine rasche Weiterentwicklung gemacht. Ein vollständiger Überblick über die bestehenden Palliativinstitutionen und Palliativprogramme ist bei fehlenden nationalen Daten allerdings nicht möglich.

Die Versorgung von Patienten im weit fortgeschrittenen Stadium von Erkrankungen liegt in der Verantwortung der Gemeinden und ist daher primär Teil des Gesundheitswesens. Die Betreuung zu Hause hat teilweise einen Standard erreicht, der »einem Krankenhausbett im Hause des Patienten« entspricht (Motala-Modell). Die Hausbetreuungsdienste haben sich während der 1990er Jahre explosionsartig entwickelt.

Nach Angaben aus dem Jahr 2002 gibt es in Schweden 34 Palliativstationen. Die erste wurde Anfang der 1980er Jahre gegründet; die meisten wurden in den 1990er Jahren eröffnet.

Die so genannten Palliative-Inpatient-Care-Units (PICU) unterscheiden sich untereinander sehr deutlich in der Organisationsstruktur. Es gibt

- große PICUs mit angeschlossenem Hausbetreuungsdienst,
- große Hospize mit angeschlossenem Hausbetreuungsdienst,
- große Hausbetreuungsdienste mit kleinen Inpatient Units,
- kleine stationäre Einheiten mit wenigen Palliative Designed Beds an geriatrischen Kliniken und Pflegeheimen.

Die 83 Palliative Home-Care-Units sind teilweise an bestehende stationäre Palliativeinheiten angeschlossen, teilweise an Allgemeinpraxen.

Die Mehrzahl der Home-Care-Units besteht aus Krankenschwester und Arzt, die mit Vertretern verschiedener Berufsgruppen wie Sozialarbeitern, Diätassistentinnen, Physiotherapeuten, Beschäftigungstherapeuten u. a. kooperieren. Eine relativ neue Entwicklung ist die pädiatrische Hausbetreuung, die inzwischen an 21 pädiatrischen Abteilungen im ganzen Land eingerichtet wurde.

1998 existierten 27 Palliative-Care-Consulting-Teams (ohne eigene Betten). Es gibt

- Beratungszentren ausschließlich für Tumorpatienten;
- Teams, die in ihrer Betreuung sowohl Tumorpatienten als auch andere Patienten mit fortgeschrittenen Erkrankungen einschließen;
- Teams, die sich primär um die Betreuung zu Hause kümmern.

Ausbildung in Palliativmedizin:

Studenten erhalten ca. 10 Stunden Unterricht in Palliativmedizin, die im Rahmen der Geriatrie, Onkologie, Chirurgie oder Anästhesie gelehrt werden. Inhalte sind u. a. Schmerztherapie, Kommunikation und Ethik. Im Jahr 1997 wurde der erste und bisher einzige Lehrstuhl für Palliativmedizin eingerichtet.

Palliativmedizin ist in Schweden kein eigenständiges Fachgebiet. Es gibt aber eine große Anzahl von Ausbildungsprogrammen für alle in Palliativmedizin involvierten Berufsgruppen.

Schweden hat mehrere Organisationen für Palliativmedizin, die z. T. berufsgruppenspezifisch sind. Die Sweden Association für Palliative Medicine ist eine der beiden ärztlichen Gesellschaften.

Die Schwedische Regierung nahm im Jahr 1979 gegen die Eröffnung von Hospizen Stellung und empfahl als Alternative die Entwicklung von Palliativprogrammen innerhalb des bestehenden Gesundheitssystems. Stationäre palliativmedizinische Versorgung findet zum größten Teil auf Palliativstationen sowie in geriatrischen Einrichtungen und Pflegeheimen statt. Der Schwerpunkt liegt aber eindeutig auf der ambulanten Versorgung. Angehörige, die Schwerstkranke und Sterbende im häuslichen Bereich betreuen, können bis zu 8 Wochen von ihrer Arbeitstelle freigestellt werden und erhalten vom Staat eine Vergütung, die ihrem Einkommen während einer eigenen Erkrankung für diesen Zeitraum entspricht.

Die Erarbeitung und Implementierung von Qualitätsstandards ist genauso vorgesehen wie die regelmäßige Erhebung nationaler Daten zur palliativmedizinischen Versorgungslage, wurde bisher aber noch nicht realisiert.

Mit Beginn der 1990er Jahre entwickelte sich die Palliativmedizin in Schweden sehr rasch. Inzwischen hat die schwedische Regierung offiziell beschlossen, der Palliativmedizin die gleiche hohe Priorität im Gesundheitssystem einzuräumen wie der Versorgung akuter, lebensbedrohlicher Erkrankungen. Ein flächendeckendes, bedarfsgerechtes Angebot ist noch nicht realisiert.

1.2.9 Schweiz

Die 1988 gegründete Schweizerische Gesellschaft für Palliative Medizin, Pflege und Begleitung (SGPMPB) ist Mitglied in der EACP und gibt eine viermal jährlich erscheinende Zeitschrift heraus (Info Kara). Die Gesellschaft hatte im Jahr 2005 ca. 1.500 Mitglieder. Die SGPMPB bietet regelmäßige Fortbildungs-

veranstaltungen an und steht in Verhandlungen mit den Krankenkassen zur Anerkennung und Honorierung der Palliativmedizin und Palliativpflege. In der Zeitschrift Info Kara werden Institutionen für Palliativmedizin, Pflege und Begleitung in der Schweiz aufgeführt, die sich schriftlich dazu verpflichtet haben, sich nach den Grundsätzen der Palliativmedizin und Pflege zu richten.

- In diesen Institutionen arbeiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine Zusatzausbildung oder Weiterbildung in Palliativmedizin und Pflege absolviert haben. Es wird eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit von Sozialarbeitern, Psychologen, Seelsorgern, Ärzten, Pflegekräften, Physiotherapeuten, Ernährungstherapeuten, Ehrenamtlichen und anderen gesucht. Ebenso wird die Zusammenarbeit mit verschiedenen Diensten, z. B. mit der Gemeinde, Krankenpflegern, den Spitälern, dem Caritasverband, der Krebsliga, der Aids-Hilfe und anderen gesucht. Wegen unterschiedlichster Kategorisierungen einzelner Dienste und Einrichtungen sind Angaben zur Zahl vorhandener Dienste schwierig. Nach Expertenauskunft gehen wir für das Jahr 2004 von 24 stationären Einrichtungen mit insgesamt 146 Betten aus (20 Betten pro 1 Mio. Einwohner) sowie von 9 ambulanten Palliativdiensten [16].

Palliativmedizin ist in der Schweiz kein eigenständiges Fachgebiet, und es gibt auch keinen Lehrstuhl für Palliativmedizin. Aufgrund des Engagements der SGPMPB ist aber eine deutliche Zunahme der Fortbildungsaktivitäten zu verzeichnen.

Die Fälle der nach § 115 StGB erlaubten Beihilfe zum Suizid nehmen zu. Im Kanton Zürich haben im Zeitraum von fünf Jahren (2000 bis 2005) 851 Menschen mithilfe der Sterbehilfeorganisationen Dignitas und Exit einen Suizid begangen. Im Fünfjahreszeitraum davor waren es nur 88 dokumentierte Fälle. Seit Dezember 2005 akzeptiert als erstes der fünf Schweizer Universitätskliniken das Universitätsspital Lausanne unter bestimmten Bedingungen Sterbehilfe mithilfe von Sterbehilfeorganisationen, wenn Patienten nicht mehr in der Lage sind, zum Sterben nach Hause zurückzukehren. Ärzte der Einrichtung dürfen auf freiwilliger Basis mitwirken, allerdings nicht während ihrer Dienstzeit.

1.2.10 Spanien

Die Palliativmedizin begann in Spanien nach einer Sensibilisierungsphase 1984 mit der Einführung der Hospizidee in einer onkologischen Abteilung

eines Akutkrankenhauses. 1987 wurde die erste Palliativstation in einem Krankenhaus eröffnet. Das erste Hospital-Support-Team wurde 1989 etabliert. 1992 wurde die spanische Palliativgesellschaft (SECPAL) gegründet. Sie hatte im Jahr 2004 etwa 700 individuelle Mitglieder.

Im Jahr 2000 gab es 81 Palliativstationen, 104 ambulante Palliativdienste und 21 palliativmedizinische Konsiliardienste; für das Jahr 2004 werden nach Expertenschätzung etwa 80 Palliativstationen mit insgesamt 400 Betten angegeben, des Weiteren 15 Konsiliarteams in Krankenhäusern, eine Tageseinrichtung und etwa 100 spezialisierte Hausbetreuungsdienste [16].

Bis auf eine hospizliche Einrichtung für an der Costa del Sol lebende Ausländer gibt es keine Hospize in Spanien, denn mit der Vokabel für Hospizbewohner, »hospiciano«, werden äußerste Armut und schlechte Bedingungen für die Gesundheit der dort Lebenden verbunden, da Hospiz in früheren Zeiten die Bezeichnung für Armenhäuser, Gefängnisse für die Armen und Waisenanstalten war.

Es werden zahlreiche palliativmedizinische Aus- und Fortbildungskurse/Programme an Universitäten und Ausbildungsstätten für Ärzte und das Krankenpflegepersonal angeboten, an 6 Universitäten gibt es einen Masterkurs Palliativmedizin. Einen Lehrstuhl für Palliativmedizin gibt es bisher nicht, aber ein Lehrbuch für Palliativmedizin in spanischer Sprache. Die Spanische Palliativgesellschaft gibt eine vierteljährlich erscheinende Zeitschrift heraus.

Die Spanische Palliativgesellschaft führt zurzeit Gespräche, um Palliativmedizin in die Ausbildung aller Medizinstudenten mit einem Umfang von 50 Stunden im letzten Jahr zu integrieren sowie Palliativmedizin als Subspezialisierung der Medizin zu etablieren. Die Palliativmedizin hat sich in den letzten Jahren außerordentlich dynamisch entwickelt, dabei besteht ein großes Ausbildungsdefizit trotz der oben beschriebenen Angebote.

Ein eindrucksvolles palliativmedizinisches Projekt ist in Katalonien – einem Teilstaat Spaniens – auf den Weg gegangen. Mit Unterstützung der Weltgesundheitsorganisation und einer konzertierten Aktion der katalonischen Regierung und der Ärzteschaft wurde dieses Projekt 1990 gestartet und hat bis 2001 Folgendes erreicht:

Die Anzahl der Palliativstationen stieg von 2 auf 51 mit insgesamt 523 Betten. Da Katalonien 6 Mio. Einwohner hat, bedeutet dies 87 Palliativbetten pro 1 Mio. Einwohner (Deutschland hat derzeit 10 Palliativ- und 15 Hospizbetten pro 1 Mio. Einwohner). Vier dieser Palliativstationen mit insgesamt 53 Betten waren ausschließlich für Aids-Patienten reserviert, eine

davon für inhaftierte. Weiterhin hatte die Region 52 ambulante Palliativdienste sowie 18 Konsiliarteams.

Ein wichtiges Anliegen der Palliativmedizin ist es, das Sterben zu Hause wieder zu ermöglichen. Das katalonische Beispiel hat eindrucksvolle Zahlen dokumentiert. Steht kein Palliative-Care-Team zur Verfügung, können 30% der Tumorpatienten bis zu ihrem Tode zu Hause betreut werden; ist ein Palliative-Care-Team im Krankenhaus vorhanden, steigt der Prozentsatz auf 50%; existiert ein solches sowohl im Krankenhaus als auch zu Hause, beträgt der Anteil der Patienten, die zu Hause sterben, 65%. Gleichzeitig ging der Anteil der Patienten, die im Terminalstadium in Notfallambulanzen der Krankenhäuser eingewiesen wurden, auf weniger als 5% zurück, wenn ein Palliative-Care-Team rund um die Uhr erreichbar war.

Ein weiteres äußerst erfolgreiches Projekt wurde im Jahr 2002 in der Region Estremadura auf den Weg gebracht, dem im Jahr 2003 der Institutional Recognition Award der International Association for Hospice and Palliative Care (IAHPC) verliehen wurde. Noch im Februar 2002 gab es keinerlei öffentliche Strukturen für die spezialisierte palliativmedizinische Versorgung der jährlich etwa 2.500 Menschen, die in der Region Estremadura (1,1 Mio. Einwohner, 41.602 km^2, 8 Krankenhäuser) an ihrer Krebserkrankung sterben.

In nur 10 Monaten wurde mit Unterstützung der neuen autonomen Gesundheitsbehörde ein palliativmedizinisches Programm entwickelt, das in die bestehenden Versorgungsstrukturen integriert werden sollte. Bereits im Januar 2003 wurden 8 Konsiliarteams eingesetzt, die sowohl in Akutkrankenhäusern arbeiteten als auch für die häusliche Versorgung in der Gemeinde zuständig waren. Von Oktober 2003 bis September 2004 wurden mehr als 1.500 Patienten im Rahmen des Palliative-Care-Programms betreut; konsiliarisch fanden mehr als 8.000 Patientenbesuche statt und wurden mehr als 10.000 Behandlungsempfehlungen ausgesprochen. In allen bestehenden Gesundheitseinrichtungen der Region wurden Fortbildungsmaßnahmen zu den Themen Palliativmedizin, Schmerzbehandlung und Symptommanagement durchgeführt.

Somit wurde in nur 11 Monaten ein auf die Region Estremadura zugeschnittenes palliativmedizinisches Versorgungsprogramm implementiert mit einer 100%igen flächendeckenden Struktur. Dies gelang durch drei wesentliche Schritte: klare Erfassung des dortigen Bedarfs, Planung unter Berücksichtigung der örtlichen Ressourcen und einen Konsens der professionell Tätigen mit den entsprechenden Gesundheitsbehörden.

Ein nationaler Plan des Gesundheitsministeriums, der im Jahr 2000 verabschiedet worden war, um die palliativmedizinische Versorgung v. a. im ambulanten Bereich voranzutreiben, hat bisher keine wesentliche Verbesserung der nationalen Situation bewirken können. Aufgrund der Dezentralisierung können die regionalen Gesundheitsbehörden ihre eigenen Prioritäten für die Versorgungsbelange in ihrem Zuständigkeitsgebiet festlegen, und da der Madrider Plan weder klare Ziel- oder Zeitvorgaben enthält und auch keine finanziellen Sonderzuwendungen vorsieht, ist er nur als Empfehlung zu verstehen [16].

1.3 Kommunikation und Ethik

Kommunikation und Ethik haben in der Palliativmedizin ihren besonderen Stellenwert durch die Herausforderungen, die entstehen, wenn ein Mensch mit seinem Lebensende konfrontiert wird [28]. Die Notwendigkeit zum offenen und wahrhaftigen Gespräch bestätigt die Studie von Meredith et al. [24]. Danach wollten von 250 befragten Krebspatienten 91% eine differenzierte Aufklärung über Diagnose, Therapie und Prognose; 97% dieser Patienten mit fortgeschrittener Tumorerkrankung wollten nicht, dass ihre Angehörigen Einfluss auf die Informationübermittlung nehmen können. Thomsen et al. [34] konnten zeigen, dass 34% der Ärzte sich grundsätzlich scheuen, Patienten über einen bösartigen Befund aufzuklären, weil Aufklärung zu einer Depression führen kann und dies die Lebensqualität möglicherweise verschlechtert [4, 34].

Diese Ergebnisse machen evident, wie eindeutig Patienten sich Offenheit wünschen und wie schwer Ärzte sich mit dieser Frage tun. Ärzte sollten in Zukunft imstande sein, den Patienten mit Empathie und Feingefühl die Konsequenzen ihrer Krankheit deutlich zu machen. Es ist nicht mit dem ärztlichen Ethos zu vereinbaren, einem schwerkranken Patienten die Möglichkeit zu nehmen, sich mit seinem bevorstehenden Lebensende auseinanderzusetzen, oder ihn »um jeden Preis« weiter zu therapieren. Der Versuch, einer Entscheidung auszuweichen, der in der medizinischen Praxis nicht selten anzutreffen ist, kann für den Patienten und seine Angehörigen folgenschwer sein. In Aufklärungsgesprächen ist immer zu berücksichtigen, welche Signale der Patient gibt, und die Herausforderung an die fachliche und soziale Kompetenz der Ärzte besteht darin, diese Signale in der rechten Weise zu berücksichtigen. Die Wahrheit am Krankenbett bedeutet keineswegs eine Ankündigung des Sterbens, sondern den Beginn eines Prozesses, der die Sinnerschließung des Sterbens zum Inhalt hat.

1.4 Organisationsformen der Palliativmedizin

Obwohl das Ziel der Hospizidee überall gleich ist, gibt es bei der Realisierung große regionale Unterschiede, was u. a. von der Struktur des Gesundheitswesens in den einzelnen Ländern abhängt. Weiterhin existieren innerhalb der verschiedenen Organisationsformen mangels einheitlicher Standards große Unterschiede in der qualitativen Umsetzung der Hospizidee und der Palliativmedizin.

Bei den Organisationsformen unterscheiden wir zwischen stationären, teilstationären und ambulanten Diensten. Die Palliativmedizin arbeitet multidisziplinär und basiert auf der Kooperation der Ärzte verschiedener Disziplinen, des Krankenpflegepersonals und anderer Berufsgruppen, die mit der ambulanten und stationären Betreuung unheilbar Kranker befaßt sind. Durch eine ganzheitliche Behandlung, Betreuung und Begleitung soll Leiden umfassend gelindert werden, um dem Patienten und seinen Angehörigen bei der Krankheitsbewältigung zu helfen und ihnen eine Verbesserung ihrer Lebenssituation zu ermöglichen. Zu den Hauptaufgaben der Palliativdienste gehören deswegen kompetente Schmerztherapie und Symptomkontrolle sowie Integration der psychischen, geistig-seelischen und sozialen Bedürfnisse der Patienten und ihrer Angehörigen.

1.4.1 Ambulante Dienste

Hausarzt und Gemeindeschwester

Terminal kranke Tumorpatienten möchten in der Regel zu Hause sterben, und selbst, wenn dies nicht möglich ist, verbringen diese Patienten die meiste Zeit ihrer letzten Lebensphase zu Hause. Es liegt nahe, dass der Hausarzt erster Ansprechpartner für den Patienten ist. Er gewährleistet die Kontinuität der Versorgung und koordiniert die verschiedenen Hilfsangebote, die der Patient benötigt. Der Hausarzt muss daher Schmerztherapie und Symptomkontrolle beherrschen, und auch die Gemeindeschwester muss die Grundprinzipien der Palliativpflege anwenden können. Gerade darin liegt aber ein Problem, denn in Deutschland hat bisher kein praktizierender Arzt während seines Studiums von den Grundprinzipien der Palliativmedizin, der Schmerztherapie, Symptomkontrolle, der Kommunikation mit Schwerstkranken und Sterbenden, der Ethik im Zusammenhang mit Sterben und Tod gehört.

Weil die Fort- und Weiterbildung der Eigeninitiative des Arztes überlassen bleibt, brauchen viele Hausärzte Unterstützung, um kompetente Hilfestellung zu geben. Statistisch gesehen versorgt jeder Hausarzt 1–2 finale Tumorpatienten pro Jahr. Daraus folgt, dass grundsätzlich nur wenig Erfahrungen in der Schmerztherapie und Symptomkontrolle vorliegen. Starke Opioide werden immer noch zu selten und zu spät verschrieben. Und wenn sie zum Einsatz kommen, wird häufig die Dosis zu niedrig gewählt, und eine Dosisanpassung an das Schmerzniveau unterbleibt [23].

Diese grundsätzliche Einschränkung in der Qualifizierung betrifft auch die Gemeindeschwestern und Mitarbeiter der Sozialstationen. Es besteht deswegen ein enormer Bedarf an Aus- und Fortbildung in Schmerztherapie, Symptomkontrolle, speziellen Verbands- und Lagerungstechniken, Gesprächsführung mit Schwerstkranken und Sterbenden sowie in der Anleitung und Stützung von Angehörigen.

Hausbetreuungsdienste – ambulante Hospizgruppen oder -initiativen

Aus der Erkenntnis dieser Defizite heraus haben sich zur Verbesserung der Situation im ambulanten Bereich Hausbetreuungsdienste entwickelt. Die Realisierung nichtspezialisierter Hausbetreuungsdienste in Deutschland wurde in den letzten Jahren überwiegend unter dem Gesichtspunkt der Ehrenamtlichkeit gesehen, da viele den Patienten und seine Angehörigen unterstützende Tätigkeiten weniger einer professionellen, sondern eher einer lebenspraktische und mitmenschlichen Kompetenz bedürfen. Ehrenamtliche werden daher nicht ausgebildet, sondern »befähigt«, d. h. von hauptamtlichen Koordinatoren angeleitet und entsprechend ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten eingeteilt. Zur Verwirklichung einer flächendeckenden Versorgung ist Ehrenamtlichkeit ein unverzichtbarer Dienst im Sinne der Hospizidee.

Weitere Hausbetreuungsdienste

Unterschieden werden ambulante Hospizdienste (AHD), ambulanter Hospiz- und PalliativBeratungsdienst (AHPD), ambulanter Hospiz- und Palliativpflegedienst (AHPP) und ambulanter Palliativdienst (APD). Die genauen Definitionen nach der Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz (BAG) und der

Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) sind umfangreich und können im Internet nachgelesen werden [6]. Generell ist für eine qualifizierte, den hohen Ansprüchen gewachsene, finanziell tragbare Hospiztätigkeit ein professionelles Kernteam mit ehrenamtlicher Unterstützung die Alternative für die Zukunft. Aufgaben eines *spezialisierten* Hausbetreuungsdienstes sind

- Überwachung der vom Hausarzt eingeleiteten Schmerztherapie und Symptomkontrolle bezüglich Wirkung, Nebenwirkung und Regelmäßigkeit,
- spezielle Palliativpflege,
- Anleitung und Qualifizierung von Familie, Freunden, Ehrenamtlichen und Sozialstationen in pflegerischen und schmerztherapeutischen Maßnahmen und Techniken,
- psychosoziale Betreuung von Patienten und Angehörigen, sozialrechtliche Beratung, Trauerbegleitung.

Das Aufgabengebiet der Ehrenamtlichen kann sehr umfangreich sein und reicht von Besuchsdiensten über praktische hauswirtschaftliche Tätigkeiten bis hin zur Sterbebegleitung. Dabei muss jederzeit berücksichtigt werden, dass die Tätigkeit der Ehrenamtlichen kein Ersatz für notwendige ärztliche oder pflegerische Hilfe sein darf und dass diese Tätigkeit professioneller Supervision unterliegen muss.

Um diesen Aufgaben gerecht zu werden, benötigt das spezialisierte Hausbetreuungsdienstteam eine intensive Fortbildung und Professionalität in der Schmerztherapie, Symptomkontrolle und Pflege sowie der psychosozialen Betreuung von Patienten und Angehörigen bzw. muss eine entsprechende Befähigung der Ehrenamtlichen sicherstellen.

- Das erklärte Ziel eines Hausbetreuungsdienstes ist es, dem Wunsch des Patienten und seiner Angehörigen nach Selbstbestimmung und Erhaltung oder Wiederherstellung von Lebensqualität so lange wie möglich im häuslichen Bereich gerecht zu werden. Grenzen werden dem Team eines Hausbetreuungsdienstes aufgezeigt, wenn Patienten z. B. einen Singlehaushalt führen und nicht auf Angehörige, Freunde oder Nachbarschaftshilfe zurückgreifen können.

In Deutschland sind in den letzten Jahren mehrere Modellprojekte, teilweise von Bundesministerien finanziert, auf den Weg gegangen. Alle Projekte,

so unterschiedlich sie auch organisiert waren, konnten nachweisen, dass die Möglichkeit, zu Hause anstatt in stationären Einrichtungen zu sterben, eindrucksvoll verbessert und gesteigert werden konnte. So stieg der Anteil der Tumorpatienten, die zu Hause starben, von bundesdurchschnittlich 30% auf mindestens 50%, in einigen Projekten auf über 80%. Diese Erkenntnisse müssen zur Konsequenz haben, dass palliativmedizinische und palliativpflegerische Expertise in die Breite getragen werden muss. Der Gesetzgeber hat durch die Ergänzung im § 39a des V. Sozialgesetzbuches einen ersten Schritt zur Verbesserung der ambulanten Versorgung gemacht, indem ambulante Hospizdienste durch die Krankenkassen unterstützt werden, wenn sie qualifizierte ehrenamtliche Sterbebegleitung erbringen und dies von palliativmedizinisch erfahrenen Pflegekräften und Ärzten fachlich verantwortet wird.

1.4.2 Tageshospize

Unter den Hospizdiensten ist das Tageshospiz in Deutschland am wenigsten vertreten. Der Palliativ- und Hospizführer »Palliativmedizin 2002« registrierte 18 Hospize und Palliativstationen, die auch Tagesbetten anboten.

Grundsätzlich können zwei Tageshospizmodelle unterschieden werden. Die einen orientieren sich mehr an der Erfüllung psychosozialer Aufgaben (Beschäftigungstherapie, Krankheitsbewältigungsstrategien, Herstellung gesellschaftlicher Kontakte). Wenige andere Zentren bieten zusätzlich ein intensives medizinisches Angebot mit kompetenter Schmerztherapie, Symptomkontrolle und Physiotherapie an. Diese Tageshospize sind in der Regel integrativer Teil eines stationären Hospizes, einer Palliativstation oder eines Hausbetreuungsdienstes. Sie fungieren gleichsam als Bindeglied zwischen ambulanten und stationären Versorgungsformen, sodass stationäre Patienten über die Tagesklinik nach Hause entlassen werden können bzw. Patienten aus der Betreuung durch einen Hausbetreuungsdienst über die Tagesklinik in die stationäre Behandlung übernommen werden können. Das Team besteht aus hauptamtlichen Mitarbeitern (Arzt, Krankenschwestern, Beschäftigungstherapeuten, Physiotherapeuten) und Ehrenamtlichen. Schwerpunkt der Arbeit ist die Rehabilitation der Patienten, die Entlastung der Angehörigen, die Verhinderung unnötiger stationärer Aufnahmen und die Verkürzung stationärer Behandlungen in Hospizen oder auf Palliativstationen zugunsten der

von den Patienten gewünschten schwerpunktmäßig häuslichen Betreuung. Da die Rehabilitation wegen der fortschreitenden Erkrankung begrenzt ist, muss das betreuende Team sensibel für die Grenzen der Belastungsfähigkeit des Patienten sein.

Die Arbeit des Tageshospizes zielt darauf ab, die Unabhängigkeit sowie das körperliche und seelische Wohlbefinden des Patienten so lange wie möglich aufrecht zu erhalten und dabei in größtmöglichem Maße seine Wünsche für die Behandlung, Betreuung und Begleitung zu respektieren.

1.4.3 Stationäre Einrichtungen

Nicht jeder hat eine Familie, und nicht jede Familie ist in der Lage, schwerstkranke Patienten im Endstadium zu pflegen und zu betreuen. Und selbst dort, wo Familienangehörige willens sind, den Erkrankten zu versorgen, scheitert die weitere Betreuung häufig an physischen und psychischen Überlastungen der Betroffenen. Indikationen für eine stationäre Behandlung sind

- eine unzureichende Symptomkontrolle (Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Dyspnoe, Verwirrtheit, Unruhe und vieles mehr);
- unzureichende Versorgung zu Hause durch Zusammenbruch oder Nichtvorhandensein eines versorgenden sozialen Netzes (Familie, Freunde, Nachbarschaft);
- psychosoziale und seelische Krisen des Patienten, die ambulant oder auf einer Allgemeinstation nicht überwunden werden können.

Hospiz

Das Wort »Hospiz« steht im weitesten Sinne für eine Bewegung und Idee. Im engeren Sinne versteht man darunter die stationäre Verwirklichung der Hospizidee in einem frei stehenden Gebäude mit eigener Infrastruktur.

Hospize machen es sich zur Aufgabe, Menschen in der letzten Phase einer unheilbaren Erkrankung zu unterstützen und zu pflegen.

Obwohl in den verschiedenen Ländern die Aufgaben und Ziele der Hospizbewegung gleich sind, unterscheidet sich die praktische Umsetzung z. T. deutlich. Dies möchte ich am Beispiel amerikanischer und britischer Hospize deutlich machen.

Aufnahmekriterien für amerikanische Hospize [35]

- Die Lebenserwartung der Patienten darf nicht über 6 Monate betragen.
- Patienten und Angehörige müssen über den terminalen Zustand aufgeklärt sein.
- Alle Hospizpatienten müssen eine pflegende Bezugsperson haben.
- Die Hospizversorgung sollte aus Kostengründen zu Hause erfolgen.
- Hospizpatienten erhalten weniger ärztliche Betreuung.

Aufnahmekriterien für britische Hospize [35]

- Patienten mit weit fortgeschrittener, fortschreitender, inkurabler Erkrankung.
- Die Aufnahme der Patienten ist nicht an die Lebenserwartung von 6 Monaten gebunden.
- Patienten und Angehörige müssen nicht über den terminalen Zustand aufgeklärt sein, wenngleich dies wünschenswert ist.
- Hospizpatienten müssen keine pflegende Bezugsperson haben.
- Hospizarbeit ist intensive Arbeit für Patienten und Angehörige, die mehr ärztliche Betreuung benötigen.

Aufnahmekriterien in Deutschland

- In Deutschland wurde eine Rahmenvereinbarung im Jahr 1998 und dann in der Fassung vom 09.02.1999 nach § 39a Satz 4 SGB V zwischen den Spitzenverbänden der Krankenkassen und der Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz sowie einigen karitativen Organisationen wie z. B. dem Arbeiterwohlfahrtsverband und dem Deutschen Roten Kreuz und anderen abgeschlossen.

In dieser Vereinbarung wird festgelegt,

- was ein stationäres Hospiz ist,
- wer Anspruch auf die Leistungen eines Hospizes hat,
- welcher Versorgungsumfang zu erbringen ist,
- welche Qualitätsanforderungen zu erfüllen sind und
- welche Vergütungsgrundsätze und Krankenleistungen zu gewährleisten sind.

Nach dieser Vereinbarung sind stationäre Hospize selbstständige Einrichtungen mit eigenständigem Versorgungsauftrag für Patienten mit unheilbaren Krankheiten in der letzten Lebensphase, bei denen **palliativmedizinische Behandlung** erbracht wird. Grundvoraussetzung für die Aufnahme in eine stationäre Hospizeinrichtung ist, dass der Patient an einer Erkrankung leidet,

- die progredient verläuft und bereits ein fortgeschrittenes Stadium erreicht hat und
- bei der eine Heilung ausgeschlossen und eine palliativmedizinische Behandlung notwendig oder vom Patienten erwünscht und
- die lediglich eine begrenzte Lebenserwartung von Wochen oder wenigen Monaten zu erwarten lässt und
- eine Krankenhausbehandlung im Sinne des § 39 SGB V nicht erforderlich ist.

Folgende Krankheitsbilder kommen für eine palliativmedizinische Behandlung in einem stationären Hospiz in Betracht:

- fortgeschrittene Krebserkrankung;
- Vollbild der Infektionskrankheit AIDS;
- Erkrankungen des Nervensystems mit unaufhaltsam fortschreitenden Lähmungen;
- Endzustände einer chronischen Nieren-, Herz-, Verdauungstrakt- oder Lungenerkrankung.

In den stationären Hospizen des Landes Nordrhein-Westfalen liegt der tagesbezogene Bedarfssatz für Pflege, Betreuung und Unterbringung zwischen 190 Euro und 240 Euro. Die Krankenkassen zahlten im Jahr 2005 einen täglichen Zuschuss nach § 39a Abs. 1 SGB V in Höhe von 144,90 Euro. Leistungen der Pflegekassen kommen aus dem Bereich SGB XI bei anerkannter Pflegebedürftigkeit dazu und betragen im Mittel ca. 50 Euro. Die Hospizträger sind per Gesetz verpflichtet, einen 10%igen Eigenanteil beizutragen.

Die Kosten für ärztliche Leistungen und Arzneimittel werden separat abgerechnet.

Diese Rahmenvereinbarung ist als großer Schritt zur Qualitätssicherung in deutschen Hospizen zu sehen. Sie sichert die qualifizierte Krankenpflege und psychosoziale und seelsorgerische Hilfe.

Wenn man berücksichtigt, dass in Hospizen schwerstkranke Patienten im Endstadium ihrer Erkrankung liegen und bekanntermaßen im Finalstadium

zahlreiche behandlungsbedürftige Symptome (Änderung der Schmerzintensität, Übelkeit, Erbrechen, Regurgitation, finales Lungenödem, Myoklonien usw.) auftreten, ist auch in den Hospizen die gesicherte 24-Stunden-Erreichbarkeit qualifizierter, unmittelbar verfügbarer Ärzte einzufordern. Über die ärztliche Präsenz in den deutschen Hospizen liegen bisher nur unzureichend gesicherte Daten vor; Kritiker haben lange Zeit deutlichen Verbesserungsbedarf gesehen. Inzwischen besteht aber Konsens darüber, dass die Anzahl ärztlich gut versorgter Hospizpatienten deutlich zugenommen hat.

Palliativstationen

Die Palliativstation ist neben dem Hospiz eine weitere Umsetzung der Hospizidee im stationären Bereich. Sie ist entweder in ein Krankenhaus integriert oder diesem angegliedert.

Die Palliativstationen können als zweite Generation der Hospizbewegung angesehen werden; sie bringen die »Hospizlichkeit« wieder zurück in Akutkrankenhäuser.

Es gibt eine Reihe von Gründen, warum Palliativstationen in Krankenhäusern etabliert werden sollten:

- Die Terminalphase nichtmaligner Erkrankungen kann nur sehr selten vorausgesagt werden. Hospize können deswegen nur ausnahmsweise Patienten aufnehmen, die keine Tumorerkrankung oder Aids-Erkrankung haben.
- Die meisten Menschen sterben heutzutage in Krankenhäusern. Hospize erreichen mit ihrer Weiterbildung und ihren Weiterbildungsprogrammen in der Regel jedoch nur diejenigen, die bereits an der Pflege und Begleitung Sterbender interessiert sind. Die Philosophie der Hospizarbeit muss als Standard für Schwerstkranke und Sterbende angesehen werden und nicht als Ausnahme. Deshalb ist es notwendig, dass die Weiterbildung dort stattfindet, wo nicht nur die meisten Menschen sterben, sondern wo sich Ärzte, Krankenschwestern, Seelsorger, Sozialarbeiter und Physiotherapeuten tagtäglich mit dem Sterben auseinandersetzen müssen.
- Viele sterbende Patienten haben medizinische und psychosoziale Probleme, die hohe fachliche Kompetenz der Behandelnden und Begleitenden erfordern.

Ärzte und das Krankenpflegepersonal sind gleichermaßen gefordert, sich fachliche Kompetenz in Schmerztherapie und Symptomkontrolle anzueig-

nen, die Grundprinzipien der Onkologie zu erlernen, sich mit den Themen Sterben, Tod und Trauer auseinanderzusetzen und über Kenntnisse in der Gesprächsführung mit schwerstkranken Tumorpatienten zu verfügen.

Um die Arbeit auf einer Palliativstation leisten zu können, müssen personelle Voraussetzungen erfüllt werden; dazu gehört im Krankenpflegebereich ein Stellenplan von 1,4 : 1 (Krankenpflege zu Patient) und einer Arztstelle für 8–10 Betten. Das interdisziplinäre Team wird ergänzt von Physiotherapeut, Sozialarbeiter, Psychologe oder Seelsorger. Hinzu kommt die Unterstützung durch Ehrenamtliche.

Voraussetzungen für ein gut funktionierendes Palliativteam sind fachliche und menschliche Qualifikationen. Ideal sind authentische Persönlichkeiten mit medizinischer und pflegerischer Kompetenz, kommunikativen, sozialen und emotionalen Kompetenzen, der Fähigkeit anzuleiten oder zu unterrichten. Regelmäßige Supervision ist aufgrund der oft physisch und seelisch sehr belastenden Arbeit unerlässlich.

Vorteile einer Palliativstation ergeben sich aus der Qualifikation und dem besonderen Personalschlüssel des Teams: Neben kompetenter Schmerztherapie und Symptomkontrolle ist bei Bedarf auch eine umfassende psychosoziale Unterstützung von Patient und Angehörigen möglich.

Vorteile gegenüber einem Hospiz ergeben sich auf einer Palliativstation aufgrund der diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten bei einer problemlosen konsiliarischen Einbindung verschiedener Fachdisziplinen.

Für den stationären Bereich in Deutschland wurde ein neues Vergütungssystem – das G-DRG-System – eingeführt. Palliativmedizinische Spezialabteilungen sind über die bisher vorhandenen DRGs allerdings nicht adäquat finanzierbar.

Palliativpatienten werden in der Regel mit nicht-palliativmedizinischen Patienten gleicher Hauptdiagnose in dieselbe DRG gruppiert, obwohl deutlich längere Verweildauern und höhere Komorbiditäts-/Komplikationslevel vorliegen. Um der vielschichtigen Symptomatik dieser Patienten begegnen zu können, ist eine komplexe, multiprofessionelle Behandlung nötig, bei der eine enge Verzahnung der beteiligten Berufsgruppen erforderlich ist. Im aktuellen DRG-System ist es nicht möglich, palliativmedizinische Patienten in homogene Kostengruppen zu fassen. Die durch die derzeit kodierbaren ICD- und OPS-Codes erreichten Erlöse führen nicht zu einer leistungsgerechten Vergütung.

Unabhängig von einer im Rahmen einer Neuregelung möglichen Finanzierung der palliativmedizinischen Leistungen im G-DRG-System ab dem

Jahr 2007 blieb auch für das letzte Übergangsjahr 2006 das Problem bestehen, dass die aktuellen Kodiermöglichkeiten eine Vergütung spezieller palliativmedizinischer Leistungen nicht zulassen. Es ist daher eine Regelung nötig, die die Finanzierung palliativmedizinischer Leistungen, auf Palliativstationen z. B. durch Anerkennung als »besondere Einrichtung«, sicherstellt.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass eine leistungsgerechte Pauschalierung palliativmedizinisch zu behandelnder Patienten innerhalb des G-DRG-Systems nicht erreicht werden wird. Vor diesem Hintergrund sollte die stationäre Palliativversorgung mittelfristig als Behandlung in einer »besonderen Einrichtung« anerkannt, aus der DRG-Finanzierung herausgenommen und in ein System der tagesbasierten Finanzierung unter Berücksichtigung der patientenindividuellen Schweregrade überführt werden. An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass unser DRG-Referenzland Australien zwischen Akut- und Subakutmedizin unterscheidet. Die Akutmedizin wird über DRGs, die Subakutmedizin wird alternativ finanziert. Die Palliativmedizin ist in Australien der Subakutmedizin zugeordnet.

Konsiliarteam

Ein in der Palliativmedizin erfahrenes Team (Arzt, Krankenschwester, Krankenpfleger, Seelsorger, Physiotherapeut) bietet seine Kenntnisse und Erfahrungen in der Schmerztherapie, Symptomkontrolle, ganzheitlichen Pflege und psychosozialen Begleitung den Allgemeinstationen eines Krankenhauses an. Der Vorteil liegt darin, dass die Grundprinzipien der Palliativmedizin einen unmittelbaren Multiplikatoreneffekt erhalten.

Ein palliativmedizinisches Konsiliarteam ist damit für die Symptomkontrolle aller terminal Kranker ansprechbar, zu einem Zeitpunkt, der weit vor der Finalphase liegen kann.

Ein Konsiliarteam kann auch zu einem sehr frühen Zeitpunkt einer unheilbaren Krankheit eingebunden werden. So kann eine palliativmedizinische Betreuung im Voraus geplant, Krisensituationen antizipativ begegnet werden.

Auf diese Weise kann Expertise sowohl in Schmerztherapie und Symptomkontrolle als auch in Belangen psychosozialer Betreuung für nicht in Palliativmedizin spezialisiertes ärztliches und pflegerisches Personal auf den Allgemeinstationen der Krankenhäuser nachhaltig vermittelt werden.

Das Konsiliarteam sollte wie in Großbritannien und Skandinavien grundsätzlich beratend sein. Hierdurch kann am besten ein Multiplikatoreneffekt

erreicht werden. Bei einigen Patienten wird aber aufgrund vor Ort nicht beherrschbarer Schmerzen, anderer Symptome oder psychosozialer Probleme eine direkte Behandlungsverantwortung des Konsiliarteams nach Absprache mit den einzelnen Stationen sinnvoll sein. Gegebenenfalls wird ein Beratungsteam auch als Vermittler zu einem Hospiz oder einer Palliativstation dienen, wenn die palliativmedizinischen Probleme auf der Allgemeinstation nicht zu lösen sind.

In Großbritannien wie in Skandinavien haben besonders diese Konsiliarteams, Hospital-Support-Teams genannt, große Multiplikatorenwirkung [12]. In Norwegen, Schweden und Frankreich sowie in den Projekten in Katalonien und Estremadura (Spanien) gibt es sehr gute Erfahrungen mit diesen Teams, auch außerhalb der Krankenhäuser, denn sie ermöglichen in diesen Ländern eine vollwertige Betreuung zu Hause auch in solchen Fällen, in denen in Deutschland stationäre palliative Behandlung benötigt wird.

1.5 Ausbildung und Standard

Der Bedarf an Palliativmedizin ist weltweit und inzwischen auch in Deutschland unbestritten. Nach zögerlichem Beginn in den 1980er Jahren begann mit den 1990er Jahren eine dynamische Entwicklung, die in Deutschland regional allerdings sehr unterschiedlich verlief und verläuft.

Aufgrund der raschen Entwicklung der Anzahl palliativmedizinischer Dienste benötigen wir zur Qualitätssicherung klar definierte Standards, auch für die Aus- und Fortbildung. In den Arbeitsgruppen der DGP wird an einer einheitlichen Festlegung gearbeitet.

In Großbritannien gilt als Standard, dass in allen Palliativeinrichtungen nur ein in der Palliativmedizin ausgebildeter Spezialist die Leitung übernehmen darf [8], und auch vom Krankenpflegepersonal wird ein hoher Standard an Training, Erfahrung und kontinuierlicher Fortbildung erwartet [8].

Im englischsprachigen Raum und Skandinavien ist man schon früh zu der Überzeugung gekommen, dass die Integration der Palliativmedizin in die Ausbildung eine unabdingbare Voraussetzung für eine zeitgemäße, humane und der Würde und Selbstbestimmung ihrer Patienten verpflichtete Disziplin ist. Alle Medizinstudenten in den klinischen Semestern werden mit den Themen der Palliativmedizin vertraut gemacht [17]. In vielen anderen Ländern setzt sich der Einzug der Palliativmedizin in die studentische Lehre fort.

In einigen Ländern [1] ist Palliativmedizin ein etabliertes Fachgebiet. Ausbildungsrichtlinien für Studenten, Ärzte, das Krankenpflegepersonal, Sozialarbeiter und Seelsorger sowie für die Weiterbildung zum Spezialisten für Palliativmedizin wurden geschaffen. In Großbritannien, Belgien, Deutschland, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Schweden und demnächst in der Schweiz gibt es an den Universitäten Lehrstühle für Palliativmedizin. Die European Association for Palliative Care (EAPC) hat ein Curriculum für Ärzte entwickelt, das inzwischen auch von verschiedenen Staaten als Lehrplan akzeptiert wird. Alle bisher bekannten Curricula legen ihre Schwerpunkte auf Grundlagenkenntnisse in der Onkologie, der kausalen Schmerztherapie, der Strahlentherapie, der chirurgischen Tumortherapie, der Krankheitsentwicklung, der pharmakologischen und interventionellen Schmerztherapie und Symptomkontrolle, der Betreuung von Patienten und Angehörigen mit psychischen, sozialen und spirituellen Problemen sowie in Kommunikationstechniken und Ethik.

In Deutschland gibt es inzwischen von der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin empfohlene Curricula für Medizinstudenten, Ärzte, Sozialarbeiter, Seelsorger und Krankenpflegekräfte. Inhalte der Weiterbildung sind: Schmerztherapie, Symptomkontrolle, konservative, interventionelle und operative Onkologie, Strahlentherapie, Ethik, Kommunikation, Sterben, Tod und Trauer, Seelsorge, Psychologie und Betreuung des therapeutischen Teams. Nach Verabschiedung der reformierten ärztlichen Approbationsordnung, die am 1. Oktober 2003 in Kraft getreten ist, wurde von der DGP ein neues Curriculum erarbeitet: Grundlagen der Palliativmedizin. Gegenstandskatalog und Lernziele für Studierende der Medizin.

Eine Ende 2001 durchgeführte Befragung an den deutschen Universitäten hatte unverkennbare Defizite in der Aus- und Fortbildung zum Ergebnis [20]:

Die Rücklaufquote war mit 94,3% sehr hoch, 33 der 35 angeschriebenen Dekanate haben den Fragebogen ausgefüllt zurückgeschickt. Nur 9% der Dekanate gaben an, einen oder mehrere Lehrbeauftragte für Palliativmedizin beschäftigt zu haben; nur an einer der Universitäten war bis dato ein Lehrstuhl eingerichtet worden. An keiner Universität wurde ein Pflichtpraktikum verlangt. Der Grund hierfür ist, dass Palliativmedizin bisher im Fächerkatalog der ärztlichen Approbationsordnung nicht vorgesehen ist. Somit enthalten die von den Fachbereichsräten der jeweiligen medizinischen Fakultät erlassenen Schulordnungen keine Pflichtveranstaltung im Fach Palliativmedizin.

Ein freiwilliges Praktikum wurde von 27% der Universitäten angeboten. Dieses Angebot wurde aber leider nur von sehr wenigen Studenten genutzt (weniger als 1%). Seminare fanden an 45% der Universitäten statt. Die Mehrheit der medizinischen Fakultäten (54,5%) bot Vorlesungen mit palliativmedizinischen Inhalten an. Eine Vorlesung explizit unter dem Namen Palliativmedizin wurde nur bei 1/3 der befragten Universitäten angeboten. An etwa 20% der Universitäten konnten Studierende einen Teil der klinischen Ausbildung im Rahmen eines Praktikums auf einer Palliativstation absolvieren. Nur 6 der Universitätskliniken hatten eine eigene Palliativstation angegliedert. Selten (6,1%) hatten die Studenten die Möglichkeit, praktische Erfahrungen in einem Hospiz zu sammeln. Am häufigsten (39,3%) wurde genannt, dass die Studenten im Rahmen eines Akutteams im Krankenhaus (z. B. palliativmedizinischer Konsiliardienst) klinische Erfahrungen sammeln konnten.

Durch die Sackler-Stiftungsprofessur für Palliativmedizin an der Universität Bonn wurde seit dem Wintersemester 1999/2000 das schon bestehende Angebot an Vorlesungen für Studenten im klinischen Abschnitt intensiviert. In das Vorlesungsverzeichnis wurde eine Vorlesung mit dem Titel »Grundzüge der Palliativmedizin« aufgenommen, in der die Schwerpunkte Schmerztherapie, Symptomkontrolle, Kommunikation und Umgang mit unheilbar Kranken referiert und diskutiert wurden. Zudem fand wöchentlich ein Seminar statt, in dem intensiv Patientenbeispiele zur Symptomkontrolle, aber auch ethische Probleme in der Palliativmedizin und das Thema Kommunikation bearbeitet wurden. Die Unterrichtsveranstaltungen richteten sich vornehmlich an Studierende des 3. klinischen Semesters.

Von den Studenten, die an diesen Veranstaltungen teilnahmen, gaben 80% an, in den anderen klinischen Fächern bisher mit diesen Themen gar nicht oder nicht ausreichend konfrontiert worden zu sein. Aus den Kommentaren der Teilnehmer war zu entnehmen, dass insbesondere die Themenbereiche Kommunikation und Ethik mit den Fragestellungen der Übermittlung schlechter Nachrichten, Betreuung der Patienten in der Finalphase sowie Probleme der Entscheidung am Ende des Lebens in anderen Vorlesungen bisher in dieser Form nicht behandelt wurden.

Mit dem Sommersemester 2004 wurde an der Universität Bonn die neue Studienordnung gültig, die die Novellierung der ärztlichen Approbationsordnung umsetzt. Palliativmedizin ist Teil des Querschnittsunterrichts der Semester 3, 5 und 6 und somit für alle Studenten in Bonn verpflichtend. Unterrichtet wird in Kleingruppen à 20 Studenten im Rahmen eines problem-

orientierten Lernens. Zusätzlich zu einer Vorlesung wird für interessierte Studenten ein Tagesseminar »Palliativmedizin – Ein Überblick« veranstaltet.

Aachen und Köln als Universitäten mit bereits etabliertem palliativmedizinischem Lehrstuhl sowie Göttingen, Jena und München – Städte, in denen demnächst Lehrstühle eingerichtet werden – haben ebenfalls Palliativmedizin im Rahmen einer Selbstverpflichtung als obligatorisches Lehr- und -prüfungsfach in ihren Fächerkanon aufgenommen.

Im hippokratischen Eid nimmt die Ausbildung des angehenden Arztes durch den erfahrenen Arzt eine zentrale Rolle ein. Die Universitäten sind demnach verpflichtet, den angehenden Ärzten Wissen, praktische Fertigkeiten sowie Werte menschlichen und ethischen Handelns zu vermitteln. Für diese Aufgaben sind die Medizinischen Fakultäten in Deutschland noch nicht ausreichend gewappnet. Selbst wenn die Entwicklung in Deutschland in der Zwischenzeit weiter vorangegangen ist, haben die Ergebnisse der Fragebogenstudie, die zeigen, dass das Unterrichtsangebot für die Studenten in Palliativmedizin unter dem internationalen Niveau liegt, auch heute noch Gültigkeit. Jede Universität sollte, wenn die Einrichtung eines Lehrstuhls nicht möglich ist, einen Lehrbeauftragten für Palliativmedizin benennen. Zudem sollte durch Einrichtung von Palliativstationen an den Universitätskliniken und Lehrkrankenhäusern Studenten die Möglichkeit gegeben werden, neben den theoretischen Kenntnissen auch praktische Erfahrungen zu sammeln.

Der aufgrund der zu erwartenden demographischen Entwicklung und der sich erhöhenden Inzidenz von Tumorerkrankungen zu erwartende größere Bedarf an Palliativmedizin ist unbestritten. Daher müssen die gesundheits- und bildungspolitisch Verantwortlichen sowie die Lehrenden der einzelnen Fachdisziplinen erkennen, dass Palliativmedizin in die ärztliche Approbationsordnung und somit in die Studienordnungen und Lehrpläne integriert werden muss.

1.6 Zukunft der Palliativmedizin in Deutschland

Die weltweit guten Erfahrungen und auch diejenigen in Deutschland zeigen den dringenden Handlungsbedarf, die Palliativmedizin in unser bestehendes Gesundheitssystem zu integrieren. Es ist nicht das Ziel der Palliativmedizin, alle Patienten, die von ihrer Expertise profitieren können, auf Palliativstationen zu betreuen, sondern ihnen die Möglichkeit zu erschließen, dort zu sterben, wo sie gelebt haben, nämlich zu Hause. Die Voraussetzung dafür zu

schaffen, ist eine wichtige Aufgabe für alle, insbesondere für die Verantwortlichen im Gesundheitssystem: die Politiker, die Kostenträger und die Ärzte.

Die Gesundheitspolitik ist gefordert, sich für eine flächendeckende palliativmedizinische Versorgung im ambulanten und stationären Bereich einzusetzen. Darüber hinaus steht sie vor der Herausforderung, Aus- und Fortbildungsprogramme für Palliativmedizin für Ärzte, Krankenpflegekräfte, Psychologen, Seelsorger, Physiotherapeuten und Sozialarbeiter zu entwickeln und durchzuführen.

In Zukunft müssen speziell alle Ärzte und Pflegekräfte als Hauptansprechpartner für Patienten die Grundlagen der Palliativmedizin anwenden können. Das bedeutet aber auch, dass alle Universitäten und Krankenpflegeschulen Palliativmedizin und Palliativpflege lehren und die Ärztekammern palliativmedizinische Fortbildungen anbieten müssen. In die Musterweiterbildungsordnung der Fachgebiete, in denen schwerstkranke und sterbende Patienten betreut werden, wurde bereits aufgenommen, dass die Ärzte sich mit den Grundprinzipien der Palliativmedizin vertraut machen müssen, und eine Subspezialisierung in Palliativmedizin ist auf den Weg gebracht worden.

Die zukünftige Finanzierung unseres Gesundheitswesens wird seit Jahren strittig diskutiert. Diesen Diskussionen kann und darf die Weiterentwicklung der Palliativmedizin nicht zum Opfer fallen. Ganz im Gegenteil, sie muss weiter gefördert werden: ideell, praktisch und finanziell. Es ist deswegen eine gerechte Verteilung der Gelder für Prävention, Früherkennung, Heilung, Nachsorge und Palliativmedizin zu fordern. Palliativmedizin ist nicht billig, aber preiswert. Die gegenwärtigen Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherungen für die Palliativmedizin betragen 0,003% ihrer Gesamtausgaben. Für eine flächendeckende Versorgung sind ca. 0,5% der Ausgaben notwendig, wie eine Hochrechnung ergeben hat [19, 25].

Der Erfolg der Palliativmedizin wird sich nicht nur messen lassen an

- der Anzahl von Palliativstationen,
- der Anzahl von Palliativärzten und Pflegekräften,
- der Verbesserung der Symptomkontrolle und
- dem Anstieg der Opioidverschreibung.

Wir werden dann von einem Erfolg der Palliativmedizin sprechen, wenn

- in jeder Stadt ein leichter Zugang zur Palliativmedizin besteht,
- jeder Arzt und jede Krankenpflegekraft die Grundprinzipien der Palliativmedizin anwendet und

- jede medizinische Fakultät und jede Krankenpflegeschule Palliativmedizin lehrt
- und wenn sterbende und schwerstkranke Patienten dort behandelt, betreut und begleitet werden können, wo sie es wünschen.

Palliativmedizin strebt die bestmögliche Lebensqualität in der verbleibenden Zeit an. Dies zu erreichen sollte eine Aufgabe für alle sein.
Die Weiterentwicklung der Palliativmedizin fände nur sehr langsam statt, wenn die Zeit dafür nicht reif wäre. Die rapide Zunahme der Hospizinitiativen, Palliativstationen, Hausbetreuungsdienste und Fortbildungsveranstaltungen in Deutschland und die massive Entwicklung dieses Fachgebiets auf internationaler Ebene zeigen uns, dass nach zögerlichem Beginn eine starke Dynamik entstanden ist. Es ist nicht nur eine ethisch gebotene, sondern auch eine in der Sache begründete Aufgabe des etablierten Gesundheitswesens, seine Prioritäten zu ändern, damit ein Höchstmaß an Qualität für die zu behandelnden Patienten gesichert werden kann. Nach den Entwicklungen der letzten Jahre, in denen sich Vertreter aller Akteure im Gesundheitswesen wie auch Gremien auf höchster politischer Ebene der Förderung von Hospizarbeit und Palliativmedizin gegenüber zunehmend aufgeschlossen zeigen, wird eine ausreichende Finanzierung zwar nicht sofort und nicht überall verwirklicht werden, aber die Einsicht in die Notwendigkeit wird sie auf Dauer ermöglichen.

1.7 Abschließende Bewertung

Die Entwicklung der Palliativmedizin war in Deutschland in den 1980er Jahren durch extreme Zurückhaltung gekennzeichnet. Von 1983 bis 1990 stieg die Anzahl der Palliativstationen gerade nur von 1 auf 3. Die 1990er Jahre sind durch eine deutliche Dynamisierung gekennzeichnet. Im Januar 2006 war die Anzahl der Palliativstationen auf 116 angestiegen. Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin wurde 1994 gegründet und hat inzwischen 6 große nationale Kongresse veranstaltet. Curricula gibt es für fast alle in der Palliativmedizin involvierten Berufsgruppen, und 1999 wurde der erste Professor für Palliativmedizin an die Universität Bonn berufen.

Die Palliativstationen haben eindrucksvoll neue Maßstäbe in der Betreuung und Versorgung schwerstkranker Tumorpatienten gesetzt, so in der Pflege, der Schmerztherapie und der Symptomkontrolle.

Sie versuchen durch einen ganzheitlichen Behandlungsansatz im multidisziplinären Team Leiden umfassend zu lindern und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.

Der Bedarf an Palliativmedizin ist groß, und er wird weiter steigen. Der demographische Wandel wird auch zur Folge haben, dass der Anteil unheilbarer Tumorpatienten weiter zunehmen wird.

Obwohl in den letzten Jahren viele neue Palliativstationen und Hospize eröffnet worden sind, wird auch in Zukunft nur eine relativ kleine Anzahl von Tumorpatienten dort versorgt werden können.

Darüber hinaus haben wir Patienten mit Aids oder anderen Erkrankungen im Terminalstadium, die das gleiche Ausmaß an Umsorgung, Pflege und Begleitung wie die Tumorpatienten benötigen.

Die Lösung des Problems fordert deswegen beides, nämlich sowohl den flächendeckenden Aufbau palliativmedizinischer und hospizlicher Dienste, v. a. im ambulanten Bereich, als auch die Aus- und Fortbildung von Studenten, Ärzten, Krankenschwestern und allen anderen professionellen Mitgliedern multidisziplinärer Teams.

Mit besonderem Nachdruck wenden wir uns auch an die Entscheidungsträger in Politik und Gesundheitswesen: Wenn nur ein Teil der Empfehlungen, die die Enquete-Kommission Ethik und Recht der modernen Medizin in ihrem Bericht »Palliativmedizin und Hospizarbeit« vom 22.06.2005 ausgesprochen hat, umgesetzt würde, wäre dies ein großer Schritt in die richtige Richtung.

Literatur

1. Association for Palliative Medicine of Great Britain and Ireland (1992) Palliative medicine curriculum. The Association for Palliative Medicine. Southampton
2. Baumgartner J, Hospiz Österreich, telefonische Umfrage, Stand 03/03
3. Beardsley TA (1994) A war not won. Trends in cancer epidemiology. Sci Am 270: 130–138
4. Buckman R (1996) Talking to patients about cancer. No excuse for not doing it. BMJ 313: 699–700
5. Clark D (1994) At the crossroads: which direction for the hospices? Palliat Med 8: 1–3
6. Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin (2005): Definitionen unter http://dgpalliativmedizin.de/sn/SN%2031031%20DGP-Definitionen.pdf
7. Deutscher Bundestag, Enquete-Kommission Ethik und Recht der modernen Medizin (2005) Verbesserung der Versorgung Schwerstkranker und Sterbender durch Palliativmedizin und Hospizarbeit. Drucksache 15/5858; Download unter http://www.bundestag.

de/parlament/kommissionen/archiv15/ethik_med/berichte_stellg/05_06_22_zwischenbericht_palliativmedizin.pdf
8. Doyle D (1994) Standards und Ausbildung in der Palliativmedizin. In: Klaschik E, Nauck F (Hrsg) Palliativmedizin heute. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokio
9. Doyle D, Hanks GWC, MacDonald N (1998) Oxford Textbook of Palliative Medicine. Oxford Univ Press, Oxford
10. Engeland A, Haldorsen T, Tretli S, Hakulinen T, Hörte LG, Luostarinen T (1993) Prediction of cancer incidence in the Nordic countries up to the years 2000 and 2010. APMIS 101 (Suppl 38)
11. Europäische Gesellschaft für Palliativmedizin (EAPC), Website; Informationen unter: http://www.eapcnet.org/about/about.html
12. Eve A, Smith AM (1994) Palliative care services in Britain and Ireland – update 1991. Palliat Med 8: 19–27
13. Hartenstein R (1996) Palliativmedizin aus der Sicht des Internisten. In: Klaschik E, Nauck F (Hrsg) Palliativmedizin – Bestandteil interdisziplinären Handelns. Pmi, Frankfurt am Main
14. Hospice Information (2005); Angaben über nationale Daten unter http://www.hospiceinformation.info/docs/summary_uk_services_2005.pdf
15. House of Commons. Health Committee (2004): Palliative Care. Fourth Report of Session 2003-4. Volume I. Report, together with formal minutes. Ordered by the House of Commons to be printed by 14 July 2004. HC 454-I. Published on 22 July 2004 by authority of the House of Commons. London: The Stationery Office Limited
16. Jaspers B, Schindler T (2004) Stand der Palliativmedizin und Hospizarbeit in Deutschland und im Vergleich zu ausgewählten Staaten (Belgien, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien), erstellt im Auftrag der Enquete-Kommission »Ethik und Recht der modernen Medizin« des Deutschen Bundestags, 15. Legislaturperiode, http://www.bundestag.de/parlament/kommissionen/archiv15/ethik_med/gutachten/gutachten02_palliativmedizin.pdf
17. Kern M, Müller M, Aurnhammer A (1996) Basiscurriculum »Palliative Care«. Schriftenreihe der Ansprechstellen des Landes NRW zur Pflege Sterbender, Hospizarbeit und Angehörigenbegleitung. Bonn Münster
18. Klaschik E, Nauck F (1993) Erfahrungen einer Palliativstation. Dtsch Ärztebl 90/48 A 1: 3226–3230
19. Klaschik E, Nauck F, Ostgathe C, Hoffmann-Menzel H (2002) Palliativmedizin – Eine ärztliche Verpflichtung. Anaesthesiol Reanimat 27: 86–74
20. Klaschik E, Ostgathe C, Nauck F (2002) Defizite in der studentischen Ausbildung. Durch die Einrichtung von weiteren Palliativstationen an den Universitätskliniken sollte Studierenden die Möglichkeit gegeben werden, neben theoretischen Kenntnissen auch praktische Erfahrungen zu sammeln. Dtsch Ärztebl 99: A 1286–1288
21. Kübler-Ross E (1969) On death and dying. Tavistock, London
22. Kuch C, Ebner E, Köck C (2000) Hospiz Evaluierungsstudie. Endbericht. Wien
23. Lindena G, Müller S, Zenz T (1994) Opioidverschreibung durch niedergelassene Ärzte. Schmerz 8: 228–234
24. Meredith C, Symonds P, Webster L, Lamont D, Pyper E, Gillis CR, Fallowfield L (1996) Information needs of cancer patients in West Scotland: cross sectional survey of patients view. BMJ 313: 724–726

25. Müller-Busch HC, Andres I, Jehser T (2001) Wieviele Palliativstationen und Hospize brauchen wir in Deutschland? Z Palliativmed 2: 16–19
26. Nauck F (2002) Hospizarbeit und Palliativmedizin: Europäischer Ausblick: In: Aulbert E, Klaschik E,Kettler D (Hrsg) Palliativmedizin – Ausdruck gesellschaftlicher Verantwortung. Beiträge zur Palliativmedizin, Bd 5, unter Mitarbeit von Dietmar Beck. Schattauer, Stuttgart, S 3–14
27. ÖBIG (2000) Österreichischer Krankenanstalten- und Großgeräteplan 2001. Bundesministerium für soziale Sicherheit und Gesundheit. Wien
28. Randall F, Downie RS (1996) Palliative care ethics. Oxford Medical Publications, Oxford
29. Sabatowski R, Radbruch L, Müller M, Nauck F, Zernikow B (2003) Hospiz- und Palliativführer 2003. Stationäre und ambulante Palliativ- und Hospizeinrichtungen in Deutschland. MediMedia Neu-Isenburg
30. Saunders C (1981) Hospice: the living idea. Arnold, London
31. Schara J (1988) Gedanken zur Behandlung terminal Kranker mit Krebsschmerz. Schmerz 2: 151–160
32. Statistisches Bundesamt (2002) Todesursachen 2000.
33. Stjernswärd J, Teoh N (1990) Palliative care – a WHO-priority. Palliat Med 4: 71–72
34. Thomsen O, Wulff HR, Martin A (1993) What do gastroenterologists in Europe tell cancer patients? Lancet 341: 473–475
35. Twycross R (1990) Terminal care of cancer patients: Hospice and home care. In: Bonica JJ (ed) The management of pain. Lea & Febiger, Philadelphia London
36. Woodruff R (1993) Palliative medicine. Asperula, Melbourne
37. Zech D (1994) Entwicklung der Palliativmedizin in Deutschland. In: Klaschik E, Nauck F (Hrsg) Palliativmedizin heute. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokio

2 Ethik

S. Husebø

Die für uns wichtigen Aspekte der Dinge sind durch ihre
Einfachheit und Alltäglichkeit verborgen –
man kann es nicht bemerken, weil man es immer vor Augen hat.
Die eigentlichen Grundlagen seiner Forschung fallen
dem Menschen gar nicht auf.
(Ludwig Wittgenstein)

2.1 Autonomie oder Paternalismus?

Wie alles menschliche Handeln ist auch und gerade das Tun des Arztes ethischen, d. h. sittlichen Wertungen unterworfen. Diese führen zu gewichtigen Fragen, über die in der Medizin nur selten gesprochen wird, wie z. B.:

- Wann beginnt das Leben?
- Wann ist eine Therapie zu beenden?
- Wo verläuft die Grenze zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe?
- Müssen lebensbedrohliche Komplikationen immer behandelt werden?

Es gibt aber auch alltägliche, scheinbar unbedeutende Fragen ethischer Art, die für einen Patienten wichtig sein können:

- Wie kann ich mir ein Bild von den Bedürfnissen eines Patienten machen, damit ich diesen in bestmöglicher Weise gerecht werden kann?
- Wie vorsichtig und wie deutlich muss ich bei der Aufklärung sein?
- Kann es sein, dass die Informationen, die ich dem Patienten gebe, so kompliziert sind, dass sie mehr Unsicherheit und Verwirrung hervorrufen, als dass sie zur Klarheit beitragen?

Von großer Bedeutung für die Kommunikation zwischen dem Arzt und seinem Patienten sind oft Kleinigkeiten während der ersten Begegnung, die aber in entscheidender Weise mitbestimmen, ob das zukünftige Verhältnis zwischen beiden durch Bereitschaft und Offenheit oder durch Ablehnung

und Gleichgültigkeit geprägt ist. Das Verhalten des Arztes wird vom Kranken aufmerksam registriert:

- Hat er herzlich und offen gegrüßt?
- Wie war der Händedruck?
- Hat der Arzt ein Interesse daran, Näheres über mich, meine Herkunft, meine Interessen zu erfahren?
- Hat er sich hingesetzt?
- Hat er mir in die Augen gesehen?
- Hat er Pausen gemacht, um mir zu erlauben, Fragen zu stellen, die für mich wichtig sind?
- Worüber wurde bei der Visite nicht gesprochen?

Für die Zukunft des Patienten und für das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient ist es von entscheidender Bedeutung, wie diese und ähnliche Fragen beantwortet werden (Randall u. Downie 1996). Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, sollte der Arzt während seines Studiums mit den elementaren Fragen der Kommunikation vertraut gemacht werden.

Wohl wäre es wünschenswert, wenn jeder Arzt während seines Studiums eine Unterweisung für den Umgang mit Patienten bekäme. Noch wichtiger wäre es freilich, mehr über seine eigenen persönlichen Stärken und Schwächen im Umgang mit anderen Menschen zu erfahren, um Unzulänglichkeiten in der Ausübung seines Berufes berücksichtigen zu können (Fallowfield 1997).

Das gilt vor allem für die in der Palliativmedizin tätigen Ärzte, da deren Tätigkeit über das Medizinisch-Fachliche hinaus eine besondere Aufgeschlossenheit für ethische Fragen erfordert. Es ist nicht möglich, sich ohne ethische Einstellung mit schwerkranken Patienten zu beschäftigen und dies immer wieder neu zu überdenken.

Der Tod ist seit jeher eine Herausforderung für den Menschen. Wer täglich mit dem Tod in Berührung kommt, gewinnt eine bewusstere Haltung zum Leben und zu religiösen, ethischen und moralischen Fragen.

Die Ethik der Palliativmedizin beschränkt sich dabei keineswegs nur auf Fragen des Sterbens. Sie ist immer durch eine intensive Auseinandersetzung mit dem Alltagsleben gekennzeichnet (Randall u. Downie 1996):

- Es geht um das Leben der Patienten, die bei fortschreitender Krankheit die ihnen verbleibende Zeit zu gestalten haben.

- Es geht um die Angehörigen der Patienten, denen eine Lebenswende bevorsteht; es geht darum, wie sie mit ihren Gedanken, Gefühlen und praktischen Problemen am besten fertig werden.
- Und es geht um den Arzt, der immer wieder mit der bedrückenden Tatsache konfrontiert wird, dass ein Patient nicht geheilt werden kann und in seiner Gegenwart eine schwere Zeit durchlebt.
- Schließlich geht es um die anderen Berufsgruppen, die es sich zur Aufgabe gesetzt haben, schwerkranke Patienten zu betreuen und zu behandeln.

Alle werden von einer solchen Begegnung mit dem Sterben und dem Tod beeinflusst und zum Nachdenken angeregt.

2.1.1 Ethik und Moral

Bevor näher auf ethische Fragen des medizinischen Alltags eingegangen wird, sei ein kurzer Blick auf die Begriffe »Ethik« und »Moral« geworfen.

Während unter »Moral« die sittliche Grundhaltung eines Einzelnen, einer Gruppe, einer Zeitperiode verstanden werden kann, beschäftigt sich die »Ethik« u. a. mit der Suche nach allgemeingültigen Antworten auf die Frage: »Was ist ein gutes Leben?« Daraus ensteht für das Gesundheitswesen die Frage: »Wie können wir ein gutes Leben für unsere Patienten fördern und eine so gut wie mögliche Lebensqualität für sie aufrechterhalten?«

Die moralischen Vorstellungen eines Menschen sind aus seinem kulturellen und gesellschaftlichen Umfeld erwachsen. Sie bestimmen sein Alltagsleben, seinen Umgang mit seiner Familie und anderen Menschen. Auch das Wirken medizinischer Berufsgruppen und das verantwortliche Handeln der Ärzte wird von bestimmten moralischen Regeln geprägt. Diesen Regeln fehlt aber das Merkmal der Allgemeingültigkeit. Um solche allgemeingültigen Einsichten und Bewertungsmaßstäbe für das menschliche Handeln bemüht sich die Ethik seit den Zeiten der großen Philosophen Sokrates, Platon und Aristoteles, denen auch der Arzt Hippokrates beizuordnen ist, bis auf den heutigen Tag.

Ethik darf dabei keineswegs als etwas Theoretisches betrachtet werden, als etwas, das den Philosophen und Weisen zu überlassen sei. Ethische Fragen und Probleme sind wichtig für uns alle; sie begegnen uns zahlreiche Male an jedem Tag, ohne dass wir uns dessen bewusst werden. Der folgende Text des

zeitgenössischen dänischen Moralphilosophen Lögstrup drückt sehr deutlich aus, wie entscheidend ethisches Denken und Handeln im Alltag für uns und unseren Nächsten sein kann:

> Der Einzelne hat niemals mit einem anderen Menschen zu tun, ohne dass er etwas von dessen Leben in seiner Hand hält. Es mag wenig sein: eine vorübergehende Stimmung, eine Heiterkeit, die man erstickt oder erweckt; ein Leiden, das vertieft oder gelindert wird. Aber es kann auch unendlich viel sein, sodass der Einzelne es in seiner Hand hat, ob das Leben des Anderen gelingt oder nicht gelingt.
> (Lögstrup 1989)

Dass auch und gerade der Arzt »es in seiner Hand hat, ob das Leben des Anderen gelingt oder nicht gelingt«, braucht nicht besonders betont zu werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Bedenken der ethischen Probleme innerhalb des medizinischen Fachgebietes, die medizinische Ethik, auf das Engste verknüpft ist mit Entscheidungen über die Anwendungen medizinisch-fachlicher Kenntnisse und Mittel. Das zeigt sich besonders, wenn es um Fragen geht, deren Beantwortung über Leben und Tod entscheidet. Die diese Antwort tragende medizinisch-ethische Grundhaltung ist von zentraler und allgemeiner Bedeutung für den Arzt, den Patienten, die Angehörigen und die Gesellschaft.

Bevor wir anhand einiger Beispiele medizinisch-ethische Fragen erörtern, erscheint es sinnvoll, zwei Hauptrichtungen in der neuzeitlichen Ethik kurz vorzustellen. Sie sind durch die Namen Immanuel Kant (1724–1804) und John Stuart Mill (1806–1873) gekennzeichnet. Kant, der sich in seinem Werk »Kritik der praktischen Vernunft« grundlegend zu ethischen Fragen äußert, sieht moralisches Handeln an das Gesetz des »kategorischen Imperativs« gebunden:

»Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte.«

Die Pflicht, dem kategorischen Imperativ gemäß zu handeln, hat einen absoluten Charakter. Nicht Nutzen oder Schaden einer Tat entscheiden über ihre sittliche Qualität, sondern die Überzeugung des Handelnden, dass sein Tun grundsätzlich von allen Menschen so vollzogen werden kann und soll.

Dieser »Pflichtethik« steht die aus dem Utilitarismus des 19. Jahrhunderts hervorgegangene, vor allem durch Mill vertretene »Konsequenzethik« gegen-

über. Sie fordert ein Handeln, das durch den Gedanken an den Nutzen eines Einzelnen, einer Gruppe, der Menschheit bestimmt wird. Bei anstehenden Problemen ist die Lösung zu bevorzugen, die so viel Gutes bzw. so wenig Schlechtes wie möglich für *alle* verspricht.

Das unterschiedliche Denken beider ethischen Richtungen hat natürlich auch die medizinische Ethik beeinflusst. Die konventionelle medizinische Denkweise war wohl durchgängig von der Pflichtethik bestimmt. Der Arzt verfügte über das notwendige Wissen und Können. Er setzte es nach bestem Wissen ganz im Interesse des Patienten ein, ohne diesen an seinen Entscheidungen zu beteiligen.

Eine Einflussnahme der Konsequenzethik auf das medizinisch-ethische Denken zeigt sich heute daran, dass dem Patienten ein Recht auf Entscheidung bzw. Mitentscheidung bei ärztlichen Maßnahmen eingeräumt ist. An Stelle des an den Arzt gerichteten »Du sollst…!« ist ein Prozess gemeinsamen Überlegens getreten, eines gemeinsamen Erwägens der Fragen, was unter den vorhandenen Möglichkeiten gut oder schlecht, nützlich oder weniger gut sei.

Das Gemeinte wird an einem Beispiel aus der Praxis deutlich:

Beispiel aus der Praxis

Eine Frau, Mitte 60, hatte mich rufen lassen. Es ging um ihre Schmerzen, aber auch um ihren bevorstehenden Tod. Ihr Zustand war von fortgeschrittener Metastasierung geprägt. Sie war bettlägerig und konnte keine Nahrung mehr behalten. Schließlich fragte sie: »Wie lange noch?« Wir hatten uns wiederholt über diese Frage unterhalten; sie hatte nach allen Erfahrungen nur noch Tage zu leben, und es schien ihr wichtig, eine offene Antwort zu bekommen. Ich machte ihr vorsichtig klar, dass ihr aller Wahrscheinlichkeit nach nur noch kurze Zeit bliebe, vielleicht Wochen, vielleicht Tage nur. Sie nahm es gefasst auf. Ihr Mann war vor Jahren gestorben. Ich fragte nach den Kindern. Ihre Tochter war Schauspielerin. Sie hatte die Mutter im Krankenhaus noch nicht besucht. Sie sei beschäftigt, sagte die Mutter; in der nächsten Woche gebe es eine Premiere.

Ich fragte, ob ich die Tochter anrufen dürfe. Das wollte die Mutter nicht. Das Gespräch ging zu Ende; ich versprach, am nächsten Tag wiederzukommen. Als ich davonging, dachte ich über die Autonomie der Patientin nach. Es war ihr eindeutiger Wunsch, dass ich ihre Tochter nicht anrufen sollte. Auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, dass diese Tochter sehr viel für die Mutter bedeutete und dass diese die Tochter vor ihrem bevorstehenden Tod schützen

wollte. Alle meine Gefühle und Instinkte sagten mir, dass es eine Unterlassungssünde sei, sie nicht anzurufen. Was tun?

Ich ging zurück, setzte mich hin und sagte: »Ich habe ein Problem. Ich muss deine Tochter anrufen. Ich glaube, sie würde mir nie verzeihen, wenn sie erfährt, dass du nicht mehr am Leben bist und sie keine Nachricht bekommen hat, damit sie dich noch rechtzeitig besuchen konnte. Sie muss selbst entscheiden, ob sie kommen kann oder nicht.« Dabei betrachtete ich die Mutter aufmerksam. Sie schwieg. Aber in den Augen war deutlich eine Erleichterung zu erkennen, dass die Entscheidung von ihren Schultern genommen war. Die Tochter kam auch; beide erlebten wichtige Tage zusammen, bevor die Mutter starb. Die Tochter hat wiederholt ihre Dankbarkeit dafür ausgedrückt, dass sie angerufen wurde.

Dieses Beispiel zeigt, wie schwer es ist zu wissen, was die Patienten mit ihren Aussagen ausdrücken wollen, weil unsere Sprache begrenzt ist und weil wir nicht in der Lage sind, im Voraus zu wissen, wie wir uns ausdrücken müssen, damit unser Zuhörer das versteht, was wir verstanden wissen wollen.

Ich hatte das Gefühl gehabt, dass die Mutter etwas anderes zum Ausdruck bringen wollte als das, was sie sagte – etwa: »Ich liebe meine Tochter. Ich möchte sie schützen vor meinem Tod. Es ist für mich schwierig zu sterben. Ich brauche jetzt Hilfe. Bitte nimm mich ernst und versuche zu verstehen, was mich bedrückt.«

Der Verlauf dieser Geschichte hätte aber auch ein anderer sein können. Die Mutter hätte mir wiederholt und eindeutig verbieten können anzurufen. Oder die Beziehung zu ihrer Tochter oder die Beziehung der Tochter zur Mutter hätten gestört sein können. Nur ein ausführliches Gespräch und häufiger gestellte Fragen können klären, welche guten oder welche schlechten Konsequenzen eine bestimmte Intervention haben kann.

Kommunikation findet immer zwischen mehreren Menschen statt. Nur durch gegenseitiges Vertrauen, Zuhören, Beobachten, Fragen, Wiederholen und Probieren kann Kommunikation gelingen. Ohne Kommunikation ist das Recht auf Entscheidung bzw. Mitentscheidung des Patienten nicht mehr wert als Druckerschwärze auf dem Papier.

Im Gespräch mit der Mutter taten sich zwei gleich schwer zu bewältigende Möglichkeiten auf (ein echtes »Dilemma«). Welche Entscheidung war in ihrer Situation die richtige? Die Mutter selbst wusste es nicht.

Die Situation, dass ein Patient oder seine Angehörigen andere Perspektiven entwickeln oder andere Prioritäten setzen als der Arzt, kommt häufig vor. Worauf aber gründen sich in solchen Fällen die Entscheidungen des Arztes?

Bevor wir diese Frage zu klären versuchen, ist es erforderlich, einige Begriffe zu definieren:

- **Autonomie:** Das Recht des Patienten, selbst Entscheidungen zu treffen.
- **Paternalismus:** Die Haltung des Arztes, der für einen Patienten eine Entscheidung trifft, da er aufgrund seiner besseren Einsichten weiß, was in einer bestimmten Situation für diesen das Beste ist.
- **»Weicher« Paternalismus:** Der Patient wird vor unmöglichen Entscheidungen geschützt.
- **Informiertes Einverständnis** (»informed consent«) bedeutet, dass der Patient nicht einer Behandlung oder einem wissenschaftlichen Experiment ausgesetzt werden kann, ohne vorher
  - ausreichende Information über die Diagnostik, die Behandlung und deren Konsequenzen erhalten zu haben,
  - vor der Behandlung ausdrücklich und freiwillig »Ja« zu der vorgeschlagenen Therapie gesagt zu haben.

Die Autonomie des Patienten, sein Recht auf Selbstbestimmung, spielt heute in der medizinischen Ethik eine entscheidende Rolle (Eser et al. 1992; Tranöy 1992). Das war keineswegs immer so. Bis etwa 1970 war es normal, dass der Arzt oft ohne vorherige Rücksprache mit dem Patienten wichtige Entscheidungen über Therapie und Operation völlig selbstständig traf (Paternalismus). Es stellt sich nun aber die Frage, ob es immer gut ist, wenn der Patient entscheidet oder mitentscheidet. Wird er nicht häufig vor Fragen gestellt, die er nicht beantworten kann? Ist er nicht überfordert, wenn er über die Anwendung ärztlicher Maßnahmen entscheiden soll, deren Voraussetzungen und Konsequenzen er einfach nicht überblickt?

2.1.2 Der Helfer muss zuerst knien vor dem, dem er helfen möchte

Es ist für den Arzt keine leichte Aufgabe, die Meinungen des Patienten zu respektieren. Aber wie zeigt man diesen Respekt? Im Falle der oben beschriebenen Patientin bestand die Aufgabe darin, nicht nur zu hören, was die

Patientin sagte, sondern auch zu ergründen, was sie noch nicht aussprechen konnte, ihr durch Zuhören und Hinterfragen die Möglichkeit zu geben, das Unausgesprochene doch zu sagen.

Der aufmerksame Arzt wird sich in solchen Situationen zwei Fragen stellen:

- Welches anstehende Problem gilt es zu verdeutlichen?
- Wie gebe ich dem Patienten am besten die Möglichkeit, das Problem zu erfassen und die richtigen Entscheidungen zu treffen?

Der Arzt hat dabei alles in seiner Hand. Er kann sich dafür entscheiden, den Patienten offen, verständlich und vollständig zu informieren. Er kann einen Teil der wichtigen Informationen zurückhalten, oder er kann, was häufiger vorkommt, die Information in eine für den Patienten unverständliche Fachsprache fassen (Fallowfield 1997). Er kann den Patienten auf den Weg zu einer freien Entscheidung bringen, indem er seinen Darlegungen etwa hinzufügt: »Ich möchte versichern, dass Sie, unabhängig davon, für welche der möglichen Alternativen Sie sich entscheiden, meiner vorbehaltlosen und vollen Unterstützung gewiss sein können.«

Der Arzt kann aber auch, wenn er davon überzeugt ist, dass er eine oder mehrere der angebotenen Alternativen mit seiner Überzeugung nicht vereinbaren kann, dem »kategorischen Imperativ« folgen und die Entscheidung des Patienten in seinem Sinne massiv beeinflussen, indem er etwa ausführt: »Bitte sehen Sie ein, dass die von Ihnen erwogene Behandlung eine Reihe von für Sie sehr unangenehmen Nebenwirkungen nach sich ziehen wird, ohne dass wir die geringste Gewissheit haben, dass sie Ihre Krankheit positiv beeinflussen könnte.«

Sollte der Patient weiterhin die ärztlicherseits vorgeschlagene alternative Behandlungsmöglichkeit ablehnen, bleibt dem Arzt, was nicht selten vorkommt, als letzte Möglichkeit sich durchzusetzen, die Drohung mit der Aufgabe der Betreuung: »Bitte sehen Sie ein, dass ich unmöglich die Verantwortung für Ihre Behandlung weiterhin übernehmen kann. Falls Sie auf der nach meiner Auffassung nicht vertretbaren Behandlung bestehen, müssen Sie sich einen anderen Arzt suchen.«(Callahan 1991)

Es ist einleuchtend, dass eine solche »Lösung« für beide Seiten unbefriedigend wäre. Sie ist, von Ausnahmen abgesehen, vermeidbar, wenn dem Prinzip des informierten Einverständnisses (»informed consent«) Geltung verschafft wird. Das Recht des Patienten auf Information ist zu respektieren.

Es schließt auch das Recht ein, unangenehme Fragen zu stellen und ggf. eine vorgeschlagene Therapie abzulehnen. Für den Arzt, der das Beste für den Kranken will und dessen Handeln durch eine auf Fachkompetenz beruhende Verantwortlichkeit bestimmt ist, kommt es dann darauf an, im Gespräch dem Patienten ein Gefühl der Geborgenheit zu vermitteln und durch ausgiebige Information eine Entscheidung herbeizuführen, die keine negativen Konsequenzen für das beiderseitige Verhältnis hat.

Das Recht des Patienten auf Selbstbestimmung findet da seine Grenze, wo dieser eine Behandlung fordert, die nach Kenntnis des Arztes keinerlei Einfluss auf den Verlauf der Krankheit hat, möglicherweise sogar zu lebensbedrohlichen Folgen führt. An seine Stelle sollte dann sinnvollerweise die auf Vertrauen und Information gegründete Mitbestimmung des Patienten treten.

Ihre Handhabung und ihre Problematik sei an einem angenommenen Beispiel verdeutlicht: Ein Patient, der so unter einer fortgeschrittenen Krankheit leidet, dass er das Leben für unerträglich hält, bittet den Arzt, ihm durch Verabreichung einer Überdosis an Medikamenten weiteres Leiden zu ersparen. Es ist eine Bitte um aktive Sterbehilfe.

Viele Ärzte werden in aller Bestimmtheit diese Bitte ablehnen; für sie gilt diesbezüglich der »kategorische Imperativ«. Ein Arzt kann aber auch, anstatt die Bitte kategorisch abzulehnen, versuchen, mit großer Geduld die tieferen Gründe für den Wunsch des Patienten, sein Leben zu beenden, zu erfahren.

In dieser Alternative spiegelt sich der oben aufgezeigte Gegensatz der durch Kant und Mill vertretenen ethischen Auffassungen. Nach Kant muss der Wunsch des Patienten kategorisch abgelehnt werden, weil er gegen eines der grundlegenden ethischen Gesetze verstößt: Du sollst nicht töten. Nach Mill hätte der Arzt zu fragen, was dem Patienten den größten Nutzen bringe. Bei ihm stehen Fragen, die das Wohlergehen des Patienten betreffen, im Vordergrund: Was kann ich Gutes für den Patienten tun? Wie kann ich die Hintergründe für seine Ängste und sein Leiden besser verstehen? Die Nutzethik (Mill) würde hinterfragen, welchen Nutzen der Patient – andere Patienten – der Arzt – die Gesellschaft bei der einen oder anderen Entscheidung haben. Dabei stellt sich wieder die Frage, ob die von uns vorgezogene Handlung wirklich im Interesse des Patienten liegt.

Die beiden ethischen Grundhaltungen stehen seit jeher in einem scharfen Gegensatz zueinander; wir müssen uns mit beiden Richtungen auseinander-

setzen. Es gibt einerseits moralische Grenzen unseres Handels, die in jedem Fall zu beachten sind. Andererseits müssen wir aufgeschlossen sein für alles, was für den Patienten von Nutzen sein könnte.

Es liegt in der Hand des Arztes, Entscheidungen der Patienten und ihrer Angehörigen durch Information, Desinformation oder deren Unterlassung zu manipulieren; d. h. damit wird er in der Regel die Antwort bekommen, die er hören möchte. Es ist dann eine auf seine Verantwortung und Fachkompetenz gegründete Entscheidung: Paternalismus.

Paternalismus ist manchmal notwendig. Wenn etwa ein Schwerverletzter ins Krankenhaus eingeliefert wird und lebensrettende Maßnahmen innerhalb von Minuten eingeleitet werden müssen, bleibt kaum Zeit für Information und Debatte mit Patient oder Angehörigen. Sie müssen uns vertrauen, und es ist die Aufgabe des Arztes, diesem Vertrauen gerecht zu werden.

Wenn bei einem schwerkranken, beatmeten Kind auf einer Intensivstation trotz aller Therapiebemühungen ein Hirntod diagnostiziert wird, dann wäre es für die Eltern eine unzumutbare Belastung, ihnen die Entscheidung zu überlassen, ob die Beatmung beendet oder fortgeführt werden solle.

In einer solchen Situation könnte der Arzt nach einleitenden Worten die Aussage machen: »Bei der letzten Untersuchung wurde festgestellt, dass bei Ihrem Kind die Funktion des Gehirns unwiderruflich erloschen ist.« Er könnte dann fortfahren: »Wir haben die Situation sehr, sehr genau überlegt. Unter diesen Umständen halten wir es für Sie und für Ihr Kind für das beste, wenn wir jetzt die Therapie und die Beatmung beenden.«

Etwas anders wird die Lage für die Eltern, wenn der Arzt nach der oben erwähnten Einleitung sagt: »Aber diesen Entschluss, jetzt die Therapie zu beenden, wollen wir selbstverständlich nicht fassen ohne Ihre Einwilligung. Welche Entscheidung halten Sie für richtig?«

Die große Herausforderung für den Arzt liegt in solchen Fällen darin zu wissen, was der Patient oder die Angehörigen in ihrer Autonomie entscheiden sollen, und herauszufühlen, wann es für diese unmöglich wird, Entscheidungen zu treffen. In dem zuletzt erwähnten Beispiel kann die sicher wohlgemeinte Offenheit des Arztes bei den Eltern das Gefühl hinterlassen, dass sie letzten Endes mehr oder weniger verantwortlich für den Entschluss gewesen seien, die Therapie zu beenden – eine Belastung, unter der sie vielleicht ein Leben lang zu leiden haben.

Der Arzt muss in solchen Situationen *immer* unterstreichen, dass er allein die fachliche Verantwortung für die getroffene Entscheidung trägt. Es

gibt nicht wenige solche Situationen, in denen der Arzt allein die Verantwortung zu tragen hat, und er muss diese Verantwortung offen zu tragen wissen.

Bei schwierigen klinischen Entscheidungen entsteht immer die Frage:

- Welche Wertvorstellung soll bei der Entscheidung eine Rolle spielen?

Hinter dieser Frage liegt eine andere zentrale Frage:

- Wer soll entscheiden, welche Wertvorstellung zugrunde liegen soll?

Solange die Entscheidungen des Arztes und des Personals auf allgemeingültigen Auffassungen von Recht und Moral beruhen, ist eine bewusste Antwort auf diese Fragen nicht dringend erforderlich. Aber nicht selten haben Patienten, Angehörige, Arzt und Pflegepersonal verschiedene Interessen und verschiedene Wertvorstellungen, wodurch sie unterschiedliche Entscheidungen treffen werden.

Beispiel aus der Praxis

Ein Patient hatte wiederholt den Ärzten und Krankenschwestern signalisiert, nicht länger am Respirator behandelt werden zu wollen. Er litt unter einem Larynxkarzinom mit ausgedehnten Metastasen in Leber, Lunge und Rückenmark. Trotz einer Entlastungsoperation wegen zunehmender Lähmung führte eine zunehmende Ateminsuffizienz zu der Respiratortherapie. Eine Entwöhnung davon war jetzt aufgrund der fortgeschrittenen Krankheit nicht mehr möglich.

Der Patient machte schriftlich geltend, dass er eine Lebensverlängerung durch die Respiratortherapie verbiete. Diese Entscheidung wurde von seinen Angehörigen unterstützt. Sein Arzt meinte dagegen, der Patient könne noch einige Monate mit Respiratortherapie leben und verweigerte den Abbruch der Therapie. Er gab auch an, der Patient sei in der gegebenen Situation schwer depressiv und nicht entscheidungsfähig. Er wies auf seine Erfahrung mit einem anderen Patienten hin, der den Abbruch von lebensverlängernden Maßnahmen verlangt hatte. Der Arzt hatte dessen Wunsch nicht respektiert, und dieser Patient hatte ihm kurze Zeit später zu verstehen gegeben, dass er für diese Entscheidung sehr dankbar war (Cohen 1989).

Viele werden den Überlegungen dieses Arztes kritisch gegenüberstehen. Wir sehen, wie Ärzte andere Entscheidungen treffen können als ihre Patienten. In diesem Fall hat der Arzt eine andere Vorstellung davon, was lebenswert ist,

und er hat die Macht, seine Entscheidung geltend zu machen und die Kompetenz des Patienten in Frage zu stellen.

Das Ausmaß der Macht ist zu bedenken, das der Arzt über seinen Patienten ausübt. Diese Macht ist weitgehend unsichtbar und unreflektiert; sie ist komplizierter als andere offene Machtkonstellationen in der Gesellschaft. Medizinethische Fragen sind treibende Kräfte in der ethischen Debatte unserer Zeit; viele Ethiker sind der Meinung, dass moderne Ethik ohne die medizinischen Herausforderungen bedeutungslos wäre (Toulmin 1982; ► Kap. 9: »Die Rolle des Arztes«).

Wohl kaum einer hat so scharfsinnig und selbstkritisch zu diesem Thema geschrieben wie der dänische Philosoph Søren Kierkegaard. In einem vielzitierten Aufsatz über die Kunst des Helfens beschreibt er die Wertgrundlage für diese schwierige Aufgabe. Es wäre sehr zu wünschen, dass der Arzt, das Pflegepersonal oder andere »Helfer« sich stets vergegenwärtigen, was Kierkegaard wie folgt formulierte:

> Wenn wir beabsichtigen, einen Menschen zu einer bestimmten Stelle hinzuführen, müssen wir uns zunächst bemühen, ihn dort anzutreffen, wo er sich befindet und dort anfangen. Jeder, der dies nicht kann, unterliegt einer Selbsttäuschung, wenn er meint, anderen helfen zu können.
>
> Wenn ich wirklich einem Anderen helfen will, muss ich mehr verstehen als er, aber zu allererst muss ich begreifen, was er verstanden hat. Falls mir dies nicht gelingt, wird mein Mehr-Verständnis für ihn keine Hilfe sein. Würde ich trotzdem mein Mehr-Verständnis durchsetzen, dürfte dieses wohl in meiner Eitelkeit begründet sein. Ich möchte meine Unterstützung durch seine Bewunderung ersetzen.
>
> Aber jede wahre Kunst der Hilfe muss mit einer Erniedrigung anfangen.
>
> Der Helfer muss zuerst knien vor dem, dem er helfen möchte.
>
> Er muss begreifen, dass zu helfen nicht zu herrschen ist, sondern zu dienen;
>
> - dass Helfen nicht eine Macht, sondern eine Geduldausübung ist;
> - dass die Absicht zu helfen einem Willen gleichkommt, bis auf weiteres zu akzeptieren, im Unrecht zu bleiben und nicht zu begreifen, was der Andere verstanden hat.
>
> (Kierkegaard 1859: *Eine einfache Mitteilung*)

2.2 Sterbenlassen – passive Sterbehilfe

Meine Aufgabe ist es, mich um die Gesundheit des Patienten zu kümmern.
Es gibt Zeiten, in denen es im Interesse der Gesundheit liegt, zu sterben.
Es ist nicht gesund, das Sterben hinauszuziehen.
(Cicely Saunders)

2.2.1 Gibt es Situationen, in denen der Tod nicht mehr der Feind des Patienten ist?

Ziel des ärztlichen Strebens ist es, Krankheit zu bekämpfen und Gesundheit zu fördern. Liegt das aber immer im Interesse des Patienten? Vor 30 Jahren war es noch ungewöhnlich, größere Operationen an Patienten vorzunehmen, die das 70. Lebensjahr überschritten hatten. Heute werden nicht selten 90-Jährige nach großen Operationen geheilt nach Hause entlassen.

Wir Mediziner leben davon, Leben zu erhalten. Aber sehen wir auch, dass wir nicht selten über das Ziel hinausschießen? Fast jeden Tag kann man in jedem Krankenhaus beobachten, wie Patienten am gleichen Tag, an dem sie sterben, noch einer Reihe von diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen unterzogen werden, die nicht nur sinnlos und kostspielig sind, sondern auch einen Ersatz darstellen für das, was der Patient am meisten braucht, aber nicht bekommt (Jecker u. Pearlman 1992).

Dabei ist die Kostenverschwendung größer, als die meisten es sich vorstellen. Es ist berechnet worden, dass wir im Gesundheitswesen 50.000–100.000 Euro für das jeweils letzte Lebensjahr unserer Patienten ausgeben (Smith 1995). Damit soll nicht zum Ausdruck gebracht werden, dass dieses Geld einfach eingespart werden sollte. Aber vielleicht sollten wir uns bemühen, kritischer zu beobachten, welche diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen für welche Patienten mit diesen Geldern finanziert werden. Ist es wirklich notwendig, jeden Tag Blut abzunehmen, einen Tropf anzuhängen, Antibiotika oder Herzmittel zu verabreichen und Untersuchungen vorzunehmen, wenn wir alle eingesehen haben, dass das Leben eines Patienten nicht mehr zu retten und die verbleibende Lebenszeit nur noch sehr begrenzt ist?

Schwerwiegender als die Kostenfrage ist das körperliche und seelische Leiden für Patient und Angehörige in einer solchen Situation. Unsere unnötigen diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen lenken vom Wesentlichen ab, wenn es um das Lebensende eines Patienten geht. Sowohl der Patient wie auch die Angehörigen brauchen, um eine solche Situation verstehen und durchstehen zu können, eine offene, vertrauliche Führung des Arztes. Sie brauchen eine Atmosphäre, in der Fragen, Verzweiflung, Angst und andere Reaktionen zugelassen sind. Wir wissen durch Aussagen von Hinterbliebenen, dass die letzten Wochen und Tage eines Sterbenden, selbst wenn er um sein nahes Ende weiß, als die wichtigsten in seinem Leben bewertet wurden.

So kann es beispielsweise um die Frage gehen, ob der Kranke im Krankenhaus verbleiben oder nach Hause verlegt werden soll, um dort in Frieden zu sterben. Es kann wichtig sein, Angehörige oder Bekannte zu erreichen und zu verständigen. Vielleicht braucht jemand Informationen über den Zustand des Patienten; vielleicht sind Angehörige zu unterstützen, damit sie in der Lage sind, die letzten Stunden mit dem Kranken zu verbringen.

All dies setzt voraus, dass der Arzt nicht nur alles unterlässt, was falsch ist, sondern auch sieht, was er an Gutem ausrichten kann.

Informiertes Einverständnis

Beispiel aus der Praxis

Frau A. sollte am nächsten Tag operiert werden. Bei der präoperativen Visite fiel mir auf, dass ihr Allgemeinzustand sehr schlecht war. Sie hatte seit 6 Jahren ein schweres Krebsleiden mit multipler Metastasierung im Gastrointestinalbereich. Viermal war sie in diesem Bereich operiert worden. Jetzt litt sie unter Fistelbildung vom Darm zu Harnblase und Scheide. Dünnflüssiger Stuhl bildete sich und plagte sie sehr. Frau A. war eine aufgeschlossene und lebensbejahende Frau, die gegen ihre Krankheit mit großer Intensität gekämpft hatte. Jetzt sagte sie: »Ich kann nicht mehr, bitte hilf mir.«

Da das Operationsrisiko sehr groß war, suchte ich ihren Chirurgen auf. Auf meine Fragen sagte dieser: »Du hast Recht, das OP-Risiko ist mehr als groß. Ich fürchte, ihre Aussichten sind mit oder ohne Operation sehr gering. Aber haben wir eine Wahl?«

Darauf suchten wir gemeinsam die Frau auf und wiederholten unser Gespräch. Sie stellte dabei einige Fragen. Dann schaute sie uns an und sagte: »Wenn ich also richtig verstanden habe, habe ich die Wahl zwischen einer

> risikoreichen Operation und der Möglichkeit, nach Hause zu fahren. Wie ich mich auch entscheide, es sieht für mich schlecht aus; es bleibt mir nur noch eine kurze Zeit. – Vielen Dank für diese sehr wertvolle Offenheit. Jetzt habe ich das erfahren, was ich wissen wollte. Ich möchte nicht operiert werden, ich will nach Hause.«
>
> Dann fügte sie noch hinzu: »Wissen Sie, auf dem Weg zum Krankenhaus, kurz bevor wir ankamen, sagte ich noch zu meinem Mann: Ich glaube, dass die einzige Möglichkeit zu sterben für mich darin besteht, mit dem Essen aufzuhören.«

Nicht alle Patienten besitzen die Entscheidungskraft dieser Frau. Nicht alle haben das Verständnis, sich damit abzufinden, dass die Krankheit nicht mehr aufzuhalten ist; nicht alle kommen zu der Einsicht, dass nicht eine risikoreiche und folgenschwere Behandlung für sie hilfreich ist, sondern eine Unterstützung, die sie in die Lage versetzt, dem Ende mit offenen Augen entgegensehen zu können.

Diese letzte Aussage der Frau weist auch auf eine andere Perspektive. Einige werden fragen: Wenn sie, bevor sie zum Krankenhaus fährt, selbst sagt, »Ich sehe jetzt, dass der Tod bevorsteht, ich bin bereit zum Sterben«, warum bleibt sie dann nicht einfach zu Hause? Hier dürfen wir nicht die Bedeutung übersehen, wenn ein Arzt die Vermutungen des Patienten bestätigt oder entkräftet. Der Arzt als Besitzer der medizinischen »Wahrheit« ist gefragt. Diese Frau hat eine Familie. Sie weiß, dass sie noch gebraucht wird. Sie möchte nicht sterben, und sie braucht in ihrer Lage den medizinisch kompetenten Gesprächspartner.

Verhindern wir Ärzte aber nicht häufig durch fehlende Offenheit oder mangelnde Bereitschaft zur Kommunikation ein friedliches Sterben unserer Patienten (Buckman 1996)? Sollten wir nicht vielmehr durch offene Darlegung des Krankheitsverlaufs, der Therapiemöglichkeiten und ihrer Folgen die Voraussetzung dafür schaffen, dass der Patient zusammen mit seinen Angehörigen die letzten Wochen und Tage seines Lebens sinnvoll gestalten kann? Eine solche Aufklärung ist nicht einfach. Sie erfordert hohe fachliche und menschliche Kompetenz.

Das bereits erwähnte »informierte Einverständnis« wird in solchen Situationen uns und dem Patienten helfen, richtig vorzugehen. Unsere Aufgabe ist es daher zunächst, ihn über die Krankheit, über die Therapiemöglichkeiten und deren Folgen zu informieren. Danach sollen wir einfühlsam dem Patienten aus-

reichend Zeit lassen, Fragen zu stellen und sich zu entscheiden. Unsere Aufgabe ist es, eine oder mehrere Therapiealternativen anzubieten. Die Aufgabe des Patienten ist es, sich für die eine oder andere Alternative zu entscheiden.

Wenn der Patient sich für eine Alternative entscheiden sollte, die wir nicht für gut halten, liegt es bei uns, dies auf die eine oder andere Weise auszudrücken, um ihn damit auf mögliche negative Folgen aufmerksam zu machen. Wenn er sich für eine Therapie entscheiden sollte, die wir selbst aus fachlichen Gründen nicht vertreten können, ist es unsere Pflicht, dies in aller Deutlichkeit auszusprechen. Der Patient hat zum Beispiel kein Anrecht auf eine Operation, die der Arzt für unverantwortlich hält (Smith 1995).

Es kommt darauf an, die Autonomie des Patienten und die Fachkompetenz des Arztes in ein Verhältnis gegenseitigen Respektes zu bringen. Das setzt einmal voraus, dass der Arzt sich nicht nur für Behandlungsalternativen einsetzt, die er bisher bevorzugte. Es muss für den Patienten die Möglichkeit gewährleistet sein, freiwillig, d. h. ohne äußeren Druck, seine Entscheidung zu treffen. Das traf bei Frau A. zu. Dieses Beispiel hat nichts mit passiver Sterbehilfe zu tun. Es ging hier nicht um die Frage, ob eine lebensnotwendige Therapie unterbrochen oder nicht durchgeführt werden sollte, sondern um die autonome Entscheidung der aufgeklärten Patientin.

Es ist ideal, wenn Patient und Arzt in der Lage sind, Gespräche auf einer Ebene zu führen, die es dem Patienten ermöglichen, reife und gute Entscheidungen zu treffen. Es gibt viele Gründe, warum das nicht immer möglich ist.

Manchen Patienten und Ärzten fehlen die fachlichen und menschlichen Voraussetzungen für eine solche Verständigung. Auch in diesen Fällen hat der Arzt daran zu denken, dass er professioneller Helfer zu sein hat und darauf bedacht sein muss, den Patienten zu verstehen und ihm zu helfen (▶ Kap. 3: »Kommunikation«). Häufig ist ein Patient nicht mehr in der Lage, wichtige Entscheidungen zu treffen, weil die kognitiven Voraussetzungen bei ihm nicht oder nicht mehr vorhanden sind. Er begreift die Therapiealternativen und ihre Konsequenzen nicht mehr, weil die Krankheit zu weit fortgeschritten ist und seine Bewusstseinslage evtl. bis hin zu einem Bewusstseinsverlust beeinträchtigt.

Während bei entmündigten Menschen ein Vormund bestellt wird, der rechtskräftige Entscheidungen für diesen Menschen treffen kann und muss, ist dies bei Patienten mit einer durch die Erkrankung eingeschränkten Entscheidungsfähigkeit selten der Fall. Dies hat ganz unterschiedliche Gründe und stellt den Arzt vor schwierige Entscheidungen.

Der bewusstlose Patient

Beispiel aus der Praxis

Ein 81-jähriger Patient kommt nachts als Notaufnahme in das Krankenhaus. Die Dienst habenden Ärzte stellen fest, dass sein akuter Zustand durch ein rupturierendes Aortenaneurysma (Riss der Hauptschlagader) bedingt ist. Ohne Operation würde er innerhalb von Stunden sterben. Der Patient ist im Schock, kann also vor der Operation nicht gefragt oder informiert werden. Kein Angehöriger ist anwesend. Die Operation ist erfolgreich. Wegen des Schweregrads seines Zustands wird er nach der Operation auf die Intensivabteilung verlegt und beatmet.

Die Angehörigen, Ehefrau und zwei Töchter, werden darüber informiert, dass sein Zustand kritisch, aber stabil ist. Aufgrund des Krankheitszustands und der Wirkung der zugeführten Medikamente ist es nicht möglich, mit ihm Kontakt zu bekommen. In den nächsten Tagen ändert sich die Lage nicht. Den Angehörigen wird mitgeteilt, dass Überlebenschancen vorhanden sind, dass es aber erst in den folgenden Tagen möglich sein wird, genauere Äußerungen dazu zu machen.

Am 4. Tag der Intensivbehandlung bitten die Angehörigen um ein Gespräch. Sie erkundigen sich nach dem Zustand des Patienten. Dann erklären sie, dass der Kranke selbst sich wiederholt in den letzten Jahren dazu geäußert habe, wie man sich ihm gegenüber verhalten solle, falls er in einen behandlungsbedürftigen lebensbedrohlichen Zustand wie diesen gerate. Er wolle dann die Möglichkeit bekommen, in Frieden zu sterben und habe ein »Patiententestament« ausgefüllt. Unter keinen Umständen wolle er in einer solchen Situation einer längeren Intensivtherapie unterzogen werden.

Wie sollten die Ärzte jetzt vorgehen? Die für diesen Fall deutlich dokumentierte Entschlossenheit des Kranken und das ebenso eindeutige und einhellige Verhalten der Angehörigen machten es schwer, den Wunsch des Kranken zu übersehen. In dieser speziellen Situation brauchen die Ärzte fünf Wochen, bevor sie sich zu einer Aufgabe der therapeutischen Maßnahmen entschließen konnten. Es waren fünf Wochen mit zunehmenden Komplikationen.

Schon frühzeitig hatte sich eine Mehrheit der Ärzte zu der Einsicht bekannt, dass die Fortführung der Therapie lediglich zu einer Verlängerung des Sterbens führe. Doch sprachen sich auch immer ein oder zwei erfahrene Ärzte gegen eine Aufgabe der Therapie aus, die dann auf dieser Grundlage fortgesetzt wurde. War das notwendig? War das richtig?

Die weitere Krankheitsentwicklung des Patienten gab den Befürwortern einer Therapiefortsetzung nicht Recht. Die erfahrenen Chirurgen beriefen sich bei ihrer Argumentation auf Erfahrungen in gleich gelagerten Fällen, die einen positiven Ausgang genommen hatten. Dies ist bestimmt einer der Hauptgründe dafür, dass es vielen Ärzten so schwer fällt, eine Therapie zu beenden, auch wenn die Aussichten eines Patienten auf eine Verbesserung längst nicht mehr gegeben sind und der Tod allen Erfahrungen nach kurz bevorsteht (Andrae 1994).

Im Nachhinein ist es einfach zu sagen: Dieser Patient hätte wenigstens vier Wochen vorher die Möglichkeit bekommen sollen, in Ruhe zu sterben. Zweifellos gibt es auch Grund zu der Aussage, dass viel zu häufig in solchen Situationen sinnlos »um jeden Preis« weiter therapiert wird.

Sollten wir Ärzte uns nicht häufiger darauf besinnen, dass unsere Aufgabe vor allem darin besteht, das Leben der einzelnen Patienten zu respektieren? Und gehört dazu nicht auch das Recht jedes einzelnen Menschen auf ein möglichst würdevolles Sterben?

Wenn ein Patient sich selbst in einer solchen Situation äußern kann, ist es unsere Pflicht, seine Wünsche zu respektieren (Tranøy 1992a).

Wenn ein Patient aus welchen Gründen auch immer sich nicht äußern kann, dann muss es unser Anliegen sein, auf andere Weise zu erfahren, für welche der vorhandenen Alternativen er sich entscheiden würde. Erst wenn wir entweder aus Zeitnot oder aus anderen Gründen nicht mehr in der Lage sind zu erfahren, wie der mutmaßliche Patientenwille ist, dürfen wir die Verantwortung auf uns nehmen und eigenständig im Interesse des Patienten handeln.

In vielen Ländern gibt es für Erwachsene die Möglichkeit, ein sog. »Patiententestament«, eine Patientenverfügung, aufzusetzen. Hierin wird schriftlich niedergelegt, wie man grundsätzlich oder in bestimmten Fällen behandelt und/oder betreut werden möchte und wie nicht. Ein solches Dokument muss beachtet und ernst genommen werden. Denn unser Anliegen ist es, den Willen und die Wünsche der Patienten so weit wie möglich zu respektieren (Beleites 1997, 2004; Enquete-Kommission »Ethik und Recht der modernen Medizin« des Deutschen Bundestags 2005; Strätling et al. 2004).

Gleichwohl gibt es Einwände gegen die Schaffung einer juristisch verpflichtenden Gültigkeit eines solchen Dokuments. Wie kann, so wird gefragt, ein Patient zum Zeitpunkt der Unterzeichnung einer solchen Verfügung beurteilen, was er in der Zukunft bei Krankheitssituationen, die er vielleicht selbst noch gar nicht erlebt hat, wollen würde? Auch würden

oftmals generelle Verzichte auf bestimmte Maßnahmen (Beatmung etc.) verfügt, und die behandelnden Ärzten wären im Zweifelsfall nicht in der Lage herauszufinden, ob der Patient gewusst hat, dass er damit auch solche Fälle ausschließt, in denen er etwa durch eine vollwertige Intensivtherapie innerhalb von Wochen wiederhergestellt werden könnte.

Patientenverfügung (Kutzer 2005)

Viele Menschen haben Angst vor Schmerzen, vor einem schmerzvollen Sterben, Angst vor dem Alleingelassenwerden, Angst vor unwürdiger Behandlung und Angst vor einer nicht mehr loslassenden Medizin. Sie hoffen, durch eine Patientenverfügung sich davor schützen zu können. Sie erwarten, dass ihre Patientenverfügungen von den Handelnden beachtet werden und dazu beitragen, Leiden, bleibende Behinderung und Siechtum sowie unverhältnismäßige Belastung ihrer Angehörigen zu vermeiden und ihnen die Möglichkeit zu geben, bis zum Ende nach eigenen Vorstellungen menschenwürdig zu leben. Zurzeit sind sehr unterschiedliche von den verschiedensten Organisationen herausgegebene Formulare in Umlauf.
Der mögliche Inhalt von Patientenverfügungen reicht von Wünschen bis zu verbindlichen Anordnungen. Er betrifft die Ausschöpfung von Lebensverlängerungsmöglichkeiten oder deren Begrenzung. Noch so gut gemeintes paternalistisches Handeln der Ärzte, das sich über den rechtlich erheblichen Willen des Patienten hinwegsetzt, ist mit dem Grundrecht des Art. 2 Abs. 2 des Grundgesetzes auf körperliche Unversehrtheit nicht vereinbar und in der Regel als Körperverletzung strafbar.

Aus dem grundrechtlich verbürgten Selbstbestimmungsrecht des Patienten folgt also auch für die ärztliche Behandlung des dem Tode geweihten Menschen, und zwar unabhängig davon, ob der Tod unmittelbar bevorsteht oder nicht, dass jeder ärztliche Eingriff in die körperliche Integrität des Patienten, der von diesem nicht oder nicht mehr gewollt wird, rechtswidrig ist. Die erteilte oder versagte Einwilligung ist maßgeblich, wenn der Patient einwilligungsfähig und über die Bedeutung des Eingriffs hinreichend aufgeklärt ist.

Patientenverfügungen sind jedenfalls eine nützliche, aber nicht notwendige Option des Patienten. Dieser kann sich auch ohne Patientenverfügung uneingeschränkt der Fürsorge des Arztes und seines sozialen

▼

> Umfelds anvertrauen. Empfehlenswert erscheint es jedoch, rechtzeitig eine mit schriftlicher Vollmacht auszustattende Vertrauensperson auszuwählen, die dem Arzt als Sachwalter des Patienteninteresses zur Seite steht, wenn es darum geht, die Vor- und Nachteile schwerwiegender Maßnahmen gegeneinander abzuwägen und dann die entsprechenden Entscheidungen gemäß dem mutmaßlichen Patientenwillen zu treffen oder zu unterlassen.«

Es ist nicht einfach, sich generell zu äußern über das, was in den einzelnen Fällen das »richtige« Vorgehen ist. Jede Situation ist in ihrer Weise einzigartig und muss individuell beurteilt werden. Es besteht trotzdem Grund zu der Annahme, dass wir Ärzte Angst haben vor einem Aufgeben unserer Therapiemaßnahmen. Wir haben Angst, Fehler zu begehen und setzen deshalb lieber auf »Nummer sicher«: maximale Therapie bis zum bitteren Ende (Smith 1995).

Von Anfang an war es ein wichtiges Anliegen der Palliativmedizin, diese Fragen zu beleuchten. Einen Menschen sterben zu lassen, ist etwas, das wir nach den Grundsätzen unserer medizinischen Ausbildung als eine Niederlage zu betrachten haben, auch in solchen Situationen, in denen der Tod für den Kranken eine Erlösung wäre.

Die Palliativmedizin sagt nicht, dass sie für dieses ethische Dilemma ein allgemeingültiges Lösungsangebot zur Hand hätte. Sie will aber die Situation des Patienten und die der Angehörigen auf eine Weise beleuchten, die es uns ermöglicht, in schwierigen Situationen gute Entscheidungen zu treffen.

Eine gute Stütze bei schwierigen Entscheidungen im medizinischen Alltag ist die Frage:

Wie würde meine Entscheidung aussehen, wenn der Patient in diesem Bett nicht eine mir unbekannte Person wäre, sondern meine Mutter, mein Ehegatte, mein Kind oder ich selbst?

»Wenn man sieht, was die heutige Medizin fertigbringt, fragt man sich unwillkürlich: Wie viele Etagen hat der Tod?« (Jean-Paul Sartre)

In diesen Worten Sartres kommt zum Ausdruck, dass manche Ärzte sich weigern, sich überhaupt mit den Fragen der Änderung des Behandlungsziels, des Nichtergreifens sog. »futiler« Maßnahmen oder der passiven Sterbehilfe auseinanderzusetzen. Sie sagen, ihre ärztliche Aufgabe sei es, immer Leben zu retten und Leben zu erhalten. Sie glauben, damit eine sichere Grundlage für ihr ärztliches Handeln gefunden zu haben und sich schwierigen ethischen Entscheidungen entziehen zu können. Dabei vergessen sie aber, dass sie sich

mit einer solchen Einstellung gerade den Grundregeln ärztlichen Verhaltens und ärztlicher Ethik widersetzen (Pellegrino u. Thomasma 1994). Wenn Ärzte sich ausschließlich darauf konzentrieren würden, alles medizinisch Mögliche zu tun, werden sie medizinethisch viele Fehler machen. Sie werden kaum in der Lage sein, für den Patienten das zu tun, was dieser am meisten braucht.

2.2.2 Entscheidungen über Behandlungsabbruch

Der entscheidungsfähige (autonome) Patient

Wie wir in ▶ Kap. 2.1.1 deutlich gemacht haben, hat jeder Patient das Recht auf Information und das Recht auf Respektierung seiner eigenen Entscheidungen über weitere Diagnostik und Therapie. Der Wille eines Patienten, der bei vollem Bewusstsein Aussagen über eine Unterbrechung oder ein Unterlassen von Therapiemaßnahmen macht, muss respektiert werden. Das gilt auch für den Fall, dass diese Therapiemaßnahmen lebensnotwendig sind. Wenn der Patient also eine bestimmte Behandlung ablehnt, so entzieht er damit dem Arzt das Behandlungsrecht für diesen ganz bestimmten Fall, der Arzt darf nicht gegen den Willen des Patienten handeln. Dem entspricht es, dass die mit ärztlichen Maßnahmen verbundenen Eingriffe im rechtlich geschützten Interesse des Menschen grundsätzlich nur mit Einwilligung des Betroffenen zulässig sind (Beleites 1997; Beleites 2004).

Wenn ein autonomer Patient jede weitere Therapie ablehnt, kann nicht von passiver Sterbehilfe gesprochen werden. Diese Entscheidung, aus freiem Willen eine Therapiemöglichkeit wahrzunehmen oder nicht wahrzunehmen, entspricht einem grundlegenden Rechtsgut in der Verfassung (Eser et al. 1992).

Der nichtentscheidungsfähige Patient

Bei verwirrten Patienten oder Patienten, die nicht oder nicht mehr in der Lage sind, ihren Willen zu artikulieren und diesen auch nicht zu einem früheren Zeitpunkt schriftlich festgelegt hatten, und bei Minderjährigen kann die Einwilligung in der Regel nur von deren gesetzlichem Vertreter – also nicht von anderen Angehörigen – erteilt werden. Gesetzliche Vertreter sind bei Kindern die Eltern bzw. der Vormund, bei Volljährigen der Vorsorgebevollbemächtige oder Betreuer. Vorsorgebevollmächtige und Betreuer können vom einwilligungsfähigen, volljährigen Patienten im Voraus schriftlich für den Fall

des Eintritts einer Nichteinwilligungsfähigkeit bestimmt werden; ein Betreuer kann bei Bedarf und fehlender Vorausverfügung des Patienten durch ein Vormundschaftsgericht eingesetzt werden. Wer zu einer Einrichtung, in welcher der Betreute untergebracht ist oder wohnt, in einer engen Beziehung steht, darf nicht zum Betreuer bestellt werden (§ 1897 Abs. 3 BGB).

Patientenvertreter (Kutzer 2005)
Ist der Patient zur Abgabe einer den rechtlichen Erfordernissen genügenden Einwilligung nicht in der Lage, so kommt es für das ärztliche Handeln auf die Einwilligung des Vertreters des Patienten an. Vertreter des Patienten kann sein der vom Vormundschaftsgericht bestellte Betreuer in gesundheitlichen Angelegenheiten oder der vom geschäftsfähigen Patienten durch eine schriftliche Vollmacht bestellte Bevollmächtigte.
Die Befugnis des potenziellen Patienten zur Erteilung einer so genannten Vorsorgevollmacht auch in gesundheitlichen Angelegenheiten, Gesundheitsvollmacht genannt, ist nach dem Inkrafttreten des Betreuungsrechtsänderungsgesetzes am 1. Januar 1999 (BGBl I S. 1580) nicht mehr in Frage gestellt.

Die rechtliche Institution der Betreuung und des vom Vormundschaftsgericht zu bestellenden Betreuers ist unter Ärzten allgemein bekannt. Dagegen ist die neu geschaffene Rechtsfigur des privatrechtlichen Gesundheitsbevollmächtigten unter Ärzten und Patienten noch vielfach unbekannt. Die Vollmacht braucht nicht notariell beurkundet oder beglaubigt zu werden. Soll die Vollmacht auch die Bevollmächtigung zur Entscheidung über ärztliche Maßnahmen einschließen, die zum Tode des Vollmachtgebers oder zu schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schäden führen können, so muss die Vollmacht diese Maßnahmen ausdrücklich umfassen und schriftlich erteilt worden sein. Es empfiehlt sich dringend, in oder neben einer Patientenverfügung eine Vertrauensperson als Gesundheitsbevollmächtigten zu bestellen. Hierbei kann man seit dem 1. Juli dieses Jahres auch die Hilfe der örtlichen Betreuungsbehörde in Anspruch nehmen. Dadurch vermeidet man die gerichtliche Bestellung eines Betreuers.

Die Entscheidung über fehlende Einwilligungsfähigkeit sollte der Arzt nicht allein treffen, sondern hierzu einen erfahrenen Kollegen, nach Möglichkeit

einen Fachmann (Psychiater), oder – in Zweifels- und Streitfällen – das Gericht zu Rate ziehen.

Bei Minderjährigen wird die Einsichts- und Urteilsfähigkeit vom Reifegrad und der konkreten vorliegenden Situation abhängig sein. Alltägliche und verhältnismäßig harmlose Eingriffe wird ein älteres Kind selbst gut beurteilen können, während das Risiko bei größeren oder folgenschweren Operationen (z. B. Sterilisation) für es noch nicht überschaubar ist.

Bei der Beurteilung, inwiefern psychisch Kranke in der Lage sind, eine Entscheidung mitzutragen, kommt es auf den Grad ihrer Störung einerseits und die Größe und Folgen des Eingriffs andererseits an.

Wenn der Arzt eine Behandlung vornimmt, ohne eine wirksame Einwilligung eingeholt zu haben, obwohl dies möglich gewesen wäre (was besonders bei mangelhafter Aufklärung der Fall sein kann), oder wenn der Arzt die Grenzen der erteilten Einwilligung überschreitet, so ist sein Handeln rechtswidrig – und kann strafrechtliche Folgen haben (Eser et al. 1992).

Der mutmaßliche Patientenwille

Kann die Zustimmung zu einer Behandlung nicht eingeholt werden, z. B. bei bewusstlosen Patienten oder Nichterreichbarkeit des gesetzlichen Vertreters, so kann sie weder durch die Einwilligung eines anderen Angehörigen ersetzt werden noch darf der Arzt selbst sich grundsätzlich die Entscheidungskompetenz zuschreiben.

Hat der eigentliche Sterbeprozess bereits begonnen, so werden lebensverlängernde Maßnahmen in aller Regel schon ärztlich nicht mehr indiziert sein, sodass sie auch ohne Feststellung eines ausdrücklichen oder mutmaßlichen Patientenwillens unterlassen werden dürfen.

In Fällen, in denen weder das Überleben noch das langfristige Wohl des Patienten von äußerst raschem Handeln abhängt, ist der Arzt gehalten, den mutmaßlichen Willen des Patienten zu ermitteln (BÄK 2004). Dies muss er tun, wenn keine Patientenverfügung vorliegt oder eine, in der die vorausverfügten, an bestimmte Bedingungen geknüpften Behandlungswünsche nicht auf die aktuelle Situation anwendbar sind und aus der auch sonst keine eindeutigen Wertekategorien des Patienten zu ersehen sind. Der mutmaßliche Patientenwille sollte über Befragungen von Menschen, die dem Patienten nahe stehen, evtl. auch den Hausarzt, ermittelt werden.

In Situationen, in denen das Überleben und/oder das langfristige Wohl eines Patienten (Sauerstoffunterversorgung des Gehirns etc.) von raschem Handeln abhängen und der Wille des Patienten unklar ist, gilt »in dubio pro vita«. Dies entbindet aber nicht davon, nach der Durchführung der zunächst notwendigen Maßnahmen den Willen des Patienten zu ermitteln und eingeleitete Maßnahmen ggf. einzustellen.

Wachkomapatienten, Demenz und künstliche Ernährung

Ein wichtiges Urteil des Bundesgerichtshofs 2004

1. »Bei einem unheilbar erkrankten, nicht mehr entscheidungsfähigen Patienten kann der Abbruch einer ärztlichen Behandlung oder Maßnahme ausnahmsweise auch dann zulässig sein, wenn die Voraussetzungen der von der Bundesärztekammer verabschiedeten Richtlinien für die Sterbehilfe nicht vorliegen, weil der Sterbevorgang noch nicht eingesetzt hat. Entscheidend ist der mutmaßliche Wille des Kranken.
2. An die Voraussetzungen für die Annahme eines mutmaßlichen Einverständnisses sind strenge Anforderungen zu stellen. Hierbei kommt es vor allem auf frühere mündliche oder schriftliche Äußerungen des Patienten, seine religiöse Überzeugung, seine sonstigen persönlichen Wertvorstellungen, seine altersbedingte Lebenserwartung oder das Erleiden von Schmerzen an.«

Urteil des 1. Strafsenats vom 13. September 1994 (BGHSt 40, 257)

Dazu Klaus Kutzer (2005):
Durch dieses Urteil ist einer weiten Öffentlichkeit erstmals klargeworden, dass Patienten bei irreversibler Bewusstlosigkeit eine jahrelange künstliche Ernährung rechtlich nur vermeiden können, wenn sie zuvor ihren Willen auf Einstellung der lebenserhaltenden Maßnahmen bekundet haben. Die Form dazu bietet eine schriftliche oder auch mündliche Patientenverfügung. Dieses Problem ist von erheblicher praktischer Bedeutung. Denn die Zahl der so genannten Wachkomapatienten, also der Kranken mit apallischem Syndrom,

deren Zustand sich während der Akutbehandlung oder Frührehabilitation nicht gebessert hat, liegt nach Schätzungen des Bundesministeriums für Gesundheit aus dem Jahr 2001 bei rund 5.000, von denen etwa 70% in der häuslichen Umgebung versorgt werden. Die Zahl der irreversibel hirngeschädigten Wachkomapatienten steigt ständig, zum Teil auch als Folge zu später Reanimationen.

Ähnliche Probleme ergeben sich durch die unaufhaltsame Zunahme von Demenzerkrankungen. Will der Patient also vermeiden, dass er jahrzehntelang künstlich durch die Bauchdecke ernährt wird, ohne dass er die Chance einer Wiedererlangung des Bewusstseins oder der Kommunikationsfähigkeit hat, so muss er tunlichst eine Patientenverfügung errichten. Dies gilt nicht nur für ältere Menschen. Denn auch junge Menschen können, z. B. aufgrund eines schweren Unfalls, ins irreversible Wachkoma fallen.

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs hat damit zwar die grundsätzliche rechtliche Bindungswirkung einer Patientenverfügung anerkannt, wenn sie die konkrete Entscheidungssituation betrifft und nicht widerrufen worden ist. Der Bundesgerichtshof hat jedoch auch eine weit reichende Ausnahme postuliert, nämlich das Verbot, eine auf den Verzicht lebenserhaltender Maßnahmen gerichtete Patientenverfügung umzusetzen, wenn keine »letzte Sicherheit« darüber zu gewinnen ist, dass das Grundleiden des Betroffenen einen irreversiblen tödlichen Verlauf angenommen hat, und wenn durch die abgelehnte ärztliche Maßnahme das Leben des Betroffenen verlängert oder erhalten würde.

Wichtig an dieser Entscheidung ist ferner die Aussage, dass für das Einstellen lebenserhaltender Maßnahmen außerhalb des eigentlichen Sterbeprozesses eine Genehmigung des Vormundschaftsgerichts nur erforderlich ist, wenn Arzt und Patientenvertreter insoweit unterschiedlicher Auffassung sind. Das Vormundschaftsgericht ist also nicht mehr, wie es früher noch ein Strafsenat des Bundesgerichtshofes entschieden hatte, in jedem Fall der Einstellung der künstlichen Ernährung im Vorfeld des Sterbens, z. B. bei einem nicht im Sterben liegenden Wachkomapatienten, einzuschalten, sondern nur noch, wenn ein so genannter Konfliktfall vorliegt, weil der Patientenvertreter sich gegen ein Weiterbehandlungsangebot des Arztes entscheidet. Hat der Sterbeprozess jedoch schon begonnen, dürfte die Einstellung lebenserhaltender Maßnahmen maßgeblich von der allein vom Arzt zu verantwortenden medizinischen Indikation abhängen, sodass er frei von Weisungen Dritter ist.

2.2.3 Passive Sterbehilfe – Klinische Beurteilung und Definition

Passive Sterbehilfe betrifft nur nichteinwilligungsfähige Patienten, bei denen nicht die Möglichkeit zu vorbereitenden Gesprächen gegeben war und bei denen eine Fortführung bestimmter lebenserhaltender Therapien oder das weitere Ergreifen von lebenserhaltenden/-verlängernden Maßnahmen aus medizinischen, ethischen und humanitären Gründen sehr fraglich erscheint. So wäre es z. B. passive Sterbehilfe, wenn der Arzt auf die Behandlung einer Pneumonie oder einer anderen lebensbedrohlichen Komplikation verzichtet, um bei einem Sterbenden den Sterbeprozess nicht zu verlängern.

Das Nichtfortführen oder Nichtergreifen therapeutischer Maßnahmen bei einwilligungsfähigen, aufgeklärten Patienten entsprechend deren Willen hingegen ist *keine* passive Sterbehilfe.

Ärzte werden regelmäßig vor Situationen stehen, in denen sie bei der Behandlung eines nichtautonomen, schwerkranken und sterbenden Patienten zu der Einsicht kommen, dass es nicht im Interesse des Patienten liegen kann, die jetzt laufende Therapie weiter durchzuführen. Wenn sie dann nach reifer und gründlicher Überlegung, wobei die zuvor beschriebenen Betrachtungen über Einwilligung, mutmaßlichen Patientenwillen und Autonomie ernsthaft erwogen wurden, zu der Ansicht kommen, dass die das Sterben verlängernde Therapie unterbrochen werden sollte, wird dies juristisch und in der medizinischen Ethik als passive Sterbehilfe bezeichnet.

Passive Sterbehilfe ist im Bereich der Medizin ein international etablierter Begriff (Rachels 1975). Viele halten ihn für unglücklich gewählt und meinen, er solle ersetzt werden durch das einfachere und korrektere »Sterbenlassen«. Die Hauptfunktion des Begriffes liegt wohl darin, den Ärzten den Unterschied deutlich zu machen zwischen dem, was unter gewissen Voraussetzungen erlaubt sein kann (passive Sterbehilfe), und dem, was nicht erlaubt ist (aktive Sterbehilfe).

Die Europäische Gesellschaft für Palliativmedizin (EAPC) hält die Unterteilung in »aktive Euthanasie/Sterbehilfe«, »passive Euthanasie/Sterbehilfe« und »indirekte Euthanasie/Sterbehilfe« für grundsätzlich fragwürdig und in der Praxis v. a. für missverständlich. Sie schlägt vor, nur noch in *Euthanasie* und *ärztlich assistierten Suizid* zu unterscheiden. Beides sei in den meisten Ländern der Erde strafbar, passive und indirekte Sterbehilfe aber nicht, und zur Definition des Terminus Euthanasie gehöre ja der ausdrückliche Wunsch und die Einwilligung des Patienten, was daher aus rein logischen Gründen

Termini wie passive und indirekte Euthanasie absurd erscheinen lasse (EAPC Ethics Task Force 2003).

Definition

Passive Sterbehilfe

Passive Sterbehilfe ist die Entscheidung des Arztes, bei einem sterbenden, nicht einwilligungsfähigen Patienten

- entweder auf eine das Sterben verlängernde Therapie zu verzichten
- oder eine bereits begonnene das Sterben verlängernde Therapie zu unterbrechen.

Das Ziel dieser Maßnahme ist es, einem schwerkranken, sterbenden Menschen die Möglichkeit zu geben, an seiner Krankheit zu sterben – ihn sterben zu lassen.

Die ethische Grundlage dieser sog. passiven Sterbehilfe ist der Respekt vor dem Leben und vor dem Sterben des Patienten.

Aufgabe der Medizin ist es zwar, Krankheit zu bekämpfen und Krankheitssymptome unter Kontrolle zu halten. In Bezug auf den gesamten Lebenslauf eines Menschen gehört es aber auch zu den Aufgaben des Arztes, den persönlichen Tod eines jeden zu respektieren und zuzulassen.

Wenn die therapeutischen Maßnahmen, die wir eingesetzt haben, um Krankheit zu bekämpfen oder sie unter Kontrolle zu halten, beim Patienten nichts Gutes mehr bewirken, sondern nur sein Leiden verlängern, dann muss er von uns erwarten können, dass unnötige Therapiemaßnahmen eingestellt werden. Das führt dann nicht dazu, dass der Patient getötet wird, sondern dass die Krankheit ihren natürlichen Verlauf nehmen kann. Passive Sterbehilfe bedeutet »sterben lassen«. Es bedeutet keineswegs, den Patienten »aufzugeben« (Randall u. Downie 1996, Husebø u. Tausjø 1986)!

Besonders in den letzten Wochen und Tagen brauchen sterbende Patienten eine kompetente ärztliche Betreuung. Ausgezeichnete Symptomkontrolle und zugewandte menschliche Fürsorge gewährleisten, dass der Patient in der ihm verbleibenden Zeit seine Würde behalten kann. Für den Angehörigen ist diese Zeit entscheidend für seine Erinnerungen und, was noch wichtiger ist, für seine seelische Verarbeitung des erlebten Krankheitsverlaufes und des Verlustes.

Technisch und ethisch gesehen kann bei passiver Sterbehilfe *jede* Therapie unterbrochen werden, damit der Krankheitsverlauf ein friedliches Sterben ermöglicht.

Dabei kann es sich um die Einstellung oder Unterlassung der Therapie mit z. B. Antibiotika, Kreislaufmitteln, Ernährung, Respirator, Zytostatika oder einer Flüssigkeitssubstitution oder Dialyse handeln.

Es gibt oft unterschiedliche Auffassungen unter den Ärzten darüber, wie die Frage der passiven Sterbehilfe im Einzelfall zu beurteilen sei. In einem Krankenhaus begegnet man dieser Frage in großer Offenheit, im anderen ist dies nicht der Fall. Diese Unterschiede können in einem Krankenhaus zwischen den Abteilungen ebenso wie innerhalb einer Abteilung vorhanden sein.

Die Frage der passiven Sterbehilfe stellt in der praktischen Medizin sowohl in ihrer Quantität als auch in ihrer Qualität ein viel größeres Problem dar als die Frage der aktiven Sterbehilfe.

Einige dieser Probleme sowie die sich anbietenden Lösungsmöglichkeiten sollen im Folgenden dargestellt werden.

2.2.4 Wann sollen wir eine das Sterben verlängernde Therapie einstellen?

Die für den Arzt schwer zu beantwortende Frage ist: »Weiß ich mit Sicherheit, dass das Leben des Patienten jetzt zu Ende geht?« Sich in der Beantwortung dieser Frage zu irren, ist für jeden Arzt eine hohe Belastung. So ist es verständlich, wenn Ärzte zugeben, wie schwer es für sie ist, aufgrund unsicherer Voraussetzungen einen Beschluss zu fassen, der über Leben und Tod entscheiden kann.

Rechtliche Grenzen in Abhängigkeit der medizinischen Leistungsfähigkeit (Kutzer 2005)

Wenn die Würde des Menschen – wie der Bundesgerichtshof zu Recht festgestellt hat – es gebietet, das in einwilligungsfähigem Zustand ausgeübte Selbstbestimmungsrecht auch dann noch zu respektieren, wenn der Patient später infolge Unfalls, Alters oder Krankheit zu eigenverantwortlichem Entscheiden nicht mehr in der Lage ist, ist dies ein grundrechtlich

▼

gesicherter Achtungsanspruch. Das heißt: Der mängelfrei und formgerecht vorweg bekundete Wille des Patienten gilt immer dann, wenn er auf die konkrete Entscheidungssituation zutrifft und der Patient die Bekundung nicht zwischenzeitlich widerrufen hat. Er gilt also ohne Rücksicht auf Art und Stadium der Erkrankung. Soll der Patient trotz entgegenstehender Patientenverfügung erst dann sterben dürfen, wenn sicher ist, dass die irreversible Erkrankung schon einen tödlichen Verlauf angenommen hat? Was soll in den häufigen Zweifelsfällen gelten, in denen der Arzt nicht ausschließen kann, dass eine weitere kurative Behandlung doch noch den tödlichen Verlauf aufhalten kann?

Würde die rechtliche Grenze des Selbstbestimmungsrechts sich je nach dem Inhalt der ärztlichen Prognose verschieben und von der sich verändernden Leistungsfähigkeit medizinischer Apparaturen und von der tatsächlichen Ausstattung des Krankenhauses abhängen, so wäre sie nicht mehr eigengesetzlich festgelegt, sondern zu einer Variablen der jeweiligen ärztlichen Prognose degradiert. So könnte der lebensmüde hochbetagte Mensch, der an mehreren schweren Erkrankungen oder an einem multiplen Organversagen leidet, von denen jedes Symptom für sich genommen noch kurativ behandelbar erscheint, nicht mehr rechtswirksam verfügen, bei einem Notfall nicht mehr in ein Krankhaus eingeliefert und nicht wiederbelebt werden zu wollen.

Richtige Entscheidungen zu treffen setzt ebenso gute medizinische Fachkenntnisse voraus wie einen genauen Einblick in die zu beurteilende Situation. Der Arzt muss den Patienten aus der Anamnese genauso gut kennen wie die aktuelle Entwicklung und die Prognose. Es wäre eine Katastrophe (und u. U. strafbar), wenn leichtfertig über Leben und Tod entschieden würde (Downie u. Calman 1994).

Bei einigen Krankheiten können erfahrene Ärzte trotzdem mit großer Wahrscheinlichkeit voraussagen, ob eine Heilung außerhalb des Möglichen liegt. Bei einer Reihe von Krebskrankheiten im fortgeschrittenen Stadium ist dies der Fall, ebenso bei zahlreichen anderen fortgeschrittenen Organerkrankungen. Das Finalstadium einer Erkrankung ist grundsätzlich schwierig zu beschreiben. Jede Krankheit hat bei jedem Patienten ihren besonderen Verlauf. Am deutlichsten wird dies bei alten Patienten. Sie können unabhängig

von ihrem Alter lange ihre Autonomie und ihre Integrität bewahren. Sie mögen ihre gesamte Familie verloren haben, und sie können trotz altersbedingter Funktionsstörungen ein Leben führen, das für sie eine hohe Lebensqualität hat. Dies kann eigentlich nur derjenige selbst oder ein anderer beurteilen, der diesen Menschen genau kennt, etwa der ihn seit Jahren betreuende Arzt (Morgan 1996).

Gleichwohl gibt es für das Finalstadium bestimmte Merkmale. Wenn zusätzlich zum nicht heilbaren Grundleiden schwere Begleitsymptome oder Sekundärerkrankungen auftreten, der Allgemeinzustand schwer beeinträchtigt ist, mehrere Organsysteme versagen, die Richtung der Verschlechterung deutlich ist, das Bewusstsein zunehmend beeinträchtigt ist, der Patient selbst nicht mehr die Kraft und den Willen hat, für seine Genesung zu kämpfen, dann spricht vieles dafür, dass er bald sterben wird. Die Engländer nennen diese Situation »the point of no return«. Die Flieger verwenden diesen Ausdruck für das Abhebe- und das Landemanöver, bei denen jeweils ein Punkt erreicht wird, von dem an sie nicht mehr umkehren können. In der Medizin ist damit gemeint, dass der Punkt erreicht wird, an dem sich das Ziel der medizinischen Behandlung ändert. Der Arzt muss jetzt erkennen und akzeptieren, dass ein friedliches und würdevolles Sterben Hauptaufgabe seiner weiteren Patientenbetreuung ist.

Der Ausdruck »point of no return« hat für den Piloten noch einen anderen positiven Aspekt. Es ist für ihn »the moment of maximal attention«, der Augenblick, der größte Aufmerksamkeit verlangt.

Diese »größte Aufmerksamkeit« finden wir am Anfang des Lebens, bei der Geburt. Viele Menschen halten diesen Augenblick für einen heiligen, unendlich wichtigen Moment des Lebens. Im Vergleich dazu kann die Lage der Sterbenden oft traurig sein. Sie bekommen selten die Zuwendung, die sie brauchen; sie sterben häufig unter großem Therapieeinsatz und in großer Einsamkeit. Ist aber der Augenblick des Sterbens nicht ein genauso wichtiger Augenblick wie der der Geburt?

2.2.5 Wann sollen wir die lebenserhaltende Therapie nicht einstellen?

Wenn ein 80-Jähriger eine Schenkelhalsfraktur erleidet, können eine schnelle Operation und Mobilisation dem Kranken innerhalb weniger Wochen gut

rehabilitieren. Würden Operation und Mobilisation nicht erfolgen, wäre die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass der Patient dann im Bett liegen bliebe und dass wegen der fehlenden Mobilisation dann innerhalb von Wochen und Monaten medizinische Komplikationen einträten, die unter Umständen einen vorzeitigen Tod hervorrufen könnten. Läge einer solchen Nichtbehandlung die Beurteilung oder gar Anordnung eines Arztes zugrunde, so dürfte diese keineswegs befolgt werden, da sich aus ihr der Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung ergäbe.

Als unterlassene Hilfeleistung (vielleicht sogar als Tötungsdelikt) wäre auch zu werten, wenn in einem Krankenhaus bei knapper Bettenzahl einem alten, unsympathischen, allein stehenden Pflegepatienten, der aus sozialen Gründen nicht entlassen werden kann, aus diesen Gründen bei einer schweren Pneumonie die notwendigen Antibiotika vorenthalten würden.

Beim zerebrovaskulären Insult folgt oft eine Halbseitenlähmung und eine Bewusstseinstrübung des Patienten. Als Folge davon kann dieser völlig außerstande sein, Nahrung oder Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Es kann sogar vorkommen, dass ein solcher Patient sich weigert, mit Hilfe anderer Nahrung und Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Diese Weigerung kann auf die auf den Schlaganfall folgende Bewusstseinsstörung zurückzuführen sein.

Diese Krankheitssymptome können, wie wir wissen, reversibel sein. Erst nach Tagen oder Wochen der aktiven Therapie kann genauer bestimmt werden, wie schwer der Gehirnschaden und die Funktionsstörung des Patienten sind und ob sie irreversibel sein werden. Während dieser Zeit wird es aber richtig sein, dem schwerkranken Patienten, vielleicht sogar gegen seinen bewusstseinsgetrübten Willen, eine maximale Therapie anzubieten. Falls sich jedoch nach dieser Zeit der Zustand des Kranken als so ernst herausstellt, dass er mit dem Leben nicht mehr vereinbar erscheint, dann kann es genauso richtig und wichtig sein, die angefangene Therapie zu unterbrechen.

An dieser Stelle sollte ein international anerkanntes, in Deutschland aber oft verkanntes Prinzip der medizinischen Ethik erwähnt werden: der Appleton Consensus. Er wurde im Jahr 1989 bei einem Treffen führender medizinischer Ethiker aller westlichen Nationen beschlossen. Das Dokument hat weltweite Anerkennung und großen Einfluss gewonnen. Daraus ein Zitat: »Ethisch betrachtet, besteht kein Unterschied zwischen dem Unterlassen und dem Unterbrechen einer aktiven Behandlung.« (Appleton Consensus 1989)

2.2.6 Wenn die Entscheidung besonders schwer fällt, sollte man sich Zeit lassen

Eine wichtige Aussage des zuvor zitierten Appleton Consensus gibt uns das, was wir vor schwierigen ethischen Entscheidungen vor allem brauchen: Zeit. Bei all den oben angeführten Fällen sind wir mehr oder weniger davon ausgegangen, dass wir alle notwendigen Informationen sammeln konnten, bevor die wichtigen Entscheidungen getroffen wurden. In der klinischen Praxis ist dies häufig nicht möglich. Die Patienten werden nicht selten notfallmäßig im Krankenhaus aufgenommen, und es gibt keine Angaben zur Vorgeschichte der Patienten. In solchen Situationen, in denen wir nicht die Hintergründe kennen, weder über die Krankheitsentwicklung noch über den Allgemein- und Funktionszustand des Patienten informiert sind, können wir nur in Ausnahmefällen Entscheidungen über Einstellung oder Abbrechen der therapeutischen Maßnahmen treffen. Dazu brauchen wir Zeit und ausreichende Information.

Es kommt leider durchaus vor, dass sterbende Patienten als Notfall zur Aufnahme ins Krankenhaus geschickt werden, weil die Versorgung zu Hause unzureichend war oder weil ein Notarzt gerufen wurde, dem der Patient unbekannt ist. Wenn ein solcher Patient im Krankenhaus ankommt und die genaue Krankengeschichte hier bei der Aufnahme nicht vorliegt, kann der Aufnahmearzt nichts anderes tun, als die vorliegenden behandlungsbedürftigen Probleme anzugehen. Das Gleiche gilt, wenn ein Patient in akuter Lebensnot aufgefunden wird – sei es auf der Straße oder zu Hause oder auf einer Krankenstation. Wenn dem dann gerufenen Arzt die genaue Krankengeschichte und die aktuelle Krankheitsentwicklung nicht vorliegen, muss er sich zunächst für ein sehr aktives Handeln entscheiden, um womöglich das Leben des Patienten zu retten oder schwere Komplikationen zu verhindern.

Der Consensus von Appleton zeigt uns nun, dass durch diese aktiven primären Behandlungsmaßnahmen die weitere ärztliche Behandlung keineswegs präjudiziert wird. Wenn am nächsten Tag die genaue Krankengeschichte bekannt wird und die medizinische Gesamtsituation zu überblicken ist, kann, falls es für sinnvoll und richtig erachtet wird, die begonnene Therapie durchaus abgebrochen werden. Das kann selbstverständlich nur dann geschehen, wenn die behandelnden Ärzte nach einer Gesamtbeurteilung zu der Einsicht gelangen, dass eine Fortsetzung der Therapie nicht im Interesse des Patienten liegt und dass weitere Therapiemaßnahmen tatsächlich nur dazu dienen können, den fortgeschrittenen Sterbeprozess hinauszuziehen.

2.2.7 Wie soll eine Therapie eingestellt werden?

Soll die Einstellung erfolgen
- durch »Einfrieren« der Therapiemaßnahmen?
- durch vorsichtige Reduktion der Therapiemaßnahmen?
- durch das Absetzen aller Therapiemaßnahmen?

In der folgenden Diskussion setzen wir voraus, dass die medizinisch-ethischen und die rechtlichen Grundlagen für ein passives Sterbenlassen – wie Entsprechung des mutmaßlichen Patientenwillens und irreversibler Sterbeprozess – bei einem nichtautonomen Patienten erfüllt sind.

Vor uns liegt ein Patient im Sterben, der aufgrund seiner Krankheit keine Entscheidungen treffen kann. Die behandelnden Ärzte sind sich einig, dass der Sterbeprozess irreversibel ist. Wir haben die zuverlässige Information – z. B. durch eine Patientenverfügung, einen von den Patienten ernannten Gesundheitsbevollmächtigten, durch vorherige Gespräche mit dem Arzt oder durch Angaben von mehreren glaubwürdigen Angehörigen –, dass der Kranke einer Verlängerung des Sterbens nicht zugestimmt hätte.

Es ergeben sich grundsätzlich fünf verschiedene Handlungsmöglichkeiten:

1. Das therapeutische Regime bleibt unverändert, d. h. die intensivtherapeutischen Maßnahmen werden weder gesteigert noch reduziert. Je nach der Situation werden auftretende Komplikationen behandelt oder nicht behandelt.
2. Die medikamentöse Substitution wird teilweise oder vollständig reduziert (z. B. Antibiotika, Kreislaufmittel).
3. Die Ernährung und Flüssigkeitssubstitution wird teilweise oder vollständig reduziert.
4. Technischer Behandlungsabbruch, z. B. durch teilweise oder vollständige Reduktion von Dialyse oder Beatmung.
5. Die Einstellung jeglicher Therapie – inklusive der Beatmung.

Unter den beschriebenen Voraussetzungen sind diese Maßnahmen ethisch und rechtlich einem passiven Sterbenlassen zuzuordnen; der Patient stirbt infolge seiner Grundkrankheit – nicht infolge unserer Handlung.

Trotzdem kann beobachtet werden, dass Ärzte diese Entscheidungen ethisch verschieden bewerten. Für viele ist es weitaus problematischer, eine begonnene Therapie zu beenden, als eine Therapie nicht zu beginnen. Es ist

nicht einfach für Ärzte, Patienten sterben zu lassen, besonders dann nicht, wenn sie dabei das Gefühl haben, für das Sterben mitverantwortlich zu sein.

Man kann sogar feststellen, dass sich das Verhalten deutscher Ärzte in diesen Entscheidungsprozessen von dem ihrer Kollegen in den westlichen Ländern unterscheidet. In Deutschland wird auch nicht selten dann noch weiter therapiert, wenn sich in einem vergleichbaren Fall ausländische Kollegen für einen Behandlungsabbruch bei sterbenden Patienten entschieden hätten. Die Erklärung dafür kann in der jüngeren deutschen Geschichte zu finden sein. Deutsche Ärzte wollen nicht noch einmal angeklagt werden, Menschen vorzeitig dem Tode ausgeliefert zu haben.

Jemand braucht Zeit

Bringt eine Verzögerung des Sterbeprozesses für einen sterbenden, bewusstlosen oder schwer bewusstseinsgestörten Patienten Vorteile? Es kann sein, dass Angehörige oder Behandlungspersonal noch Zeit brauchen, um die gefallene Entscheidung zu akzeptieren und um sich auf den bevorstehenden Abschied vorzubereiten. Falls möglich, sollte diese benötigte Zeit – Stunden oder Tage – gewährt werden. In dieser Situation kann es sinnvoll sein, sich für Punkt 1 zu entscheiden: Das therapeutische Regime bleibt unverändert, d. h. die intensivtherapeutischen Maßnahmen werden weder gesteigert noch reduziert. Der Patient stirbt an den zu erwartenden medizinischen Komplikationen, die symptomatisch behandelt werden.

Die Frage »Wie lange« muss uns vor Augen stehen, denn die gewährte Zeitspanne *kann* eine zusätzliche Belastung für den Patienten, für Angehörige und Personal bedeuten. Es kann aber auch eine gute Zeit der Vorbereitung auf den bevorstehenden Abschied bedeuten. Auf jeden Fall muss der behandelnde Arzt in den Gesprächen mit den Angehörigen klarstellen, dass *er* die Verantwortung für die getroffene Entscheidung trägt. Dabei sollte er sich die notwendige Zeit nehmen, um ungeklärte Fragen und Reaktionen zuzulassen.

Zusätzliches Leiden verhindern

Oft empfinden die Ärzte, dass eine Therapie leichter abzusetzen ist als eine andere. Oft fällt es leichter, die Therapie graduell zu reduzieren oder sie »einzufrieren«. Einfrieren bedeutet, dass man auf weitere Therapiemaßnahmen

verzichtet, die man eingesetzt hätte, wenn Hoffnung auf die Genesung des Patienten bestanden hätte.

Das Abbrechen einer Antibiotikatherapie, eine Einstellung der Ernährung, der Flüssigkeitszufuhr, der Dialyse oder Respiratortherapie bereitet vielen Ärzten große Bedenken, da sie glauben, das Leiden des Patienten zu vergrößern.

Bei sterbenden Patienten treten häufig Komplikationen wie eine Pneumonie oder ein Lungenödem auf. Beides kann qualvoll sein. Sollte es dann nicht unsere Aufgabe sein, diese Komplikationen der Grunderkrankung zu behandeln? Aber sind auf der anderen Seite nicht gerade ein Lungenödem oder eine Pneumonie die häufigsten Todesursachen – eine Gelegenheit für sterbende Patienten, dass sie sterben dürfen?

In der Palliativmedizin haben wir gesehen, wie friedvoll Patienten trotz dieser Komplikationen sterben können. Die Voraussetzung ist, dass nicht länger die Krankheitsursache, sondern die Folgen und das Leiden durch gezielte Therapiemaßnahmen behandelt werden.

Komplizierter zu beantworten ist für viele die Frage der Ernährung oder Flüssigkeitssubstitution bei Patienten, die nicht länger essen oder trinken. Es ist qualvoll zu hungern, sagen viele, und noch schlimmer, zu verdursten. Wir haben im Medizinstudium gelernt, dass Patienten, die nicht trinken können, auf jeden Fall eine Infusion bekommen müssen.

Die Erfahrungen bei einem bis zum Tod durchgeführten Hungerstreik zeigen uns einen nichtqualvollen Sterbeprozess, ein allmähliches Schwächerwerden des Betroffenen – bis zur Bewusstlosigkeit und zu einem friedvollen Sterben (Ahronheim u. Gasner 1990).

Und die Flüssigkeitssubstitution? In der gesamten medizinischen Dokumentation liegt *kein* Nachweis vor, der zeigt, dass Durst bei Sterbenden durch Zufuhr von Flüssigkeit gelindert werden kann (Twycross 1993). Basierend auf einer Übersicht der wissenschaftlichen Literatur ist es wahrscheinlich, dass fortgeschrittene Dehydrierung und Hunger zu keinen Schmerzen und nur zu geringem Unbehagen durch trockenen Mund führen. Letzteres kann gelindert werden. Bei Personen, die unter der Belastung von fortgeschrittener Krankheit und Invalidität leiden, oder bei denjenigen, bei denen eine Verbesserung ihres Zustands in der allerletzten Phase ihres Lebens nicht mehr zu erwarten ist, sollte eine Ernährung oder Hydrierung im Finalstadium nicht angeboten, ggf. abgebrochen werden. Ängste, dadurch das Leiden des Patienten zu vergrößern, sind von der Sache her unbegründet (Sullivan 1993).

Oft können wir erleben, dass die Angehörigen vehement verlangen, dass der sterbende Patient, wenn er nicht mehr trinkt und isst, Flüssigkeit und Nahrung durch eine Sonde oder über eine Infusion erhält. Viel zu oft lenkt der Arzt in diesen Situationen ein, um einen Konflikt mit den Angehörigen zu vermeiden, ohne dass er den notwendigen Kommunikationsprozess hierüber erst tatsächlich in Gang gebracht hätte. Im Fachjargon wird dieser »finale Tropf« häufig »Angehörigentropf« genannt.

Hier ist wieder eine kompetente Analyse gefragt. Wir wissen, dass in den meisten Kulturen Essen und Trinken mit Gesundheit und Leben auf das Engste verknüpft sind und dass das Gegenteil, nicht zu essen und zu trinken, interpretiert wird als ein Versagen derer, die sich um den Patienten kümmern, möglicherweise als Uneinsichtigkeit des Patienten in Bezug auf seine »Gesundung« und als zum Tode führend. Wenn die Angehörigen noch nicht erfasst haben, dass der Patient bereits sterbend ist, ist es mehr als zu erwarten, dass sie Ernährung und Hydrierung verlangen.

Die zentrale ethische Aufgabe ist wieder *Kommunikation*. Den Angehörigen muss mit Kompetenz und Empathie verständlich gemacht werden, dass der Augenblick des Todes nahe ist. Weiterhin müssen sie verstehen, wie wichtig jetzt ihre Anwesenheit und die Durchführung palliativer Maßnahmen sind, dass aber »künstliche« Hydrierung oder Ernährung nach unserem Wissenstand nicht mehr eine Linderung von Durst oder Hunger bringen kann, sondern - im Gegenteil – oft zu einer bedeutenden Verschlechterung des Zustands in den letzten Tagen und Stunden beitragen kann, z. B. durch Verursachung/Begünstigung eines Lungenödems. Nach meiner Erfahrung lenken die Angehörigen nach einem gut gelaufenen Kommunikationsprozess immer ein und sagen: »*Vielen Dank, das haben wir nicht gewusst…*«

Musgrave et al. (1995) fanden in einer Studie keine Korrelation zwischen Flüssigkeitszufuhr, Serumanalyse von Kalium, Natrium und Harnstoff und Durstangaben der Patienten, obwohl 70% von ihnen bereits manifeste Zeichen einer Harnretention zeigten.

Eine Reihe wissenschaftlicher Beiträge (Twycross 1993; McCann et al. 1994) dokumentieren das Hauptproblem, die durch Mundatmung bedingte Mundtrockenheit mit Infektionen und Belägen im Lippen-, Zungen- und Rachenbereich.

Viele dieser Patienten bekommen einen Tropf, obwohl nach unserem heutigen Wissen *kein Nachweis* vorliegt, dass dieser Linderung oder Vorteile für den Sterbenden bringt. Die notwendige kompetente Mundpflege und

Mundhygiene, Befeuchtung von Lippen, Zunge und Rachen, erhalten diese Patienten *nicht!* (Andrews et al. 1993; McCann et al. 1994)

Wir müssen uns bei jedem Patienten fragen, welche Vor- und Nachteile eine Infusion bringen kann – für den Patienten, für die Angehörigen und für den Arzt. Die heute vorliegenden wissenschaftlichen Daten deuten zunehmend darauf hin, dass eine iatrogene Flüssigkeitszufuhr Sterbenden keinen Nutzen bringt und für sie eine erhebliche Belastung darstellt.

In einer Studie zeigte Ahmedzai (unveröffentlich), dass bei Sterbenden, die Infusionen bekamen, das Durstzentrum des Gehirns nicht deaktiviert wurde. Eine deutliche Deaktivierung hingegen erfolgte durch gute Mundhygiene und wiederholte Befeuchtung von Lippen, Mund und Rachen.

Die meisten sterbenden Patienten werden nicht unter Dehydrierung leiden (Andrews et al. 1993). Andererseits könnte es Situationen geben, wie z. B. bei präfinalem Delirium, wo die Symptome durch Zufuhr von Flüssigkeit gebessert werden (Fainsinger u. Bruera 1994; ▶ Kap. 4.10).

Als besonders schwierig empfinden im deutschsprachigen Raum viele Ärzte die Fragen des *technischen Behandlungsabbruchs*.

Bei sterbenden Patienten mit Nierenversagen die Dialyse einzustellen, trifft häufig auf Verständnis, da eine Urämie weitgehend ein friedvolles Sterben ermöglicht. Dem gegenüber steht die Unterbrechung einer etablierten Respiratortherapie. Die Einstellung dieser Behandlung würde für einen über längere Zeit beatmeten Patienten das Eintreten des Todes innerhalb weniger Minuten durch eine respiratorische Insuffizienz bedeuten. Hypoxämie und Hypoventilation durch eine unzureichende Atemmechanik spielen hierbei eine entscheidende Rolle. Beendigung der Beatmung und Extubation des Patienten kann eine Dyspnoe und damit zusätzliches Leiden zur Folge haben in einer Situation, in der alles unternommen werden muss, Leiden zu verhindern.

Aber stehen wir hier nicht vor einem ähnlichen Problem wie bei der Behandlung des finalen Lungenödems und der finalen Pneumonie? Könnte nicht die Weiterbeatmung, unter Umständen bei bis auf Raumluft reduzierter Sauerstoffzufuhr, eine Verlängerung des Leidens des Patienten bedeuten? Und ist diese Weiterbehandlung nicht eine zusätzliche Belastung für die Angehörigen und das Personal?

Aber die Befürchtung einiger deutscher Mediziner, der Patient könne durch die Extubation wegen fortgeschrittener Ateminsuffizienz ersticken, was für Patient, Angehörige und Personal zu unangenehmen Erlebnissen und Erinnerungen führen könnte, kann aus der intensivmedizinischen Praxis aus

den skandinavischen und angelsächsischen Ländern und auch von deutschen Kollegen nicht bestätigt werden (Pellegrino u. Thomasma 1994; Downie u. Calman 1994; F.J. Tentrup, persönliche Mitteilung 1997). Die medizinischen Probleme konnten, wenn es die Situation erforderte, durch Applikation von Analgetika und Sedativa suffizient unter Kontrolle gehalten werden.

Die große Mehrheit der Angehörigen berichtete, dass es für sie eine positive Erfahrung gewesen sei, beim Abschluss der Behandlung und beim Sterben des Patienten dabei gewesen zu sein. Es war für sie nicht erschreckend zu sehen, wie innerhalb weniger Minuten der Tod eingetreten sei. Der Lebensausklang verbinde sich in ihrer Erinnerung mit einem Gefühl der Erleichterung, das sowohl den Patienten wie sie selbst betraf. Wiederholt berichteten Angehörige, dass ihnen die Zeit der Extubation und die Zeit danach wie eine tiefgreifende Feier des Abschieds erschien (Husebø 1992). Um den Patienten und den Angehörigen einen bewussten Abschied zu ermöglichen, sollte eine ordnungsgemäße Entwöhnung vom Respirator angestrebt werden, falls dies eine realistische Möglichkeit darstellt. Bei bewusstlosen sterbenden Patienten kann unter Umständen auch die Beendigung der Beatmung mit Extubation eine Möglichkeit sein, die im Interesse des mutmaßlichen Patientenwillens liegt. Dies ist dann moralisch und ethisch nicht anders zu bewerten als andere Formen des technischen Behandlungsabbruchs (Pellegrino u. Thomasma 1994, Brock 1993).

Unser Hauptanliegen muss das Wohl des Patienten bleiben. Keine Entscheidungen dürfen getroffen werden gegen den mutmaßlichen Patientenwillen oder weil Angehörige oder das Krankenhauspersonal ihre eigenen persönlichen Interessen oder Gefühle in den Vordergrund stellen. Die Fortführung oder der Abbruch von Maßnahmen dürfen auch niemals eine Frage wirtschaftlicher Überlegungen sein (Beleites 1997).

Welche Motive hat der Arzt?

Es ergibt sich eine Reihe von Fragen:

- Welche Motive liegen den Entscheidungen und Handlungen des Arztes zugrunde?
- Welche Konsequenzen ergeben sich für den Patienten und seine Angehörigen?
- Ist der Nutzen einer weiteren Therapie größer, oder überwiegt die Belastung?

- Braucht jemand Zeit (Ärzte, Pflegepersonal, Angehörige), um die getroffene Entscheidung zu akzeptieren?
- Hat die Entscheidung, die Therapie einzufrieren oder zu reduzieren, nicht die gleiche Konsequenz wie das Absetzen aller lebenserhaltenden Therapiemaßnahmen?
- Trifft es zu, dass der Entschluss zur Reduktion oder zum Abbruch der Therapie ausschließlich gefasst wird, um das Sterben des Patienten nicht unnötig zu verlängern?

Wir sehen hier wichtige und zentrale Fragen der medizinischen Ethik.

Auf wen sollen wir Rücksicht nehmen (Jecker u. Pearlman 1992):

- auf den Patienten?
- auf den Arzt?
- auf das Krankenpflegepersonal?
- auf die Angehörigen?
- Gibt es andere wichtige Personen?
- Wer beeinflusst noch unsere Entscheidungen?

Wenn wir diese Fragen genau betrachten, sehen wir, dass unterschiedliche Interessen bestehen, aus denen sich Konflikte ergeben können. Konflikte entstehen aber nicht nur im Verhältnis Arzt–Patient, im eigenen ärztlichen oder pflegerischen Team, sondern auch gegenüber den Angehörigen, interdisziplinär und über das eigene Krankenhaus hinaus (Callahan 1991).

Aus der Sicht der Autonomie und der Würde der sterbenden Patienten können wir die in ▶ Kap. 2.2.7 genannten fünf Entscheidungsmöglichkeiten auf drei reduzieren (Smith 1995):

1. Das therapeutische Regime bleibt unverändert.
2. Das therapeutische Regime wird reduziert.
3. Jegliche Therapie wird eingestellt, inklusive technischer Behandlung wie z. B. Dialyse oder Beatmung.

Auch bei diesen Alternativen gehört es unverzichtbar zu den ärztlichen und pflegerischen Aufgaben, für eine menschliche und palliativmedizinische Basisbetreuung zu sorgen. Welcher Weg der richtige ist, muss der Arzt in der jeweiligen Situation mit seinen Kollegen gemeinsam entscheiden. Es gibt keine Universallösung wie und wann eine Therapie beendet werden soll. Es ist schwer, feste Regeln aufzustellen, wie im Einzelfall Entschei-

dungen aussehen sollen und welche Vorgehensweise adäquat ist. Diese ethischen Entscheidungen müssen immer individuelle Entscheidungen sein (Buchanan u. Brock 1989, Randall u. Downie 1996). Im Zweifelsfall werden der fachlichen Begründung und den Motiven des Arztes moralisch wie rechtlich entscheidender Wert beigemessen (Eser et al. 1992; Brock 1993).

Können wir aus dieser Diskussion etwas lernen? Ärzte, Pflegepersonal, Patient und Angehörige haben häufig jeweils unterschiedliche Motive und Argumente für die eine oder andere Entscheidung. Für sterbende Patienten kann eine Verzögerung des Sterbeprozesses eine Verlängerung des Leidens bedeuten. Wir können verschiedene Gründe haben, die mehr oder weniger berücksichtigt werden sollten, um Zeit zu gewinnen.

Wir Mediziner haben allen Anlass, unser Verhalten und dessen Rechtfertigung kritisch und neu zu überdenken (Buchanan u. Brock 1989). Bisher war es einfach, sich hinter der häufigen Argumentation zu verschanzen, eine Fortsetzung der Therapie sei für Patienten und Angehörige gut. Dabei wird übersehen, dass das Problem des Aufhörens häufig ein Problem des behandelnden Arztes ist.

Um dem belastenden Augenblick eines unausweichlichen Todes zu begegnen, kann es für den Arzt leichter sein, sich für das Einfrieren oder die langsame Reduktion der bisherigen Therapie zu entscheiden. Aber entspricht dies den Interessen der Patienten? Die Aufgabe des Arztes ist es, dieses Interesse zu erkennen, zu respektieren und zu vertreten, unter Berücksichtigung des eigenen Ethos und der vorhandenen Rechtslage.

Juristisch gesehen gibt es in Deutschland (ebenso in Österreich und der Schweiz) keine direkten Vorschriften zu den Fragen der passiven Sterbehilfe. Juristen beschäftigen sich zunehmend mit diesen Themen, wobei zwei aktuelle Urteile des Bundesgerichtshofs zeigen, dass ein Raum für passives Sterbenlassen unter bestimmten Voraussetzungen gegeben sein muss.

Urteil des BGH Mai 1991

Bei todkranken Patienten ist die Nichteinleitung oder der Abbruch lebensverlängernder Maßnahmen rechtlich zulässig.

Dies entspreche dem natürlichen, der Würde des Menschen gemäßen Verlauf des Sterbens. Maßstab sei der mutmaßliche Wille des Sterbenden und nicht das Ermessen der behandelnden Ärzte.

Die Ausschöpfung intensivmedizinischer Technologie ist, wenn sie dem wirklichen oder anzunehmenden Patientenwillen widerspricht, rechtswidrig.

Urteil des BGH September 1994

Die Erlaubnis zur passiven Sterbehilfe gilt auch bei Personen, die sich nicht im akuten Sterbeprozess befinden.

Der 1. Strafsenat hob die Verurteilung eines Arztes und des Sohnes einer unheilbar schwerst hirngeschädigten 72-jährigen Frau auf, die sich für den Abbruch der künstlichen Ernährung entschieden hatten.

Auch bei Komapatienten komme es nach dem verfassungsrechtlich verbürgten Selbstbestimmungsrecht auf den mutmaßlichen Willen des Patienten an.

Strafbar bleibt weiterhin die aktive Sterbehilfe – die gezielte Tötung eines Menschen, auch eines Todgeweihten, auf Verlangen. Die entscheidenden Urteile sind:

Urteil des BGH (Zivilsenat) vom 17. März 2003 (NJW 2003, 1588):

Lebenserhaltende oder -verlängernde Maßnahmen müssen unterbleiben, wenn dies der Patient vorher so angeordnet hat, wenn

- das Grundleiden des Betroffenen einen irreversiblen tödlichen Verlauf angenommen hat,
- der Arzt diese lebenserhaltende Maßnahme als nicht indiziert ansieht und sie nicht anbietet.

Im Konfliktfall entscheidet das Vormundschaftsgericht.

Beschluss des BGH (Zivilsenat) vom 08.06.2005 (XII ZR 177/03):

Wenn zwischen Arzt und Patientenvertreter Übereinstimmung besteht und die Unterlassung der Ernährung dem (mutmaßlichen) Willen des Patienten entspricht, kann die Durchsetzung dieser Anordnung gegenüber dem Heim (oder auch dem Krankenhaus) erzwungen werden. Der Hinweis auf den anders lautenden Pflegevertrag zwischen Patienten und Heim sowie die Gewissensentscheidungen des Pflegepersonals ist nicht stichhaltig.

2.3 Aktive Sterbehilfe (Euthanasie)

Das Wort »Euthanasie« ist aus dem Griechischen hergeleitet (*euthanatein:* »einen leichten, schönen Tod haben«). Historisch betrachtet, hat der Begriff »Euthanasie« eine andere Bedeutung als aktive Sterbehilfe. Euthanasie bedeutet »ein guter Tod«. Der Begriff könnte vom Wort her ein Synonym für das sein, was das Anliegen der Hospizbewegung ist. Ist doch ein gutes Sterben das, worum diese Bewegung sich bei vielen Menschen bemüht. Dabei wird von den Mitgliedern dieser Bewegung immer wieder betont, dass sie aktive Sterbehilfe grundsätzlich ablehnen und in ihrer eigenen Aktivität die entscheidende Alternative zur aktiven Sterbehilfe sehen (Moulin et al. 1994). Die menschliche Kulturgeschichte ist voll von Zeugnissen und Auseinandersetzungen über die Frage eines guten Todes des Menschen. Namhafte Historiker und Philosophen haben sich für einen angenehmen, vom Arzt herbeigeführten Tod ausgesprochen (Rachels 1975), noch mehr aber haben eindeutig dagegen Stellung bezogen (Brock 1993; Gaylin et al. 1988; Pellegrino u. Thomasma 1994; Roy 1990; Dunstan u. Shinebourne 1989).

In Deutschland wird die Diskussion über die aktive Sterbehilfe mit besonderer Sensibilität geführt. Zum Teil liegt es daran, dass viele Menschen vor und während des letzten Krieges von deutschen Ärzten umgebracht wurden – ihrer Rasse, ihrer Hautfarbe, einer Diagnose wegen oder weil sie physisch oder psychisch behindert waren. Überraschenderweise ist gerade in einem als besonders humanitär geltenden Nachbarland seit einigen Jahren die aktive Sterbehilfe unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen straffrei: in den Niederlanden.

Heute werden auf internationaler Ebene die Begriffe »aktive Sterbehilfe« und »Euthanasie« synonym verwandt, und wir werden in dem vorliegenden Buch ähnlich verfahren. In England wird dieses Verfahren »mercy killing« – »Töten aus Barmherzigkeit« – genannt, ein Ausdruck, der einen wichtigen Hinweis enthält: den Hinweis auf das Töten.

Definition

Aktive Sterbehilfe – Euthanasie

ist das aktive, bewusste ärztliche Eingreifen zur Beendigung des Lebens auf ausdrücklichen Wunsch des Patienten. Ziel der Handlung ist es, den schnellen Tod des Patienten herbeizuführen – zu töten.

Die Begriffe Euthanasie und aktive Sterbehilfe werden in der medizinischen Fachliteratur meistens dann verwendet, wenn das Leben eines schwerkranken Patienten durch Injektion von letalen Arzneimitteldosen, z. B. durch eine Kombination von Medikamenten wie Barbituraten, Morphin, Curare und/oder Kalium, vom Arzt beendet wird.

Die aktive Sterbehilfe ist in Deutschland wie in allen westlichen Ländern ein Straftatbestand, in einigen Nationen (Niederlande, Belgien) allerdings nur dann, wenn eine Verletzung der gesetzlich vorgeschriebenen Regelungen vorliegt. In der Schweiz ist die ärztliche Beihilfe zum Suizid legalisiert, was in der Praxis in unseren Augen gleich zu werten ist wie die aktive Sterbehilfe.

Obwohl in der Geschichte die Euthanasie immer wieder als gesellschaftliches Problem auftaucht, wird ihre Legalisierung in der medizinischen Fachwelt fast geschlossen mit der Begründung abgelehnt, dass ihre Konsequenzen nicht zu übersehen sind (World Medical Association 1987). Die heutige Euthanasiebewegung hat ihren Ursprung zum einen in den unwürdigen Umständen, bei denen Menschen ihr Leben unter Schmerzen, Leiden und Verlassenheit beenden, und zum anderen im Protest gegen die Macht der modernen Medizin.

Zum Thema der Euthanasie wurde in den letzten Jahren in Laien- und Fachgremien gleichermaßen Stellung bezogen. Wie Meinungsumfragen ergeben haben, nahm die Zustimmung der deutschen Bevölkerung zur aktiven Sterbehilfe in den letzten 20 Jahren deutlich zu. So stieg sie von 1974 mit 54% bis zum Jahr 1994 auf über 80%.

2.3.1 Argumente, die für eine aktive Sterbehilfe sprechen könnten

Das Recht des Patienten auf Selbstbestimmung (Autonomie)

Wenn nun ein schwerkranker Patient, erschöpft und geplagt von Symptomen, die nicht mehr unter Kontrolle zu bringen sind, völlig auf die Hilfe anderer angewiesen, zu uns sagt: »Ich leide, ich kann nicht mehr, hilf mir, damit es vorbei ist« – ist diese Bitte nicht verständlich und wohlbegründet? (Jens u. Küng 1995)

Wenn der Patient nun zusätzlich enttäuscht ist: von Angehörigen, die sich nicht länger kümmern, vom Gesundheitswesen, von den Ärzten, die nichts mehr zu bieten haben – wenn er das Gefühl hat, dass er seiner gesamten Umgebung nur zur Last fällt –, sollte man seine Bitte nicht respektieren? (Singer u. Siegler 1990)

Unerträgliche und ungelinderte Schmerzen und andere physische und psychische Probleme

Viele, die die letzten Wochen und Tage mit einem Sterbenden verbracht haben, berichten, dass es für den Patienten grausam war. Dies kann von vielen Angehörigen, Schwestern, Ärzten und anderen bestätigt werden. Die Schmerzen wurden unerträglich, eine Reihe anderer Symptome oder Probleme war nicht mehr zu kontrollieren: mochte es sich um Übelkeit, Erbrechen, Schwäche, Atemnot oder andere »physische« Symptome handeln oder auch um psychische Probleme wie Angst, Depression, Isolation, Hysterie oder Ähnliches.

Die Aufgabe der Ärzte ist es, das »Beste« für ihre Patienten zu tun

Wenn die Not und die Qualen des Patienten nicht mehr unter Kontrolle zu bringen sind, ist es dann nicht die Pflicht des Arztes, dem Patienten zu helfen, auch wenn dies das Herbeiführen eines schnellen Todes bedeutet? Hat die Pflicht zur Barmherzigkeit nicht immer im Mittelpunkt unserer Kulturgeschichte gestanden? (Jens u. Küng 1995; Boisvert 1990, Quill et al. 1992)

Die Ärzte haben längst angefangen, Leben und Tod zu manipulieren

Bei der Betrachtung der modernen Medizin wird deutlich, dass ein Teil der heutigen medizinischen Praxis darin besteht, Entscheidungen über Leben und Tod zu treffen. Wir beschrieben im vorigen Abschnitt, wie Ärzte fast täglich (notwendige) Entscheidungen treffen, um das Leben eines Patienten unter bestimmten Umständen nicht zu verlängern. Diese Entscheidungen haben in vielen Fällen den Tod des Patienten innerhalb weniger Tage oder Stunden zur Folge. Für die ethische Analyse ist es sehr schwierig, in solchen Fällen zwischen »Sterbenlassen« und »Töten« zu unterscheiden.

Dieser ethische Konflikt wird noch deutlicher am Anfang des Lebens, indem wir der Mutter das Recht zugesprochen haben, über das Leben des ungeborenen Kindes zu entscheiden. Sollte es moralisch und ethisch nicht vertretbarer sein, wenn ein Arzt einem schwer leidenden Patienten auf dessen ausdrückliche Bitte hilft, aus dem Leben zu scheiden, als das Leben eines Kindes zu beenden, das bestimmt hätte leben wollen?

2.3.2 Argumente, die gegen aktive Sterbehilfe sprechen

Aktive Sterbehilfe ist verboten und strafbar

Nach geltendem Recht ist aktive Sterbehilfe verboten und strafbar. Aus *juristischer Sicht* steht die »Tötung auf Verlangen« bisher in fast allen Ländern prinzipiell unter Strafe. In Deutschland ist dies festgelegt durch den §216 StGB (Eser et al. 1992). Die erste Ausnahme war der australische Bundesstaat Northern Territory, der 1995 beschloss, dem Arzt in bestimmten Fällen eine Tötung auf Verlangen zu erlauben. Dieser Beschluss wurde 1997 vom australischen Bundesgerichtshof wieder aufgehoben.

Es wird immer wieder Ärzte geben, die sich mit ethischen Fragestellungen wenig auseinandergesetzt und sich deswegen auch keine Kompetenz in der Ethik der Medizin angeeignet haben. Besonders diese Ärzte müssen wissen, welche Entscheidungen sie nach dem Gesetz treffen sollten und welche sie nicht treffen sollten, was strafbar ist und was nicht strafbar ist. Daher brauchen wir zu diesem Thema eine klare gesetzliche Vorlage.

Berufsethische Aspekte

Seit es eine Berufsethik für Ärzte gibt, haben diese sich gegen das Ansinnen der Gesellschaft zu wehren, ihnen auch (für bestimmte Fälle) eine Erlaubnis zum Töten einzuräumen. Sie fürchten, dass ihnen durch die Erlaubnis zu töten der ethisch-moralische Halt verlorengehen könnte, den sie in ihrem Berufsalltag dringend benötigen, und dass darüber hinaus aus der Erlaubnis zu töten eine Pflicht zum Töten entstehen könne. Autonomie und Selbstbestimmung eines Menschen können nicht dazu führen, einen Dritten dazu zu verpflichten, zu töten.

Ein Arzt, der bewusst einen Patienten tötet, auch wenn dieser schwer krank ist und schwer leidet, muss mit erheblichen Konsequenzen rechnen. Er sieht einer Freiheitsstrafe entgegen; eine Ausübung seines Berufs wird ihm weiterhin kaum noch gestattet werden.

So nahm der 98. Deutsche Ärztetag 1995 wie folgt Stellung:

> Mit Sorge verfolgt der Deutsche Ärztetag die Entwicklung der Praxis und der gesetzlichen Regelung der Euthanasie in den Niederlanden, droht mit ihr doch die Tötung unheilbar kranker Menschen zu einem Bestandteil ärztlicher Aufgaben zu werden.

Und weiter wird ausgeführt:

> Die Angst vor unerträglichem Leiden und vor den medizinischen Möglichkeiten der Lebensverlängerung darf nicht dazu führen, dass der Arzt auch mit der Erlaubnis zu töten ausgestattet wird. Der Deutsche Ärztetag tritt daher allen Bestrebungen zur Durchführung und Legalisierung aktiver ärztlicher Euthanasiemaßnahmen entschieden entgegen.

Diese Aussage wurde auf dem 99. Deutschen Ärztetag 1996 bekräftigt.

Auf dem 113. Deutschen Chirurgenkongress 1996 in Berlin wurde in den Leitlinien bezüglich der Begleitung Sterbender folgende Aussage gemacht:

> Inhalt ärztlicher Sterbebegleitung sind ärztliche und menschliche Zuwendung, die Linderung von Beschwerden sowie Schmerzbekämpfung. *Nicht* zum ärztlichen Behandlungsauftrag gehören: die Anleitung zur Selbsttötung, die Hilfe bei der Selbsttötung und die aktive Sterbehilfe.

Nachdrücklich wird darauf hingewiesen, dass die aktive Sterbehilfe »keinesfalls Inhalt des ärztlichen Behandlungsauftrages ist […] und mit großem Nachdruck abzulehnen ist«.

Auch die Bundesärztekammer hat in den Stellungnahmen *Richtlinien zur Sterbehilfe* (1979) und *Richtlinie zur Sterbebegleitung* (1993) sowie in den *Grundsätzen zur ärztlichen Sterbebegleitung* (2004) eindeutig gegen aktive Sterbehilfe Stellung genommen (Beleites 1997; BÄK 2004).

Menschen werden vorzeitig sterben

Die Erfahrungen aus den Niederlanden zeigen, dass die Möglichkeit zur aktiven Sterbehilfe, die eigentlich nur bei sterbenden und schwerst leidenden Patienten angewandt werden darf, auch in Fällen genutzt wird, in denen die Patienten nicht sterbend und nicht schwerst leidend sind. Es darf keine Praxis akzeptiert werden, die dazu führt, dass Menschen getötet werden, die statt aktiver Sterbehilfe eine Hilfe zum Leben benötigt hätten (Roy 1991).

Menschen können es als ihre Pflicht ansehen, aus dem Leben zu scheiden

Menschen können es als ihre Pflicht ansehen, aus dem Leben zu scheiden, weil sie glauben, von ihren Angehörigen, von ihrer Umgebung oder von der Gesellschaft nicht mehr ertragen zu werden (Ten Have u. Welie 1996). Patienten können alt und krank werden und sich einsam und verlassen fühlen. Durch scheinbar unerträgliches chronisches Leiden suchen sie aus Verzweiflung nach Auswegen. Wenn der Arzt die Erlaubnis hätte, unter solchen Umständen aktive Sterbehilfe zu leisten, könnte ein solcher Patient eine solche Lösung suchen, wenn der Arzt und die Gesellschaft das Signal gäben, aktive Sterbehilfe sei eine bequeme Lösung aus diesem Dilemma.

Schmerzen, andere Symptome, Angst und Not können durch gute Palliativmedizin gelindert werden

Die Mehrheit der Patienten, die vor dem natürlichen Tod getötet werden möchten, gibt als Hauptgrund Schmerzen und unerträgliches Leiden an (Van der Wal et al. 1996). Sie leiden unnötig, weil sie keine kompetente palliative Behandlung, Pflege und Fürsorge bekommen (World Medical Association 1987; Moulin et al. 1994). Die Alternative dazu, dass Inkompetenz und fehlendes Interesse zu unerträglichem Leiden führen, kann nicht darin liegen, diesen Menschen zu zeigen, dass sie für uns nichts mehr wert sind, indem wir sie töten.

Durch Euthanasie zeigen wir diesen Patienten, dass sie für uns nichts mehr wert sind

Eine Gesellschaft, in der der Arzt, aus welchen Motiven auch immer, nicht mehr das Leiden bekämpft, sondern den Leidenden tötet, ist auf dem besten Weg zu einer Menschenfeindlichkeit, die im »Kranken« und dem »Leiden« nur das »Unnütze« sieht, das durch die Euthanasie beseitigt werden soll. Der Wert, den ein Mensch seinem Leben beimisst, hängt entscheidend von dem Wert ab, den andere seinem Leben beimessen. Seine Würde hängt wesentlich vom Ansehen ab, das er in den Augen der Umwelt hat. Wenn wir ihm zu verstehen geben, dass wir sein Leben so wenig achten, dass wir bereit sind, ihn zu töten, nehmen wir bereits im Voraus seiner Existenz Würde und Wert. Nicht mehr die Erlösung des anderen, sondern die Erlösung vom anderen würde angestrebt.

Argumente, die für eine aktive Sterbehilfe sprechen

- Das Recht des Patienten auf Autonomie.
- Unerträgliche Schmerzen und andere physische und psychische Probleme.
- Die Aufgabe der Ärzte ist es, das »Beste« für ihre Patienten zu tun.
- Die Ärzte haben längst angefangen, Leben und Tod zu manipulieren.

Argumente, die gegen aktive Sterbehilfe sprechen

- Aktive Sterbehilfe ist verboten und strafbar.
- Berufsethische Aspekte.
- Menschen werden durch Inkompetenz anderer vorzeitig sterben.
- Menschen können es als ihre Pflicht ansehen, aus dem Leben zu scheiden.
- Schmerzen, andere Symptome, Angst und Not können durch gute Palliativmedizin gelindert werden.
- Durch Euthanasie zeigen wir diesen Patienten, dass sie für uns nichts mehr wert sind.

2.3.3 Die Erfahrungen in den Niederlanden

In den Niederlanden besteht seit Ende der 1970er Jahre die Möglichkeit, aktive Sterbehilfe auszuüben. Entgegen der Meinung vieler ist sie nicht legalisiert, d. h. dass derjenige, der eine aktive Sterbehilfe durchführt, sich theoretisch strafbar macht. In der Praxis verzichtet man aber in den Niederlanden in den letzten 20 Jahren in diesen Fällen auf eine Strafverfolgung. Dieser Verzicht soll aber nur unter bestimmten Voraussetzungen stattfinden.

Voraussetzungen, die die Straffreiheit bei aktiver Sterbehilfe gewährleisten, sind (Van der Wal et al. 1996):

- Dem Arzt muss ein ausdrückliches, freies und beständiges Verlangen des über seinen Zustand vollständig unterrichteten Patienten nach Tötung vorliegen.
- Es muss die Rede sein von einem untragbaren Leiden des Patienten.

- Der Patient muss sich in einem irreversiblen, unheilbaren Zustand befinden.
- Der Arzt muss einen weiteren, unabhängigen Mediziner zu Rate ziehen.
- Allein der behandelnde Arzt oder ein Arzt, der mit diesem gemeinsam beratschlagt hat, darf dem Gesuch des Patienten nach Sterbehilfe Folge leisten.
- Auf all sein Handeln muss der Arzt die größtmögliche Sorgfalt legen.
- Der Arzt hat einen ausführlichen Bericht über den gesamten Fall zu erstatten.

Dieses Verfahren nennt man in den Niederländen verkürzt »Meldeprozedur – Euthanasie«, obwohl sie ebenso für medizinisch assistierten Suizid sowie für Tötung des Patienten ohne dessen ausdrückliche Bitte Gültigkeit besitzt. Ziele des Gesetzgebers bei der Einführung dieser Meldepraxis waren:

- Die Sicherstellung der Überprüfbarkeit von Handlungen, die eine Beendigung des Lebens des Patienten zur Folge haben;
- den Ärzten über ihre lebensbeendenden Handlungen Auskunft zu geben;
- das Wissen über sorgfältiges medizinisch-ethisches Handeln zu vergrößern;
- die Vereinheitlichung der Meldeweise.

Die Kriterien, bei deren Erfüllung der Arzt mit Straffreiheit rechnen kann, wurden 1984 von der Königlich Niederländischen Ärztekammer, in der die überwiegende Mehrheit der niederländischen Ärzte organisiert ist, veröffentlicht. Voraussetzung für das Aussetzen einer Strafverfolgung muss die Erfüllung aller Kriterien sein (Van der Wal et al. 1996).

1983 wurden zehn Fälle gemeldet, davon wurden zwei strafrechtlich verfolgt; 1989 waren es bereits 338 Fälle, von denen einer strafrechtlich verfolgt wurde; 1994 wurden von 1427 gemeldeten Fällen zehn strafrechtlich verfolgt.

Da ganz offensichtlich nicht alle Fälle gemeldet wurden, wurden Anfang der 1990er Jahre zwei breit angelegte Studien durchgeführt und veröffentlicht, mit deren Hilfe man einen genaueren Überblick über die tatsächliche Anzahl der Euthanasiefälle zu gewinnen hoffte.

Van der Wal et al. befragten 1024 der insgesamt 6300 Hausärzte in den Niederlanden über ihre Euthanasiepraxis in den Jahren 1986–1989 (Tab. 2.1). Etwa 75% aller befragten Hausärzte waren in diesem Zeitraum

Tab. 2.1. Euthanasiepraxis in den Niederlanden (nach Van der Wahl et al. 1996)

a) Anzahl der Fälle		
	1995	1990
Anzahl der Sterbefälle insgesamt	135.700	128.800
Anzahl der von Patienten ausdrücklich ausgesprochenen Bitten um Euthanasie	9.700	8.900
Anzahl der tatsächlichen Euthanasiefälle	3.200	2.300
Anzahl der Fälle von medizinisch assistiertem Suizid	400	400
Anzahl der Fälle von Tötung ohne ausdrückliche Bitte	900	1.000

b) Ärztliches Verhalten in Hinsicht auf Euthanasie und medizinisch assistierten Suizid			
Euthanasie oder medizinisch assistierter Suizid	Hausärzte 1995 (n = 124) [%]	Ärzte 1995 insgesamt (n = 405) [%]	Ärzte 1990 insgesamt (n = 405) [%]
haben sie bereits einmal ausgeführt	63	53	54
haben sie nicht ausgeführt, wären aber unter bestimmten Umständen dazu bereit	28	35	34
würden sie selbst nie ausführen, den Patienten jedoch an einen anderen Kollegen verweisen	7	9	8
würden sie weder selbst ausführen noch den Patienten an einen anderen Kollegen verweisen	2	3	4

c) Begründung der Patienten für das Verlangen nach Euthanasie/medizinisch assistiertem Suizid nach Aussagen der Ärzte (Angaben in %)	
Aussichtsloses und unerträgliches Leiden	74
Vermeidung von Entwürdigung	56

▼

Tab. 2.1. *Fortsetzung*	
Vermeidung von stärkerem bzw. weiterem Leiden	47
Sinnloses Leiden	44
Schmerz	32
Lebensmüdigkeit	18
Vermeidung von Ersticken	18
Wunsch, der Familie nicht mehr zur Last zu fallen	13
Vermeidung von Schmerz	10
d) Wichtigste Gründe bei der Entscheidung des Arztes, ohne ausdrückliche Bitte das Leben des Patienten zu beenden (1995) (Angaben in %)	
Jede medizinische Handlung war sinnlos geworden	67
Keine Aussicht auf Verbesserung	44
Die Nächsten konnten es nicht mehr ertragen	38
Geringe Lebensqualität	36
Wollte nicht unnötig verlängern	33
(Unterstellter) Wunsch des Patienten	30
Vermeidung von Entwürdigung/weiterem Leiden	9
Eine Behandlung war eingestellt, doch der Patient verstarb nicht	2
Andere Gründe	8

wenigstens einmal mit dem Wunsch nach aktiver Euthanasie oder Hilfe zum Selbstmord konfrontiert worden; 47% von ihnen hatten mindestens einmal eine Tötung auf Verlangen durchgeführt oder Hilfe zur Selbsttötung geleistet. Die Initiative zum ersten Gespräch ging in 83% der Fälle vom Patienten aus, in 10% vom Hausarzt und in 6% von den Angehörigen.

Aus Teil b) der Tab. 2.1 können wir entnehmen, dass Euthanasie unter den holländischen Kollegen eine akzeptierte Handlung ist, obwohl etwa die Hälfte angeben, sie würden diese selbst nicht ausführen.

Nach diesem Bericht äußern in den Niederlanden jährlich etwa 9.000 Patienten (7% der Todesfälle) die konkrete Bitte um aktive Sterbehilfe. Etwa 2.300 Personen (1,8% der Todesfälle) sterben pro Jahr durch aktive Sterbehilfe, die gemäß der aufgeführten Kriterien gewährt wurde. 400 Personen (0,3%) erhielten Beihilfe zur Selbsttötung. In diesem Bericht wird auch mitgeteilt, dass in den Niederlanden in jedem Jahr bei etwa 1.000 Menschen (0,7% der Todesfälle) aktive Sterbehilfe durchgeführt wurde, ohne dass sie die Bitte um Euthanasie geäußert hatten. Zum Teil konnten sie diese Bitte nicht äußern, da sie nicht bei klarem Bewusstsein waren. Etwa die Hälfte dieser Patienten hatte zuvor selbst wiederholt den Wunsch nach Euthanasie geäußert oder klar ausgedrückt, dass sie Euthanasie wünschten, falls ihr Leiden unerträglich werde. Diese Patienten waren alle schwerkrank und hatten nach Angaben der Ärzte nur mehr kurze Zeit zu leben. Ihr Leiden wurde als unerträglich angesehen. Nur 4% der Ärzte in den Niederlanden lehnen die aktive Sterbehilfe grundsätzlich ab. Weitere 4% würden, falls ein Patient den Wunsch nach Euthanasie äußert, diesen an einen anderen Kollegen verweisen; 88% der niederländischen Ärzte halten die aktive Sterbehilfe oder die Hilfe zur Selbsttötung für ethisch vertretbar.

Selbst wenn mit Ausnahme der Niederlande weltweit praktisch alle ärztlichen Standesorganisationen die aktive Sterbehilfe ablehnen, ergibt sich die Frage, ob nicht auch in diesen Ländern aktive Sterbehilfe geleistet wird, ohne dass dies öffentlich bekannt wird. Dass wir uns in Deutschland damit auseinandersetzen müssen, zeigen nicht zuletzt Stellungnahmen und Umfragen in der Fach- und Laienpresse.

Sind die niederländischen Ärzte weniger moralisch eingestellt, weniger ethisch bewusst und geschult als ihre Kollegen in anderen westlichen Ländern? Oder sind die Niederländer nur mutiger, ein großes ethisches Problem offen anzusprechen und zu diskutieren?

In unseren Augen zeigen gerade die Erfahrungen aus Holland, wie gefährlich es für eine Gesellschaft werden kann, wenn die aktive Tötung von schwerkranken Menschen geduldet wird (Ten Have u. Welie 1996). Hauptgründe für die aktive Tötung waren für die Ärzte »Respekt vor Autonomie«, »Unerträgliches Leiden«, »Sinnlose Therapie«. Wie kann aber ein Arzt wissen, dass jemand getötet werden möchte, wenn der betreffende bewusstlos ist? Und sind nicht diese Begriffe sehr subjektiv, setzen sie nicht voraus, dass die Person, die »unerträglich leidet«, sich selbst dazu äußern kann?

Angebot erzeugt Nachfrage. Die Zahl der in Holland auf Verlangen getöteten Menschen zeigt zwar eine sinkende Tendenz (Onwuteaka-Philipsen

2003), aber die Anzahl der Patienten, die aktive Sterbehilfe bekommen, ohne ausdrücklich darum gebeten zu haben, ist nicht gesunken.

Die Vermutung liegt nahe, dass einige Patienten diese »Lösung« suchen, weil sie als einzige Alternative in einer schwierigen Lebenslage angeboten wird.

Allein die Tatsache, dass Patienten der aktiven Sterbehilfe zugeführt werden, ohne dass sie ausdrücklich selbst dies eingefordert haben, ist eine Bestätigung der Befürchtungen vieler Gegner einer Legalisierung der aktiven Sterbehilfe. Diese führen als eines der wichtigsten Argumente gegen die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe die Gefahr an, dass möglicherweise Patienten »unfreiwillig« getötet werden könnten. Die Befürchtung vieler Kritiker scheint zuzutreffen. Es werden »unschuldige« Menschen getötet (Chochinov 1995).

Die wichtigste Frage, die moralische Auseinandersetzung mit dem großen Thema, ob es moralisch und ethisch akzeptabel ist jemanden zu töten, rückt in Holland immer weiter in den Hintergrund. Die Diskussion hat heute zunehmend ihren Fokus auf technischen Lösungen und auf Meldeprozeduren. Die Moral hat sich in Prozedur aufgelöst wie bei der Praxis des Schwangerschaftsabbruchs.

Wäre nicht ein einziger Mensch, der mit aktiver Sterbehilfe getötet wird, ein Mensch zuviel, wenn er mit kompetenter Hilfe hätte leben können? Und ist dies nicht unsere Aufgabe, diese Hilfe kompetent anzubieten?

2.3.4 Aktive Sterbehilfe oder Palliativmedizin? Die neue Entwicklung in Europa und deren Konsequenzen

Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann etwas anderes
als Äquivalent gesetzt werden.
Was dagegen über allen Preis erhaben ist, das hat seine Würde.
(Immanuel Kant)

Als erstes europäisches Land haben die Niederlande eine Gesetzesänderung angenommen, die aktive Sterbehilfe unter bestimmten Vorbedingungen nicht unter Strafe stellt. Das niederländische Gesetz über die Kontrolle der Lebensbeendigung auf Verlangen ist am 01.04.2002 in Kraft getreten. Jedes Jahr erhalten ungefähr 3.000 Patienten nach wiederholtem Drängen aktive Sterbe-

hilfe durch ihren Arzt mit Hilfe einer tödlichen Injektion, die ihr Leben beendet. Zusätzlich wird bei schätzungsweise 1.000 Patienten aktive Sterbehilfe durchgeführt, ohne dass sie darum gebeten haben. Diese Patienten waren bewusstlos oder aus einem anderen Grund nicht in der Lage, in ihrer letzten Lebensphase auf Fragen zu antworten. In diesen Situationen hat der Arzt die Entscheidung im Namen des Patienten getroffen.

Im Jahr 2005 wurden in den Niederlanden parlamentarische Vorstöße unternommen, Euthanasiemaßnahmen bei unheilbar kranken Neugeborenen gesetzlich zu regeln; das Justizministerium bereitet eine Gesetzesvorlage vor. Aktive Euthanasie soll strafbar bleiben, aber nicht verfolgt werden, wenn Ärzte bestimmte, so genannte Sorgfaltskriterien beachten und einer Kommission anschließend Bericht erstatten. Die medizinische Prognose der in Frage kommenden Neugeborenen muss »aussichtslos« sein, die Kinder müssen »unerträglich leiden«, die Zustimmung der Eltern ist zwingend. Auch muss die Meinung eines weiteren Arztes eingeholt werden. Sind diese Kriterien auch für Ungeborene erfüllt, darf eine Schwangerschaft auch noch nach der 24. Woche abgebrochen werden.

Damit soll Empfehlungen von Experten gefolgt werden, die diese im »Protokoll von Groningen« zusammengestellt hatten (Verhagen et al. 2005). Darin hatten Ärzte für 22 Neugeborene im Zeitraum von 1997–2004 die Durchführung gezielt lebensbeendender Maßnahmen dokumentiert. Im Juli 2005 hat der niederländische Verband der Kinderärzte die dort formulierten Kriterien als Richtlinie anerkannt (Ärzte Zeitung Online, 1.12.2005).

Als zweites europäisches Land hat Belgien am 30.09.2002 ein Gesetz zur eingeschränkten Legalisierung der Euthanasie verabschiedet. Es sieht die Straffreiheit für eine Tötung auf Verlangen für unheilbar kranke Menschen unter Einhaltung bestimmter Auflagen vor: Der Kranke, der um Sterbehilfe ersucht, muss unheilbar krank, handlungsfähig, bei Bewusstsein und volljährig sein sowie seinen Wunsch mehrfach äußern.

Im Gegensatz zu Holland ist die Legalisierung der Sterbehilfe in Belgien nicht an das unmittelbare Bevorstehen des Todes geknüpft, sondern weiter gefasst. Unter anderem wurde es auch auf Fälle »dauerhaften und unerträglichen physischen oder psychischen Leidens« ausgedehnt. Zwischen Antragsstellung und Tötung müssen vier Wochen vergehen.

Die belgischen Regelungen sind detaillierter als die holländischen und schreiben unter anderem vor:

- Umfassende Aufklärung des Patienten durch den Arzt über Gesundheitszustand, Lebenserwartung, mögliche alternative Maßnahmen einschließlich der Palliativmedizin, mehrere Gespräche in zeitlichem Abstand.
- Einbeziehung des etwaigen Behandlungsteams.
- Wenn der Arzt der Überzeugung ist, dass der Tod nicht in Kürze eintritt, Hinzuziehung eines Psychiaters oder eines auf die betreffende Krankheit spezialisierten Arztes.
- Voraussetzungen und Form einer Patientenverfügung.
- Widerrufsmöglichkeiten.
- Keine Verpflichtung des Arztes zur Euthanasie.
- Rechtsanspruch auf Palliativmedizin.

Für Behinderte und Demenzkranke gilt das Gesetz nicht. Voraussetzung für Euthanasiemaßnahmen ist, dass die Sterbewilligen volljährig und im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte sind. Auch müssen sie mündlich oder schriftlich ausdrücklich den Wunsch nach Sterbehilfe geäußert haben. Laut einer Umfrage der Freien Universität Brüssel (VUB) bei 175 Neonatologen in Flandern (Provoost et al. 2005) befürworten jedoch viele auch die Legalisierung einer tödlichen Medikamentengabe bei schwerkranken Neugeborenen und Säuglingen. Ein Team der VUB hatte die Totenscheine aller Neugeborenen und Säuglinge in Flandern ausgewertet, die zwischen August 1999 und Juli 2000 gestorben waren. Von den 175 für das Ausstellen des Totenscheins verantwortlichen Ärzten hatten 121 an der anonymen Befragung teilgenommen. Innerhalb des Beobachtungszeitraums hatten 292 Kinder die ersten 12 Monate nicht überlebt. Mehr als die Hälfte von ihnen waren vor der 37. Schwangerschaftswoche geboren worden. Ein Drittel wies schwere angeborene Missbildungen auf.

In 143 Fällen (57%) trafen die Neonatologen gemeinsam mit den Eltern die Entscheidung zur aktiven oder passiven Euthanasie. Bei 68% von ihnen wurde die Intensivbehandlung abgebrochen oder gar nicht erst begonnen, 16% erhielten das Leben verkürzende Schmerzmittel, bei 9% verabreichten die Ärzte Medikamente, die das Leben des Kindes beendeten. Die Hauptgründe für diese Maßnahmen waren nach Angaben der Ärzte das Fehlen einer reellen Überlebenschance oder im Falle des Überlebens eine zu erwartende sehr niedrige Lebensqualität.

Obgleich, wie oben bereits angeführt, die Anwendung von letalen Medikamenten bei Minderjährigen trotz des seit September 2002 geltenden

liberalen Sterbehilfegesetzes auch in Belgien illegal geblieben ist, erklärten 95 der 121 befragten Ärzte, dass es manchmal zur Erfüllung ihrer Pflicht gehöre, unnötiges Leiden zu verhindern. Eine Legalisierung der aktiven Sterbehilfe bei Neugeborenen in speziellen Fällen forderten 69 von ihnen.

In einem zweiten Gesetz wird Kranken ein Anspruch auf Schmerztherapie garantiert. Die Regierung Belgiens hat eine Regierungskommission eingesetzt, die über die Einhaltung der Bedingungen wachen soll.

Das Gesetz stößt aber v. a. deshalb auf erhebliche Bedenken, weil es:

- eine aktive Lebensbeendigung weit vor dem natürlichen Todeszeitpunkt zulässt und somit nicht die Sterbehilfe, sondern die Tötung auf Verlangen normiert,
- nicht nur auf dauernde und unerträgliche physische, sondern auch auf die psychischen Leiden abstellt und damit letztlich die subjektive Lebensablehnung ausreichen lässt,
- durch die Übertragung der Kontrolle auf eine Kommission praktisch die »Exmittierung« der Staatsanwaltschaft aus diesem Bereich der Strafverfolgung bedeutet – ein für unser Rechtsverständnis gravierendes Defizit an rechtstaatlicher Kontrolle.

Wenn alle europäischen Länder die niederländische und belgische Praxis einführen würden, müsste man, berechnet nach den niederländischen Daten, jährlich mit etwa 200.000 Patienten in Europa rechnen, die infolge aktiver Sterbehilfe sterben. Darunter würden sich 50.000 Patienten befinden, die nicht darum gebeten hätten.

Die folgenden Argumente waren für holländische Ärzte die wichtigsten Gründe, aktive Sterbehilfe durchzuführen (Van der Wal et al. 1996; Ten Have u. Welie 1996):

- Leiden kann nicht ausreichend gelindert werden (74%),
- Vorbeugung zum Verlust der Würde (56%),
- Vorbeugung stärkerer Leiden (47%),
- unnötiges Leiden (44%),
- Schmerzen (32%).

Diese Begründungen nehmen ihren Ausgang in den Begriffen: *Leiden, Würde, Schmerzen.* Zahlreiche Publikationen zeigen, dass nur wenige Menschen keine Leiden oder Schmerzen in ihrer letzten Lebenszeit haben. Ungefähr 70–80% aller Tumorpatienten erleben im Laufe ihrer Erkrankung starke

Schmerzen. Dyspnoe, Todesrasseln, Übelkeit, Angst, Unruhe und Panik sind häufige am Lebensende beschriebene Symptome.

Diese Probleme gelten nicht allein für Tumorpatienten. Andere Patientengruppen mit ernsten chronischen Organerkrankungen, wie z. B. Herz-Kreislauf-Leiden oder neurologische Erkrankungen, haben umfassende Probleme mit Schmerzen und Leiden über viele Jahre, bevor sie sterben. Patienten mit psychischen Problemen klagen nahezu ohne Ausnahme über Leiden, Schmerzen und den Verlust der Würde.

- **Schmerzen**
  sind ein unangenehmes Erleben und häufig verbunden mit einer akuten Erkrankung. Schmerzen sind subjektiv. Nur die Person, die Schmerz erlebt, ist in der Lage, das Gefühl und die Intensität zu beschreiben. Niemand anderer als der Patient selbst kann beurteilen, welche Schmerzen unerträglich sind und mit welchen Schmerzen er leben kann.
- **Leiden**
  ist möglicherweise noch stärker verbunden mit der menschlichen Existenz. »Ich habe ein ernstes Leiden«, so sagt vielleicht ein Krebspatient zu uns, und wir nicken verständnisvoll. Wir wissen, was dies für den Einzelnen bedeutet, weil wir aus der Erfahrung im Umgang mit vielen Krebspatienten die Konsequenzen dieser Erkrankung beurteilen können.
  Aber das Leiden ist nicht nur ausschließlich an die Erkrankung geknüpft. Leben und Tod, Trauer und Freude, Freiheit und Unterdrückung, Sinn und Kränkung, Krankheit und Gesundheit, Nahrung und Hunger, Ruhe und Erschöpfung, Liebe und Einsamkeit sind einige Wortpaare, die eine schmale Balance zwischen Leid und Wohlbefinden beschreiben. Die Wahrnehmung von Leiden ist gebunden an die individuelle Lebensgeschichte, den kulturellen Hintergrund und die persönliche Beurteilung der aktuellen Lebenssituation.
  Wenn jemand zu uns sagt: »Ich habe Schmerzen«, oder: »Ich leide«, dann ist es nicht unsere Aufgabe, das Gegenteil zu beweisen. Die Aufgabe ist weit mehr zu tun als nur zu verstehen, was gesagt wurde.
- **Würde**
  Wer hat Würde? Oder vielleicht einfacher gefragt: Wer hat keine Würde? Unser Arbeitsalltag im Gesundheitswesen ist geprägt durch den Umgang mit Menschen, die mit akuten oder chronischen Erkrankungen in unterschiedlicher Ausprägung leben. Oft begegnen wir Menschen mit umfassenden Problemen. Es stellt sich dann die Frage, ob diese Menschen ihre

Würde verlieren, wenn sie ernsthaft erkranken, vollständig von der Hilfe anderer abhängig sind, von Schmerz und Leid geprägt oder sich bereits im Prozess des Sterbens befinden.
Können Sie sich in die folgende Situation hineinversetzen?
Bevor Sie sterben, wird es vielleicht eine Zeit für Sie geben, in der Sie durch den Verlust an physischer und psychischer Gesundheit schwach und hilfsbedürftig sind. Vielleicht brauchen Sie täglich Hilfe bei der Körperpflege. Vielleicht können Sie nicht mehr das Bett verlassen und sind nicht mehr voll orientiert. Sie sind von der Hilfe anderer abhängig. Haben Sie dann Ihre Würde verloren?
Kinder sind in ihrer ersten Lebensphase rund um die Uhr von Liebe und Fürsorge abhängig. Wenn alles gut geht, erhalten sie das, was sie brauchen. In den ersten Jahren müssen sie gefüttert, gewickelt und an der Hand geführt werden. Später entwickelt sich ihre Selbstständigkeit zunehmend. Doch auch weiterhin ist der Bedarf an Unterstützung und Fürsorge gegeben, bis dass das Kind 15 oder 20 Jahre alt ist. Niemand stellt in diesem Zusammenhang die Frage, ob ein Kind Würde hat, trotz des enormen Bedarfs an Fürsorge und Hilfe. Was ist die Ursache dafür, dass wir auf Schwäche und Hilflosigkeit bei Kranken und Alten herabsehen? Warum sehen wir auf denjenigen herab, dem sein Leben nicht gelingt? Haben diese Menschen ihre Würde verloren?
Besonders Schwäche, verbunden mit Erkrankung und Altwerden, ist zu allen Zeiten mit Minderwertigkeit in Verbindung gebracht worden. Aussagen wie: »Zum Glück trifft es nicht mich« oder: »Der arme Kerl« signalisieren, dass wir glauben, uns auf der »sicheren Seite« zu befinden. Die Alten haben den Höhepunkt des Lebens passiert, wir hingegen sind geprägt durch Unverletzbarkeit, Selbstbegeisterung, Zukunftschancen und Arbeitsaktivitäten. Die Alten sind die Verlierer.

Doch Vorsicht: Wenn wir lange genug leben, werden wir selbst unter diesen Vorurteilen zu leiden haben. Denn was vielleicht noch schwerer wiegt, ist unsere Unfähigkeit, die positiven Seiten von Schwäche und Alter zu sehen: die Lebenserfahrung, die langen Freundschaften und die historischen Lehrstücke, die unsere Zeit braucht, um klüger zu werden.

Alle Menschen haben Würde (Janssens u. Gordijn 1998). Es ist undenkbar, dass einige Menschen keine Würde haben. Die Herausforderung besteht darin, dass Würde gekränkt/verletzt werden kann. Je größer die Schwäche des

einzelnen Menschen, je größer seine Abhängigkeit von Hilfe, desto größer das Risiko und die Wahrscheinlichkeit, dass seine Würde verletzt wird.

Wenn ein Sterbender in ein Krankenhaus oder ein alter Mensch in ein Pflegeheim eingewiesen wird, kann es bedeuten, dass er Hilfe und Fürsorge rund um die Uhr braucht. Wenn niemand diesen Patienten besucht, weil er krank, dement oder schwach ist, dann wird seine Würde gekränkt. Wenn dieser Patient Windeln erhält, obwohl er mit Hilfe die Toilette besuchen könnte, wenn wir seine Einsamkeit übersehen und den Bedarf an Schmerzmedikamenten, dann zeigen wir, dass er eine Belastung ist und wertlos. Unsere Gleichgültigkeit gegenüber diesen Menschen, Mangel an Kompetenz, Verständnis und Liebe ist ihre größte Kränkung.

Die Würde der Schwachen, der Sterbenden und der Alten muss jeden Tag durch uns bestätigt werden!

Die aktive Sterbehilfe hat zu allen Zeiten in dieser Debatte einen zentralen Platz eingenommen. Wenn Kränkung und Leid groß genug sind, ist es verständlich, dass der Patient und seine Angehörigen um Hilfe aus dieser unerträglichen Situation bitten. Die entscheidende Frage ist, wie diese Hilfe aussehen kann (Janssens u. Gordijn 1998; Gordijn u. Janssens 2000).

Auf einem internationalen Ärztekongress in Wien (1999) hielt ein amerikanischer Arzt einen Vortrag, in dem er die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe befürwortete. Unter anderem erzählte er über Gespräche mit seinem krebskranken Vater. Er hatte seinem Vater versprochen, ihm die notwendigen Medikamente für aktive Sterbehilfe zu geben, falls seine Leiden oder Schmerzen unerträglich würden.

In den USA gibt es in vielen Staaten Bestrebungen, »physician-assisted suicide« (vom Arzt assistierten Suizid) zu legalisieren. In einigen wenigen Staaten ist dies bereits legalisiert. Die Amerikaner – wie die Holländer und Belgier – geben als Hauptgrund für diese Legalisierung von »Tötung auf ausdrückliches Verlangen« an, dass die Autonomie, das Recht der Bürger auf eigene, freie Entscheidungen, in ihren Ländern einen besonders zentralen Stellenwert hat.

In unseren Augen hat dieser amerikanische Sohn und Arzt zwei Alternativen. Er könnte zu seinem Vater gesagt haben:

> Vater, natürlich möchte ich auf keinem Fall, dass du leidest. Wenn deine Probleme unerträglich werden, rufst du mich an. Dann werde ich dir mit einer Spritze helfen, damit du schnell stirbst und von deinen Leiden befreit wirst.

Oder er könnte zu seinem Vater gesagt haben:

> Vater, du bist ein Stern für mich. Ich liebe dich. Ich verspreche dir, alles zu tun, was in meiner Macht steht, damit du kompetente Hilfe bekommst, um deine Leiden so gut wie möglich zu lindern. Ich werde jeden Tag bei dir sein und dich in meinen Armen halten in der Zeit, die dir noch bleibt. Du bedeutest mir alles, besonders jetzt, wo du so krank bist.

Kann man die Würde eines Menschen mehr kränken, als dadurch, dass man ihm anbietet, ihn zu töten?

Oder indem wir Augen und Ohren vor seinen Wünschen verschließen, die um Fürsorge, Kompetenz und palliative Behandlung bis zu seinem Lebensende bitten? Ist nicht die Gefahr unendlich groß, dass verzweifelten, einsamen, unnötig leidenden Patienten eine Tötung angeboten wird – wenn Fürsorge, Pflege und kompetente palliative Behandlung nicht vorhanden sind?
In unzähligen Fällen haben wir im medizinischen Alltag Situationen erlebt, in denen sterbende und leidende Patienten mit großer Verzweiflung dem Sterben entgegensehen. Wenn diese Patienten mit der Liebe, Fürsorge und Kompetenz der Palliativmedizin behandelt werden, fiebern sie nicht länger dem schnellen Tod entgegen. Sie – und ihre Angehörigen – berichten, dass diese letzten Tage und Wochen für sie eine Zeit sind, die zu einer unvorstellbaren Bereicherung und einem würdevollen Abschied beiträgt.

Ein wichtiger Grundsatz von Palliative Care ist: »Wenn die Lebenssituation eines Patienten hoffnungslos erscheint, gibt es noch unendlich viel, was wir ihm anbieten können«. Unser Angebot besteht in einer kompetenten medizinischen Behandlung und ausgezeichneten Pflege. Verständnis und Einsicht für die Schmerzen und Leiden eines Menschen sind keine leeren Versprechungen. Aber dieses Engagement und diese Kompetenz soll nicht nur Einzelpersonen gelten, die das Glück haben, auf einer »guten Palliativstation« behandelt zu werden.

So lange nicht alle sterbenden und schwerst leidenden Patienten die Sicherheit haben, Palliative Care zu erhalten – und die haben sie wegen der jetzigen, fehlenden Aus- und Weiterbildungsstandards für Palliativmedizin in den meisten europäischen Staaten nicht –, ist es fast verständlich, wenn die Bevölkerung den »schnellen, schmerzfreien Tod« als Sicherheitsausweg herbeiwünscht. Das Angebot der Zukunft, Palliativmedizin, muss für *alle* Patienten gelten, die unter lebensbedrohlichen Erkrankungen leiden, unabhän-

gig von Diagnose, Alter und Aufenthaltsort: im Krankenhaus, im Pflegeheim oder zu Hause.

Mit Vertretern aller europäischer Staaten verabschiedete im Juni 1999 der Europarat einstimmig ein Dokument (Protection of the Human Rights and Dignity of the Terminally Ill and the Dying – Recommendation 1418 – 1999), das detailliert den Bedarf für Palliative Care beschreibt. Das Dokument wurde erarbeitet und dem Europarat vorgelegt von den Universitätsprofessoren Günter Virth und Franz Lackner (beide Universität Wien), Henk Ten Have (Universität Nijmegen) und Stein Husebø (Universität Wien/Bergen). In diesem Dokument wird unterstrichen, dass alle europäischen Staaten verpflichtet sind, schwerkranken und sterbenden Patienten kompetente Palliative Care anzubieten. Gleichzeitig ist dieses Dokument eine deutliche Aussprache gegen die aktive Sterbehilfe.

In einem bemerkenswerten Aufsatz im Juli 2002 kommentiert Generalstaatsanwalt Dr. Heinrich Kintzi (Braunschweig) einige rechtliche Grundlagen in Deutschland für ein würdevolles Sterben, wo er unterstreicht, dass in den Diskurs über Sterbehilfe nicht nur die Medizin, sondern die Rechtswissenschaft, die Theologie und die Ethik involviert sind:

> In dem notwendigen Dialog der Wissenschaften ist der Beitrag der Rechtswissenschaft nicht als Anmaßung oder Reglementierung zu verstehen, sondern als Hilfe. Der Arzt/die Ärztin muss sicheren Boden unter den Füßen spüren, um verantwortungsvolles Wirken sachgerecht ausüben zu können… Was die Standesethik vom Arzt fordert, übernimmt das Recht weithin zugleich als rechtliche Pflicht…
>
> Maßnahmen zur Verlängerung des Lebens dürfen in Übereinstimmung mit dem Willen des Patienten unterlassen oder nicht weitergeführt werden, wenn diese nur den Todeseintritt verzögern und die Krankheit in ihrem Verlauf nicht mehr aufgehalten werden kann…
>
> Durch die Hinweise auf den Willen und den mutmaßlichen Willen des Patienten, die die Rechtssprechung vornimmt, haben die Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht einen erheblichen Bedeutungszuwachs erfahren… Im selben Maß, in dem der Patient durch Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen seinem Willen hinsichtlich lebensverlängernder Maßnahmen verbindlich Geltung verschaffen kann, schwindet die Besorgnis, im Sterben eine Missachtung seines Selbstbestimmungsrechts zu erfahren…
>
> ▼

> Bei Sterbenden kann die Linderung des Leidens so im Vordergrund stehen, dass eine möglicherweise unvermeidbare Lebensverkürzung hingenommen werden darf…

Zu Grenzziehung zwischen indirekter und passiver Sterbehilfe und direkter Lebensbeendigung schreibt Kinzi:

> Bei der gebotenen indirekten und verbotenen aktiven Sterbehilfe liegt kein Etwas-in-die-Tasche-Lügen vor, indem die Ärzte gleichartiges Handeln unter verschiedenen Etiketten vollziehen. Zwar ist die Einflussnahme auf das Leiden das verbindende voluntative Element des ärztlichen Tuns, doch bekanntlich heiligt nicht der Zweck jedes Mittel.
>
> Es besteht nicht nur ein gradueller, sondern ein substanzieller Unterschied zwischen der zielgerichteten absichtlichen Tötung eines Menschen und der Lebensverkürzung, die ungewollt, aber unvermeidbar als Nebenfolge eintritt oder eintreten kann. Der Wertungsunterschied wird auch daran deutlich, dass sich die aktive Sterbehilfe aus dem Erfolg der Lebensbeendigung definiert, während bei der hier reflektierten Therapie nur das Risiko, aber nicht die Gewissheit der Lebensverkürzung besteht. Drängt sich hier nicht der Vergleich mit der allgemeinen Medikation auf, die mit negativen Nebenwirkungen verbunden ist? Es ist ein gutes ärztliches Tun, das auf Heilung oder Linderung gerichtet ist, auch wenn der Beipackzettel gravierende Nebenwirkungen aufweist.
>
> Der wesentliche Ansatz der passiven Sterbehilfe ist der Verzicht auf kurative Therapie, auf die künstliche Verlängerung des Sterbevorganges. Das Ärztlich-ethische und das Rechtliche können sich in der tragfähigen Zäsur vereinigen, die begrifflich zwischen der direkten Euthanasie, die auf Tötung abzielt, einerseits und der schicksalhaften Entwicklung andererseits unterscheidet, deren natürlichem Verlauf der Arzt nicht in den Arm zu fallen braucht.

Die Zusammenfassung seines Aufsatzes könnte wie folgt ausgedrückt werden:

> Die in unserer Verfassung bestehende Grundrechtsbindung an die Unantastbarkeit der menschlichen Würde schließt auch das Recht auf Respekt der Würde eines Sterbenden ein.

Um dieses Ziel, die Würde der Sterbenden in unserem Umgang mit ihnen zu achten, zu erreichen, bedarf es einiger Voraussetzungen. Unsere Gesellschaft muss mit einer Änderung ihrer Haltung gegenüber den Schwachen und Sterbenden zu dieser Entwicklung beitragen. Die Verantwortlichen im Gesundheitswesen müssen die Augen öffnen gegenüber den Sterbenden und den Alten, damit sie die Hilfe erhalten, die sie brauchen. Doch die Gesellschaft und das Gesundheitswesen werden diese Probleme nicht allein lösen können. Eine zentrale Voraussetzung ist, wie wir als Privatpersonen Verantwortung übernehmen, wenn unsere Angehörigen schwer erkranken oder alt werden.

Nur durch ein funktionierendes Netzwerk, in dem Angehörige, Ehrenamtliche, Nachbarn, die »professionellen« Helfer, Institutionen und Lehreinrichtungen zusammen arbeiten mit Respekt gegenüber der Kompetenz des Anderen, kann es gelingen, das Empfinden ihrer eigenen Würde bei Schwachen und Schwerkranken bis zuletzt zu stärken.

Die Lösung für Schmerzen, Leiden und Kränkung von Würde eines Patienten besteht nicht in einer tötenden oder sedierenden Spritze. Die Lösung besteht darin, dass wir kompetente palliativmedizinische und -pflegerische Versorgung anbieten für alle, die sie brauchen.

2.3.5 Ärztliche Beihilfe zum Suizid

Ein wesentliches Argument gegen die aktive Sterbehilfe ist die Tatsache, dass der Patient eine andere Person einbindet und die Tötung durchführen lässt. Gegner der Euthanasie fordern deswegen häufig, dass der Patient in Wahrung und Achtung seiner Autonomie selbst die Tötung durchführen solle und könne (Quill et al. 1992).

Jeder Arzt wird Verständnis für Patienten haben, für die das Sterben ein äußerst qualvoller Prozess ist und die deswegen den Wunsch äußern, nicht weiter leben zu wollen. Aus diesem Verständnis kann aber nicht die Erlaubnis zur aktiven Sterbehilfe abgeleitet werden. Andererseits wird argumentiert, dass die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs Ärzten bereits die Erlaubnis zum Töten gegeben hat. Manche Ärzte (Quill et al. 1992) können sich durchaus vorstellen, unter bestimmten Voraussetzungen Beihilfe zum Suizid zu leisten, auch wenn dies in Deutschland von den Standesorganisationen abgelehnt wird.

Der Suizid ist in unserer Gesellschaft fast so umstritten wie die Euthanasie und der Schwangerschaftsabbruch. Der Suizidversuch war in vielen Ländern bis zur 2. Hälfte des vorigen Jahrhunderts strafbar. Die Beihilfe zum Suizid ist in einigen Ländern (u. a. in Deutschland, Schweden) *nicht* strafbar, in anderen Ländern mehr (Österreich, Norwegen) oder weniger (Schweiz) strafbar. Es wird aber prinzipiell als problematisch angesehen, wenn ein Arzt diese Beihilfe leistet.

Eine entscheidende Frage bei der Beurteilung des Suizids ist es, ob der Mensch nicht das Recht hat, über sein eigenes Leben zu befinden. Auf den ersten Blick könnte man glauben, eine Lösung dieser Fragen darin zu sehen, wenn dem Arzt das Recht zugestanden wird, Patienten, die das Leben nicht mehr ertragen können, den Weg zur Selbsttötung zu zeigen und unter Umständen die dafür geeigneten Medikamente bereitzustellen. Wie in anderen Ländern gibt es auch in Deutschland Ärzte, die öffentlich eine ärztliche Beihilfe zum Suizid befürworten, und auch solche, die in aller Öffentlichkeit darstellen, wie sie solche Hilfe geleistet haben. Ein pensionierter Pathologe in Michigan (USA) hat durch die Entwicklung und den Einsatz einer Selbsttötungsmaschine große öffentliche Wirkung erzielt. In Deutschland bietet eine Gruppe den Menschen, die nicht mehr leben wollen, Hilfe beim Suizid an. Sie setzt dabei Blausäure ein und verlangt für jede geleistete Beihilfe zum Selbstmord 5.000–25.000 Euro (Condrau 1991). Das Einnehmen von Blausäure führt zu einem schnellen und sehr qualvollen Tod.

Die Gegner der aktiven ärztlichen Beihilfe zum Suizid weisen darauf hin, dass ein Patient häufig die Möglichkeit habe, selbst, ohne fremde Hilfe Suizid zu begehen. Entgegen vielerlei Meinungen sei es nicht schwer, sich das Leben zu nehmen, unter der Voraussetzung, dass dafür die richtige Methode gewählt wird.

Es kann diskutiert werden, ob der Patient, der selbst in der Lage ist, Suizid zu begehen, einen höheren Grad von Autonomie und Integrität besitzt als ein Patient, der durch seine Krankheitsentwicklung keinerlei Möglichkeiten mehr hat, dass ein solches Vorhaben ohne fremde Hilfe gelingen könnte. Wir kennen Situationen, wo Patienten, wenn sie ausreichend Information über ihre Möglichkeit zum Suizid erhielten, durch die gewonnene Autonomie mehr Lebensmut bekamen und sich dadurch für ein weiteres Leben bis zum natürlichen Todeseintritt entschieden (Quill et al. 1992).

In der Betreuung sterbender Patienten erfahrene Ärzte berichten, dass es zwar zutreffe, dass einige Patienten den Wunsch äußern, vorzeitig aus

dem Leben zu scheiden, wenn die Krankheitsentwicklung zu einem unkontrollierbaren, unwürdigen Zustand führen sollte. Die Erfahrung zeige aber auch, dass ein solcher Wunsch vorwiegend in einer frühen oder mittleren Phase der Krankheit zum Ausdruck gebracht werde. Sterbende Patienten dagegen äußerten fast nie den Wunsch, sich zu töten oder töten zu lassen.

Es gibt in der Tat nur sehr wenige Fälle, in denen sterbende Patienten Suizid begehen (Bolund 1985). Dies ist umso bemerkenswerter, als vielen dieser Patienten mehr als ausreichend Medikamente zur Verfügung stehen, durch deren Einnahme der Tod herbeigeführt werden könnte (▶ Kap. 5.6.2: »Depression« und ▶ Kap. 5.7: »Suizid«). Was Patienten in einer so schwierigen Phase ihres Lebens brauchen, ist Unterstützung, Begleitung und das Gespräch. Gespräche mit solchen Patienten sind schwierig. Sie setzen voraus, dass der Arzt als Gesprächspartner über Kompetenz, Zeit und Mitgefühl verfügt. Mit der Aufgabe, den Patienten das zu geben, was sie als Alternative zum Tod brauchen, sind viele Ärzte überfordert.

Die Lösung dieses Problems kann nicht sein, dass der Arzt ein Rezept zum Sterben ausstellt. Wenn dieses Rezept ausgestellt und der Patient allein gelassen wird oder Unterstützung zu seinem Vorhaben bekommt, kann dies nur als eine Aufforderung zum Suizid aufgefasst werden. Eine solche ärztliche Beihilfe zum Suizid ist moralisch und ethisch gleichwertig mit aktiver Sterbehilfe – eine aktive Tötung eines Menschen. (Wilkinson 1990; Moulin et al. 1994; Husebø 1991)

2.3.6 Indirekte Sterbehilfe

Zunächst wollen wir auf Fälle hinweisen, die häufig missverstanden werden.

Wenn beispielsweise ein Patient mit ausgeprägter Metastasierung im Hals-Lungen-Bereich plötzlich eine Durchbruchblutung zum Bronchialsystem oder aus der Aorta bekommt, wird diese Komplikation innerhalb von Minuten zum Tode führen. Diese Zeit kann für den Patienten und für andere Anwesenden äußerst qualvoll sein. In einer solchen Situation ist es die Aufgabe des Arztes, eine adäquate Therapie des vorhandenen Schmerzes und der vorhandenen Panik durchzuführen. Sinnvoll wäre es, falls möglich, sofort einen intravenösen Zugang zu legen, um die notwendigen Medikamente rasch und effektiv zuführen zu können. Die wichtigen Medi-

kamente in dieser Situation wären Analgetika und Anxiolytika, am besten Morphin und Midazolam, die im Notfall auch tief intramuskulär gegeben werden können.

Der verantwortungsbewusste Arzt sollte bei dem Patienten bleiben und die notwendigen Dosen der Medikamente so titrieren, bis die Panik und das Leiden des Patienten unter Kontrolle sind. Dabei können die benötigten Dosen eine Bewusstlosigkeit des Patienten hervorrufen. Es kann auch durchaus sein, dass der Patient durch diese Behandlung einige Minuten früher stirbt als ohne eine solche Behandlung. Der Arzt nimmt bewusst diese unerwünschten Nebenwirkungen in Kauf.

Dies ist weder aktive noch passive Sterbehilfe, sondern gute Symptomkontrolle – oder wie es in Deutschland genannt wird: indirekte Sterbehilfe. Es handelt sich hierbei um eine kompetente und angebrachte medizinische Behandlung (Roy 1991; Müller-Busch 2004).

Das Gleiche würde beispielsweise auch bei einem Patienten mit schwerem, unkontrollierbarem Herzversagen zutreffen, bei dem abgeklärt ist, dass er nicht weiter beatmet werden soll, falls die Respiration versagt. Hier ist die intravenöse Zufuhr von Analgetika und Sedativa zur Minimalisierung des Leidens auch dann als adäquate medizinische Behandlung anzusehen, wenn der Patient dadurch früher sterben sollte.

Die häufigste Todesursache ist ein Linksherzversagen; das dabei entstehende Lungenödem wird oft vom Patienten als sehr qualvoll empfunden. Es sei hier mit Nachdruck betont, dass Patienten, deren Leben nicht mehr gerettet werden kann, in ihren letzten Stunden immer eine optimale Behandlung ihrer Symptome erhalten müssen. Es kann niemals akzeptiert werden, dass Ärzte sich von solchen Patienten zurückziehen unter dem Vorwand, doch nichts mehr tun zu können (Klaschik u. Husebø 1997). Passive und indirekte Sterbehilfe sind insbesondere für unerfahrene Ärzte und Krankenschwestern problematisch, da ihnen der fachliche Überblick fehlt und ihnen auch der Umgang mit den Medikamenten in der Finalphase Ängste bereitet. So haben sie Angst vor der eigenen Verantwortung bei der »letzten« Spritze. Derjenige, der die letzte Injektion gibt, fühlt sich oft für den Tod des Patienten verantwortlich. Diese Angst hat ihre Begründung in der Haltung, mit der Ärzte häufig dem Tod begegnen.

Die Beurteilung der Situation, welche Form der Sterbehilfe vorliegt, ob unsere Handlung ethisch, moralisch und rechtlich richtig ist, hängt davon ab, ob

- der Arzt kompetent und verantwortungsbewusst handelt,
- das Ziel seiner therapeutischen Intervention eine Linderung und nicht das Töten gewesen ist,
- der Patientenwille berücksichtigt wurde.

Dabei muss selbstverständlich das Recht des Patienten auf Mitbestimmung beachtet werden. Falls der Patient noch bei Bewusstsein ist, muss er selbst entscheiden dürfen, ob er Analgetika und andere angebrachte Medikamente bekommen will oder ob er es vorzieht, bei evtl. besserer Erhaltung seines klaren Bewusstseins länger zu leiden (Mount u. Hamilton 1994 Cherny et al. 1994 b).

Im Allgemeinen hat eine suffiziente Symptomkontrolle zur Folge, dass der Patient besser und länger lebt, nicht aber, dass sein Leben verkürzt wird. Die Ärzte sollen aber wissen, dass sie eine richtige Behandlung durchgeführt und sich keineswegs strafbar gemacht haben, wenn – was selten vorkommt – ein todkranker Patient, der eine suffiziente Symptomkontrolle erhalten hat, etwas früher stirbt als ohne eine solche Therapie (Eser et al. 1992; Cherny et al. 1994 b).

Ein BGH-Urteil zu diesen Problemen wird nachfolgend dargestellt.

Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH), November 1996

Zulässigkeit »indirekter Sterbehilfe«:

Indirekte Sterbehilfe ist die unbeabsichtigte, aber als unvermeidliche Nebenfolge in Kauf genommene Beschleunigung des Todeseintrittes durch schmerzlindernde Medikamente.

Die massive Schmerztherapie muss:

- dem Patientenwillen entsprechen,
- ärztlich geboten sein,
- darf den Tod nur um »kurze Zeit« beschleunigen.

Die Ermöglichung eines Todes in Würde und Schmerzfreiheit gemäß dem erklärten oder mutmaßlichen Patientenwillen ist ein höherwertiges Rechtsgut als die Aussicht, unter schwersten Schmerzen, insbesondere sog. Vernichtungsschmerzen, noch kurze Zeit länger leben zu müssen.

Das Urteil gegen zwei Ärzte wegen Totschlags wurde aufgehoben.

2.3.7 Der Wunsch (?), getötet zu werden

Beispiel aus der Praxis

Eine Patientin ist 34 Jahre alt, ihr Sohn ist 15 Jahre alt. Zum Vater des Sohnes hat keiner von beiden seit der Geburt des Jungen Kontakt gehabt. Sie ist ausgebildete Sozialarbeiterin. Im Alter von 2 Jahren wurde sie von ihren Eltern adoptiert. Angeblich wurde sie nie darüber informiert.

Seit 2 Jahren hat sie einen Hirntumor. Der Tumor wurde sofort operiert und bestrahlt. Jetzt hat sie ein inoperables Rezidiv. Weitere tumorspezifische Maßnahmen sind nicht möglich.

Versetzen wir uns nun in die Lage ihres Hausarztes! Sie hat in den letzten Monaten zunehmend Beschwerden gehabt: Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Appetitverlust, Kopfschmerzen etc. Um diese Symptome des erhöhten Hirndrucks unter Kontrolle zu halten, bekommt sie Morphin, hochdosierte Steroide und Haloperidol. Der betreuende Arzt steht laufend in Verbindung mit sehr kompetenten Ärzten in der Uniklinik, um eine optimale Symptomkontrolle zu sichern.

Die Patientin will unter keinen Umständen ins Krankenhaus. Der Hausbetreuungsdienst versorgt sie gut zu Hause, unterstützt von einem befreundeten Ehepaar und ihrem Sohn. Zu ihren Eltern hat sie seit 2 Monaten jeden Kontakt abgebrochen.

Zweimal in der Woche bekommt sie Hausbesuche vom Hausarzt. Die Patientin hat kein Vertrauen zu anderen Ärzten. Er hat ihr versprochen, dass er ihr in der verbleibenden Zeit beisteht. Sie hat mehrfach gesagt, dass sie nur ihres Sohnes wegen noch am Leben ist. Sie sagt, dass sie Suizid begehen werde, falls ihr Zustand sich dramatisch verschlechtern sollte.

Dann kommt der Sohn in der Praxis. Er erzählt, dass die Mutter in den letzten Tagen wiederholt hingefallen sei; sie krieche mehr oder weniger auf dem Boden herum und leide schwer unter Übelkeit, Erbrechen, Schwindel und Schmerzen. Seine Mutter habe ihn gebeten, den Arzt zu holen. Er und seine Mutter seien beide fest entschlossen, dass die Mutter nicht mehr länger leiden solle. Beide bitten um Hilfe, das Leben der Mutter zu beenden. Als Alternative bleibe ihm nur, der Mutter beim Suizid behilflich zu sein.

Welche Möglichkeiten hat der Arzt? Soll er ihr Beihilfe zum Suizid leisten? Der weitere Verlauf dieser konkreten Krankengeschichte zeigt, welche Probleme und Konflikte ein solcher Fall in der Praxis mit sich bringen kann.

Beispiel aus der Praxis (Fortsetzung)

Der Arzt hat am Abend nach dem Besuch des Sohnes einen Krankenbesuch bei der Patientin gemacht. Zuvor war er alle 2–3 Tage gekommen. Nachdem er sich einen Überblick über die aktuelle Lage verschafft hatte, schlug er der Patientin trotz ihres Wunsches, zu Hause zu bleiben, eine sofortige Krankenhauseinweisung vor. Dabei gab er an, dass es für ihn darum gehe, ihr die letzten Tage und Stunden so erträglich wie möglich zu machen und alles zu tun, um ihren Sohn auf diese und die dann folgende Zeit so gut wie möglich vorzubereiten. Die Patientin willigte ohne große Widerrede ein. Dem Sohn fiel es schwerer einzusehen, dass seine Mutter die letzten Tage ihres Lebens nicht zu Hause verbringen sollte. Sie wurde aber stationär im Krankenhaus aufgenommen.

In dieser Abteilung wurde sie zunächst gut verpflegt und versorgt. Der Hausarzt arbeitete im Krankenhaus eng mit den dort zuständigen Ärzten zusammen. Es gelang dabei, die von der Patientin als so qualvoll empfundenen Schmerzen, die Übelkeit, das Erbrechen etc. etwas besser unter Kontrolle zu bekommen. Sie bat aber weiterhin jeden Tag darum, ihr eine Überdosis an Medikamenten zu verabreichen, damit ihrem Leiden und ihrem Leben ein Ende gesetzt werde.

Etwa zehn Tage nach der Einlieferung bekam sie an einem Wochenende eine schwere Pneumonie. Zu diesem Zeitpunkt war ihr Allgemeinzustand sehr schlecht, es war kaum möglich, Kontakt mit ihr zu bekommen. Der am Wochenende Dienst habende Arzt entschloss sich, ihr Antibiotika zu verabreichen unter dem Vorwand, dass eine Komplikation wie die Pneumonie bei einem so schwachen Patienten unbedingt zu behandeln sei. Er argumentierte: »Sonst wird sie sterben.«

Diese von ihm getroffene Entscheidung wurde in der darauffolgenden Woche eingehend diskutiert. »Wie ist es möglich,« fragte der noch immer sehr um sie besorgte Hausarzt, »dass Kollegen in der Lage sind, auf diese Weise den sehr klar geäußerten Wunsch der Patientin, bei der ersten Gelegenheit zu sterben, zu überhören und zu missbilligen?« Er wurde dabei von vielen Kollegen in der chirurgischen Abteilung in seiner Haltung unterstützt. Die Therapie mit Antibiotika wurde trotzdem fortgesetzt.

Fünf Tage darauf, nach zweiwöchigem Aufenthalt, besserte sich der Allgemeinzustand der Patientin etwas. Es war über kürzere Zeitabstände des Tages möglich, sich mit ihr zu verständigen. Die chirurgische Abteilung hielt es nun unter Berufung auf die Bettenknappheit für notwendig, die Patien-

tin zu verlegen. Die einzige Stelle, die bereit war, sie aufzunehmen, war ein nahegelegenes Pflegeheim, wohin sie dann unter lauten Protesten der Angehörigen und des Hausarztes verlegt wurde. Hier verbrachte sie ihre letzten qualvollen Wochen, bis sie starb.

Der Hausarzt hat diese tragische Krankengeschichte eingehend in einer Publikation dargestellt und diskutiert (Husebø 1989).

War die Art und Weise, in der die Krankenhausärzte die Pneumonie der sterbenden Patientin gegen ihren Willen behandelt haben, nicht ein ernster Übergriff gegen die Autonomie dieser Frau?

In ihren letzten Lebenstagen ist dann etwas sehr Beeindruckendes geschehen.

Beispiel aus der Praxis (Fortsetzung)

Sie wurde zunehmend so schwach, dass jeden Tag damit zu rechnen war, dass sie sterben werde. In diesen Tagen war sie über kurze Zeiträume bei vollem Bewusstsein. Sie hat dann nicht ein einziges Mal mehr um aktive Sterbehilfe gebeten. Sie hat dagegen unerwartet die Eltern darum gebeten, zu ihr zu kommen. Zuerst bat sie die Eltern, sich um ihren Sohn zu kümmern, wenn sie verstorben sei. Dann verriet sie, dass sie immer von ihrer Adoption gewusst habe, ohne in der Lage zu sein, darüber zu sprechen. Es sei ein großes Problem für sie gewesen, dass die Eltern dieses Thema nicht angesprochen hätten. Dies sei auch der Grund gewesen, warum sie während ihrer Krankheit über längere Zeit hin den Kontakt zu den Eltern abgebrochen habe.

Die Engländer sprechen von »unfinished business«, von »unerledigten Geschäften«. Sie sagen, dass die Sterbenden sich schwer tun, das Leben zu verlassen, solange unbewältigte Aufgaben auf ihrem Gewissen lasten.

Obwohl die letzten Monate eine fast unbeschreibliche Belastung für diese Frau waren, hatten nicht die letzten beiden Wochen aber einen Sinn für sie und für die Hinterbliebenen?

Dabei hatten die Ärzte eine medizinisch-ethische Frage übersehen. Die Frau bekam in den letzten Monaten immer höhere Dosen von Steroiden, um den sehr hohen Hirndruck unter Kontrolle zu halten. Wenn diese Steroide plötzlich abgesetzt worden wären, hätte dies zur Folge gehabt, dass die Patientin innerhalb von Stunden das Bewusstsein verloren hätte und innerhalb von Tagen friedvoll gestorben wäre. Bei erfahrenen Palliativmedizinern ist es bei Hirntumorpatienten nicht ungewöhnlich, ein solches schnelles Absetzen der

Steroide in ähnlichen Situationen nach Wunsch des Patienten durchzuführen (Twycross 1993).

Eigentlich ist es die *Pflicht* des Arztes, den Patienten über Wirkung und Nebenwirkung der Medikamente aufzuklären (Buchanan u. Brock 1989). Wenn die Patientin nach einer solchen Information die Kortisonbehandlung eingestellt hätte, wäre dies ihre eigenständige Entscheidung gewesen. Sie war zu diesem Zeitpunkt zu schwach für einen Suizid aus eigener Kraft. Das Absetzen des Kortisons wäre dabei nicht einmal Suizid gewesen und hat nichts mit aktiver Sterbehilfe zu tun; es ist eine autonome Entscheidung einer kompetenten Person.

2.3.8 Was bedeuten Begriffe wie »unwürdig«, »unerträglich« und »friedvoll«?

Wir können die Schmerztherapie optimieren und alles tun, damit andere Krankheitssymptome unter Kontrolle gehalten werden. Es wird Patienten geben, bei denen trotz maximaler Kompetenz und trotz maximalen Einsatzes die Forderungen nach »suffizienter Symptomkontrolle« und »würdiger Existenz« nicht erfüllt werden können. Bevor wir uns mit diesen seltenen »unerträglichen« Situationen befassen, wollen wir zunächst sehr wichtige und häufig verwendete Begriffe wie: »unerträglich«, »unwürdig« und »friedvoll« beleuchten (Cherny et al. 1994 a).

Diese Begriffe sind Wertbegriffe, Qualitätsbegriffe, subjektiv gewählte Wörter, die dem Menschen dazu dienen, das Gute und das Schlechte, das Böse und das Befriedigende, das Viel und das Wenig in der menschlichen Existenz zu bezeichnen. Diese Wörter sind für uns Menschen nützlich. Sie dienen uns in unserem Alltag, damit wir uns verständigen können. Sie machen uns deutlich, was wir geringschätzen oder für wertvoll halten. Die Begriffe sind auch wichtig für uns Mediziner, weil sie etwas aussagen über das subjektive Befinden unserer Patienten.

Wenn wir Ärzte mit schwierigen und »unerträglichen« Situationen auf der Grenze zwischen Leben und Tod konfrontiert werden, müssen wir hinterfragen, was »unerträglich« bedeutet und wer am meisten darunter leidet. Da die Feststellung des »Unerträglichen« immer in einem Gespräch zwischen mehreren Personen getroffen wird, ist es von Bedeutung, wie die einzelnen Gesprächsteilnehmer auf die Aussage der »Unerträglichkeit« reagieren.

Wir müssen auch hinterfragen, *für wen* etwas unerträglich ist. Diese subjektiven Werte haben nur für den Betroffenen eine Gültigkeit. Wenn der Patient sagt: »Es ist für mich unerträglich«, ist die Aussage für ihn gültig. Wenn die Angehörigen, das Pflegepersonal oder der Arzt sagt: »Es ist für den Patienten unerträglich oder unwürdig,« beschreiben sie, dass es für *sie* unerträglich oder unwürdig ist. Wie es für den Patienten ist, kann nur er oder sie selbst entscheiden.

So können schwerwiegende Leidensursachen für den Betroffenen subjektiv ein unlösbares Problem darstellen. Menschen aus einer solchen Situation herauszuführen, ist durch adäquate Reaktion oft weitgehend möglich.

Es gibt viele Beispiele dafür, wie scheinbare Kleinigkeiten für Menschen in einer schwierigen Lage große Bedeutung haben. Wer dem Schmerz und der Panik eines Patienten auf einer Station im Krankenhaus mit Unkenntnis, mangelnder Zuwendung und Unfähigkeit zur Kommunikation begegnet, sollte sensibel genug sein, diese Defizite auszugleichen, und bereit sein, von kompetenten Ärzten und Krankenschwestern dazuzulernen.

Wenn die Situation von uns als unerträglich oder unwürdig empfunden wird, sollten *wir* eine kompetente Hilfe bekommen (▶ Kap. 9: »Die Rolle des Arztes«).

Es zeigt sich also, dass nicht alles, was als unerträglich oder als unwürdig beschrieben wird, tatsächlich unerträglich oder unwürdig sein muss. Kann die Würde nicht darin liegen, das Unerträgliche sichtbar zu machen, den Kranken mit seinem Leiden nicht allein zu lassen, ihm zu zeigen, dass er für uns noch viel wert ist, und Linderung und Hilfe anzubieten?

Der Mensch ist in seinen Reaktionen nie allein, es kommt sehr darauf an, wie die Umgebung diese Reaktionen beeinflusst. Diejenige Gruppe, deren Einflussnahme auf die Reaktionen im allgemeinen zu wenig beachtet wird, ist die der Angehörigen. Ängste und Kränkungen, die den Angehörigen widerfahren, übertragen sich sehr schnell auf den Patienten – und umgekehrt.

Unerträglichkeit des Leidens ist auch abhängig von dem Ort, an dem der Patient sich befindet. Patienten, die z. B. im Krankenhaus – wo Zeitnot herrscht, menschliche und fachliche Kompetenz fehlen – unerträglich leiden, ändern ihre Einstellung, wenn es gelingt, sie nach Hause, in ein Hospiz oder auf eine Palliativstation zu verlegen. Patienten benötigen in diesen Situationen Personen, die Zeit haben und menschliche sowie fachliche Kompetenz besitzen. Unter diesen Voraussetzungen kann oft innerhalb von Stunden eine

Änderung der Beschreibung des Leidenszustandes beobachtet werden (Cherny et al. 1994 b).

Dabei spielt es weniger eine Rolle, was in den ersten Stunden gemacht wird. Das Entscheidende scheinen die dem Kranken vermittelten Eindrücke zu sein:

- Wir haben Zeit für Sie.
- Wir wissen, wie Ihre Schmerzen unter Kontrolle gebracht werden können.
- Sie können bei uns in Offenheit zeigen, wie Ihnen zumute ist.
- Sie sind uns viel wert.
- Wir sind für Sie da, wenn die Gedanken, das Leiden und die Einsamkeit Sie zu überwältigen drohen.

Wir haben die Aufgabe, »hoffnungslos« Kranke und Sterbende zu betreuen und zu behandeln und müssen uns fragen, ob das, was der Kranke als »unerträglich« und »unwürdig« beschreibt, allein eine angemessene Beschreibung seiner aktuellen Situation ist oder ob es ihm nicht auch dazu dienen könnte, das Unerträgliche erträglich zu machen. In letzterem Fall kann es nicht unsere Aufgabe sein, fortlaufend zu signalisieren, dass alles unternommen werde, um eine angemessene Therapie gegen die Angst, die Einsamkeit, den Schmerz zu finden.

Viele Kranke, aber auch Gesunde, machen Aussagen wie: »Ich wünsche mir ein friedvolles Sterben.« Dies sollte auch unser Ziel sein. Aber die Ereignisse im Leben, wie im Sterben, sind nicht immer friedvoll. Wer in Lebensnot und Lebenskrisen kommt, *ist noch am Leben.* Reaktionen auf die Lebenskrise können Wut, Zorn, Abweisung oder Apathie sein. Diese Gefühle oder Reaktionen sind oft erforderlich, um in dieser Lebenskrise existieren zu können.

Viele, die im Gesundheitswesen arbeiten, denken in solchen Situationen, dass es ihre Aufgabe sei, für alle vorhandenen Probleme eines Patienten eine Lösung bereit zu haben. So sehen wir es häufig als unsere Aufgabe an, die Voraussetzungen für ein schmerzfreies und harmonisches Sterben zu schaffen.

Die Umgebung, wie das Pflegepersonal, die Ärzte oder die Angehörigen, sollte in diesen Situationen Respekt vor den Reaktionen des Patienten haben. Ein Teil seiner Würde kann darin liegen, dass er vor dem Tod nicht »lieb«, »freundlich«, »friedvoll« oder »harmonisch« ist. Wenn der Patient seine existentielle Not zum Ausdruck bringt, wird es unsere wichtigste Aufgabe sein, diese Not zuzulassen und, soweit wir dazu in der Lage sind, zu teilen.

Wir dürfen nicht übersehen, dass wir den Patienten weder vor der Trennung noch vor den Ängsten und Gefühlen, die das Sterben begleiten, und auch nicht vor dem Tod bewahren können. Unsere gut gemeinten Bestrebungen in Richtung auf ein »friedvolles« Sterben können nicht nur für uns selbst eine große Belastung sein. Sie können das Leiden, die Verzweiflung und die Einsamkeit des Patienten und die Ängste der Angehörigen erheblich verstärken.

Oft ist es dieses Verständnis, das der Patient und die Angehörigen am meisten brauchen, wenn sie vor einer großen Lebenskrise stehen. Wenn uns dieses Verständnis fehlt und wir uns trotzdem gezwungen sehen zu handeln, dann entstehen Konflikte, die durch unsere »Lösungen« hervorgerufen werden und die die Krise beim Patienten und seinen Angehörigen nicht nur erhalten, sondern sogar verstärken können (Cassel 1982).

Der Ethiker Peter Kemp (1992) unterstreicht in seinem Buch über Medizin und Ethik, dass die Grundlage für ein ethisches Bewusstsein darin besteht, dass sich jeder von uns mit dem eigenen Leben und mit seiner Verwundbarkeit auseinandersetzt. Er sagt auch, dass die wichtigste Quelle für dieses Bewusstsein in den Geschichten, in der Literatur und in der Kunst zu finden sei.

Die Probleme der Sterbenden finden wir kaum eindrucksvoller in der Literatur als in der Geschichte *Der Tod des Iwan Iljitsch,* vor über 100 Jahren von Tolstoj geschrieben. Hier lesen wir von einem todkranken Akademiker, der zunehmend isoliert und allein gelassen wird, weil weder seine Familie noch der Arzt sich zu seinem Leiden und zu seiner fortschreitenden Krankheit verhalten können.

Von diesem Augenblick begann jenes drei Tage lang ohne Unterbrechung währende Schreien, das so furchtbar war, dass man es hinter zwei Türen nicht ohne Entsetzen hören konnte. In dem Augenblick, wo er seiner Frau die Antwort gegeben hatte, war ihm klargeworden, dass er verloren sei, dass es keine Rückkehr mehr gebe, dass das Ende da sei, dass der Zweifel nicht gelöst sei und darum in ihm zurückbleibe. – Uh! Uh! Uh! schrie er in den verschiedensten Tonarten. Er hatte angefangen: Lass mich in Ruh und zog nun diesen einen Laut in die Länge.

In diesen drei Tagen, in deren Verlauf die Zeit für ihn aufgehört hatte, warf er sich in jenem schwarzen Sack herum, in den ihn eine unsichtbare, unüberwindliche Kraft hineinstieß. Er schlug um sich, wie ein zum Tode

▼

Verurteilter in den Händen des Scharfrichters sich wehrt, und doch wusste er, dass er nicht zu retten sei. In jedem Augenblick fühlte er, dass er trotz aller Kraftanstrengungen dem immer näher und näher komme, was ihn mit Entsetzen erfüllte. Er fühlte, dass die Pein sowohl darin lag, dass er in dieses schwarze Loch gestoßen wurde, und noch mehr darin, dass er nicht hineinkam. Denn daran hinderte ihn noch der Gedanke, dass sein Leben gut war. Diese Rechtfertigung seines Lebens hielt ihn noch fest und ließ ihn nicht weiter und quälte ihn mehr denn alles andere.

Plötzlich stieß ihn irgendeine geheimnisvolle Kraft in die Brust, in die Seite, benahm ihm noch mehr den Atem. Er drang in das Loch hinein, und dort am Ende des Loches leuchtete etwas auf. Ihm ging es so, wie es einem in der Eisenbahn geht: Man glaubt vorwärts zu fahren und fährt rückwärts, und dann plötzlich weiß man die Richtung.

Ja es war alles nichts, sagte er zu sich – doch das hat nichts zu bedeuten. Aus dem Nichts kann etwas werden. Wie soll aber dieses Etwas sein? fragte er sich und wurde plötzlich still.

Das war am Ende des dritten Tages, eine Stunde vor seinem Tode. Um diese Zeit hatte sich der Gymnasiast leise zum Vater hereingestohlen und war an sein Bett getreten. Der Sterbende schrie verzweifelt und schlug mit den Händen um sich. Seine Hand fiel auf das Haupt des Gymnasiasten. Der Knabe fasste sie, drückte sie an seine Lippen und weinte.

In diesem selben Augenblick war Iwan Iljitsch ins Loch hineingefallen und sah das Licht, und ihm war offenbar, dass sein Leben nicht so war, wie es hätte sein sollen, aber dass er es noch gutmachen könne. Er fragte sich: Was ist denn gut? und war still und horchte. Da fühlte er dass jemand seine Hand küsste. Er öffnete die Augen und sah seinen Sohn. Er tat ihm Leid. Seine Frau kam zu ihm. Er sah sie an, sie blickte ihn mit verzweifelter Miene an. Ihr Mund stand noch offen, Tränen rannen ihr auf die Nase und die Backen. Sie tat ihm Leid.

Ja, ich quäle sie, dachte er. Ich tue ihnen leid, aber ihnen wird besser sein, wenn ich gestorben bin.

Er wollte ihnen das sagen, aber es ging über seine Kräfte. – Warum auch sprechen, tun muss man es, dachte er. Er sah die Frau an mit einem Blick auf seinen Sohn und sagte: Führe ihn hinaus… er tut mir Leid … auch du.

▼

Er wollte noch was sagen: – Verzeih mir! und versprach sich, und hatte nicht mehr die Kraft, sich zu verbessern, und er winkte nur mit der Hand ab, denn er wusste, dass der, auf den es ankam, ihn verstehen werde.

Und plötzlich war ihm klar, dass das, was ihn quälte und nicht aus ihm heraus wollte, auf einmal herausging von zwei Seiten, von zehn Seiten, von allen Seiten. Sie taten ihm Leid, er musste etwas tun, dass sie nicht mehr zu leiden brauchten; er musste sie retten und sich selber von den Leiden retten. – Wie gut und wie einfach, dachte er. – Und der Schmerz? fragte er sich. Wo soll der hin? Ja, wo ist denn der Schmerz? Und er horchte auf. – Ja da ist er. Nun, meinetwegen.

Und der Tod? Wo ist der Tod? Und er suchte seine frühere Todesangst und fand sie nicht. – Wo ist sie? Wo ist der Tod? Die Angst war nicht mehr da, weil auch der Tod nicht mehr da war. Anstelle des Todes war ein Licht da.

Das ist es also! sagte er laut. – Welche Freude!

Für ihn vollzog sich das alles in einem Augenblick. Und die Bedeutung dieses Augenblicks wechselte nicht mehr. Für die, welche an seinem Bett standen, dauerte der Todeskampf zwei Stunden. In seiner Brust brodelte es, sein ausgezehrter Körper bebte. Dann wurde das Brodeln und Röcheln immer seltener.

Es ist zu Ende, sagte jemand über ihm.

Er hörte diese Worte und wiederholte sie in seiner Seele.

Der Tod ist zu Ende sagte er sich, er ist nicht mehr.

Er schöpfte Luft, blieb mitten im Atemzug stecken, streckte sich aus und starb.

(Leo Tolstoj, *Der Tod des Iwan Iljitsch*)

2.3.9 Zusammenfassung: Respekt vor dem Leben und vor dem Sterben – aber nicht töten

Die Diskussion um die aktive Sterbehilfe ist vor allem eine Diskussion derjenigen, die Angst vor dem Sterben haben und vor unerträglichem Leiden. Sie fürchten, in Schmerzen, Einsamkeit, in Isolation, bei Verlust ihrer Würde und ihres Selbstbestimmungsrechtes zu sterben.

Die Reaktion auf diese Ängste darf nicht darin bestehen, dass diese Menschen der aktiven Sterbehilfe zugeführt werden.

Wir müssen uns darum bemühen, dass das Sterben wieder seinen Platz in unserem Leben gewinnt. Dabei ist Lebensverlängerung um jeden Preis, auch gegen den Willen und die Interessen sterbender Patienten, ebenso kritisch zu beurteilen wie die Situation, den Sterbenden die menschliche und fachliche Behandlung und Aufmerksamkeit vorzuenthalten, die ein friedlicheres Sterben ermöglichen können (Harris 1985; Roy 1990).

Es muss begriffen werden, dass die letzte Wegstrecke vor dem Tod es wert ist, gelebt zu werden, und dass dieser Weg gemeinsam vom Patienten und seinen Angehörigen und Freunden zu begehen ist und von der Gesellschaft gestützt und geschützt werden muss.

Es muss auch die Gefahr erkannt werden, die nicht auszuschließen ist, wenn Ärzte aktive Sterbehilfe durchführen dürfen: die Gefahr, dass Menschen getötet werden, die eigentlich Hilfe brauchen, um das Leben bis zum Tode zu ertragen.

Eine Gesellschaft, in der der Arzt, aus welchen Motiven auch immer, nicht mehr das Leiden bekämpft, sondern den Leidenden tötet, ist auf dem besten Weg zu einer Menschenfeindlichkeit, die im »Kranken« und im »Leiden« nur noch das Unnütze sieht, das durch die Euthanasie beseitigt werden soll.

Der Wert, den ein Mensch seinem Leben beimisst, hängt entscheidend von dem Wert ab, den andere seinem Leben beimessen. Seine Würde hängt wesentlich vom Ansehen ab, das er in den Augen der Umwelt hat. Wenn wir ihm zu verstehen geben, dass wir sein Leben so wenig achten, dass wir bereit sind, ihn zu töten, nehmen wir bereits im Voraus seiner Existenz Würde und Wert. Nicht mehr die Erlösung des anderen, sondern die Erlösung vom anderen würde angestrebt.

Das entschiedene »Nein« zur Legalisierung aktiver Sterbehilfe setzt aber voraus, dass diejenigen Patienten, die unerträglich leiden und nicht mehr mit ihrem Leben zurechtkommen, jederzeit und überall – wo immer sie sich befinden sollten: im Krankenhaus, zu Hause, im Pflegeheim usw. – eine kompetente und ausreichende menschliche, fachliche und soziale Hilfe bekommen. Das ist heute längst nicht überall der Fall (Foley 1991; Foley 2002).

Die Verantwortung dafür tragen wir alle. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Tod und Sterben tabuisiert werden, in einer Gesellschaft, in der das Kranke und Schwache keinen Stellenwert hat, in einer Gesellschaft, die

Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit, Menschenwürde in der Würdelosigkeit, Liebe im Leiden nicht zu geben bereit ist (Cassel 1982).

Wir müssen auf alle diejenigen Einfluss nehmen, die in unserem Gesundheitswesen Entscheidungen treffen, damit sie gemeinsam mit uns die Voraussetzungen für ein entschiedenes und allgemein akzeptiertes Nein zur aktiven Sterbehilfe herbeiführen.

Wir sollten dabei ihnen und uns die folgenden Fragen stellen:

- Wie möchten Sie sterben, wenn die Zeit dazu reif ist?
- Möchten Sie in der letzten Phase Ihres Lebens von inkompetentem Personal behandelt werden, das für Sie keine Zeit und kein Interesse mehr aufbringt?
- Möchten Sie sicher gehen, dass Sie eine suffiziente Behandlung Ihrer Schmerzen erfahren und dass man Ihnen mit Menschlichkeit, Zuwendung und Offenheit begegnet?
- Möchten Sie, weil wir alle nicht rechtzeitig zu den notwendigen fachlichen und menschlichen Voraussetzungen für ein friedvolles Sterben beigetragen haben, dass wir Sie töten?

2.4 Palliativmedizin und aktive Lebenshilfe – die Alternative zur Euthanasie

Die vorangegangenen Abschnitte haben die bestehende Problematik bei Schwerstkranken und extrem leidenden Menschen dargestellt. Es ergibt sich die Frage, ob es eine echte Alternative zur aktiven Sterbehilfe und dem assistierten Suizid gibt, und wenn ja, wie kann sie aussehen?

Dieses Problem zu erkennen und zu lösen ist die Grundlage der Hospizbewegung und der modernen Palliativmedizin.

Patienten, die ihr Leid als unerträglich empfinden, die Angst vor dem Sterben haben, benötigen eine umfassende Versorgung und Betreuung, die geprägt ist von Kompetenz und Empathie. Wenn die Ärzte und die Gesellschaft aus ethischer und fachlicher Überzeugung die aktive Sterbehilfe bei Patienten, die sich in solchen Situationen befinden, grundsätzlich ablehnen, dann müssen wir auch eine Alternative zum Leiden und zur Einsamkeit dieser Patienten schaffen.

Dabei wissen wir,

- dass es Medikamente gibt, die Schmerzen und andere Symptome lindern können,

- dass es Verständnis gibt, das helfen kann,
- dass der Patient weder getötet werden noch sich das Leben nehmen muss, um in Würde sterben zu können,
- dass es Zuwendung, Kompetenz und Pflege gibt, also Hilfen, um die Kluft zwischen Unwürde und Würde, zwischen Unerträglichem und Erträglichem, zwischen Hoffnungslosigkeit und Hoffnung, zwischen Todeswunsch und Lebenswunsch zu überbrücken.

Die aktive Behandlung und Betreuung von schwerkranken, leidenden Patienten ist die Alternative zur aktiven Sterbehilfe. Diese Alternative kann den Todeswunsch in einen Lebenswunsch wandeln.

Aktive Lebenshilfe ist die Aufgabe und der fachliche und menschliche Inhalt der Palliativmedizin. Das Hauptargument der Palliativmediziner gegen eine Legalisierung der aktiven Sterbehilfe beruht auf der Befürchtung, dass diese Legalisierung der aktiven Sterbehilfe von der heute noch immer nicht ernst genommenen Aufgabe der Ärzte und der Gesellschaft ablenkt, schwerkranken Menschen ein würdevolles Leben bis zu ihrem Tode zu ermöglichen.

Die Gesellschaft ist aufgefordert, sich wieder den Leidenden mitmenschlich zuzuwenden, damit der Kreislauf von Einsamkeit, Isolation, Depression und Verzweiflung durchbrochen wird. Wir Ärzte müssen umfassende Kenntnisse in der Symptomkontrolle inkl. der Schmerztherapie besitzen, um Patienten jederzeit und damit auch im Sterbeprozess die bestmögliche Versorgung zukommen zu lassen.

Es kann nicht angehen, dass Unwissenheit und mangelnde Kenntnisse in der Schmerztherapie und Symptomkontrolle Ärzte veranlassen könnten, aktive Sterbehilfe zu leisten.

Zahlreiche Studien zeigen, dass ca. 70% der Krebspatienten keine ausreichende Schmerztherapie erhalten (Foley 1991). Dagegen wissen wir, dass durch gute Palliativmedizin und Schmerztherapie bei fast allen Tumorpatienten in der Sterbephase eine gute Symptomkontrolle und Schmerzreduktion erreicht werden kann (Foley 1985, 2002).

Die Erfahrungen kompetenter Hospize und Palliativstationen zeigen auch, dass die hier behandelten Patienten fast nie um aktive Sterbehilfe oder um Beihilfe zum Selbstmord bitten. Es gibt Patienten, die sich am Anfang der Behandlung wiederholt für eine Durchführung der Euthanasie aussprechen. Sind wir in der Lage, die Probleme der Patienten zu erkennen und zur Lösung

beizutragen, wollen auch diese Patienten leben und haben kaum Verlangen nach aktiver Sterbehilfe.

Diese Erfahrungen zeigen auch, dass diese Patienten im Allgemeinen eine ebenso gute Betreuung und Versorgung zu Hause bekommen können, falls sie dabei von kompetentem Personal begleitet und behandelt werden (Beck-Friis 1993). Hier nimmt der Hausarzt eine Schlüsselrolle ein.

Gute Palliativmedizin darf aber nicht nur einigen wenigen beneidenswerten Patienten vorbehalten bleiben. In Zukunft müssen alle Ärzte, alle Schwestern und alle anderen, die im Gesundheitswesen tätig sind, eine Aus- und Weiterbildung erhalten, die sie durch der Vermittlung fachlicher Kenntnisse und ethischer Einstellungen in die Lage versetzt, schwerstkranken Patienten in ihrem für sie wahrscheinlich wichtigsten Lebensabschnitt die notwendige Hilfe geben zu können (James u. MacLeod 1993; Klaschik u. Husebø 1997).

Diese Aufgabe ist schwieriger zu lösen, als die meisten es sich vorstellen. Derzeit werden noch längst nicht an allen deutschsprachigen Universitäten Vorlesungen bezüglich Symptomkontrolle, Empathie, Kommunikation oder medizinischer Ethik gehalten (Klaschik et al. 2002; Jaspers u. Schindler 2004).

Diese Verhältnisse in deutschsprachigen Ländern sind aber immer noch weit entfernt vom Entwicklungsstand in Ländern wie Großbritannien, den USA, Kanada und Skandinavien, wo die Ausbildung auf diesem Gebiet bereits einen beachtlichen Umfang angenommen hat und auch geprüft wird (Scott u. MacDonald 1994; Husebø 1997).

Die Ausbildung in palliativmedizinischer Kompetenz als Alternative zur aktiven Sterbehilfe ist eine Aufgabe, die vor allem den Universitäten und Hochschulen zufällt. Hierfür die erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen, liegt in der Verantwortung der für das Gesundheitswesen zuständigen Politiker und bei jedem Arzt und jeder Krankenschwester (Bruera 1994; Klaschik u. Husebø 1997).

Die demographische Entwicklung der europäischen Länder gibt Grund zur besonderen Sorge (▶ Kap. 6: »Palliativmedizin für alte Menschen«) und stellt die größte sozialpolitische und medizinethische Herausforderung in Europa in den kommenden Jahrzehnten dar. Kaum ein europäisches Land hat angefangen, sich auf diese Herausforderung bezüglich der notwendigen qualitativen und quantitativen Kompetenz für die medizinische und pflegerische Versorgung des proportional erheblich ansteigenden Anteils alter Menschen vorzubereiten. Schon derzeit ist der Bestand an Pflegeplätzen und

Pflegeheimen nicht bedarfsdeckend, und das Versorgungsproblem wird dramatisch zunehmen.

Für alte, schwerkranke Menschen ist der Zugang zu Palliative Care keineswegs sichergestellt, und ein viel zu geringer Anteil von ihnen erhält die eigentlich notwendige palliativmedizinische und -pflegerische Betreuung in der letzten Lebensphase. Es wird in allen Ländern Europas ein umfassendes Programm für diese alten Patienten auf den Weg gebracht werden müssen, mit einem Schwerpunkt auf Palliative Care, und zwar unabhängig von Diagnose, Alter und Aufenthaltsort des Patienten.

2.5 Grundsätze der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung – 2004

(Die Grundsätze sind eine Überarbeitung der im Jahr 1999 veröffentlichten Erstfassung. Sie gelten als wichtige Grundlage für den ärztlichen Umgang mit schwerkranken und sterbenden Patienten)

Präambel

Aufgabe des Arztes ist es, unter Beachtung des Selbstbestimmungsrechtes des Patienten Leben zu erhalten, Gesundheit zu schützen und wieder herzustellen sowie Leiden zu lindern und Sterbenden bis zum Tod beizustehen. Die ärztliche Verpflichtung zur Lebenserhaltung besteht daher nicht unter allen Umständen.

So gibt es Situationen, in denen sonst angemessene Diagnostik und Therapieverfahren nicht mehr angezeigt und Begrenzungen geboten sein können. Dann tritt die palliativmedizinische Versorgung in den Vordergrund. Die Entscheidung hierzu darf nicht von wirtschaftlichen Erwägungen abhängig gemacht werden.

Unabhängig von anderen Zielen der medizinischen Behandlung hat der Arzt in jedem Fall für eine Basisbetreuung zu sorgen. Dazu gehören u. a.: menschenwürdige Unterbringung, Zuwendung, Körperpflege, Lindern von Schmerzen, Atemnot und Übelkeit sowie Stillen von Hunger und Durst.

Art und Ausmaß einer Behandlung sind gemäß der medizinischen Indikation vom Arzt zu verantworten; dies gilt auch für die künstliche Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr. Er muss dabei den Willen des Patienten

beachten. Ein offensichtlicher Sterbevorgang soll nicht durch lebenserhaltende Therapien künstlich in die Länge gezogen werden. Bei seiner Entscheidungsfindung soll der Arzt mit ärztlichen und pflegenden Mitarbeitern einen Konsens suchen.

Aktive Sterbehilfe ist unzulässig und mit Strafe bedroht, auch dann, wenn sie auf Verlangen des Patienten geschieht. Die Mitwirkung des Arztes bei der Selbsttötung widerspricht dem ärztlichen Ethos und kann strafbar sein.

Diese Grundsätze können dem Arzt die eigene Verantwortung in der konkreten Situation nicht abnehmen. Alle Entscheidungen müssen individuell erarbeitet werden.

I. Ärztliche Pflichten bei Sterbenden

Der Arzt ist verpflichtet, Sterbenden, d. h. Kranken oder Verletzten mit irreversiblem Versagen einer oder mehrerer vitaler Funktionen, bei denen der Eintritt des Todes in kurzer Zeit zu erwarten ist, so zu helfen, dass sie unter menschenwürdigen Bedingungen sterben können.

Die Hilfe besteht in palliativmedizinischer Versorgung und damit auch in Beistand und Sorge für Basisbetreuung. Dazu gehören nicht immer Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr, da sie für Sterbende eine schwere Belastung darstellen können. Jedoch müssen Hunger und Durst als subjektive Empfindungen gestillt werden.

Maßnahmen zur Verlängerung des Lebens dürfen in Übereinstimmung mit dem Willen des Patienten unterlassen oder nicht weitergeführt werden, wenn diese nur den Todeseintritt verzögern und die Krankheit in ihrem Verlauf nicht mehr aufgehalten werden kann. Bei Sterbenden kann die Linderung des Leidens so im Vordergrund stehen, dass eine möglicherweise dadurch bedingte unvermeidbare Lebensverkürzung hingenommen werden darf. Eine gezielte Lebensverkürzung durch Maßnahmen, die den Tod herbeiführen oder das Sterben beschleunigen sollen, ist als aktive Sterbehilfe unzulässig und mit Strafe bedroht.

Die Unterrichtung des Sterbenden über seinen Zustand und mögliche Maßnahmen muss wahrheitsgemäß sein, sie soll sich aber an der Situation des Sterbenden orientieren und vorhandenen Ängsten Rechnung tragen. Der Arzt kann auch Angehörige des Patienten und diesem nahe stehende Personen informieren, wenn er annehmen darf, dass dies dem

Willen des Patienten entspricht. Das Gespräch mit ihnen gehört zu seinen Aufgaben.

II. Verhalten bei Patienten mit infauster Prognose

Bei Patienten, die sich zwar noch nicht im Sterben befinden, aber nach ärztlicher Erkenntnis aller Voraussicht nach in absehbarer Zeit sterben werden, weil die Krankheit weit fortgeschritten ist, kann eine Änderung des Behandlungszieles indiziert sein, wenn lebenserhaltende Maßnahmen Leiden nur verlängern würden und die Änderung des Therapieziels dem Willen des Patienten entspricht. An die Stelle von Lebensverlängerung und Lebenserhaltung treten dann palliativmedizinische Versorgung einschließlich pflegerischer Maßnahmen. In Zweifelsfällen sollte eine Beratung mit anderen Ärzten und den Pflegenden erfolgen.

Bei Neugeborenen mit schwersten Beeinträchtigungen durch Fehlbildungen oder Stoffwechselstörungen, bei denen keine Aussicht auf Heilung oder Besserung besteht, kann nach hinreichender Diagnostik und im Einvernehmen mit den Eltern eine lebenserhaltende Behandlung, die ausgefallene oder ungenügende Vitalfunktionen ersetzen soll, unterlassen oder nicht weitergeführt werden. Gleiches gilt für extrem unreife Kinder, deren unausweichliches Sterben abzusehen ist, und für Neugeborene, die schwerste Zerstörungen des Gehirns erlitten haben. Eine weniger schwere Schädigung ist kein Grund zur Vorenthaltung oder zum Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen, auch dann nicht, wenn Eltern dies fordern. Wie bei Erwachsenen gibt es keine Ausnahmen von der Pflicht zu leidensmindernder Behandlung und Zuwendung, auch nicht bei unreifen Frühgeborenen.

III. Behandlung bei schwerster zerebraler Schädigung und anhaltender Bewusstlosigkeit

Patienten mit schwersten zerebralen Schädigungen und anhaltender Bewusstlosigkeit (apallisches Syndrom; auch so genanntes Wachkoma) haben, wie alle Patienten, ein Recht auf Behandlung, Pflege und Zuwendung. Lebenserhaltende Therapie einschließlich – ggf. künstlicher – Ernährung ist daher unter Beachtung ihres geäußerten Willens oder mutmaßlichen Willens grundsätzlich geboten. Soweit bei diesen Patienten eine Situation eintritt, wie sie unter I–II beschrieben ist, gelten die dort dargelegten Grund-

sätze. Die Dauer der Bewusstlosigkeit darf kein alleiniges Kriterium für den Verzicht auf lebenserhaltende Maßnahmen sein. Hat der Patient keinen Bevollmächtigten in Gesundheitsangelegenheiten, wird in der Regel die Bestellung eines Betreuers erforderlich sein.

IV. Ermittlung des Patientenwillens

Bei einwilligungsfähigen Patienten hat der Arzt die durch den angemessen aufgeklärten Patienten aktuell geäußerte Ablehnung einer Behandlung zu beachten, selbst wenn sich dieser Wille nicht mit den aus ärztlicher Sicht gebotenen Diagnose- und Therapiemaßnahmen deckt. Das gilt auch für die Beendigung schon eingeleiteter lebenserhaltender Maßnahmen. Der Arzt soll Kranken, die eine notwendige Behandlung ablehnen, helfen, die Entscheidung zu überdenken.

Bei einwilligungsunfähigen Patienten ist die in einer Patientenverfügung zum Ausdruck gebrachte Ablehnung einer Behandlung für den Arzt bindend, sofern die konkrete Situation derjenigen entspricht, die der Patient in der Verfügung beschrieben hat, und keine Anhaltspunkte für eine nachträgliche Willensänderung erkennbar sind.

Soweit ein Vertreter (z. B. Eltern, Betreuer oder Bevollmächtigter in Gesundheitsangelegenheiten) vorhanden ist, ist dessen Erklärung maßgeblich; er ist gehalten, den (ggf. auch mutmaßlichen) Willen des Patienten zur Geltung zu bringen und zum Wohl des Patienten zu entscheiden. Wenn der Vertreter eine ärztlich indizierte lebenserhaltende Maßnahme ablehnt, soll sich der Arzt an das Vormundschaftsgericht wenden. Bis zur Entscheidung des Vormundschaftsgerichts soll der Arzt die Behandlung durchführen.

Liegt weder vom Patienten noch von einem gesetzlichen Vertreter oder einem Bevollmächtigten eine bindende Erklärung vor und kann eine solche nicht – auch nicht durch Bestellung eines Betreuers – rechtzeitig eingeholt werden, so hat der Arzt so zu handeln, wie es dem mutmaßlichen Willen des Patienten in der konkreten Situation entspricht. Der Arzt hat den mutmaßlichen Willen aus den Gesamtumständen zu ermitteln. Anhaltspunkte für den mutmaßlichen Willen des Patienten können neben früheren Äußerungen seine Lebenseinstellung, seine religiöse Überzeugung, seine Haltung zu Schmerzen und zu schweren Schäden in der ihm verbleibenden Lebenszeit sein. In die Ermittlung des mutmaßlichen Willens sollen auch Angehörige oder nahe stehende Personen als Auskunftspersonen einbezogen werden,

wenn angenommen werden kann, dass dies dem Willen des Patienten entspricht.

Lässt sich der mutmaßliche Wille des Patienten nicht anhand der genannten Kriterien ermitteln, so soll der Arzt für den Patienten die ärztlich indizierten Maßnahmen ergreifen und sich in Zweifelsfällen für Lebenserhaltung entscheiden. Dies gilt auch bei einem apallischen Syndrom.

V. Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen

Mit Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen nimmt der Patient sein Selbstbestimmungsrecht wahr. Sie sind eine wesentliche Hilfe für das Handeln des Arztes.

Eine Patientenverfügung (auch Patiententestament genannt) ist eine schriftliche oder mündliche Willensäußerung eines einwilligungsfähigen Patienten zur zukünftigen Behandlung für den Fall der Äußerungsunfähigkeit. Mit ihr kann der Patient seinen Willen äußern, ob und in welchem Umfang bei ihm in bestimmten, näher umrissenen Krankheitssituationen medizinische Maßnahmen eingesetzt oder unterlassen werden sollen.

Anders als ein Testament bedürfen Patientenverfügungen keiner Form, sollten aber schriftlich abgefasst sein.

Mit einer Vorsorgevollmacht kann der Patient für den Fall, dass er nicht mehr in der Lage ist, seinen Willen zu äußern, eine oder mehrere Personen bevollmächtigen, Entscheidungen mit bindender Wirkung für ihn, u. a. in seinen Gesundheitsangelegenheiten, zu treffen (§ 1904 Abs. 2 BGB). Vorsorgevollmachten sollten schriftlich abgefasst sein und die von ihnen umfassten ärztlichen Maßnahmen möglichst benennen. Eine Vorsorgevollmacht muss schriftlich niedergelegt werden, wenn sie sich auf Maßnahmen erstreckt, bei denen die begründete Gefahr besteht, dass der Patient stirbt oder einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet. Schriftform ist auch erforderlich, wenn die Vollmacht den Verzicht auf lebenserhaltende Maßnahmen umfasst.

Die Einwilligung des Bevollmächtigten in Maßnahmen, bei denen die begründete Gefahr besteht, dass der Patient stirbt oder einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet, bedarf der Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes, es sei denn, dass mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist (§ 1904 Abs. 2 BGB).Ob dies auch bei einem Verzicht auf

lebenserhaltende Maßnahmen gilt, ist umstritten. Jedenfalls soll sich der Arzt, wenn der Bevollmächtigte eine ärztlich indizierte lebenserhaltende Maßnahme ablehnt, an das Vormundschaftsgericht wenden. Bis zur Entscheidung des Vormundschaftsgerichts soll der Arzt die Behandlung durchführen.

Eine Betreuungsverfügung ist eine für das Vormundschaftsgericht bestimmte Willensäußerung für den Fall der Anordnung einer Betreuung. In ihr können Vorschläge zur Person eines Betreuers und Wünsche zur Wahrnehmung seiner Aufgaben geäußert werden. Eine Betreuung kann vom Gericht für bestimmte Bereiche angeordnet werden, wenn der Patient nicht in der Lage ist, seine Angelegenheiten selbst zu besorgen, und eine Vollmacht hierfür nicht vorliegt oder nicht ausreicht. Der Betreuer entscheidet im Rahmen seines Aufgabenkreises für den Betreuten. Zum Erfordernis der Genehmigung durch das Vormundschaftsgericht wird auf die Ausführungen zum Bevollmächtigten verwiesen.

2.6 Schwerkranke und Sterbende – Richtlinien für ethische Entscheidungen angesichts des Abbruchs oder im Hinblich auf das Nichteinleiten lebensverlängernder Therapiemaßnahmen

1. Ethische Entscheidungen über das Nichteinleiten oder Abbrechen von lebensverlängernden Therapiemaßnahmen sowie über palliative Maßnahmen sollen vom Arzt in enger Kooperation mit Patient, Angehörigen und Pflegepersonal getroffen werden.

Kommentar

Das Stichwort heißt »vorbereitende Kommunikation«. Bei Patienten mit hohem Alter und/oder Diagnose(n) mit schlechter Lebensprognose kann fast allen potenziellen ethischen Konfliktsituationen durch offene, vorbereitende Gespräche vorgebeugt und ein Einvernehmen über weitere Vorgehensmaßnahmen erzielt werden, sodass das Einschalten des Gerichts oder eines »Gesundheitsachverwalters« oder Betreuers überflüssig wird.

2. Wichtige Voraussetzungen für ethische Entscheidungen auf Seiten des Arztes sind gute Kenntnisse bezüglich der Krankheits- und Lebensgeschichte des Patienten und die fachliche Kompetenz, medizinische und ethische Herausfor-

derungen beurteilen zu können. Falls notwendig, sollte der Arzt Rat bei einem erfahrenen Kollegen einholen.

Kommentar

Die große Herausforderung ist zwar zunächst erst einmal die Erlangung der fachlichen Kompetenz, um den Krankheitszustand und die aktuellen medizinischen und ethischen Fragen und Behandlungsoptionen beurteilen zu können. Jedoch wird diese Beurteilung um ein Vielfaches kompetenter sein, wenn der Arzt den Patienten und dessen Angehörige kennt, verglichen mit einem im akuten Notfall dazu gerufenen Dienst habenden Arzt oder einem Notarzt, der diese Vorkenntnis nicht besitzt. In Situationen, in denen der Arzt im Zweifel oder in Bezug auf seine eigene fachliche oder ethische Kompetenz unsicher ist, sollte er Rat bei einem auf diesem Gebiet erfahrenen Kollegen, wie einem Palliativmediziner, einholen.

3. Bei Patienten, die selbst kompetente Entscheidungen treffen können, ist der Arzt immer verpflichtet, ein informiertes Einverständnis einzuholen bzw. herzustellen.

Kommentar

Bei der Planung aller diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen muss, soweit möglich, ein offenes Gespräch mit dem Patienten geführt werden. Ziel solcher Gespräche ist es v. a., ein gemeinsames Verständnis über die Erkrankung(en) und Diagnose(n) zu erzielen. Darauf folgend werden die Möglichkeiten und der Nutzen bezüglich weiterer Diagnostik und Therapieoptionen besprochen wie auch mögliche Nebenwirkungen oder Folgen dieser Maßnahmen.

Ist die Lebensprognose trotz optimaler Therapie begrenzt, ist der Arzt dem Patienten gegenüber verpflichtet, während der Gespräche die zeitliche Perspektive zu thematisieren.

Falls der Gesundheitszustand sich ändert, müssen neue Gespräche geführt werden, in denen ein der neuen Situation angepasstes informiertes Einverständnis anzustreben ist.

Wenn der informierte Patient dies ablehnt, dürfen weder diagnostische noch therapeutische Maßnahmen durchgeführt werden, auch dann nicht, wenn die Ablehnung im Konflikt steht zu den ärztlich vorgeschlagenen und medizinisch sinnvollen Therapiemaßnahmen. Im Klartext heißt das, wenn

z. B. ein schwerkranker, beatmungspflichtiger Patient das Einstellen der Beatmung fordert, v. a. wenn keine Aussicht auf eine Verbesserung seines sonstigen Krankheitszustands besteht, kann es auch rechtswidrig sein, die Beatmung fortzusetzen.

4. Bei diesen Gesprächen sollten nach Möglichkeit zusätzlich zum Patienten die nahen Angehörigen und ein Vertreter des Pflegepersonals anwesend sein.

Kommentar

Unser Auftraggeber ist der Patient. Wenn der Patient wach und orientiert ist, sollten niemals Aufklärungsgespräche oder das Einholen eines informierten Einverständnisses über den Kopf des Patienten hinweg stattfinden, etwa nur in Abstimmung mit Angehörigen oder Betreuern. Es kann aber auch sein, dass der Patient ausdrücklich wünscht, an diesen Gesprächen nicht teilzunehmen. Ansonsten dürfen nur bei minderjährigen Kindern Angehörige das informierte Einverständnis für die Behandlungsmaßnahmen des Patienten erteilen.

Wenn nun einerseits die Angehörigen Informationen bekommen, die der Patient aber nicht hat, folgt daraus sehr häufig, dass die Familie ihrer Möglichkeiten beraubt wird, in der letzten Lebensphase des Patienten gemeinsam Herausforderungen und wichtige Themen besprechen zu können. Auch eine für alle Familienmitglieder heilende, vorbereitende Trauer kann so nicht gelebt werden. Auf der anderen Seite brauchen auch die Angehörigen wichtige Informationen über Krankheitsverlauf und Zukunftsperspektiven, und sie sollten so früh wie möglich in wichtige Aufklärungsgespräche integriert werden. Dabei hat es gerade für Kinder und jugendliche Angehörige des Patienten eine zentrale Bedeutung, dass sie soweit wie möglich in den bevorstehenden Prozess integriert werden.

Das Einbeziehen der Pflegenden in diese Gespräche kann die Qualität dieser Prozesse um ein Vielfaches erhöhen. Oft haben die Pflegenden Kenntnisse über den Patienten und seine Angehörigen, die der Arzt nicht hat. Des Weiteren gibt die Anwesenheit einer Pflegeperson den Patienten die Möglichkeit, später klärende oder vertiefende Gespräche mit diesen Pflegenden zu führen, wenn der Arzt nicht da ist. Zusätzlich können Pflegende eine Unterstützung für den Arzt vor, während und nach diesen oft schwierigen Gesprächen sein und im Betreuungsteam vermitteln, worüber gesprochen wurde und wo in den nächsten Tagen die Herausforderungen liegen.

5. Falls die Erhebung und Dokumentation des informierten Einverständnisses auf Grund von eingeschränktem Bewusstsein, Verwirrtheit, Delirium, Demenz oder Bewusstlosigkeit des Patienten nicht möglich ist, muss der Arzt den mutmaßlichen Patientenwillen nach Einholen entsprechender Information (Angehörige, Pflegepersonal, Hausarzt, Patientenverfügung, Gesundheitsbevollmächtigter etc.) ermitteln und als Grundlage für seine Behandlungsentscheidungen nehmen und dies hinreichend dokumentieren.

Kommentar

Ethische Entscheidungen bei bewusstseinsklaren, schwerkranken Patienten müssten einfach sein, weil diese Entscheidungen weitgehend von den Patienten selbst nach der Erhebung des informierten Einverständnisses getragen werden. Um ein Vielfaches schwerer sind diese Entscheidungen, wenn das eingeschränkte Bewusstsein aufgrund der Krankheitsentwicklung die Erhebung eines informierten Einverständnisses nicht länger ermöglicht. Das zentrale Problem ist dann die Ermittlung des mutmaßlichen Patientenwillens, welche in vielfachen Entscheidungen des deutschen Bundesgerichtshofs und in den Grundsätzen der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung thematisiert wird.

Die Frage, die dann immer gestellt werden sollte, ist: *Welche Entscheidung hätte der Patient in seiner jetzigen Situation getroffen?*

Falls der Patient einen Gesundheitsbevollmächtigten ernannt hat, muss dieser gehört werden. Seine Aussage ist rechtlich mit der des vollmachtgebenden Patienten gleichzusetzen.

1. »Bei einem unheilbar erkrankten, nicht mehr entscheidungsfähigen Patienten kann der Abbruch einer ärztlichen Behandlung oder Maßnahme ausnahmsweise auch dann zulässig sein, wenn die Voraussetzungen der von der Bundesärztekammer verabschiedeten Richtlinien für die Sterbehilfe nicht vorliegen, weil der Sterbevorgang noch nicht eingesetzt hat. Entscheidend ist der mutmaßliche Wille des Kranken.
2. An die Voraussetzungen für die Annahme eines mutmaßlichen Einverständnisses sind strenge Anforderungen zu stellen. Hierbei kommt es vor allem auf frühere mündliche oder schriftliche Äußerungen des Patienten, seine religiöse Überzeugung, seine sonstigen persönlichen Wertvorstellungen, seine altersbedingte Lebenserwartung oder das Erleiden von Schmerzen an.« Urteil des 1. Strafsenats vom 13. September 1994 (BGHSt 40, 257)

»Ist ein Patient einwilligungsunfähig und hat sein Grundleiden einen irreversiblen tödlichen Verlauf angenommen, so müssen lebenserhaltende oder –verlängernde Maßnahmen unterbleiben, wenn dies seinem zuvor – etwa in Form einer sog. Patientenverfügung – geäußerten Willen entspricht. Dies folgt aus der Würde des Menschen, die es gebietet, sein in einwilligungsfähigem Zustand ausgeübtes Selbstbestimmungsrecht auch dann noch zu respektieren, wenn er zu eigenverantwortlichem Entscheiden nicht mehr in der Lage ist.« (BGHZ 154, 205 – Urteil vom 17. März 2003).

In dem gleichen Urteil heißt es weiter:

»Ist für einen Patienten ein Betreuer bestellt, so hat dieser dem Patientenwillen gegenüber Arzt und Pflegepersonal in eigener rechtlicher Verantwortung [und nach Maßgabe des § 1901 BGB] Ausdruck und Geltung zu verschaffen. Seine Einwilligung in eine ärztlicherseits angebotene lebenserhaltende oder –verlängernde Behandlung kann der Betreuer jedoch nur mit Zustimmung des Vormundschaftsgerichts wirksam verweigern.

Für eine Einwilligung des Betreuers und eine Zustimmung des Vormundschaftsgerichts ist kein Raum, wenn ärztlicherseits eine solche Behandlung oder Weiterbehandlung nicht angeboten wird – sei es dass sie von vornherein medizinisch nicht indiziert, nicht mehr sinnvoll oder aus sonstigen Gründen nicht möglich ist…«

6. Alle wichtigen Therapieentscheidungen, die ein medizinethisches Problem betreffen, sollen in der Krankenakte dokumentiert und begründet werden – mit Blick auf das informierte Einverständnis oder den mutmaßlichen Patientenwillen.

Kommentar

Diese Dokumentation wird sehr häufig vernachlässigt. Eine fehlende Dokumentation kann jedoch besonders bei der Behandlung von bewusstlosen, sterbenden Patienten zu Fehlentscheidungen führen, die den Patienten und Angehörige mehr als geboten belasten, wie etwa unnötige Wiederbelebungsmaßnahmen, Transporte oder Krankenhauseinweisungen. Für einen in solchen Situationen gerufenen Notarzt ist es oft unmöglich, die medizinethische Lage zu erfassen, wenn eine entsprechende Dokumentation (am besten direkt am Krankenbett, auf dem Nachttisch etc.) nicht vorliegt.

7. Diese Entscheidungen sollten, falls möglich, in der normalen Arbeitszeit getroffen werden und in den entsprechend zuständigen Gremien (Team- oder Stationsbesprechung, Ärzte- und Pflegekompetenz, Patienten und Angehörige).

Kommentar

Mehr als die Hälfte aller Todesfälle im deutschsprachigen Raum findet in Kliniken statt. Die große Mehrheit dieser Todesfälle tritt nicht plötzlich und unerwartet ein, sondern ist bei angemessener fachlicher Betreuung vorauszusehen, d. h. dass die notwendigen medizinischen, ethischen, kommunikativen und palliativen Maßnahmen antizipiert, vorbereitet und geplant werden könnten. Diese Vorbereitung und Planung sollte mit optimaler Kompetenz geführt werden, d. h. – wenn möglich – in der normalen Arbeitszeit, damit alle professionell involvierten Personen einbezogen und erreicht werden können.

8. Sollten die Grundlagen für das erteilte informierte Einverständnis oder den ermittelten mutmaßlichen Patientenwillens sich unerwartet ändern, z. B. bei Veränderungen im Gesundheitszustand, müssen die Entscheidungen neu überprüft werden.

Kommentar

Die Beurteilung medizinethischer Herausforderungen, wie sie bei schwerkranken Patienten in Bezug auf Entscheidungen über Therapie oder den Abbruch von Therapiemaßnahmen entstehen können, bezieht sich stets auf die aktuelle, vorliegende Situation in der Patientenbehandlung. Ändert sich die Situation, müssen sowohl Beurteilung als auch Zustimmung (oder Ablehnung) erneuert werden.

Hat der eigentliche Sterbeprozess bereits begonnen, so werden lebensverlängernde Maßnahmen in aller Regel schon ärztlich nicht mehr indiziert sein, sodass sie auch ohne Feststellung eines ausdrücklichen oder mutmaßlichen Patientenwillens unterlassen werden dürfen.

9. Von zentraler Bedeutung ist es, den Patienten (falls möglich), die Angehörigen und das Pflegepersonal laufend über Änderungen des Gesundheitszustands und Veränderungen der ethischen Fragestellung und Entscheidung zu informieren.

Kommentar

Die Voraussetzung für kompetente Entscheidungen und Vorbereitungen ist, die Landkarte zu kennen. Klärende Fragen und gefühlsmäßige Reaktionen können vorbereitend zugelassen werden, wodurch das Vertrauen und der oft mühsame Prozess des Loslassens gefördert wird. Dadurch können potenzielle Konflikte vermieden werden.

10. Optimal sind offene, mutige, vorbereitende ethische Gespräche mit Patient, Angehörigen und Pflegepersonal – möglichst gemeinsam, möglichst zeitnah zu Aufnahme, Diagnose, Veränderung des Zustandes etc., damit die wichtigen Bezugspersonen sich vorbereiten können und die Möglichkeit bekommen, wichtige Fragen zu stellen und gehört zu werden.

Kommentar

Wenn Informationen über eine lebensbedrohliche Krankheitsentwicklung mit schlechter Prognose vermittelt werden, werden viele Betroffene in der akuten Phase mit Schock, Wut, Apathie oder Verdrängung reagieren. Oft wird der Botschaftsüberbringer zum Feind erklärt. Diese zu erwartenden Reaktionen sind vorwiegend Trauerreaktionen. Erst mit der Zeit kann die Situation erfasst und akzeptiert werden (▶ Kap. 3 »Kommunikation«).

Besonders in Pflegeinstitutionen können Pflegende oder anderes Personal eine wichtige Rolle ähnlich derjenigen der Angehörigen einnehmen, daher sollten sie integriert werden in die Kommunikationsprozesse vor, während und nach dem Sterben des Patienten.

Ethische Konflikte am Lebensende können durch vorbereitende, offene Gespräche vermieden werden. Dabei ist v. a. zu bedenken, dass mehrere Gespräche geführt werden müssen, weil erst in dem Prozess der Kommunikation die Feindbilder erlöschen und eine Akzeptanz des zu Erwartenden erreicht werden kann.

11. Wenn der Arzt oder das Pflegepersonal erkennen, dass der Patient sterbend ist, sollen die Angehörigen darüber unverzüglich informiert werden, um ihnen die Möglichkeit zur Vorbereitung und zur Anwesenheit beim Sterben zu geben.

Kommentar

Es gibt Augenblicke, die wichtiger als alle anderen sind. Für die meisten Menschen ist dies der Augenblick, wenn ihre nächsten Angehörigen sterben.

Dieser Moment kann ein Höhepunkt des Lebens bedeuten, oder wie viele es ausdrücken: – *Es war wie eine Hochzeit…*

Nochmals ist das Stichwort: Vorbereitung. Hier geht es auch wieder um Deutlichkeit. Ist die Mutter oder der Ehepartner sterbend, müssen Sätze wie: »*Ihre Mutter (Ihr Ehemann) stirbt jetzt*« gesagt werden. Sehr viele Angehörige sind erst bei dieser Deutlichkeit in der Lage, sich auf den bevorstehenden Abschied einzustellen und in dieser Situation im Krankenzimmer zu bleiben. Die Angehörigen sollten auch aufgefordert werden, Kinder oder Enkelkinder in diesen Prozess zu integrieren.

12. Spätestens wenn das Sterben sich nähert oder unmittelbar bevorsteht, soll der Arzt sofort gemeinsam mit dem Pflegepersonal einen Plan für Palliative Care und Symptomlinderung erstellen, wobei alle unnötigen, belastenden oder unnötig sterbensverlängernden Therapiemaßnahmen einzustellen sind.

Kommentar

Palliative Care ist ein Gesamtkonzept für optimale Lebensqualität in der letzen Lebensphase. Gegenwärtig wird dies aber vorwiegend jüngeren Krebspatienten angeboten. So gut wie alle Sterbenden brauchen aber Palliative Care, und zwar unabhängig von ihrer Diagnose, ihrem Alter oder ihrem Aufenthaltsort. So sollte es Routine sein, bei allen Schwerkranken oder Sterbenden vorbereitend einen Plan für palliativmedizinische Maßnahmen zu erstellen, bevor es zu spät ist.

13. Falls das Pflegepersonal oder andere erkennen, dass der Sterbende an Schmerzen oder anderen belastenden Symptomen leidet, soll unverzüglich Kontakt mit dem zuständigen Arzt aufgenommen werden.

Kommentar

Schmerzen und andere belastende Symptome sind bei den Sterbenden die Regel und nicht die Ausnahme. Zum Beispiel sterben die meisten Menschen an einem Herzversagen. Die überwiegende Mehrzahl der Patienten entwickelt beim terminalen Herzversagen akute Dyspnoe mit einem vernichtenden Erstickungsgefühl. Die einzige suffiziente Linderung in diesem sich oft akut entwickelnden finalen Zustand ist die Applikation von Morphin (Opioide). Häufig aber ersticken diese Patienten, weil das Personal am Krankenbett das Problem nicht erkennt und kein kompetenter Arzt in der

notwendigen Reichweite ist oder aber, weil nicht für Verfügbarkeit eines Opioids für den Bedarfsfall gesorgt wurde.

14. Bei nicht erwartetem Todesfall sollen Arzt und Angehörige sofort informiert werden.

Kommentar

Einige Patienten sterben plötzlich oder unerwartet. Für die Hinterbliebenen kann dies oft eine erhebliche Belastung darstellen, weil die Möglichkeit der Vorbereitung und des Abschieds nicht gegeben war. War der Todesfall dramatisch, sollten auf jeden Fall Nachgespräche geplant werden.

Besonders in Pflegeinstitutionen können die Pflegenden oder andere eine wichtige Rolle ähnlich der von Angehörigen einnehmen, daher sollten sie integriert werden in die Kommunikationsprozesse nach dem Sterben des Patienten.

15. Den Angehörigen muss reichlich Zeit und Gelegenheit geboten werden, um Abschied von dem Toten nehmen zu können. Dies bedeutet auch, falls erwünscht, Gelegenheit zu bekommen, andere Angehörige, Kinder oder Enkelkinder usw. holen zu können, beim Waschen, Kleiden und Herrichten des oder der Verstorbenen teilzunehmen und später oder am nächsten Tag zurückzukommen.

Kommentar

Noch vor etwa 100 Jahren starb kaum jemand nicht in seiner häuslichen Umgebung, heute gilt dies nur noch für die meisten Entwicklungsländer. Das heißt, so gut wie alle Familien hatten seinerzeit aus nächster Nähe Erfahrung im Umgang mit Tod und Sterben. Heute finden Sterben und Tod weitgehend in Institutionen statt. Die früher über Tage stattfindende Verabschiedung von der Leiche hatte für den Trauerprozess und unsere Kultur eine zentrale Bedeutung, heute verabschiedet man sich oft nur wenige Minuten oder gar nicht, und viele wichtige Rituale sind in Vergessenheit geraten.

Das betreuende Personal hat beim Umgang mit dem Verstorbenen die Schlüssel in der Hand. Wir können die Angehörigen integrieren oder vor der Tür lassen. Wir können ihnen die notwendige Zeit und Rituale anbieten und sie auffordern, diese Zeit zu nutzen. Wir können sie auffordern, die Kinder

der Familie zu integrieren in die Verabschiedung, oder wir können sie auch in Fällen, in denen es erwünscht ist, unterstützen, damit sie den oder die Verstorbene bis zum Begräbnis zur Aufbahrung mit nach Hause nehmen können.

Was bedeuten Einverständnis und gute Kommunikation?

- **Informiertes Einverständnis**
  bedeutet, dass der Patient über seinen aktuellen Gesundheitszustand, d. h. Diagnose, Krankheitsbild, weitere diagnostische und therapeutische Möglichkeiten sowie Alternativen, Risiken und Prognose informiert wird, und zwar auf eine Weise, die er versteht und, falls nötig, wiederholte Male. Nachdem der Patient die Information verstanden hat und seine Fragen kommentiert und beantwortet wurden, gibt er seine Zustimmung – informiertes Einverständnis – oder er gibt sie nicht, oder er entzieht sie. Falls der Gesundheitszustand sich ändert, muss der zur Erteilung eines informierten Einverständnisses notwendige Prozess erneut durchlaufen werden. Bei bewusstseinsklaren Patienten darf keine diagnostische oder theraupeutische Maßnahme ohne das ausdrückliche, informierte Einverständnis durchgeführt werden.
- **Mutmaßlicher Patientenwille**
  bedeutet, dass wir bei Patienten, die aufgrund ihrer Erkrankung oder ihres Zustands selbst nicht die Situation erfassen oder Entscheidungen treffen können (bewusstlose, kognitiv eingeschränkte, verwirrte, psychotische oder demente Patienten), erhebliche Anstrengungen aufwenden müssen, um zu erfassen, welche Entscheidung sie in ihrer aktuellen Situation getroffen hätten. Quellen der Information für diesen Prozess sind v. a. Personen: Angehörige, betreuendes Personal, Hausarzt oder andere Menschen, die dem Patienten nahe standen, und zusätzliche Informationen wie: Lebensgeschichte, Krankengeschichte, Patientenverfügung, frühere Gespräche, Lebenseinstellung oder Religion.
- **Sowohl als auch –**
  Sehr viele Patienten, v. a. alte Menschen, können etwas oder viel verstehen und erfassen – aber nicht alles. Ein informiertes Einverständnis kann und muss nicht vollständig erreicht werden. Manche Kritiker halten das Konzept des informierten Einverständnisses für eine Fiktion.

▼

Oft sagt der Patient, nicht selten zu Recht: *Das verstehe ich nicht – Sie müssen für mich entscheiden, Herr Doktor.* Die Aufgabe ist es, dann zu begreifen, dass diese Verhandlungen wichtig sind – um zu einer Entscheidung zu kommen, die dem tatsächlichen Willen des Patienten entspricht. Der Arzt sollte dann nicht die Entscheidungen treffen, die er in dieser Situation für sich selbst für richtig halten würde, sondern die Entscheidung, die dem mutmaßlichen Willen des Patienten entspricht, gestützt auf das, was er von und über ihn erfahren konnte und unter Berufung auf seinen respektvollen Umgang mit dem Leben und Sterben des Patienten, der sich seiner Fürsorge anvertraut, indem er ihm das *Einverständnis* dazu gegeben hat, *für ihn* zu entscheiden.

Literatur

Ärzte Zeitung Online (2005) Holland regelt Tötung unheilbar kranker Babies. Ärzte Zeitung vom 1.12.2005, www.aerztezeitung.de

Ahronheim JC, Gasner MR (1990) The sloganism of starvation. Lancet 335: 278–279

Andrae M (1994) Facing death. Physicians' difficulties and coping strategies in cancer care. Medical Dissertations No 395, Umeå University

Andrews M, Beel ER, Smith SA (1993) Dehydration in terminally ill patients – is it a appropiate palliative care? Postgrad Med J 93: 201–208

Appleton Consensus (1992) International guidelines for decisions to forgo medical treatment. Proceedings of guidelines for non-treatment decicions. In: Tranøy KE (ed) Medisinsk etikk i vår tid. Sigma forlag, 5060 Søreidegrend/Norwegen

Beck-Friis B (1993) Hospital based homecare of terminal ill cancer patients. The Motala model. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 309. Uppsala University

Beleites M (1997) Entwurf der Richtlinie der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung und den Grenzen zumutbarer Behandlung. Dtsch Ärztebl 94/20: 1064–1065

Beleites M (2004) Ärzte wollen in Zukunft dem Willen der Patienten entsprechen. Ärzte Zeitung online vom 05.05.2004, http://www.aerztezeitung.de

Boisvert M (1990) About an »unconfirmed« stand. J Palliat Care: 2: 5–7

Bolund C (1985) Suicide and cancer: II. Medical and care factors in suicide by cancer patients in Sweden 1973–1976. J Psychosoc Oncol 3: 17–30

Brock D (1993) Life and death. Philosophical essays in medical ethics. Cambridge Univ Press, Cambridge

Bruera E (1994) Ethical issues in palliative care research. J Palliat Care 10/3: 7–9

Buchanan AE, Brock DW (1989) Deciding for others. Cambridge Univ Press, Cambridge

Buckman R (1996) Talking to patients about cancer. No excuse now for not doing it. BMJ 313: 699–671

Bundesärztekammer (2004) Grundsätze der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung. Dtsch Ärztebl 19, 17. Mai 2004
Bundesgerichtshof (1994) Urteil des 1. Strafsenats vom 13. September 1994 (BGHSt 40, 257)
Bundesgerichtshof (2003) Zivilsenat, Urteil vom 17. März 2003 (BGHZ 154, 205 und NJW 2003, 1588)
Bundesgerichtshof (2005) Zivilsenat, Beschluss vom 08.06.2005 (XII ZR 177/03)
Callahan D (1991) Medical futility, medical necessity: the problem without a name. Hastings Center Report 21: 30–35
Cassell EJ (1982) The nature of suffering and the goals of medicine. N Engl J Med 305: 639–45
Cherny NI, Coyle N, Foley KM (1994 a) Suffering in the advanced cancer patient: a definition and taxonomy. J Palliat Care; 10: 57–70
Cherny NI, Coyle N, Foley KM (1994 b) The treatment of suffering when patients request elective death. J Palliat Care 10: 71–79
Cherny NI, Portenoy EK (1994) Sedation and the management of refractory symptoms: Guidelines for evaluation and treatment. J Palliat Care 10: 31–38
Chochinov HM, Wilson KG (1995) The euthanasia debate: attitudes, practices and psychiatric considerations. Can J Psychiatry 40: 593–602
Cohen S (ed) (1989) Casebook on the termination of life-sustaining treatment and the care of the dying. Indiana Univ Press, Indiana
Condrau G (1991) Der Mensch und sein Tod. Kreuz-Verlag, Zürich
Davies E, Higginson IJ (2004): Better Palliative Care for Older People. A WHO Collaboration Project. WHO, Geneva
Downie RS, Calman KC (1994) Healthy respect: ethics in health care. Oxford Univ Press, Oxford
Dunstan GR, Shinebourne EA (eds) (1989) Doctors' decisions: ethical conflicts in medical practice. Oxford Univ Press, Oxford
EAPC Ethics Task Force (2003) Euthanasia and physician-assisted suicide: a view from an EAPC Ethics Task Force. Eur J Palliative Care 10(2): 63-66
Enquete-Kommission »Ethik und Recht der modernen Medizin« des Deutschen Bundestags, 15. Wahlperiode, Zwischenbericht »Patientenverfügungen«, BT-Drs. 15/3700, Berlin, 2005
Eser A, Lutterotti M, Sproken P (1992) Lexikon Medizin-Ethik-Recht. Herder, Freiburg i. Br.
Fainsinger R, Bruera E (1994) Management of dehydration in terminally ill patients. J Palliat Care 10: 55–59
Fallowfield L (1997) Truth sometimes hurts, but deceit hurts more. In: Surbone A, Zwitter M (eds) Communication with the cancer patient. Information and truth. Ann N Y Acad Sci 809: 525–537
Foley KM (1985) The treatment of cancer pain. N Engl J Med 313: 84–95
Foley KM (1991) The relationship of pain and symptom management to patient request for physician-assisted suicide. J Pain Symptom Manage 6: 289–297
Foley KM (2002) Improving Palliative Care: The need for change. J Am Med Womens Assoc 2002;5: 71–77
Gaylin W et al. (1988) Doctors must not kill. JAMA 259: 2139–2140
Gordijn B, Janssens R (2000) The prevention of euthanasia through palliative care: New developments in The Netherlands. Patient Educ Couns 41: 35–46
Harris J (1985) The value of life. Routledge & Kegan, London
Husebø S (1989) Is euthanasia a caring thing to do? J Palliat Care 4: 111–114

Husebø S (1991) Er aktiv dødshjelp et alternativ? Samtiden 91/6: 24–32
Husebø S (1992) Medisin – kunst eller vitenskap. Ad Notam Gyldendal, Oslo
Husebø S (1993) Autonomi og paternalisme – hva betyr det ved alvorlig sykdom? Omsorg 3: 61–66
Husebø S (1997) Communication, autonomy and hope. How can we treat serious ill patients with respect? In: Surbone A, Zwitter M (eds) Communication with the cancer patient. Information and truth. Ann N Y Acad Scie 809: 440–460
Husebø S (1997) Undervisning i palliativ medisin. Omsorg 3
Husebø S, Tausjø J (1986) Dying patients in hospital. Tidsskr Nor Lægef 110: 2233–2235
James CR, MacLeod RD (1993) The problematic nature of education in palliative care. J Palliat Med 9: 5–10
Janssens R, Gordijn B (1998) Palliativmedizin in den Niederlanden. Dtsch Med Wochenschr 123: 432–435
Jaspers B, Schindler T (2004) Stand der Palliativmedizin und Hospizarbeit in Deutschland und im Vergleich zu ausgewählten Staaten (Belgien, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien), erstellt im Auftrag der Enquete-Kommission »Ethik und Recht der modernen Medizin« des Deutschen Bundestags, 15. Legislaturperiode, http://www.bundestag.de/parlament/kommissionen/archiv15/ethik_med/gutachten/gutachten02_palliativmedizin.pdf
Jecker NS, Pearlman RA (1992) Medical futility: who decides. Arch Intern Med 152: 1140–1144
Jens W, Küng H (1995) Menschenwürdig sterben. Piper, München
Kant I (Ausg 1989) Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. In: Weischedel W (Hrsg) Kant I: Kritik der praktischen Vernunft. Suhrkamp, Frankfurt am Main
Kemp P (1992) Medisin, teknikk og etikk. Munksgaard, Copenhagen
Kierkegaard S (1859, Ausg 1994) Fra en forfatters virksomhet (Aus dem Wirken eines Verfassers). Eine einfache Mitteilung. Sören Kierkegaard Gesammelte Werke. Munksgaard, Copenhagen
Kintzi H (2002) Ärztliche Indikationen zum Töten. Deutsche Richter Zeitung Juli: 256–263
Klaschik E, Husebø S (1997) Palliativmedizin. Anaesthesist 46: 177–185
Klaschik E, Ostgathe C, Nauck F (2002): Defizite in der studentischen Ausbildung. Dtsch Ärztebl 99: A 1286–1288
Kutzer K (2005). Vorsitzender des 1. Zivilsenats des Bundesgerichtshofes a. D. Vortrag in Karlsruhe Oktober 2005.
Lögstrup KE (1989) Den etiske fordring, 12. Aufl. Gyldendal, Copenhagen (1. Aufl. 1956)
McCann RM, Hal WJ, Groth Juncker A (1994) Comfort care for the terminally ill patients, the appropriate use of nutrition and hydration. JAMA 272: 1263–1266
Morgan JD (ed) (1996) Ethical issues in the care of the dying and bereaved aged. Baywood, New York
Moulin DE, Latimer, EJ, MacDonald N et al. (1994) Statement on euthanasia and physician-assisted suicide. J Palliat Med 10: 80–81
Mount BM, Hamilton P (1994) When palliative care fails to control suffering. J Palliat Care 10: 24–26
Müller-Busch HC (2004) Sterbende sedieren? Z Palliativmed 5: 107-112
Musgrave CF, Opstad B, Opstad J (1995) The sensation of thirst in patients receiving iv. hydration. J Palliat Care 11: 17–21

Onwuteaka-Philipsen B, van der Heide A, Koper D, Keij-Deerenberg I, Rietjens JA, Rurup ML, Vrakking AM, Georges JJ, Muller MM, van der Wal G, van der Maas PJ (2003): Euthanasia and other end-of-life decisions in the Netherlands in 1990, 1995, and 2001. Lancet, online publication, June 17, 2003, http:image.thelancet.com/extras/03art3297web.pdf

Pellegrino ED, Thomasma DC (1994) The virtues in medical practice. Oxford Univ Press, Oxford

Provoost V, Cools F, Mortier F, Bilsen J, Ramet J, Vandenplas Y, Deliens L (2005) Medical end-of-life decisions in neonates and infants in Flanders. Lancet 365: 1315–1320

Putz u. Teipel, Rechtsanwälte, Pressemitteilung vom 24.07.2005

Quill TE, Cassell TK, Meier DE (1992) Care of the hopelessly ill. Proposed criteria for physician-assisted-suicide. N Engl J Med 327: 1380–1384

Rachels J (1975) Active and passive euthanasia. N Engl J Med 292: 78–80

Randall F, Downie RS (1996) Palliative care ethics. A good companion. Oxford Medical Publications, Oxford

Roy D (1990) Euthanasia – taking a stand. J Palliat Med 1: 3–5

Roy DJ (1991) Relief of suffering: the doctor's mandate. J Palliat Care 7: 3–4

Scott JF, MacDonald N (1993) Education in palliative medicine. In: Doyle D, Hanks J, MacDonald N (eds) Oxford Textbook of Palliative Medicine. Oxford University Press, Oxford, pp 761–781

Singer PA, Siegler M (1990) Euthanasia – a critique. N Eng J Med 322: 1881–1883

Smith GP (1995) Restructuring the principle of medical futility. J Palliat Med 11/3: 9–16

Strätling M, Sedemund-Adib B, Schmucker P (2004) Patientenverfügungen und Rahmenbedingungen für Entscheidungen am Lebensende in Deutschland. Praktische, standesrechtliche und berufspolitische Konsequenzen der jüngsten Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Z Palliativmed 5: 13–18

Sullivan RJ (1993) Accepting death without artificial nutrition or dehydration. J Gen Intern Med 8: 220–224

Ten Have HAMJ, Welie JVM (1996) Euthanasia in the Netherlands. Crit Care Clin 12: 97–108

Tolstoj L (1884, Ausg 1994) Der Tod des Iwan Iljitsch. Insel Taschenbuch

Toulmin S (1982) How medicine saved the life of ethics. Perspect Biol Med 32: 72–79

Tranøy KE (1992 a) Medisinsk etikk i vår tid. Sigma forlag, 5060 Søreidegrend/Norwegen

Tranøy KE (1992) Nobel conference on ethics in medicine. International review on health legislation. World Health Organization, Geneva

Twycross RG (1993) Symptom control: The problem areas. J Palliat Med 7: 1–8

Van der Wal G, Van der Maas PJ, Bosma JM (1996) Evaluation of the notification procedure for physician assisted suicide, and other medical practices ivolving the end of life in the Netherlands. N Engl J Med 335: 1706–1711

Verhagen E et al (2005) The Groningen Protocol – Euthanasia in severely ill newborns. NEJM 352: 959–962

Wilkinson J (1990) The ethics of euthanasia. Palliat Med 4: 81–86

World Medical Association (1987) Declaration on euthanasia. Ferney-Voltaire, Paris

3 Kommunikation

S. Husebø

Zeige mir deine Maske,
und ich kann dir sagen, wer du bist.
(Maurice English)

3.1 Kommunikation – Hintergründe

Der Umgang und die Kommunikation mit schwerkranken Patienten stellen für den Arzt eine erhebliche fachliche, ethische und menschliche Herausforderung dar. Nicht selten führt dieser Umgang zu Problemen und Belastungen, weil Kommunikation schwierig ist und ihre Bedeutung zunimmt, wenn sich ein Mensch innerhalb kurzer Zeit auf eine neue Lebenssituation einstellen muss.

Die meisten Patienten konsultieren im Laufe einer ernsten Erkrankung mehrere Ärzte, die unterschiedliche Fähigkeiten zur Kommunikation besitzen und unterschiedliche Kenntnisse über die Person des Patienten haben.

Kommunikation lernen wir im Leben; in der Kindheit, im Umgang mit Menschen, durch Erfahrungen und Begegnungen mit guten und schlechten Vorbildern. Nicht zuletzt wird Kommunikationsfähigkeit entwickelt durch unsere Fähigkeit zu eigener Reflexion, dadurch, dass wir in der Lage sind, über eigene Unzulänglichkeiten und sichtbare und unsichtbare Probleme nachzudenken.

Kunst ist Kommunikation, und Kommunikation ist Kunst (Husebø 1992). Kann diese Kunst gelehrt und gelernt werden? Ist es möglich, durch das Lesen eines Lehrbuches seine eigene Fähigkeit zur Kommunikation zu verbessern?

Das Hauptanliegen dieses Kapitels ist es, durch Beispiele und Kommentare zu einem größeren Verständnis der Ziele und der Möglichkeiten der Kommunikation zwischen Arzt und Patient beizutragen. Die Rechte der Patienten und die Pflichten der Ärzte werden diskutiert. Die Kommunikation bei schwerer, lebensbedrohlicher Krankheit, die Hoffnung und Hoffnungslosigkeit beim Patienten und seinem Arzt sollen beleuchtet und beschrieben werden.

Viele fragen sich, wie es dazu gekommen ist, dass die Mediziner über viele Jahrhunderte es für richtig hielten, ihre Information und Einsicht für sich zu behalten und nicht mit ihren Patienten zu teilen. Im Jahr 1672 schrieb der französische Arzt Samuel de Sorbiere (1984) einen Aufsatz, in dem er das Problem, den Patienten die Wahrheit vorzuenthalten, erkannte, sah aber keine Möglichkeit, die vorhandene Praxis zu ändern.

Auch 300 Jahre später halten viele Mediziner an dieser Strategie fest. Wir erkennen, dass etwas getan werden muss, um den Patienten als gleichwertigen Gesprächspartner anzuerkennen. Es fehlt uns aber nicht an Entschuldigungen, um ihn vor der Wahrheit zu schützen. Im Jahr 1961 (Oken) zeigte eine Untersuchung unter Chirurgen in den USA, dass mehr als 90% der Ärzte den Patienten nicht über seine Krebsdiagnose aufklärten.

Onkologen führen in ihrem Berufsleben etwa 100.000–200.000 Gespräche mit Krebspatienten und deren Angehörigen (Fallowfield 1995). In den meisten anderen klinischen Spezialgebieten finden wir ähnliche Situationen. Gespräche mit Patienten nehmen mehr Zeit in Anspruch als jede andere ärztliche Tätigkeit. Sie werden von vielen Ärzten als der schwierigste und am meisten belastende Teil ihrer Berufsaufgaben angegeben. Fallowfields Studie (1996) über Kommunikationsprobleme hat diese »Problemgebiete« der Ärzte in fünf Punkten zusammengefasst:

- Schlechte Nachrichten vermitteln
- Informiertes Einverständnis erzielen
- Mit Angehörigen sprechen
- Diskussion von Therapiealternativen
- Psychosoziale Probleme ansprechen

Bis heute hat kaum ein Arzt eine Ausbildung in Kommunikation erhalten. Sie hat nur einen äußerst geringen Stellenwert im Fächerkanon des Medizinstudiums. Im späteren Berufsleben bekommen Ärzte nur in Ausnahmefällen eine Weiterbildung.

Wir haben lange gedacht, dass Kommunikation nicht gelernt werden kann. Erfahrungen mit Studentenunterricht und Weiterbildungsprogrammen, v. a. im englischsprachigen Raum und in Skandinavien, zeigen uns heute, dass diese Annahme nicht zutrifft (Maguire 1990; Bird et al. 1993; Fallowfield 1996). Es gibt wohl kaum ein Gebiet der Medizin von größerer Bedeutung für den Patienten und seinen Angehörigen. Es bleibt für uns in den kommenden Jahren viel nachzuholen.

3.2 Sollen wir den Patienten vor der Wahrheit schützen?

Ärzte beschäftigen sich intensiv mit der Frage, ob und wann ein Patient über sein Leiden aufgeklärt werden soll oder ob die Aufklärung eine nicht akzeptable Belastung sein kann. »Der Patient muss aufgeklärt werden«, sagen die einen. »Der Patient muss vor dem Schock brutaler Aufklärung geschützt werden«, sagen die anderen. Sie haben beide Recht.

Ein häufig gehörtes Argument ist, dass »Krebs« in den Augen der Bevölkerung eine fürchterliche Diagnose ist. Das Wort allein ist so verknüpft mit Vorurteilen, Angst, Befürchtungen und Panikreaktionen, dass der Arzt es möglicherweise als seine Aufgabe empfindet, den Patienten vor der Wahrheit zu schützen.

Ärzte, die behutsam mit Aufklärung und Offenheit vorgehen wollen und selbst die Entscheidungen treffen, wie viel sie ihren Patienten sagen und wie viel sie zurückhalten, stützen sich v. a. auf zwei Argumente:

- Es war immer die Aufgabe der Ärzte, den Patienten vor Schaden zu schützen.
- Es würde vielen Patienten mehr Schaden als Nutzen bringen, wenn sie sich zu der »Wahrheit« verhalten müssten.

Ärzte, die dagegen behaupten, die Patienten müssen *immer* alles erfahren, was für sie, ihre Zukunft und ihre Entscheidungen wichtig sein kann, führen als Argumente auf:

- Das Recht auf Information und Selbstbestimmung ist ein grundlegendes Menschenrecht, das in unserer Verfassung und in den Menschenrechten der UNO verankert ist.
- Der Arzt hat nur in sehr begrenzten Situationen das Recht, Entscheidungen für den Patienten zu treffen.
- Eine fachliche Grundlage für die Behauptung, durch Zurückhalten von Information werde der Patient vor Schaden geschützt, gibt es nicht.

Wir wollen die heutige Praxis in verschiedenen Ländern kurz darstellen, um uns dann den Fragen zu widmen, unter welchen Umständen es begründbar sein könnte, dass der Arzt Entscheidungen über den Kopf des Patienten hinweg trifft, und wann und wo es gut oder schlecht ist, die Wahrheit zu erfahren.

3.2.1 Wie wird heute über bösartige Erkrankung informiert?

Eine britische Studie zeigt, dass 44% der Krankenhausärzte und 25% der Niedergelassenen normalerweise mit den Krebspatienten über ihre Diagnose sprechen (Wilkes 1984). In Deutschland gibt es nur wenige vergleichbare Studien. Es liegt kein Grund zur Annahme einer größeren Offenheit vor. Eine Untersuchung über Information vor chirurgischen Eingriffen (Verres 1997) ergab, dass nur 18% der Patienten die wichtigsten Teile der gegebenen Information verstanden hatten; 49% konnten sich daran erinnern, dass ein Informationsgespräch stattgefunden hatte, und Fragmente des Gespräches wiedergeben. Die übrigen 33% gaben entweder an, ein solches Gespräch habe nicht stattgefunden, oder sie hatten den Inhalt völlig missverstanden.

Eine Befragung europäischer Gastroenterologen zeigt, dass die Kollegen in West- und Nordeuropa grundsätzlich eine Offenheit gegenüber ihren Krebspatienten bezüglich ihrer Diagnose befürworten. Die Mehrheit der Kollegen in Süd- und Osteuropa meint dagegen, es gehöre zu ihren ärztlichen Pflichten, ihr Wissen über Diagnose und Prognose für sich zu behalten und den Patienten vor der Wahrheit zu schützen, manchmal sogar wenn der Patient selbst ausdrücklich die Wahrheit wissen will (Østergaard et al. 1993). Sie würden eher die Angehörigen als die Patienten informieren. Allein 60% der gesamteuropäischen Ärzte würden nur dann die Diagnose »Krebs« sagen, wenn der Patient ausdrücklich danach fragt.

Noch deutlicher wird der beschriebene Konflikt, wenn wir den Blick in den fernen Osten richten oder auf die Länder der so genannten Dritten Welt. In China und Japan gehört es zur seltenen Ausnahme, dass ein Krebspatient die Diagnose erfährt (Li u. Chou 1997). In vielen Ländern Afrikas, wie Nigeria (Solanke 1997), Ägypten (El-Ghazali 1997) oder Südafrika (Colvin u. Lehoka 1997), hängt die gegebene Information über eine bösartige Erkrankung vom sozialen Status und von der Ausbildung des Patienten ab. Nur eine kleine, gut gestellte, gut ausgebildete Minorität besitzt überhaupt eine Möglichkeit, etwas über ihre Diagnose zu erfahren.

Demgegenüber zeigte eine Wiederholung der von Oken 1961 durchgeführten Studie (Novack et al.) im Jahr 1979, dass mehr als 90% der Ärzte in den USA ihre Patienten über eine Krebsdiagnose aufklären.

Wir stehen vor einem Konflikt zwischen den zwei zentralen Begriffen in Medizin und Ethik: Paternalismus und Autonomie.

> Paternalismus ist eine zwingende Einmischung in die Handlungsfreiheit eines anderen aus Gründen, die sich ausschließlich auf das Gute für einen anderen, auf das Wohl und das Glücklichsein und auf die Bedürfnisse, Interessen oder Werte des anderen berufen.
> (Dworkin 1972)

Bei der Autonomie trifft der Patient selbst Entscheidungen. Wie vorsichtig und begrenzt der Arzt mit Paternalismus vorgehen muss, ist im Kapitel über Ethik (▶ Kap. 2) besprochen.

Aufklärung ist nicht nur eine Frage von Medizin und Ethik. Es ist auch eine Frage von Kultur, Tradition und Altersgeneration der Ärzte und Patienten. Wir beobachten in unserer Gesellschaft eine unaufhaltsame Entwicklung zu mehr Offenheit und Aufklärung. Gleichwertigkeit, Gleichberechtigung und Autonomie stellen bei uns grundlegende Wertbegriffe dar. Diese Werte werden heute ganz anders verstanden als in früheren Generationen. Auch in der heutigen Zeit sind zwischen Großeltern, ihren Kindern und Enkelkindern erhebliche Unterschiede in der Auffassung und im Verständnis dieser Begriffe vorhanden.

Sowohl die Menschenrechte der Vereinten Nationen (1948) als auch Beschlüsse des Europarats unterstreichen das Selbstbestimmungsrecht eines jeden. Der Europarat geht in einem Dokument über die Rechte des Sterbenden hinaus (Condrau 1991). In dem Dokument wird rechtsverbindlich für alle 12 Staaten des Europarates das *Recht* des Patienten auf Autonomie und Information festgehalten. Inzwischen sind das Recht des Patienten auf ausführliche und offene Information – inklusive dem Recht, die Diagnose zu erfahren, und die Pflicht des Arztes, diese mitzuteilen – in vielen Ländern (USA, Kanada, Skandinavien) gesetzlich verankert (Buckman 1996).

Bei kompetenten, entscheidungsfähigen Patienten gibt es für den Arzt keine fachliche oder moralische Grundlage, paternalistisch zu handeln. Wenn er sich vor Entscheidungen über Aufklärung oder Nichtaufklärung auf seine eigene Intuition beruft, wird er vielen Patienten Unrecht und Schaden zufügen. Ärzte, die das Selbstbestimmungsrecht des Patienten nicht als Hauptgrundlage ihrer medizinischen Tätigkeit bewerten, verstoßen sowohl gegen die heute anerkannten Grundregeln der medizinischen Ethik als auch gegen die zentralen Rechtsgrundlagen der Gesellschaft (Eser et al. 1992; Loewy 1995; Kahlke u. Reither-Theil 1995; Buckman 1996).

- Somit besteht nicht die Frage, ob der Arzt oder der Patient entscheiden soll, was für den Patienten gut und richtig ist. Denn:
- Solange der Patient entscheidungsfähig ist, darf *nur* der Patient selbst diese Entscheidungen treffen.

Dabei müssen wir Rücksicht auf die Kultur, die Erfahrungen und den Hintergrund des Patienten nehmen. Diese kulturellen, individuellen und gesellschaftlichen Hintergründe sind die Voraussetzungen für das Selbstbestimmungsrecht.

Patienten haben auch das Recht, *nicht* gegen ihren Willen aufgeklärt zu werden (Buckman 1993; 1996; Husebø 1997). In seinem Buch über Krebsrisiko und Psyche schreibt Verres (1994):

> Es kann auch inhuman sein, einem Menschen das Wissen von seinen Tod gleichsam aufzuzwingen und ihn dadurch in ein Stadium von Hoffnungslosigkeit zu versetzen.

Aber wie wissen wir, welchen Willen der Patient hat, ohne ihn gefragt zu haben?

Wenn der Patient bei einem Gespräch über die Krankheit sagt: »Ich will aber nicht mehr über diese Diagnose wissen. Ich habe verstanden, dass es ernst aussieht. Helfen Sie mir bitte, damit ich kämpfen kann und mit Würde diese Zeit überstehe«, wissen wir, dass er heute nicht mehr verkraften kann.

Viele Patienten zeigen mit dieser Aussage Vorurteile und Befürchtungen. Es wäre ein Fehler zu glauben, weitere Gespräche über die Erkrankung sollten jetzt gemieden werden. Der Arzt muss durch Offenheit und Vertrauen in der kommenden Zeit vorsichtig versuchen, notwendige Information zu geben und Gesprächsbereitschaft zu zeigen, damit Angst und unrealistische Befürchtungen reduziert werden können und der Patient wichtige Entscheidungen über seine Zukunft treffen kann.

Das Recht des Patienten, selbst Entscheidungen zu treffen, bedeutet nicht das Recht auf unangemessene Behandlung oder Diagnostik (▶ Kap. 2 und ▶ Kap. 5.2). Auch Patienten haben Pflichten. Sie müssen sich an die sittlichen und moralischen Grundlagen der Gesellschaft anpassen. Kranke sollen, wie Ärzte, nicht lügen oder rücksichtslos sein.

Wir dürfen Patienten nicht allein lassen bei wichtigen Entscheidungen. Es ist unsere Aufgabe, die Situationen mit ihnen zu diskutieren und verantwortungsbewusst mitzutragen (Degner u. Sloan 1992). Patienten ohne Unterstützung und Hilfestellung ihrer Autonomie auszuliefern, hieße ärztliche oder pflegerische Pflichten sehr leicht zu nehmen. Der Arzt besitzt einen Überblick über Information und Wissen, worauf der Patient angewiesen ist, um eine in dieser Situation »richtige« Entscheidung treffen zu können (Holland 1989).

- »Für solche Gespräche habe ich einfach keine Zeit. Wer von mir erwartet, Zeit für lange Informationsgespräche mit Patienten zu haben, versteht nicht, wie groß meine Arbeitsbelastung ist.«
- »Ich war froh, als ich das Krankenzimmer betrat und der Patient nicht da war. Dadurch wurde ich vor einem schwierigen Gespräch bewahrt.«

Aussagen wie diese sind nicht ungewöhnlich (Senn 1985). Es mag zutreffen, dass Ärzte zunehmend Aufgaben auf sich genommen haben und vom Arbeitgeber auferlegt bekommen und weniger Zeit für den einzelnen Patienten haben. Aber Informations- und Aufklärungsgespräche sind eine ärztliche *Pflicht*. Überall in der Ausübung unseres Berufes stellen wir hohe Forderungen an Qualität und Kompetenz, Forderungen, die von den Patienten und den Arbeitgebern sehr unterstützt werden.

Es kann nicht angehen, dass wir bezüglich Diagnostik und Behandlung ein Höchstmaß an Qualität anstreben, während wir dem Selbstbestimmungsrecht, der Ethik und Kommunikation Qualitätsforderungen zugrunde legen, die entweder im vorigen Jahrhundert aktuell waren oder auf einem anderen kulturellen Kontext beruhen, z. B. Osteuropa oder Afrika, und somit nicht ohne Weiteres übertragbar sind!

Bei schwerkranken Patienten ist wohl keine Aufgabe wichtiger, als die Schmerzen und das Leiden zu lindern. Für viele Patienten ist dieses Ziel kaum erreichbar ohne Offenheit und gute Kommunikation. Oder, wie Viktor Frankl (1975) es ausdrückt:

> Es gilt, das Leiden anzunehmen, das Schicksal zu bejahen, sich zu stellen. Auf diesem Weg kommen wir an die Wahrheit heran, kommen wir ihr nahe, auf diesem Weg allein, nicht auf den Wegen der Flucht und Furcht vor dem Leiden.

3.2.2 Wieviel Information und Offenheit wollen die Patienten?

Der Anteil der Patienten, die eine vollständige Offenheit von ihrem Arzt bezüglich Diagnose, Therapie und Prognose wollen, unterliegt lokalen und zeitlichen Variationen. Studien, die in Nordeuropa und Nordamerika in den letzten 20 Jahren durchgeführt wurden, zeigen einen Durchschnitt von 85–95% (Northouse u. Northouse 1987; Meredith et al. 1996).

Meredith et al. fanden in ihrer Befragung von 250 Patienten eines onkologischen Zentrums in Schottland, dass 79% der Patienten so viel wie möglich über Krankheit, Diagnose, Therapie und Prognose erfahren wollten; 96% der Befragten wollten ausdrücklich wissen, ob sie Krebs hatten oder nicht. Fast alle wollten auch Informationen über die Möglichkeit einer Heilung, die Prognose und die Nebenwirkungen der Therapie erhalten.

In einer anderen Untersuchung von 1996 (Benson u. Britten) sagten fast sämtliche Patienten (94%), dass die Angehörigen nur nach einer dazu gegebenen Erlaubnis des Patienten über die Krebserkrankung informiert werden sollten. *Alle* Patienten sagten, dass ihre Angehörigen unter keinen Umständen das Recht hätten, vom Arzt zu verlangen, er solle Informationen vor dem Patienten verheimlichen.

50 Patienten wurden nach der Aufklärung über Lungenkrebs über ihre Reaktionen auf die Aufklärung befragt (Sell et al. 1993). Zwei Patienten sagten, dass keiner sie aufgeklärt habe. Zwei wären lieber ohne diese Information geblieben. Die restlichen 46 (92%) erlebten die ehrliche, offene Information als richtig. Keiner sagte aus, er hätte zu viel Information bekommen, aber 26% wollten mehr über die Prognose wissen.

In Deutschland wurden 537 Personen (Tumorpatienten, Laien, Pflegepersonal und Ärzte) zu ihrer Einstellung bezüglich Aufklärung und Wahrhaftigkeit befragt (Husebø 1997). Die Ergebnisse (Tab. 3.1) zeigen eine eindeutige Bestätigung der in den letzten Jahren in Großbritannien, in den USA und in Skandinavien durchgeführten Studien.

Diese Studie (sie wurde 1998 publiziert) bestätigt eindeutig, dass die Patienten dem Arzt ein klares Mandat zur Offenheit und Kooperation geben. Die Befragten sagen fast ohne Ausnahme, dass sie alles über Diagnose, Krankheit, Therapie und Prognose erfahren wollen. Therapieentscheidungen wollen sie entweder selbst oder gemeinsam mit dem Arzt treffen; 98% von ihnen wollen keinen »sinnlosen« Therapien ausgesetzt werden. Die häufig mit den Angehörigen anberaumten Aufklärungsgespräche sollten nur

Tab. 3.1. Ergebnisse zur Umfrage »Falls ein Krebsleiden bei Ihnen diagnostiziert wird, wie möchten Sie vom Arzt aufgeklärt werden?« (Angaben in Klammern: Prozentzahlen)

Antwortmöglichkeit	Tumor-patienten n = 144	Laien n = 112	Pflege-personal n = 164	Ärzte n = 117	Befragte insgesamt n = 537
Ich erwarte *völlige* Offenheit des Arztes hinsichtlich Krankheit, Diagnose, Therapie und Prognose	132 (92)	109 (97)	162 (98)	116 (99)	519 (96)
Ich erwarte von meinem Arzt, dass er					
– mir gegenüber die Initiative ergreift, wenn er die Information bekommen hat	105 (73)	89 (80)	149 (91)	91 (78)	434 (80)
– sich Zeit lässt und mir die Information über mehrere Wochen (verteilt) vermittelt	67 (47)	33 (30)	67 (41)	41 (35)	208 (39)
– mir die Information nur gibt, wenn ich darum bitte	7 (4,9)	3 (2,7)	2 (1,2)	3 (2,6)	15 (2,8)
– selbst entscheidet, ob ich eine offene Information verkraften kann	4 (2,8)	1 (0,9)	–	2 (1,2)	7 (1,3)
– mich schützt, indem er mir seine Information verschweigt	1 (0,7)	–	–	–	–
– nicht ohne meine Anwesenheit/mein Einverständnis mit meinen Angehörigen spricht	135 (94)	106 (97)	162 (99)	511 (95)	108 (92)
Ich will selbst entscheiden, welche Therapie ich bekommen soll	86 (60)	93 (83)	149 (91)	101 (86)	429 (80)
Ich will die Therapieentscheidungen gemeinsam mit meinem Arzt treffen	54 (38)	18 (17)	12 (7)	15 (3)	99 (18)
Ich will, dass mein Arzt für mich diese Entscheidungen trifft	4 (2,7)	1 (1)	–	1 (0,6)	6 (1,1)
Ich will, dass mein Arzt niemals eine Therapie durchführt, die sinnlos ist	142 (99)	109 (97)	161 (98)	113 (97)	525 (98)

in Anwesenheit des Betroffenen durchgeführt werden, es sei denn, dieser hat vorher die Erlaubnis zu separaten Gesprächen erteilt.

3.2.3 Ist es besser für den Patienten, wenn wir ihn vor unangenehmen Wahrheiten schützen?

Die Qualität der Kommunikation zwischen Arzt und Patient hat, wie in vielen Untersuchungen nachgewiesen, einen größeren Einfluss auf die Lebensqualität, die Gesundheit und das Wohlergehen der Patienten als alle andere Faktoren (Simpson et al. 1991; Kaplan et al. 1989; Headache Study Group 1986). Sie zeigt auch, wie Kommunikationsprobleme den Patienten und die Behandlung schwer belasten können (Stewart et al. 1979; Stedeford 1994). Diese und eine Reihe anderer Studien zeigen auch, dass der Arzt falsche Vorstellungen hat bezüglich der von den Patienten gewünschten Art, dem Ausmaß und Inhalt von Information (Simpson 1980; Frances et al. 1969; MacKillop et al. 1988). Die Ergebnisse der Behandlung waren bedeutend besser, wenn der Arzt die vorliegenden Probleme gemeinsam mit dem Patienten identifizieren konnte und dann mit ihm über seine Vorstellungen, Gedanken, Befürchtungen und Gefühle sprach (MacLeod 1991).

Die Fähigkeit oder Unfähigkeit eines Arztes, mit seinen Patienten über Krankheit, Behandlung und Leben zu kommunizieren, macht nicht selten den Unterschied zwischen einem Leben in Verzweiflung und Angst und einem Leben mit Hoffnung und Zukunft aus. Viele Ärzte denken, wir haben kein Recht, den Patienten die Hoffnung, den letzten »Strohhalm« zu nehmen.

- Wie kann aber der Patient eine Einstellung zu seiner Krankheit, zu den therapeutischen Möglichkeiten und zu seiner Lebenssituation entwickeln, wenn er nicht die Möglichkeit bekommen hat zu erfassen, in welcher Lebenssituation er sich befindet?
- Würden Sie einen Arzt aufsuchen, von dem Sie wüssten, dass er nicht in der Lage ist, offen mit Ihnen über alles, was für Sie wichtig ist, zu reden?
- Hätten Sie Vertrauen zu Ihrem Arzt, wenn Sie wüssten, dass er lügt?

In den letzten Jahren hat eine Reihe von Untersuchungen gezeigt, dass fast alle Patienten mit fortgeschrittener Krankheit und infauster Prognose selbst wissen, wie es um sie steht. Es gibt mehrere Gründe, warum dies der Fall ist (Simpson et al. 1991; Buckman 1996; Fallowfield 1996):

- Patienten sind hellhörig.
  Sie beobachten die Krankheitsentwicklung und den Erfolg oder Misserfolg der Therapie. Sie achten auf ihre Umgebung, z. B. wie dem Arzt und den Angehörigen zumute ist. Eine bei ihnen zu beobachtende unerwartete oder andauernde Traurigkeit, eine unerwartete Zuwendung oder Abwendung sagt viel. Die dabei verwendete Körpersprache, der Ausdruck des Gesichts bedeutet mehr, als die meisten sich vorstellen können.
- Patienten haben Befürchtungen.
  Viele Menschen haben lange vor der sicheren Diagnose Befürchtungen, dass es um sie ungünstiger steht, als der Arzt es angedeutet hat. Dies hat nicht nur mit der Eigenschaft vieler Menschen zu tun, bei Problemen das Schlimmste zu befürchten, sondern auch mit der Lebenserfahrung.
- Der Patient erhielt Informationen.
  Viele Ärzte bemühen sich um Offenheit und haben dem Patienten die Diagnose, die Krankheitsentwicklung und deren Konsequenzen mitgeteilt. Vielleicht haben die Patienten auch Bruchstücke von Gesprächen zwischen Ärzten, Krankenschwestern oder anderen Personen mitbekommen, aus denen sie die entsprechenden Folgerungen ziehen. Nicht selten konnten Patienten einen Einblick in die Krankenakte oder einzelne Befunde nehmen.

Menschen haben Vorstellungen. Viele Menschen werden durch Alter oder Krankheit geschwächt und durch Schicksalsschläge getroffen. Viele sehen den Tod nicht länger als einen Feind an. Dies trifft besonders im Alter oder bei fortgeschrittener schwerer Krankheit zu.

Unabhängig von der Einschätzung des Patienten bezüglich seiner Erkrankung ergibt sich für den Arzt das Problem der Aufklärung. Diese Frage ist v. a. eine Frage der menschlichen Würde. »Die Würde des Menschen besteht in der Wahl«, schreibt Max Frisch.

Nur wer die vor ihm liegende Landschaft kennt oder eine Landkarte besitzt, weiß, welche Ziele erreichbar sind und welche Wege er einschlagen muss, um am Ziel anzukommen. Das Problem für einen Patienten mit unerwarteter lebensbedrohlicher Krankheit besteht darin, dass die Landschaft weitgehend unbekannt ist und nur der Arzt den Überblick und die Landkarte besitzt.

Die Patienten wissen mehr über die Krankheit und Prognose, als wir vermuten.

- Sollen wir sie allein lassen?
- Müssen wir nicht eine Brücke zwischen dem, was der Patient vermutet und befürchtet, und unserem eigenen Wissen schlagen, damit eine offene Kommunikation und Bearbeitung des Problems stattfinden kann?

Der Wunsch, den Patienten vor der Wahrheit schützen zu wollen, kann manchmal aus »guten« Motiven hervorgehen. Trotzdem wird der Arzt, der nicht in der Lage ist, dem Patienten zu sagen, dass er Krebs hat, auf Dauer Schaden und Hoffnungslosigkeit verursachen (Butow et al. 1995). Die Wahrheit kann eine schmerzvolle Belastung bedeuten; Betrug ist aber eine weit größere Belastung (Fallowfield 1997). Es widerspricht ärztlicher Ethik, wenn ein Arzt nicht zu dieser Offenheit beiträgt (Buckman 1996; Loewy 1995). Für den Patienten machen Offenheit und Verständnis einerseits und Heimlichkeit und Unverständnis andererseits den Unterschied zwischen Würde und Unwürde aus.

> Die Krise des Menschen ist immer durch fehlendes Verständnis verursacht. Was wir verstanden haben, können wir ertragen und ausführen.
> (Raymond Williams)

3.3 Warum sind Aufklärungsgespräche so schwierig?

Immer wieder berichten Patienten und Angehörige, welche Belastung es für sie war, als der Arzt sich mit ihnen über die Krankheit und deren Folgen unterhielt. Für andere kann es eine unerträgliche Belastung sein, dass der Arzt überhaupt keine Aufklärungsgespräche geführt hat. Es fehlt nicht an Literatur über die erlebte Belastung der Ärzte bei Aufklärungsgesprächen (Andrae 1994; Bennet 1987; Gorlin et al. 1983; Vachon 1987). Wir müssen darum Verständnis haben, wenn viele Kollegen diese Gespräche und Schwierigkeiten scheuen.

Warum sind diese Gespräche so schwierig?

- Wir schützen uns vor etwas, das für uns unerträglich ist.
- Es fehlt uns an Fachkenntnissen über die Reaktionen von Patienten.
- Es fällt uns schwer, eine Niederlage zuzugeben.

- Es fehlt uns an Ausbildung, Praxis und guten Vorbildern.
- Wir haben Erfahrung mit Aufklärungsgesprächen, die schwere Folgen hatten.
- Es ist nicht jedermanns Sache, sich mit gefühlsmäßigen Reaktionen auseinanderzusetzen.
- Wir möchten nicht sterben.

3.3.1 Wir schützen uns vor etwas, das für uns unerträglich ist

In der Geschichte finden wir wiederholt, wie folgenschwer es für einen Boten war, schlechte Nachrichten zum Hofe zu bringen. Der König duldete kein Versagen in seinem Reich. Anstatt nach der Ursache des Schadens zu fragen, wurde derjenige, der die Botschaft übergab, nicht selten umgebracht.

Aufklärung hat häufig zur Folge, dass der gesprächsführende Arzt vom Patienten oder seinen Angehörigen mit Aggressionen konfrontiert wird. Folgendes Beispiel soll das verdeutlichen:

Beispiel aus der Praxis

Es war meine Aufgabe als Oberarzt der Intensivabteilung, die Eltern eines zweijährigen Kindes darüber aufzuklären, dass ihr Kind hirntot sei. Obwohl die Eltern über den Verlauf und die ernste Lage des Kindes informiert waren, konnten sie diese Realität nicht akzeptieren. Nach einigen Minuten des Schweigens sagte die Mutter: »Sie wissen, dass wir nie aufgeben werden. Falls Sie die Therapie beenden und die Beatmung einstellen, werden wir den kompetentesten Rechtsanwalt in Norwegen nehmen und Sie bis zu Ihrem Lebensende verfolgen.«

Spätestens zu diesem Zeitpunkt wurde mir klar, dass ich einen schweren Beruf gewählt hatte. Es war hilfreich für mich, dass ich mich in die Lage der Eltern versetzen konnte.

Dabei »hörte« ich, was sie nicht ansprachen: »Sie versuchen uns zu erklären, dass unsere Tochter nicht mehr am Leben ist. Wir sind nicht imstande, das zu verstehen. Wir lieben unsere Tochter über alles auf der Welt. Unser Hauptanliegen in diesem Augenblick ist es, zu schreien. Bitte bleiben Sie bei uns, damit wir Sie anbrüllen können.«

Durch diese meine Vorstellung wurde es mir leichter zu bleiben. Nach etwa zehn Minuten, die mir unendlich lang vorkamen, sagte ich dann: »Sie können

bei ihrem Kind sitzen, so lange Sie es wollen. Bitte überlegen Sie dabei, was für Ihr Kind gut ist.« Am nächsten Tag wollten sie nicht mit mir reden, auch am übernächsten nicht. Dann kamen sie zu mir und sagten: »Jetzt können Sie die Beatmung beenden. Vielen Dank, dass wir Zeit bekommen haben.«

Dieses Erlebnis ist für Eltern eine unendliche Belastung. Die Situation bleibt mir v. a. in Erinnerung, weil sie mir vor Augen geführt hat, dass Wut, Verzweiflung und Aggressivität natürliche Reaktionen sind. Diese Reaktionen sind für den Betroffenen therapeutisch, d. h. sie haben die wichtige Funktion, das Unerträgliche und Unverständliche erträglicher und verständlicher erscheinen zu lassen. Unsere Aufgabe ist es, diese Aggressivität und Verzweiflung zuzulassen und zu ertragen. Wenn wir uns dagegen wehren, werden Patienten und Angehörige noch mehr leiden.

3.3.2 Es fehlt uns an Fachkenntnissen über die Reaktionen von Patienten

Vor fast 40 Jahren hat Elisabeth Kübler-Ross als erste (1970) anhand ihrer klinischen Erfahrungen mit Sterbenden Phasen beschrieben, die von Sterbenden und Angehörigen im Laufe der letzten Lebenszeit durchlaufen werden.

Die von Kübler-Ross beschriebenen Phasen sind:

- **Verneinung und Isolation:** das Nicht-wahrhaben-Wollen der Gegebenheit des kommenden Todes.
- **Zorn, Wut und Auflehnung gegen das Schicksal:** Die Patienten zeigen dabei nicht selten ein aggressives Verhalten gegenüber dem Arzt, dem Helfer und den Angehörigen.
- **Verhandeln mit dem Schicksal:** Versuche des Patienten, mit Hilfe von immer neuen Spezialisten oder paramedizinischen Helfern dem drohenden Schicksal zu entrinnen oder dieses hinauszuzögern.
- **Depression:** Traurigkeit, Isolation und Vereinsamung – dabei ein großes Bedürfnis nach Kontakt und Nähe eines verständnisvollen Menschen.
- **Anpassung und Annahme des nahenden Todes:** Bejahung der deutlicher werdenden Realität.

Kübler-Ross beschreibt, wie Patienten schrittweise diese Stadien durchlaufen. Heute ist man der Ansicht, dass diese Stadien einen wichtigen Beitrag zum

besseren Verständnis schwerkranker Patienten leisten, legt sie aber nicht in einer Reihenfolge fest. So können mehrere Phasen gleichzeitig auftreten oder bereits durchlaufene Phasen erneut für den Patienten relevant werden. Die Intensität der Reaktionen in den einzelnen Phasen hängt sehr von der Persönlichkeit und der Lebenserfahrung ab. Für den einen stehen Wut und Aggression im Vordergrund, für den anderen Verzweiflung und Isolation. Der kritische Leser sieht, wie vergleichbar Trauerreaktionen mit den beschriebenen Phasen sind. Dieser Vergleich ist fachlich begründbar, da viele Verhaltensmuster als Trauerreaktionen verstanden werden können.

Die fünf Stadien von Kübler-Ross sind hilfreich, aber nicht ausreichend, um die Lage der Sterbenden zu verstehen. Menschen haben sehr individuelle Reaktionsmuster, wenn sie sich in einer lebensbedrohlichen Krise befinden. Angst und Panik sind so normale Reaktionen, dass wir uns fragen müssen, ob ein Patient die Botschaft verstanden hat, wenn er keine Angstreaktionen zeigt.

Paul Sporken (1982) hat zu dem Phasenmodell Stellung bezogen. Er ist der Meinung, dass dieses Modell nicht erst zum Tragen kommt, wenn der Patient bereits seine Diagnose kennt. Schon lange bevor jemand mit ihm über die »Wahrheit« spricht, bemerkt er am veränderten Verhalten des Körpers und der Umgebung den Ernst der Lage. Sporken beschreibt vier Etappen *vor* der Phaseneinteilung nach Kübler-Ross:

- **Unwissenheit** des Kranken, während andere, der Arzt, Helfer oder Angehörige etwas mehr wissen.
- **Unsicherheit:** Phase des einerseits/andererseits – zunehmende Unruhe.
- **Unbewusstes Leugnen:** unbewusster Widerstand gegen die immer deutlicher werdenden Zeichen, dass die Krankheit keinen guten Verlauf nehmen wird.
- **Entdeckung und Besprechung** der schon vermuteten Wahrheit über die unheilbare Krankheit.

Bei Kindern können wir den Wechsel der Phasen und die Vielfalt der Reaktionen besonders gut beobachten. Kinder können in der einen Sekunde traurig und verstimmt sein, in der nächsten offen und spielend, kurz darauf hören wir lautes Lachen und sind später wieder mit Weinen konfrontiert.

Dieser Wechsel zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, Mut und Verzweiflung, Schuld und Offenheit scheint geradezu identisch mit der Wirklichkeit des Kranken. Der Patient hat die Zuversicht, dass es noch gut gehen kann, und weiß gleichzeitig, dass dies nicht der Realität entspricht. Er empfin-

det es als ungerecht, auf diese Weise bestraft zu werden, und hat gleichzeitig Schuldgefühle. Menschen zu hinterlassen, die seiner Hilfe bedürftig sind, wird jeder als eine Belastung empfinden.

Humor ist sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen eine Hilfe bei der Bewältigung einer schweren Krankheit. Der Begriff »Galgenhumor« entspricht der Wirklichkeit. Das Lachen bedeutet jetzt mehr als im »normalen« Leben; es kann eine unerträgliche Situation oder einen schlechten Tag erträglicher gestalten. Es wäre ein Fehler, diese auch in noch so aussichtslosen Situationen fröhlichen Seiten bei den Patienten und bei uns selbst zu übersehen (Jaffee 1996). Gerade in aussichtslosen Situationen ist es möglich und therapeutisch, mit Feingefühl Fröhlichkeit zu aktivieren und gemeinsam zu lachen.

Solange noch offene, nach außen getragene Reaktionen des Kranken zu beobachten sind, ist dies eher als ein positives Zeichen in Bezug auf die innere Verarbeitung aufzufassen. Dies trifft auch zu für die häufig missverstandene Aggressivität. Aggressives Verhalten ist als eine normale Reaktion anzusehen, die leichter zu ertragen ist, wenn sie zugelassen wird. Problematischer ist es, wenn der Patient sich über längere Zeit in sich zurückzieht und sich isoliert, wenn Gefühle und Reaktionen, Angst oder Verzweiflung nicht mehr zu beobachten sind.

Alle diese Reaktionen können bei dem Kranken *und* bei den Angehörigen beobachtet werden. Verhaltensweisen der Angehörigen, des Arztes oder des Krankenpflegepersonals können die Reaktionen der Kranken verstärken oder abschwächen. Es ergibt sich folgendes Fazit:

Es wäre ein Missverständnis anzunehmen, dass die Phasen genau beschreiben, wie es dem Patienten in Wirklichkeit geht. Die Landkarte ist eine Stütze, um einen Überblick über die Landschaft zu bekommen, sie ist nicht die Landschaft selbst.

3.3.3 Es fällt uns schwer, eine Niederlage zuzugeben

Wir haben in unserem Medizinstudium gelernt, dass wir als gute Ärzte die Lösungen für medizinische Probleme bereitstellen müssen. Dass es manchmal eine schwere oder unmögliche Aufgabe ist, Lösungen zu finden, wurde uns im Studium kaum gesagt.

Es kommt leider selten vor, dass der Arzt mit Patienten offen über seine diagnostischen und therapeutischen Begrenzungen spricht (Maguire 1988).

Dabei ist es nicht schwer zu verstehen, warum dies dem Arzt so schwer fällt. Niederlagen und die Angst, das Gesicht zu verlieren, sind für uns alle ein großes Problem. Von besonderer Bedeutung ist die Betrachtung, warum der Arzt es als eine Niederlage auffasst, wenn eine Therapie nicht den erwarteten Erfolg hat, wenn unerwartete Komplikationen auftreten oder wenn der Patient, den er betreut hat, stirbt.

Der Arzt will sich gewissenhaft um seinen Patienten kümmern. Er möchte, dass der Patient zufrieden ist, weil Ärzte auch Menschen sind, die gerne erfahren, dass sie gebraucht werden und dass sie etwas Gutes getan haben. Es ist nicht nur eine Frage der richtigen fachlichen Einstellung des Arztes. Der Arzt steckt seine persönliche Überzeugung und seine Kraft in die von ihm vorgeschlagene Therapie. Und dieser persönliche Einsatz des Arztes ist eine wichtige Voraussetzung, er stellt einen unentbehrlichen Teil eines möglichen Therapieerfolges dar. Deswegen erleben die Ärzte es nicht selten als eine sehr persönliche Niederlage, wenn die Behandlung eines Patienten nicht ausgeht, wie erwartet und gehofft (▶ Kap. 9).

Das Problem verschärft sich dadurch, dass die Patienten ihren Arzt mehr als zuvor brauchen, wenn die Therapieerfolge ausbleiben und die Krankheit unaufhaltsam fortschreitet.

»Die Operation ist nicht so ausgegangen, wie wir gehofft haben. Damit kann ich leben«, sagte der wegen eines Pankreastumors frisch operierte, schwerkranke Patient. »Ich verstehe aber nicht, warum er nicht mehr zu mir hereinkommt. Ich bin überhaupt nicht böse auf ihn, ganz im Gegenteil, es tut mir so unheimlich Leid für ihn. Er hat sich solche Hoffnungen gemacht, dass es mit der Operation gut gehen wird. Mein Problem ist jetzt, dass er nicht mehr zu mir kommt. Ich schätze ihn ungeheuer, sowohl als Arzt wie als Mensch. Jetzt brauche ich ihn mehr denn je.«

3.3.4 Es fehlt uns an Ausbildung, Erfahrung und guten Vorbildern

Diese hier aufgezeigten Hintergründe sind kaum ein Thema in der theoretischen Ausbildung von Medizinstudenten. Sie spielen auch in der praktischen Ausbildung kaum eine Rolle. Klinische Psychologie nimmt heute einen Anteil von 4,5% in der vorklinischen Ausbildung der Medizinstudenten ein (Verres 1997). Im klinischen Curriculum fehlt das Fach vollständig, mit Ausnahme von Unterricht in Psychiatrie oder psychosomatischer Medizin.

Kommunikationsgrundlagen und -fähigkeiten werden fast nie im Unterricht der anderen klinischen Fächer erwähnt (Calman 1996).

Das Hauptproblem liegt im fehlenden bzw. falschen Konzept. In den letzten 50 Jahren hat die Medizin ihr naturwissenschaftliches Wissen vervielfältigen können, ohne dass die humanistischen Perspektiven der Medizin ihren notwendigen Platz in Forschung und Lehre haben behalten können. Das Ergebnis ist besonders problematisch für diejenigen Patienten, die dann mit den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen der Mediziner nicht geheilt werden können.

Die Studenten sind beim Eintritt in das Studium offen, neugierig und menschlich. In den ersten Studienjahren erfahren sie dann in der Tat, dass der Mensch ein totes Objekt sein kann (an der Leiche) und dass Kenntnisse der Organe und der lebenden Zelle im Zentrum des Studiums stehen.

Der Umgang mit den Patienten ist aber v. a. eine menschliche Herausforderung. Im Medizinstudium lernen wir das Benehmen und das Verhalten gegenüber den Patienten an Lernmodellen:

- Wie geht der Vorgesetzte, wie geht der Professor mit den Patienten um?
- Wie werden die Patienten aufgeklärt?
- Werden Gefühle, Ängste, Fragen und Schweigen zugelassen, wenn sie für den Patienten natürliche und notwendige Reaktionen sind?
- Ist es die Regel oder die Ausnahme, dass der Arzt sich bei der Visite zu dem Patienten hinsetzt?
- Ist es die Regel oder die Ausnahme, dass der Arzt Pausen macht, die lang genug sind, um dem Patienten die Möglichkeit zu geben, bei Wichtigem nachzufragen?

Den Vorbildern, das heißt den den Studenten vorgesetzten Ärzten, fehlt es wieder an Vorbildern. Über viele Jahre hinweg hat sich eine Hierarchie entwickelt, in der der Arzt einen großen Abstand zu seinen Patienten hält.

3.3.5 Wir haben Erfahrung mit Aufklärungsgesprächen, die schwere Folgen hatten

Fallbeispiel aus der Praxis

Ein 46 Jahre alter Patient mit Lungenkrebs lag im Sterben. Seit dem Zeitpunkt seiner Diagnose war er aggressiv und leugnete die Situation. In Gesprächen mit mir und seinen früheren Ärzten hatte er keine Bereitschaft gezeigt, über

seine Diagnose, Situation oder Zukunft sprechen zu wollen. Er kämpfte unerbittlich um sein Leben und er wartete jeden Tag, dass ein Wunder geschehen solle. Wiederholt verlangte er von uns, jede Therapie zu versuchen, auch unter der Möglichkeit eines geringen Erfolges. Als wir ihm erklärten, dass wir keine kurativen Möglichkeiten mehr sähen und dass weitere Chemotherapie, Bestrahlung oder Chirurgie sein Leiden nur vergrößern werde, wendete er sich den paramedizinischen Heilverfahren zu. Er suchte einen Heiltherapeuten nach dem anderen auf.

Seine Frau und seine Kinder im Alter von 18 und 20 Jahren kümmerten sich vorbildlich um ihn. Sie sahen, wie die Krankheit fortschritt. Sie sahen, dass der Tod näher kam. Als der Patient nicht mehr die Kraft hatte, sein Bett zu verlassen, baten sie mich, ihnen zu helfen, damit sie von ihrem Ehemann und Vater Abschied nehmen könnten.

Wiederholt versuchte ich, vorsichtig mit dem Patienten über seine Aussichten zu sprechen. Dieser versicherte mir, dass es keinen Grund zur Besorgnis gäbe.

»Es geht mir momentan nicht ganz gut. Ich habe aber Zuversicht, dass die Ersatzmedikamente, die mein Heilpraktiker verschreibt, den ‚Schatten' auf der Lunge, meine ‚Lungenentzündung' unter Kontrolle bekommen werden.«

Die Verzweiflung seiner Angehörigen gab mir die Kraft, einen letzten Versuch zu machen. In einem Gespräch, in dem Ehefrau und Kinder anwesend waren, zeigte ich ihm die letzten Röntgenaufnahmen der Lunge und sprach die massive Metastasierung an.

Das Ergebnis war fatal. Er wendete sich gegen die Wand und befahl allen, den Raum zu verlassen. Zehn Tage später starb er. In den verbliebenen Tagen lehnte er es ab, mit mir zu sprechen. Der Versuch, zu einer Offenheit beizutragen, führte eher zu einer Verschlechterung der Beziehung zu seiner Frau und seinen Kindern.

Ich habe mir lange Zeit schwere Vorwürfe wegen dieses Gesprächs gemacht (Husebø 1997). Viele Kollegen haben leider ähnliche Erfahrungen. Sie sagen nicht selten:

»Wissen Sie, bei mir (oder bei einem Kollegen) hat ein Patient Suizid begangen, nachdem er erfuhr, dass er Krebs hatte. Sie können wohl nicht von mir erwarten, dass ich in Zukunft einem Patienten erzähle, dass er Krebs hat, ohne dass er ausdrücklich danach fragt!«

Diese Kommentare sind verständlich. Wir haben aber gelernt, dass unsere Diagnostik und Behandlung sich nicht nur auf Vermutungen und Gefühle berufen sollten. Wenn ein Informationsgespräch nicht gelungen ist, wäre es ein Fehler, darum alle Informationsgespräche abzulehnen. Wir sollten uns fragen:

- Was ist schief gelaufen?
- Was kann auf welche Weise besser gemacht werden?
- Hätten wir aufgrund der Vorgeschichte des Patienten anders vorgehen sollen?
- Bin ich zu schnell vorgegangen?

Wie an anderer Stelle dargestellt (Bolund 1985; Breitbart u. Passik 1994), ist die Suizidrate in der Bevölkerung erschreckend hoch. Die Gefahr, dass ein Krebspatient sich *wegen eines Aufklärungsgesprächs* und der dabei vermittelten Diagnose selbst tötet, wird dagegen als äußerst gering eingestuft.

Dies gibt uns niemals ein Recht, brutale Aufklärungsgespräche zu führen. Unsere Fehler geben uns einmalige Gelegenheiten zu lernen, was und wie etwas besser gemacht werden kann. Welche Gedanken ich heute zu dem erwähnten, fehlgeratenen Gespräch habe, werde ich in ▶ Kap. 3.5 darstellen.

3.3.6 Es ist nicht jedermanns Sache, sich mit gefühlsmäßigen Reaktionen auseinanderzusetzen

Wir haben im Leben und im Beruf Erfahrungen gemacht. Zu diesen Erfahrungen gehört auch der Umgang mit den eigenen Gefühlen:

- Wie reagiere ich, wenn es mir schlecht geht?
- Wie waren die Reaktionen in meiner Familie?
- Wie reagiere ich, wenn es meinem Patienten schlecht geht?
- Wie reagiere ich, wenn ich bei einem aufklärenden Gespräch mit meinem Patienten seiner Reaktion entnehme, dass er den Boden unter den Füßen verliert?
- Wäre es für mich dann wichtig, nicht »mitgerissen« zu werden, weil ich Angst vor meinen eigenen Reaktionen habe?

Der Chirurg des in ▶ Kap. 3.8 erwähnten Patienten mit Pankreastumor hat es so ausgedrückt:

> Meine Patienten bedeuten viel für mich. An einigen Tagen muss ich bei fünf oder mehr Patienten Visite machen, die unheilbar sind und bald sterben werden. Ich könnte diese Aufgabe nicht überleben, wenn ich nicht vorher einen bleiernen Schutzmantel anzöge. Ich sage zu mir selbst, bevor ich das Krankenzimmer betrete: »Bleibe gefasst, zeige nicht, wie schwer es für dich selbst ist.«

Dieser Chirurg steht keinesfalls allein. Viele haben in solchen Situationen Angst oder wissen nicht, wie sie damit zurechtkommen können. Eine Strategie liegt dann darin, in dieser Situationen die Selbstkontrolle zu behalten, oder zu verhindern, überhaupt in solche Situationen zu geraten. Es wird andererseits heute vom Arzt v. a. Menschlichkeit erwartet. Diese Fähigkeit, sich in die Lage des Patienten zu versetzen, Mitgefühl und Gefühl zu zeigen, nennen wir Empathie. Wie wir unsere Empathie wiederentdecken können, wird in ► Kap. 9 (»Die Rolle des Arztes«) beschrieben.

3.3.7 Wir möchten nicht sterben

Ärzte fürchten sich vor dem Sterben und dem Tod wie jeder andere Mensch (Feigenberg 1977).

Der Arzt wird der Herausforderung, sterbende Patienten zu betreuen, nur in dem Maß gewachsen sein, wie er die eigene Sterblichkeit vor Augen hat. Das Verhältnis nämlich zur eigenen Endlichkeit, zum eigenen Sterben, zum eigenen Tod bestimmt auch das Verhalten des Arztes gegenüber dem Sterben des von ihm betreuten Patienten. Selbst nach dem Versterben des Patienten muss der Arzt sich mit dessen Tod auseinandersetzen. Er muss mit den Angehörigen sprechen, die sich selbst oder andere für den Tod verantwortlich machen könnten und die von Trauer und Schuldgefühlen belastet werden. Und er muss mit eigenen Vorwürfen und Gefühlen zurechtkommen.

Nur wer zur eigenen Not und zur eigenen Angst steht, kann die Angst und die Not des anderen verstehen (Andrae 1994).

Diese Kommentare sind verständlich. Wir haben aber gelernt, dass unsere Diagnostik und Behandlung sich nicht nur auf Vermutungen und Gefühle berufen sollten. Wenn ein Informationsgespräch nicht gelungen ist, wäre es ein Fehler, darum alle Informationsgespräche abzulehnen. Wir sollten uns fragen:

- Was ist schief gelaufen?
- Was kann auf welche Weise besser gemacht werden?
- Hätten wir aufgrund der Vorgeschichte des Patienten anders vorgehen sollen?
- Bin ich zu schnell vorgegangen?

Wie an anderer Stelle dargestellt (Bolund 1985; Breitbart u. Passik 1994), ist die Suizidrate in der Bevölkerung erschreckend hoch. Die Gefahr, dass ein Krebspatient sich *wegen eines Aufklärungsgesprächs* und der dabei vermittelten Diagnose selbst tötet, wird dagegen als äußerst gering eingestuft.

Dies gibt uns niemals ein Recht, brutale Aufklärungsgespräche zu führen. Unsere Fehler geben uns einmalige Gelegenheiten zu lernen, was und wie etwas besser gemacht werden kann. Welche Gedanken ich heute zu dem erwähnten, fehlgeratenen Gespräch habe, werde ich in ▶ Kap. 3.5 darstellen.

3.3.6 Es ist nicht jedermanns Sache, sich mit gefühlsmäßigen Reaktionen auseinanderzusetzen

Wir haben im Leben und im Beruf Erfahrungen gemacht. Zu diesen Erfahrungen gehört auch der Umgang mit den eigenen Gefühlen:

- Wie reagiere ich, wenn es mir schlecht geht?
- Wie waren die Reaktionen in meiner Familie?
- Wie reagiere ich, wenn es meinem Patienten schlecht geht?
- Wie reagiere ich, wenn ich bei einem aufklärenden Gespräch mit meinem Patienten seiner Reaktion entnehme, dass er den Boden unter den Füßen verliert?
- Wäre es für mich dann wichtig, nicht »mitgerissen« zu werden, weil ich Angst vor meinen eigenen Reaktionen habe?

Der Chirurg des in ▶ Kap. 3.8 erwähnten Patienten mit Pankreastumor hat es so ausgedrückt:

3.4.3 Inhalt

Die Botschaft

- Welche Informationen habe ich als Arzt, die der Patient braucht, um für seine Erkrankung und sein Leben die richtigen Entscheidungen zu treffen?
- Wie kann ich ihn unterstützen, damit er seine eigenen Möglichkeiten in der kommenden Zeit erkennt?

Diese Informationen können Erkenntnisse über die Diagnose, die Behandlung oder die Prognose sein. Dabei ist es wichtig zu wissen, welche Kenntnisse der Patient bereits hat und wie eine Brücke gebaut werden kann zu dem notwendigen Verständnis für die Erkrankung und den daraus resultierenden Entscheidungen.

Wir Ärzte lernen, uns in unserer Fachsprache und unseren Fachausdrücken auszudrücken und uns dahinter zu verstecken (Maguire 1989). Im Gespräch mit dem Patienten muss das zu vermittelnde Wissen in einer für den Patienten verständlichen Sprache ausgedrückt werden.

Diagnose und Therapie sind *verständlich* zu vermitteln, v. a. für den betroffenen Patienten. Eine Diagnose kann mehr schaden als nutzen, wenn der Arzt nicht hinterfragt, was der Patient sich bei dieser Diagnose vorstellt. Wenn der Arzt zu dem Patienten sagt: »Sie haben Krebs«, kann der Patient *ohne* weitere Erklärungen durch den Arzt keine folgerichtigen Konsequenzen für die Therapie und sein Leben ziehen. Er würde wahrscheinlich die Diagnose »Krebs« mit »unheilbar« oder »Tod« verbinden. Eine solche Aufklärung wäre eine Katastrophe.

Zur Botschaft gehört, dass der Arzt dem Patienten ermöglicht, die Konsequenzen seiner Krankheit und der vorliegenden Therapiemöglichkeiten zu erfassen (▶ Kap. 2: »Ethik«).

Die Reife

- Wie reif ist der Patient, die Wahrheit zu erfassen?
- Wie reif bin ich als Arzt, diese Botschaft zu vermitteln?

Die Antworten auf diese Fragen entscheiden oft über den bevorstehenden Kommunikationsprozess.

Die Reife des Patienten ist abhängig von seiner Biographie, von den von ihm gemachten Lebenserfahrungen, beispielsweise wie er mit Krankheiten und Krisen vorher zurechtgekommen ist. Der Arzt muss diese Biographie

kennen, ein Bereich, der in der heutigen Praxis stark vernachlässigt wird. Die besten Kenntnisse darüber, und damit gute Voraussetzungen für die Information, hat oft der Hausarzt des Patienten.

Eine zentrale Bedeutung für das Ausmaß der Aufklärung hat auch die Reaktion des Patienten auf die aktuelle Erkrankung.

- Hat er die frühere Information verstanden?
- In welcher Gefühlslage befindet er sich?
- Überwiegen Trauer und Wut oder hat er sich zunehmend mit seinem Lebensschicksal versöhnt?
- Wie weit soll das heutige Gespräch gehen?
- Sollte mehr Gewicht auf Zeit und Behutsamkeit gelegt werden?
- Schützt er sich oder Angehörige vor der Wahrheit?

Das Ziel, »richtig« zu informieren, ist häufig unerreichbar. Information ist mehr oder weniger »richtig« oder mehr oder weniger »falsch«. Information wird häufig mit technischen Fachausdrücken überlastet und bleibt optimistisch, selbst wenn sich die Prognose für den Patienten verschlechtert. Durch kühle Distanz des Arztes zu den aktuellen Problemen können die Patienten mit ihren Ängsten und der zunehmenden Gewissheit des nahenden Todes allein gelassen werden. In ▶ Kap. 9: »Die Rolle des Arztes« wird genauer erläutert, wie diesen Ärzten geholfen werden kann.

Der Prozess

- Wieviel Zeit brauchen unsere Patienten, um die von uns gegebene Information zu verstehen?

Wir brauchen alle Zeit, um uns an eine neue Lebenssituation zu gewöhnen. Sich Zeit zu lassen und Wiederholungsmöglichkeiten einzuplanen, ist deswegen unerlässlich. Was heute nicht von dem Patienten verstanden werden kann, weil die innere Bereitschaft dazu fehlt, kann morgen oder übermorgen möglich sein. Es wird immer eine Diskrepanz vorliegen zwischen dem, was gesagt wird, und dem, was der Patient versteht. Durch den Informationsprozess kann dieser Abstand verringert werden.

Der Arzt sollte nie wichtige Informationen vermitteln, ohne am Ende des Gesprächs ein neues Gespräch für die nächsten Tage zu vereinbaren und den Patienten dabei aufzufordern, sich Gedanken darüber zu machen, welche Fragen er dann erläutert haben möchte und wer anwesend sein soll.

Verbale/nonverbale Kommunikation

- Was ersieht der Patient aus unserem Verhalten?
- Welche Bedeutung hat unser Körperausdruck?
- Welche Aussage liegt in dem, was nicht gesagt wird?

Jeder hat erfahren, welche Auswirkungen es auf uns hat, wenn wir einer Verschlossenheit oder einer Unhöflichkeit begegnen. Unfreundlichkeit kann eine gute Stimmung stören oder einen eigentlich guten Tag in einen schlechten verwandeln. Umgekehrt kann eine unerwartete Freundlichkeit oder der Ausdruck von Vertrauen bei uns neue Hoffnung und Kraft freisetzen.

Während wir uns mit anderen unterhalten, werden unsere Worte durch das, was nicht gesagt wird, ergänzt. Die Körpersprache gibt zusätzliche Informationen, die für unser Verständnis wichtig sein können. Von den Patienten wissen wir, dass sie sehr genau beobachten, wie der Arzt ihnen begegnet, wie er grüßt, ob er Freundlichkeit und Offenheit ausstrahlt, ob das, was er sagt, positiv verstärkt oder ob es im Gegensatz zu seinem Benehmen steht. Viele Patienten haben schnell ein Gespür dafür, wenn der Arzt etwas verbirgt oder wenn es ihm schwerfällt, etwas auszusprechen. Sie machen Beobachtungen, ob der Optimismus oder der Pessimismus, der zum Ausdruck kommt, vom sonstigen Verhalten abgeschwächt oder verstärkt wird.

Untersuchungen zeigen auch, dass der Patient sich viel besser an die gegebene Informationen erinnern kann, wenn der Arzt ihm zusätzlich zu den verbalen Erklärungen auch z. B. Skizzen, Bilder oder Zeichnungen zeigt (Maguire 1988; Buckman 1993, 1994).

Obwohl Musik nicht direkt mit der Vermittlung schlechter Nachrichten verglichen werden kann, gibt es viele interessante gemeinsame Perspektiven. Viele Musiker haben zum Ausdruck gebracht, dass der Unterschied zwischen guter und schlechter Musik in den Pausen liege, in den Intervallen und in der Betonung. Musik ist mehr als alles andere Kommunikation. Sie gibt uns die Möglichkeit, zu denken und zum Ausdruck zu bringen, was nicht gesagt werden kann. Oder wie Novalis es zum Ausdruck brachte: »Jede Krankheit ist ein musikalisches Problem – die Heilung eine musikalische Auflösung. Je kürzer und dennoch vollständiger die Auflösung – desto größer das musikalische Talent des Arztes.«

Nicht nur Ärzte kommunizieren nonverbal. Die Mimik, die Gesten, die Atmung, der Blick des Patienten sagen oft deutlicher als seine Worte, wie ihm zumute ist.

3.4.4 Der Rahmen

- Wo fühlen Sie sich wohl?

Jeder von uns kennt den Rahmen, der jeweils zu uns passt und der unser Selbstwertgefühl fördert. Unser ausgewählter Rahmen vermittelt Geborgenheit und Vertrautheit. Dorthin ziehen wir uns zurück, um uns zu erholen und um neue Kräfte zu sammeln. Eine der Voraussetzungen dafür ist, dass es uns in dieser Atmosphäre gestattet ist, unsere Schwäche zu zeigen. Keiner kann über längere Zeit ohne diesen vertrauten Rahmen körperliches und seelisches Gleichgewicht aufrechterhalten.

Die Patienten befinden sich meist nicht in einem Rahmen, der ihnen Geborgenheit vermittelt. Sie sind durch die Ungewissheit und die Erkrankung verunsichert. Zusätzlich kann die Atmosphäre im Krankenzimmer eher erschreckend sein. Sie fördert, wenn nicht besondere Rücksicht gezeigt wird, eher Angst und Unsicherheit. Diese Rücksicht sollte in unserem täglichen Verhalten einen festen Platz einnehmen. Sie ist besonders wichtig, wenn es dem Patienten schlecht geht, wenn z. B. zusätzlich zu der Krankheit psychische und seelische Belastungen entstehen.

Viele der Patienten berichten mit Entsetzen, wo und wie sie die Diagnose oder eine für sie belastende Nachricht erhalten haben. Per Brief oder Telefon sollten solche Nachrichten *nie* vermittelt werden, es sei denn, in ganz ungewöhnlichen Ausnahmefällen.

Viele haben gute Erfahrungen mit einem dafür geeigneten Botschafter. Je nach Möglichkeiten kann ein Verwandter, ein Nachbar, ein Freund, der Hausarzt, ein Seelsorger oder ein Polizist die »schlechte Nachricht« vermitteln. Besonders wichtig kann der Einsatz eines solchen »Botschafters« bei einem unerwarteten, plötzlichen Todesfall sein.

Der Raum

Wo ist es für Sie gemütlich:

- Zu Hause?
- In der Natur?
- In Ihrem Büro?
- Wo möchten Sie etwas Wichtiges über Ihre Zukunft erfahren?

Es muss nicht unbedingt ein Nachteil sein, dass das Gespräch dort stattfindet, wo der Patient sich gerade befindet. Die Voraussetzung ist aber, Vorsorge zu treffen, damit die Gesprächspartner während des Gesprächs ungestört bleiben. Und es ist erforderlich, dass alle sich bequem in gleicher Augenhöhe gegenübersitzen.

Falls der Patient bettlägerig ist, ist es noch wichtiger, dass die anderen Beteiligten, insbesondere der Arzt, sich hinsetzen. Es ist nicht möglich, ein offenes Gespräch zu führen, wenn derjenige, der von vornherein schwach ist, im Bett liegt, und derjenige, der von vornherein stark ist, an der Bettkante steht.

Die Krankenhäuser sind leider oft gebaut worden, ohne an Gesprächszimmer zu denken. In Zukunft müssen wir erwarten können, dass jede Station mit einem solchen Zimmer ausgestattet ist. Viele haben aus der Not eine Tugend gemacht und ein kleines ungenutztes Areal gefunden und hergerichtet. Viel ist keinesfalls notwendig. Ein Sofa, ein paar Sessel, eine Lampe, Blumen und Bilder, und schon ist viel gewonnen.

Die Zeit

»Wenn wir bloß mehr Zeit hätten!« Wie oft wird dies gedacht oder geäußert. Und es scheint tatsächlich schlechter zu werden mit der uns zur Verfügung stehenden Zeit. Es gibt eine Reihe von Untersuchungen, die zeigen, dass die Ärzte weniger Zeit mit den Patienten verbringen als bisher. Der Effektivitätsdruck in den Krankenhäusern und in den Praxen ist groß. Es wird erwartet, dass wir Patienten wie am Fließband behandeln, um Kosten zu senken. Die Klagen von Patienten und Angehörigen, die sich auf mangelhafte Information und Zeit der Ärzte beziehen, haben deutlich zugenommen; eine Entwicklung, die sich in der Zukunft noch verstärken wird.

Auf der einen Seite scheint weniger Zeit vorhanden zu sein. Auf der anderen Seite besteht die Forderung, dass wir uns Zeit nehmen müssen, weil die Patienten ihr »informiertes Einverständnis« geben müssen und Hilfe bei der Bearbeitung von Problemen brauchen.

- Ist wirklich weniger Zeit vorhanden?
- Verbringen wir nicht viel Zeit mit sinnlosen Beschäftigungen?
- Gibt es nicht *immer* die Möglichkeit, die Prioritäten anders zu setzen?

Wir können viel erreichen, wenn wir dem Patienten von Anfang an ein Signal geben, wie viel Zeit wir zur Verfügung haben. Man sollte sich auch auf die Tatsache besinnen, dass ein Gespräch zu führen mehr eine Sache der Tiefe

als der Länge ist. Mit zehn Minuten kann viel Gutes getan werden, falls diese zehn Minuten zugunsten des Patienten genutzt werden. Dreißig Minuten reichen unter den gleichen Voraussetzungen weit. In besonderen Situationen kann eine volle Stunde erforderlich sein. Länger ist selten notwendig; da lohnt es sich eher, eine Wiederholung oder Nachfolge zu planen.

Der Münchner Richter Ernst Wolf (1987) beschreibt seine über viele Jahre gewonnene Erfahrung mit dieser Frage wie folgt:

> Ist es, weil die Patienten öfters nicht in der Lage waren, die Sprache des Arztes zu verstehen? Ist es, weil diese Gespräche statistisch gesehen eine Dauer von 3,5 Minuten haben? Haben die Ärzte wirklich zu wenig Zeit, um ihre Patienten angemessen zu informieren? […] Ist es, weil die Ärzte unerschütterlich davon überzeugt sind, dass jedes denkbare ärztliche Vorgehen von der Definition her im Interesse der Patienten liegt? Sind es die Ängste der Patienten, die es für sie so schwierig machen, die Information zu verstehen?

Die Personen

- Wer soll dabei sein?
- Wer hat Bedeutung für den Kranken und wen möchte er dabei haben?
- Wer hat Bedeutung für den Arzt und sollte dabei sein?
- Dürfen wir die Angehörigen informieren, wenn der Patient nicht anwesend ist?

Der Patient ist unser Hauptauftraggeber. Er allein soll entscheiden, ob Angehörige bei Informationsgesprächen dabei sein sollen oder nicht (Fitch 1994). Untersuchungen zeigen, dass die Patienten keineswegs Entscheidungen der Angehörigen über die Art und Menge der Information akzeptieren können (Benson u. Britten 1996).

Wir sollten frühzeitig *gemeinsame* Gespräche mit den Angehörigen vorschlagen. Diese gemeinsamen Gespräche bewähren sich fast immer. Sie können Kommunikationsproblemen innerhalb der Familie vorbeugen und die Isolation und die Vereinsamung des Patienten reduzieren. Bei minderjährigen Kindern ist es selbstverständlich, dass die Eltern anwesend sind.

Wenn die Angehörigen ohne den Patienten informiert werden, entstehen besondere Belastungen. Die Praxis von »getrennter« Information unter dem Motto »Der Patient kann nicht vertragen, die Wahrheit zu hören, die

Angehörigen können es vertragen, und sie müssen es wissen, weil sie die Konsequenzen zu tragen haben…« kann tiefe Risse im Verhältnis zwischen dem Kranken und seinen Angehörigen bewirken. Sie verhindert die Möglichkeit vorbereitender Trauer. Dadurch können der Kranke und die Angehörigen der Möglichkeit beraubt werden, die Herausforderungen in der letzten Zeit gemeinsam anzugehen. Der so wertvolle offene Abschied kann verloren gehen.

Oft werden Angehörige den Patienten vor schlechten Nachrichten in Schutz nehmen wollen, wobei das eigentliche Problem ihre eigenen Reaktionen sind (Fallowfield 1997). Eine getrennte Information von Patient und Angehörigen sollte *niemals* stattfinden, es sei denn in besonderen Situationen, wie z. B. Bewusstlosigkeit oder Gesprächsunfähigkeit des Patienten.

Es kommt vor, dass die Patienten uns bitten, allein mit ihren Angehörigen zu sprechen und sie über die Erkrankung und die Zukunft aufzuklären. Dabei sollten wir die Gelegenheit nutzen, die Patienten zu fragen, welche Gründe sie haben, selbst nicht dabei zu sein. Wir sollten auch mit ihnen über die Bedeutung gemeinsamer Gespräche reden und unsere Hilfe anbieten, damit ein gemeinsames Gespräch über diese für sie schwierigen Fragen doch gelingen kann.

Im Krankenhaus hat es sich oft bewährt, Informationsgespräche zu zweit durchzuführen. Die zweite Person kann ein Arzt oder eine Krankenschwester oder ein Pfleger sein. Teils kann diese Person für Arzt und Patient im Gespräch oder danach eine Stütze sein. Er/sie kann auch eine wichtige Rolle übernehmen in den nächsten Stunden und Tagen, falls der Arzt nicht anwesend ist. Es fördert auch die Transparenz im Team und die Möglichkeit, mit dem Patienten offen zu kommunizieren.

3.4.5 Die Bereitschaft

Das Zuhören

Jedes Gespräch sollte ein Austausch von Information sein.

Dieser Informationsaustausch ist häufig schwierig, weil nicht alle gute Zuhörer sind. Nur durch aktives Zuhören können wir uns ein Bild von der Gedankenwelt des Patienten machen. Durch das Verstehen dieser Gedankenwelt können wir einschätzen, wie Informationen vom Patienten verarbeitet werden.

Aktives Zuhören heißt, sich Zeit zu nehmen und sich dem Gesprächspartner zu widmen. Während eines Gespräches ist es wichtig zu hinterfragen:

- Worüber sprechen der Patient (und der Arzt) nicht?

Bei der Antwort auf diese Frage sollten wir uns Gedanken machen über die Situation, in der sich der Patient und die Angehörigen befinden, über die bisherigen Informationen und über die Reife der Betroffenen, die Situation zu verstehen.

Die Fragen

»Mehr fragen und zuhören als erzählen« ist die Voraussetzung für einen guten Informationsaustausch. Wenn wir ein Gespräch über eine ernste Erkrankung so führen können, dass der Patient selbst die für ihn wichtigen Fragen stellt, ist vieles gewonnen.

Um das zu erreichen, brauchen wir Zeit und Geduld. Unter Zeitdruck ist ein Patient kaum in der Lage, die für ihn wichtigen Fragen zu stellen oder die Aussagen des Arztes zu verstehen.

Eine zentrale und gute Anfangsfrage ist fast immer: »Wiederholen Sie etwas von dem, was der Arzt zu Ihnen über die Krankheit gesagt hat.« Diese Frage ist dann auch nützlich, wenn wir selbst der Informant waren.

Damit gewinnen wir einen Eindruck, nicht so sehr darüber, was die Ärzte gesagt haben, sondern darüber, was der Patient in der Lage war zu verstehen. Wir bekommen Information über die Reife des Patienten.

Schwerkranke Patienten – was darf der Arzt sagen, und was sollte er nicht sagen?

- Was darf der Arzt sagen?
  - Welche Information haben Sie von den Ärzten über Ihre Erkrankung bekommen?
  - Was glauben Sie selbst, was die Ursache für ihre Beschwerden ist?
  - Haben Sie gedacht, es könnte Krebs sein?
  - Wer ist das Kind auf dem Bild?
  - Machen Sie sich Sorgen über die Zukunft?
  - Machen Ihre Angehörigen sich Sorgen?

- Sagen Sie etwas mehr darüber…
- Das habe ich nicht ganz verstanden, können Sie das genauer erklären?
- Möchten Sie, dass wir uns etwas genauer über diese Fragen unterhalten?
- Ist es für Sie passend, wenn ich zu diesem Thema einige Fragen stelle?
- Wie denken Sie selbst darüber?
- Ich kann diese Frage heute nicht sicher beantworten, aber ich verspreche Ihnen, bis zum nächsten Mal habe ich mich ausführlich informiert.
- Sehen Sie es immer so optimistisch oder gibt es auch Zeiten, in denen Sie andere Gedanken haben?
- Haben Sie noch Fragen an mich?
- Gibt es Fragen, über die Sie gerne in Anwesenheit Ihrer Angehörigen sprechen möchten?
- Wie kann ich Sie am besten unterstützen?
- Wie kann ich Ihre Familie am besten unterstützen?
- Es gibt unendlich viel, was wir für Sie und Ihre Familie noch tun können.

Was sollte der Arzt nicht sagen?

- Es besteht keine Hoffnung mehr. (Auch wenn die Heilung keine realistische Möglichkeit mehr ist)
- Jetzt kann ich nichts mehr für Sie tun.
- Es besteht kein Grund, sich Sorgen zu machen. (Wenn Grund besteht)
- Sie werden wieder gesund. (Wenn diese Aussicht nicht mehr besteht)
- Sie werden morgen sterben. (Auch wenn die Wahrscheinlichkeit da ist)
- Ich verspreche, dass Sie schmerzfrei sein werden.
- Sie müssen leider mit Ihren Schmerzen leben.
- Ich habe diese und nächste Woche leider keine Zeit.
- Wir haben noch die Möglichkeit einer Chemotherapie. (Wenn diese Möglichkeit sinnlos ist)
- Wir haben noch die Möglichkeit einer Operation. (Wenn diese Möglichkeit sinnlos ist)
- Warum hören Sie nicht auf mit Ihren blöden Vorwürfen?
- Reißen Sie sich zusammen!
- Was ich Ihnen erzählt habe, sollten Sie für sich behalten. Bitte sprechen Sie nicht mit dem Patienten darüber.

Die eigene Offenheit

- Welche Bereitschaft hat der Arzt, ein Gespräch zu führen?
- Welche Fragen stellt er, wenn er zu einem Patienten geht, um ein Aufklärungsgespräch zu führen?
- Ist er bereit, die schwierigen Probleme bezüglich Diagnose, Therapie, Prognose und Zukunft des Patienten anzusprechen?
- Falls er diese Offenheit hat, ist er bereit, die Fragen und Antworten, die Angst und die Verzweiflung des Patienten zuzulassen?

In Gesprächen mit Ärzten fällt es immer wieder auf, wie unterschiedlich die Kollegen sich zu der Frage der Aufklärung verhalten. Der eine will maximale Offenheit, während der andere meint, dass man einige Patienten vor der Wahrheit schützen muss. Eine fehlende Offenheit des Arztes in der letzten Lebensphase eines Patienten kann die Regelung wichtiger Dinge für Patienten wie Angehörige verhindern.

Diese Patienten sind dem Arzt fast vollständig ausgeliefert. Wenn der Arzt bestimmte Themen und Probleme ausklammert, werden Patienten selbst selten wagen, diese anzusprechen. Wenn der Arzt, aus verschiedenen Motiven, den Patienten durch Zurückhaltung von Informationen in Schutz nehmen will, unterbindet er gleichzeitig die Möglichkeit des Patienten, Befürchtungen und Ängste auszusprechen.

Schlimmstenfalls wird durch die fehlende Offenheit des Arztes die letzte Lebensphase des Patienten und die Zukunft der Angehörigen zu einer unkontrollierbaren und andauernden Katastrophe.

Das Problem ist häufig die innere Bereitschaft des Arztes.

- Hat der Arzt akzeptiert, dass er selbst sterben wird?
- Ist er bereit, darüber zu reden?
- Wird er, wenn die Zeit dafür reif ist, mit Offenheit seine Umgebung aufsuchen?

Die Beantwortung dieser Fragen entscheidet häufig darüber, mit welcher Offenheit der Arzt seinen Patienten begegnet. Eine gewöhnliche Aussage vieler Kollegen ist:

»Ich spreche mit meinen Patienten über alles, aber nur wenn sie selbst fragen.«

Diese Aussage ist ein Beispiel für fehlende Bereitschaft zur Kommunikation. Gute Kommunikation setzt eine *aktive* Bereitschaft des Arztes

voraus. Er muss selbst die Initiative ergreifen, um wichtige Problemgebiete anzusprechen. Die allermeisten Patienten sprechen nur das an, was der Arzt erlaubt.

Vor schwierigen Gesprächen sollten wir uns immer vor der Visite fragen:

- Was wäre jetzt für meinen Patienten wichtig zu verstehen?
- Wie helfe ich ihm dabei?

Die Wiederholung

Jeder, der einmal auf der Schule war, weiß, wie wichtig Wiederholungen für Lernprozesse sind. Untersuchungen über Arzt-Patient-Gespräche zeigen uns, dass der Patient nur einen Bruchteil der gegebenen Information behalten und verstehen kann, falls Wiederholungen nicht regelmäßig stattfinden.

Wir haben alle einen sehr persönlichen »Händedruck« und Kommunikationsstil. Mit einigen Menschen kommunizieren wir gut, mit anderen weniger gut. Einige Patienten mögen vielleicht »schwierig« oder »konfliktsuchend« sein. Im Grunde genommen sind Patienten, wie Ärzte, Menschen. Der Unterschied ist, dass *wir* von den Patienten bezahlt werden, damit sie Hilfe bekommen. Wenn die Hilfe versagt, haben wir unsere Aufgabe nicht erfüllt.

Untersuchungen der letzten Jahre zeigen, dass es doch möglich ist zu lernen, wie Kommunikation besser gelingen kann (Fallowfield 1995; McHugh et al. 1995). Zusätzlich liefert die Wiederholung die Möglichkeit einer »Reparatur«, wenn einiges im ersten Gespräch schwierig verlaufen ist. Beim Erstgespräch ist zu erwarten, dass Missverständnisse, Kurzschlüsse und Abwehrreaktionen auftreten. Entscheidend ist vielmehr, ob es gelingt, einen Kommunikationsprozess mit dem Patienten und den Angehörigen zu etablieren.

Der Wert des Wiederholungsgesprächs liegt zum einen in der Rekapitulation der bereits gegebenen Informationen. Noch wichtiger ist es aber, um die Gedanken, Fragen und Gefühle zu erfahren. Die meisten Patienten und Angehörigen entwickeln in diesem Prozess eine große Offenheit und sprechen dann selbst die für sie wichtigen Themen und Fragen an. Der Arzt wird auch erleben, wie von ihm gestellten Fragen (vgl. »Die Fragen«), die im ersten Gespräch kaum von dem Patienten beantwortet wurden, in späteren Gesprächen vertieft besprochen werden können.

Im modernen Gesundheitswesen ist es manchmal nicht einfach, der zentralen Bedeutung der Wiederholung gerecht zu werden. Im Krankenhaus findet ein ständiger Wechsel der zuständigen Ärzte statt. Der Patient kann

leider heute nicht damit rechnen, dass *ein* Arzt während des Aufenthalts oder der Aufenthalte für ihn zuständig ist. Gemessen an der Bedeutung der Kontinuität für schwerkranke Patienten muss Vorsorge getroffen werden, damit *ein* zuständiger Arzt sich um sie kümmert und dafür sorgt, dass der Kommunikationsprozess nicht unterbrochen wird.

Der Hausarzt besitzt die besten Voraussetzungen für den Kommunikationsprozess mit seinen Patienten. Er kennt meistens den Patienten und sein Umfeld. Er hat die Möglichkeit, mit dem Patienten zwischen den Krankenhausaufenthalten zu kommunizieren. Er kann auch den Patienten unterstützen in der wichtigen Zeit, wenn er zu Hause ist und viel Zeit zum Nachdenken hat. Die Voraussetzung dafür ist aber, dass die für den Patienten verantwortlichen Krankenhausärzte einen guten und laufenden Kommunikationsprozess mit dem Hausarzt in Gang halten. Jeder Krankenhausarzt ist gut beraten, sich beim Hausarzt über die Lebensumstände des Patienten und seiner Familie zu informieren.

3.4.6 Was wurde nicht angesprochen?

Grundsätzlich sollten wir uns immer Gedanken machen, wie unsere Gespräche verlaufen sind und was in der folgenden Zeit von Bedeutung sein kann.

Aus dem Krankenzimmer kommend oder nach dem Abschluss eines wichtigen Gespräches, ist es meist sinnvoll, sich einige Fragen zu stellen, damit der weitere Informationsprozess gut gelingen kann. Eine zentrale Frage dabei ist: »Was haben wir heute nicht angesprochen?« Das ist besonders wichtig für diejenigen Dinge, von denen wir annehmen, dass sie für das Leben und die Zukunft des Patienten und der Angehörigen von Bedeutung sein werden.

Die unausgesprochen Fragen und Themen geben zum einen Aufschluss darüber, was in den nächsten Gesprächen berücksichtigt werden sollte. Sie werden uns andererseits etwas über Abwehrmechanismen des Patienten (oder der Angehörigen oder von uns selbst) vermitteln. Es sollte nicht unser Ziel sein, die Abwehr des Patienten zu brechen. Wenn Mauern zur Selbstverteidigung errichtet werden, sind sie meistens zu dieser Zeit notwendig, damit der Patient mit den vermittelten schlechten Nachrichten in seiner gegenwärtigen Lage zurechtkommt.

Diese »Mauern« sind aber flexibel. Der Arzt braucht Geduld, und er sollte sich fragen:

- Wo sind die Mauern?
- Warum sind sie zur Zeit für den Patienten notwendig?
- Welchen Schaden haben sie auf Dauer für den Patienten und die Angehörigen?

Wenn der Arzt Geduld aufbringt, ist vieles gewonnen.

> Wenn einem Sterbenden erlaubt wird, stufenweise, in kleinen Schritten, mit seinem eigenen Tempo voranzuschreiten, und vorausgesetzt, er darf die dabei entstehenden Gefühle mit anderen teilen, und diese anderen überlasten ihn nicht mit ihren Ängsten, wird er sich weiterbewegen, bis er seine Situation erfassen kann, ohne von Panik oder Hoffnungslosigkeit überwältigt zu werden.
> (Parkes 1978)

3.5 Es ist schwer zu sterben

Wie wir besprochen haben, ist das Leugnen eine Reaktion, die bei Patienten und bei Trauer sehr häufig zu erwarten ist. Das Leugnen ist eine Abwehr, eine unbewusste Reaktion, die den Menschen vor einer existenzbedrohenden Belastung schützt. Wenn sie nach Information über eine schwere Erkrankung oder einen Todesfall auftritt, ist sie ein Zeichen, dass die Wahrheit für den Patienten zu schmerzvoll ist.

- Gibt es Situationen, in denen es im Interesse des Patienten liegen kann, dass diese Abwehr gebrochen wird?

Anhand des Beispiels in ▶ Kap. 3.3.1 wurde dargestellt, wie ein Aufklärungsgespräch zu einer Verstärkung der Probleme des Patienten führte.

Für mich war dieses Erlebnis ein erschütterndes persönliches Beispiel, wie folgenschwer es sein kann, wenn der Arzt eine »Wahrheit loswerden will«, die der Patient leugnet (Husebø 1997). Ich dachte, dass ich als Arzt besser weiß als der Patient, was für ihn gut ist. Mit diesem meinem »Mehr-Verständnis« versuchte ich, ihm zur Einsicht zu verhelfen (s. auch Kierkegaards Kommentar zum »Mehr-Verständnis«, ▶ Kap. 2.1.2). Ich habe nicht nur die Autonomie

und Integrität des Patienten gekränkt. Meine Kommunikation mit Angehörigen und dem Patienten war ein Versagen.

Der Patient versuchte, mir zu sagen, dass er nicht in der Lage ist, mit seinem bevorstehenden Tod zurechtzukommen. Im Leugnen seiner Krankheit fand er seine individuelle Strategie, Gesicht und Würde zu wahren.

Auf das Leugnen eines Patienten einzuwirken, kann unter bestimmten Voraussetzungen richtig sein (Faulkner et al. 1994). Kritisch gegenüber stehe ich aber meinem eigenen Verhalten, seine an mich gerichtete Botschaft übersehen zu haben:

- Ich bin nicht in der Lage zu akzeptieren, dass ich sterben muss.
- Ihr braucht mich nicht wiederholt mit meinem Tod zu konfrontieren, ich habe es bereits verstanden.
- Es ist schwer zu sterben.
- Wofür ich Hilfe brauche, ist meine zunehmende Einsamkeit.
- Frag mich, wer ich bin, und du wirst meine Reaktionen und mein Verhalten besser verstehen können.

Wie kommt es, dass wir so wenig Interesse und Verständnis für die Biographie eines Patienten haben?

Er war leitender Direktor einer größeren Firma mit mehreren hundert Angestellten. Über die letzten 3–4 Jahre hatte er mit großer Kraft eine Firmenerweiterung erfolgreich vorgenommen und dadurch einen Konkurs vermieden. Sein Berufsmotto: »Ich kämpfe und werde niemals aufgeben« galt auch für sein Privatleben. Sein ältester Sohn war vier Jahre zuvor nach einem Motorradunfall gestorben. Seine Strategie, mit dem Verlust zurechtzukommen, war, noch ernster und intensiver zu arbeiten als zuvor. Über den Verlust des Sohnes war er kaum in der Lage zu sprechen. In seiner Familie sprach man wenig über Gefühle. Niederlagen wurden durch Stärke überlebt.

- Was habe ich aus dieser Situation gelernt?

3.5.1 Es ist schwer, über den eigenen Schatten zu springen

Leugnen ist der Schutz des einzelnen. Er muss gewahrt bleiben, außer in Situationen einer ernsten Belastung für den Patienten oder die Angehörigen.

Ohne unser Drängen hätte dieser Patient in seinen verbleibenden Tagen vielleicht eine Möglichkeit gehabt, mit Offenheit Abschied zu nehmen.

Umgekehrt können wir sagen: Er hat auf seine Weise Abschied genommen. Unsere Trauer war zu viel für seinen Mut und seine Kraft. Vielleicht wäre es anders gekommen, wenn wir seine Lösung akzeptiert hätten, wenn wir ihn wie zuvor liebevoll und anspruchslos betreut hätten. Die meisten Menschen werden sterben, wie sie gelebt haben. Nicht jeder kann über den eigenen Schatten springen. Wir fügen Patienten Schaden zu, wenn wir sie zwingen wollen, etwas zu verstehen, wozu ihnen die Kraft fehlt.

3.5.2 Die Lebensgeschichte und die Wertsysteme des Patienten sind grundlegende Voraussetzungen für die Kommunikation

Heute sehe ich mein Vorgehen als einen paternalistischen Übergriff auf die Autonomie dieses Mannes. Mir war nicht ausreichend bewusst, dass häufig Verwundbarkeit und persönliche Niederlagen Leugnen und Regression zur Folge haben. Überstandene Lebenskrisen können zu einer größeren Reife führen mit Offenheit und Verständnis, wenn der Betroffene dazu bereit ist. Kenntnis über und Einsicht in die betreffende Lebensgeschichte und Wertsysteme des Patienten sind Voraussetzungen, in vergleichbaren Situationen eine positive Änderung zu bewirken.

Wir dürfen nicht glauben, einem Menschen in schweren Lebenskrisen helfen zu können, ohne zu wissen, wer er ist. Nur mit diesem Verständnis können schwierige Fragen und Belastungen angesprochen werden, um Betroffenen die Möglichkeit zu geben, Alternativen für eine aussichtslose Lage zu sehen.

3.5.3 Für schwierige Gedankenprozesse brauchen Patient und Arzt Zeit

Die Begrenzung der Zeit bei lebensbedrohlicher Erkrankung und bei sterbenden Patienten ist eine Belastung. Auch wenn wir nur noch wenig Zeit haben, müssen wir behutsam vorgehen. Fragen können vorsichtig gestellt werden. Sobald die Abwehr des Patienten deutlicher wird, sollte der Arzt sich Zeit lassen und einen Schritt zurücktreten.

Beispiel aus der Praxis

In unserem Beispiel könnte ein anderes Gespräch stattgefunden haben:

Arzt: Wie geht es Ihnen heute?
Patient: Nicht so gut. Aber es wird sich bald wieder bessern.
Arzt: Möchten Sie, dass wir gemeinsam über die Situation sprechen?
Patient: Heute fehlt mir die Kraft, Doktor, morgen wäre besser.

Der Arzt sollte dann bis morgen warten. Am nächsten Tag kann es aber weitergehen:

Arzt: Guten Morgen, Herr Peters. Wie sieht es heute aus? Haben Sie eine ruhige Nacht verbracht?
Patient: Ganz gut Doktor. Ganz gut. Es ist bloß diese Atemnot…Aber es wird bald wieder besser.
Arzt: Sind Sie sich sicher, dass es bald wieder besser geht?
Patient: Ja, sicher. Es wird bald wieder besser, ich bekomme ja jetzt Penicillin. Das wird schon wirken.
Arzt: …[Pause]…Herr Peters, ich verstehe, dass Sie die Vorstellung haben, es wird besser durch das Penicillin. Aber gibt es Zeiten, in denen Sie nicht so sicher sind? In denen Sie denken: So einfach ist es nicht?

Wenn der Patient dann sagt: »Nein, ich bin absolut sicher, es wird gut gehen«, sollten wir uns nochmals Zeit geben. Manchmal ist das Problem, dass es keine Zeit mehr gibt. Der Kranke wird zu schwach, um solche Gespräche zu führen. Er stirbt, bevor eine Versöhnung möglich ist. Dann bleibt die Aufgabe, sich um die Hinterbliebenen zu kümmern.

Sagt der Patient aber: »…Ja…Es gibt eine Dunkelheit. Ich kann sie aber nicht ertragen«, kann ein weiteres Gespräch vorsichtig an diese Dunkelheit anknüpfen, damit der Patient es wagt, in kleinen Schritten weiterzugehen.

3.5.4 Ein Gespräch, in dem die Teilnehmer Befürchtungen und Gefühle äußern dürfen

Erfahrungen aus der Familien- und Systemtherapie haben neue Türen zur Kommunikation mit der Familie geöffnet. Wenn ein oder mehrere Familienmitglieder Verdrängungs- und Leugnungsreaktionen zeigen, können in ei-

nem gemeinsamen Gespräch mit der betroffenen Familie Problemgebiete auf eine Weise angesprochen werden, die zu einer größeren Offenheit beitragen kann. Diese *gemeinsamen* Gespräche kann der Arzt anbieten, sobald ein oder mehrere Familienmitglieder darum bitten. Sie müssen aber auf freiwilliger Basis der einzelnen Teilnehmer beruhen.

Beispiel aus der Praxis

Arzt: Guten Morgen, Herr Peters. Wie sieht es heute aus? Haben Sie eine ruhige Nacht verbracht?

Patient: Ganz gut, Herr Doktor. Ganz gut. Es ist bloß diese Atemnot…Aber es wird bald wieder besser.

Arzt: Sind Sie sicher, dass es bald wieder besser geht?

Patient: Ja, sicher. Es wird bald wieder besser, ich bekomme ja jetzt Penicillin. Das wird schon wirken.

Arzt: Und Sie, Frau Peters, wie geht es bei Ihnen?

Frau P.: Mir geht es…schlecht.

Arzt: …Machen Sie sich Sorgen um Ihren Mann?

Frau P.: Sorgen? Ihn so zu sehen? Es wird ja jeden Tag schlechter. Ich kann es nicht ertragen…

Arzt: …Was können Sie nicht ertragen?

Frau P.: Dass wir nicht darüber reden können…

Wenn Herr Peters nicht mit uns über *seine* Situation reden möchte, besteht die Möglichkeit, dass seine Frau oder die Kinder in seiner Anwesenheit *ihre* eigenen Probleme ansprechen. Dadurch bekommt der Patient eine Möglichkeit, sich zu den Reaktionen und Sorgen seiner Familie zu verhalten. Aus Erfahrung weiß ich, dass solche Gespräche äußerst wertvoll für alle Beteiligten sein können. Der Arzt oder Therapeut muss vorsichtig und aufmerksam vorgehen, damit die Belastung für den Patienten nicht zu groß wird. Dieser Rahmen ist auch wertvoll, wenn Familienmitglieder Leugnen und Verdrängung zeigen und der einsichtsvolle, sterbende Patient Abschied nehmen möchte.

3.5.5 Ein früheres, brutales Aufklärungsgespräch oder eine fehlende Aufklärung können die Ursache für Leugnen und Verdrängung sein

Das Ideal der Aufklärung ist ein Prozess über mehrere Gespräche, in denen Arzt und Patient sich besser kennen lernen und der Patient stufenweise seine Situation, Diagnose, Therapiemöglichkeiten und Zukunft erfassen kann. Dies ist ein Ideal.

In der Wirklichkeit wird ein solcher Prozess häufig nicht stattfinden, weil Ärzte sich dafür zu wenig Zeit nehmen, weil die Ausbildung und erforderliche Kompetenz fehlen und weil der schwerkranke Patient meist mit zahlreichen Ärzten konfrontiert wird. Nicht selten liegt die Verdrängung der Krankheitsentwicklung auf Seiten des Arztes, und der Patient wird dadurch der Möglichkeit beraubt, seine Situation zu erfassen.

Wenn der Arzt in der Aufklärung die entgegengesetzte Strategie wählt und »alles auf einmal« sagt, um die »Wahrheit« loszuwerden, um seiner Aufklärungspflicht nachgekommen zu sein, kann die Botschaft niederschmetternd für den Patienten sein. Eine solche brutale Aufklärung ist häufig die Ursache für Leugnen und Verdrängung (Maguire 1988; Faulkner et al. 1994).

3.5.6 Ich werde bald gesund und gehe dann nach Hause

Auch Patienten haben Träume und Metaphern. Sie sind imstande, auch in aussichtsloser Lage, zu hoffen, dass es noch gut gehen kann. Viele sterbende Patienten haben bis zuletzt an dieser oder einer ähnlichen Aussage festgehalten: »Ich werde bald gesund und gehe dann nach Hause.«

Wir können dabei denken: Sie sind verwirrt. Sie haben Bodenkontakt verloren. Sie haben bei den vielen Informationsgesprächen nichts verstanden. Sie schützen sich, weil sie die Wahrheit nicht verkraften können.

Das Gegenteil kann zutreffend sein. Ihre Worte können eine Schilderung von dem sein, was sie sich erhoffen. Sie können auch eine Metapher über das Zuhause und die Gesundheit darstellen, von dem letzten Zuhause und der letzten Gesundheit, die entsteht, wenn das Leben und das Sterben zu Ende sind. Statt in dieser Situation den »Irrtum« aufklären zu wollen, sollten wir Einsicht und Respekt für die gewählte Lösung zeigen.

3.6 »Wie lange habe ich noch, Herr Doktor?«

Viele Ärzte stehen ratlos da, wenn sie schwierige Fragen bekommen. Die obige Frage kann in den früheren Stadien einer Krebserkrankung unmöglich zu beantworten sein. Viele Kollegen geben an, dass sie auf diese Frage *grundsätzlich nicht* antworten. Eine solche Einstellung kann eine große Belastung für Patienten bedeuten, wenn sie, vor dem eigenen Lebensende stehend, Auskunft brauchen, um mit der Situation zurechtzukommen und wichtige Geschäfte in der letzten Zeit noch zu regeln. Statt sture und vorgefertigte Antworten und Haltungen zu vertreten, sollten wir jederzeit Bereitschaft zeigen, individuell auch auf schwierige Patientenfragen einzugehen.

Patienten werden nur solche Fragen stellen, wenn sie großes Vertrauen zu dem Befragten haben.

- Was ist unsere Aufgabe, wenn jemand uns dieses große Vertrauen schenkt?
- Sollen wir sie allein lassen, indem wir sagen: »Ich kann diese Frage nicht beantworten«?

Leo Tolstoj hat uns durch seine Geschichte *Der Tod des Iwan Iljitsch* (Ausgabe 1975) die wohl eindrucksvollste Schilderung der Weltliteratur über das Leben eines Sterbenden hinterlassen (▶ Kap. 2.1).

> Ob es Morgen oder Abend, Freitag oder Samstag war, war ja ganz gleich; es war immer ein und dasselbe: der nagende, auch nicht einen Augenblick aussetzende Schmerz, das hoffnungslose Bewusstsein, dass das Leben zu Ende gehe, aber noch nicht zu Ende sei, dass der furchtbare, gehasste Tod, das einzig Wirkliche, immer näher komme, und dazu immer dieselbe Lüge. Was bedeuten da Tage, Wochen, Stunden…
>
> Eine Stunde, zwei Stunden vergingen. Die Glocke im Vorzimmer. »Ist es vielleicht der Doktor?« Ja, es ist der Doktor, frisch, munter, fett, heiter, mit einer Miene, die zu sagen scheint: »Sie haben sich wieder geängstigt, aber wir werden es schon machen.« Der Doktor weiß, dass diese Miene hier nicht mehr wirkt, aber er hat sie nun einmal angenommen und kann sie nicht mehr lassen, ebensowenig wie ein Mensch den Frack, den er in der Frühe anzieht, um Visiten zu machen.
>
> ▼

Der Doktor reibt sich munter und vergnügt die Hände.

»Ich bin ganz kalt. Eine eisige Kälte draußen. Lassen Sie mich erst ein wenig warm werden«, sagt er mit einem Ausdruck, als brauche Iwan Iljitsch nur ein wenig zu warten, bis er warm geworden sei, und dann musste alles in Ordnung kommen.

»Nun, wie geht's?«

Iwan Iljitsch fühlt, dass der Doktor gern gesagt hätte: »Nun, wie geht das Geschäft?« Doch auch er begreift, dass man so schließlich nicht reden darf, und fragt darum: »Wie haben Sie die Nacht verbracht?«

Iwan Iljitsch sieht den Doktor an, als wollte er fragen: »Wirst du dich niemals schämen, so zu lügen?«

Aber der Doktor will die Frage nicht verstehen. Und Iwan Iljitsch sagt: »Schlecht, der Schmerz geht nicht weg, lässt nicht nach, auch nicht für einen Augenblick!«

»Ihr Kranken seid nun einmal so. Jetzt bin ich ganz warm geworden, selbst die empfindliche Praskowja Fjodorowna hätte nichts mehr gegen meine Temperatur einzuwenden. – Na also, guten Morgen!« Der Doktor drückt ihm die Hand.

Der Spaß wird nun beiseite gelassen, und der Doktor beginnt ihn mit ernstem Gesicht zu untersuchen, den Puls, die Temperatur, er beklopft und behorcht ihn.

Iwan Iljitsch weiß genau, dass alles Unsinn und leerer Betrug ist…

Sie begann von der Arznei zu sprechen. Er wandte den Blick nach ihr hin. Sie sprach den Satz nicht zu Ende, den sie begonnen hatte, so böse war der Blick, mit dem er sie ansah. »Um Christi willen, lass mich doch ruhig sterben!«, sagte er. Sie wollte hinausgehen, aber da kam die Tochter und wollte guten Morgen sagen. Er sah die Tochter mit demselben Blick an und antwortete auf die Frage nach seinem Befinden trocken, dass er sie alle bald von sich befreien werde…

Zur gewohnten Stunde kam der Doktor. Iwan Iljitsch antwortete ihm: Ja-Nein, ohne seinen erbosten Blick von ihm zu wenden, und zuletzt sagte er zu ihm: »Sie wissen doch selber, dass Sie mir nicht helfen können. Lassen Sie mich also in Ruhe!«

»Wir können die Leiden wenigstens erleichtern«, sagte der Doktor.

»Auch das können Sie nicht. Lassen Sie mich in Ruhe.«

Der Doktor ging ins Speisezimmer und teilte Praskowja Fjodorowna mit, dass es dem Kranken sehr schlecht gehe und es nur ein Mittel gebe für ihn – Opium, um die Schmerzen zu lindern, die jetzt furchtbar sein müssten. Der Doktor sprach von körperlichen Schmerzen und hatte Recht. Aber noch furchtbarer als die körperlichen Schmerzen waren die seelischen, und in ihnen lag für Iwan Iljitsch die große Qual.

> Die seelischen Leiden bestanden darin, dass ihm in dieser Nacht […] plötzlich der Gedanke gekommen war: »Und wenn wirklich mein ganzes Leben, mein bewusstes Leben nicht das richtige gewesen ist?«
>
> Er sah in ihnen sich selber, alles das, wofür er gelebt hatte, und er sah klar, dass das gar nichts, dass das alles ein furchtbarer, ein ungeheurer Betrug war, der Leben und Tod verdeckte. Dieses Bewusstsein vergrößerte, verzehnfachte seine körperlichen Leiden. Er stöhnte auf, warf sich hin und her, riss die Kleider von sich, als wollten sie ihn ersticken. Dafür hasste er sie jetzt alle.

Iwan Iljitsch hatte das Gefühl, von allen im Stich gelassen worden zu sein: Der Doktor, die Ehefrau, die Tochter, der Sohn; keiner zeigte Bereitschaft, mit ihm über den Abschied zu sprechen. Einzige Ausnahme blieb der Diener Gerasim. Aus dieser Geschichte können wir unendlich viel lernen.

Wahrscheinlich wichtiger als die konkrete Anwort auf die Frage: »Wie lange noch, Doktor?« ist unser Verhalten gegenüber diese Fragen. Patienten, die Fragen zu dem bevorstehenden Tod stellen, geben ein Signal: »Bitte setze dich zu mir. Rede mit mir. Lass mich nicht allein. Wenn ich mit dir über meine Gedanken reden darf, wird es mir besser gehen. Vielleicht brauche ich auch ein Signal von dir, dass mir tatsächlich nur mehr kurze Zeit bleibt. Ich habe noch unerledigte Geschäfte. Ich möchte mich noch von jemandem verabschieden.«

Es ist ein besonderes Verdienst der Hospizbewegung, den Sterbenden in diesen Situationen nicht allein lassen zu wollen. Der Mut zur Offenheit in diesen Gesprächen ist gefragt. (Mehr darüber in ▶ Kap. 9: »Die Rolle des Arztes«)

Was sagt der Arzt auf die Frage: »Wie lange habe ich noch, Doktor?«

Was darf der Arzt sagen?

- Wie denken Sie selbst?
- Sagen Sie bitte mehr darüber.
- Brauchen Sie Hilfe, um von Ihren Angehörigen Abschied zu nehmen?
- Wir haben ja offen miteinander darüber gesprochen. Sie wissen, dass es ernst ist. Sie wissen auch, dass es fast unmöglich ist, einen genauen Zeitpunkt vorauszusagen. Die Krankheit kann nicht mehr geheilt werden, darüber haben wir uns unterhalten. Weil Sie mich jetzt so offen fragen, möchte ich Ihnen auch offen antworten: Die verbleibende Zeit ist begrenzt. Vielleicht ist es mehr eine Frage von Tagen oder Wochen als von Monaten…
- Wie Sie selbst wiederholt gesagt haben, jetzt ist es nur eine Frage um kurze Zeit.
- Welche Unterstützung brauchen Sie jetzt von mir?
- Wenn es sich schnell verschlechtern sollte, verspreche ich, so schnell wie möglich mit Ihnen darüber zu reden.
- Ich sehe, Sie machen sich Sorgen, aber finden es schwer, darüber zu sprechen…Lassen Sie sich Zeit. Es wird häufig besser, wenn man anspricht, was Sorgen bereitet, und ich höre gerne zu.

Was sollte der Arzt nicht sagen?

- Diese Frage kann ich niemals beantworten.
- Solch dumme Gedanken sollten wir so schnell wie möglich vergessen.
- Der Patient wird bald sterben, Sie sollten mit ihm/ihr aber nicht darüber sprechen.
- Wir können jetzt nichts mehr tun.
- Ich finde es unverantwortlich, wenn Ärzte versuchen, auf diese unmögliche Frage zu antworten.
- Sie sollten auf jeden Fall einen Tropf bekommen, jetzt wo Sie nicht mehr die Kraft haben zu trinken.

3.7 »Ihr Kind ist tot.«

Beispiel aus der Praxis

Ein vierjähriges Mädchen wird vor dem Kindergarten angefahren. Es ist auf der Stelle tot. Die Eltern werden telefonisch benachrichtigt, dass ein Unfall passiert sei und dass ihr Kind in das nächstliegende Krankenhaus gebracht wurde.

Stellen Sie sich vor, dass sie in der Aufnahme des Krankenhauses als Arzt oder Krankenpfleger arbeiten. Zehn Minuten nachdem das Kind tot eingeliefert wurde, kommen die Eltern. Das Gesicht des Kindes ist schwer entstellt. Sie sind für die weitere Information zuständig.

- Wie würden Sie vorgehen?
- Was werden Sie sagen?
- Wie ist Ihnen dabei zumute?

Es wird kaum jemanden geben, der sich bei einer solchen Herausforderung wohl fühlt. Der unerwartete Verlust eines Kindes ist für alle Beteiligten, besonders für die Eltern, unbeschreiblich traumatisch. Zeit zur Vorbereitung des Gespräches ist in diesem Beispiel kaum gegeben. Heftige gefühlsmäßige Reaktionen müssen erwartet werden und sind verständlich.

Zwei mögliche Gespräche sollen dargestellt werden. Wir versuchen, uns in die Lage des Arztes und der Eltern zu versetzen. Vielleicht können Überlegungen und Anregungen gewonnen werden, wie wir in einer solchen Situation vorgehen können.

Beispiel aus der Praxis

Version I.a

Die Eltern kommen direkt in die Ambulanz und sagen: »Wo ist unsere Tochter? Was ist passiert?«

Die angesprochene Krankenschwester antwortet: »Warten Sie eine Sekunde hier. Ich hole sofort den Arzt.«

Drei Minuten später kommt sie zurück mit dem Arzt. Alle vier befinden sich in der Eingangshalle der Ambulanz. Eine ungestörte Sitzmöglichkeit gibt es hier nicht.

Die Mutter des Kindes wiederholt ihre Frage: »Wo ist unsere Tochter? Was ist passiert?«

Doktor Hansen antwortet: »Wo können wir uns hinsetzen, Schwester, gibt es eine Möglichkeit?« Bevor die Schwester antworten kann, ergreift die Mutter das Wort und sagt mit Heftigkeit: »Ich will mich nicht hinsetzen, ich will jetzt wissen was los ist! Sagen Sie es uns!«

»Es fällt mir unendlich schwer, hier darüber zu reden«, antwortet der Arzt.

»Ihre Tochter wurde vor dem Kindergarten von einem Auto angefahren. Es war kaum möglich, etwas zu machen…«

Die Mutter verliert jetzt die Kontrolle: »Was meinen Sie mit ‚kaum möglich, etwas zu machen', ist sie etwa tot?!«

»Es muss unendlich traurig für Sie sein. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll…«

»Sagen Sie es, Mann! Ich will es wissen! Ich will sofort zu ihr!«

Wir können uns vorstellen, dass weitere Gespräche weder für den Arzt noch für die Eltern in angenehmer Erinnerung bleiben würden.

Beispiel aus der Praxis

Version I.b

Die Eltern kommen direkt in die Ambulanz und sagen: »Wo ist unsere Tochter? Was ist passiert?«

Die Krankenschwester antwortet: »Dann sind Sie Herr und Frau Diez. Ich bin Schwester Monika. Bitte kommen Sie mit, ich zeige Ihnen, wo Sie sich hinsetzen können. Ich hole sofort den Arzt.«

Sie bringt die Eltern in einen Untersuchungsraum, wo vier Sessel bereitstehen. Drei Minuten später kommt sie mit dem Arzt zurück.

»Herr und Frau Diez«, sagt er, »ich bin Doktor Hansen, der Dienst habende Oberarzt hier in der Ambulanz. Was haben Sie erfahren?«

»Ich wurde vom Kindergarten angerufen. Sie sagten, es sei ein Unfall vor dem Kindergarten passiert, und dass unsere Tochter mit dem Krankenwagen hierher gebracht wurde. Mein Mann hat mich sofort abgeholt.«

»Ihre Tochter wurde von einem Lastwagen angefahren. Wie wir erfahren haben, war sie auf der Stelle tot.«

Auch in diesem Fall ist anzunehmen, dass das weitere Gespräch nicht einfach verlaufen ist. Durch geringe, aber wichtige Unterschiede wird jedoch einiges erreicht, was für die Information und den weiteren Verlauf von Wert sein kann.

3.7.1 Höfliches und respektvolles Benehmen

Sowohl die Schwester als auch der Arzt stellen sich mit ihrem Namen und ihrer Funktion vor. Sie sprechen auch die Eltern mit ihrem Namen an. Wir können auch hoffen, dass sie bei dem Gespräch mit den Eltern in Bezug auf nonverbale Kommunikation diesen Respekt vermitteln (Blickkontakt, Zuhören, Schweigen und Gefühle zulassen etc.). Das Ergebnis: Das Gespräch wird persönlicher. Der Respekt wird schnell gegenseitig.

3.7.2 Ein ungestörter Raum

Das Vorgehen der Krankenschwester ermöglicht den Eltern, bereits in einem ungestörten Raum zu sein, *bevor* der Arzt dazukommt und *die Information beginnt*. Für den Arzt wäre es schwieriger, das Gespräch hinauszuschieben. Fast alle denkbaren Gefühlsreaktionen sind zu erwarten und sollten dann auch bei einem solchen Gespräch zugelassen werden. Wir brauchen aber nicht viel Phantasie, um uns vorzustellen, welche Belastung es in solchen Fällen sein muss, wenn das Gespräch auf einem Gang stattfindet, auf dem fremde Menschen vorbeiziehen und auf dem Telefone und Geräusche aller Art für Unterbrechung und Störung sorgen.

3.7.3 Information teilen

Die Anfangsfrage des Arztes: »Was haben Sie erfahren?« erlaubt den Eltern, sich zu äußern. Diese Möglichkeit kann eine größere Bedeutung haben, als wir denken. Sie gibt auch dem Arzt eine kurze Möglichkeit, sich auf seine nächste und entscheidende Aussage zu konzentrieren.

3.7.4 Die Botschaft im richtigen Moment verständlich erklären

Wer in solchen Situationen Erfahrung hat, weiß, dass es sinnlos und provozierend wirken kann, wenn die Information über den Zustand des Kindes verschleiert wird. In diesem Fall muss die Einleitung sehr kurz sein, weil die Anspannung für die Eltern unerträglich werden kann. Die Wortwahl ist von

Bedeutung. Selbst erfahrene Ärzte haben hier Probleme. Wir sagen: »Sie ist eingeschlafen.« »Sie ist nicht mehr am Leben.« »Sie hat uns verlassen.« Damit gelingt es uns, eine direkte Aussage über den Tod zu umgehen. Aber gerade diese Aussage ist gefragt. Durch die Aussage: »Sie ist tot« wird das Unerträgliche ausgesprochen. Es wird den Eltern gestattet, sich zu der vernichtenden Botschaft zu verhalten.

3.7.5 Gefühle und Ohnmacht zulassen

Nach der Aussage: »Sie ist tot« kann jede denkbare Reaktion möglich sein. Keiner kann voraussagen, wie wir oder andere in einer solchen Situation reagieren werden. Jede Reaktion – Wut, Verzweiflung, Stille, Verdrängung, Verschlossenheit usw. – ist als »normal« zu betrachten. Eine der wichtigsten und schwierigsten Aufgaben in einer solchen Situation ist es, solche Reaktionen mit Geduld und Feingefühl zuzulassen. Die fast schwierigste Aufgabe ist, im richtigen Moment zu schweigen und dabei die eigene Ohnmacht und die der Eltern zu akzeptieren.

3.8 »Ja, Sie haben Krebs.«

Die Situation mit dem toten Kind ist für die meisten Ärzte und Schwestern der Albtraum unter möglichen Aufklärungsgesprächen. Es gibt aber viele andere Situationen, in denen es schwer fällt, dem Patienten mit seinen Ängsten und Nöten gerecht zu werden.

Beispiel aus der Praxis

Unser Patient ist 46 Jahre alt. Er hat sich drei Wochen unwohl gefühlt, mit ständigem Druckgefühl im Oberbauch, bei gleichzeitig zunehmendem Appetitverlust. Die ersten Untersuchungen beim Hausarzt haben keine Erklärung für seine Beschwerden gebracht. Er wird stationär auf einer chirurgischen Abteilung aufgenommen. Bei einem Computertomogramm des Oberbauchs findet man einen größeren Tumor im Pankreasbereich, der bereits in das benachbarte Gewebe infiltriert ist. Eine Biopsie bestätigt den Verdacht auf soliden Pankreastumor. Am Nachmittag ist das Gespräch mit dem Patienten vorgesehen.

Version II.a

Der chirurgische Stationsarzt, Oberarzt Ganz, sucht den Patienten in seinem Dreibettzimmer auf. Alle drei Patienten haben gerade Kaffee getrunken und liegen in ihren Betten.

»Ja, Herr Müller«, sagt Dr. Ganz an der Bettkante stehend, »Sie sind sicher gespannt, wie die Untersuchungen gelaufen sind.«

Herr Müller schweigt.

»Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, Herr Müller«, fährt Dr. Ganz dann zögernd fort, »aber wir haben einen Schatten hinter dem Magen entdeckt.«

Herr Müller schweigt noch immer.

»Jetzt fragen Sie sich bestimmt, Herr Müller, was das bedeuten kann, ‚ein Schatten hinter dem Magen'. Hinter dem Magen liegt die Bauchspeicheldrüse. Wir vermuten, dass Sie einen Tumor in diesem Bereich haben. Und es sieht leider nicht gut für Sie aus…«

Als Herr Müller weiter schweigt, sagt Dr. Ganz dann: »Haben Sie keine Fragen, Herr Müller?«

Nach einer kurzen Pause sagt Dr. Ganz dann abschließend: »Ja, ich kann Sie verstehen, es ist für Sie bestimmt wie ein Schock. Ich hätte selbstverständlich gern eine bessere Botschaft mitgebracht. Vielleicht können Sie sich in den nächsten Tagen mit Ihrer Frau aussprechen. Morgen bin ich nicht da, aber übermorgen können wir noch einmal darüber sprechen, falls Sie wollen.«

Dr. Ganz verlässt das Zimmer.

- Wie wird jetzt Herrn Müller zumute sein?
- Und Dr. Ganz?
- Ist es ein gutes Gespräch gewesen?
- Ist Herr Müller jetzt gut informiert und auf seine Zukunft vorbereitet?

Beispiel aus der Praxis

Version II.b

»Sagen Sie, Schwester Bettina, wie sollten wir das machen?«, sagt Dr. Ganz zu seiner Stationsschwester, »es sieht bei Herrn Müller nicht gut aus. Er hat einen soliden Pankreastumor. Er liegt ja im Dreibettzimmer. Wie können wir ungestört mit ihm sprechen?«

»Seine Frau kommt immer um diese Zeit«, sagt Schwester Bettina. Zimmer 14 ist gerade frei. Ich könnte den beiden sagen, dass Sie gerne mit ihnen sprechen wollen, und sie dann auf 14 mitnehmen. Darf ich dabei sein?«

»Selbstverständlich. Aber was meinen Sie: Wie wird Herr Müller die Botschaft aufnehmen, was wissen wir über ihn?«

»Er ist sehr verschlossen. Er äußert sich kaum über die Krankheit und spricht auch wenig mit den anderen Patienten. Aber er blüht auf, wenn seine Frau kommt und v. a. wenn die beiden Jungen da sind. Wie ich seinem Verhalten entnehme, muss er selbst schon einen Verdacht haben, dass etwas nicht stimmt, dass es ernst sein kann. Er hat auch erzählt, dass seine Mutter vor einem Jahr nach einem schweren Verlauf an Krebs gestorben ist.«

»Ja, er macht einen ängstlichen Eindruck. Holen Sie mich, wenn die beiden auf Zimmer 14 sind?«

Dr. Ganz betritt dann das Zimmer 14, gemeinsam mit Schwester Bettina.

»Guten Tag Frau Müller, ich bin Dr. Ganz, der chirurgische Oberarzt. Guten Tag Herr Müller«, sagt Dr. Ganz. Sie setzen sich alle. »Wie haben Sie die Strapazen der Untersuchungen verkraftet? Wie geht es Ihnen jetzt?«

»Oh, es war nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe.«

»Wir freuen uns, dass Sie, Frau Müller, an dem Gespräch teilnehmen. – Herr Müller, wir wollen uns gerne mit Ihnen über die vorläufigen Ergebnisse der Untersuchungen unterhalten. Aber zuerst möchte ich Sie fragen, welche Gedanken Sie sich selbst gemacht haben«, setzt Dr. Ganz fort.

»Ich? – Ja ich, habe mich – nicht wohl gefühlt. Der Hausarzt sagte, dass alles in Ordnung sei, dass er zur Sicherheit eine Krankenhauseinweisung für erforderlich hält.«

»Und, was haben Sie gedacht, könnte die Ursache sein?«

»Sie sind der Arzt, Dr. Ganz. – Ein Problem für mich ist bestimmt, dass meine Mutter vor einem Jahr an Krebs gestorben ist«, antwortet Herr Müller. »Ich glaube aber nicht, dass es Krebs sein kann.«

»Wir haben in den letzten Tagen einige Untersuchungen gemacht, Herr Müller. Vor allem nach der heutigen Untersuchung kann es nicht ausgeschlossen werden, dass es doch etwas Bösartiges sein könnte. Wir haben einen Schatten im Gebiet der Bauchspeicheldrüse entdeckt.«

»Was bedeutet das, ‚ein Schatten'?, fragt Frau Müller nach einer Pause.

»Das heißt, wir können nicht ausschließen, dass es sich hier um einen Tumor handelt.«

»Das darf nicht sein«, antwortet Frau Müller, »Sie müssen sich irren.«

»Falls es ein Tumor sein sollte«, sagt Dr. Ganz, »kann dieser gutartig oder bösartig sein. In beiden Fällen können wir viel machen. Ich würde vorschlagen, dass wir zur weiteren Klärung in den nächsten Tagen eine kleine Opera-

tion vornehmen. Hierbei können wir eine sichere Diagnose stellen und besser entscheiden, was gemacht werden kann.«

»Eine Operation? Ist das notwendig?«, fragt Herr Müller.

»Notwendig ist es nicht. Ich glaube aber, dass Sie beide großen Wert darauf legen, zu erfahren, was los ist und was gemacht werden kann. Ich werde auch nochmal die Computerbilder und die anderen Ergebnisse mit meinen Kollegen besprechen und morgen zu Ihnen kommen. Dann besprechen wir nochmals die Situation und was gemacht werden kann. Sind Sie damit einverstanden?«

»…Wir haben zwei kleine Jungen, Dr. Ganz,« sagt Frau Müller leise. »Was soll ich sagen, wenn ich heute nach Hause komme?«

»Ja, ich verstehe, wie wichtig die Jungen für Sie sind. Wie alt sind sie?«

»Fünf und acht.«

»Erzählen Sie etwas über die beiden. Wie sind sie?«

»Lukas ist fünf,« sagt Frau Müller, anfangs zögernd, aber nach und nach aufgeschlossener. »Und Jacob ist acht. Jacob ist der Ruhigere, etwas schüchtern – ja, fast wie der Vater. Für Lukas gibt es selten Probleme. Aber Temperament hat er, und brüllen kann er auch.«

Dr. Ganz nimmt sich Zeit für die Antwort. »Ich würde mir an Ihrer Stelle Zeit lassen. Auf der einen Seite sollten wir mit Kindern immer offen sprechen, damit kommen sie am besten zurecht. Auf der anderen Seite wissen wir noch nicht ganz sicher, wie es mit Ihrem Mann weitergeht. Wenn Sie wollen, können Sie gerne die Kinder in den nächsten Tagen mitbringen, damit ich sie kennen lernen kann. Überlegen Sie sich es. Ich komme morgen zwischen drei und vier wieder, Herr Müller, ich glaube auch, dass es für Sie beide wichtig ist, wenn Sie morgen hier sein können, Frau Müller. Wäre das möglich?«

»Ja, ich komme morgen um drei«, antwortet Frau Müller.

»Sehr schön. Und vielleicht fallen Ihnen beiden bis morgen wichtige Fragen ein, die Sie mir stellen wollen. Bis morgen, Herr Müller. Bis morgen, Frau Müller.«

Einige Schwerpunkte des zweiten Gesprächs sollen im Folgenden besprochen werden.

3.8.1 Welche Geschichte hat der Patient?

Der Arzt erkundigt sich vor dem Gespräch bei der Stationsschwester über Herrn Müller. Die Informationen über das Verhalten des Patienten seit der stationären Aufnahme, über seine Familie und sein bisheriges Leben zeigen,

dass dieser Patient wahrscheinlich viel Zeit brauchen wird, bevor er die Konsequenzen seiner Erkrankung verstehen kann.

3.8.2 Gemeinsames Gespräch mit der wichtigsten Bezugsperson

Aus der Schilderung der Stationsschwester ergibt sich, dass die Ehefrau für den Patienten eine wichtige Vertrauensperson ist. Deswegen sollte großer Wert darauf gelegt werden, dass das Ehepaar gemeinsam an dem Aufklärungsgespräch teilnimmt. So sind beide gleichermaßen informiert und wissen voneinander und haben Voraussetzungen bekommen, um die Probleme und Fragen offen miteinander zu diskutieren. Andernfalls könnte es zu Schwierigkeiten führen, wenn etwa Frau Müller mehr Information bekäme als ihr Mann und sie diese aus verschiedenen Gründen gegenüber ihrem Mann verschwiege.

Bevor wir ein gemeinsames Gespräch anbieten, muss klar sein, wie das Verhältnis der Partner zueinander ist. Es könnte sein, dass die Beziehung zwischen den Ehepartnern kompliziert ist oder dass Herr Müller größten Wert darauf legt, zuerst informiert zu werden.

Wir sollten *nie* die Informationen an Angehörige geben, ohne dass der Patient anwesend ist oder uns dazu aufgefordert hat! Herr Müller ist in diesem Fall unser Patient und Vertragspartner, nicht seine Familie.

Aufgrund der Vorinformationen konnten wir davon ausgehen, dass das Ehepaar ein gutes Verhältnis zueinander hat und dass deswegen das Gespräch gemeinsam geführt werden sollte.

3.8.3 Die Krankenschwester nimmt an dem Gespräch teil

Obwohl es in vielen Krankenhäusern nicht üblich ist, dass eine Krankenschwester am Aufklärungsgespräch teilnimmt, hat sich dies dort bewährt, wo es eingeführt wurde. Es kann sein, dass der Arzt wenig Zeit hat, in den nächsten Tagen nicht zur Verfügung steht oder dass es ihm bei dem Informationsgespräch nicht gelingt, den Gedanken und Gefühlen des Patienten gerecht zu werden. Wenn die Krankenschwester anwesend ist, weiß der Patient, dass sie das Gespräch gehört hat, und es wird sowohl für ihn wie für die Krankenschwester leichter sein, sich in den folgenden Tagen darüber zu

unterhalten. Die Schwester besitzt jetzt wichtige Informationen über die Reaktionen des Patienten und den Inhalt des Gesprächs, Information, die für sie und die anderen Pflegenden und Behandelnden von größter Bedeutung sein können. Vielleicht kann ihre Teilnahme dem Patienten in den nächsten Tagen erlauben, wichtige Fragen oder Reaktionen zuzulassen. Krankenschwestern verbringen meist viel mehr Zeit mit den Patienten als Ärzte. Es wäre ein Fehler, ihre Kommunikationsmöglichkeiten mit den Patienten nicht zu unterstützen und zu fördern.

3.8.4 Höflichkeit und Menschlichkeit

Höflichkeit und Menschlichkeit sind elementar wichtige Eigenschaften im Umgang mit Menschen. Der Arzt stellt sich vor, setzt sich hin und nimmt sich zwei Minuten Zeit, um auch den anderen besser kennen zu lernen. Dies wird konsequent während des ganzen Gespräches durchgeführt. Patienten und Angehörige sind unendlich dankbar, wenn sie dies im Umgang mit Ihnen erleben. Sie werden selbst mit Offenheit und Vertrauen reagieren, wenn sie mit Offenheit und Vertrauen behandelt werden. Wenn der Arzt sich menschlich zeigt, werden sie eher Mut haben, sich menschlich zu zeigen. Menschliche Reaktionen und Gefühle sind die Hauptgrundlage im Umgang mit schwerkranken Patienten.

3.8.5 Offenheit und nicht alles auf einmal

Eine schwierige Frage in solchen Situationen ist:

- Wie viel soll erzählt werden?
- Alles auf einmal oder nach und nach?

Es gibt keine Standardantwort. Auf der einen Seite geht es nicht ohne Offenheit. Auf der anderen Seite gibt es Situationen und Menschen, bei denen es richtig ist, sich Zeit zu nehmen. Bei Herrn Müller müssen wir annehmen, dass er sich in panischer Angst vorstellt: »Es könnte wie bei meiner Mutter Krebs sein.« Gerade seine Aussage: »Ich glaube aber nicht, dass es Krebs sein kann«, muss als Beweis bewertet werden: Er befürchtet stark, dass es Krebs ist.

Unsere Aufgabe ist es, mit Herrn Müller mit Behutsamkeit und Vorsicht Informationen zu teilen und ihm wiederholt Möglichkeiten zu geben, seine

Situation zu erfassen. Nur wenn er seine Situation erfasst hat, kann er zu den für ihn wichtigen, geradezu lebensentscheidenden Fragen Stellung nehmen. Die Gefahr ist bei ihm groß, dass er, falls »alles auf einmal« erzählt wird, sich zu schützen sucht. Solche Schutzmechanismen können sich auf viele Arten äußern: Wut, Aggression, Gleichgültigkeit, Depression und Angst usw.

Behutsames Vorgehen heißt aber nicht, dass die Wahrheit verschwiegen werden soll.

Herr Müller hat ein Recht darauf zu erfahren, wie es um ihn steht. Die Gefahr ist mehr als groß, dass er ohne diese Offenheit nicht in der Lage sein wird, die für ihn und seine Familie richtigen Entscheidungen zu treffen. Am besten wäre es, wenn Herr Müller selbst in den nächsten Tagen fragt: »Sagen Sie, Dr. Ganz, wie es ist, ich muss es wissen, ich bin schließlich der Patient…« Falls Herr Müller dies nicht sagt, und die Gefahr dürfte in seinem Fall sehr groß sein, gibt es für Dr. Ganz viele Möglichkeiten, ihm auf dem Weg dorthin zu helfen.

Bei der ersten Informationsvariante können wir ziemlich sicher sein, dass der Patient im Schockzustand zurückgelassen wird. Das Vertrauen und die weitere Kommunikation werden sehr darunter leiden.

Bei der zweiten Variante setzt Dr. Ganz bewusst auf »nicht alles auf einmal«. Obwohl er selbst davon überzeugt ist, dass nichts gemacht werden kann, um die Krankheitsentwicklung aufzuhalten oder zu verlangsamen, gibt er durch den Hinweis auf die Möglichkeit einer Laparotomie eine kleine Hoffnung, dass es doch nicht sicher ist oder dass etwas gegen die Krankheit gemacht werden kann. Einige Ärzte werden diese »Hinhaltetaktik« für eine unnütze und sinnlose Verzögerung halten. Andere werden sagen, dass eine solche Laparotomie zur Sicherheit der Diagnose dienen kann und gleichzeitig dem Patienten die Möglichkeit gibt, die Situation stufenweise zu erfassen.

3.8.6 Die Lage der Kinder

Wichtig in unserem Beispiel ist, dass die Mutter der Kinder selbst die Lage ihrer Kinder anspricht und uns dadurch die Möglichkeit gibt, darauf zu reagieren. Häufig ist dies nicht der Fall und es bleibt dann unsere Aufgabe, die Lage der Kinder anzusprechen (Eden et al. 1994).

Einige werden sich fragen, ob dies nicht außerhalb der ärztlichen Aufgaben liegt. Wir müssen uns bei der Beantwortung dieser Frage vor Augen halten, dass es unsere Aufgabe ist, dem schwerkranken Patienten in seiner

Krankheit beizustehen und zu sehen, was für ihn am wichtigsten ist. Wir können davon ausgehen, dass fast alle schwerkranken Patienten mit minderjährigen Kindern sich in einer solchen Situation um sie große Sorgen machen, ja es wird oft ihr größtes Problem sein. Die Probleme der Kinder sollten deswegen bewusst einen Teil unserer Betreuung dieser Patienten ausmachen.

Fragen wie »Erzählen Sie von Ihren Kindern« oder »Wie geht es den Kindern; sehen sie, dass Sie krank sind?« können genügen. Der Arzt sollte auf jeden Fall versuchen, eine oder mehrere Begegnungen mit den Kindern zusammen mit ihren Eltern zu arrangieren; erstens, um mit ihnen bekannt zu werden; zweitens, um sich ein Bild zu machen, wie die Kinder mit der Krankheit der Mutter oder des Vaters zurechtkommen.

Kinder können in solchen Situationen als Problem aufgefasst werden, besonders dann, wenn die Krise in der Familie stattfindet, ohne dass sie eine Möglichkeit bekommen teilzunehmen. Wenn den Kindern mit Vorsicht in ihrer Sprache erzählt wird, was los ist, werden sie besser verstehen können, warum Vater weg ist und warum Mutter so traurig ist. Sie können dann trösten und getröstet werden. Besonders wenn ein Familienmitglied im Sterben liegt, kann es für die Kinder nichts Schlimmeres geben als »geschützt« und ferngehalten zu werden, bis es zu spät ist. Wenn die Kinder als Kinder von Anfang an teilnehmen dürfen, werden sie oft gut vorbereitet sein. In der Regel werden dann die Eltern erleben, dass die Kinder ihnen eine nicht wegzudenkende Unterstützung geben werden.

3.8.7 Wiederholung

»Ich komme morgen um 16 Uhr wieder.« Wir sollten Patienten in diesen Situationen nie verlassen, ohne klar zu machen, wann der nächste gemeinsame Gesprächstermin stattfinden wird.

Aus verschiedenen Gründen werden Aufklärungsgespräche oft nicht so offen und vertraulich verlaufen wie geplant. Die Ursache mag auf Seiten des Patienten, des Arztes oder in der zu vermittelnden Botschaft liegen.

Wenn, wie in den dargestellten Situationen, jemand bald sterben wird oder bereits unerwartet gestorben ist, werden Gefühle und Abwehrmechanismen aktiviert. Wut und Trauer werden dann nicht auf die Botschaft, sondern auf den Vermittler der Botschaft projiziert. Obwohl dies eine normale Reaktionsweise ist, kann sie sich auf Dauer zu einer Katastrophe für den Patienten

und sein Umfeld entwickeln. Die Lösung liegt in der Wiederholung und Fortsetzung dieser Gespräche.

Es ist weder im ersten Beispiel noch im zweiten zu erwarten, dass die beteiligten Personen alles verstehen können, was passiert ist. Sie brauchen Zeit und erneute Gespräche mit dem Arzt. Diese sind oft wichtiger als das Erstgespräch. Was beim ersten Gespräch »schief gelaufen« ist, kann in den nächsten Gesprächen gut gemacht werden.

Literatur

Andrae M (1994) Facing death. Physicians' difficulties and coping strategies in cancer care. Med. Dissertation No 395, Umeå University

Bennet G (1987) The wound and the doctor. Warburg, London

Benson J, Britten N (1996) Respecting the autonomy of cancer patients when talking to their families. BMJ 313: 729–731

Bird J et al. (1993) Workshops for consultants on the teaching of communication skills. Med Education 27: 181–185

Bolund C (1985) Suicide and cancer: II. Medical and care factors in suicide by cancer patients in Sweden 1973–1976. J Psychosoc Oncol 3: 17–30

Breitbart W, Passik S (1993) Psychiatric aspects of palliative care. In: Doyle D, Hanks J, MacDonald N (eds) Oxford Textbook of Palliative Medicine. Oxford Univ. Press, Oxford, pp 609–626

Buckman R (1993) How to break bad news. Macmillan, London

Buckman R (1993) Communication in palliative care: a practical guide. In: Doyle D, Hanks J, MacDonald N (eds) Oxford Textbook of Palliative Medicine. Oxford Univ. Press, Oxford, pp 47–61

Buckman R (1996) Talking to patients about cancer. No excuse now for not doing it. BMJ 313: 699–671

Butow PN, Dunn SM, Tattersall MHN (1995) Communication with cancer patients: Does it matter? J Palliat Care 11: 34–38

Calman KC (1996) Cancer: science and society and the communication of risk. BMJ 313: 799–802

Cassell EJ (1982) The nature of suffering and the goals of medicine. N Engl J Med 306: 639–45

Cassileth BR, Steinfeld AD (1987) Psychological preparation of the patient and family. Cancer 60: 547–552

Colvin H, Lehoka J (1997) Transcultural and language problems in communicating with cancer patients in South Africa. In: Surbone A, Zwitter M (eds) Communication with the cancer patient. Information and truth. Ann N Y Acad Sci 809: 119–133

Condrau G (1991) Der Mensch und sein Tod. Kreuz Verlag, Zürich, S 413

Degner LF, Sloan JA (1992) Decision making through serious illness: What role do patients really want to play? J Clin Epidemiol 45: 941–950

De Sorbiere (1672) Advice to a young physician. Zitiert in: Katz J (1984) The silent world of doctor and patient. N Y Free Press 10: 2

Dworkin G (1972) Paternalism. Monist 56: 64–84
Eden OB, Black I, MacKinlay GA, Emery AEH (1994) Communication with parents of children with cancer. Palliat Med 8: 105–115
El-Ghazali S (1997) Is it wise to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth to a cancer patient? In: Surbone A, Zwitter M (eds) Communication with the cancer patient. Information and truth. Ann N Y Acad Sci 809: 97–109
Eser A et al. (1992) Lexikon Medizin–Ethik–Recht. Herder, Freiburg
Falowfield LJ (1995) Communication skills of oncologists. Forum Trends Exp Clin Med 5: 99–103
Fallowfield LJ (1996) Giving sad and bad news. Lancet 341: 476–478
Fallowfield LJ (1997) Truth sometimes hurts, but deceit hurts more. In: Surbone A, Zwitter M (eds) Communication with the cancer patient. Information and truth. Ann N Y Acad Sci 809: 525–537
Faulkner A, Maguire P, Regnard C (1994) Breaking bad news – a flow diagram. Palliat Med 8: 145–153
Feigenberg L (1977) Terminalvård. En metod for psykologisk vård av döende cancerpatienter. Med. Dissertation. Karolinska Institutet, Stockholm; Lund, Liber
Fitch MI (1994) How much should I say to whom. J Palliat Care 10: 90–100
Frances V, Korsch BM, Morris MJ (1969) Gaps in doctor-patients-communication: patients' response to medical advice. N Engl J Med 280: 535–540
Frankl V (1975) Anthropologische Grundlagen der Psychotherapie. Herder, Freiburg
General assembly of the United Nations (1948) Universal declaration of human rights. United Nations, Geneva
Gorlin R et al. (1983) Physicians' reactions to patients. N Engl J Med 308: 1059–1063
Headache Study Group (1986) Predictors of outcome in headache patients presenting to family physicians – a one year prospective study. Headache J 26: 285–294
Holland JC (1989) Now we tell, but how well? J Clin Oncol 7: 557–559
Husebø S (1992) Medisin – kunst eller vitenskap? Ad Notam Gyldendal, Oslo
Husebø S (1997) Communication, autonomy and hope. How can we treat serious ill patients with respect? In: Surbone A, Zwitter M (eds) Communication with the cancer patient. Information and truth. Ann N Y Acad Sci 809: 440–460
Jaffee BJ (1996) Using laughter as a cathartic process in grief counselling. In: Morgan JD (ed). Ethical issues in the care of the dying and the bereaved aged. Baywood, New York, pp 283–296
Kahlke W, Reither-Theil S (1995) Ethik in der Medizin. Enke, Stuttgart
Kaplan SH, Greenfield S, Ware JE (1989) Assessing the effects of physician–patient interaction on the outcome of chronic disease. Med Care 27: 110–127
Kübler-Ross E (1970) On death and dying. Tavistock, London
Li S, Chou JL (1997) Communication with the cancer patients in China. In: Surbone A, Zwitter M (eds) Communication with the cancer patient. Information and truth. Ann N Y Acad Sci 809: 243–248
Loewy EH (1995) Ethische Fragen in der Medizin. Springer, Wien, S 37
MacKillop WJ, Stewart WE, Ginsberg AD, Stewart SS (1988) Cancer patients perception of disease and its treatment. Br J Cancer 58: 355–358

MacLeod R (1991) Patients with breast cancer: the nature and disclosure of their concerns. Med. Dissertation, University of Manchester
Maguire P (1989) Barriers to a psychological care of the dying. Br Med J 291: 907–909
Maguire P (1988) Communication with cancer patients: I. Handling bad news and difficult questions. BMJ 297: 907–909
Maguire P (1988) Communication with cancer patients: II. Handling uncertainty, collusion, and denial. BMJ 297: 972–974
Maguire P (1990) Can communication skills be taught? Br J Hosp Med 43: 215–216
Meredith C, Symonds P, Webster L et al. (1996) Information needs of cancer patients in the west of Scotland. BMJ 313: 724–726
McHugh P, Lewis S, Ford S, Newlands E et al. (1995) The efficacy of audiotapes in promoting psychological well-being in cancer patients: a randomised, controlled trial. Br J Cancer 71: 388–392
Nelson-Jones R, Cosolo W (1994) How to assess thinking skills in cancer patients. Palliat Med 8: 115–122
Northouse P, Northouse LLO (1987) Communication and cancer: issues confronting patients, health professionals and family members. J Psychosoc Oncol 5: 17–45
Novack DH, Plumer R, Smith RI, Ochitill H et al. (1979) Changes in physicians attitudes toward telling the cancer patient. JAMA 241: 897–900
Oken D (1961) What to tell cancer patients. JAMA: 175: 1120–1128
Østergaard Thomsen O, Wulff HR, Alessandro M, Singer P (1993) What do gastroenterologists in Europe tell cancer patients? Lancet 341: 473–476
Parkes CM (1978) Psychological aspects. In: Saunders CM (ed) The management of terminal disease. Arnold, London pp 44–64
Randall F, Downie RS (1996) Palliative care ethics. A good companion. Oxford Medical Publ, Oxford
Sell LB, Devlin SJ, Bourke NC, Munro PA et al. (1993) Communicating the diagnosis of lung cancer. Resp Med 87/1: 61–63
Senn HJ (1985) Wahrhaftigkeit am Krankenbett. In: Meerwein F (Hrsg) Einführung in die Psychoonkologie. Huber, Bern, S 59–74
Simpson MA (1980) Clinical psycholinguistics: the language of illness and healing. Irvington, New York
Simpson M, Buckman R, Stewart M et al. (1991) Doctor-patient communication: The Toronto consencus statement. BMJ 303: 1385–1387
Solanke TF (1997) Communication with the cancer patient in Nigeria. Information and truth. In: Surbone A, Zwitter M (eds) Communication with the cancer patient. Information and truth. Ann N Y Acad Sci 809: 109–119
Sporken P (ed) (1982) Was Sterbende brauchen. Herder, Freiburg
Stedeford A (1994) Facing death: Patients, families and professionals. Sobell, Oxford
Stewart MA, McWhinney IR, Buck CW (1979) The doctor-patient relationship and its effect upon outcome. J Roy Coll Gen Pract 29: 77–82
Tolstoj LN (Ausg 1975) Der Tod des Iwan Iljitsch. Insel, Frankfurt am Main (Insel-Taschenbuch 18)
Verres R (1987) Ethische Probleme bei der Krebsvorsorge und der Krebsfrüherkennung im Lichte von Diskrepanzen zwischen Laientheorien und professionellen Theorien zur

Krebsbekämpfung. In: Schmähl D, Erhart H (Hrsg) Ethik in der Behandlung Krebskranker. Zuckschwerdt, München

Verres R (1994) Die Kunst zu leben – Krebsrisiko und Psyche. Piper, München

Verres R (1997) Straight talking about cancer. Duty or danger? In: Surbone A, Zwitter M (eds) Communication with the cancer patient. Information and truth. Ann N Y Acad Sci 809: 367–381

Vachon MLS (1987) Occupational stress in the care of critically ill, the dying and bereaved. Hemisphere Publ, New York

Wilkes E (1984) The »quality of life«. In: Doyle D (ed) Palliative care: The management of far advanced illness. Charles Press, Philadelphia, pp 9–19

Wolf E (1987) Die Aufklärungspflicht des onkologisch tätigen Arztes: Rechtliche Beurteilung unter besonderer Berücksichtigung der klinischen Prüfung. Onkologischer Service Lederle, Wolfratshausen (7. Ausg.)

4 Schmerztherapie und Symptomkontrolle in der Palliativmedizin

E. Klaschik

4.1 Häufigkeit von Schmerzen bei Patienten mit Tumorerkrankungen

In Deutschland erkranken jährlich ca. 400.000 Menschen neu an einer Tumorerkrankung [8]. Die Mehrzahl der Patienten wird im Verlauf der Erkrankung an Schmerzen unterschiedlicher Intensität leiden. In der Frühphase einer Tumorerkrankung berichten etwa 20–50%, im fortgeschrittenen Stadium etwa 55–95% der Patienten über Schmerzen [13, 199].

Für Deutschland ergibt sich, dass ca. 220.000 Menschen an einem Tag behandlungsbedürftige Tumorschmerzen haben [81]. Diese Patienten könnten in der Mehrzahl (90%) relativ einfach erfolgreich schmerztherapeutisch behandelt werden [216]. Dieser positiven Aussage steht aber die traurige Realität gegenüber, dass Patienten immer noch unterversorgt sind [218]. Die tägliche klinische Erfahrung dieses Defizits, die bei Aufnahmen von Patienten mit Schmerzen gemacht wird, ist auch im Jahr 2005 noch weit entfernt von den positiven Schlussfolgerungen im Arzneiverordnungsreport 2002 [182].

4.2 Ursachen von Schmerzen bei Tumorpatienten

Bereits 1953 hat der amerikanische Schmerztherapeut Bonica [13] folgende Ursachen von Karzinomschmerzen aufgeführt:

- Kompression von Nervenwurzeln, -stämmen oder -plexus,
- Fraktur angrenzender Knochen durch Metastasen,

- Infiltration von Nerven oder Gefäßen, die zur Reizung sensorischer Nervenendigungen führt,
- Verlegung eines Hohlorganes (Darm- oder Urogenitaltrakt),
- Verschluss eines arteriellen oder venösen Gefäßes,
- Infiltration und Schwellung von Geweben, die von Faszien eng umschlungen sind, Periost oder anderen schmerzempfindlichen Strukturen,
- Nekrosen benachbarter Tumormassen mit Infiltration schmerzempfindlicher Strukturen.

Twycross [199], Bonica [13] und andere Schmerztherapeuten haben folgende Unterteilung der Zuordnung von Schmerzen bei Tumorpatienten vorgenommen:

1. **Tumorbedingte Schmerzen:** Darunter sind weitgehend die angegebenen Ursachen einzuordnen (60–90% der Tumorschmerzpatienten).
2. **Therapiebedingte Schmerzen:** Diese Schmerzen (10–25% der Tumorpatienten) sind Folgen der Tumortherapie. So führen
   - Operationen evtl. zu Nervenschädigungen, Lymphödem u. a.,
   - Chemotherapien evtl. zu Neuropathien, Mukositis u. a.,
   - Bestrahlungen evtl. zu Nervenschädigungen, Fibrose u. a.
3. **Tumorassoziierte Schmerzen:** Diese Schmerzen (5–20% der Tumorschmerzpatienten) treten häufig in Begleitung einer Tumorerkrankung auf. Dazu gehören
   - postzosterische Neuralgie,
   - Venenthrombosen u. a.
4. **Tumorunabhängige Schmerzen:** Darunter sind alle weiteren Schmerzsyndrome (3–10% der Tumorschmerzpatienten) zu verstehen, die unabhängig vom Tumorgeschehen durch eine Vielzahl von Erkrankungen oder Ereignissen hervorgerufen werden können, d. h. alle Formen von Kopfschmerzen, Schmerzen des Bewegungsapparates, gastrointestinale Schmerzen und viele andere mehr. Um über eine Arbeitsdiagnose hinaus zu einer definitiven Diagnose zu kommen, ist abhängig vom Krankheitsstadium neben der Anamnese und der körperlichen Untersuchung eine weiterführende Diagnostik (z. B. Röntgen, Sonographie, Computertomographie, Kernspintomographie, Szintigraphie u. a.) indiziert.

4.3 Pathophysiologie der Schmerzen

Wir unterscheiden zwischen nozizeptiven und neuropathischen Schmerzen (s. Übersicht) [84].

Nozizeptorschmerzen entstehen durch direkte Irritation von Schmerzrezeptoren.

Von **somatischen** Nozizeptorschmerzen sprechen wir, wenn die Nozizeptoren der Haut, Skelettmuskulatur, Sehnenfaszien, Gelenke u. a. erregt werden. Oberflächliche Schmerzen sind im Gegensatz zu den tiefer liegenden Schmerzen gut lokalisierbar, scharf begrenzt und stechend.

Viszerale Nozizeptorschmerzen entstehen durch Reizung von Schmerzrezeptoren in den inneren Organen des Brust-, Bauch und Beckenraumes. Sie sind in der Regel schlecht lokalisierbar, drückend, ziehend und werden häufig auf Dermatome übertragen.

Neuropathische Schmerzen kommen durch eine Kompression oder Irritation peripherer Nerven (z. B. Neurom), eines Spinalganglions (z. B. Wurzelkompression), des Rückenmarkes oder im Thalamus (z. B. nach apoplektischem Insult) zustande. Bei Beteiligung des vegetativen Nervensystems kann eine mehr peripher oder mehr zentral ausgelöste sympathische Reflexdystrophie auftreten.

Schematische Darstellung der Pathophysiologie von Schmerzen

- nozizeptiv
  - somatisch
  - viszeral
- neuropathisch
  - überwiegend zentral
    - Deafferenzierung
    - sympathisch
  - überwiegend peripher
    - Mononeuropathie
    - Polyneuropathie
    - sympathisch

Ein Deafferenzierungsschmerz ist ein neuropathischer Schmerz, der nach partieller oder kompletter Durchtrennung des afferenten Nervensystems

entstehen kann (z. B. Phantomschmerz, Ausriss zervikaler Wurzeln, Engpasssyndrome u. a.).

Neuropathische Schmerzen werden überwiegend von zwei unterschiedlichen Beschwerdebildern geprägt. In ihrer neuralgiformen Variante sind die Schmerzen einschießend, schneidend, stechend und attackenweise auftretend. Die zweite Erscheinungsform ist durch einen Dauerschmerz gekennzeichnet, der als brennend und bohrend beschrieben wird. Er geht meist mit Dys- und Hyperästhesie einher.

4.4 Ursachen einer unzureichenden Schmerztherapie

Die Sicherstellung einer guten Tumorschmerztherapie ist ein weltweit ungelöstes Problem. Dies liegt zum einen an der Nichtverfügbarkeit verschiedener Arzneimittel in vielen Ländern der Erde. Aber selbst in den Staaten, in denen alle Substanzen – inkl. der starken Opioide – verschrieben werden können, ist man von einer zufrieden stellenden Lösung weit entfernt. Zudem gibt es erhebliche Unterschiede in der Qualität der Tumorschmerztherapie. Länder wie Großbritannien, Frankreich, Kanada, die Vereinigten Staaten, die skandinavischen Länder, Australien und Neuseeland haben das Problem früher erkannt und konsequenter zu lösen versucht als Deutschland.

Es steht außer Zweifel, dass in den letzten Jahren die Opioidverordnungen deutlich zugenommen haben [12, 90]. So stieg der Morphinverbrauch pro 1 Mio. Einwohner in Deutschland von 7,3 kg im Jahr 1993 auf 18,9 kg im Jahr 2003 [103, 91]. Dieser erfreulichen Entwicklung steht aber die klinische Realität gegenüber, dass Patienten immer noch deutlich unterversorgt sind [221, 156]. Nachdenklich stimmt die Untersuchung von Lindena et al. [121], die nachweisen konnte, dass selbst die Ärzte, die die Betäubungsmittelrezepte besitzen und betäubungsmittelpflichtige Substanzen verschreiben, dies zu selten, d. h. v. a. nicht regelmäßig tun. Weiterhin zeigt diese Studie, dass die Opioiddosis nicht dem Schmerzniveau des Patienten angepaßt wird [121].

Eine weitere häufige Ursache einer unzureichenden Schmerztherapie ist die **fehlende Schmerzdiagnose.** Die Diagnose »Tumorschmerz« gibt lediglich den Hinweis, dass der diagnostizierende Arzt die Tumorerkrankung als Ursache der Schmerzen ansieht, klärt aber nicht, ob kausal- oder palliativtherapeutische Maßnahmen zur Tumorentfernung oder -verkleinerung (noch) sinnvoll sind oder ob eine symptomatische Schmerztherapie eingeleitet wer-

den muss. Die Diagnose »Tumorschmerz« gibt ebenfalls *keinen Hinweis auf die pharmakologische Beeinflussbarkeit des Schmerzes. Diese kann jeweils nur nach Klärung der Schmerzursache und der Pathophysiologie des Schmerzes eingeordnet werden.*

Oft erfolgt auch eine **Unterschätzung der Schmerzintensität.** Damit verbunden ist die Verschreibung nicht betäubungsmittelrezeptpflichtiger Opioide. Die Dosierung wird zu niedrig, und die Dosisintervalle werden zu lang gewählt (z. B. Metamizol dreimal täglich, d. h. alle 8 h) oder zu kurz (z. B. Morphin-Retardtablette alle 4 h).

Toleranzentwicklung und Abhängigkeitspotenzial gehören zu den Morphinmythen, die offensichtlich nur langsam bei Laien wie Professionellen abgebaut werden können.

Mit Sicherheit sind auch die mit der Morphinverschreibung verbundenen aufwändigen **betäubungsmittelrechtlichen Formalia** für die Unterversorgung von Patienten mit Tumorschmerzen verantwortlich zu machen.

Der **fehlende Einsatz von Begleitmedikamenten** ist eine weitere häufige Ursache inadäquater Schmerztherapie. Nur selten kann mit einer einzigen Substanz das Ziel der Schmerzfreiheit oder zumindest der deutlichen Schmerzreduktion erreicht werden.

Einer der schwerwiegendsten Gründe für eine fehlerhafte Schmerztherapie ist in der **Verschreibung von Analgetika nach Bedarf** zu sehen.

4.5 Einschätzung der Schmerzintensität

Schmerz ist ein duales Phänomen: Zum einen besteht es aus der subjektiven Wahrnehmung des Schmerzes, zum anderen aus der psychischen Reaktion des Patienten auf diese Wahrnehmung.

Aus Untersuchungen zum postoperativen Schmerz [111] wissen wir, dass Patienten trotz gleicher, körperlich begründbarer Schmerzursache (z. B. eine Laparotomie) postoperativ extrem unterschiedlich hohe Analgetikamengen benötigen, um eine zufrieden stellende Schmerzreduktion zu erhalten.

Da es keine objektiven Messkriterien für die Schmerzintensität gibt, erfolgt die Einschätzung durch:

- die Beschreibung des Schmerzes durch den Patienten,
- die Erfassung des Effektes einer vorangegangenen oder eingeleiteten Schmerztherapie,

- die klinische Beurteilung durch den Schmerztherapeuten,
- die Erfassung der Schmerzintensität auf einer visuellen oder numerischen Analogskala oder einer verbalen Ratingskala.

Zur Erfassung der subjektiven Schmerzintensität hat sich die visuelle Analogskala (VAS) bewährt (Abb. 4.1). Der Patient markiert auf einer Skala die von ihm empfundene Schmerzintensität. Auf der Rückseite der Analogskala ist diese Strecke numerisch von 0 (= kein Schmerz) bis 10 (= stärkster vorstellbarer Schmerz) angegeben (Abb. 4.2). So kann man die vom Patienten markierte Stelle numerisch erfassen.

Abb. 4.1. Visuelle Analogskala zur Schmerzintensitätserfassung

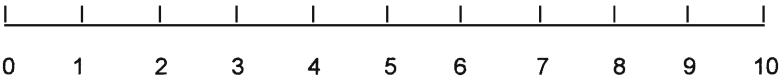


Abb. 4.2. Numerische Analogskala zur Schmerzintensitätserfassung

4.6 Schmerztherapie

4.6.1 Kausale Schmerztherapie

Sind die Schmerzen eines Patienten einer Tumorprogression zuzuordnen, muss – solange sinnvoll – kausal- oder palliativtherapeutisch eine Operation, Chemo-, Hormon-, Radioisotopen- oder Strahlentherapie in Betracht gezogen werden.

Die Beseitigung oder Verkleinerung eines Tumors führt in der Regel zu einer Abnahme der Schmerzintensität. Im fortgeschrittenen Stadium einer Tumorerkrankung muss man die Belastungen und Komplikationen solcher Maßnahmen sehr sorgfältig gegen ihren Nutzen abwägen. *Die Palliativmedi-*

zin schließt also solche therapeutischen Ansatzpunkte nicht aus; Voraussetzung ist aber, dass die Vorteile dieser Maßnahmen größer sind als deren potenzielle Nachteile.

Unter den oben aufgezählten therapeutischen Maßnahmen hat die Strahlentherapie auch unter palliativmedizinischen Gesichtspunkten einen sehr hohen Stellenwert.

Wenn Patienten mit Tumorerkrankungen Schmerzen haben, muss – in welchem Tumorstadium sie sich auch befinden – eine adäquate analgetische Therapie durchgeführt werden.

4.6.2 Symptomatische Schmerztherapie

Nichtinvasive Verfahren

Orale Arzneimittelgabe

[1, 5, 6, 10, 12, 18, 20, 24, 28–31, 33, 40, 42, 50, 55, 57–61, 65, 66, 70, 68, 69, 75, 77, 89, 93, 96, 112, 114, 132, 136, 138, 142–145, 149–151, 158, 159, 162, 173, 177, 188, 200, 201, 208, 212, 217, 220]

Weltweit wird akzeptiert, dass 90% der Tumorschmerzpatienten durch eine orale medikamentöse Applikationsweise ausreichend schmerzreduziert werden können. Die orale Schmerztherapie ist die Methode der Wahl und gilt heute als Referenzverfahren. Zu den Grundregeln der medikamentösen Therapie chronischer Schmerzen gehören neben der oralen Applikationsform die regelmäßige Einnahme nach einem festen Zeitschema (nach der Wirkungsdauer der jeweiligen Zubereitung), die individuelle Dosierung, die kontrollierte Dosisanpassung, die Gabe der Medikamente nach dem Prinzip der Antizipation und die Prophylaxe von Nebenwirkungen durch Begleitmedikamente.

Das Prinzip der Antizipation bedeutet, dass die nächste Medikamentengabe erfolgen muss, bevor der schmerzstillende Effekt der vorangegangenen Applikation aufgebraucht ist und bevor der Patient spürt, dass eine weitere Analgetikagabe notwendig ist. Nur auf diese Weise ist es möglich, die Erinnerung an und die Furcht vor dem Schmerz auszulöschen.

Werden diese Grundregeln nicht eingehalten, ist die Schmerztherapie zum Scheitern verurteilt. Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass die orale Schmerztherapie nicht konsequent genug durchgeführt wird. Viele Ärzte nehmen Nebenwirkungen und Komplikationen invasiver destruktiver Verfahren in Kauf, ohne die Möglichkeiten der oralen Therapie ausgeschöpft zu haben.

Ursachen einer unzureichenden Schmerztherapie

- Falsche Schmerzdiagnose
- Unterschätzung der Schmerzintensität
- Verschreibung »nach Bedarf«
- Verzicht auf starke Opioide
- Dosierung zu niedrig
- Vorurteile gegenüber den Opioiden, z. B. Angst vor physischer und psychischer Abhängigkeit
- Falscher Applikationsweg
- Verzicht auf Begleitmedikamente

Ziel der Initialbehandlung ist eine deutliche Schmerzlinderung in den ersten 24–48 h und die Gewährleistung einer guten Nachtruhe.

Im Laufe der Behandlung wird der Analgetikaspiegel gegen den Schmerz des Patienten titriert, wobei die Dosis nach und nach soweit erhöht wird, bis der Patient ausreichend schmerzreduziert ist. Selbst ein erfahrener Schmerztherapeut unterschätzt in der Regel zu Beginn einer Schmerztherapie das Schmerzpotential.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Richtlinien zur Therapie von Patienten mit Tumorschmerzen erarbeitet, die inzwischen allgemein anerkannt sind.

Nach dem **Stufenschema der WHO** (◘ Abb. 4.3 [210, 211]) beginnt eine regelmäßige Analgetikagabe bei einem niedrigen Schmerzpotential mit der Applikation von nichtopioidhaltigen (»peripheren«) Analgetika.

Ist dadurch keine zufrieden stellende Analgesie zu erreichen, ist zusätzlich ein schwach zentralwirkendes Opioid indiziert. Wegen ihrer unterschiedlichen Wirkorte hat sich die Kombination von nichtopioidhaltigen und opioidhaltigen Analgetika bewährt.

Ist auch bei gleichzeitiger Gabe von Begleitmedikamenten der erzielte analgetische Effekt unzureichend, so ist der Übergang auf ein stark wirkendes Opioid erforderlich. Die Basismedikation von nichtopioidhaltigen Analgetika wird in der Regel beibehalten. In allen Phasen der Schmerztherapie werden Begleitmedikamente eingesetzt und können bei Bedarf mit physikalischen Maßnahmen ergänzt werden; d. h. die Tumorschmerztherapie ist praktisch

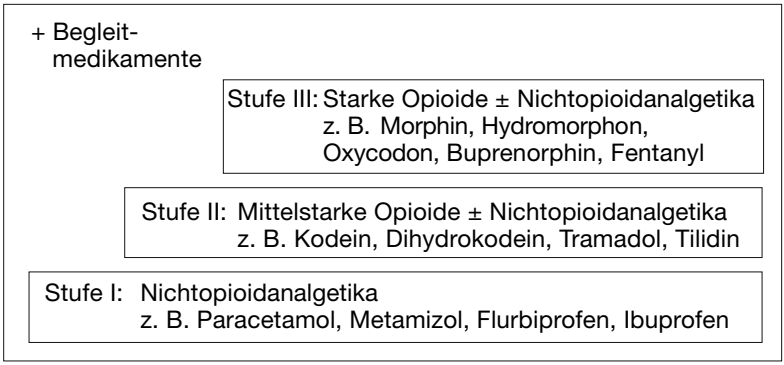


Abb. 4.3. WHO-Stufenplan [210, 211]

immer eine Kombinationstherapie aus Monosubstanzen, evtl. mit unterstützenden weiteren Maßnahmen.

Bei nicht beherrschbaren Schmerzzuständen ist eine evtl. hochdosierte Neuroleptikagabe in Kombination mit Morphin als Ultima Ratio indiziert (dies ist nur sehr selten notwendig).

Es besteht heute weitgehend Einigkeit, dass das Stufenschema der WHO kein starrer Plan ist [103, 192], in dem jede Stufe von unten nach oben durchlaufen werden müsste. So richtet sich der Einsatz der Substanzen nach der Schmerzursache und der Pathophysiologie des Schmerzes. Mittelstarke Opioide werden am ehesten bei viszeralen Nozizeptorschmerzen zum Einsatz kommen, während bei somatischen Nozizeptorschmerzen und neuropatischen, neuralgiformen und dysästhetischen Schmerzen praktisch immer starke Opioide – neben Nichtopioidanalgetika und Koanalgetika – indiziert sind.

Weitere Einzelheiten der in der Schmerztherapie verwendeten Pharmaka in ▶ Kap. 4.7: »Arzneimittel«.

Alternativen zur oralen Arzneimittelgabe

Als Variante der oralen Applikation kann die **sublinguale** Gabe angesehen werden. Sie hat dort ihren Vorteil, wo aufgrund von Passagehindernissen im Ösophagus oder Schluckstörungen Tabletten und Tropfen nicht mehr geschluckt werden können.

Die **intranasale** Applikation kurz wirksamer, starker Opiode ist möglicherweise eine Methode der Zukunft, um plötzlich auftretende starke Schmerzen schnell zu durchbrechen [190]. Diese Applikationsform ist für starke Opiode noch nicht zugelassen. Seit einiger Zeit ist ein oral-transmukosales therapeutisches System (o-TTS) zur Behandlung von Durchbruchschmerzen im Handel, das einen schnellen Wirkungseintritt – innerhalb von 5 min – hat.

Die **rektale** Gabe von Opioiden [131] ist als passagere Lösung anzusehen, wenn eine orale Medikamenteneinnahme vorübergehend oder dauerhaft nicht mehr möglich ist. Um die vierstündliche Einführung der Morphinsuppositorien zu umgehen, ist es möglich, die Morphin-Retardtabletten in einer Gelatinekapsel rektal zu applizieren. Die Bioverfügbarkeit und der Retardeffekt der Morphintabletten gehen dadurch nicht verloren, sodass ein Zeitintervall von 12 h eingehalten werden kann.

In Großbritannien wurde schon vor Jahren die Anwendung von Morphin **per inhalationem** eingehend untersucht [54]. Die in diese Methode gesetzten Hoffnungen konnten nicht erfüllt werden. Morphin ist zwar auch auf diesem Wege wirksam gegen Schmerzen und Dyspnoe, das Nebenwirkungsspektrum gegenüber der oralen Gabe aber unverändert bei gleichzeitig kurzer Wirkdauer von 4 h.

Die transdermale Opioidapplikation ist bei guter Patientencompliance eine sinnvolle Ergänzung [44, 215]. Indikationen sind Schluckstörungen (Umgehung des Gastrointestinaltraktes), Ileussymptomatik, therapieresistente Nebenwirkungen oraler Opioide und evtl. vor dem Einsatz invasiver Methoden bei einem mäßig starken Tumorschmerz mit stabilem Schmerzniveau.

Die **transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS)** geht in ihrer Wirksamkeit bei einem tumorbedingten Schmerzsyndrom über den Plazeboeffekt nicht hinaus. Deswegen sollte sie hier nicht eingesetzt werden. Für nichttumorbedingte Schmerzen gelten die allgemein anerkannten Indikationen, z. B. Phantom- und Stumpfschmerzen, chronische Rückenschmerzen, Spannungskopfschmerz u. a.

Physiotherapeutische Maßnahmen als Begleittherapie tumorbedingter Schmerzen haben einen hohen Stellenwert und sollten deshalb großzügig eingesetzt werden.

Invasive Verfahren

Nichtdestruktive Methoden

Die Notwendigkeit, eine orale Schmerztherapie abzubrechen, ergibt sich am häufigsten

- bei Schluck- und Passagestörungen, also bei Gesichts- oder Ösophagus- sowie stenosierenden Magen-Darm-Karzinomen;
- bei Patienten mit therapie- oder tumorbedingten Begleitsymptomen wie Übelkeit und Erbrechen;
- bei unzureichender Analgesie unter der eben noch verträglichen Dosis;
- bei nicht mehr tolerablen, dosisabhängigen Nebenwirkungen.

Die **subkutane** Opioidapplikation [36] ist ein einfaches und sicheres Verfahren, das bei chronischen Schmerzen in Form von Bolusgaben durch das Krankenpflegepersonal oder angeleitete Laien durchgeführt werden kann. Über Pumpensysteme (es gibt ein großes Angebot sehr unterschiedlicher Geräte) können konstante Flussraten und/oder vom Patienten gesteuerte Bolusgaben gewählt werden. Die Flussrate für die subkutane Applikation sollte nicht über 5 ml/h liegen. Eine subkutan gelegte Butterflynadel kann 5–7 Tage benutzt werden.

Die Umrechnung einer oralen Morphindosis zur subkutanen erfolgt im Verhältnis 2 : 1 (oral : subkutan).

Die **intravenöse** Analgetikazufuhr ist immer dann sinnvoll, wenn die Volumina für eine subkutane Gabe zu hoch sind, schmerzhafte Interventionen geplant sind oder eine parenterale Flüssigkeitszufuhr notwendig ist. Für einen längeren Zeitraum ist ein untertunnelter und mit einem Portsystem verbundener zentralvenöser Katheter zweckmäßig.

Bei sehr starken Schmerzen (»Schmerznotfall«) ist die intravenöse Opioidgabe die Therapie der Wahl; Morphin wird so lange 1- bis 2-mg-weise titriert (in kurzen Abständen), bis eine deutliche Schmerzlinderung eintritt. In dieser Phase muss der Patient intensiv überwacht und die Schmerzreduktion in Relation zu den Nebenwirkungen (abnehmende Vigilanz und Atemfrequenz) beobachtet werden. Anschließend kann auf die orale Gabe umgestellt werden.

Die Umrechnung der intravenösen Morphindosis zur oralen erfolgt im Verhältnis 3 : 1 (oral: intravenös).

Grundsätzlich sollte man festhalten, dass die Schmerztherapie für den Patienten *einfach* gestaltet werden sollte; nicht die Virtuosität komplizierten

Denkens und Handelns ist entscheidend, sondern die einfache, für den Patienten verständliche, nachvollziehbare und erfolgreiche Schmerztherapie.

Wurde bei einem Patienten aufgrund seiner Krankheitssituation eine PEG-Sonde gelegt, können die Morphinkapseln geöffnet werden und die Morphingranula über die PEG-Sonde eingeschwemmt werden. Dabei ist zu beachten, dass die Sonde einen Durchmesser von 15 Charr haben sollte. Zum Einschwemmen der Granula auf keinen Fall Wasser verwenden, sondern dies mit einer Sondennahrung vornehmen. Anschließend sollte mit Wasser nachgespült werden.

Seit Februar 1997 gibt es ein Morphin-Retardgranulat, das sich als Morphintrinksuspension besonders gut für diese Applikationsweise eignet. In Wasser aufgelöst, kann es auch durch dünne Sonden gegeben werden.

Die Entdeckung, dass rückenmarknah [43, 87, 178, 214] und intraventrikulär applizierte Opioide [100, 214] eine gute und langanhaltende Schmerzunterdrückung bewirken, führte zu periduralen, spinalen und intraventrikulären Kathetertechniken [107, 146, 155]. Indikationen für die Durchführung rückenmarknaher Opioidapplikationen sind eine unzureichende systemische Schmerztherapie, therapieresistente Nebenwirkungen bei systemischer Arzneimittelgabe, eine tumorbedingte Ileussymptomatik oder als Zeit überbrückende Maßnahme, bis andere Therapieverfahren (z. B. eine Bestrahlung) »gegriffen« haben.

Die Entscheidung, ob bei der rückenmarknahen Opioidgabe die epidurale oder intrathekale Applikation gewählt werden soll, hängt u. a. von der Lebenserwartung des Patienten ab (Tab. 4.1). Liegt diese unter drei Monaten, wird man dem Periduralkatheter den Vorzug geben, bei einer längeren Lebenserwartung ist die Anlage eines intrathekalen Katheters mit subkutanem Portsystem das Verfahren der Wahl. Nachteile des Periduralkatheters sind eine höhere Störanfälligkeit und die Entstehung von Fibrosierungen, die die Diffusionsverhältnisse verändern oder durch Septierung partiell unwirksam werden können [64, 141, 155].

Andererseits können die periduralen Opioide mit Lokalanästhetika kombiniert werden. Dies ist zwar bei intrathekaler Katheterlage ebenfalls möglich, die Risiken dieser Applikation sind aber so hoch anzusetzen, dass dies nur in Abteilungen mit ausreichender Erfahrung vertretbar ist. Weitere Risiken einer intrathekalen Opioidgabe über Kathetertechniken sind die Liquorfistel und aufsteigende Infektionen. Die Gefahr einer Infektion besteht auch bei einer periduralen Opioidgabe; zur Reduktion dieser Komplikation sollte bei

längerer Liegezeit der Katheter untertunnelt werden. Die Implantation eines subkutanen Ports mit Anschluss an den Katheter sollte Standard sein, wenn die Indikation für die peridurale Anwendung gegeben ist und die Lebenserwartung des Patienten wenigstens einige Monate beträgt.

Es gibt inzwischen eine große Anzahl unterschiedlicher Kathetersysteme, Ports und Pumpen, auf die nicht im Einzelnen eingegangen werden kann. Die ◘ Tab. 4.1 und 4.2 geben Auswahlkriterien für die Implantationstechnik und Applikationsweise bzw. Dosisempfehlungen rückenmarknaher Opioide an. In der Übersicht sind Kontraindikationen und Nebenwirkungen dieser Applikationsform aufgeführt:

◘ **Tab. 4.1.** Auswahlkriterien für die Implantationstechnik und Applikationsweise rückenmarknah verabreichter Opioide

Lebenserwartung	Technik	Applikation
<3 Monate	PDK	Bolus oder externe Pumpe mit Dauerinfusion
3–6 Monate	PDK/SK + Portsystem	Bolus oder externe Pumpe mit Dauerinfusion
>6 Monate	Pumpsystem	kontinuierliche Gabe

◘ **Tab. 4.2.** Rückenmarknahe Applikation von Morphin

	Bolusdosis [mg]	Wirkdauer [h]
peridural		
initial	3–5	12 (1–96)
später	bis zu 150	
intrathekal		
initial	1–2	12 (1–40)
später	bis zu 50	

Kontraindikationen rückenmarknaher Opioidanalgesie

- lokale Infektionen
- Gerinnungsstörungen
- spinale Metastasen

Nebenwirkungen rückenmarknaher Opioidanalgesie

- Übelkeit/Erbrechen 17%
- Miktionsstörungen 10%
- Juckreiz 1–2%
- Atemdepression extrem selten

Die **intraventrikuläre** Opioidgabe kann in Ausnahmefällen indiziert sein. Dies ist der Fall bei unzureichender oraler, parenteraler, periduraler oder spinaler Schmerztherapie und wenn lokale Verfahren nicht erfolgreich waren oder nicht indiziert sind. Nach Zech [216] werden die besten Ergebnisse bei Tumoren im Kopf-, Gesichts- und Nackenbereich, bei Weichteilinfiltration der oberen Extremitäten und des oberen Thorax sowie bei diffuser Knochenmetastasierung erzielt. Die initialen Tagesdosen betragen 0,25–0,5 mg (0,1–4 mg) Morphin. Später liegen die Tagesdosen im Mittel bei 10 mg. Tagesdosierungen bis 36 mg [216] sind beschrieben.

Die Nebenwirkungsrate intraventrikulär applizierten Morphins ist relativ hoch; dies sind Übelkeit, Erbrechen, Vigilanzstörungen, Halluzinationen, Infektionen und v. a. Atemdepressionen (4%), besonders in der Einstellungsphase. Weitere Probleme, wie Leckage an der Einstichstelle oder Verstopfung des Katheters, kommen vor. Die Patienten müssen deswegen initial intensiv überwacht werden.

Invasive Techniken machen in der Tumorschmerztherapie aber nur einen sehr geringen Prozentsatz aus.

Nervenblockaden mit Lokalanästhetika spielen bei tumorbedingten Schmerzen eine untergeordnete Rolle. Ihr Stellenwert ist dort gegeben, wo diagnostische Blockaden zur Differenzierung zwischen somatischen und viszeralen Schmerzen beitragen. Darüber hinaus kann eine Blockade mit Lokalanästhetika eine Aussage darüber ermöglichen, ob eine Neurolyse des entsprechenden Gebietes zu einer ausreichenden Schmerzreduktion führen würde.

Zu den **Elektrostimulationsverfahren** gehören:
- transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS),
- Hinterstrangstimulation (Dorsal Column Stimulation, DCS) = Epidurale Spinale Elektrostimulation (ESES),
- Hirnstimulation (Deep Brain Stimulation, DBS).

Alle drei Verfahren haben bei tumorbedingten Schmerzen einen geringen Stellenwert. Bei therapiebedingten Schmerzen (z. B. nach Amputation) oder chronischen nichttumorbedingten Schmerzen (z. B. umschriebene Muskelschmerzen) ist der Einsatz der TENS sinnvoll.

Während die DCS bei Phantom- und Ischämieschmerzen, inkompletten Plexusläsionen und anderen inkompletten Nervenläsionen sowie der sympathischen Reflexdystrophie [197] einen Stellenwert hat, ist die DBS bei inkurablen Gesichtsschmerzen und Deafferenzierungsschmerzen in die therapeutischen Überlegungen mit einzubeziehen [213].

Destruktive Methoden

Die Abnahme der Indikationen für invasive destruktive Techniken ist in der Verbesserung der oralen und rückenmarknahen Schmerztherapie mit Opioiden zu sehen und in der Tatsache, dass neurodestruktive Verfahren
- zeitlich begrenzt wirken,
- nicht immer erfolgreich sind und
- zu einem hohen Prozentsatz Nebenwirkungen oder Komplikationen auslösen.

Neurolytische Blockaden werden zur Therapie starker Tumorschmerzen seit über 50 Jahren durchgeführt. Dem Vorteil, durch chemische Zerstörung von Schmerzen mit einer einmaligen Behandlung und ohne systemische Nebenwirkungen eine gute Schmerzreduktion zu erzielen, steht eine Reihe von Nachteilen [67, 78] gegenüber:
- Die Wirkung ist lokal begrenzt.
- Die Wirkung ist durch regenerative Prozesse oder Tumorwachstum zeitlich begrenzt. Im Mittel hält eine neurolytische Blockade 3–6 Monate, die Variation liegt zwischen Stunden und Monaten.
- Es werden gleichermaßen sensible, motorische und vegetative Anteile des Nerven zerstört.

- Nach einer Neurolyse können eine Alkoholneuritis oder durch Deafferenzierung starke, nur schwer zu therapierende Schmerzsyndrome auftreten.

Diese Nachteile haben dazu geführt, dass zunächst mit den am wenigsten invasiven und sichersten Methoden begonnen wird. So kommen nichtdestruktive vor destruktiven Methoden zum Einsatz.

Die Indikation zu einer Neurolyse sollte nur gestellt werden, wenn

- ein fortgeschrittenes Stadium einer Tumorerkrankung vorliegt,
- die Lebenserwartung begrenzt ist (6–12 Monate),
- andere Verfahren (Pharmakotherapie, Radiatio) erfolglos waren.

Von der Vielzahl möglicher neurolytischer Blockaden haben heute in der Tumorschmerztherapie nur noch wenige Bedeutung, darunter die Neurolyse des Plexus coeliacus. Eine Neurolyse ist bei viszeralen Oberbauchschmerzen [67] indiziert; d. h. bei Tumoren oder Metastasen im Pankreas, Magen, der Leber, dem Colon ascendens oder Colon transversum, den Nieren, den Gallenwegen, distalem Ösophagus, Lymphomen des Oberbauches.

Die Wirkungsdauer einer Plexus-coeliacus-Neurolyse beträgt Wochen bis Monate und kann bei Wiederkehren von Schmerzen wiederholt werden. Sind allerdings somatische Strukturen befallen, ist diese Neurolyse allein nicht ausreichend.

Neben der Plexus-coeliacus-Neurolyse gibt es in seltenen Fällen die Indikation zu einer intrathekalen Neurolyse, zur Neurolyse des Grenzstranges bei viszeralen Schmerzen im Becken und Unterbauch sowie Neurolysen im Trigeminusbereich.

Untersuchungen von Grond et al. [67-70] zum Stellenwert neurolytischer Blockaden bei Tumorpatienten zeigten, dass die Neurolyse des Plexus coeliacus und die intrathekale sakrale Neurolyse bei den meisten Patienten (87%) nur zu einer mäßigen Schmerzreduktion führten, sodass in der Regel weiterhin eine medikamentöse Schmerztherapie notwendig war. Die Schmerzreduktion war auf 7–36 Tage bei der Coeliacusneurolyse bzw. 1–84 Tage bei der Sakralneurolyse begrenzt.

Neben der chemischen Neurolyse mit Alkohol oder Phenol ist auch eine Neurolyse durch Kälteanwendung (Kryoanalgesie) möglich. Bei einer Sondentemperatur von -65 bis -80° C werden bei diesem Verfahren die Nerven-

fasern bei intakter Nervenmembran zerstört [122]. Die Indikation zu einer Kryoanalgesie kann großzügiger gestellt werden als zu einer chemischen Neurolyse, da eine Restitutio ad integrum eintritt [216].

Die destruktiven **neurochirurgischen Verfahren** besitzen heute in der Therapie chronischer tumorbedingter Schmerzen nur noch einen geringen Stellenwert.

In seltenen Fällen ist bei therapieresistenten Schmerzen im Arm (Schädigung des Armplexus nach Ablatio mammae, Pancoast-Tumor u. a.) eine selektive hintere Rhizotomie indiziert, bei der die nozizeptiven Fasern der Hinterwurzel durchtrennt werden.

Die Chordotomie (Durchtrennung des Tractus spinothalamicus) in Höhe von C1/C2 wird zur Schmerzausschaltung in der Schulter-Arm-Region, in Höhe des 3.–5. Brustwirbels zur Therapie von Schmerzen in der unteren Körperhälfte durchgeführt.

Komplikationen (Schlafapnoe, Paresen, Blasenentleerungsstörungen, schmerzhafte Dysästhesien) und häufig nur kurzzeitiger Therapieerfolg haben dazu geführt, dass die neurochirurgischen destruktiven Verfahren eine strenge Indikationsstellung erfordern und nur noch in Einzelfällen zur Anwendung kommen [216].

4.7 Arzneimittel

4.7.1 Nichtopioidanalgetika

Analgetika werden heute in die beiden Hauptgruppen Nichtopioidanalgetika und Opioide unterteilt [20, 71].

Die Begriffe »peripher« und »zentral« wirkende Analgetika sollten nicht mehr verwendet werden, da sowohl für die peripheren Analgetika zentrale Wirkeigenschaften nachgewiesen sind als auch für zentrale Analgetika periphere Wirkeigenschaften [219].

Nichtopioidanalgetika sind pharmakologisch von sehr unterschiedlicher Struktur, wobei im Wesentlichen unterschieden wird zwischen

- nichtsauren, antipyretischen Analgetika,
- sauren, antiphlogistisch-antipyretischen Analgetika und
- Analgetika ohne antipyretische und antiphlogistische Wirkung.

Tab. 4.3. Auswahl nichtopioidhaltiger Analgetika. Applikationsformen, Dosierung, Wirkdauer, Nebenwirkungen

	Stoffgruppe	Freiname (Handelsname)	Applikationsform			Einzeldosis	Analgetische Wirkdauer [h]	Maximal dosis/Tag Langzeittherapie	Nebenwirkungen Kontraindikationen
			oral	rektal	i.v.				
I. Saure antiphlogistische antipyretische Analgetika	Salizylate	Azetylsalizylsäure (Aspirin)	1 Tbl. = 500 mg		1 Inj.-Fl. = 500 mg	0,5–1 g	4	6 g	Gastrointestinale Störungen und Blutungen, allergische Reaktionen (Haut, Asthma)
	Arylpropionsäuren	Naproxen (Proxen)	1 Tbl. = 500 mg	1 Supp. = 250 mg = 500 mg		500 mg	12	1000 mg	Gastrointestinale Beschwerden
		Ibuprofen (Imbun)	1 Tbl. = 500 mg	1 Supp. = 500 mg	i.m. = 400 mg	500–1000 mg	8	2500 mg	Wie bei Flurbiprofen und Naproxen
	Arylessigsäuren Phenylessigsäure	Diclofenac (Voltaren)	1 Tbl. = 25 mg = 50 mg retard = 100 mg	1 Supp. = 50 mg = 100 mg	1 Amp. = 3 mg = 75 mg	25–100 mg	6–8	150 mg	Schwindel, Ohrensausen, Schwerhörigkeit Kontraindikationen: hämorrhagische Diathese, Magen-Darm-Ulzera
	Indole	Indometacin (Amuno)	1 Tbl. = 25 mg = 50 mg retard: 75 mg Sirup: 5 ml = 1 TL = 25 mg	1 Supp. = 50 mg = 100 mg		25–100 mg	8–12	150 mg	Kopfschmerz, Schwindel, Somnolenz, Psychose, Sehstörungen (Retina), Störungen der Hämatopoese

	Oxicame	Piroxicam (Felden)	1 Kaps. = 10 mg = 20 mg	1 Supp. = 20 mg	1 Amp. i. m. = 20 mg	initial 40 mg, dann 20 mg	24	20 mg	Gastrointestinale Störungen, Leukopenie, Nierenfunktionsstörungen, Phototoxizität
II. Nichtsaure antipyretische Analgetika	Anilinderivate	Paracetamol (Ben-u-ron)	1 Tbl. = 500 mg Saft: 5 ml = 1 TL = 200 mg	1 Supp. = 500 mg = 1 g		0,5–1 g	4	6 g	Leberschädigung; Kontraindikation: schwere Nierenfunktionsstörung, Saccharose-Intoleranz
	Pyrazolinone	Metamizol (Novalgin)	1 Tbl. = 20 Tr. = 500 mg	1 Supp. = 1 g	1 Amp. 2 ml = 1 g 5 ml = 2,5 g	0,5–1 g	4	6 g (–9 g)	Hautreaktionen, Schock, Leukopenie, Agranulozytose; Kontraindikation: akute hepatische Porphyrie, Glukose-6-Phospat-Dehydrogenase-Mangel, Niereninsuffizienz
	Selektive COX-II-Hemmer	Celecoxib (Celebrex)	1 Kps. = 100 mg = 200 mg			100–200 mg	12	400 mg	Weniger ausgeprägte gastrointestinale Toxizität [85], Ödeme, Langzeittherapie noch nicht ausreichend beurteilbar
III. Nichtopioidanalgetika ohne antipyretische und antiphlogistische Wirkung	Pyridylkarbamate	Flupirtin (Katadolon)	1 Kps. = 100 mg	1 Supp. = 75 mg = 150 mg		100–200 mg	(6–) 8	300–600 mg	Vigilanzstörungen, Unruhe, Bewegungsstörungen
	Benzoxazozine	Nefopam (Ajan)	1 Tbl. = 30 mg		1 Amp. = 20 mg	30–90 mg	(4–) 8	bis 270 mg	Herzfrequenz, Blutdruck, Schweißausbrüche, Vigilanzstörungen

Tab. 4.4. Wirkungsspektrum nichtopioidhaltiger Analgetika; + bis +++ zunehmende Wirkung, – keine Wirkung

Freiname	Handelsname, z. B.	Einzeldosis [mg]	Intervall [h]	Analgesie	Antiphlogistische Wirkung	Antipyrese	Spasmolytische Wirkung	Kommentar
Azetylsalizylsäure	Aspirin ASS-ratiopharm	500–1000	4	++	+	++	–	Verwenden wir wegen der gastrointestinalen Nebenwirkungen nicht
Paracetamol	Ben-u-ron	1000	4	+	–	++	–	Keine grastrointestinalen Nebenwirkungen. Vorsicht bei vorbestehenden Leberschäden, Tagesdosen nicht > 6 g wählen. Ausweichsubstanz, wenn Kontraindikationen zu Metamizol bestehen
Metamizol	Novalgin Novaminsulfon	500–1000	4	+++	(+)	+++	+	Leukopenie, Agranulozytose sehr selten; Anaphylaxie bei i.v. Gabe. *Wichtigstes Nichtopioidanalgetikum* in der Tumorschmerztherapie
Flupirtin	Katadolon	100–(200)	8	++	–	–	–	Muskelrelaxierende Wirkung; Einsatz bei neuropathischem Schmerz; sedierende Nebenwirkung

Für die praktische Durchführung der Schmerztherapie ist es sinnvoll, aus der großen Anzahl von Substanzen einige wenige aus jeder Substanzgruppe auszuwählen, um mit diesen wenigen Substanzen möglichst viel Erfahrung zu sammeln, da Wirkungen und Nebenwirkungen dieser Einzelsubstanzen besser beurteilt werden können. Dann kann systematisch die Therapie begonnen, die Dosis erhöht und evtl. das Arzneimittel gewechselt werden.

Eine Übersicht über das Wirkungsspektrum nichtopiodhaltiger Analgetika, Applikationsformen, Dosierung, Wirkdauer und Nebenwirkungen geben ◘ Tab. 4.3 und 4.4.

Nichtsaure, antipyretische Analgetika

Paracetamol

Der Mechanismus der analgetischen Wirkung von Paracetamol ist noch weitgehend ungeklärt. Angenommen wird eine periphere wie zentralnervöse Prostaglandinsynthesehemmung. Gleichwohl ist der analgetische Effekt von Paracetamol eher als gering einzustufen. Notwendige Tagesdosierungen von 6 g sollten nicht überschritten werden, da es durch Entstehen von Benzochinoniminen [219] zu Leberzellnekrosen kommen kann. Dosen über 10 g Paracetamol pro Tag führen bei Erwachsenen zu lebensbedrohlichen Leberschäden. Glutathionmangel (z. B. bei vorbestehenden Leberschäden) kann schon bei normaler Tagesdosis zum Leberversagen führen. Paracetamol hat *keine* antiphlogistische Wirkung.

Metamizol

Metamizol hat kaum eine antiphlogistische, dafür aber eine gute analgetische, antipyretische und spasmolytische Wirkung.

Metamizol hemmt direkt die Erregungsübertragung im nozizeptiven System [88] und aktiviert die vom periaquäduktalen Grau ausgehende Hemmung [96]. Wegen der Gefahr einer Agranulozytose ist Metamizol in einigen Ländern nicht verfügbar. Diese tritt meist nach i.v.-Gabe auf und imponiert zunächst als Tonsillitis oder Pneumonie, die in eine Sepsis übergehen können. Rechtzeitiges Absetzen von Metamizol und eine Antibiotikatherapie verhindern diesen Verlauf, da sich die Granulozyten rasch regenerieren.

Die Boston-Studie [14] erbrachte ein errechnetes Exzessrisiko von 1,1 : 1 Mio. Anwendungswochen. Die Exzessmortalität pro 1 Mio. Nutzer lag

für Diclofenac bei fast 600, für Metamizol und Paracetamol bei 25 bzw. 20. Das Risiko einer tödlichen gastrointestinalen Blutung lag bei 0,17 gegenüber 2,0 bei der Azetylsalizylsäure und 5,9 bei Diclofenac [32]. Anaphylaktoide Reaktionen sind nach oraler Gabe äußerst selten.

Aufgrund der guten allgemeinen und gastrointestinalen Verträglichkeit und der guten analgetischen Wirksamkeit ist Metamizol das wichtigste Nichtopioidanalgetikum in der Tumorschmerztherapie.

Saure, antiphlogistisch-antipyretische Analgetika (Non-Steroidal Antiinflammatory Drugs, NSAID)

Substanzen dieser Wirkgruppe sind in der Lage, die Prostaglandinsynthese aus der Arachidonsäure zu unterdrücken. An dieser Umwandlung ist ein Enzymsystem beteiligt, besonders die Zyklooxygenase. Deswegen werden die nichtsteroidalen Antiphlogistika auch Zyklooxygenasehemmer genannt [21].

Prostaglandine werden nicht nur im Rahmen von Entzündungen gebildet, sondern nehmen auch sonst im Körper regulatorische Funktionen wahr. So lassen sich charakteristische unerwünschte Arzneimittelwirkungen ableiten. Einerseits werden unabhängig von der Art der Applikation hohe Wirkstoffspiegel im entzündlichen Gewebe erreicht. Andererseits treten auch Anreicherungen im Magen-Darm-Trakt, in den Nieren, im Knochenmark und in der Leber auf.

Azetylsalizylsäure (ASS)

Azetylsalizylsäure gilt als Referenzsubstanz bei den Nichtopioidanalgetika; das liegt u. a. daran, dass die Azetylsalizylsäure weltweit im Handel ist, dagegen steht z. B. Metamizol in Schweden, Großbritannien oder den USA nicht zur Verfügung.

Während bei kurzfristiger Einnahme selten Nebenwirkungen auftreten, ist bei längerfristiger Einnahme mit zahlreichen Nebenwirkungen zu rechnen; im Vordergrund stehen die gastrointestinalen Nebenwirkungen. Diese treten trotz Magenschutzprophylaxe bei notwendigen Dosierungen von 4–6 g pro Tag nach einigen Wochen so häufig auf, dass wir die Azetylsalizylsäure praktisch nicht einsetzen.

Arylessigsäuren, Arylpropionsäuren, Ketoenolsäuren

Substanzen dieser heterogenen Gruppen stammen von organischen Säuren ab. Wie die Azetylsalizylsäure besitzen sie neben dem peripheren Wirkmechanismus auch zentral wirksame Eigenschaften, weil sie ebenfalls hemmend auf die Prostaglandinsynthese im ZNS wirken. Es gilt heute als gesichert, dass die Hauptaktivität der sauren Nichtopioidanalgetika in der Normalisierung der erhöhten Empfindlichkeit der Nozizeptoren im geschädigten Gewebe liegt [86]. Nebenwirkungen dieser Substanzen betreffen v. a. den Gastrointestinaltrakt (besonders Ulkusbildung), die Nieren (Niereninsuffizienz) und das ZNS (Vigilanzminderungen).

Von den Arylessigsäuren hat Diclofenac die weiteste Verbreitung gefunden, bei den Arylpropionsäurederivaten Ibuprofen (Tab. 4.4).

Nichtopioidanalgetika ohne antipyretische und antiphlogistische Wirkung

In diese Gruppe gehören Flupirtin und Nefopam. Sie hemmen die Prostaglandinsynthese nicht und haben keine oder nur geringe antipyretische und antiphlogistische Wirkungen [150].

Flupirtin

hat eine mittelstarke analgetische und zentral muskelrelaxierende Wirkung.

Flupirtin soll über die Erhöhung der neuronalen Kaliumpermealibität zu einer Hyperpolarisation und damit zu einer verminderten nozizeptiven Stimulierbarkeit führen. Die mittlere Tagesdosis liegt bei 300 mg, verteilt auf drei Einzeldosen. Die Tageshöchstdosis liegt bei 600 mg [219, 20, 88]. Nebenwirkungen sind zentrale und gastrointestinale Störungen (Müdigkeit, Übelkeit, Obstipation, Diarrhö) und Mundtrockenheit.

Nefopam

ist ein mittelstark wirkendes Analgetikum. Der Wirkmechanismus besteht wahrscheinlich in einer Beeinflussung des noradrenergen und serotogenen absteigenden schmerzhemmenden Systems [150].

Die Einzeldosis beträgt 30–60 mg alle 8 h. Häufige Nebenwirkungen sind Übelkeit, Erbrechen, Schweißausbrüche, zerebrale Beeinträchtigung, Tachykardie, Hypertonie und Mundtrockenheit.

4.7.2 Opioidanalgetika

Wirkung

Die Wirkungen der Opioide werden über spezifische Rezeptoren (Opioidrezeptoren) im Körper vermittelt [29], die peripher, besonders aber spinal (Substantia gelatinosa) und supraspinal (limbisches System, periaquäduktales Grau, Medulla oblongata) zu finden sind [92, 88].

Opioide bewirken über Rezeptorinteraktion eine

- Hemmung der aszendierenden Schmerzleitung auf der Ebene der Umschaltung im Rückenmark,
- Aktivierung des deszendierenden schmerzmodulierenden Systems,
- Hemmung der Schmerzausbreitung im Hirnstamm und Thalamus sowie Linderung des Schmerzerlebens durch Wirkungen im limbischen System [92].

Darüber hinaus wurde auch eine peripher analgetische Wirksamkeit der Opioide nachgewiesen [82].

Unter Opioiden verstehen wir alle Substanzen, die an Opioidrezeptoren wirksam werden, wobei bezüglich ihrer Wirkungen die Opioide in Agonisten, partielle Agonisten, Agonist-Antagonisten und Antagonisten unterschieden werden.

Die meisten im klinischen Einsatz befindlichen Opioide sind, wie z. B. das Morphin, reine Agonisten. Buprenorphin ist ein partieller Agonist, während Pentazocin ein Vertreter der Agonist-Antagonisten ist. Ein reiner Antagonist ist das Naloxon; es wirkt an den μ-, κ- und δ-Rezeptoren antagonistisch. Der δ-Rezeptor wird heute nicht mehr als Opioidrezeptor klassifiziert; über ihn werden halluzinogene und kardiostimulierende Effekte vermittelt [86].

Partielle Agonisten und Agonist-Antagonisten besitzen einen Ceilingeffekt, d. h. nach Erreichen eines Wirkungsmaximums führt eine weitere Dosissteigerung zu keiner weiteren Zunahme ihres analgetischen Effektes. Reine Agonisten scheinen keinen Ceilingeffekt bezüglich ihrer analgetischen Wirkung zu haben.

Die unterschiedlichen pharmakologischen Eigenschaften der verschiedenen Opioide sind durch die Wechselwirkungen mit den Opioidrezeptoren zu erklären. So unterscheiden sich die Opioide u. a. durch die Affinität zum Rezeptor, d. h. durch die Stärke, mit der sie sich an den Rezeptor binden [84].

Nach der Bindung an den Rezeptor wird eine Reaktion des Rezeptors mit seinem Effektorsystem ausgelöst (sog. »intrinsic activity«).

Ist die »intrinsic activity« gleich null, ist trotz hoher Rezeptorbindung ein analgetischer Effekt nicht zu erreichen (z. B. Naloxon als reiner Antagonist).

Für die Wirkstärke eines Opioids sind das Ausmaß der Rezeptoraffinität und die intrinsische Aktivität die verantwortlichen Faktoren [92]. Für den klinischen Einsatz ist es wichtig, zwischen Potenz und Effektivität eines Opioids zu unterscheiden [11, 92, 111].

Tab. 4.5 zeigt eine Auswahl opioidhaltiger Analgetika mit ihren Applikationsformen, ihrer analgetischen Äquivalenz, ihrer Wirkdauer und ihrem Wirktyp.

Nebenwirkungen

Der große Vorteil bei der Schmerztherapie mit Opioiden ist die Tatsache, dass wir die Nebenwirkungen dieser Substanzgruppe gut kennen und in der Regel durch prophylaktische Maßnahmen verhindern können.

Ein weiterer Vorteil der Opioide besteht darin, dass auch bei Langzeittherapie nicht mit Organschäden zu rechnen ist; so gibt es z. B. keinen Hinweis auf Nieren-, Leber- oder Knochenmarkschädigungen durch die Applikation von Opioiden.

Grundsätzlich ist zwischen Nebenwirkungen zu unterscheiden, die bei regelhafter Anwendung der Opioide häufig oder selten vorkommen, ob diese Nebenwirkungen potentiell gefährlich oder therapierbar sind und ob sie dauerhaft oder vorübergehend sind.

Bei intolerablen Nebenwirkungen sollte eine Änderung der Applikationsform oder ein Opioidwechsel erwogen werden [140].

Atemdepression und psychische Abhängigkeit gehören zu den am meisten gefürchteten Nebenwirkungen einer Therapie mit Opioiden.

Atemdepression

Bei schmerzfreien gesunden Probanden führt die Applikation eines Opioids dosisabhängig zu einer Atemdepression [92, 111], die durch gleichzeitige Sedierung verstärkt wird.

Schmerz verursacht offensichtlich eine Stimulation des Atemzentrums durch Erhöhung der Aktivität der Formatio reticularis [92]. Darüber hinaus

Tab. 4.5. Auswahl opioidhaltiger Analgetika: Applikationsformen, analgetische Äquivalenz, Wirkdauer, Wirktyp

Chemische Stoffgruppe	Freiname	Handelsname	Applikationsform			Analgetische Äquivalenz der Einzeldosis	Analgetische Wirkdauer [h]	Initiale Einzeldosis (ohne Gewähr)	Wirkung
			oral	rektal	i.v.				
Opiumalkaloid	Kodein	C. phosph. comp.	= 30 mg = 50 mg			1/10	4–6	30–100 mg	agonistisch
	Morphin	MST Continus	1 Ret.-Kps. = 30/60/100/200 mg				24 (Ret.-Kps.)	30 mg	agonistisch
		MST Mundipharma	1 Ret.-Tbl. = 10/30/60/100/200 mg			1	8–12 (retard)	oral: 10–30 mg	agonistisch
		MST Retardgranulat	1 Beutel = 20/30/60/100/200 mg			1	8–12	20 mg	agonistisch
		MSR Mundipharma		1 Supp. = 10/20/30 mg			4 (Lsg./Supp.)	rektal: 10–30 mg	agonistisch
		MSI Mundipharma Morphin Merck			1 Amp.: 1 ml = 10/20 mg 1 Amp.: 5 ml = 100 mg 1 Amp.: 10 ml = 200 mg		2 (i.v.) –4	i.v.: 2,5–10 mg	agonistisch
		Sevredol	1 Tbl. = 10/20 mg				4 (Tbl.)		agonistisch

Semisynthetische Opioide	Diamorphin	Heroin	in Deutschland nicht im Handel			1,5	3–4	7,5–20 mg i. v.: 2,5–10 mg	agonistisch
	Dihydrokodein	DHC Mundipharma	1 Ret.-Tbl. = 60/90/120 mg			1/6	12	60 mg	agonistisch
	Hydromorphon	Dilaudid Injektionslösung			1 Amp. = 1 ml = 2 mg	7,5	4–5	0,5–2 mg	agonistisch
		Palladon (retardiert)	1 Retard Kps. = 4/8/16/24 mg				8–12	oral: 4 mg	agonistisch
		Palladon nicht retardiert	1 Hartkapsel = 1,3/2,6 mg				4	1,3 mg	agonistisch
	Buprenorphin	Temgesic Temgesic forte	1 s.l.-Tbl. = 0,2 mg = 0,4 mg		1 Amp. = 0,3 mg	60–70	6–8	0,2–0,6 mg	partiell agonistisch
		Transtec	= 35/52,6/70 mg/h transdermal			60–70	48–72	35 µg/h	partiell agonistisch
	Hydrocodon	Dicodid	1 Tbl. = 10 mg		1 Amp. = 1 ml = 15 mg	1	4–8	5–10 mg	agonistisch
	Oxycodon	Oxygesic	1 Ret. Tbl. = 10/20/40/80 mg			2,0 bei oraler Gabe	8–12	5–10 mg	agonistisch
Synthetische Opioide	Pentazocin	Fotral	1 Tbl. = 25 mg 1 Kps. = 50 mg	1 Supp. = 50 mg	1 Amp. = 30 mg	1/6	2–3	25–50 mg	partiell antagonistisch
	Fentanyl	Durogesic SMAT	Membranpflaster 12.5, 25, 50, 75, 100 mg/h transdermal			70–100	48–72	12,5 µg/h	agonistisch

Tab. 4.5. *Fortsetzung*

Chemische Stoffgruppe	Freiname	Handelsname	Applikationsform			Analgetische Äquivalenz der Einzeldosis	Analgetische Wirkdauer [h]	Initiale Einzeldosis (ohne Gewähr)	Wirkung
			oral	rektal	i.v.				
	Fentanyl	Actiq	200, 400, 600, 800, 1200, 1600 µg transmukosal			70–100	0,5–2	200 µg	agonistisch
	Pethidin	Dolantin	25 Tr. = 1 ml = 50 mg	1 Supp. = 100 mg	1 Amp. = 1 ml = 50 mg	1/8	2–3	50–100 mg	agonistisch
	Tilidin	Valoron–N	1 Kps. = 50 mg 20 Tr. = 50 mg			1/10	2–4	50 mg	agonistisch-antagonistisch gemischt
		Valoron-N-Retard Tbl	50/100/150/200 mg			1/10	6–8–12	50 mg	agonistisch-antagonistisch gemischt
	Cetobemidon	Cliradon	in Deutschland nicht im Handel			1	4–5	5–15 mg	agonistisch
	Piritramid	Dipidolor			1 Amp. = 2 ml = 15 mg	3/4	6–8	7,5–30 mg	agonistisch
	Levo-Methadon	L-Polamidon	20 Tr. = 1 ml = 5 mg		1 Amp. = 1 ml = 5 mg	Einzel: 1,5 Dauer: 3–4	Einzel: 3–4 Dauer: 6	2,5 mg	agonistisch
	Tramadol	Tramal Tramundin	1 Kps. = 50 mg 20 Tr. = 0,5 ml = 50 mg	1 Supp. = 100 mg	1 Amp. 1 ml = 50 mg 2 ml = 100 mg	1/10	2–4	50–100 mg	agonistisch
		Tramundin retard	1 Tbl. = 100, 150, 200 mg			1/10	8–12h	50–100 mg	agonistisch
	Dextropropoxyphen	Develin-retard	1 Ret.-Kps. = 150 mg			1/20	8–12	150–300 mg	agonistisch

entsteht eine Toleranzausbildung gegenüber der atemdepressiven Wirkung der Opioide bei wiederholter Einnahme [30]. Schmerz wird als physiologischer Antagonist [74, 79, 206] zu einer opioidbedingten Atemdepression angesehen. Orientiert man sich in der Schmerztherapie mit Opioiden an der von dem Patienten angegebenen Schmerzreduktion, ist *eine Atemdepression nicht zu befürchten.*

Kommen zusätzlich andere schmerztherapeutische Verfahren zum Einsatz (z. B. eine Leitungsanästhesie oder Neurolyse), ist mit einem niedrigeren Opioidbedarf zu rechnen. Die Opioiddosis diesem möglicherweise veränderten Bedarf nicht anzupassen, entspricht einem Kunstfehler (▶ Kap. 4.7.2, S. 256).

Ist eine opioidbedingte Atemdepression aufgetreten, hängt es von der klinischen Situation ab, ob eine Antagonisierung mit Naloxon erfolgen sollte oder ob es ausreicht, die weitere Opioidgabe einzustellen.

Psychische Abhängigkeit

Der Terminus »psychische Abhängigkeit« hat den Begriff »Sucht« abgelöst, wenngleich letzterer bei Laien und in medizinischen Bereichen immer noch häufig benutzt wird.

Psychische Abhängigkeit umschreibt das zwanghafte Bestreben, mit Hilfe einer Substanz einen bestimmten psychischen Effekt zu erreichen. Umfangreiche klinische Erfahrungen mit dem indizierten Einsatz von Opioiden haben immer wieder zeigen können, dass psychische Abhängigkeit bei Patienten mit Tumorerkrankungen und Schmerzen *kein klinisch relevantes Risiko* ist [92, 165, 181].

Tumorpatienten haben ein Verlangen nach dem schmerzstillenden und *nicht* nach dem psychischen Effekt des Opioids. Deswegen darf einem Patienten mit Tumorschmerzen *keinesfalls* ein Opioid vorenthalten werden.

Physische Abhängigkeit

Unter physischer Abhängigkeit einer Opioidtherapie wird das Auftreten typischer Entzugssymptome verstanden, wenn das Opioid abrupt abgesetzt oder ein Antagonist appliziert wird. Die exzitatorische Wirkung ist bei Absetzen des Opioids auf ein Überwiegen der normalen Gegenregulation im ZNS zurückzuführen.

Eine Entzugssymptomatik kann bei geplanter Beendigung einer Opioidtherapie verhindert werden, wenn die Opioiddosis schrittweise reduziert

wird. Die körperliche Abhängigkeit darf deswegen auf keinen Fall mit der psychischen Abhängigkeit (Sucht) gleichgesetzt oder verwechselt werden.

Toleranzentwicklung

Toleranzentwicklung bei der Einnahme von Arzneimitteln ist charakterisiert durch die Notwendigkeit, die Dosis zu erhöhen, damit weiterhin der gleiche Effekt erreicht werden kann.

Opioide haben die Eigenschaft einer selektiven Toleranzentwicklung. Gegenüber der obstipierenden Wirkung eines Opioids (besonders Morphin, Kodein, Dihydrokodein) entwickelt sich keine Toleranz. Im Gegensatz dazu steht die Toleranzentwicklung innerhalb von einigen Tagen in Bezug auf die Symptome Übelkeit, Erbrechen, Atemdepression und Sedierung. Eine *Toleranzentwicklung gegenüber dem analgetischen Effekt tritt nicht ein.*

Eine Dosissteigerung des Opioids ist in der Regel auf ein Fortschreiten der Tumorerkrankung zurückzuführen [56].

Sedierung

Zu Beginn einer Therapie mit Opioiden ist Sedierung ein häufiges Symptom. Innerhalb weniger Tage (selten mehr als acht Tagen) entwickelt sich eine Toleranz gegenüber der vigilanzmindernden Wirkung des Opioids. Vor Beginn einer Therapie sollten Patienten und deren Angehörige auf diese Nebenwirkung hingewiesen werden, damit keine unnötige Beunruhigung auftritt. Nicht selten empfinden Patienten, bei denen zuvor keine ausreichende Analgesierung erreicht worden war, diesen initial sedierenden Effekt als angenehm und genießen den erholsamen, regenerierenden Schlaf.

Wenn die Müdigkeit anhält und zu einem den Patienten belastenden Problem wird oder im Verlauf der Therapie auftritt, sollten folgende Strategien in Betracht gezogen werden:

- Alle eingesetzten Arzneimittel auf zentraldämpfenden Effekt überprüfen, evtl. reduzieren oder absetzen,
- Opioiddosis reduzieren,
- Opioidwechsel [200],
- Amphetamine einsetzen (Methylphenidat – Ritalin) [17, 22],
- Komedikation optimieren,
- Nutzen des Einsatzes invasiver Verfahren abwägen.

Verwirrtheit und Halluzinationen

Verwirrtheit und Halluzinationen sind Symptome, die ausgesprochen selten als Nebenwirkung einer Opioidtherapie auftreten. Deswegen müssen erst alle anderen möglichen Ursachen differentialdiagnostisch abgeklärt werden.

Die symptomatische Behandlung beginnt in der Regel mit der Gabe von Haloperidol 0,5 mg per os alle 8 h; evtl. sind Tagesdosen zwischen 5 und 10 mg notwendig. Erst bei Unwirksamkeit von Haloperidol kommen auch die sedierenden Neuroleptika, wie Levomepromazin (Neurocil), zum Einsatz.

Übelkeit und Erbrechen

Übelkeit und Erbrechen kommen zu Beginn einer Therapie mit Opioiden häufig vor. Die Inzidenz liegt bei ca. 20% und wird von den Patienten als sehr belastend empfunden mit der häufigen Folge, dass sie das Opioid absetzen. Aus diesem Grunde geben wir routinemäßig zu Beginn einer Opioidtherapie prophylaktisch Antiemetika. Da sich nach ca. einer Woche eine Toleranz gegenüber der emetischen Wirkung des Opioids entwickelt, setzen wir das Antiemetikum nach ca. zehn Tagen ab, wenn nicht andere Gründe (z. B. Übelkeit durch gastrointestinale Tumoren u. a.) für den weiteren Einsatz sprechen.

Ursachen der opioidinduzierten Nausea und Emesis sind in der Erregung der Chemorezeptoren in der Area postrema der Medulla oblongata (Chemorezeptortriggerzone), einer Vestibularisreizung und/oder in direkten Wirkungen im Gastrointestinaltrakt zu sehen.

Mittel der ersten Wahl bei opioidbedingter Übelkeit sind Haloperidol und Metoclopramid (Näheres in Abschn. »Antiemetika«, in ► Kap. 4.7.3 und ► Kap. 4.10: »Symptomkontrolle«).

Obstipation [102]

Obstipation ist die häufigste und hartnäckigste Nebenwirkung bei der Schmerztherapie mit Opioiden, besonders mit Kodein und Morphin. Ursache einer Obstipation durch Opioide ist die Bindung des Opioids an Opioidrezeptoren im Darm und ZNS [97, 101]. Nicht nur die periphere, sondern auch die intrathekale und intraventrikuläre Applikation von Opioiden führt zu einer Verzögerung der Darmpassage. Am Dünn- und Dickdarm kommt es zu einer Hemmung der Kontraktion der Längsmuskulatur durch Hemmung der Freisetzung von Azetylcholin aus dem Plexus myentericus. Folge ist eine Abnahme der propulsiven Motorik.

Darüber hinaus bewirken Opioide eine Zunahme der segmentalen Kontraktion. Durch die verlängerte Verweildauer des Darminhalts kommt es zu Wasserentzug, und die Fäzes wird eingedickt.

Weiterhin kommt es zu einer Verminderung der intestinalen, gastrischen, biliären und pankreatischen Sekretion. Verstärkt wird die Obstipation durch Zunahme des Tonus der intestinalen Sphinkteren und Abnahme des Defäkationsreflexes.

Gegenüber der opioidbedingten Obstipation entsteht *keine* Toleranzentwicklung; deswegen *müssen Laxanzien so lange gegeben werden, wie eine Opioidtherapie notwendig ist.*

Aufgrund klinischer Erfahrungen haben sich folgende Maßnahmen als Obstipationsprophylaxe bei der Schmerztherapie mit Opioiden bewährt:

Basismaßnahmen

Zunächst sollte eine Anamnese erhoben werden bezüglich des Stuhlgangs und der Erfolge vorheriger Laxanzienanwendung. Ballaststoffreiche Kost, ausreichende Flüssigkeitszufuhr und körperliche Aktivitäten sind sinnvolle Basismaßnahmen zur Verhütung einer Obstipation – bei Patienten mit Schmerzen und fortgeschrittener Tumorerkrankung allerdings häufig nicht mehr möglich.

Laxanzien

Die Indikation zur Therapie mit Laxanzien ist praktisch immer gegeben (Ausnahmen, z. B. »short bowel syndrom«), und eine Obstipation bei der Therapie mit Opioiden ist als Folge einer unzureichenden Prophylaxe anzusehen.

Obwohl die Obstipation durch Opioide hinreichend bekannt ist, gibt es überraschenderweise kaum experimentelle Untersuchungen bezüglich der Auswahl und Dosierung von Laxanzien.

Gesichert ist heute, dass bei einer Schmerztherapie mit Opioiden (Ausnahmen sind Tramadol, Tilidin)

- Laxanzien regelmäßig gegeben werden müssen,
- die Dosis der Laxanzien sich nach dem Erfolg richtet und deswegen rechtzeitig und individuell angepasst werden muss.

Laxanzien haben unterschiedliche Wirkmechanismen (▶ Kap. 4.10.3). Folgendes »Stufenschema« hat sich bei uns als Obstipationsprophylaxe und

Obstipationstherapie bei Einsatz von Opioiden, besonders Morphin, bewährt:

»Stufenschema« der Laxanzientherapie bei Opioidgabe

- Macrogol (M)
- M + Laxoberal (L)
- M + Liquidepur
- M + L + Obstinol (O) mild
- M + L + O + Supp./Klysma/Einlauf
- L + O + Gastrografin
- Rizinusöl
- manuelle Ausräumung

Bei niedriger Dosierung von Morphin (z. B. zweimal 30 mg Morphin-Retardtabletten) oder dem Einsatz weniger obstipierend wirkender Opioide (z. B. Buprenorphin, Tramadol) reicht in der Regel die Gabe des osmotisch wirkenden Laxans Macrogol aus. Lactulose dagegen verwenden wir wegen seines Nebenwirkungsspektrums (Meteorismus, Flatulenz) praktisch überhaupt nicht. Im Gegensatz zur gängigen Lehrmeinung sind bei Patienten in palliativmedizinischer Betreuung Gleitmittel (Paraffinöl) als ergänzende Maßnahmen sinnvoll und notwendig [102]. Hydragog und sekretagog wirkende Laxanzien haben in der Palliativmedizin ihren festen Stellenwert, insbesondere die Senna-Präparate und Natrium-Picosulfat (▶ Kap. 4.10.3).

Blasenentleerungsstörungen

Da Opioide eine Erhöhung des Sphinktertonus bewirken, kann die Folge eine Blasenentleerungsstörung sein, die in der Regel passagerer Natur ist. Bleibt das Problem bestehen, ist manchmal die Gabe von Distigminpromid (Ubretid) 1 Tbl. = 5 mg p.o. oder 1 Amp. = 0,5 mg i.m. erfolgreich; evtl. ist aber eine Blasenkatheterisierung notwendig.

Opioide für schwache und mittelstarke Schmerzen [94]

Opioide sind mehr oder weniger willkürlich in schwache und starke Opioide unterteilt worden. Hanks [76] empfiehlt, die Opioide als *eine* pharmakologi-

sche Gruppe zu betrachten und nach ihrer Verwendung bei Schmerzzuständen unterschiedlicher Intensität einzuteilen.

Zu den Opioiden, die bei schwachen und mittelstarken Tumorschmerzen eingesetzt werden, gehören in erster Linie Kodein, Dihydrokodein, Tramadol, Dextropropoxyphen und Tilidin N, wohingegen Petazocin gar keinen Stellenwert in der Tumorschmerztherapie besitzt.

Kodein

Kodein war lange Zeit bei uns Mittel der Wahl bei geringen und mittelstarken opioidsensiblen Schmerzen. Inzwischen ist es von den Retardpräparaten verdrängt worden. Kodein hat einen sicheren Wirkungszeitraum von 4 h und wird in einer Dosierung von 30–120 mg im regelmäßigen Zeitintervall von 4 h gegeben. Häufigste Nebenwirkung ist die Obstipation, die so hartnäckig ist wie beim Einsatz von Morphin; es muss deswegen *immer* eine Obstipationsprophylaxe betrieben werden.

Kodein ist ein Prodrug und wird zu Morphin und Norkodein metabolisiert. 30 mg Kodein per os ist dosisäquivalent zu 50–60 mg Azetylsalizylsäure.

Dihydrokodein

Es handelt sich um ein semisynthetisches Opioid, dessen analgetische Potenz etwa 1/3 größer ist als Kodein [199]. Ein wesentlicher Vorteil liegt in der Tatsache, dass diese Substanz auch in retardierter Form zur Verfügung steht. Die Wirkdauer beträgt 8–12 h, wobei man in der Regel mit der zweimal täglichen Gabe auskommt. Nebenwirkungen sind insbesondere Obstipation – vergleichbar mit Kodein und Morphin – und Übelkeit.

Tramadol

Die Bioverfügbarkeit bei oraler Aufnahme liegt bei ca. 70%, und die analgetische Äquivalenz zu Morphin beträgt 1/10. Die analgetische Wirkung von Tramadol kommt sowohl über Bindung an die Opioidrezeptoren als auch über Verminderung der präsynaptischen Noradrenalin- und Serotoninwiederaufnahme zustande [170].

Obwohl Tramadol seltener als Kodein und Dihydrokodein eine Obstipation bewirkt, haben wir aufgrund der häufig auftretenden, ausgeprägten Übelkeit, insbesondere aber wegen der meist kurzen klinischen Wirkdauer von nur 2 h lange Zeit auf den Einsatz von Tramadol verzichtet.

In der später eingeführten retardierten Form verfügt Tramadol jedoch über eine sichere Wirkdauer von 8–12 h, Übelkeit und Obstipation treten selten als Nebenwirkung auf. Daher ist Tramadol retard als Opioid der Wahl bei schwachen bis mittelstarken opioidsensiblen Schmerzen anzusehen. Die maximale Tagesdosis liegt bei 900 mg [160]; bei höherer Dosis tritt der Ceilingeffekt ein, d. h. bei einer weiteren Dosiserhöhung wird keine weitere Schmerzreduzierung erreicht.

Tilidin

Tilidin ist ein mittelstarkes Opioid, das in retardierter und nichtretardierter Form vorliegt. Tilidin ist ein Prodrug, das nach oraler Einnahme durch einen First-Pass-Metabolismus in der Leber in Nortilidin umgewandelt wird. Der beigefügte Opioidantagonist Naloxon spielt bei Gebrauch therapeutischer Dosen keine Rolle. Die orale Bioverfügbarkeit ist mit 98% sehr hoch. Eine Dosisreduktion ist bei Niereninsuffizienz nicht notwendig, da die Metabolisierung zu inaktiven Metaboliten unabhängig von der Nierenfunktion verläuft [1, 16, 127, 183]. Im Gegensatz dazu sollte bei einer ausgeprägten Leberinsuffizienz die Therapie mit Tilidin-N überdacht werden, da der Opioidantagonist klinisch relevante Wirkung entwickeln kann bei gleichzeitig zu geringer Bildung von aktivem Nortilidin.

Die Tageshöchstdosis wird mit 600 mg angegeben. Unsere klinische Erfahrung hat gezeigt, dass der Ceilingeffekt eher im Bereich von 1000 mg anzusiedeln ist. Die vom Hersteller propagierte Retardwirkung von 12 h wird häufig nicht erreicht. Die Retardtabletten dürfen nicht geteilt werden, da sonst der Retardeffekt nicht mehr gewährleistet ist. Deswegen dürfen die Tabletten auch nicht zerkaut werden. Nebenwirkungen sind Übelkeit, Erbrechen, Schwindel und Müdigkeit.

Dextropropoxyphen

Dieses synthetische Opioid ist strukturell dem Methadon verwandt; die analgetische Potenz im Vergleich zu Kodein beträgt ca. 1/2.

Wegen der langen Plasmahalbwertszeit des Abbauproduktes Norpropoxyphen von ca. 30–36 h besteht Kumulationsgefahr [199].

Diese Substanz ist weltweit verfügbar und wird deswegen von der WHO auch in der 2. Ausgabe von *Cancer pain relief* (1996) als Alternative zu Kodein bei schwachen und mittelstarken Schmerzen angegeben [210].

Opioide für mittelstarke und starke Schmerzen [94] – Morphin

Morphin gilt bis heute als Referenzsubstanz, an der sich die Wirksamkeit und die Nebenwirkungen anderer Opioide messen lassen müssen [50, 93, 162, 201, 103].

Morphin wurde 1804 von dem Apotheker Sertürner aus Opium isoliert, das heute nicht nur aus dem Mohnsaft, sondern auch aus Mohnstroh (ca. 40%) gewonnen wird [194, 195]. Opium ist der eingetrocknete Milchsaft, der aus den unreifen, noch grünen, ausgewachsenen Kapseln von Papaver somniferum L., dem Schlafmohn, gewonnen wird.

Rohopium besteht zu 20–30% aus Alkaloiden. Den größten Anteil macht das Morphin (7–21%) aus; es folgen Narkotin (1–13%), Kodein (0,3–7%), Papaverin (0,1–5%), Thebain und Narcain. Weitere Inhaltsstoffe sind Kautschuk, Harze, Fette und Schleimstoffe [194, 195]. Morphin ist ein reiner Agonist, der seine Wirkung fast ausschließlich am μ-Rezeptor entfaltet [29].

Für Morphin stehen invasive und nichtinvasive Applikationsformen zur Verfügung. Nach oraler Gabe schwankt die Bioverfügbarkeit zwischen 15 und 49% [111].

Das Hauptstoffwechselprodukt ist Morphin-3-Glukuronid (M-3-G), das keine analgetische Wirkung hat [113]. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass M-3-G antagonistische Wirkung an den Opioidrezeptoren entwickeln kann [27, 126, 134, 185, 205]. Ein weiterer Morphinmetabolit ist Morphin-6-Glukuronid (M-6-G), das die Blut-Hirn-Schranke durchdringt, sich fest an die Opioidrezeptoren bindet und stärker analgetisch wirksam ist als Morphin [111, 113].

Da sowohl M-3-G als auch M-6-G über die Niere ausgeschieden werden, können sie bei Niereninsuffizienz kumulieren, was daher eine Dosisanpassung notwendig macht [7, 112]. Die Auswirkungen einer Leberfunktionsstörung sind nicht direkt voraussagbar. Zum einen kann es zu einem überproportionalen Anstieg der Morphinplasmakonzentration kommen, andererseits wird M-6-G bei schwerer Leberfunktionsstörung vermindert gebildet, aber bei normaler Nierenfunktion renal eliminiert [157].

Aus klinischen Erfahrungen haben sich die in der Übersicht genannten Äquivalenzdosen von Morphin bei unterschiedlichen Applikationsformen ergeben.

Äquivalenzdosen von Morphin

- oral: 30 mg
- s.c.: 15 mg
- i.v., i.m.: 10 mg
- epidural: 3 mg
- intrathekal: 0,3 mg
- intraventrikulär: 0,001 mg

Alter und Morphinbedarf

Neugeborene haben eine signifikant verlängerte Plasmahalbwertszeit von Morphin (ca. 6–7 h) [128]. Bereits vier Wochen nach der Geburt entspricht der Morphinmetabolismus den Werten bei Erwachsenen. Kinder haben keine erhöhte Sensibilität gegenüber der atemdepressiven Wirkung [199].

Im Allgemeinen gilt die These, dass Patienten über 60 Jahre weniger Morphin benötigen als jüngere [60]; begründet wird dies mit einer verminderten Kreatininclearance. Wahrscheinlich gilt dies nur für die Anfangsdosierungen, da die Arbeitsgruppe von Lehmann und Radbruch [124] in ihrem Patientenkollektiv nachweisen konnte, dass Tumorpatienten über 74 Jahre signifikant höhere Tagesdosen an Morphin benötigten als Patienten unter 65 Jahren. Wie auch immer man diese unterschiedlichen Ergebnisse wertet, die wichtigste Schlussfolgerung ist, dass eine Therapie mit Morphin immer unter ärztlicher Kontrolle individuell angepasst durchgeführt werden muss.

Hinweise zur Anwendung von Morphin

Wir besprechen offen und im Voraus jede Schmerztherapie, Änderungen der Maßnahmen und Dosierungen mit den Patienten, um häufig vorhandene Vorurteile, Ängste und Bedenken bezüglich einer Therapie mit Morphin abzubauen.

Wenn man annimmt, dass Schmerzen die atemdepressive Wirkung der Opiate »antagonisieren«, wird verständlich, dass der erfolgreiche Einsatz regionaler Methoden der Schmerzlinderung (Neurolyse, Bestrahlung usw.) eine Reduktion oder Absetzen des Morphins erforderlich macht. Opioide können lange Zeit ohne Toleranzentwicklung eingesetzt werden. Eine erforderliche Dosiserhöhung lässt sich meist durch Zunahme der Schmerzen erklären.

Psychische Abhängigkeit tritt beim Tumorpatienten nicht ein, denn er hat kein Verlangen nach den psychischen Effekten des Opiats, sondern nach der schmerzstillenden Wirkung. Bei regelmäßiger und antizipativer Applikation der Medikamente ist eine Entwicklung psychischer Abhängigkeit in der Regel ausgeschlossen; wegen des Entstehens physischer Gewöhnung können bei abruptem Absetzen der Opioidmedikation körperliche Entzugsscheinungen wie etwa Schwitzen, Unruhe etc. auftreten; daher sollte eine Beendigung der Opioidtherapie immer ausschleichend erfolgen.

Fazit

Werden die Grundregeln der Schmerztherapie eingehalten, ist Morphin ein wirksames und sicheres Medikament. Atemdepression und Abhängigkeit kommen bei richtiger Anwendung praktisch nicht vor. Diesbezügliche von Patienten und Ärzten geäußerte Ängste und Bedenken sind in der Sache unbegründet.

Hinweise für die Applikation verschiedener Opioide

Die orale Morphingabe ist die Therapie der Wahl; in den letzten zwei Jahren hat sich für die orale Applikation das Hydromorphon in der Tumorschmerztherapie als gute Alternative zum Morphin erwiesen [152].

Bestehen mäßiggradige Schluckstörungen, kann die Morphin Retardkapsel geöffnet werden und das Mikrogranulat ohne Wirkungsverlust sowohl in flüssiger als auch in breiiger Kost oral verabreicht werden.

Das Morphin-Retardgranulat kann als Trinksuspension sowohl bei mäßiggradigen Schluckstörungen oral oder bei liegender PEG-Sonde problemlos eingegeben werden. Das aufgelöste Granulat sollte innerhalb von 15–20 min getrunken werden, da sonst der Retardeffekt verloren geht.

Bei Übelkeit, Erbrechen oder auch bei terminalem inoperablem Ileus können Morphinsulfatsuppositorien in retardierter oder nichtretardierter Form gegeben werden.

Bei Schluckstörungen ist auch Buprenorphin sublingual in Erwägung zu ziehen. Ist bei stabilem Schmerzniveau und opioidsensiblen Schmerzen die enterale Gabe nicht möglich, sind transdermales Buprenorphin oder Fentanyl Alternativen.

Bei Einsatz der transdermalen Systeme muss Folgendes berücksichtigt werden [119]:

- Langsame Anflutung (12–24 h) mit einem Steady State von der 24. bis zur 72. Stunde nach der Erstgabe bei Fentanyl und über 50 h bei Buprenorphin bis zum Erreichen der maximalen Blutkonzentration nach Verabreichung des 35-µg-Pflasters.
- Langsame Abklingzeit von ca. 16 h nach Entfernung des Fentanylpflasters und >48 h beim Buprenorphinpflaster.
- Zur Therapie einer Atemdepression durch Fentanyl reicht die einmalige Antagonisierung mit Naloxon nicht aus, sie macht die stationäre Einweisung möglichst auf einer Intensivstation notwendig.
- Aufgrund der Pflastergröße (Fentanyl: 5,25–42 cm^2 bzw. Buprenorphin: 25–50 cm^2) und begrenzter Körperoberfläche ist der Einsatz der transdermalen Systeme nur bei niedrigem bis mittlerem Opioidbedarf sinnvoll. Benutzte Hautareale sollten für sieben Tage nach Entfernen eines Pflasters frei bleiben.
- Bei instabilem Schmerzsyndrom und der Indikation zu schneller Dosissteigerung sind die transdermalen Systeme ungeeignet.
- Schmerzattacken unter laufender Therapie mit transdermalem Buprenorphin oder Fentanyl machen eine zusätzliche Behandlung mit schnell wirkenden Opioiden notwendig; d. h. Buprenorphin sublingual bzw. schnelllösliche Morphintabletten oder Hydromorphon Hartkapseln beim Einsatz von Fentanyl.
- Pflaster nicht auf beschädigte Haut kleben (Läsionen, frisch rasiert etc.).
- Pflasterstelle nicht erhöhter Wärmezufuhr aussetzen (Heizkissen, direkte Sonneneinstrahlung, Sauna, heiße Bäder oder Duschen).

Anwendung von Morphin [117]

Das therapeutische Vorgehen mit Morphin richtet sich v. a. nach der Stärke der Schmerzen. Kommt ein Patient mit **extremen Schmerzen** als »Schmerznotfall«, titrieren wir Morphin intravenös in Bolusgaben, deren Höhe sich nicht nur nach der Schmerzintensität, sondern auch nach dem Allgemeinzustand des Patienten und der bisherigen Analgetikatherapie richtet [164].

Bei einem opioidnaiven Patienten in relativ gutem Allgemeinzustand liegt der Einzelbolus bei 2,5–5 mg, der alle 10–20 min so lange wiederholt wird, bis der Patient eine ausreichende Schmerzreduktion angibt und unerwünschte Nebenwirkungen nicht auftreten (alternative Dosisfindung in ▶ Kap. 4.7.2; S. 254).

Alternativ kann eine Dauerinfusion von 40–60 mg Morphin in 500 ml kristalliner Lösung gegeben werden, wobei die Infusionsgeschwindigkeit

unter ständiger Anwesenheit eines Arztes (auf einer Palliativstation auch einer versierten Krankenschwester) der Änderung des Schmerzniveaus und Beobachtung der Vigilanz und Atmung angepasst wird. Diese Form der Notfallbehandlung stellt eher die Ausnahme dar.

Hat ein Patient **mittelstarke oder starke Schmerzen,** die innerhalb kurzer Zeit deutlich reduziert werden sollen, und ist er in der Lage, Medikamente oral aufzunehmen, so hat sich folgendes Vorgehen bewährt:

Nach Einschätzung der Schmerzintensität (auf einer Schmerzskala möglichst durch den Patienten selbst) und einer vorläufigen Arbeitshypothese bezüglich des Schmerzsyndroms (wichtig wegen der analgetischen Zusatzmedikation) erhält der Patient entweder eine Morphinlösung (Beispiel s. unten) oder eine schnellwirkende Morphinsulfattablette in einer Anfangsdosis von 10 mg; ist nach 2 h keine wesentliche Schmerzreduktion eingetreten, erhält der Patient entweder erneut 10 mg, oder es wird in vierstündlichen Abständen die Morphindosis wie folgt erhöht, bis eine zufrieden stellende Schmerzlinderung eingetreten ist:

15 – 20 – 30 – 45 – 60 – 75 – 90 mg.

Eine Dosierung über 90 mg alle 4 h oder die Verkürzung des Intervalls auf 3 h sind selten notwendig. In unserem Patientenkollektiv benötigten 16% der Patienten eine Tagesdosierung von über 300 mg Morphin; ein Patient erhielt allerdings eine intravenöse Tagesdosis von 5.000 mg Morphin. In der Literatur wurde ein Patient beschrieben, der eine Tagesdosis von über 35.000 mg Morphin benötigte [38].

Ist die Dosisfindung abgeschlossen, stellen wir die Patienten auf die Morphin-Retardtablette bzw. -kapsel um im Verhältnis 1 : 1 des Tagesbedarfs.

Ist die Tagesdosis gleich bzw. unter 60 mg, bevorzugen wir die Morphinsulfatkapseln. Liegt der Dosisbereich zwischen 60 und 120 mg, entscheiden wir von Fall zu Fall, ob die Retardkapsel oder die Morphinsulfat-Retardtabletten eingesetzt werden; bei Tagesdosen über 120 mg verschreiben wir die Morphinsulfat-Retardtablette.

Beispiel für die Rezeptur einer Morphinlösung

- Rp.
- Morphinum hydrochloricum 1200 mg (eintausendzweihundert)
- Aqua dest. ad 240 ml
- 1 ml=5 mg
- S.: 4 ml = 20 mg alle 4 h; täglich 120 mg.

Sowohl die Menge als auch die Konzentration der Morphinlösung kann dem notwendigen individuellen Bedarf des Patienten angepasst werden. Die oben dargestellte Morphinlösung hat eine begrenzte Haltbarkeit von 28 Tagen. Seit kurzem steht uns eine fertige Trinklösung zur Verfügung. Diese Morphinlösung ist in 10, 30 und 100 mg Trinkampullen verfügbar.

Schmerztherapie mit Morphin bei Kindern

Für die Schmerztherapie bei Kindern (▶ Kap. 7) gelten prinzipiell die gleichen Regeln, wie sie zuvor für Erwachsene dargestellt worden sind (d. h. Zeitschema, individuelle Dosis, individuelle Dosisanpassung, Prinzip der Antizipation).

Der Unterschied zur Schmerztherapie bei Ewachsenen liegt darin, dass *zu Beginn* der Schmerztherapie bei Kindern die Medikamente nach dem Körpergewicht gegeben werden.

Auch bei Kindern ist bei entsprechender Schmerzursache und Schmerzsymptomatik der Einsatz opioid- und nichtopioidhaltiger Analgetika entweder allein oder auch in Kombination sinnvoll und möglich.

Für die Schmerzeinstellung bietet die Morphinlösung Vorteile, da sie in sehr feiner Abstufung gegeben werden kann. Für die initiale orale Analgetikagabe können die in ◘ Tab. 4.6 angegebenen Dosierungen als Richtlinien gelten.

Die individuelle Dosisfindung erfolgt anhand des Ausmaßes der Schmerzreduktion. Die gefundene Tagesdosis der Morphinlösung kann als Morphin-Retardtabletten oder Morphin-Retardgranulat, dann aufgeteilt auf zwei Einzeldosen, gegeben werden.

◘ **Tab. 4.6.** Dosierungsrichtlinien für Morphin

Körpergewicht [kg]	Morphinlösung [mg/4 h]	Morphinsulfat-Tbl. (Sevredol) [mg/4 h]
10	1–2	2,5
20	2–4	2,5–5,0
30	3–6	5,0–7,5
40	4–10	5,0–10,0
50	5–20	7,5–20,0

Auch bei Kindern ist die bei Erwachsenen beschriebene Begleitmedikation (Laxanzien, Antiemetika) in der Regel notwendig. Der emetische Effekt von Morphin scheint bei Kindern jedoch weniger stark ausgeprägt zu sein (▶ Kap. 7).

Alternativen zu Morphin

Buprenorphin

Buprenorphin ist ein partieller Agonist, dessen Rezeptoraffinität hoch ist. Er wird sublingual gut resorbiert, der Wirkungseintritt erfolgt nach ca. 30 min und die Wirkdauer beträgt ca. 6–8 h. Buprenorphin hat einen Ceilingeffekt, der bei einer Tagesdosis zwischen 3 und 5 mg eintritt (dies entspricht etwa einer Morphinmenge von 180–300 mg). Daraus kann man folgern, dass Buprenorphin als Alternative zu Morphin bei niedrigem und mittlerem Bedarf angesehen werden kann. Die sublinguale Applikationsform eignet sich besonders bei Dysphagie.

Ist der Wechsel von Buprenorphin auf Morphin notwendig, wird die Tagesdosis von Buprenorphin mit 60–80 multipliziert und ergibt die Tagesdosis von Morphin. Obwohl Buprenorphin eine geringere Obstipation als Morphin bewirken soll, benötigen die meisten Patienten im fortgeschrittenen Tumorstadium Laxanzien.

Bei Niereninsuffizienz bleiben die pharmakokinetischen Charakteristika unverändert [23, 127].

Buprenorphin ist auch als transdermales System in 3 Wirkstärken (35/52,5/70 µg/h) verfügbar [119]. Dies entspricht einer oralen Morphinäquivalenz von ca. 60/90/120 mg. Der Wirkstoff ist in eine Polymermatrix der Klebeschicht eingelagert und kann deswegen zerschnitten werden; es kommt zu *keiner* unkontrollierten Freisetzung von Buprenorphin. Geht man davon aus, dass eine praktikable Pflasterfläche von maximal 200 cm^2 zur Verfügung steht [93], ist mit 280 µg/h die Höchstdosis erreicht; dies entspricht ca. 480 mg Morphin oral appliziert. Die Anflutung nach der ersten Pflasterapplikation ist langsam, erreicht nach 12–24 h die minimal-effektive Konzentration und nach 57–59 h die maximale Konzentration im Plasma (Fachinformation Grünenthal 2001).

Nach Entfernen des Pflasters beträgt die Halbwertszeit ca. 30 h. Übelkeit und Erbrechen sind relativ häufige Nebenwirkungen, Obstipation mit ca. 5% eher selten.

Methadon

Levomethadon ist ein synthetisches Opioid und ein reiner Agonist, dessen analgetische Äquivalenz bei Dauertherapie drei- bis viermal höher ist als die von Morphin.

Obwohl die Plasmahalbwertszeit zwischen 10 und 75 h variiert, liegt die klinische Wirkdauer zwischen 6 und 12 h [199]. Besonders in der Einstellphase besteht Kumulationsgefahr, weswegen die Patienten in dieser Zeit engmaschig überwacht werden müssen. Etwa 50% von Levomethadon und seinen Metaboliten werden über den Intestinaltrakt ausgeschieden, die andere Hälfte über die Nieren. Levomethadon wird von der WHO als Ausweichsubstanz bei Morphinintoleranz empfohlen.

Wegen der ausgeprägten interindividuellen Variabilität der Halbwertszeit von Methadon und der Schwierigkeit, die äquianalgetische Dosis von Methadon zu anderen Opioiden festzulegen, gibt es für die Dosisfindung von Methadon zahlreiche unterschiedliche Empfehlungen [18, 19, 89, 174, 179, 201]. Das in der Übersicht gezeigte Vorgehen hat sich bei uns beim Opioidwechsel auf Methadon bewährt.

Opioidwechsel auf Methadon

- Tag 1:
  - Absetzen des bisherigen starken Opioids
  - Unabhängig von der bisherigen Opioiddosis Beginn mit (2,5–)5 mg Levomethadon p.o. alle 4 h
  - Bedarfsmedikation analog der Einzeldosis (5 mg) maximal 1-mal/h
- Tag 2 und 3:
  - Bei weiterhin bestehenden Schmerzen Dosissteigerung, bis eine ausreichende Schmerzreduktion ohne Nebenwirkungen erreicht ist
  - Bei ausreichender Schmerzreduktion Dosierung wie am Ende von Tag 1
  - Bei auftretenden Nebenwirkungen Dosisreduktion bis zur Reduzierung der Nebenwirkungen oder Schmerzzunahme
- Tag 4:
  - Nach 72 h Verlängerung des Applikationsintervalls auf 8-stündliche Gabe
  - Bedarfsmedikation analog der Einzeldosis, jedoch maximal alle 3 h

- Nach Tag 4:
  - Bei nicht ausreichender Schmerzreduktion Dosissteigerung, bis eine Schmerzabnahme erreicht ist, ohne dass Nebenwirkungen auftreten
  - Bei ausreichender Schmerzreduktion Erhaltungsdosis alle 8 h
  - Die Erfahrung zeigt, dass die Dosis zwischen 5 und 100 mg/8 h variiert.

Oxycodon

ist ein semisynthetisches, agonistisches Opioid, dessen Wirksamkeit zur Behandlung akuter und chronischer tumor- wie nicht tumorbedingter Schmerzen nachgewiesen ist [73, 98, 162, 167, 209]. Es wird in der Leber metabolisiert, wobei Noroxycodon (1/100 der Wirkstärke von Oxycodon) und in geringem Maße das analgetisch potente Oxymorphon entstehen [166].

Bei Leberfunktionsstörungen ist die Oxycodonclearance vermindert. Auch bei terminaler Niereninsuffizienz kommt es zur Abnahme der Ausscheidung von Oxycodon und seinen Metaboliten. Sowohl bei Leberfunktionsstörungen als auch bei Niereninsuffizienz sollte eine Dosisreduktion in Erwägung gezogen werden. Aufgrund der hohen oralen Bioverfügbarkeit (60–87%) beträgt die orale Äquivalenz zu Morphin 1 : 2, d. h. 30 mg Oxycodon entsprechen 60 mg Morphin [99].

Oxycodon hat keinen Ceilingeffekt. Die Retardtablette hat eine duale Galenik, wobei Oxycodon unterschiedlich schnell freigesetzt wird [98]. Ein Teil des Oxycodons wird innerhalb 1 h freigesetzt, sodass Oxycodon als Retardpräparat eine ungewöhnlich schnelle Anschlagzeit hat. Der andere Teil des Oxycodons wird verzögert freigesetzt, wodurch eine Wirkdauer von (8–)12 h erreicht wird.

Die Oxycodon-Retardtablette gibt es in vier Wirkstärken zu 10/20/40 oder 80 mg. Die Dosistitration beim opioidnaiven Patienten kann wie folgt durchgeführt werden:

Nach dem Beginn mit 2-mal 10 mg und unzureichender Schmerzreduktion erfolgt die Steigerung der Dosis alle 12–24 h auf 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 mg usw., bis es zu einer deutlichen Schmerzabnahme gekommen ist und wenn im Verlauf keine Nebenwirkungen aufgetreten sind.

Hydromorphon

ist ein semisynthetisches Opioid mit opioidagonistischen Eigenschaften [120]. Es ist pharmakologisch dem Morphin sehr ähnlich, bei intravenöser

Gabe ca. 5-mal, bei oraler Gabe 7,5-mal potenter als Morphin. Die orale Bioverfügbarkeit liegt bei 35–62% [103, 109, 110, 127]. Die Metabolisierung findet hauptsächlich in der Leber statt; Hauptmetabolit ist Hydromorphon-3-Glukuronid (HM-3-G), das pharmakologisch inaktiv ist, während die 6-Hydroxymetaboliten pharmakologisch wirksam sind, aber quantitativ in sehr niedriger Konzentration vorliegen. Die Metaboliten werden renal eliminiert; Hydromorphon wird bis zu 13% unverändert renal ausgeschieden [127].

Eine Leberinsuffizienz kann mit einer höheren und länger andauernden Plasmakonzentration einhergehen, sodass auch hier eine Dosisreduktion notwendig werden kann [127].

Hydromorphon hat keinen Ceilingeffekt, d. h. es gibt keine klinisch relevante Dosisbegrenzung nach oben. Nichtretardiertes Hydromorphon hat eine Wirkdauer von 3–4 h, die Retardkapseln (8–)12 h. Die Resorption erfolgt unabhängig von der Nahrungsaufnahme und der Wirkungseintritt der Retardkapseln erfolgt innerhalb von 3 h [72, 73]. Die Retardkapsel kann geöffnet und das Granulat ohne Wirkungsverlust der Nahrung zugemischt werden. Hydromorphon ist zur Behandlung akuter und chronischer, starker und stärkster Schmerzen gleichermaßen gut geeignet.

Die Erfahrungen mit Hydromorphon haben gezeigt, dass wir mit dieser Substanz ein sicheres und zuverlässiges Opioid in der Hand haben, wenn die Grundregeln der Schmerztherapie (▶ Kap. 4.8, S. 273) eingehalten werden. Bei grundsätzlich opioidtypischem Nebenwirkungsprofil – insbesondere Obstipation – zeichnet es sich durch eine gute Verträglichkeit und geringe Beeinträchtigung der Vigilanz aus. Es kann deswegen auch als Opioid der 1. Wahl bei starken und stärksten Schmerzen betrachtet werden.

Hydromorphon steht uns als Fertigpräparat als Retardkapsel zu Verfügung mit Wirkstärken von 4, 8, 16 und 24 mg, zudem als kurzwirksames, nichtretardiertes Präparat (Hartkapsel) mit 1,3 bzw. 2,6 mg. Die orale Morphinäquivalenz von 4 mg Hydromorphon entspricht 30 mg Morphin.

Für die schnelle Dosisfindung lassen wir uns in der Apotheke folgende Lösung herstellen:

- Rp.:
  - Hydromorphonhydrochlorid 500 mg,
  - Aqua ad injectabile ad 100 ml, 1 ml = 5 mg.

Die wässrige Lösung enthält keine Konservierungsstoffe und ist nach Anbruch im Kühlschrank aufbewahrt 7 Tage haltbar. Wir beginnen mit 1–2 mg dieser

Hydromorphonlösung und steigern alle 4 h die Dosis um 1–2 mg, bis eine zufrieden stellende Schmerzreduktion erreicht ist.

Die Titration mit der Retardkapsel kann wie folgt durchgeführt werden: 2-mal 4 mg, 3-mal 4 mg, 2-mal 8 mg, 2-mal 12 mg, 3-mal 12 mg, 2-mal 24 mg usw. (s. Patientenbeispiel in ▶ Kap. 4.8, S. 273).

Fentanyl [44, 49, 79, 119, 169]

Das synthetische Opioid Fentanyl ist ein μ-Rezeptoragonist und hat bei parenteraler Anwendung eine analgetische Potenz, die um den Faktor 70–100 höher liegt als die von Morphin (◘ Tab. 4.7).

Seine hohe Lipidlöslichkeit und niedrige Molekülgröße erleichtern die transdermale Aufnahme [119]. Fentanyl wird in der Leber durch N-Dealkylierung und Hydroxylierung inaktiviert. Rund 10% werden unverändert über die Niere ausgeschieden [127]. Nierenfunktionsstörungen können zur Wirkungsverstärkung und Verlängerung der Wirkdauer bis zur Opiodintoxikation führen [127, 104].

Inzwischen gibt es mehrere Berichte über Opioidintoxikation durch transdermales Fentanyl, insbesondere bei unsachgemäßer Anwendung [39, 47, 62, 79, 104-106, 135, 154].

Bei Auftreten von Nierenfunktionsstörungen sollte frühzeitig eine Dosiserniedrigung oder gar ein Opioidwechsel in Erwägung gezogen werden, da durch die langsame Elimination von Fentanyl aus dem kutanen Depot mit einem langsamen Abklingen der Nebenwirkungen gerechnet werden muss.

◘ **Tab. 4.7.** Äquivalenzdosierung von oralem Morphin und TTS-Fentanyl [215]

Pflastergröße [cm^2]	Abgaberate TTS-Fentanyl [mg/24 h]	Morphin oral [mg/24 h]
10	0,6	0–90
20	1,2	91–150
30	1,8	151–210
40	2,4	211–270

Das transdermale therapeutische System von Fentanyl (TTS-Fentanyl) hat eine Anschlagzeit von 12 h mit einer Variation von 1–31 h [215], mit stabilen Blutspiegeln von der 24. bis zur 72. Stunde.

Die Abklingzeit nach Entfernen des Pflasters ist mit 16 h ebenfalls lang. Das Pflaster soll seltener als Morphin zur Obstipation führen [168].

Indikationen für das transdermale System mit Fentanyl sind insbesondere dann gegeben, wenn eine orale Medikation nicht (mehr) möglich ist (Tumoren aus dem HNO-Bereich) oder anhaltende gastrointestinale Probleme mit Übelkeit und Erbrechen eine orale Therapie unwirksam machen.

Seit einiger Zeit ist ein schnell wirkendes oraltransmukosales therapeutisches System (o-TTS) für die Behandlung von Durchbruchschmerzen [163] auf dem Markt. Die Lutschtablette mit Kunststoffapplikator gibt es in sechs Wirkstärken mit 200, 400, 600, 800, 1200 und 1600 µg Fentanyl. Der Wirkungseintritt ist mit 5 min sehr rasch [34, 118].

Heroin – Diazetylmorphin

Heroin ist ein semisynthetisches agonistisches Opioid, das durch zweifache Azetylierung von Morphin gewonnen werden kann und vorwiegend in Großbritannien eingesetzt wird.

Heroin ist ein Prodrug, das zu Monoazetylmorphin und Morphin abgebaut wird. Es ist lipophil und passiert die Blut-Liquor-Schranke rascher als Morphin. Bei oraler Applikation sind Morphin und Heroin äquipotent, bei intramuskulärer Gabe ist die analgetische Potenz von Heroin zu Morphin um den Faktor 2 höher. Die analgetische Wirkdauer beträgt 4 h; Wirkungen und Nebenwirkungen sind vergleichbar zu Morphin.

Die Briten sehen einen Vorteil von Heroin in der Tatsache, dass die Löslichkeit von Heroin gegenüber Morphin um den Faktor 15 höher liegt und damit Vorzüge bei der subkutanen Applikation wegen der größeren Konzentrierbarkeit und damit des geringeren Volumens hat.

Das Brompton Hospital stellte in den 1960er und 1970er Jahren eine eigene Analgetikamischung zur Schmerztherapie her, den »Brompton Cocktail«, der aus folgenden Substanzen bestand: Heroin (15 mg), Kokain (10 mg), Gin (2 ml), Honig (4 ml), Chloroform (15 ml) [199]. Lange Zeit wurde dieser Cocktail mystifiziert, bis Untersuchungen nachweisen konnten, dass er keine Vorteile gegenüber einer konventionellen Schmerztherapie mit Monosubstanzen hat [139, 203].

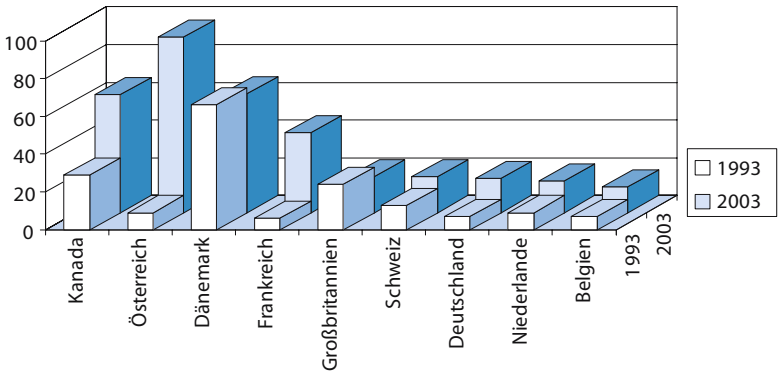
Opioidverfügbarkeit und Verschreibung

Weltweite Perspektiven

Die Sicherstellung einer guten schmerztherapeutischen Versorgung von Tumor- und Nichttumorpatienten ist nicht nur ein deutsches, sondern ein weltweites Problem.

Das International Narcotics Control Bord (INCB) – eine Organisation der Vereinten Nationen – hat nachweisen können, dass die Angst vor Abhängigkeit den Hauptgrund für die mangelnde Verfügbarkeit und den zögernden Einsatz von Opioiden darstellt. Weitere Gründe sind unzureichende Ausbildung der Ärzte und restriktive, teils interessenorientierte Gesetze für Herstellung, Vertrieb und Verschreibung von Opioiden. Die Folge davon ist, dass Opioide in vielen Ländern gar nicht, unzureichend oder nur für einkommenstarke Bevölkerungsgruppen zur Verfügung stehen.

Durch Aktivitäten der WHO, vieler Schmerzgesellschaften und der Einsicht einiger Regierungen ist der Morphinverbrauch in den vergangenen zwei Jahrzehnten deutlich gestiegen. Dieser Anstieg ist aber ausschließlich durch die Länder zustande gekommen, die traditionsgemäß zu den führenden gehören (Dänemark, Großbritannien, Kanada, Norwegen, USA, Australien, Neuseeland, Irland, Island), und einigen wenigen, die sich endlich einer Verschreibung von Opioiden zugewendet haben (Schweiz, Österreich, Deutschland, Frankreich, Spanien, Japan, Polen ◘ Abb. 4.4).



◘ **Abb. 4.4.** Morphinverbrauch 1993–2003 im Ländervergleich. (Quelle: International Narcotics Control Board [90, 91])

Besonders eindrucksvoll ist der Anstieg des Morphinverbrauchs in Frankreich und Österreich (Abb. 4.4), zwei Länder, in denen auch die Palliativmedizin große Fortschritte gemacht hat. Im Gegensatz dazu ist die Morphinverschreibung in den Niederlanden von 1993–2003 nur von 9 auf 16,6 kg pro 1 Mio. Einwohner angestiegen, in Belgien von 7 auf 13,6 kg pro 1 Mio. Einwohner. In weiteren Teilen der Welt (Mittel- und Südamerika, Afrika, Asien) besteht eine extreme Unterversorgung von Schmerzpatienten mit Opioiden.

Deutschland

Deutschland gehört zu den Ländern mit steigender Morphinverschreibung. So stieg der Morphinverbrauch von 0,8 kg pro 1 Mio. Einwohner im Jahr 1985 auf 18,9 kg pro 1 Mio. Einwohner im Jahr 2003 (Abb. 4.5 [90, 91]). Gemessen am Bedarf bedeutet dies immer noch eine extreme Unterversorgung von Schmerzpatienten, die starke Opioide benötigen.

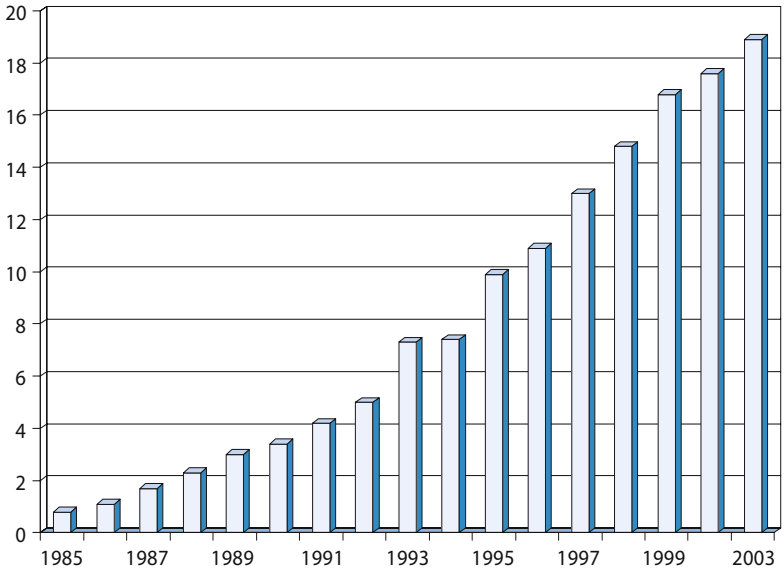


Abb. 4.5. Morphinverbrauch in Deutschland 1985–2003. (Quelle: International Narcotics Control Board [90, 91])

Folgende Hochrechnung soll die Unterversorgung belegen. Grundlage für die Berechnung ist der Einsatz von Morphin auf unserer Palliativstation, auf der ausschließlich Patienten im weit fortgeschrittenen Stadium ihrer Tumorerkrankung behandelt werden. Es handelt sich also um Patienten, die sich in aller Regel in ihrem letzten Lebensjahr befinden. Eine Analyse zu dem Einsatz von mittelstarken und starken Opioiden zum Entlassungszeitpunkt der Patienten aus dem Jahre 2005 zeigt, dass auf unserer Palliativstation 89% der Patienten starke Opioide erhielten nur bei 3% der Patienten mittelstarke Opioide zum Einsatz kamen. Dies unterstreicht die Diskussion, inwieweit die Stufe II des WHO Stufenschemas bei Patienten im fortgeschrittenen Tumorstadium relevant ist [197]. Als oral applizierte, retardierte Opioide kamen Morphin (38,2%) und Hydromorphon (47,9%) am häufigsten zur Anwendung, während nur 2,8% der entlassenen Patienten transdermales Fentanyl erhielten. Während bei Patienten, die nach Hause entlassen werden können, die nichtinvasive Applikation von Opioiden dominiert, ändert sich dies in der Finalphase. Während ca. 22% der Patienten bis zuletzt eine orale Medikamentengabe erhielten, stieg der Anteil der subkutanen Gabe auf 48% und der intravenösen Gabe auf 23% [153].

220.000 Menschen sterben pro Jahr in Deutschland an den Folgen ihrer Krebserkrankung; 70% dieser Patienten (154.000) haben Schmerzen; 84% davon (130.000) brauchen starke Opioide vom Typ des Morphins.

Davon benötigen

- 65% bis 120 mg, im Durchschnitt 60 mg/Tag;
- 20% bis 300 mg, im Durchschnitt 150 mg/Tag;
- 15% über 300 mg; im Durchschnitt 450 mg/Tag.

Daraus ergibt sich folgende Berechnung des Morphinbedarfs:

- 84.500 Patienten à 60 mg pro Tag – 21,9 g/Jahr/Patient = 1851 kg pro Jahr;
- 26.000 Patienten à 150 mg pro Tag – 54,75 g/Jahr/Patient = 1424 kg pro Jahr;
- 19.500 Patienten à 450 mg pro Tag – 164,25 g/Jahr/Patient = 3200 kg pro Jahr;

insgesamt 6475 kg pro Jahr.

Aus dieser Hochrechnung können wir jetzt folgende Schlussfolgerung ziehen: Bei einer notwendigen Verschreibung von ca. 6500 kg pro Jahr und einer Einwohnerzahl in Deutschland von 81 Mio. ergibt sich ein *Verschreibungsbedarf*

von ca. 80 kg Morphin pro 1 Mio. Einwohner. Realitität in Deutschland war 2003: 18,9 kg pro 1 Mio. Einwohner.

Selbst wenn diese Kalkulation auf der Basis eines kleinen Patientenkollektivs entstanden ist, halten wir diese Zahlen für grundsätzlich valide, und sie liegen eher an der unteren Grenze des Bedarfs, da noch diejenigen Patienten hinzukommen, die zwar Morphin benötigen, sich aber nicht im letzten Jahr ihrer Erkrankung befinden.

Sucht man nach Gründen der unzureichenden Verschreibung von Opioiden, so sind diese vielfältig und seit Jahren unverändert (▶ Kap. 4.4).

Ein großes Problem in der Schmerztherapie ist nicht nur darin zu sehen, dass zu selten starke Opioide verschrieben werden, sondern auch, dass sie bei Patienten sehr häufig nur einmal verschrieben werden [121].

Ein weiterer wichtiger Grund für eine unzureichende Schmerztherapie ist die Tatsache, dass keine Dosisanpassung an das Schmerzniveau erfolgt. Unsere Erfahrung ist, dass viele Ärzte zu Beginn einer Schmerztherapie keine Dosistitration durchführen; d. h. die Einstiegdosis ist identisch mit der Erhaltungsdosis, obwohl keine zufrieden stellende Schmerzreduktion erreicht worden ist. Bei Änderung der Schmerzintensität erfolgt keine Anpassung der Dosis an das neue Schmerzniveau.

Fazit

Starke Opioide werden zu selten verschrieben, zu niedrig dosiert, und die Dosis wird nicht angepasst.

Fragen zur Therapie mit Opioiden

Wie verhalte ich mich bei einer Schmerztherapie mit Opioiden ohne bisher ausreichende Schmerzlinderung?

Hat der Patient bisher ein schwaches Opioid »nach Bedarf« erhalten und nach der Einnahme vorübergehend eine gute Schmerzreduktion erlebt, sollte die regelmäßige Einnahme dieses Opioids nach festem Zeitschema entsprechend der Wirkdauer der Substanz gegeben werden. Ist das bisherige Applikationszeitintervall dieses Analgetikums sehr kurz, sollte auf eine Retardpräparation übergegangen werden.

Hat ein Patient ein schwaches Opioid in ausreichend hoher Dosis (Dosis unterhalb des Ceilingeffektes) erhalten und keine ausreichende Schmerzreduktion erlebt, dann sollte man mit einer Morphintherapie beginnen.

Wie beginne ich eine Therapie mit starken Opioiden?

Die *orale* Gabe von Opioiden ist die Methode der Wahl, wobei die Arzneimittel im *festen Zeitintervall* gegeben werden müssen. Im Folgenden soll aus Gründen der Übersichtlichkeit nur auf die Therapie mit Morphin und Hydromorphon eingegangen werden.

Die Einstiegdosis von Morphin berechnet sich aus der Äquivalenzdosis (◘ Tab. 4.5) zu dem zuvor eingesetzten Opioid. Dies ist nur ein grober Anhalt.

Opioidnaive Patienten in schlechtem Allgemeinzustand und/oder hohem Alter (über 80 Jahre) erhalten als Initialdosis 2,5-5 mg Morphinlösung (Rezeptur in ▶ Kap. 4.7.2, S. 242) oder die Morphinsulfattablette bzw. 5-10 mg Morphinsulfat-Retardtablette.

Patienten im guten Allgemeinzustand erhalten initial 5-10 mg Morphinlösung oder Morphinsulfattablette bzw. 30 mg Morphin-Retardtablette. Die Einstiegsdosis von Hydromorphon ist 4 mg alle 12 h.

Klagt der Patient über stärkste, sog. vernichtende Schmerzen, sollte er als »Schmerznotfall« behandelt werden und initial Morphin-i.v.-Boli von 2–5 mg erhalten, die unter ständiger Kontrolle im Abstand von 3–5 min wiederholt werden, bis der Patient eine deutliche Schmerzreduktion angibt (Alternative in ▶ Kap. 4.7.2, S. 241).

Ist der Patient sehr ängstlich, verzweifelt oder panisch, sollte die zusätzliche Gabe eines Benzodiazepins (z. B. Midazolam 1–5 mg i.v.) in Erwägung gezogen werden. Dies erfordert eine *kontinuierliche* Kontrolle durch einen *erfahrenen* Arzt oder ein erfahrenes Team. Solche Patienten sollten einem schmerztherapeutisch versierten Arzt (Schmerzpraxis, Ambulanz, Klinik, Palliativstation) zugewiesen werden.

Wie erfolgt die Anpassung von Opioiden (am Beispiel von Morphin und Hydromorphon)?

2 h nach Gabe der Einstiegsdosis als Morphinlösung oder Morphinsulfattablette bzw. 5 h nach der ersten Gabe der Morphin-Retardtablette sollte der schmerztherapeutische Erfolg überprüft werden. Ist eine *deutliche* Schmerzreduktion eingetreten, erhält der Patient regulär die gleich hohe Dosis alle 4 h (Morphinlösung und Morphinsulfattablette) bzw. alle 12 h (Morphin-Retardtablette).

Ist *keine* ausreichende Schmerzreduktion eingetreten, erhält der Patient nach diesen 2 bzw. 5 h die wiederholte Einstiegsdosis, und zum nächsten Einnahmezeitpunkt wird auf die doppelte Einstiegsdosis erhöht.

Die weitere Anpassung der Morphindosis erfolgt dann in folgenden Stufen:

- **Morphinlösung** (mg): 2,5 – 5 – 10 – 15 – 20 – 30 – 45 – 60 – 75 – 90 – 100 – 120 – 160 – 200 – 240 – 300 – 360.
- **Morphinsulfat-Tabletten** können bis zu Dosierungen von 60 mg alle 4 h wie die Morphinlösung verwendet werden; bei Einzeldosen über 60 mg ist in der Einstellungsphase die Morphinlösung vorzuziehen.
- **Morphinsulfat-Retardtabletten** (mg): 10 – 20 – 30 – 40 – 60 – 90 – 120 – 160 – 200.

Die Morphinlösung und die Morphinsulfattablette werden im Abstand von 4 h gegeben, die Morphinsulfat-Retardtablette im Abstand von 12 h; Verkürzungen des Intervalls sind bei adäquater Dosis selten notwendig. Bei niedrigem Tagesbedarf an Morphin kann dosisäquivalent alternativ zur Morphinlösung die Morphinsulfattablette, die Morphin-Retardkapsel, die Morphinsulfat-Retardtablette und das Morphinsulfat-Retardgranulat gegeben werden. Bei Schluckstörungen oder zur Applikation über eine PEG-Sonde kann bei zwölfstündiger Wirkdauer das Morphin-Retardgranulat als Trinksuspension gegeben werden.

Die Dosisanpassung von Hydromorphon mit der Retardkapsel führen wir wie folgt durch: Initial 2-mal 4 mg; bei nicht ausreichender Schmerzreduktion Erhöhung auf 3-mal 4, 2-mal 8, 2-mal 12, 3-mal 12, 2-mal 24, 2-mal 28, 2-mal 32, 2-mal 40, 2-mal 48 mg usw., bis eine zufrieden stellende Abnahme der Schmerzen erreicht ist und wenn im Verlauf keine Nebenwirkungen aufgetreten sind. Vorübergehende Müdigkeit ist in der Einstellungsphase die Regel, und bei weiterhin bestehenden Schmerzen sollte die Dosis auch nicht reduziert werden. Andererseits sollte eine weitere Dosissteigerung nur unter engmaschiger Kontrolle des Patienten erfolgen. Seit Mitte 2004 stehen mit Palladon 1,3/2,6 zwei Zubereitungen mit schnellem Wirkungseintritt und kurzer Wirkdauer (4 h) zur Verfügung. Sie sind geeignet zur Dosistitration während der Einstellungsphase und zur Therapie von Durchbruchschmerzen. Palladon 1,3 (1 Hartkapsel) entspricht 10 mg Morphin oral.

Verursachen Opioide eine Atemdepression?

Bei gesunden schmerzfreien Probanden erzeugt Morphin dosisabhängig Atemdepression. Bei Patienten mit starken Schmerzen tritt eine Atemde-

pression so lange nicht auf, wie man sich an dem Ausmaß der Schmerzreduktion orientiert. Schmerz gilt als Antagonist zu einer opioidinduzierten Atemdepression. Atemdepression ist ein Zeichen für eine relative Überdosierung.

Muss ich überhaupt keine Atemdepression bei Patienten mit einer Opioidtherapie befürchten?

Wenn bei einer laufenden Morphintherapie eine schmerztherapeutische Maßnahme dazukommt, die schlagartig den Schmerz ausschaltet, kann eine opioidbedingte Atemdepression auftreten.

Beispiel: Ein Patient erhält 600 mg Morphin-Retardtabletten als Tagesdosis; er klagt trotzdem noch über Schmerzen, verursacht durch Metastasen im Lendenwirbelbereich. Ein konsiliarisch hinzugezogener Kollege legt einen Periduralkatheter und appliziert 15 ml 0,375%iges Bupivacain-HCl; der Patient ist nach 15 min schmerzfrei, somnolent, entwickelt eine Lippenzyanose und hat nur noch 3–4 Atemzüge/min.

Kommentar: Ein solches Vorgehen ist ein *Kunstfehler.*

Korrektes Vorgehen: Erst die Morphindosis reduzieren; Patienten über Eintreten vorübergehender Schmerzverstärkung aufklären, dann (falls Indikation gerechtfertigt ist) Periduralkatheter legen und Bupivacain-HCl 10 ml 0,125%ig injizieren oder Morphin 5 mg in 10 ml 0,9%igem NaCl oder evtl. mit 10 ml 0,125%igem Bupivacain-HCl; anschließend engmaschige Kontrolle!

Muss ich bei Niereninsuffizienz die Opioiddosis reduzieren?

Morphin wird zu Morphin-3-Glukuronid und Morphin-6-Glukuronid abgebaut, die über die Nieren ausgeschieden werden. Morphin-6-Glukuronid ist ein aktiver analgetischer Metabolit, der kumulieren und damit zu Nebenwirkungen führen kann.

Deswegen muss bei einer Niereninsuffizienz die Morphindosis relativ frühzeitig reduziert werden. Dies gilt allerdings in eingeschränktem Maße auch für Fentanyl. Buprenorphin und Tilidin haben bei Niereninsuffizienz eine unveränderte Pharmakokinetik.

Haben Leberfunktionsstörungen Einfluss auf den Opioidabbau?

Erst ausgeprägte Leberfunktionsstörungen haben einen Einfluss auf den Metabolismus der Opioide und machen eine Dosisreduktion erforderlich.

Machen Opioide abhängig?

Weltweite Erfahrungen in der Tumorschmerztherapie haben zeigen können, dass psychische Abhängigkeit praktisch nicht auftritt (extreme Ausnahme).

Unsere eigenen, ca. 20-jährigen Erfahrungen mit Morphin und anderen Opioiden bestätigen diese Mitteilungen. Wir nehmen aber an, dass einige unserer Patienten eine physische Abhängigkeit entwickeln. Soll eine laufende Opioidtherapie abgesetzt werden, reduzieren wir aus diesem Grund die Opioiddosis stufenweise über einige Tage und sehen bei diesem Vorgehen keine Entzugssymptomatik. Gelegentlich berichten einweisende Ärzte über eine Opioidabhängigkeit. In der Regel haben diese Patienten eine inadäquate Opiattherapie erhalten, d. h. zu niedrige Dosis, zu lange Zeitintervalle, kein Zeitschema. Dieses Verhalten ist aber nicht als Abhängigkeit zu werten, sondern als Verlangen nach Schmerzreduktion anzusehen.

Richtiges Verhalten: adäquate Dosis, Dosisanpassung, Zeitschema entsprechend der Wirkdauer der Substanz und der Zubereitungsform, Therapiekontrolle.

Entwickelt sich rasch eine Opioidtoleranz?

Nein. Zu Beginn einer Morphintherapie unterschätzen auch sehr versierte Schmerztherapeuten die Schmerzintensität; d. h. die Einstiegsdosis ist in der Regel zu niedrig. In der Einstellungsphase muss eine Dosisanpassung erfolgen, bis der Patient eine zufrieden stellende Schmerzreduktion angibt; bei unzureichender Schmerzlinderung erfolgt die Dosissteigerung, bis Nebenwirkungen eine weitere Dosiserhöhung verbieten. Die Dosiserhöhungen in der Einstellungsphase stehen somit nicht im Zusammenhang mit einer etwaigen Toleranzentwicklung. Die Anhebung des Opioiddosisbedarfs während einer laufenden Opioidtherapie hingegen kann in der Regel auf eine Tumorprogression zurückgeführt werden. Bei vielen Patienten können wir im Verlauf der Erkrankung die Opioiddosis reduzieren; auch dies spricht gegen eine Toleranzentwicklung gegenüber dem analgetischen Effekt.

Beschleunigen Opioide den Eintritt des Todes?

Nein, wenn die Opioide nach den zuvor dargestellten Regeln angewendet werden! Morphin beispielsweise ist ein hochpotentes Opioid; selbstverständlich kann eine *nicht adäquate Dosis* in der Agonie den Eintritt des Todes beschleunigen. Deswegen muss auch in dieser Phase eine Dosisanpassung erfolgen. Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass bei 30% der

Patienten in der Sterbephase die Opioiddosis erhöht werden muss, weil die Schmerzintensität zunimmt. Bei 20% der Patienten müssen wir die Opioiddosis reduzieren. Bei 50% der Patienten ist eine Dosisänderung nicht notwendig. Aus diesen Verläufen muss gefolgert werden, dass ein Arzt bis zum Tod eines Patienten die Schmerztherapie überwachen und bedarfsgerecht anpassen muss.

Muss man Opioide häufig absetzen, weil Patienten sie nicht vertragen?

Nein! Wenn die Grundregeln einer Opioidtherapie berücksichtigt werden, sind Opioide sichere Arzneimittel, die gut verträglich sind. Voraussetzung ist die Kenntnis der Nebenwirkungen und deren Verhinderung durch Prophylaxe. Häufigste Nebenwirkungen sind Übelkeit, Erbrechen und insbesondere Obstipation; diese können jedoch durch adäquate Prophylaxe (▶ Kap. 4.7.3, S. 259ff.). verhindert werden.

Opioide und Fahrtüchtigkeit

Opioide haben Nebenwirkungen, die die Fahrtüchtigkeit in Frage stellen können. Im Vordergrund stehen Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Abnahme der Reaktionsfähigkeit, extrem selten Verwirrtheit oder Halluzinationen [108, 125, 129, 176, 191, 204].

Die Bochumer Arbeitsgruppe um Zenz und Strumpf [191] kam nach eigenen Untersuchungen und den Ergebnissen aus der Literatur zu folgenden Empfehlungen:

- Eine Opioidtherapie führt nicht zwangsläufig zu einer Beeinflussung der Leistungsfähigkeit bei komplexen sensomotorischen Handlungen.
- Der Arzt hat vor Beginn einer Opioidtherapie Aufklärungspflicht bezüglich der Wirkungen, Nebenwirkungen und verkehrsrelevanten Beeinträchtigungen durch die Opioide.
- Die Aufklärung muss dokumentiert werden.
- Die Fahrzeugführung muss in der Einstellungsphase auf Opioide bei Dosiskorrekturen (Erhöhung, Reduktion), bei Wechsel des Opioids und bei schlechtem Allgemeinzustand des Patienten unabhängig von der Opioidtherapie untersagt werden.
- Eine Therapiekontrolle mit Dokumentation ist obligatorisch; diese muss den physischen und psychischen Zustand des Patienten, den Therapieerfolg und Nebenwirkungen umfassen.

- Der Fahrzeugführung kann aus ärztlicher Sicht zugestimmt werden, wenn der Therapieverlauf stabil ist, ein guter Allgemeinzustand gegeben ist und der Patient auf seine Pflicht zur kritischen Selbstprüfung hingewiesen wird.
- Im Zweifelsfall sollte sich der Patient einer Leistungsüberprüfung durch den örtlich zuständigen Technischen Überwachungsverein (TÜV) unterziehen.

4.7.3 Adjuvante Substanzen

Antiemetika [171]

Erbrechen ist ein Symptom, das ganz unterschiedliche Ursachen hat. Dazu gehören u. a. Gastroenteritiden, (Sub-)Ileus, Magenausgangsstenosen, akutes Abdomen, erhöhter Hirndruck, metabolische Störungen (z. B. Urämie, Hyperkalzämie), Arzneimittel (Opioide, Zytostatika) [4].
Übelkeit und Erbrechen werden ausgelöst durch

- afferente Impulse aus dem oberen Gastrointestinaltrakt an das Brechzentrum in der Formatio reticularis der Medulla oblongata,
- Erregung von Chemorezeptoren in der Area postrema der Medulla oblongata (Chemorezeptortriggerzone, CTZ),
- Vestibularisreizung, Hirndrucksteigerung,
- psychische (visuelle oder olfaktorische) Stimuli.

Ist nach der körperlichen Untersuchung, den technischen Zusatzuntersuchungen und Laborbefunden eine symptomatische oder begleitende Therapie indiziert, kommen als antiemetische Substanzen Antihistaminika, Neuroleptika, Anticholinergika, prokinetische Substanzen, 5-HT_3-Antagonisten [46] und evtl. Glukokortikoide zur Anwendung. Einzelheiten sind ◘ Tab. 4.8 zu entnehmen. Grundsätzlich ist eine Prophylaxe wirksamer als die Behandlung.

Um einer *opioidinduzierten* Emesis vorzubeugen, verwenden wir Haloperidol und/oder Metoclopramid/Cisaprid prophylaktisch als Mittel der Wahl. Führt das nicht zum Erfolg, geben wir zusätzlich Cyclizin (kann über die internationale Apotheke bestellt werden). Nach 7 Tagen kann das Antiemetikum versuchsweise abgesetzt werden, da gegenüber der emetischen Wirkkomponente des Opioids in der Regel eine Toleranz entsteht. Glukokortikoide sind bei hirndruckbedingter Nausea und Emesis Mittel der Wahl.

Tab. 4.8. Antiemetika

Substanzgruppe	Freiname	Handelsname	Dosis [mg]	Intervall [h]	Kommentar
Antihistaminika	Dimenhydrinat Meclozin Cyclizin	Vomex-A Bonamine Valoid, Marzine	100–200 25–50 50	8 12 (–24) 8	Antihistaminika wirken sedierend, bewirken Mundtrockenheit. In Deutschland nicht im Handel (Cyclizin)
Neuroleptika					Sedierend, orthostatische Regulationsstörung
Phenothiazine	Triflupromazin	Psyquil	10–20	(6–) 8	Leicht sedierend
	Levomepromazin	Neurocil	3	8	Als Ultima Ratio, Breitbandantiemetikum, stark sedierende, gute antiemetische Wirkung
Butyrophenone	Haloperidol	Haldol	0,3–0,5	8–12	Routinemäßig prophylaktisch verwendetes Antiemetikum in der Tumorschmerztherapie; nicht sedierend in dieser Dosierung
Anticholinergika	Scopolamin	Scopoderm TTS	1 Pflaster	3 (–4) Tage	Leicht sedierend, Mundtrockenheit, Mydriasis
		Scopolamin hydrobromicum	0,2–0,4 s.c.	8	
Prokinetische Substanzen	Metoclopramid	Paspertin	10	4–5	Routinemäßig verwendetes Antiemetikum in der Tumorschmerztherapie; nicht sedierend; erzeugt keine Mundtrockenheit; evtl. Dyskinesie
	Domperidon	Motilium	10	4–6	Dopaminantagonist mit hauptsächlich peripherer Wirkung; direkte Blockade der Dopaminrezeptoren in der Chemorezeptorentriggerzone: leichte Sedierung und Mundtrockenheit bei höherer Dosis (100 mg p.o.)

5-HT_3-Antagonisten	Ondansetron	Zofran	4–8	8–12	Blockierung der 5-HT_3-Rezeptoren in der Chemorezeptorentriggerzone; keine extrapyramidalen NW; evtl. Obstipation
Glukokortikoide	Dexamethason	Fortecortin	4–8	8–24	Bei Hirndruckerhöhung mit peritumorösem Ödem und bei zytostatikabedingtem Erbrechen evtl. deutlich höhere Dosis erforderlich
Cannabinoide	Cannabis	Marinol	2,5–5	6–8	
Benzodiazepine	Lorazepam	Tavor	0,5–2	8–12	Bei emotional bedingter Nausea und Emesis

Tab. 4.9. Laxanzien. **Beachte:** Die angegebene Dosis bezieht sich auf die Symptomkontrolle bei Tumorpatienten

Laxanzien nach Wirkprinzipien	Wirkgruppe	Wirkstoff und/oder Freiname	Enthalten in und/oder Handelsname	Dosis	Latenzzeit [h]	Kommentar
I. Quellstoffe		Weizenkleie Indischer Flohsamen Leinsamen	Normacol Agiolax	10–30 mg	initial 24–72, danach 8–24	Nach der Mahlzeit mit genügend Flüssigkeit nehmen, nahezu nebenwirkungsfrei
II. Osmotisch wirksame Laxanzien	Salinische Laxanzien	Magnesiumsulfat= Bittersalz		10–20 g	2–8	Schwer resorbierbare Salze; machen den Darminhalt weich
		Natriumsulfat = Glaubersalz		10–20 g	2–8	
	Zuckeralkohole	Mannit/Mannitol	Mannit-Lösung 10/20%	1 Klysma		
		Sorbit	Microklist	1 Klysma	0,5–2	

Tab. 4.9. *Fortsetzung*

Laxanzien nach Wirkprinzipien	Wirkgruppe	Wirkstoff und/oder Freiname	Enthalten in und/oder Handelsname	Dosis	Latenzzeit [h]	Kommentar
	Zucker	Laktulose	Bifiteral	10–20 g	48	Wird im Dickdarm in Milchsäure und Essigsäure gespalten, durch Wasserretention Stimulation der Peristaltik
	Polyethylen-Glykol	Macrogol 3355	Movicol	13–40 g	1–3 Tage	Osmotische Wasserretention im Darmlumen; wird unverändert ausgeschieden
III. Antiresorptiv und hydragog wirkende Laxanzien	Anthraglykosid	Sennosid B	Liquidepur	10–20 ml	12	Relativ große therapeutische Breite, Hemmung der Na^+- und H_2O-Resorption und vermehrte H_2O- und Elektrolytabgabe in das Darmlumen
	Phenolphthalein	Bisacodyl	Dulcolax-Drag. Dulcolax-Supp.	10 mg 10 mg	oral: 5–10 rektal: 15–60 min	Spezifische, unerwünschte Wirkungen nicht bekannt
		Natriumpicosulfat	Laxoberal	5–10 mg	2–4 (8)	Keine spezifischen Nebenwirkungen
	Rizinusöl	Rizinusöl	Rizinuskapseln Pohl	4–6 g	2–6	drastisch wirkend
IV. Gleitmittel		Docusat-Natrium Paraffin	Agaroletten Obstinol mild	25–50 mg 10–30 ml	12–48 8–12	Durch Wasseranreicherung weicher Stuhl
V. Laxanzien mit Wirkung auf den Defäkationsreflex	Alkohole	Sorbit Glycerol	Mikroklist Glycilax-Supp.	1 Klysma 1 Supp.	0,5–1	

Laxanzien

Obstipation ist bei fortgeschrittener Tumorerkrankung ein häufiges Symptom. Sie kann so hartnäckig sein, dass es manchmal schwieriger ist, die Obstipation zu behandeln als den Schmerz.

Obstipation ist entweder durch eine verzögerte Darmpassage oder einen gestörten Entleerungsreflex bedingt. Ursachen für eine verzögerte Darmpassage sind u. a. ballaststoffarme Ernährung, Tumoren, Arzneimittel (besonderes Opioide). Ein gestörter Defäkationsmechanismus kommt u. a. bei Hämorrhoiden, Analfissuren, Verlust des rektalen Dehnungsreflexes und Schwäche der Bauchpresse vor.

Laxanzien beschleunigen die Stuhlentleerung durch intraluminale Volumenvermehrung, Erhöhung der Gleitfähigkeit des Darminhalts, Erhöhung der Peristaltik durch pH-Änderungen oder Angriff an der glatten Muskulatur.

Opioide haben eine ausgeprägte obstipierende Wirkung, die sowohl durch eine Herabsetzung der Darmmotilität und der intestinalen Sekretion als auch durch Wirkung auf zerebrale und spinale Rezeptoren bedingt ist.

Sie zeigt keine Toleranzentwicklung. Die Obstipation ist die häufigste [101] und hartnäckigste Nebenwirkung bei der Schmerztherapie mit Opioiden. Deswegen muss immer mit Beginn einer Therapie mit starken Opioiden eine Begleitmedikation mit Laxanzien erfolgen (◘ Tab. 4.9).

Basismaßnahmen zur Unterstützung einer Laxanstherapie sind Mobilisation des Patienten und Gabe von ballaststoffreicher Kost und reichlich Flüssigkeit (Fruchtsäfte); Maßnahmen also, die bei fortgeschrittener Tumorerkrankung häufig nicht möglich sind.

Ein medikamentöses »Stufenschema« der Laxanzientherapie bei Opioidgabe kann so aussehen wie in ▶ Kap. 4.7.2, S. 235.

Glukokortikoide

Glukokortikoide spielen in der Tumorschmerztherapie eine wichtige Rolle. Der Grund liegt in deren antiödematösen, antiphlogistischen und allgemein roborierenden Wirkungen. Außerdem wird, basierend auf der Hypothese der Prostaglandinhemmung durch Glukokortikoide, ein direkt analgetischer Effekt angenommen, dessen klinische Relevanz noch unklar ist.

Wenn ein peritumoröses Ödem Schmerzen auslöst oder verstärkt, sind Glukokortikoide indiziert (◘ Tab. 4.10).

Tab. 4.10. Indikationen und Dosierungen einer Therapie mit Glukokortikoiden

Indikation	Anfangsdosierung mit Dexamethason
Erhöhter intrakanieller Druck	16–40 mg
Nervenkompression, insbesondere bei Tumorinfiltration des Plexus brachialis oder Plexus lumbosacralis	8–16 mg
Rückenmarkkompression	16–32 mg
Leberkapselspannungsschmerz	6–8 mg
Tumoren im kleinen Becken, im Retroperitoneum	6–8 mg
Weichteilinfiltration	6–8 mg
Lymphödem	6–8 mg
Metastasenbedingte Gelenkschmerzen	6–8 mg
Atemwegsobstruktion	4–6 mg
Steigerung des Appetits	2–4 mg
Verminderung der Übelkeit	4–8 (16) mg
Stimmungsaufhellung	4 mg
Therapie einer Hyperkalzämie	4–8 mg

Als Nebenwirkungen einer Langzeitsteroidtherapie sind Osteoporose, Ulzera im Gastrointestinaltrakt, Erhöhung des Blutzuckerspiegels mit der Gefahr einer Entgleisung des Zuckerhaushalts bei Patienten mit Diabetes mellitus und Exazerbation von Infektionen möglich. Vorbestehende Erkrankungen aus diesem Nebenwirkungsbereich schränken den Einsatz von Kortikoiden ein.

Relevante **Kontraindikationen** für eine kurze Zeit dauernde Steroidbehandlung bei dringlicher Indikation gibt es nicht; eine Ausnahme ist die Herpes-simplex-Infektion am Auge.

Relative **Kontraindikationen** für eine langfristige Steroidtherapie sind eine Ulkusanamnese, ausgeprägte Osteoporose und chronische, bakterielle Infekte (besonders Tuberkulose).

Ist die Indikation zum Einsatz von Glukokortikoiden gegeben, sollte Folgendes berücksichtigt werden:

- ausreichend hohe Initialdosis,
- in der Regel morgendliche Einnahme,
- Dosisreduktion nach 4 Tagen,
- Erhaltungsdosis nach 14–21 Tagen,
- Langzeitanwendung ist selten notwendig; wenn, dann in niedrigster Dosierung (**Cave:** oben angegebene Nebenwirkungen und Kontraindikationen).

Dexamethason bevorzugen wir wegen der deutlich appetitfördernden, psychostimulierenden und ausschließlich glukokortikoiden Wirkung; gleichzeitig hat es praktisch keine Na^+-retinierende Eigenschaft (Tab. 4.11).

Antidepressiva

Antidepressiva (Tab. 4.12) setzen wir in der Tumorschmerztherapie fast ausschließlich zur Behandlung neuropathischer Schmerzen mit Brennschmerzkomponente ein. Diese sind auf eine Schädigung peripherer oder zentraler Nerven zurückzuführen. Nerveninfiltration oder Nervenkompression durch Tumorwachstum, Polyneuropathien nach Chemotherapien, Strahlenbehandlungen, operative Nervenläsionen u. a. können Ursachen dieser Schmerzen sein. Die Schmerzreduktion wird mit niedriger Dosierung erreicht und tritt innerhalb weniger (2–4) Tage ein [184].

Antikonvulsiva

Antikonvulsiva (Tab. 4.13) sind bei einschießenden neuropathischen Schmerzen indiziert. Nerveninfiltration oder Nervenkompression durch Tumorwachstum, Zustand nach Amputation u. a. können Ursache dieser Schmerzform sein [25, 26, 95, 133, 175, 196].

Die Therapie mit Antikonvulsiva erfolgt einschleichend mit stufenweiser Steigerung, da besonders initial mit Nebenwirkungen gerechnet werden muss.

Tab. 4.11. Auswahl verschiedener Kortisonpräparate. Die gluko- und mineralokortikoide Wirkung von Prednisolon und Dexamethason ist in Relation zu derjenigen von Kortison gesetzt.

Freiname	Handelsname	Therapeut. Äquivalenzdosis [mg]	Glukokortikoide Wirkung	Mineralokortikoide Wirkung	Dosierung initial [mg/Tag]	Erhaltungsdosis [mg/Tag]	Kommentar
Kortison	Cortison-Ciba	50	1,0	1,0			Verwenden wir nicht in der Tumorschmerztherapie.
Prednisolon	Decortin-H	10	4,5	0,3	30–100	10–15	Aus Kostengründen in den USA häufiger eingesetzt.
Dexamethason	Fortecortin	1,5	37,5	0	6–40	1,5–3	Kortikosteroid der Wahl in der Tumorschmerztherapie, u. a. wegen fehlender mineralokortikoider Wirkung.

Tab. 4.12. Antidepressiva

Freiname	Handelsname	Dosis [mg]	Dosissteigerung [mg] bis	Kommentar
Amitriptylin	Saroten	10	75	Müdigkeit, Mundtrockenheit Obstipation, Schwitzen, Schwindel, orthostatische Regulationsstörungen, Harnverhalt, Herzrhythmusstörungen
Doxepin	Aponal	10	75	

Tab. 4.13. Antikonvulsiva

Freiname	Handelsname	Dosis [mg]	Dosissteigerung [mg] bis	Kommentar
Carbamazepin	Tegretal	100	800	Müdigkeit, Schwindel
Clonazepam	Rivotril	0,3	2(–3)	Herzrhythmusstörungen
Phenytoin	Zentropil	100	300	
Gabapentin	Neurontin	100	2.400	Relativ nebenwirkungsarm

Benzodiazepine

Benzodiazepine haben anxiolytische, sedativ-hypnotische, antikonvulsive und muskelrelaxierende Wirkungen (Tab. 4.14–4.17 [115]).

Bei psychoreaktiven Schlafstörungen sind Benzodiazepine Mittel der ersten Wahl. Die Verordnung der Substanz richtet sich nach pharmakokinetischen Eigenschaften und danach, ob Ein- und/oder Durchschlafstörungen vorliegen.

Diazepam, Flunitrazepam, Lormetazepam, Midazolam, Nitrazepam, Temazepam, Triazolam sind stark *sedativ* wirkende Benzodiazepine. Wir setzen bevorzugt bei Einschlafstörungen Midazolam (7,5 mg) und bei Durchschlafstörungen Flunitrazepam (1–2 mg) ein.

Klinisch relevante Interferenzen mit einer Schmerztherapie mit Opioiden haben wir bisher nicht beobachtet.

Soll der *anxiolytische* Effekt der Benzodiazepine im Vordergrund stehen, bevorzugen wir Lorazepam in einer Dosierung von 1,0–2,5 mg oder Bromazepam (6 mg).

Ausgeprägt *antikonvulsiv* wirkende Benzodiazepine sind Clonazepam, Nitrazepam und Diazepam, wobei die beiden letzteren gleichzeitig

Tab. 4.14. Benzodiazepine als Anxiolytika

Freiname	Handelsname	Standarddosis [mg]	HWZ [h]
Bromazepam	Lexotanil	3–6	18–20
Dikalium-chlorazepat	Tranxilium	10	1,5–2,5 (aktiver Metabolit 50–80)
Lorazepam	Tavor	1,0	12–18
Oxazepam	Adumbran	10,0	8–15

Tab. 4.15. Benzodiazepine als Schlafmittel

Freiname	Handelsname	Standarddosis [mg]	HWZ [h]
Diazepam	Valium Roche	5	20–50
Flurazepam	Dalmadorm	15,0	2–3 (aktiver Metabolit 2–4 Tage)
Flunitrazepam	Rohypnol	1,0	14–24
Lormetazepam	Noctamid	1,0	11,5
Midazolam	Dormicum Roche	7,5	1,5–2,5
Nitrazepam	Mogadan Roche	5,0	26–38
Temazepam	Planum	10,0	12,5
Triazolam	Halzion	0,25	2–5
Zopiclon	Ximovan	7,5	6–8

Tab. 4.16. Benzodiazepine als Antikonvulsiva

Freiname	Handelsname	Standarddosis [mg]	HWZ [h]
Clonazepam	Rivotril	0,3–3,0	20–40
Nitrazepam	Mogadan Roche	5	25

Tab. 4.17. Benzodiazepine als Muskelrelaxanzien

Freiname	Handelsname	Standarddosis [mg]	HWZ [h]
Diazepam	Valium Roche	5	20–50
Tetrazepam	Musaril	25–50	10–25

ausgeprägt sedativ wirken. Clonazepam ist deswegen das Benzodiazepin der Wahl bei einschießenden, neuropathischen Schmerzen; es wird einschleichend in einer Dosierung von 0,3 mg gegeben und allmählich auf eine Tagesdosis von 2,0 mg gesteigert.

Benzodiazepine mit ausgeprägter *muskelrelaxierender* Wirkung sind Diazepam und Tetrazepam, wobei Tetrazepam nur geringe anxiolytische, sedierende und antikonvulsive Wirkungen aufweist.

Neuroleptika

Neuroleptika spielen in der Schmerztherapie bei Tumorpatienten eine untergeordnete Rolle. Großen Stellenwert besitzen sie in niedriger Dosierung zur Prophylaxe und Therapie von Übelkeit und Erbrechen (s. dort) und hochdosiert bei motorischer Unruhe und deliranten Zuständen oder terminaler Agitation.

Levomepromazin (Neurocil)

Levomepromazin hat einen stark sedierenden, geringen antipsychotischen, guten antiemetischen und mäßig starken antidepressiven Effekt mit blutdrucksenkender Nebenwirkung. Bei motorischer Unruhe und terminaler Agitation wird es in einer Dosierung von 10–50 mg vierstündlich p.o., s.c. oder i.m. gegeben [137]. Zur Therapie der Übelkeit wird es in einer Dosierung von 3 x 3 mg (3 x 3 Tr.) p.o. gegeben.

Haloperidol (Haldol Janssen)

Haloperidol ist ein hochpotentes Neuroleptikum, gering sedierend, gut antiemetisch und vergleichbar zu Levomepromazin antidepressiv wirksam.

Haloperidol ist das Mittel der Wahl zur Prophylaxe und Therapie opioidbedingter Nausea und Emesis in einer Dosierung von 0,3–0,5 mg alle 8 h.

Die Tagesdosis zur Therapie einer terminalen Agitation beträgt 5–40 mg, zur Therapie eines deliranten Syndroms 1,5–6 mg p.o., s.c. oder i.v. [137].

Antiarrhythmika

Oral und intravenös appliziertes Mexiletin ist sowohl bei einschießenden neuropathischen als auch bei neuropathischen Dauerschmerzen wirksam.

Die Indikation zum Einsatz dieser Substanz sollte erst gestellt werden, wenn die neuropathischen Schmerzen mit anderen Begleitmedikamenten zu

einer Therapie mit Opioiden (Antidepressiva, Antikonvulsiva) nicht erfolgreich behandelt werden konnten.

Vor Beginn einer Therapie mit Mexiletin müssen u. a. kardiale Kontraindikationen ausgeschlossen werden. Nach einer Einstiegsdosis von 150 mg/Tag erfolgt eine kontrollierte Dosissteigerung alle vier Tage um 100–150 mg, bis die Maximaldosis von 900 mg erreicht wird, wenn nicht zuvor Nebenwirkungen eine Dosissteigerung verbieten [41, 161].

Bisphosphonate [130]

Bisphosphonate hemmen die Osteoklastenaktivität, wobei drei Wirkmechanismen diskutiert werden: die direkte sowie die indirekte Hemmung der Osteoklastentätigkeit und die Reduktion der Anzahl der Osteoklasten.

Im Rahmen der palliativmedizinischen Behandlung von Tumorpatienten bestehen drei Indikationen für Bisphosphonate:

- Hyperkalzämie – hier sind Bisphosphonate neben der Basistherapie die Mittel der Wahl (▶ Kap. 4.10.6: »Hyperkalzämie«);
- Knochenschmerzen;
- Osteolysen.

Malignomassoziierte Hyperkalzämien sind besonders häufig beim Lungen- und Mammakarzinom und beim multiplen Myelom.

Hinweis: Die Infusionslösungen müssen kalziumfrei sein, sonst kommt es zu einer Ausfällung schwer lösbarer Kalziumkomplexe. Die Gesamtdosis pro Behandlungszyklus richtet sich nach dem anfänglichen Kalziumspiegel im Serum (Tab. 4.18).

Ibandronsäure (Bondronat)

Einmalinfusion von 2–4 mg in 500 ml 0,9%iger Kochsalzlösung. Normokalzämie wird innerhalb von 3–7 Tagen erreicht und hält etwa 11–12 Tage an; mit einem Wiederanstieg des Kalziumwertes ist nach 18 Tagen zu rechnen [45].

Pamidronsäure (Aredia)

Die Gesamtdosis (15–60–90 mg) von Pamidronsäure richtet sich nach dem anfänglichen Kalziumspiel im Serum des Patienten. Sie kann als Einzelinfusion oder in mehreren Infusionen über 2–4 Tage gegeben werden. Eine Senkung des Kalziumspiegels tritt nach 24–48 h ein, eine Normalisierung

Tab. 4.18. Dosierungshinweise für verschiedene Bisphosphonate bei Hyperkalzämie

Bisphosphonat	Applikation (i.v.)	Infusionsdauer [h]	Gesamtdosis [mg]	Eintritt der Senkung des Kalziumspiegels (Tage)	Dauer der Wirkung (Tage)
Clodronsäure (Ostac)	300 mg in 500 ml 0,9%iger NaCl-Lösung	> 2	300–3000 an 1–10 Tagen	2–3	7–21
Ibandronsäure (Bondronat)	2–4 mg in 500 ml 0,9%iger NaCL-Lösung	> 2	2–4 an 1 Tag	3–7	18
Pamidronsäure (Aredia)	15 mg in 125 ml 0,9%iger NaCL-Lösung	> 1	15–90 an 2–4 Tagen	2	21–28

wird nach 3–7 Tagen erreicht. Bei Wiederansteigen des Kalziumspiegels kann die Pamidronbehandlung wiederholt werden. Jeweils 15 mg Pamidronsäure werden in 125 ml 0,9%igem NaCl gelöst. Die Lösung muss kalziumfrei sein, da es sonst zu einer Ausfällung schwer lösbarer Kalziumclodronatkomplexe kommt; 30 mg des Wirkstoffs können innerhalb von 2 h gegeben werden.

Clodronsäure (Ostac)

Pro Tag werden 300 mg (1 Amp.) bis zur Normalisierung des Kalziumspiegels gegeben; 300 mg Clodronsäure werden in 500 ml 0,9%iger Kochsalzlösung über mindestens 2 h langsam infundiert. Eine tägliche Wiederholung der Infusion erfolgt, bis der Kalziumwert sich normalisiert hat. Die Behandlung sollte nicht länger als 10 Tage erfolgen. Eine Kalziumsenkung tritt nach 2–3 Tagen ein; die volle Wirkung ist nach 4–8 Tagen erreicht und hält ca. 1–3 Wochen an.

4.8 Exemplarische Therapiepläne

In ▶ Kap. 4.3 ist die Pathophysiologie der Schmerztypen dargestellt worden. Anhand der Differenzierung in somatische und viszerale Nozizeptorschmerzen sowie in neuropathische Schmerzen mit ihrer neuralgiformen Erscheinungsform bzw. mit brennender Komponente ergeben sich therapeutische Strategien.

In aller Regel ist die Tumorschmerztherapie eine Kombinationstherapie aus Monosubstanzen. Die Kunst des Therapeuten besteht darin, die richtigen

Arzneimittel in der richtigen Kombination, der adäquaten Dosierung und Dosisanpassung und im richtigen Zeitintervall einzusetzen. Dies betrifft sowohl Analgetika als auch Begleitmedikamente.

Anhand der pathophysiologischen Einteilung der Schmerztypen lassen sich vier grundlegende schematische Therapiepläne erstellen. Bei Vorliegen von nozizeptiven und neuropathischen Schmerzen ergeben sich zusätzliche Medikationskombinationen, die von den dargestellten Therapieplänen abgeleitet werden können.

Somatischer Nozizeptorschmerz

- Starkes Opioid, z. B. Hydromorphon, Morphin
- Ibuprofen
- Metamizol
- Dexamethason
- Laxans
- Antiemetikum

Beispiel: Knochenmetastasen

Viszeraler Nozizeptorschmerz

- Mittelstarkes Opioid oder starkes Opioid niedrig dosiert
- Metamizol
- Dexamethason
- Laxans
- Antiemetikum

Beispiel: Leberkapselspannungsschmerz

Neuropathischer Schmerz (neuralgiform)

- Starkes Opioid, z. B. Hydromorphon, Morphin
- Ibuprofen
- Carbamazepin
- Dexamethason
- Laxans
- Antiemetikum

Beispiel: Plexus-brachialis-Infiltration

▼

Neuropathischer Schmerz mit Brennschmerz

- Starkes Opioid, z. B. Hydromorphon, Morphin
- Ibuprofen
- Dexamethason
- Amitriptylin
- Laxans
- Antiemetikum

Beispiel: Plexus-brachialis-Infiltration

Anhand eines somatischen Nozizeptorschmerzes soll im Folgenden ein Schmerztherapieplan mit Zeitschema dargestellt werden.

Beispiel aus der Praxis

Ossäre Nozizeptorschmerzen; Prostatakarzinom

- Patient: H.S., männlich – 79 Jahre (Abb. 4.6).
- Diagnosen:
  - Prostatakarzinom,
  - multiple Knochenmetastasen,
  - pathologische Rippenfrakturen V–VIII rechts und IV–IX links,
  - gekammerter Pleuraerguss links bei Verdacht auf Pleurokarzinose,
  - COPD.
- Schmerzen:
  Seit einem halben Jahr zunehmende Schmerzen im Bereich des linken Thorax und der Schulter mit deutlicher Verstärkung in den letzten zwei Monaten. Die Schmerzen werden im Bereich der linken Thoraxseite bis paravertebral links als dumpf, drückend, nicht ausstrahlend, nicht einschießend, nicht brennend angegeben.
- Bisherige Schmerztherapie:
  Unregelmäßige Einnahme verschiedener mittelstarker Opioide (Tramadol, Tilidin N) und Nichtopioide. Schwierige Anamneseerhebung mit Unklarheiten bezüglich Wirkung und Nebenwirkungen der bisherigen Schmerztherapie.
- Jetzt eingeleitete Schmerztherapie:
  Siehe Tab. 4.19.

Kommentar:
Zeitgleich mit Beginn der medikamentösen Schmerztherapie palliative Bestrahlung im Bereich der pathologischen Frakturen. Die Bestrahlungstherapie stellte allerdings für den Patienten eine so große Belastung dar, dass in Rücksprache mit dem behandelnden Kollegen auf eine Fortsetzung der Radiatio verzichtet wurde. Eine sukzessive Dosissteigerung bis auf 2-mal 40 mg Palladon führte zu einer deutlichen Schmerzreduktion, die für den Patienten zufrieden stellend war. Prophylaktische, antiemetische Medikation, die nach 5 bzw. 7 Tagen abgesetzt werden konnte, ohne dass es zum Auftreten von Übelkeit und Erbrechen kam.

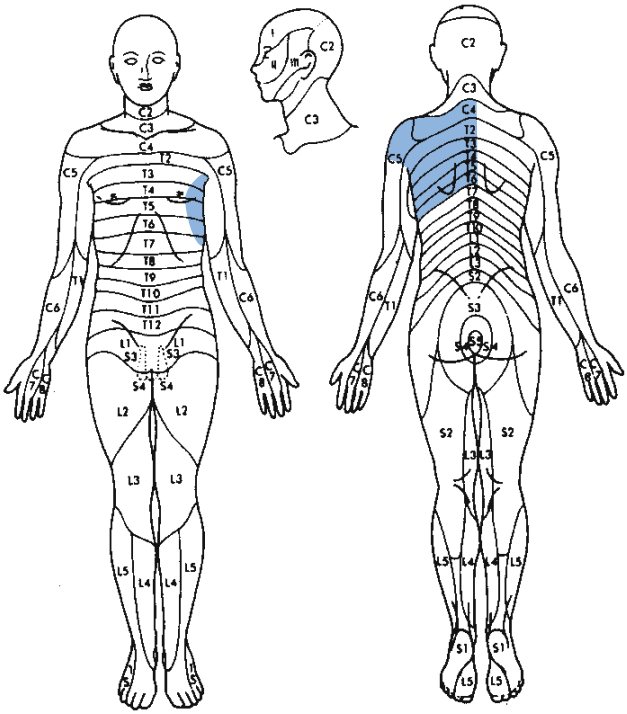


Abb. 4.6. Patient H.S. aus dem Fallbeispiel

Tab. 4.19. Exemplarischer Therapieplan (→ wie zuvor; ∅ abgesetzt)

	13.10.	15.10.	17.10.	19.10.	21.10.	27.10.	29.10.	03.11.	04.11.
Hydromorphon (Palladon) [mg]	16	24	→	48	→	72	96	120	→
Ibuprofen (Ibubeta 800) [mg]	2 400	→	→	→	→	→	→	→	→
Metamizol (Novalgin) [g]	5	→	→	→	→	→	→	→	→
Haloperidol (Haldol) [gtt]	5	→	→	→	→	→	→	∅	
Flupiritin (Katadolon) [mg]					300	→	→	→	→
Dexamethason (Fortecortin) [mg]						8	→	6	→
Metoclopramid (MCP Retard) [mg]	60	→	→	→	→	∅			
Natriumpicosulfat (Laxoberal) [gtt]	20	→	→	→	→	∅			
Macrogol (Movicol) (Btl.)	1	→	→	→	→	→	→	→	→
VAS R	8	5	4	3	3	2	2	1	1
VAS B	8	6	6	6	4	3	4	2	2

4.9 Strahlentherapie in der Palliativmedizin

In der Praxis wird der Stellenwert der palliativen Strahlentherapie auch im Rahmen der palliativmedizinischen Betreuung leider häufig unterschätzt. Es geht nicht nur um die Behandlung von Schmerzen, sondern auch um die Besserung, Beseitigung oder Verhinderung unterschiedlichster Befindlichkeitsstörungen und Symptome [180].

Hauptindikationen zur palliativen Schmerztherapie sind lokalisierte oder diffuse osteolytisch-osteoplastische Knochenmetastasen, Wirbelkörper- oder epidurale Metastasen mit oder ohne Querschnittssymptomatik, Lymphknotenmetastasen, Hautmetastasen, Lymphangiosis cutis carcinomatosa, Hirnmetastasen, Orbita- und Aderhautmetastasen, obere Einflussstauung, Bronchuskompression und/oder -obstruktion, Rektumkarzinomrezidive, nur noch palliativ zu beeinflussende Primärtumoren bzw. Tumorrezidive in verschiedenen Organsystemen [180].

Darüber hinaus gibt es noch weitere Indikationen, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll.

Ausgedehnte Peritonealkarzinose mit Aszites und Pleuraergüssen stellt in der Regel *keine* Indikation zur Strahlenbehandlung dar [180].

Therapiefolgezustände (z. B. radiogene oder zytostatische Nervenschädigungen, Lymphödeme durch Fibrosen) lassen sich durch Bestrahlung *nicht* bessern [180].

4.10 Symptomkontrolle

4.10.1 Dyspnoe

Dyspnoe ist das subjektive Symptom der Atemnot, dessen Schwere nur der Patient allein beurteilen kann [35].

Dyspnoe ist wie der Schmerz ein duales Phänomen, nämlich zum einen die Wahrnehmung der Atemnot und zum anderen die Reaktion des Patienten auf die Atemnot. Palliativmedizinische Maßnahmen zielen deswegen darauf ab, sowohl die Wahrnehmung als auch die Verarbeitung der Atemnot durch den Patienten zu beeinflussen.

Etwa die Hälfte aller Patienten mit einem fortgeschrittenen Tumorleiden klagt über Dyspnoe [198]. Der Anteil steigt bei Patienten mit Lungentumoren

oder Lungenmetastasen auf 70% an. In den letzten 24 h vor dem Tod leiden ca. 80% der Patienten unter Atemnot [83].

Die Ursachen von Dyspnoe

- Pulmonal-obstruktiv
  - Asthma bronchiale
  - asthmoide Bronchitis
  - COLD
  - Bronchialobstruktion
  - Trachealstenose
  - tracheoösophageale Fistel
- Pulmonal-restriktiv
  - extrapulmonal:
    - Pleuraerguss
    - Pleuritis carcinomatosa
    - Thoraxwandtumor
    - Zwerchfelltumor
    - Pneumothorax
  - intrapulmonal:
    - Fibrose
    - Atelektase
    - Pneumonie
    - Resektion
- Kardial
- Neuromuskulär
- Psychogen

Häufige Ursachen einer Dyspnoe bei Tumorpatienten sind Lungentumoren, -metastasen, Pleuraergüsse, Aszites, Obstruktion der Atemwege, Schmerzen, Pneumonie und kardiale Probleme.

Da die Ursachen einer Dyspnoe vielfältig sind, muss jede neu aufgetretene Atemnot differentialdiagnostisch mit möglichst einfachen, den Patienten wenig belastenden Untersuchungen abgeklärt werden [2].

Wichtig ist die Unterscheidung, ob die Ursache der Dyspnoe reversibel oder irreversibel ist und ob der Patient sich in der Finalphase oder Rehabilitationsphase befindet.

Bei reversiblen Ursachen in der Rehabilitationsphase müssen neben medikamentösen Maßnahmen auch Strahlentherapie, interventionelle Radiologie, Laser- und Kryotherapie, Punktionen von Pleuraergüssen oder von Aszites in Erwägung gezogen werden.

Bei reversiblen Ursachen in der Finalphase werden Patienten fast ausschließlich von medikamentösen Maßnahmen wie Bronchodilatatoren, Glukokortikoiden oder Diuretika profitieren. Indikationen für Glukokortikoide sind periphere und zentrale Obstruktionen, obere Einflussstauung und Lymphangitis carcinomatosa.

Irreversible Ursachen einer Dyspnoe werden durch symptomatische Strategien therapiert. Diese zielen darauf ab, die Wahrnehmung der Atemnot und die Reaktion auf diese zu beeinflussen.

Kompetente Begleitung des Patienten und der Angehörigen sind wichtige Grundelemente der Betreuung, wobei die Ausstrahlung von Ruhe und Sicherheit wichtig ist. Der Helfer selbst darf nicht panisch oder ängstlich wirken oder reagieren. Frische Luft, Befreiung von enger Kleidung, Entspannungstechniken und Atemübungen sind sinnvolle Maßnahmen, um Panikattacken beim Patienten zu vermeiden.

Für die medikamentöse, symptomatische Behandlung stehen uns Opioide und Nichtopioide zur Verfügung [3].

Morphin ist das Opioid, das am häufigsten zur Reduktion einer Atemnot verwendet wird. Opioidnaive Patienten erhalten initial 2,5–5–10-15 mg Morphinsulfattabletten oder Morphinlösung alle 4 h. Alternativ können 2,5–5 mg Morphin s.c. vierstündlich oder 1–2 mg i.v. in Abständen von 5–10 min gegeben werden, bis eine zufrieden stellende Erleichterung eingetreten, eine Atemfrequenz von 15–20/min erreicht ist und Nebenwirkungen nicht aufgetreten sind.

Bei Patienten, die bereits Morphin erhalten und über Atemnot klagen, sollte die Morphindosis um 50% erhöht werden. Die häufigste Nebenwirkung der Morphintherapie bei dieser Indikation ist eine Vigilanzminderung, welche evtl. eine Dosisreduktion notwendig macht. Neben den Opioiden, die zu einer symptomatischen Therapie der Dyspnoe eingesetzt werden, können ergänzend Phenothiazine und Benzodiazepine verabreicht werden.

Phenothiazine (Chlorpromazin 10–25 mg) und Benzodiazepine (Midazolam 5–10 mg i.v.) sind hilfreich, wenn eine akute schwere Dyspnoe,

verbunden mit Angst oder Panik, durchbrochen werden muss. Wenn die Atemnot weitgehend unter Kontrolle ist, eine weitere Anxiolyse jedoch notwendig erscheint, kann die Therapie mit Lorazepam (Tavor expidet 1–2 mg) fortgeführt werden.

Barbiturate sollten nur zum Einsatz kommen, wenn ein ausgeprägt sedierender Effekt erwünscht ist. Der Einsatz von Barbituraten erfordert große klinische Erfahrung im Umgang mit dieser Substanzgruppe. Individuelle Dosierung bei engmaschiger klinischer Überwachung ist obligat.

Eine Atemnot durch »Lungenrasseln« in der Finalphase kann in der Regel gut beherrscht werden durch 0,2–0,4 mg Scopolamin s.c. alle 6–8 h.

Die Applikation von *Sauerstoff* über Maske oder Nasensonde wird den Patienten häufig angeboten, ohne dass man sich über den therapeutischen Nutzen im Klaren ist. Atemnot wird in der Regel durch Versagen der Atemmechanik und Ansteigen des arteriellen CO_2-Partialdrucks hervorgerufen. Die Gabe von Sauerstoff entspricht hier einem Plazeboeffekt.

Eine Abnahme des arteriellen O_2-Partialdrucks – insbesondere bei chronischem Verlauf – ist erst bei sehr niedrigen Werten Ursache von Dyspnoe. Bei ausgeprägter Zyanose und gleichzeitig bestehender Atemnot ist eine O_2-Sonde (neben der medikamentösen symptomatischen Therapie) eine adjuvante Maßnahme zur Linderung der Dyspnoe.

4.10.2 Übelkeit und Erbrechen

Übelkeit und Erbrechen sind bei Patienten mit fortgeschrittener Tumorerkrankung Symptome, die häufig auftreten. Die Inzidenz liegt bei 40–70%. Während wir für die Therapie tumorbedingter Schmerzen über gute Leitlinien verfügen, fehlen diese für die Behandlung fast aller anderen körperlich begründbaren Symptome dieser Patienten.

Für die Auslösung und Vermittlung von Übelkeit und Erbrechen und die Koordination des Brechvorganges sind folgende Organstrukturen von Bedeutung:

- vagale Afferenzen von Chemo- und/oder Mechanorezeptoren der Leber und des Darms;
- vagale Afferenzen von Mechanorezeptoren im Kopf-Hals-Bereich, Thorax, Abdomen und Becken;
- Vestibularapparat;

- zerebraler Kortex;
- Chemorezeptorentriggerzone; sie liegt in der Area postrema am Boden des 4. Ventrikels außerhalb der Blut-Hirn-Schranke;
- Brechzentrum, das in der Nähe der Area postrema innerhalb der Blut-Hirn-Schranke liegt.

Die Auslösung oder Verhinderung von Übelkeit und/oder Erbrechen ist in diesen Organstrukturen rezeptorvermittelt, wobei die Reizung dieser Rezeptoren zur Auslösung der Symptome führt. Eine Ausnahme sind die μ-Rezeptoren im Brechzentrum, die bei Aktivierung inhibitorisch auf das Brechzentrum wirken. Normalerweise überwiegt aber die stimulierende Wirkung der Opioide auf die D_2-Rezeptoren in der Chemorezeptorentriggerzone mit der Folge, dass Übelkeit auftritt.

Veränderungen der Erregungsübertragung am Darm können für die Auslösung bzw. Unterdrückung von Übelkeit und Erbrechen eine Rolle spielen. Abb. 4.7 zeigt, dass Reizung von 5-HT_4-Rezeptoren die Erregungsübertragung von Acetylcholin auf die glatte Muskulatur fördert und Dopamin die Erregungsübertragung blockiert. Therapeutische Ansatzpunkte sind der Abb. 4.7 zu entnehmen. Metoclopramid fördert die Peristaltik durch Blockade dopaminerger Rezeptoren und Aktivierung der 5-HT_4-Rezeptoren; Domperidon wirkt selektiv an den D_2-Rezeptoren und unterstützt so die cholinerge Erregungsübertragung (Abb. 4.7).

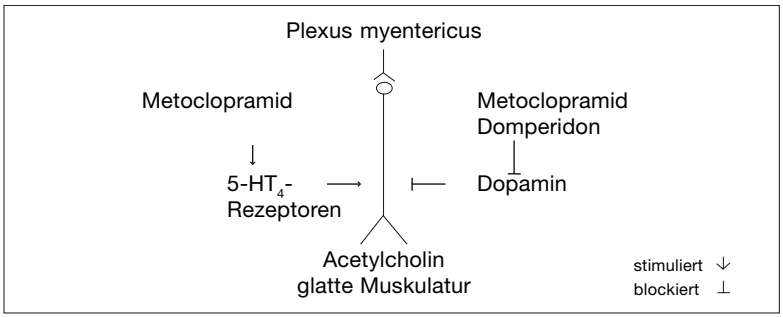


Abb. 4.7. Erregungsübertragung am Darm

Ursachen von Übelkeit und Erbrechen

Übelkeit und Erbrechen können durch sehr unterschiedliche Ursachen ausgelöst werden.

Dazu gehören:

- gastrointestinale Probleme (z. B. Gastrostase, Obstruktion),
- pharyngeale Ursachen (z. B. Candidainfektion, exulzerierende Tumoren),
- Arzneimittel (z. B. Opioide, Antiphlogistika),
- metabolische Ursachen (z. B. Hyperkalzämie, Urämie),
- toxische Ursachen (z. B. Bestrahlung, Chemotherapie),
- Hirnmetastasen,
- psychosomatische Ursachen (z. B. Angst),
- Schmerzen.

Allgemeine Grundlagen zur Therapie von Übelkeit von Übelkeit und Erbrechen

1. Kausale Behandlung (z. B. Geruchsbeseitigung, Therapie einer Hyperkalzämie).
2. Nichtmedikamentöse Basismaßnahmen:
   - ruhige Umgebung,
   - kleine Mahlzeiten,
   - keine Mahlzeiten anbieten, die durch Anblick oder Geruch Übelkeit oder Erbrechen bewirken.
3. Rezeptorbezogenes Antiemetikum 1. Wahl.
4. Rezeptorbezogenes Antiemetikum 2. Wahl.
5. Kombination von 1–4.
6. Breitsprektrumantiemetikum als Ultima Ratio (z. B. Levopromazin).

Symptomatische Therapie von Übelkeit und Erbrechen

Zur antiemetischen Therapie stehen uns Antihistaminika, Neuroleptika, Anticholinergika, prokinetische Substanzen, 5-HT_3-Rezeptorantagonisten und Glukokortikoide zu Verfügung. Einzelheiten sind der Tab. 4.8 zu entnehmen.

Die Therapie von Nausea und Emesis erfolgt unter folgenden Kautelen:

- Diagnose der Ursache; wenn möglich Kausaltherapie;
- rezeptorspezifisches Antiemetikum;
- Zeitschema;
- Bedarfsmedikation;
- Dosisanpassung nach 24 h;
- Kombination unterschiedlicher rezeptorspezifischer Antiemetika.

Die antiemetische Therapie sollte so lange wie nötig durchgeführt werden, d. h. bei einer opioidbedingten Indikation kann nach 8–10 Tagen ein Auslassversuch gemacht werden, da nach dieser Zeit die emetische Potenz der Opioide in der Regel nachlässt.

Die Wirkung der Antiemetika auf Rezeptoren des Vestibularapparats, der Chemorezeptoren-Triggerzone, des Brechzentrums und des Magen-Darm-Trakts kann den ◘ Tab. 4.20–4.22 entnommen werden.

◘ **Tab. 4.20.** Wirkungen von Antiemetika auf Rezeptoren des Vestibularapparats, der Chemorezeptorentriggerzone (CTZ), des Brechzentrums und des Magen-Darm-Trakts

	Achm-	D_2-	H_1-	5-HT_2-Rezeptoren	5-HT_3-	5-HT_4-	μ-
Vestibular-apparat	X			X			
CTZ		X			X		
Brech-zentrum	X		X	X			X
Magen-Darm-Trakt		X			X	X	

Achm = muscarinartige Azetylcholinrezeptoren
D_2 = Dopamin-Typ-2-Rezeptoren
H_1 = Histamin-Typ-2-Rezeptoren
5-HT_2 = 5-Hydroxytryptamin-2-Rezeptoren
5-HT_3 = 5-Hydroxytryptamin-3-Rezeptoren
5-HT_4 = 5-Hydroxytryptamin-4-Rezeptoren
μ = μ-Opioidrezeptoren
CTZ = Chemorezeptorentriggerzone

Basisantiemetika

Als Basisantiemetika gelten die in Tab. 4.23 genannten Substanzen.

In Abhängigkeit von der auslösenden Ursache sind unterschiedliche »Stufenschemata« zur Antiemese anzuwenden.

Tab. 4.21. Wirkungen von Antiemetika auf die D_2-, 5-HT_3- und 5-HT_4-Rezeptoren

		D_2-	5-HT_3-	5-HT_4-Agonist
		Antagonisten		
Metoclopramid	Paspertin	++	(+)	++
Domperidon	Motilium	++	∅	∅
Ondansetron	Zofran	∅	+++	∅

Tab. 4.22. Wirkungen von Antiemetika auf Achm-, D_2-, H_1- und 5-HT_2-Rezeptoren

	Achm-	D_2-	H_1-	5-HT_2-
		Antagonisten		
Cyclizin (Marzine)	++	∅	++	∅
Hyoscin (Buscopan)	+++	∅	∅	∅
Haloperidol (Haldol)	∅	+++	∅	∅
Promethazin (Atosil)	+	++	++	∅
Levomepromazin (Neurocil)	++	++	+++	+++

Tab. 4.23. Basisantiemetika

Basisantiemetikum	Wirkort
Metoclopramid	Darm
Haloperidol	Chemorezeptorentriggerzone
Cyclizin	Brechzentrum

»Stufenschema« der Antiemese bei Gastrostase

- Metoclopramid,
- Domperidon.

»Stufenschema« der Antiemese bei Gabe von Opioiden

- Haloperidol,
- Metoclopramid,
- Halperidol + Metoclopramid,
- Haloperidol + Domperidon,
- Haloperidol + Domperidon + Ondansetron.

»Stufenschema« der Antiemese bei gastrointestinaler Obstruktion

- Spezifische Maßnahmen (Scopolamin, Octreotid, Dexamethason),
- Haloperidol (Wirkung auf die Chemorezeptorentriggerzone),
- Cyclizin (Wirkung auf das Brechzentrum),
- 5-HT_3-Antagonist (vagale Rezeptorblockade),
- Levopromazin (Ultima Ratio als Breitspektrumantiemetikum).

4.10.3 Obstipation [102]

Schätzungen gehen davon aus, dass ein Drittel der Bevölkerung in den westlichen Industriestaaten an Obstipation leidet. Bis heute gibt es keine international verbindliche Definition und Klassifikation der Obstipation [80, 123, 186, 187, 189, 193].

Die Patienten klagen in der Regel über eine zu niedrige Stuhlfrequenz, zu geringe Stuhlmenge, zu harte Stuhlkonsistenz und eine als zu schwierig empfundene Stuhlentlehrung [148].

Ursachen

Obstipation kann organisch oder funktionell bedingte Ursachen haben.

- Organische Ursachen können u. a. Tumoren, Divertikulitis, Megakolon, endokrine (z. B. Hypothyreodismus), metabolische (z. B. Hyperkalzä-

mie), rekto-anale Erkrankungen oder neurogene (z. B. M. Parkinson) Störungen sein.

Eine funktionell bedingte Obstipation kann u. a. durch verlangsamte Kolonpassage, Störungen der Defäkation, ballaststoffarme Kost, geringe Flüssigkeitsaufnahme, Immobilität und Arzneimittel hervorgerufen werden. Zu Letzteren gehören Opioide, trizyklische Antidepressiva, Anticholinergika, Antikonvulsiva, Phenothiazine, Kalziumantagonisten u. a. m.

Grundlagen der Behandlung einer Obstipation bei Tumorpatienten

Die Obstipation als Begleiterkrankung einer Grunderkrankung sollte kausal behandelt werden. Wenn Arzneimittel Ursache einer Obstipation sind, ist die Überlegung notwendig, ob diese Substanzen abgesetzt werden können. Dies ist im Rahmen einer Schmerztherapie mit Opioiden nicht sinnvoll. Vielmehr muss eine Obstipationsprophylaxe mit Laxanzien eingeleitet und aufrechterhalten werden, und zwar solange z. B. Morphin gegeben wird. Pathophysiologie und Therapie einer opioidbedingten Obstipation sind in ▶ Kap. 4.7.2, S. 233ff. beschrieben.

Eine Umstellung auf eine ballaststoffreiche Kost, Erhöhung der Trinkmenge und Steigerung der körperlichen Aktivität sind Maßnahmen, die bei Patienten mit fortgeschrittener Tumorerkrankung häufig nicht mehr möglich sind. Wenn diese allgemeinen Maßnahmen nicht erfolgreich sind oder nicht durchgeführt werden können, ist die Indikation für eine medikamentöse, symptomatische Therapie mit Laxanzien gegeben.

Laxanzien (lat. laxare – lockern) sind Substanzen, die die Defäkation beschleunigen. Sie entfalten ihre Wirkung über eine Beeinflussung des Wasser- und Elektrolyttransfers der Dünn- und Dickdarmmukosa, weichen eingedickte Fäzes auf und setzen die Defäkation in Gang [207].

Quellstoffe

sind Polysaccharide, die nicht verdaut oder resorbiert werden (◘ Tab. 4.9). Voraussetzung für die Wirksamkeit ist eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme. Da dies bei Tumorpatienten häufig nicht möglich ist, sollten diese Substanzen nicht eingesetzt werden.

Osmotisch wirksame Laxanzien

werden in salinische Laxanzien, Zucker, Zuckeralkohole und Polyethylenglykole eingeteilt.

Die salinischen Laxanzien bewirken einen Einstrom von Wasser aus dem Gewebe in das Darmlumen und fördern damit eine Dehydratation. Da Tumorpatienten häufig bereits dehydriert sind, sollte auf diese Substanzgruppe verzichtet werden.

Lactulose

wird im Dünndarm nicht resorbiert und erst im Dickdarm durch Bakterien in kurzkettige Fettsäuren und Milchsäure abgebaut. Die kurzkettigen Fettsäuren führen über eine osmotische Aktivität zur erhöhten Wasserbindung mit der Folge der Volumenvergrößerung und Peristaltikförderung. Die fermentative Spaltung führt u. a. zur Gasbildung mit der Folge von Meteorismus und Flatulenz. Der süße Geschmack der Laktulose wird von den Patienten meist als unangenehm empfunden.

Polyethylenglykole

sind Polymere aus Ethylenoxid und Wasser. Polyethylenglykole mit einem Molekulargewicht über 1000 werden nicht aus dem Darmlumen resorbiert. Macrogol besitzt ein definiertes Wasserbindungsvermögen. Oral zugeführte Flüssigkeit gelangt in das Kolon zur Stuhlaufweichung, ohne Flüssigkeit aus dem Gewebe in das Darmlumen zu ziehen. Es kommt deswegen auch nicht zu einer Dehydratation. Macrogol wird unverändert mit dem Stuhl ausgeschieden. Eine fermentativ verursachte Gasbildung – wie bei der Lactulose – tritt nicht auf.

Amidotrizoesäure (Gastrografin)

ist ein hyperosmolares jodhaltiges Röntgenkontrastmittel mit starkem osmotischem Effekt, wasserbindend und ausgeprägt laxativ wirksam. Es wird bei uns in Ausnahmefällen verwendet, um eine Defäkation wieder in Gang zu bringen. Die Dosis liegt bei 50–100 ml oral appliziert, ggf. eine Repetitionsdosis nach 8–12 h.

Zu den antiresorptiv und hydragog wirkenden Laxanzien

gehören Natriumpicosulfat, Bisacodyl, Anthraglykoside und Rizinusöl. Aufgrund der peristaltikfördernden Wirkung am Plexus myentericus, der Hem-

mung der Natrium- und Wasserresorption und vermehrten Wasser- und Elektrolytabgabe in das Darmlumen entwickeln sie eine ausgeprägt laxative Wirkung. Ihr Wirkmechanismus ist optimal für einen direkten Angriff auf die mophininduzierte Obstipation. Der Wirkungseintritt ist mit 5-8 h relativ schnell.

Zu den **Gleitmitteln** gehören Paraffinöl und Glyzerin. Obwohl dem Paraffin zahlreiche Nebenwirkungen (z. B. Hemmung der Resorption fettlöslicher Vitamine, Fremdkörperreaktion in Lymphknoten) angelastet werden, kommt es zur Therapie einer Obstipation in der Palliativmedizin sehr häufig zum Einsatz und ist hier keineswegs obsolet, wie dies aus allgemeinmedizinischer Sicht gesehen wird [63]. Durch Verbesserung der Gleitfähigkeit und Wasseranreicherung kommt es zum Absetzen eines weichen Stuhls.

Prokinetika

wie Metoclopramid und Domperidon werden in erster Linie als Antiemetika eingesetzt (▶ Kap. 4.10.2). Beide Substanzen sind zur Therapie einer Obstipation nicht geeignet, da sie am unteren Dünndarm und im Kolon keine Wirkung entfalten.

Laxanzien mit Wirkung auf den Defäkationsreflex

(Sorbit, Glycerol) werden in der Regel als Suppositorien verabreicht. Der Vorteil liegt im raschen Wirkungseintritt (◘ Tab. 4.9). In der Regel werden diese Substanzen als adjuvante Maßnahmen gegeben, wenn die orale Laxanziengabe allein nicht erfolgreich ist.

Klysmen, Einläufe

verschiedener Zusammensetzung und *manuelle Ausräumung* sind sinnvolle und notwendige Maßnahmen, wenn die oralen Laxanzien entweder nicht indiziert sind oder nicht ausreichend wirksam sind. *Neostigmin* (Prostigmin) und *Ceruletid* (Takus), jeweils intravenös appliziert, kommen im Rahmen der Palliativmedizin nur selten zum Einsatz.

Grundsätzlich sollte – wenn möglich – eine kausale Therapie durchgeführt werden; so etwa operative Maßnahmen bei Fisteln oder Rektumprolaps, eine medikamentöse Substitution bei endokriner Erkrankung. Das Flussdiagramm (◘ Abb. 4.8) zeigt ein systematisches Vorgehen zur Ermittlung der adäquaten therapeutischen Strategien.

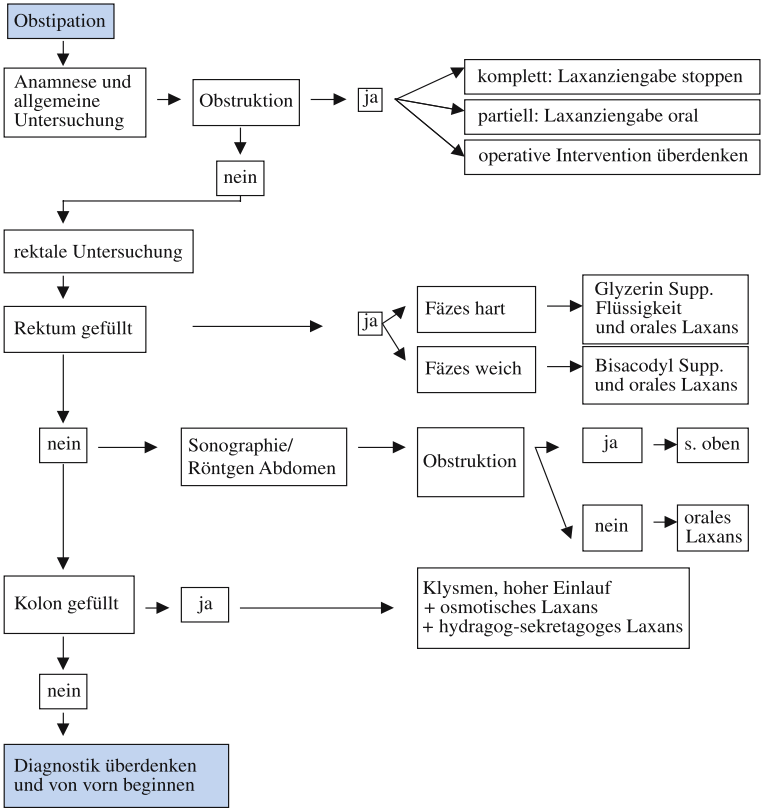


Abb. 4.8. Flussdiagramm zur Therapie der Obstipation bei Patienten in der Palliativmedizin

4.10.4 Obstruktion

Eine intramurale und extramurale Kompression des Darms, ein paralytischer Ileus oder eine Obstipation können zum Syndrom der gastrointestinalen Obstruktion führen.

Der paralytische Ileus und die Obstipation sind klassische Indikationen für die medikamentöse Therapie, während der mechanische Ileus in der

Regel operativ angegangen werden muss. Bei weit fortgeschrittener Tumorerkrankung (z. B. bei ausgeprägter Peritonealkarzinose und/oder großen Tumorkonglomeraten) ist häufig eine entlastende Operation durch ein Stoma nicht mehr möglich, oder der Eingriff wird vom Patienten abgelehnt.

Symptome der Obstruktion sind ein aufgetriebenes Abdomen, Nausea, Emesis, kolikartige oder kontinuierliche Abdominalschmerzen und Obstipation. Erbrechen ist häufig, wenn die Obstruktion im oberen Gastrointestinaltrakt liegt, seltener wenn sie im distalen Ileum oder Kolon lokalisiert ist.

Ziel der palliativen Behandlung ist die Therapie von Schmerzen, Übelkeit und Erbrechen, die Vermeidung von Durst und Hunger und eine Verminderung der gastrointestinalen Sekretion.

Übelkeit und Erbrechen (▶ Kap. 4.10.2; [116]) werden bei uns in erster Linie mit *Cyclizin* (Valoid oder Marzine 50 mg alle 8 h s.c. bzw. p.o.) und *Haloperidol* (1–2 mg alle 8 h p.o. oder s.c.) therapiert.

Bei kolikartigen Schmerzen geben wir *Butyl-Scopolamin* (Buscopan) vierstündlich 10 mg. Als Alternative kann auch *Scopolamin* alle 6–8 h 0,5 mg gegeben werden, um die gastrointestinalen Spasmen und die gastrointestinale Sekretion zu vermindern.

Obwohl der Wirkmechanismus nicht ganz klar ist – evtl. Verminderung der Obstruktion durch antiödematöse Wirkung im peritumorösen Gewebe –, profitieren einige Patienten durch hochdosierte Gabe von *Dexamethason* (initial 20–60 mg und Reduktion in den nächsten Tagen auf die Erhaltungsdosis von 4 mg/Tag) [52, 161].

Die Entwicklung von **Octreotid** – ein zyklisches Octapeptid – ist ein wesentlicher Fortschritt in der symptomatischen Therapie einer Obstruktion. Octreotid führt zu einer Abnahme der gastrointestinalen Sekretion (Magen, Galle, Pankreas), der Darmmotilität und der Splanchnikusdurchblutung und zu einer Zunahme der Wasser- und Elektrolytresorption aus dem Darmlumen.

Indikationen für Octreotid sind neben dem inoperablen Ileus gastrointestinale Fisteln, das Short-Bowel-Syndrom, sekretorische Diarrhöen, Blutungen des oberen Gastrointestinaltraktes u. a.

Die palliative Therapie einer intestinalen Obstruktion beginnt mit der Gabe von 2- bis 3-mal täglich 0,05–0,1 mg s.c. oder i.v. In Abhängigkeit von der klinischen Wirkung kann die Dosis bis auf 0,6 mg als Tagesdosis gesteigert werden.

Octreotid beeinflusst den Circulus vitiosus von Darmüberdehnung und Sekretion. Klinisch zeigt sich dies in einer Abnahme von Übelkeit, Erbrechen und einer Reduktion der abdominellen Schmerzen.

Die Indikation zur *Flüssigkeitssubstitution* bei Patienten im terminalen Stadium einer Tumorerkrankung wird kontrovers diskutiert (s. unten; [48, 53, 51]).

Wenn Übelkeit und Erbrechen gut kontrolliert sind, die Obstruktion weit distal liegt, dann sollte man den Patienten ermutigen, zu essen und zu trinken, was ihm beliebt. In solchen Situationen ist eine ausreichende Hydratation kein Problem.

Können Übelkeit und Erbrechen für den Patienten nicht zufrieden stellend reduziert werden – besonders häufig bei proximal liegender Obstruktion – droht durch Dehydratation Somnolenz oder agitierte Verwirrtheit. Hier ist sowohl eine Magensonde oder PEG-Sonde als auch eine intravenöse – seltener subkutane – Hydratation indiziert.

Für eine gute Symptomkontrolle ist die Unterscheidung wichtig, ob es sich um eine komplette oder partielle Obstruktion handelt.

Bei *inkompletter Obstruktion* besteht die Kunst der Therapie in der Beherrschung von Übelkeit, Erbrechen und Schmerzen sowie der Vermeidung einer kompletten Obstruktion. Die richtige Balance zwischen laxativen Maßnahmen (Gabe von Weichmachern und nicht zu aggressiv propulsiven Substanzen), darmrelaxierenden Arzneimitteln und ausreichender Analgesie erfordert subtiles pharmakologisches Wissen, Kenntnisse der Pathophysiologie und engmaschige Kontrollen des klinischen Verlaufs.

Die palliativmedizinische Therapie einer *irreversiblen kompletten Obstruktion* ist insofern einfacher, da hier alle Maßnahmen ausschließlich auf eine gute Symptomkontrolle abzielen und eine arzneimittelbedingte Verstärkung der Ileussymptomatik zur Vermeidung von Darmspasmen in Kauf genommen werden kann [172].

4.10.5 Flüssigkeitssubstitution in der Finalphase

Die Frage nach der ärztlichen Pflicht zur Flüssigkeitssubstitution in der Finalphase ist Gegenstand kontroverser öffentlicher, medizinischer und medizinethischer Diskussionen [15, 48, 51]. Die folgenden Ausführungen zu diesem Thema sollen Anregungen geben, sich mit der Problematik intensiv

auseinanderzusetzen. Forschung auf diesem Gebiet ist unverzichtbar, um über unser Erfahrungswissen hinaus wissenschaftlich sicherere naturwissenschaftliche Erkenntnisse für medizinische Entscheidungen in diesem Bereich zu gewinnen.

Für eine Flüssigkeitssubstitution spricht:

- Exsikkose und Störungen des Elektrolythaushaltes können zu Unruhe, Bewusstseinsstörungen und Muskelkrämpfen führen. Neuroleptika oder Muskelrelaxanzien wären hier der falsche Weg, eine Symptomkontrolle zu erreichen. Da palliativmedizinisch betreute Patienten wegen ihrer begrenzten verbleibenden Lebenszeit oft großen Wert auf Erhaltung ihrer Bewusstseinsklarheit legen, ist bei oben aufgeführten Symptomen eine Rehydratation sinnvoll.
- Bisher gibt es keinen wissenschaftlich begründeten Nachweis, dass eine Flüssigkeitssubstitution das Sterben künstlich verlängert.
- Grundsätzlich ist wichtig zu hinterfragen, ob sich ein Patient überhaupt in der Finalphase befindet oder ob nicht z. B. eine ausgeprägte Dehydratation und Hypovolämie vorliegen und fälschlicherweise als Agonie interpretiert wurden.

Gegen eine Flüssigkeitssubstititution werden folgende Argumente ins Feld geführt:

- Bewusstseinsklare Sterbende haben selten Durst, solange die Mundschleimhaut feucht und sauber ist.
- Bisher gibt es keinen wissenschaftlich begründeten Nachweis, dass eine *minimale* Flüssigkeitszufuhr das Leben verkürzt oder Leiden vergrößert.
- Parenterale Flüssigkeitszufuhr erschwere die Betreuung zu Hause.
- Parenterale Flüssigkeitszufuhr kann zu peripheren und Lungenödemen führen.
- Es gibt bisher keinen wissenschaftlich begründeten Nachweis, dass Flüssigkeitsinfusionen dem Sterbenden Erleichterung bringen.

Grundsätzlich gilt es zu beachten:

- Jeder Patient hat das Recht auf Selbstbestimmung.
- Der bewusstseinsklare Patient hat das Recht, einer Behandlung zuzustimmen oder sie abzulehnen.
- Jeder Patient hat ein Recht auf individuelle Entscheidung und Behandlung.

Der behandelnde Arzt muss sich folgende **Fragen** stellen:
- Wo steht der Patient?
- Welche Prognose kann für den Krankheitsverlauf gestellt werden?
- Was ist das Ziel der Behandlung?
- Welche Behandlung ist die angemessene für den Patienten?

Für eine restriktive Handhabung der Flüssigkeitszufuhr wird häufig damit argumentiert, dass dann vermehrt Endorphine ausgeschüttet würden, was zu geringerer Schmerzempfindung und einer geringeren pulmonalen Sekretion führen soll. Atemnot trete dann seltener auf. Diesen beiden Argumenten muss man Folgendes entgegenhalten:
- Ist die Ausschüttung von Endorphinen eine Reaktion auf eine Leidenssituation (Durst, Atemnot, Schmerzen), widerspricht die Inkaufnahme des Leids den Grundregeln der Palliativmedizin.
- Eine Dehydratation vermindert sicher die natürlichen Sekretionen, aber bei bestehender Pneumonie oder Tumorinfiltration der Lunge ist die Kapillarmembran soweit defekt, dass mit einer Minderung der Sekretion in diesen Bereichen und mit einer Verminderung einer »Rasselatmung« durch Dehydratation nicht gerechnet werden kann. Zu berücksichtigen ist auch, dass eine Dehydratation zu einer verminderten Durchblutung und zu einer Niereninsuffizienz führen kann mit der Folge einer Kumulation von Morphin-6-Glukuronid und einer Gefahr der Morphinintoxikation.

Fazit

Eine individuelle Fallentscheidung ist zwingend notwendig.
- Die Autonomie des Patienten ist zu respektieren.
- Eine optimale Symptomkontrolle ist anzustreben.
- Bei bewusstlosen Patienten im Zweifelsfall Flüssigkeit substituieren.
- Klärung des Stadiums (final?).
- Die Indikationsstellung für parenterale Flüssigkeitszufuhr muss begründet werden.

Medizinische und ethische Indikationen für eine Flüssigkeitszufuhr sind:
- durch Dehydratation bedingte Unruhe, Delir, Muskelkrämpfe, toxische Konzentrationen von Arzneimitteln;
- Patient klagt über Durst, der durch enterale Zufuhr nicht gelindert werden kann;
- im Zweifelsfall für die Flüssigkeitssubstitution entscheiden.

4.10.6 Hyperkalzämie

Knochenmetastasen sind eine klinisch relevante Komplikation verschiedener Tumoren, da sie durch Verursachung von Knochenschmerzen, pathologischen Frakturen und Hyperkalzämie den Verlauf der Erkrankung erheblich beeinflussen können.

Besonders häufig gehen das Mammakarzinom, das Bronchialkarzinom und das Prostatakarzinom mit Knochenmetastasen einher.

Klinisch manifestiert sich eine Hyperkalzämie durch Müdigkeit, Verwirrtheit, Desorientiertheit, Depression, Übelkeit, Erbrechen, Obstipation, Polyurie, Dehydratation und Schmerzen. Der klinische Verdacht auf Hyperkalzämie lässt sich leicht durch Bestimmung des ionisierten Serumkalziumspiegels verifizieren.

Die Therapie einer Hyperkalzämie hat vier unterschiedliche Ansatzpunkte:

1. Behandlung des Primärtumors,
2. Korrektur der Dehydratation,
3. Verbesserung der Kalziumausscheidung,
4. Verminderung der Osteoklastentätigkeit.

Glukokortikoide haben einen blockierenden Effekt auf den osteoklastenaktivierenden Faktor; sie verhindern eine erhöhte Kalziumabsorption aus dem Gastrointestinaltrakt und besitzen eine Antiprostaglandinaktivität durch Stabilisierung der Zellmembran [202].

Eine Inaktivierung und Hemmung der Neubildung von Osteoklasten ist durch Bisphosphonate möglich. Dies führt sekundär zu einer Abnahme des Kalziumspiegels.

Wir geben z. B. Clodronat (Ostac) ausschließlich intravenös in einer Dosierung von 300 mg/Tag. Die Behandlungsdauer richtet sich nach dem Serumkalziumspiegel (in der Regel sind 10 Tage notwendig; ▶ Kap. 4.7.3: »Bisphosphonate«).

4.10.7 Schmerztherapie und Symptomkontrolle bei Sterbenden [156]

Der *Weltärztebund* hat 1990 eine Erklärung herausgegeben, die sich dem Umgang mit Patienten im Endstadium einer zum Tode führenden Krankheit mit starken, chronischen Schmerzen widmet.

Darin heißt es:

- Der Arzt *muss* sich der Dynamik von Schmerzen bewusst sein.
- Alle Anstrengungen müssen darauf gerichtet sein, Leiden zu lindern.
- Die Behandlung muss auf die individuellen Bedürfnisse des Patienten abgestellt sein und den bestmöglichen Zustand des Wohlbefindens herbeiführen.
- Der Arzt muss Wirksamkeit, Wirkungsdauer und Nebenwirkungen der verfügbaren Analgetika kennen, um die richtige Wahl des Medikaments, der Dosierung, Verabreichungsart und Applikationsintervalle treffen zu können, damit ein Höchstmaß an Schmerzbefreiung für den Patienten sichergestellt werden kann.

Diese Erklärung verpflichtet uns Ärzte, uns intensiv mit dem Sterbeprozess auseinanderzusetzen und vertraut zu machen, damit wir individuellen Verläufen gerecht werden können.

In der Finalphase einer Tumorerkrankung sind die häufigsten Symptome, unter denen die Patienten leiden, Schmerz, Unruhe, Dyspnoe, präfinales Lungenödem (»Rasseln«), Übelkeit und Erbrechen [9].

Bei fast der Hälfte unserer Patienten (48%), die auf unserer Palliativstation starben, war eine Änderung der Analgetikadosis nicht notwendig. Bei 32% der Patienten musste bei Ansteigen der Schmerzintensität die Opioiddosis erhöht werden. Bei 20% der Patienten sahen wir die Notwendigkeit, die Schmerzmitteldosis zu reduzieren.

Wenn möglich, sollten die Arzneimittel bis zum Tod enteral gegeben werden; ist dies nicht mehr möglich (Patient nicht ansprechbar, klagt über Dysphagie, Übelkeit, Erbrechen, Obstruktion), erfolgt die Schmerztherapie in Anlehnung an die orale Äquivalenzdosis parenteral. Die prozentuale Häufigkeit der bei uns angewandten Applikationswege für Analgetika in der Finalphase ist wie folgt:

- i.v.: 45,
- s.c.: 30,
- oral/Supp.: 18,
- peridural: 2,
- keine Analgetika: 5.

Zur **Schmerztherapie** benötigen 90% unserer Patienten bis zu ihrem Tod, ihrem Schmerzniveau angepasst, Opioide.

Dyspnoe (► Kap. 4.10.1: »Dyspnoe«) ist ein weiteres wichtiges Symptom im Krankheitsverlauf einer Tumorerkrankung, besonders aber in der Finalphase. Für Patienten, die bisher kein Morphin oder ein anderes Opioid erhalten haben, liegt die Anfangsdosis bei 2,5-5–15 mg Morphinsulfattabletten oder Morphinlösung oral alle 4 h gegeben. Alternativ können 2,5-5 mg Morphin subkutan 4-stündlich oder 1–2 mg intravenös in Abständen von 5–7 min gegeben werden, bis eine zufrieden stellende Erleichterung eingetreten ist und eine Atemfrequenz von 15–20 min erreicht ist, ohne dass Nebenwirkungen aufgetreten sind.

Bei Patienten, die bereits Opioide erhalten und über Atemnot klagen, sollte die Opioiddosis um 50% erhöht werden.

Ist die Dyspnoe mit Angst, Unruhe oder Panik verbunden, die durch ein Opioid allein nicht zu therapieren sind, können zusätzlich Lorazepam (1–2 mg bukkal), Midazolam (5–10 mg intravenös) und in extremen Situationen Levopromazin (5–15 mg p.o. oder subkutan) gegeben werden.

»Death Rattle« ist eine geräuschvolle Atmung in den letzten Stunden oder Tagen des Lebens. Die Patienten sind nicht mehr in der Lage, Speichel reflektorisch zu schlucken oder Schleim aus der Trachea abzuhusten. Die Sekretobstruktion liegt in den großen Luftwegen (Trachea und Hauptbronchien) und im Glottisbereich. Die Sekretproduktion erfolgt in den Speicheldrüsen und in der bronchialen Mukosa. Durch Verlust von Schluck- und Hustenreflex kommt es zu Ansammlung der Sekretion im Oropharynx, in der Trachea und in den Bronchien. Die Häufigkeit von »Death Rattle« wird in der Literatur mit 60–90% bei sterbenden Patienten angegeben.

Nach der Lokalisation der Schleimproduktion wird zwischen Typ I und II unterschieden.

Typ I entspricht der Speichelproduktion in den letzten Stunden eines bewusstseinsgetrübten Patienten bei Verlust des Schluckreflexes.

Bei Typ II liegt eine bronchiale Sekretion vor, die der Patient durch zunehmende Schwäche nicht mehr ausreichend abhusten kann. Im Gegensatz zu Typ I entwickelt sich Typ II eher bei Patienten, bei denen ein größeres Zeitintervall zwischen der Unfähigkeit abzuhusten und dem Versterben liegt.

Die medikamentöse Therapie besteht in dem Einsatz von Anticholinergika, wobei wir Scopolamin in einer Dosierung von 0,25–0,5 mg, alle 6–8 h subkutan appliziert, bevorzugen. Alternativen sind Butylscopolamin (40 mg pro Tag subkutan), Atropin (0,5 mg 6-stündlich subkutan) oder Glycopyrolat (0,2 mg 6-stündlich subkutan).

Scopolamin hat neben dem antisalivatorischen Effekt eine zentralnervös sedierende Wirkung.

Während die Patienten die geräuschvolle Atmung in der Regel nicht wahrnehmen, kann sie für Angehörige, Nachbarpatienten und das betreuende Team eine große Belastung darstellen. Deswegen sind Informationen über dieses Symptom und die Aufklärung über therapeutische Maßnahmen für die Angehörigen und Mitpatienten außerordentlich wichtig.

Eine der *schwierigsten Entscheidungen* in der Palliativmedizin ist diejenige, ob und ab wann ein Patient in der Finalphase **sediert** werden soll und darf [2, 37, 147]. Das Problem stellt sich zumeist dann, wenn Bewusstseinsstörungen, motorische Unruhe, terminale Agitation, delirante oder psychotische Syndrome keine klare Willensäußerung mehr erkennen lassen oder der geäußerte Wille – auch in einer Patientenverfügung niedergelegt – dem aus ärztlicher Sicht notwendigen oder gebotenen Handeln entgegensteht.

Ist eine medikamentöse, symptomatische Behandlung nach Ausschluss anderweitig zu behandelnder Ursachen bei terminaler Agitation oder motorischer Unruhe notwendig, geben wir Flunitrazepam (Rohypnol) individuell dosiert, intermittierend subkutan (ist für diese Applikationsform nicht zugelassen) oder als kontinuierliche Gabe in die Infusion.

Dosierungshinweise:

- 0,5 mg Flunitrazepam alle 4–6 h subkutan.
- 2–4 mg Flunitrazepam pro 24 h in die Infusion. Alternativ geben wir Lorazepam (Tavor expidet) 1–2 mg bukkal oder Levomepromazin (Neurocil) 5–15 mg p.o., s.c., mit Repetitionsdosen alle 6–8 h.

Bei deliranten Syndromen geben wir hochdosiert Haloperidol als Tagesdosis 4–8 mg p.o., s.c., i.v.; bei Erregungszuständen und motorischer Unruhe ist evtl. eine Steigerung bis 40 mg/Tag notwendig.

In der Finalphase muss sorgfältig geprüft werden, welche Arzneimittel fortgeführt, abgesetzt oder evtl. hinzugefügt werden müssen.

Ursache einer unbefriedigenden Symptomkontrolle bei uns waren respiratorische Probleme, akute Blutungen, Regurgitation und Unruhe.

Das Behandlungsziel bei Patienten in der Finalphase ist, ihnen ein gut symptomkontrolliertes, friedvolles Sterben zu ermöglichen. Dies kann in einem hohen Prozentsatz erreicht werden, der vom St. Christopher's Hospice mit 98% angegeben wird und bei uns auf der Palliativstation bei 93% liegt.

Literatur

1. Adamietz et al. (1999) Leitlinien zur Tumorschmerztherapie. Erstellt im Auftrag der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Schmerztherapie (DIVS). Tumordiagn. u. Ther. 20: 105-129
2. Ahmedzai S (1998) Palliation of respiratory symptoms. In: Doyle D, Hanks GWC, MacDonald N (eds) Oxford Textbook of Palliative Medicine, 2nd edition. Oxford Univ Press, Oxford New York, pp 583-616
3. Ajemian SG (1993) Palliative management of dyspnea. J Palliat Care 7/3: 44-45
4. Allan SG (1993) Nausea and vomiting. In: Doyle D, Hanks GWC, MacDonald N (eds) Oxford Textbook of Palliative Medicine. Oxford Univ Press, Oxford New York, pp 282-290
5. American Pain Society (1989) Principles of analgesic use in the treatment of acute pain and chronic cancer pain. A concise guide to medical practice, 2nd edn. American Pain Society, Skokie/IL
6. Anderson R, Saijers JH, Abram S, Schlicht C (2001) Accuracy in equianalgesic dosing: conversion dilemmas. J Pain Symptom Manage 21: 397-406
7. Angst MS, Bührer M, Lötsch J (2000) Insidious intoxication after morphine treatment in renal failure: delayed onset of morphine-6-glucuronide action. Anesthesiology 92: 1473-1476
8. Arbeitsgemeinschaft Bevölkerungsbezogenes Krebsregister in Deutschland in Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut (2004): Krebs in Deutschland – Häufigkeiten und Trends, 4. Auflage
9. Back IN (1992) Terminal restlessness in patients with advanced malignant disease. Palliat Med 6: 293-298
10. Baron R, Jänig W (2001) Neuropathische Schmerzen. In: Zenz M, Jurna I (Hrsg) Lehrbuch der Schmerztherapie, 2. Auflage. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart, 65-87
11. Boas RA, Holford NHG, Villinger JW (1985) Clinical pharmacology of opiate analgesia. Adv Pain Res Ther 9: 695-708
12. Böger RH, Schmidt G (2002) Analgetika. In: Schwabe U, Paffrath D (Hrsg) Arzneiverordnungsreport 2002. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokio, 89-103
13. Bonica JJ, Loeser JD, Chapman CR, Fordyce WE (1990) The management of pain. Lea & Febinger, Philadelphia London
14. Boston-Studie (1986) Risk of agranulocytosis and aplastic anemia. A first report of their relation to drug use with special reference to analgesics. The International Agranulocytosis and Aplastic Anemia Study. JAMA 256: 1749-1757
15. Bozetti et al. (1996) Guidelines on artificial nutrition versus hydration in terminal cancer patients. Nutrition 12/3: 163-167
16. Brennscheidt U, Seiler KU, Thomann P (2000) Pharmacokinetics of nortilidine and naloxone after administration of tilidine/naloxone solution and of tilidine/naloxone sustained release tablets. Arzneim.-Forsch/Drug Res 50: 1015-1022
17. Bruera E, Chadwick S, Brenneis C, Hanson J, MacDonald RM (1987) Methylphenidate associated with narcotics for the treatment of cancer pain. Cancer Treat Report 76: 17
18. Bruera E, Pereira J, Watanabe SE et al. (1996) Opioid rotation in patients with cancer pain. A retrospective comparison of dose ratios between methadone, hydromorphone, and morphine. Cancer 78: 852-857

19. Bruera E, Sweeney C (2002) Methadone use in cancer patients with pain: A review. J Pall Med 5: 127-138
20. Brune K, Hinz B (2001) Nichtopioidanalgetika (antipyretische Analgetika und andere). In: Zenz M, Jurna I (Hrsg) Lehrbuch der Schmerztherapie, 2. Auflage. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart, 233-253
21. Brune K, Kalden J, Zacher J, Zeilhofer HU (2000) Selektive Inhibitoren der Zyklooxygenase. 2. Evolution oder Revolution? Dtsch Ärztebl 97: B1540-1547
22. Buera E, Brenneis C, Paterson AH, MacDonald RM (1989) Use of methylphenidate as an adjuvant to narcotic analgesics in patients with advanced cancer. J Pain Symptom Manage 4:3
23. Bullingham R, McQuay H, Porter E, Weir L (1982) Sublingual buprenorphine used postoperatively: 10 hour plasma drug concentration analysis. Br J Clin Pharmacol 13: 665
24. Campbell JN (1996) Pain 1996 – An updated review. IASP Press, Seattle
25. Caraceni A, Zecca E, Martini C, De Conno F (1999) Gabapentin as an adjuvant to opioid analgesia for neuropathic cancer pain. J Pain Symptom Manage 17: 441-445
26. Chandler A, Williams JE (2000) Gabapentin, an adjuvant treatment for neuropathic pain in a cancer hosipital. J Pain Symptom Manage 20: 82-86
27. Cherny N, Ripamonti C, Pereira J et al. (2001) Strategies to manage the adverse effects of oral morphine: an evidence-based report. J Clin Oncol 19: 2542-2554
28. Cherny NI (1996) The medical treatment of pain in the terminal stages of cancer and other illnesses. In: Campbell JN (ed) Pain 1996 – An updated review. IASP Press, Seattle, pp 469-484
29. Cherny NI, Portenoy RK, Raber M, Zenz M (1994) Medikamentöse Therapie von Tumorschmerzen, Teil I: Eigenschaften von Nichtopioiden und Opioiden. Der Schmerz 8: 195-209
30. Cherny NI, Portenoy RK, Raber M, Zenz M (1994) Medikamentöse Therapie von Tumorschmerzen, Teil II: Anwendung von Opioiden. Der Schmerz 9: 3-1
31. Cherny NI, Portenoy RK, Raber M, Zenz M (1994) Medikamentöse Therapie von Tumorschmerzen, Teil III: Adjuvanzien. Der Schmerz 9: 55-69
32. CIOMS (Council for International Organizations of Medical Sciences) (1998) Benefit-risk balance for marketed drugs: evaluating safety signals. Report of CIOMS Working Group IV. Geneva, 117-114
33. Collins SL, Faura CC, Moore A, McQuay HJ (1998) Peak plasma concentrations after oral morphine: a systematic review. J Pain Symptom Manage 16: 388-401
34. Coluzzi PH, Schwartzberg L, Conroy Jr JD et al. (2001) Breakthrough cancer pain: a randomized trial comparing oral transmucosal fentanyl citrate (OTFC) and morphine sulfate immediate release (MSRI). Pain 91: 123-130
35. Comroe JH, Forster RE, Dubois AB, Briscoe WA, Carlsen E (1968) Die Lunge. Schattauer, Stuttgart
36. Cools HJM, Berkhout AMM, De Bock GH (1996) Subcutaneous morphine infusion by syringe driver for terminally ill patients. Age Ageing 25: 206-208
37. Coyle H, Ingham J (1996) Pain management in the imminently dying – Goals of care, ethical issues, and the role of sedation: An illustrative case. In: Campbell JN (ed) Pain 1996 – An updated review. IASP Press, Seattle, pp 567-57

38. Coyle N, Adelhardt J, Foley KM, Portenoy RK (1990) Character of terminal illness in the advanced cancer patient. J Pain Symptom Manage 5: 83
39. De Sio JM, Bacon DR, Peer G, Lema MJ (1993) Intravenous abuse of transdermal fentanyl therapy in a chronic pain patient. Anesthesiology 79: 1139-1141
40. De Stoutz ND, Bruera E, Suarez-Almazor M (1995) Opioid rotation for toxicity reduction in terminal cancer patients. J Pain Symptom Manage 10: 378-384
41. Dejgard A, Petersen P, Kastrup J (1988) Mexiletine for treatment of chronic painful diabetic neuropathy. Lancet I: 9-11
42. Deutsche Krebsgesellschaft (2002) Kurzgefasste Interdisiplinäre Leitlinien. 3. Auflage, 2002
43. Devulder J, Ghys L, Dhondt W, Rholly G (1994) Spinal analgesia in terminal care: Risk versus benefit. J Pain Symptom Manage 9/2: 75-81
44. Donner B, Strumpf M, Dertwinkel R, Zenz M (1997) Neue Alternative in der Tumortherapie. Richtige Anwendung von Fentanyl TTS entscheidend. Dtsch Ärztebl 94/10: A 598-599
45. Dooley M, Balfour JA (1999) Ibandronate. Drugs 57: 101-108
46. Drechsler S, Bauer R (1995) 5-HT-3-Rezeptorantagonisten. Der Weg zum therapeutischen Fortschritt in der supportiven Tumortherapie. Arzneimitteltherapie 8: 224-235
47. Edinboro LE, Poklis A, Trautman D, Lowry S, Backer R, Harvey CH (1997) Fatal fentanyl intoxication following excessive transdermal application. J Forensic Sci 42: 741-743
48. Ellershaw JE, Suttcliffe JM, Saunders CM (1995) Dehydration and the dying patient. J Pain Symptom Manage 10/3: 192-197
49. Elsner F, Radbruch L, Sabatowski R et al. (1999) Opioidwechsel auf transdermales Fentanyl im klinischen Alltag. Schmerz 13: 273-278
50. Expert Working Group of the Research Network of the European Association for Palliative Care: Hanks GW, deConno F, Cherny N, Hanna M, Kalso E, McQuay HJ, Mercadante S, Meynadier J, Poulain P, Rpiamonti C, Radbruch L, Twycross R et al. (2001) Morphine and alternative opioids in cancer pain: the EAPC recommendations. Br J Cancer 84: 587-593
51. Fainsinger RL, Bruera E (1994) The management of dehydration in terminally ill patients. Palliat Care 10: 55-59
52. Fainsinger RL, Spachynski K, Hanson J, Bruera E (1994) Symptom control in terminally ill patients with malignant bowel obstruction (MBO). J Pain Symptom Manage 9/1: 12-18
53. Fainsinger RL; Miller MJ, Bruera E (1991) Symptom control during the last weeks of life on a palliative care unit. J Palliat Care 7/1: 5-11
54. Farncombe M, Chater S (1993) Case studies outlining use of nebulized morphine for patients with end-stage chronic lung and cardiac disease. J Pain Symptom Manage 8/4: 221-225
55. Foley KM (1985) The treatment of cancer pain. N Engl J Med 313: 84
56. Foley KM (1989): Controversies in cancer pain: medical perspective. Cancer 63: 2257
57. Foley KM (1993) Opioid analgesics in clinical pain management. In: Herz A (ed) Opioids. Handbook of experimental pharmacology, vol 104/II. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokyo, pp 697–743
58. Foley KM, Inturrisi CE (1987) Analgesic drug therapy in cancer pain: Principles and practice. Med Clin North Am 71: 107
59. Foley KM, Inturrisi CE(1989) Pharmacological approaches to cancer pain. In: Foley KM, Payne RM (eds) Current therapy of pain. Decker, Toronto, pp 303-331

60. Forman B, Portenoy RK, Yanagihara RH, Hunt WC, Kush R, Shepard K (1992) Elderly cancer patients with pain: response to oral morphine (MS) dose, pain and toxicity. J Am Geriatr Soc 40/10: SA 26
61. Freynhagen R, Zenz M, Strumpf M (1994) WHO Stufe II – Klinische Realität oder didaktisches Instrument. Der Schmerz 8: 210-215
62. Frolich M, Gianotti A, Modell JH (2002) Opioid overdose in a patient using a fentanyl patch during treatment with a warming blanket. Anesth Analg 93: 647-648
63. Füsgen I, Wanitschke R (2001) Obstipationsmanual. Diagnostik, Therapie und Rehabilitation. Schriftenreihe Geriatrie. Der ältere Patient in Praxis und Klinik. Vincentz Verlag, Hannover
64. Gestin Y, Vainio A, Pérugier AM (1997) Long-term intrathecal infusion of morphine in the home care of patients with advanced cancer. Acta Anaesthesiol Scand 41: 12-17
65. Goh CR (1996) Routes of opioid administration: The role of sublingual/buccal, transdermal and parenteral infusion therapy. In: Campbell JN (ed) Pain 1996 – An updated review. IASP Press, Seattle
66. Gorman DJ (1991) Opioid analgesics in the management of pain in patients with cancer: An update. Palliat Med 5: 277-29
67. Grond S, Zech D (1992) Aktuelle Strategien in der Behandlung von Tumorschmerzen. Med Klinik 87/4: 198-206
68. Grond S, Zech D, Dahlmann H, Schug SA, Stobbe B, Lehmann KA (1990) Überweisungsgrund »therapieresistente« Tumorschmerzen. Schmerz 4: 193-200
69. Grond S, Zech D, Meuser T, Radbruch L, Kasper M, Lehmann KA (1992) Prävalenz und Charakteristik neuropathischer Schmerzen bei malignen Erkrankungen. Der Schmerz 6: 99-104
70. Grond S, Zech D, Schug SA, Lynch J, Lehmann KA (1991) Validation of World Health Organisation Guidelines for cancer pain relief during the last days and hours of life. J Pain Symptom Manage 6/7: 411-412
71. Hackenthal E (1999) Therapie mit Analgetika/nicht steroidalen Antirheumatika. In: Platt D, Mutschler E (Hrsg) Pharmakotherapie im Alter. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart, 377-401
72. Hagen N, Thrilwell MP, Dhaliwal HS, Babul N, Harsanyi Z, Darke AC (1995) Steady-state pharmacokinetics of hydromorphone and hydromorphone-3-glucuronide in cancer patients after immediate and controlled-release hydromorphone. J Clin Pharmacol 35: 37-44
73. Hagen NA, Babul N (1997) Comparative clinical efficacy and safety of a novel controlled-released oxycodone formulation and controlled-release hydromorphone in the treatment of cancer pain. Cancer 79: 1428-1437
74. Hamunen K, Olkola KT, Maunuksela EL (1993) Comparison of the ventilatory effects of morphine and buprenorphine in children. Acta Anaesthesiol Scand 37: 449-453
75. Hankemeier U, Schüle-Hein K, Krizanits (Hrsg) (2001) Tumorschmerztherapie, 2., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Springer Verlag, Berlin
76. Hanks GW (1996) Principles of system opioid pharmacotherapy. In: Campbell JN (ed) Pain 1996 – An updated review. IASP Press, Seattle, pp 219–238
77. Hanks GW, Justins DM (1992) Cancer pain: management. Lancet 39: 1031-1036
78. Hanks GW, Twycross RG, Lloyd JW (1981) Unexpected complication of successful nerve block. Anaesthesia 36: 37-39

79. Hardwick WR Jr, King WD, Palmisano PA (1997) Respiratory depression in a child unintentionally exposed to transdermal fentanyl patch. South Med J 90: 9962-964
80. Heaton KW, O'Donnell LJ, Braddon FE, Mountford RA, Hughes RO, Cripps PJ (1992) Symptomes of irritable bowel syndrome in a British urban community: consulters and nonconsulters. Gastroenterology 102: 1962-1967
81. Heidemann E (1999) Tumorpatienten in Deutschland: Was wissen wir über Schmerzprävalenzen? Schmerz 13: 249-252
82. Herz A, Stein C (1992) Opioide vermitteln antinozizeptive Wirkungen in der entzündeten Pfote von Ratten. Der Schmerz 5: 158-159
83. Heyse-Moore LH, Poss V, Mullee MA (1991) How much of a problem is dyspnoea in advanced cancer? Palliat Med 5: 20-26
84. Hildebrandt J (1994) Therapie chronischer Schmerzen. Jungjohann Verlagsgesellschaft, Neckarsulm
85. Hinz B, Brune K (1999) Spezifische COX-2-Inbitoren: Perspektiven einer Therapie mit neuen analgetischen und antiinflammatorischen Wirkstoffen. Wien Klein Wochenschr 111: 103-112
86. Hinz B, Brune K (2002) Pharmakologie: Analgetika. In: Beck H, Martin E, Motsch J, Schulte am Esch J (Hrsg)1 Schmerztherapie. Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin, Schmerztherapie, Band 42. Thieme, Stuttgart New York, S. 103-117
87. Hogan Q, Haddox JD, Abram S, Weissmann D, Taylor ML, Janjan N (1991) Epidural opiates and local anesthetics fort he management of cancer pain. Pain 46: 271-279
88. Illes P, Jurna I, Kaever V, Resch K (1998) Analgetika und Antiphlogistika. Schmerzbekämpfung und antirheumatische Therapie. In: Forth W, Henschler D, Rummel W, Starke K (Hrsg) Allgemeine und spezielle Pharmakologie und Toxikologie. 7., völlig neu bearbeitete Aufl. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg Berlin, 201-225
89. Indelicato RA, Portenoy RK (2002) Opioid rotation in the management of refractory cancer pain. J Clin Oncol 20: 348-352
90. International Narcotics Control Board (2002) Consumption of principal narcotic drugs (2001) Narcotic Drugs. Estimated world requirements for 2002, statistics for 2000. United Nations, New York, pp. 181
91. International Narcotics Control Board (2005) Consumption of principal narcotic drugs. Narcotic Drugs. Estimated world requirements 2005, statistics for 2003. United Nations, New York, p 159
92. Jage J (1995) Medikamente gegen Krebsschmerzen. Chapman & Hall, London Weinheim
93. Jage J (2003) Medikamente gegen Krebsschmerzen. 4., völlig neu bearbeitete Auflage. Thieme, Stuttgart
94. Jage J, Jurna I (2001) Opioidanalgetika. In: Zenz M, Jurna I (Hrsg) Lehrbuch der Schmerztherapie, 2. Auflage. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart, 255-280
95. Jensen TS (2002) Anticonvulsants in neuropathic pain: rationale and clinical evidence. Eur J Pain 6 (Suppl A): 61-68
96. Jurna I (1997) Opioid and nonopioid agents: some aspects of central (spinal) and peripheral actions. Pain Rev 4: 205-224
97. Jurna I, Baldauf J (1993) Retardiert freigesetztes Naloxon oral: Aufhebung der Obstipation durch orales Morphin ohne Beseitigung der Analgesie. Der Schmerz 7: 314

98. Kaiko RF (1997) Pharmacokinetics and pharmacodynamics of controlled-release opioids. Acta Anaesthesiol Scand 41: 166-174
99. Kalso E, Vainio A (1990) Morphine and oxycodone in the management of cancer pain. Clin Pharmacol Ther 47: 639-646
100. Karavelis A, Foroglou G, Selviaridis P, Fountzilas G (1996) Intraventricular administration of morphine for control of intractable cancer pain in 90 patients. Neurosurgery 39: 57-62
101. Kaufmann PN, Krevsky B, Malmud LS, Maurer AH, Sommers MB, Siegel JA, Fisher RS (1988) Role of opioid receptors in the regulation of colonic transit. Gastroenterology 94: 1351
102. Klaschik E (2003) Symptome in der Palliativmedizin: Obstipation. Schlütersche, Hannover
103. Klaschik E, Clemens KE (2005) Opioide in der Tumorschmerztherapie – Wirksamkeit und Nebenwirkungen. Schmerz 19: 395–403
104. Klockgether-Radke AP, Gaus P, Neumann P (2002) Opioidintoxikation durch transdermales Fentanyl. Der Änaesthesist 51: 269-271
105. Klockgether-Radkke A, Hildebrandt J (1997) Opioidintoxikation. Unsachgemäße Anwendung von transdermalem Fentanyl. Anaesthesist 46: 428-429
106. Kramer C, Tawney H (1998) A fatal overdose of transdermally administered fentanyl. J Am Osteopath Assoc 98: 385-386
107. Krames ES (1993) Intrathecal infusional therapies for intractable pain: patient management guidelines. J Pain Sympt Manage 8: 36-46
108. Larsen B, Otto H, Dorscheid E, Larsen R (1999) Aufmerksamkeitsbelastung und Reaktionszeiten unter Opioiddauertherapie. Anaesthesist 48: 613-624
109. Lawlor P, Turner K, Hanson J, Bruera E (1997) Dose ratio between morphine and hydromorphone in patients with cancer pain: a retrospective study. Pain 72: 79-85
110. Lee MA, Leng MEF, Tiernan EJJ (2001) Retrospective study of the use of hydromorphone in palliative care patients with normal and abnormal urea and creatinine. Palliat Med 15: 26-34
111. Lehmann KA (1994) Der postoperative Schmerz. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokio
112. Lehmann KA (Hrsg) (2002) Analgetische Therapie mit Opioiden. UNI-MED, Bremen
113. Lehmann KA, Zech D (1993) Morphine-6-glucuronide, a pharmacologically active morphine metabolite. Eur J Pain 14: 28-35
114. Lema MJ (1993) Cancer pain management: An overview of current therapeutic regimens. Semin Anesth XII/2: 109-11
115. Leutner V (1990) Schlaf, Schlafstörungen, Schlafmittel. Editiones Roches, Basel
116. Lichter I (1993) Results of antiemetic management in terminal illness. J Palliat Care 9/2: 19-21
117. Lichter I (1994) Accelerated titration of morphine for rapid relief of cancer pain. NZ Med J 107: 488-490
118. Lichtor JL, Sevarino FB, Joshi GP, Busch MA, Nordbrock E, Ginsberg B (1999) The relative potency of oral transmucosal fentanyl citrate compared with intravenous morphine in the treatment of moderate to severe postoperative pain. Anest Analg 89: 732-738
119. Likar R, Sittl R (2002) Praxis der transdermalen Schmerztherapie. UNI-MED, Bremen

120. Lindena G, Arnau H, Liefhold J (1998) Hydromorphon – pharmakologische Eigenschaften und therapeutische Wirksamkeit. Schmerz 12: 195-204
121. Lindena G, Müller S, Zenz T (1994) Opioidverschreibung durch niedergelassene Ärzte. Der Schmerz 8: 228-234
122. Lloyd JW, Barnard JDW, Glynn CJ (1976) Cryoanalgesia: a new approach to pain relief. Lancet II: 932-934
123. Locke GR III. (1996) The epidemiology of functional gastrointestinal disorders in North America. Gastroenterol Clin North Am 25: 1-19
124. Loick G, Radbruch L, Petzke F, Lehmann KA (1996) Tumorschmerztherapie bei geriatrischen Patienten im Vergleich mit jüngeren Patienten. Der Schmerz 10 (Suppl 1): 58
125. Lorenz J, Baumgärtner U, Zander AR, Bromm B (1996) Differenzierung von schmerz- und morphinbedingter Beeinträchtigung kognitiver Leistungen und subjektiver Befindlichkeit bei Knochenmarktransplantationspatienten. Der Schmerz 10: 80-88
126. Lorenz J, Beck H, Bromm B (1997) Cognitive performance, mood and experimental pain before and during morphin-induced analgesia in patients with chronic non-malignant pain. Pain 73: 189-195
127. Lötsch J, Geisslinger G, Tegeder I (2001) Opioide bei Leber- oder Nierenfunktionsstörung. In: Zenz M, Jurna I (Hrsg) Lehrbuch der Schmerztherapie, 2. Auflage. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart, 329-34
128. Lynn AN, Slattery JT (1987) Morphine pharmacokinetics in early infancy. Anesthesiology 66: 136-139
129. MacDonald FC, Gough KJ, Nicoll RAG, Dow RJ (1989) Psychomotor effects of ketolorac in comparison with buprenorphine and diclophenac. Br J Pharmacol 27: 453-459
130. Maier C, Senne I (2001) Calcitonin und Bisphosphonate. In: Zenz M, Jurna I (Hrsg) Lehrbuch der Schmerztherapie, 2. Auflage. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart, 309-321
131. Maloney CM, Kesner RK, Klein G, Bockenstette J (1989) The rectal administration of MS contin: Clinical implications of use in end stage cancer. Am J Hospice Care 6/4: 34-35
132. Mancini I, Lossignol DA, Body JJ (2000) Opioid switch to oral methadone in cancer pain. Curr Opin Oncol 12: 308-313
133. Mao J, Chen LL (2000) Gabapentin in pain management. Anesth Analg 91: 680-687
134. Mao J, Price D, Mayer DH (1995) Mechanisms of hyperalgesia and morphine tolerance: a current view of their possible interactions. Pain 662: 259-274
135. Marquardt KA, Tharrat RS (1994) Inhalation abuse of fentanyl patch. J Toxikol Clin Toxikol 32: 75-78
136. Mather LE (2001) Trends in the pharmacology of opioids: implications for the pharmacotherapy of pain. Eur J Pain 5 (Suppl A): 49-57
137. Maydell R von, Voltz R (1996) Palliativmedizin: Neurologie und Psychiatrie. Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, München
138. McQuay HJ, Carroll D, Faura CC, Gavagghan DJ, Hand CW, Moore RA (1990) Oral morphine in cancer pain: influences on morphine and metabolite concentration. Clin Pharmacol Ther 48: 236
139. Melzack R, Mount BM, Gordon JM (1979) The Brompton mixture versus morphine solution given orally: effects on pain. Can Med Assoc J 120: 435-439

140. Mercadante S (1999a) Opioid rotation for cancer pain. Rational and clinical aspects. Cancer 96: 1856-1866
141. Mercadante S (1999b) Problems of long-term spinal opioid treatment in advanced cancer patients. Pain 79: 1-13
142. Mercadante S, Portenoy RK (2001a) Opioid poorly-responsive cancer pain. Part 1. Clinical considerations. J Pain Symptom Manage 21: 144-150
143. Mercadante S, Portenoy RK (2001b) Opioid poorly-responsive cancer pain. Part 2. Basic mechanisms that could shift dose response for analgesia. J Pain Symptom Manage 21: 255-264
144. Mercadante S, Portenoy RK (2001c) Opioid poorly-responsive cancer pain. Part 3. Clinical strategies to improve opioid responsiveness. J Pain Symptom Manage 21: 338-354
145. Meuser T, Pietruck C, Radbruch L et al. (2001) Symptoms during cancer pain treatment following WHO-guidelines: a longitudinal follow-up study of symptom prevalence, severity and etiology. Pain 93: 247-257
146. Müller H (2001) Spinale Opioidanalgetika. In: Zenz M, Jurna I (Hrsg) Lehrbuch der Schmerztherapie, 2. Auflage. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart, 441-456
147. Müller-Busch HC (2004) Sterbende sedieren? Z Palliativmed 5: 107-112
148. Müller-Lissner S (1992) Nebenwirkungen von Laxantien. Z Gastroenterol 30: 418-427
149. Munzinger H, Horstkotte E, Hoffman W (2001) Opioidanalgetika in der Behandlung ambulanter Tumorpatienten 1993 bis 1996. Schmerz 2001 15: 26-32
150. Mutschler E, Geisslinger G, Kroemer HK, Schäfer-Korting M (2001) Arzneimittelwirkungen. Lehrbuch der Pharmakologie und Toxikologie, 8. Auflage. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart
151. Nauck F, Klaschik E (2002) Schmerztherapie. Kompendium für Ausbildung und Praxis. Wisenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart
152. Nauck F, Ostgathe C, Dickerson ED, Klaschik E (2002) Controlled-release hydromorphone: an alternative to morphine for cancer pain. The Pain Clinic, April 2002, 13-17
153. Nauck F (1994) Der Patient in der Finalphase. In: Klaschik E, Nauck F (Hrsg) Palliativmedizin Heute. Springer, Berlin, Heidelberg New York Tokio, pp 42–53
154. Newshan G (1998) Heat related toxicity with the fentanyl transdermal patch. J Pain Symptom Manage 16: 277-2
155. Nitescu P, Sjoberg M, Appelgren L, Curelaru I (1995) Complications of intrathecal opioids and bupivacaine in the treatment of »refractory« cancer pain. Clin J Pain 11: 45-62
156. Ostgathe C, Nauck F, Klaschik E (2003) Schmerztherapie heute. Stand der Schmerztherapie in Deutschland. Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 38: 312-320
157. Patwardhan RV, Johnson RF, Hoyumpa A (1981) Normal metabolism of morphine in cirrhosis. Gastroenterology 81: 1006-1011
158. Payne R, Thomas J, Prithivi Raj P (1992) Pain due to cancer - epidemiology and pharmacological approach. In: Prithivi Raj P (ed) Practical management of pain. Mosby Year Book, St. Louis
159. Peireira J, Lawlor P, Virgano A et al. (2001) Equianalgesic dose ratios for opioids: a critical review and proposals for long-term dosing. J Pain Symptom Manage 22: 672-687
160. Petzke F, Radbruch L, Sabatowski R et al. (2000) Slow-release tramadol for treatment of chronic malignant pain – an open multicenter trial. Support Care Cancer 9: 48-54

161. Portenoy RK (1996) Nontraditional analgesics in the management of cancer pain. In: Campbell JN (ed) Pain 1996 – An updated review. IASP Press, Seattle
162. Portenoy RK (1999a) Management of cancer pain. Lancet 353: 1695-1700
163. Portenoy RK, Payne D, Coluzzi P et al. (1999b) Oral transmucosal fentanyl citrate (OTFC) for the treatment of breakthrough pain in cancer patients: a controlled dose titration study. Pain 79: 303-312
164. Portenoy RK, Payne D, Jacobsen P (1999c) Breakthrough pain: characteristics and impact in patients with cancer pain. Pain 81: 129-134
165. Porter J, Jick H (1980) Addiction is rare in patients treated with narcotics (letter) N Engl J Med 302: 123
166. Poyhia R, Seppala T, Olkkola KT, Kalso E (1992) The pharmacokinetics and metabolism of oxycodone after intramuscular and oral administration to healthy subjects. Br J Clin Pharmacol 33: 617-621
167. Poyhia R, Vaino, Kalso E (1993) A review of oxycodone's clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics. J Pain Symptom Manage 8: 63-67
168. Radbruch L, Sabatowski R, Loick G et al. (2000) Constipation and the use of laxatives: a comparison between transdermal fentanyl and oral morphine. Palliat Med 14: 111-119
169. Radbruch L, Sabatowski R, Petzke F et al. (2001) Transdermal fentanyl for the management of cancer pain: a survey of 1005 patients. Palliat Med 15: 309-321
170. Raffa RB, Friderichs E, Reimann W et al. (1992) Opioid and non-opioid components independently contribute to the mechanism of action in tramadol, an »atypical« opioid analgesic. J Pharmacol Exp Ther 260: 275-285
171. Regnard C (1987) Nausea and vomiting – a flow diagram. Palliat Med 1: 62-6
172. Regnard C, Hockley J (1995) Flow diagrams in advanced cancer and other diseases. Edward Arnold, London Boston Melbourne Auckland
173. Ripamonti C, Dickersen ED (2001) Strategies for the treatment of cancer pain in the new millennium. Drugs 61: 955-977
174. Ripamonti C, Groff L, Brunelli O et al. (1998) Switching from morphine to oral methadone in treating cancer pain: what is the equianalgesic dose ratio? J Clin Oncol 16: 3216-3221
175. Rose MA, Kam PC (2002) Gabapentin: pharmacology and its use in pain management. Anesthesia 57: 451-46
176. Saarialho-Kere U, Mattila MJ, Paloheimo M, Seppälä T (1987) Psychomotor, respiratory and neuroendocrinological effects of buprenorphine and amitriptyline in healthy volunteers. Eur J Clin Pharmacol 33: 139-146
177. Sabatowski R, Arens ER, Waap I, Radbruch L (2001) Tumorschmerztherapie in Deutschland. Ergebnisse und Analysen einer Befragung von Ärzten. Schmerz 15: 241-247
178. Samuelsson H, Malmberg F, Eriksson M, Hedner T (1995) Outcomes of epidural morphine treatment in cancer pain: nine years of clinical experience. J Pain Symptom Manage 10/2: 105-112
179. Santiago-Palma J, Khojainova N, Kornick C et al. (2001) Intravenous methadone in the management of chronic cancer pain. Cancer 92: 1919-19
180. Schüle-Hein K (1989) Palliative Strahlenbehandlung. In: Hankemeier U, Bowdler J, Zech D (Hrsg) Tumorschmerztherapie. Springer, Berlin Heildelberg New York Tokio, 102-123

181. Schuster CR (1989) Does treatment of cancer pain with narcotics produce junkies? In: Hill CS, Fields WS (eds) Drug treatment of cancer pain in a drug-oriented society. Raven, New York (Advances in pain research and therapy, vol 11,1)
182. Schwabe U (2002) Qualität der Arzneimittelversorgung. In: Schwabe U, Paffrath D (Hrsg) Arzneiverordnungsreport 2002. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokio, 832–852
183. Seiler KU, Jähnchen E, Trank D et al. (2001) Pharmacokinetics of tilidine in terminal renal failure. J Clin Pharmacol 41: 79-84
184. Sindrup SH, Jensen TS (2001) Antidepressants in the treatment of neuropathic pain. In: Hansson PT, Fields RG, Hill RG, Marchetti P (eds) Neuropathic pain: pathophysiology and treatment. Progr Pain Res Manage Vol 21. IASP Press Seattle, 169-183
185. Smith MT, Watt JA (1990) Morphine-3-glucuronide – a potent antagonist of morphine analgesia. Life Sci 47: 57
186. Sonnenberg A, Koch TR (1989) Epidemiology of constipation in the United States. Dis Colon Rectum 1989; 32: 1-8
187. Stein C, Cabot PJ, Schäfer M (1999) Peripheral opioid analgesia: mechanisms and clinical implications. In: Stein C (ed) Opioid in pain control. Cambridge University Press, Cambridge, 96-108
188. Stein WM (1996) Cancer pain in the elderly. In: Ferrell BR, Ferrel BA (eds) Pain in the elderly. IASP Press, Seattle
189. Stewart WF, Liberman JN, Sandler RS, Woods MS, Sternhagen A, Chee E, Lipton RB, Farup CE (1999) Epidemiology of constipation (EPOC) Study in the United States: Relation of clinical subtypes to socioeconomic features. Am J Gastroenterol 94: 3530-3539
190. Striebel HW, Wessel A, Rieger A (1993) Intranasales Fentanyl zur Therapie akuter Schmerzspitzen bei Karzinompatienten. Eine Pilotstudie. Der Schmerz 7: 174-177
191. Strumpf M, Köhler A, Zenz M, Willweber-Strumpf A, Dertwinkel R, Donner B (1997) Opioide und Fahrtüchtigkeit. Schmerz 11: 233-240
192. Strumpf M, Willweber-Strumpf A, Zenz M (2005) Tumorschmerz. Dtsch Ärztebl 102: 916-924
193. Talley NJ, Weaver AL, Zinsmeister AR (1993) Functional constipation and outlet delay. A population-based study. Gastroenterology 105: 781-790
194. Teuscher E (1979) Pharmazeutische Biologie – Alkaloide. Vieweg, Braunschweig
195. Teuscher E (1987) Biogene Gifte – Isocholin. G. Fischer, Stuttgart
196. Tremont-Lukats IW, Megeff C, Backonja MM (2000) Anticonvulsants for neuropathic pain syndromes. Drugs 60: 1029-1052
197. Tronnier V, Winkelmüller W (2001) Neurochirurgische Methoden. In: Lehrbuch der Schmerztherapie, 2. Auflage. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart, S 373–382
198. Twycross R (1993) Symptom control: the problem areas. Palliat Med 7 (Suppl 1): 1–8
199. Twycross R (1994) Pain relief in advanced cancer. Churchill Livingstone, Edinburgh London
200. Twycross R (1998) Opioid rotation. Does it have a role? Palliat Med 12: 60–61
201. Twycross R (1999) Opioids. In: Wall PD, Melzack R (eds) Textbook of pain. 4th edition. Churchill Livingston, Edinburgh London, 1187-1214
202. Twycross R, Lack SA (1984) Symptom control in far advanced cancer. Pain relief. Pitman, London

203. Twycross RG (1979) Effect of cocaine in the Brompton cocktail. In: Bonica JJ, Liebeskind JC, Albe-Fessard DG (eds) Advances in pain research and therapy, vol 3. Raven, New York, 927-932
204. Vainio A, Ollila J, Matikainen E, Rosenberg E, Kalso E (1995) Driving ability in cancer patients receiving long-term morphine analgesia. Lancet 346: 667-670
205. Vanderath TW, Ossipov MH, Lai J et al. (2001) Mechanisms of opioid-induced pain and antinociceptive tolerance: descending facilitation and spinal dynorphin. Pain 92: 5-10
206. Walsh TD (1984) Opiates and respiratory function in advanced cancer. In: Zimmermann M, Drings P, Wagner G (eds) Pain in cancer patients. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokyo, pp 115-117
207. Wanitschke R, Goerg KJ, Loew D (2003) Differential therapy of constipation a review. International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics 41: 14-21
208. Warfield CA (1993) Guidelines for routine use of controlled-release oral morphine sulphate tablets. Semin Oncol 20/2 (Suppl 1): 36-47
209. Watson CPN, Babul N (1998) Efficacy of oxycodone in neuropathic pain. A randomized trial in postherpetic neuralgia. Neurology 50: 1837-1841
210. WHO (1996) Cancer pain relief, with a guide to opioid availability. World Health Organisation, Geneva
211. WHO Expert Committee Report (1990) Cancer pain relief and palliative care. Technical report service no. 804. World Health Organisation, Geneva
212. Willweber-Strumpf A, Zenz M, Tryba M (1995) Leitlinien zur Therapie chronischer Schmerzen mit Opioiden. Anaesthesist 44: 719-723
213. Winkelmüller W (1992) Neurostimulation: Einführung in die Thematik. Der Schmerz 6 (Suppl 1): 26
214. Yaksh TL (1996) Intrathecal and epidural opiates: A review. In: Campbell JN (ed) Pain 1996 – An updated review. IASP Press, Seattle, 381-393
215. Zech D, Grond S, Lehmann KA (1995) Transdermales Fentanyl zur Behandlung von Tumorschmerzen. Dtsch Ärztebl 92: 2554-2561
216. Zech D, Schug SA, Grond S (1992) Therapiekompendium Tumorschmerz und Symptomkontrolle. Perimed-Spitta, Erlangen
217. Zenz M (1993) Taschenbuch der Schmerztherapie. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart
218. Zenz M (2001) Zu schön, um wahr zu sein. Arzneimittelverordnungs-Report bescheinigt Deutschland Vollversorgung beim Tumorschmerz. Schmerz 15: 409-410
219. Zenz M, Jurna I (1993) Lehrbuch der Schmerztherapie. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart
220. Zenz M, Jurna I (Hrsg) (2001) Lehrbuch der Schmerztherapie, 2. Auflage. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart
221. Zenz M, Zenz T, Tryba M, Strumpf M (1995) Severe undertreatment of cancer pain: a 3-year survey of the German situation. J Pain Symptom Manage 10 (3): 187–191

5 Psychosoziale Fragen

S. Husebø

5.1 Familie und Umfeld

Menschen leben in einem sozialen Umfeld; sie haben einen Beruf und eine Arbeit oder haben keinen Beruf und/oder auch keine Arbeit. Alle haben Gefühle, Gedanken, Befürchtungen, Freunde und Familie. Vieles ist in ihrem Leben passiert, bevor sie von Krankheit betroffen wurden. Wenn der Patient von einer ernsten Erkrankung getroffen wird, erhält die Biographie der Patienten, ihre Erfahrungen mit Leben und Krankheit, eine große Bedeutung. Sie haben Stärken und Schwächen, bevor sie krank werden. Diese Stärken oder Schwächen können sich aufgrund der Krankheit ändern, sie können die Krankheitsentwicklung und den Umgang mit der Krankheit negativ oder positiv beeinflussen (Cassel 1982; Barinaga 1989).

Wir wissen, dass jeder Mensch individuell auf eine Erkrankung reagiert. In welchem Maße er oder sie mit dieser Krankheit und ihren Folgen zurechtkommt, hängt von den zuvor beschriebenen Faktoren ab. Eine Frau, die zu Hause kleine Kinder hat und selbst unter einem Mammakarzinom mit Metastasen leidet, wird vor anderen Herausforderungen stehen als ein Mann, der in einem Alter von 76 Jahren ein metastasierendes Pankreaskarzinom bekommt. Ob der Patient in Afrika oder Deutschland zu Hause ist, wird seine Gegenwart und Zukunft, Wahlen und Qualen beeinflussen. Wenn eine 83-jährige Patientin, die seit drei Jahren im Pflegeheim wohnt, von einer inkurablen Erkrankung erfährt, hat sie andere Sorgen und wird anders reagieren als der 54-jährige selbstständige Gastwirt mit der gleichen Diagnose, der zu Hause Frau und vier Kinder zu versorgen hat.

Dass Krebs oder andere lebensbegrenzende Erkrankungen eine große Belastung sowohl für den Kranken als auch für sein soziales Umfeld bedeuten, ist durch viele Studien bewiesen. Die Familie und das gesamte soziale Umfeld des Kranken werden auch durch die Erkrankung betroffen. Umgekehrt wird ein Tumorpatient besser mit seiner Krankheit zurechtkommen, wenn er einen Ehepartner und eine Familie hat, die in der Lage sind, sich um ihn zu kümmern. Es gibt sogar Hinweise, dass die Überlebenszeit verlängert wird (Ganz et al. 1991). Goodwin et al. (1987) konnten in einer großen Studie nachweisen, dass nichtverheiratete Patienten eine signifikant kürzere Überlebenszeit hatten. Es gibt aber Situationen, in denen die Familie eine zusätzliche Belastung für den Kranken bedeutet.

Es gibt Untersuchungen, die zeigen konnten, dass die Entwicklung einer Tumorerkrankung durch psychosoziale Unterstützung positiv beeinflusst werden kann (Barinaga 1989). Spiegel et al. (1989) fanden in einer prospektiven Studie, in der Frauen mit Brustkrebs über zehn Jahre betreut wurden, dass deren Überlebenszeit bei Gruppenbehandlung deutlich höher lag. Die Patientinnen in der Studie erhielten eine unterstützende Gruppentherapie über einem Zeitraum von einem Jahr nach der Diagnosestellung. Die mittlere Überlebenszeit war mit 36,6 Monaten doppelt so hoch wie bei den Teilnehmerinnen in der Kontrollgruppe, wo die mittlere Überlebenszeit 18,9 Monate betrug.

Manchmal ist es schwer zu erkennen, wo in einem Familiensystem Probleme und Reserven liegen. Viele Ärzte haben erlebt, wie der Patient über die Angehörigen folgende Aussagen machte: »Ich verstehe jetzt, dass die Krankheit unheilbar ist und der Tod bevorsteht, aber sagen Sie es bitte nicht meinem Mann!« Solche Aussagen können ein Versuch sein, den Lebenspartner zu schützen. Es wiederholt sich aber immer wieder, dass solche Aussagen eher dazu dienen, sich selbst zu schützen.

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie wir Einblick in die psychosozialen Probleme der Patienten bekommen können. Weisman (1989) beschreibt wichtige Fragen in einem offenen Gespräch mit dem Patienten über vorhandene und potenzielle Belastungen und Fragen, die es dem Patienten ermöglichen zu beschreiben, welche Hilfe er benötigt.

Fragen an Patienten:

- **Welche Probleme hat er/sie?**
  - Krankheit und Gesundheit
  - Familie und Lebenspartner
  - Wohnung und Finanzen
  - Soziale und sexuelle Funktion
  - Beruf und tägliche Aktivitäten
  - Selbstbild
  - Religion und Existenz
- **Welche Hilfe braucht er/sie?**
  - Symptomkontrolle
  - Praktische Hilfe und Unterstützung
  - Verbesserung der Sicherheit
  - Kommunikation mit Angehörigen, Freunden, Arzt/Krankenschwester
  - Mut, um die Zukunft ertragen zu können

In der Praxis sehen wir leider, wie leicht es für das medizinische Fachpersonal ist, diese Fragen nicht anzusprechen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Teils geben wir an, zu wenig Zeit zu haben. Teils müssen wir annehmen, dass es an Kompetenz und Einsicht mangelt, um diesen zentralen Fragen den notwendigen Raum zu geben. Dabei übersehen wir, dass keiner so viel über die Kompetenzen und Möglichkeiten des Patienten weiß wie er selbst. Wir bewirken dabei, dass er in seiner Autonomie von Anfang an begrenzt wird. Unsere wichtige Aufgabe liegt darin, diese Autonomie zu fördern und zu unterstützen, damit dem Patienten mit einem Minimum an fremder Hilfe ein Maximum an eigener Autonomie erhalten bleibt.

Virginia Satir hat in mehreren Publikationen Familien als »offene« und »geschlossene« Systeme beschrieben (Satir 1972). Diese Modelle der Familiensysteme sind für uns im Umgang mit den schwerkranken Patienten und ihren Angehörigen von großem Wert, weil wir so Interaktionen, Verbindungen, Rollen und Kommunikationsmuster in der Familie besser verstehen.

Offene und geschlossene Familiensysteme (nach Satir)

- **Offene Familie**
  - Direkte, klare, kongruente Kommunikation, in der jedes Mitglied die Freiheit hat, über alles zu kommunizieren;
  - flexible Verbindungen und Rollen;
  - ein System in einem Gleichgewicht, in dem Interaktion gefördert wird;
  - offene, moderne Regeln und Akzeptanz der Veränderung, die als normal und notwendig angesehen wird.
- **Geschlossene Familie**
  - Begrenzte Kommunikation, mit indirekten, unklaren oder inkongruenten Aussagen;
  - zerstörte Verbindungen ohne eine angemessene Differenzierung der Familienmitglieder;
  - Abhängigkeiten voneinander;
  - starre Familienregeln;
  - Untersysteme, in denen das Einzelmitglied unter Isolation, Unterdrückung oder ungleichem Zugang zur Macht leidet;
  - verdeckte, altmodische und starre Regeln, unter denen Änderungen kaum möglich sind, die Bedürfnisse der Mitglieder nicht erfüllt werden und Wachstum nicht zugelassen wird.
  - Das Hauptziel in einer geschlossenen Familie ist es, Änderungen zu verhindern.

Wenn ein Familienmitglied dem Tod nahe ist, ist das Gleichgewicht der Familie bedroht. Das Familiensystem wird sich gegen die Änderung wehren, um das alte Gleichgewicht wieder herzustellen.

Ein Witwer erzählte mir nach dem Tod seiner Frau: »Ich bin sehr bitter darüber, dass meine Frau vom Arzt über ihre Situation aufgeklärt wurde. Dadurch hat er ihr ihre letzte Hoffnung genommen.« Kurz zuvor berichtete er aber auch, dass sich seine Frau durch diese Aufklärung offen mit ihrem Schicksal auseinandergesetzt hat, es annehmen konnte und würdevoll vom Leben und den Angehörigen Abschied genommen hat.

Er selbst kam mit dieser Situation nicht zurecht: Wütend suchte er nach sinnlosen »alternativen« Therapien und konnte lange Zeit die tröstenden Bemühungen seiner Frau nicht ertragen. Die Aufklärung ist die Grundlage für die Akzeptanz der notwendigen Veränderungen, damit eine Familie mit Diagnose und Krankheitsentwicklung zurechtkommen kann. Das Familienmitglied, das diese Veränderung nicht akzeptieren kann, wird häufig versuchen, den notwendigen und offenen Informationsfluss zu den anderen zu unterbinden.

Familienprobleme sind nicht selten die Ursachen für belastende Symptome bei den Patienten. Schlaflosigkeit, Rollenkonflikte, Gefühlsprobleme, Schmerzen, Angst, Depression und Trauer sind häufig die Folgen (Lichtman et al. 1984). Wir wissen, wie sehr alte und scheinbar »vergessene« Konflikte und Krisen bei den Familienmitgliedern aktiviert werden, wenn neue entstehen. Jedes Familiensystem hat seine spezifische Dynamik, in dem die Rollen und Reviere unter den Familienmitgliedern über viele Jahre verteilt sind. Wenn ein Familienmitglied durch die Erkrankung eine neue Rolle bekommt, wird das ganze Familiensystem gezwungen, eine neue Rollenverteilung vorzunehmen. Besondere Belastungen können hierbei für die Kinder entstehen (▶ Kap. 5.5).

Pflegende und betreuende Ärzte müssen Sensibilität besitzen, damit sie einem durch viele Jahre, Probleme und Reaktionen etabliertem Familiengleichgewicht durch ihre Informationen und ihr Vorgehen keinen zusätzlichen Schaden zufügen. Diese »Homöostase« dient häufig dem Schutz der gesamten Familie und des einzelnen Mitglieds. Wenn Ehepartner seit 20 Jahren oder länger große Schwierigkeiten haben, miteinander über schwierige Themen und Gefühle zu kommunizieren, wird es nur selten gelingen, dieses Verhalten in einer Lebenskrise zu ändern. Wenn eine erwachsene Tochter ein kompliziertes Verhältnis zu ihrer Mutter hat, wird sich diese Beziehung durch die entstandene Krankheit nicht plötzlich verbessern.

Ärzte und Krankenschwestern sind nur ausnahmsweise in der Lage, sich einen Einblick in eine solche Familiendynamik zu verschaffen. Trotzdem erleben wir, dass diese Fachgruppen häufig unvorbereitet in komplizierte Familienkonflikte hineingezogen werden, sodass sie oft mehr Schaden als Nutzen anrichten.

Im Umgang mit diesen Kranken und ihren Angehörigen ist ein Höchstmaß an Verantwortung geboten. Wir müssen uns vor Augen halten, dass der Kranke im Mittelpunkt unserer Maßnahmen und Informationen steht.

Das Wohlergehen der Familie soll zwar auch unser Anliegen sein, aber diese Bemühungen müssen auch im Interesse des Patienten liegen und sollten mit ihm gemeinsam stattfinden.

Wenn ein Familienmitglied durch ein Aufklärungsgespräch ausführlicher und offener informiert wird als der Patient selbst, wird die Kommunikation in der Familie problematisch. Macht kann ausgeübt und missbraucht werden durch das Zurückhalten oder das Geben von Information, Wahrheiten und Unwahrheiten.

Es ist ein besonderes Verdienst der modernen Hospizbewegung, dass man frühzeitig die Bedeutung der Familie und des sozialen Umfelds bei schwerkranken Patienten erkannt hat. Die Teilnahme der Familie an Gesprächen und Kontakten wird bewusst gefördert. Auch im Krankenhaus wird die Familie in das Pflege- und Betreuungssystem eingebunden. Familiengespräche mit Beteiligung von Ärzten, Krankenschwestern und anderen Bezugspersonen haben sich bewährt (Rando 1984). In diesen Begegnungen können praktische Probleme angesprochen, Missverständnisse verhindert oder beseitigt und das gegenseitige Vertrauen vergrößert werden.

Das etablierte Gesundheitswesen zeichnet sich häufig dadurch aus, dass der Patient und seine Angehörigen mit dem Betreten des Krankenhauses zur Passivität und Inaktivität aufgefordert werden. Das Essen wird gebracht, die Betten werden gemacht, die persönliche Hygiene wird vom Pflegepersonal verrichtet. Einige Patienten sind auf fremde Hilfe angewiesen, aber die Mehrheit kann viele Aufgaben selbst durchführen. Warum müssen Patienten, die mit Vorliebe selbst den Tisch decken und mit anderen Patienten die Mahlzeiten zu sich nehmen würden, im Bett essen? Gibt es nicht einen Angehörigen, der gerne Fürsorge übernimmt, sobald er sieht, dass seine Hilfe erwünscht ist?

Die Teilnahme der Angehörigen an der Pflege und Betreuung ist wichtig für den Patienten und für die Angehörigen, sobald dieses Engagement erlaubt und gefördert wird. Besonders deutlich ist dies bei schwerkranken Kindern. Es ist fast selbstverständlich, dass Eltern im Krankenhaus übernachten können, häufig im gleichen Zimmer gemeinsam mit ihrem Kind. Aber auch bei schwerkranken Erwachsenen sind die Erfahrungen mit dieser Integration der Angehörigen für die Versorgung der Patienten sehr positiv.

Patienten und Angehörige empfinden häufig eine große Distanz zu den Ärzten und Krankenschwestern im Krankenhaus. Dadurch kann eine große Barriere entstehen, die eine Einbindung des Patienten oder der Angehöri-

gen in der Pflege verhindert. Umgekehrt erleben wir oft, dass wenig Besuch kommt, oder sehen Angehörige, die sich wenig kümmern. Wo liegt das Problem? Sind es die Angehörigen, die kein Interesse haben, oder sind wir es, die ihre Bemühungen verhindern?

»Ich sehe langsam ein, dass meine Mutter nicht mehr lange zu leben hat«, sagte der Sohn einer sterbenden Frau. »Vielleicht ist sie bewusstlos, wie ihr sagt. Ich möchte aber gerade jetzt bei ihr bleiben, bis es vorbei ist. Vielleicht kann sie nicht länger hören, was ich sage. Ich gebe aber nicht auf. Ich hoffe, dass sie irgendwie vernehmen kann, dass ich bei ihr bin, dass ich mich jetzt um sie kümmere, dass ich es bin, der sie wäscht. Auch wenn sie es nicht mehr wahrnimmt, möchte ich es für mich tun. Sie hat sich das ganze Leben um mich gekümmert.«

Drei Wochen später starb die Mutter. Der Sohn war Tag und Nacht bei ihr geblieben. Er sagte dann:

> Diese Wochen waren die wichtigsten in meinem Leben. – Auch für meine Familie, meine Kinder: Dass sie gesehen haben, wie wichtig meine Mutter für mich ist; dass ich meine sonst über alles stehende Arbeit zur Seite schob, um bei Mutter zu sein; wie ich plötzlich schwach war und viel geweint habe. Sie haben beide wiederholt zu mir gesagt, dass sie jetzt einen anderen Vater bekommen haben.
>
> Ihr Ärzte und Schwestern müsst einsehen, wie schwer es uns im Krankenhaus an der Bettkante gemacht wird, wenn wir uns kümmern wollen. Wir haben Angst, uns aufzudrängen oder etwas falsch zu machen, im Weg zu sein für die wichtige Behandlung. Dabei war für mich das Wichtigste, nichts zu machen! Mich hinzusetzen und mir Zeit zu nehmen, für mich ein Weg zur Versöhnung mit dem bevorstehenden Tod meiner Mutter, eine wichtige Vorbereitung für die Zeit danach.

In einer breit angelegten Untersuchung hat Wilber (1988) zeigen können, dass Angehörige sowohl während der Erkrankung wie auch in der Zeit danach besser mit diesem Verlust zurechtkommen können, wenn sie mit Unterstützung in die Pflege integriert wurden. Ähnliche Beobachtungen dokumentieren, dass Angehörige besser mit dem Leben während der Erkrankung und nach dem Todesfall umgehen, wenn sie frühzeitig in Gespräche mit dem Kranken und den Ärzten eingebunden werden und

auch praktische Aufgaben wie Pflege und Fürsorge übernehmen dürfen (Häggmark et al. 1987; Trijsburg et al. 1992).

Die Angehörigen brauchen wie wir Anerkennung und Erklärung. Sie haben Ängste und Gefühle, sie verstehen oder verstehen nicht, warum der Tod jetzt bevorsteht. Konflikte treten nicht selten auf, weil der Sterbende oder die Angehörigen nicht loslassen können. Häufig reagieren sie mit Eifersucht, Wut, Inkompetenz, Hilflosigkeit und Trennungsangst. In diesen Situationen dürfen wir weder Patient noch Angehörige ohne Unterstützung lassen (Wilson 1992).

Wir haben wiederholt gesagt, dass die »Aufklärungsgespräche« über Diagnose, Therapie und Prognose nicht ohne den Patienten stattfinden dürfen. Diese »goldene Regel« in der Kommunikation mit Schwerkranken darf aber keineswegs zu dem Irrglauben führen, dass wir nicht mit den Angehörigen alleine reden dürfen. Wir können sie ansprechen und begrüßen, fragen, wie es ihnen geht, und uns zu ihren Fragen und Kommentaren über ihre eigene Situation äußern. Wir können sie über Möglichkeiten der praktischen, finanziellen und pflegerischen Unterstützung aufklären, besonders wenn die Frage einer Entlassung des Patienten nach Hause besprochen wird. Selbstverständlich sollten wir immer vor Augen haben, dass diese Gespräche nicht ohne Zustimmung des Patienten stattfinden sollten. Aber der Patient kann selbst ein Signal geben, dass wir das eine oder andere praktische Problem direkt mit den Angehörigen besprechen können. Im Finalstadium der Erkrankung kann der Patient so mitgenommen sein, dass er oder sie nur wenig Kraft zu solchen Gesprächen hat.

Wenn Angehörige sich aktiv an der Pflege und Betreuung beteiligen wollen, brauchen sie mehr Unterstützung als zuvor. Vor allem müssen sie wissen, an wen sie sich rund um die Uhr wenden können, wenn nicht vorhersehbare Fragen oder Probleme entstehen.

5.2 Sollen wir immer einen »Strohhalm« anbieten?

Anhand einer Untersuchung wollen wir diskutieren, wie Ethik und Kommunikation mit der psychosozialen Gesamtsituation verknüpft sind.

Slevin et al. (1990) führten eine Befragung über die Akzeptanz chemotherapeutischer Behandlung durch. Die Antworten folgender fünf Gruppen wurden miteinander verglichen:

- Krebspatienten (Patienten mit einer neu diagnostizierten Tumorerkrankung),
- onkologische Krankenschwestern,
- Onkologen (inkl. niedergelassene Ärzte),
- Hausärzte,
- gesunde Vergleichspersonen.

Den Teilnehmern wurden folgende Fragen gestellt:

Sie haben die Wahl zwischen

A: stark belastender Chemotherapie mit einer großen Anzahl von Behandlungen, Infusionen und Venenpunktionen, mit mehreren Krankenhausaufenthalten, Übelkeit, Erbrechen, Haarausfall, Müdigkeit und Minderung der Libido;
B: einer wenig belastenden Chemotherapie, bei der nur geringe Übelkeit und Müdigkeit zu erwarten sind.

- Wie groß müssen die Heilungsaussichten (0–100%) sein, damit Sie A oder B akzeptieren können?
- Wie stark muss eine mögliche Lebensverlängerung sein (3 Monate bis 5 Jahre), damit Sie A oder B akzeptieren können?
- Wie groß muss die Reduktion (0–100%) von unangenehmen Symptomen (Schmerz, Atemnot etc.) sein, damit Sie A oder B akzeptieren können?

Die Antworten sind in Tab. 5.1 zusammengefasst.

Die Untersuchung lässt die Schlussfolgerung zu, dass Tumorpatienten fast nach jedem »Strohhalm« greifen würden. Im Durchschnitt sagen die Tumorpatienten: auch wenn nur 1% Wahrscheinlichkeit einer Heilung besteht, wären sie bereit, sowohl eine sehr belastende als auch eine weniger belastende Behandlung durchführen zu lassen. Die Onkologen, die gemeinsam mit den Patienten diese Entscheidung treffen müssen, liegen in ihrer Antwort den Patienten am nächsten. Ihre Antwort »mit 10% Heilungsaussichten« entspricht der Minimalforderung der Statistiker bei klinischen Studien, damit die Wirksamkeit einer Therapie überhaupt angenommen werden kann.

Die Krankenschwestern, die am meisten mit den Nebenwirkungen und dem Verlust an Lebensqualität der Patienten nach der Chemotherapie konfrontiert werden, lehnen eine Therapie um »jeden Preis« zu einem hohen Prozentsatz ab. Während die Hausärzte bei der Erwartungshaltung zwischen

Tab. 5.1. Chemotherapie: Akzeptanz und Erfolgsaussichten

	Krebs-patienten	Onko-logen	Haus-ärzte	Onkologische Kranken-schwestern	Gesunde Vergleichs-personen
A: Stark belastende Chemotherapie:					
Heilungs-aussichten [%]	1	10	25	50	50
Lebensverlänge-rung (Monate)	12	12	24	24	24–60
Symptom-kontrolle [%]	10	50	75	50	75
B: Wenig belastende Chemotherapie:					
Heilungs-aussichten	1	10	10	10	25
Lebensverlänge-rung [Monate]	3	6	12	12	18
Symptom-kontrolle [%]	1	25	25	25	50

den Onkologen und den Krankenschwestern liegen, ist diese bei gesunden Versuchspersonen am höchsten.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, wie schwer es ist, eine »gute« oder »richtige« Entscheidung zu treffen!

Ein Patient hat nur selten ausreichend gute Kenntnisse in Bezug auf Forschung und Statistik, um selbst beurteilen zu können, wie die Erfolgsaussichten einer Therapie einzuschätzen sind. Er ist weitgehend auf die Informationen und Empfehlungen seiner betreuenden Ärzte angewiesen.

Der Patient wird von der Situation geprägt, in der er sich befindet, und kämpft um sein Leben. So lange er glaubt, geheilt werden zu können, ist er bereit, viele Nebenwirkungen und Belastungen in Kauf zu nehmen.

Wir alle wollen bei einer Erkrankung die Autonomie des Patienten erhalten. Das ist aber nicht möglich, wenn der Patient nicht die Voraussetzungen für die zu treffenden Entscheidungen kennt.

Wenn die Wirksamkeit einer Therapie nicht nachgewiesen ist, sollen wir dennoch eine Therapie anbieten wenn

- der Patient es will?
- die Nebenwirkungen sehr groß sind? (Was ist zumutbar?)
- die Kosten sehr hoch sind?
- andere wichtige Patientengruppen aufgrund der hohen Therapieausgaben nicht behandelt werden können?

Wie gehen wir interkollegial mit diesen Fragen um? Kann es passieren, dass ein anderer Kollege den Patienten so behandelt, dass er unrealistische Hoffnungen weckt (oder fördert)?

Die genannte Studie zeigt einerseits, dass der Patient bereit ist, viele Nebenwirkungen und Belastungen in Kauf zu nehmen, auch wenn der Therapieerfolg sehr gering ist. Andererseits ergeben sich folgende Fragen:

- Würde der Patient eine andere Entscheidung treffen, wenn der Arzt eindeutig von der Therapie abgeraten hätte?
- Wie ist der Patient aufgeklärt worden?
- Weiß er, dass keine Heilungsaussichten mehr bestehen?
- Welches Signal geben wir dem Patienten?
- Ist es unsere Hauptaufgabe, die Krankheit gemeinsam und mit allen Möglichkeiten zu bekämpfen?
- Ist das gemeinsame Ziel die Planung von guten Wochen, Monaten und evtl. Jahren?
- Wird die Familie besser mit dem bevorstehenden Leben zurechtkommen, wenn wir einen »Strohhalm« anbieten?
- Verhindert eine jetzige »Lebenslüge«, dass Patient und Angehörige sich gemeinsam auf den bevorstehenden Abschied vorbereiten?

Wir müssen uns mit Offenheit und Sensibilität gemeinsam mit Patient und Angehörigen diesen Fragen widmen. Ihre Beantwortung entscheidet darüber, wie diese neue Lebenssituation bewältigt wird und eine Situation gekennzeichnet durch Last, Angst, Frustration und Depression vermieden wird. Eine heute ausgesprochene »Lebenslüge« kann nur scheinbar oder vorübergehend

hilfreich sein. Morgen allerdings fordert sie von den Betroffenen einen unbezahlbaren Preis (Fallowfield 1997).

Fallowfields Studien zeigen, wie eng das psychosoziale Wohlergehen und die Lebensqualität eines Patienten zusammenhängen mit medizinischen, ethischen und kommunikativen Fragen. Respekt vor der Autonomie und Integrität des Patienten soll unsere Leitschnur im alltäglichen Umgang sein. Dieses ist nicht möglich, wenn der Patient Entscheidungen treffen soll, für die ihm die fachlichen Voraussetzungen fehlen.

Um diesen Prozess zu fördern, bedarf es einer medizinischen und ethischen Reife des Arztes. Diese Lebensphase des Patienten ist geprägt von Unsicherheit, Angst, Wut und Verzweiflung; in ihr müssen Fragen gestellt und beantwortet werden. Der Arzt muss erklären, welche Therapie er aus fachlicher und wissenschaftlicher Überzeugung anbieten kann und welche Nebenwirkungen dabei zu erwarten sind.

Wenn keine Dokumentation über die Wirksamkeit dieser Therapie vorliegt, darf der Arzt diese Behandlung nicht anbieten, besonders wenn die Kosten und Nebenwirkungen für den Patienten (und die Gesellschaft) eine große Belastung sein könnten.

Diese Diskussion über den Nutzen einer Therapie erhält in der medizinischen Fachliteratur einen zunehmenden Stellenwert. »Futility« ist der englische Ausdruck für »Erfolglosigkeit«. Zahlreiche Publikationen zu »medical futility« zeigen uns, wie ernst dieses Thema geworden ist (Younger 1988; Callahan 1991; Jecker u. Pearlman 1992). Folgende Kriterien für unnütze medizinische Behandlung werden angegeben:

- Eine Heilung ist ausgeschlossen.
- Die Behandlung bringt für den Patienten keine Vorteile.
- Es ist unwahrscheinlich, dass der angestrebte Nutzen erreicht werden kann.
- Die Behandlung könnte begründbar sein, aber es fehlt an Validität.

Aus diesen Überlegungen sind medizinische Grundregeln entstanden, die es dem Arzt ermöglichen, die Autonomie und Integrität des Patienten mit ethischer und fachlicher Kompetenz zu fördern (Smith 1995).

Das Recht des Patienten ist es, die Vorschläge des Arztes zu akzeptieren oder abzulehnen. Weiterhin hat er das Recht, dass sich der Arzt die Zeit nimmt, Fragen zuzulassen und zu beantworten. Er hat das Recht zu erfahren, welche Alternativen vorliegen und welche Belastungen und Nebenwirkungen bei den verschiedenen Alternativen zu erwarten sind. Er hat das Recht

zu erfahren, ob es nachgewiesen ist, dass er durch die empfohlene Therapie zusätzliche Lebenszeit gewinnen kann. Dabei ist er auf das Fachwissen, die Wahrhaftigkeit und das Beurteilungsvermögen seines Arztes angewiesen.

Rechte der Patienten und Pflichten der Ärzte vor schwierigen Therapieentscheidungen bei schwerkranken Patienten

- Der Patient hat das Recht darauf, dass der Arzt sich für die Diskussion dieser Fragen die erforderliche Zeit nimmt.
- Der Patient hat das Recht zu entscheiden, welche Therapie er in seiner Situation akzeptieren will.
- Der Arzt hat die Pflicht, nach medizinischen und ethischen Kriterien zu entscheiden, welche Therapie in der gegebenen Situation angeboten werden muss.
- Der Patient hat nicht das Recht auf eine Therapie ohne dokumentierte Erfolgsaussichten, besonders wenn dabei Leid und Kosten vergrößert werden.
- Der Arzt hat die Pflicht, den Patienten vor sinnlosen Entscheidungen und Therapien in Schutz zu nehmen; er muss den Patienten vor unnötigen, unwirksamen und belastenden Therapieexperimenten schützen.
- Wenn kein dokumentierter Erfolgsnachweis für eine Therapie vorliegt, darf der Arzt diese Behandlung nur innerhalb einer streng kontrollierten wissenschaftlichen Studie vorschlagen. Für diese Studien bestehen besondere Aufklärungspflichten.

Eine Behandlung ohne kontrollierte Studien findet immer noch zu häufig statt (American 1994; MacDonald 1995). Hierbei handelt es sich um Therapien, die auf Vermutungen ohne wissenschaftliche Grundlagen basieren. Es erscheint sehr fragwürdig, wenn die Patienten solchen »therapeutischen Experimenten« mit einer Reihe unnötiger Nebenwirkungen und Kosten ausgesetzt werden.

Solange sie an der Studie teilnehmen und ein Erfolg zu erwarten ist, werden Patienten oft mit viel Interesse und Kompetenz betreut. Obwohl diese Fragen in der Helsinki-Konvention über medizinische Forschung streng geregelt sind (Helsinki 1964), ist leider nicht selten eine Reduktion des Zeit-

aufwands und der Zuwendung des Arztes gegenüber den Patienten zu beobachten, wenn eine Studie beendet oder abgebrochen wird.

Die Beantwortung der Fragen »Wie viel und welche Therapie?« und »Wie viel und welche Information?« setzt nicht nur Fachkenntnisse in der Medizin voraus. Kompetenz in Ethik und Kommunikation ist gleichermaßen gefragt. Zusätzlich benötigen wir Informationen über den Patienten, sein Leben und sein Umfeld. Erst wenn wir den Patienten und sein soziales Umfeld gut kennen, wenn wir wissen, welche Familie und welche Belastungen vorhanden sind, werden wir besser beurteilen können, welche Fragen und Entscheidungen für den Kranken von Bedeutung sein werden.

Eine Mutter mit Kindern zu Hause kann eine belastende Therapie im Krankenhaus akzeptieren, obwohl sie dadurch von der Familie getrennt ist. Sie wird hoffen, durch die Behandlung für sich und die Kinder Zeit zu gewinnen. Aber wenn diese Hoffnung auf einem Trugschluss beruht und sie durch die Information des Arztes hinters Licht geführt wurde, wird der Patientin und ihrer Familie großer Schaden zugefügt.

Die Entscheidung, einen Patienten nicht über die Prognose aufzuklären, widerspricht den Grundlagen moderner medizinischer Ethik (Fallowfield 1997), auch wenn sie für den Arzt »das geringere Übel und die bequemere Lösung« darstellt.

Die Studie von Slevin et al. (1990) zeigt uns, wie schwerkranke Patienten am Leben hängen. In dieser Situation müssen Ärzte diese Patienten unterstützen, absehbare Probleme zu sehen und zu verstehen. Erst dann können die Patienten die für sie wichtigen Entscheidungen gemeinsam mit dem Arzt treffen (Husebø 1997).

5.3 Zu Hause oder im Krankenhaus?

Eine weitere Frage hat für das Wohlergehen des Patienten eine zentrale Bedeutung:

- Wo hat es der Patient am besten – zu Hause oder im Krankenhaus?

Die Beantwortung dieser Frage hat nicht nur praktische Konsequenzen. Dieses Thema ist der Schlüssel zu einer Reihe ethischer, kommunikativer und medizinischer Perspektiven und hat einschneidende Konsequenzen für das Wohlergehen unserer Patienten.

»Wo fühlen Sie sich wohl? Wenn Sie ernsthaft erkranken und nicht mehr geheilt werden können, wo möchten Sie ihre noch verbleibende Zeit verbringen – zu Hause oder im Krankenhaus?«

Untersuchungen in der Bevölkerung zeigen, dass sich die große Mehrheit der Menschen für zu Hause entscheiden würde. Selbstverständlich müssen wir uns mit den menschlichen, sozialen und fachlichen Voraussetzungen für eine umfassende Betreuung Schwerkranker zu Hause beschäftigen.

In Skandinavien haben Modellprojekte gezeigt, dass eine Betreuung zu Hause ohne Verlust an Qualität in Pflege und Behandlung möglich ist. Die schwedische Ärztin Barbro Beck-Friis zeigte in ihrer Habilitation (Beck-Friis 1993), dass schwerkranke und sterbende Patienten, die aus medizinischen Gründen an eine Krankenhausbehandlung gebunden sind, sowohl besser als auch billiger zu Hause betreut werden können.

In Deutschland ist es nicht einfach, schwerkranke Patienten nach Hause zu schicken. Durch die starke Trennung zwischen ambulanter und stationärer ärztlicher Versorgung sind die Hürden hoch und der Widerstand zur Kooperation häufig sehr groß. Es gibt aber auch bei uns Modellprojekte, in denen eine gute Pflege terminal Kranker zu Hause organisiert wird. Voraussetzung ist eine gute Kooperation zwischen Patient, Angehörigen, Hausarzt, Krankenhausarzt, Sozialstation und Hausbetreuungsteam.

Beck-Friis nennt folgende Voraussetzungen für eine vernetzte Betreuung sterbender Patienten zu Hause:

Das Motala-Projekt: Voraussetzungen für eine umfassende Betreuung sterbender Patienten zu Hause

- Der Patient möchte aus eigener, freier Entscheidung zu Hause sein.
- Ein oder mehrere Angehörige bejahen die Entscheidung und möchten an der Pflege teilnehmen.
- Eine professionelle Pflege und medizinische Betreuung können bei Bedarf rund um die Uhr und an sieben Tagen in der Woche angeboten werden.
- Eine hohe pflegerische Kompetenz unter ärztlicher Mitwirkung ist gesichert.

- Eine stationäre Wiederaufnahme des Patienten ist, falls erforderlich, gewährleistet.
- Notwendige technische Hilfsmittel stehen zur Verfügung.
- Angehörige können für die Betreuung des Patienten krankgeschrieben werden oder finanzielle Unterstützung erhalten.
- Eine zusätzliche Haushaltshilfe kann angefordert werden.
- Es besteht eine gute Zusammenarbeit zwischen hochqualifizierten Fachkräften wie Onkologe, Chirurg, Anästhesist oder Seelsorger.
- Das betreuende Fachteam (Arzt und Krankenschwestern) besitzt Ausbildung und Praxis im Bereich der Palliativmedizin.

Mit diesem Modell wurde erreicht, dass 89% der betreuten Patienten zu Hause sterben konnten. Dieser Prozentsatz liegt weit höher als in Deutschland, selbst dann, wenn man dies mit den Ergebnissen spezialisierter Hausbetreuungsdienste vergleicht. Bei uns ist von besonderem Nachteil, dass die notwendige Verbindung im Hausbetreuungsdienst zwischen kompetenten Ärzten und Krankenschwestern mangelhaft ist. In dem schwedischen Modell gaben über 90% der Patienten und Angehörigen an, dass die Schmerztherapie, Symptomkontrolle, Pflege, Sicherheit, Umsorgung und Betreuung ausgezeichnet waren.

Ein Problem in Deutschland besteht in der Vorstellung vieler Krankenkassen, Laien und Politiker, dass in der Terminalpflege Geld durch Senkung der Qualität gespart werden kann. Unter dem Motto: »Wer nicht mehr geheilt werden kann, ist für die Krankenhäuser, die Gesellschaft und die Krankenkassen uninteressant« werden schwerkranke, »hoffnungslose« Patienten entlassen. Die Betreuung und Behandlung sterbender Patienten ist keineswegs ein Aufgabengebiet, in dem wir mit dieser Argumentation Geld sparen können.

Dabei ist die qualitativ gute Versorgung Grundvoraussetzung für eine Pflege und Behandlung zu Hause. Was uns die Modelle aus Skandinavien zeigen, ist, dass die Qualität zu Hause sogar gesteigert werden kann. Geld kann v. a. dadurch gespart werden, dass Angehörige in die Pflege eingebunden werden. In Norwegen, Schweden und Dänemark können Angehörige oder Nachbarn bis zu einem Monat mit vollen Gehaltsansprüchen krankgeschrieben werden. Interessanterweise zeigen diese Projekte, dass gerade die Mitbetreuung durch die Angehörigen zu der guten Lebensqualität zu Hause beitragen.

Diese Erfahrungen machen die Frage überflüssig, ob sich unsere Gesellschaft eine Finanzierung häuslicher Pflege sterbender Patienten leisten kann. Die aktuelle Frage ist eher umgekehrt: Wie lange können wir uns noch eine qualitativ minderwertigere und kostspieligere Betreuung im Krankenhaus leisten (Johansson 1991)?

Das wichtige Stichwort »Lebensqualität« ist angesprochen. Wo gibt es Qualität im Leben? Sind für die meisten von uns nicht gerade das Zuhause, das eigene Bett, die eigenen, privaten vier Wände, die Bücher und Blumen, die Bilder und Gewohnheiten der Inbegriff von Lebensqualität? Wird es uns im Krankenhaus je gelingen, den gleichen persönlichen Standard wie zu Hause bei den Patienten zu erreichen? Sollten wir die Herausforderung nicht dazu nutzen, zu überlegen, ob wir nicht vor einem neuen Konzept des Gesundheitswesens stehen, wo die Hauptbetreuung der chronisch und schwer Erkrankten zu Hause erfolgt und in dem die großen Institutionen nur zur Unterstützung der häuslichen Betreuung dienen sollten?

5.4 Trauer

Trauer ist die normale Reaktion, wenn wir einen Verlust erleben. Sie ist ein wichtiger Teil des menschlichen Lebens. Es kann der Verlust der Milchzähne sein, der meistens ohne großes Trauma bewältigt werden kann. Wenn wir aber im Alter Zähne verlieren, führt dieser Verlust nicht selten zu Trauerreaktionen. Wir können eine Freiheit verlieren oder eine Körperfunktion und erleben dabei Trauer. Häufig wird in der Kindheit der Verlust einer vertrauten Umgebung oder eines Freundes durch Umzug oder Schulwechsel erlebt. Heute werden viele mit Verlust und Trauer konfrontiert, weil die Eltern sich scheiden lassen. Eine besondere Belastung in der heutigen Zeit ist der Verlust der Arbeitsstelle. Es muss also keineswegs jemand sterben, damit Verlust und Trauer in unserem Leben existent werden und zu einer längeren Lebenskrise führen.

Bei einer ernsten (inkurablen) Erkrankung treten Verlust und Trauer lange vor dem Tod auf. Ausgelöst werden sie durch Verlust einer Körperfunktion oder Auftreten von Abhängigkeit von anderen. Scheinbar kleine Verluste können schwere Trauerreaktionen hervorrufen, die häufig nicht erkannt oder fehlinterpretiert werden. Es gibt aber Hinweise, dass sie als stufenweise Vorbereitung auf den großen Verlust, den Verlust des Lebens

dienen. Die Reaktion auf Verluste ist individuell. Sie wird davon abhängen, welche Bedeutung der einzelne diesen Verlusten und dem Leben beimisst. Sie hängt auch davon ab, ob die Verluste vom sozialen Umfeld erkannt und zugelassen werden. Verluste, die allein getragen werden müssen, sind grundsätzlich schwerer zu ertragen.

Siegmund Freud (Ausgabe 1982) schrieb 1917 in seinen berühmten Aufsatz *Trauer und Melancholie:*

> Trauer ist regelmäßig die Reaktion auf den Verlust einer geliebten Person oder einer an ihre Stelle gerückten Abstraktion wie Vaterland, Freiheit, ein Ideal usw. […] Es ist auch bemerkenswert, dass es uns niemals einfällt, die Trauer als einen krankhaften Zustand zu betrachten und dem Arzt zur Behandlung zu übergeben, obwohl sie schwere Abweichungen vom normalen Leben mit sich bringt. Wir vertrauen darauf, dass sie nach einem gewissen Zeitraum überwunden sein wird und halten eine Störung derselben für unzweckmäßig, selbst für schädlich.

Freud beschrieb vier zentrale Charakteristika, die mit Trauer verbunden sind:

- ein tief greifendes Erlebnis von Schmerz,
- eine Isolation des Betroffenen von der Außenwelt,
- Verlust der Fähigkeit zu lieben,
- Aktivitätsverlust durch Zurückziehen von allen Aktivitäten, die nicht mit Gedanken an die vermisste Person in Verbindung stehen.

5.4.1 Stadien der Trauer

Es haben sich viele Autoren mit dem Problem der Trauer beschäftigt. Zwei hervorragende Fachkräfte auf diesem Gebiet – Bowlby und Parkes – haben ein Vierstufenschema des Trauerprozesses beschrieben (Parkes 1972; Bowlby 1980):

1. Schockphase,
2. Reaktionsphase,
3. Bearbeitungsphase,
4. Neuorientierungsphase.

1. Schockphase – Phase der Betroffenheit und des Schocks

Dies ist ein Stadium der unmittelbaren Betroffenheit, in dem verschiedene Grade der Verdrängung beobachtet werden können. Reaktionen wie »Es ist nicht wahr« und »Sie müssen sich geirrt haben« stehen im Vordergrund. Der Betroffene kann sich häufig nur in geringem Maße an die Information in dieser Phase erinnern. Diese Phase dient zum Schutz des Individuums und dauert normalerweise Stunden, Tage oder Wochen.

2. Reaktionsphase – Phase des Suchens

Der Betroffene entwickelt eine Strategie, um das Verlorene wiederzuentdecken. Emotionelle Reaktionen wie z. B. Tränenfluss kennzeichnen den Übergang in diese Phase und werden mehr oder weniger offen gezeigt. Wut über den fehlenden Erfolg dieser Suche richtet sich gegen die Person selbst oder andere. Angst und Depression sind häufig. Dieses Stadium kann sich über Wochen, Monate und seltener Jahre hinziehen.

3. Bearbeitungsphase

In dieser Phase ist der Betroffene zunehmend in der Lage, bewusst oder unbewusst sein Trauma zu bearbeiten. In diesem Stadium beobachten wir häufig Depression und die fehlende Fähigkeit, in der Gegenwart und Zukunft einen Sinn zu sehen. Hierbei wird stufenweise das Suchen nach dem Vermissten losgelassen, indem die Erinnerungen zunehmend ertragen werden können. Die Bearbeitungsphase kann lange dauern, nicht selten mehrere Jahre.

4. Neuorientierungsphase – Stadium der Reorganisation

In dieser Phase bricht der Trauernde die Bande zu den Verlusten und beginnt stufenweise neue Bindungen aufzubauen. Interesse und Appetit kehren wieder. Die Neuorientierung beinhaltet oft ein verändertes Selbstbild – und kann erlebt werden als eine persönliche Reife auf der Basis der bearbeiteten Erfahrungen.

Es wäre ein Fehler anzunehmen, die Trauerreaktionen verliefen stur nach diesen Phasenbeschreibungen. Jeder hat individuelle Reaktionen auf Trauer. Die Reihenfolge kann unterschiedlich sein. Ein Patient kann sich lange in der Reaktionsphase aufhalten, um dann wieder zu dem Verhalten

der Schockphase zurückzukehren. Viele wechseln jahrelang zwischen den Stadien hin und zurück (Lamerton 1991).

Schon die »normale« Trauerarbeit kann sich in physischen und psychischen Störungen ausdrücken, die von der Umgebung als Krankheit empfunden werden (Stroebe u. Stroebe 1987). Das Wissen über Trauerreaktionen zeigt, dass es zu schweren Folgeerscheinungen kommen kann, wenn der Arzt akute Trauerreaktionen übersieht.

Affektive Symptome

Hier stehen Angst und Depression im Vordergrund, nicht selten in Kombination mit Schuldgefühlen und Wut. Gefühle der Einsamkeit und Isolation sind zentrale Faktoren selbst bei einem intakten sozialen Netzwerk.

Verhaltensstörungen

Die Trauer führt häufig zu Änderungen des Verhaltens im Alltag im Umgang mit anderen Menschen. Apathie, emotionale Labilität und sporadische Hyperaktivität sind typische Verhaltensweisen. Weinattacken oder eine spontane Aufräumaktion gehören zu den gewöhnlichen Reaktionen.

Änderungen des Selbstbilds

Das Selbstbild kann geprägt werden von Unsicherheit, Hilflosigkeit oder Hoffnungslosigkeit. Die Erinnerungen werden idealisiert. Unsicherheit oder Sehnsucht nach dem Vermissten steht im Vordergrund. Auch die Symptome, unter denen der Verstorbene in seiner letzten Lebensphase gelitten hat, können sich übertragen.

Kognitive Schäden

Kognitive Schäden zeigen sich als Konzentrationsschwächen und Bearbeitungsstörungen der eigenen Gedanken.

Psychophysiologische Symptome

Psychophysiologische Symptome entwickeln sich häufig und können von der Umgebung als somatische Krankheit wahrgenommen werden. Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Energieverlust und Schlafstörungen gehören dazu. Änderungen der Lebensführung bewirken Folgeprobleme. Der Stress des Traumas kann zu erhöhter Anfälligkeit gegenüber Krankheiten wie Krebs führen (Spurrel u. Creed 1993).

5.4.2 Der Sinn des Trauerns

Worden (1982) beschreibt vier Hauptaufgaben der Trauer:

1. Die Realität eines Verlustes akzeptieren.
2. Den Schmerz des Verlustes zulassen.
3. Anpassung an eine Welt, in die der Vermisste nicht zurückkommt.
4. Gefühle und Energien gegenüber dem Vermissten zurückziehen und in neue Beziehungen investieren.

Dem richtigen »Timing« der Unterstützung kann eine größere Bedeutung für das Ergebnis zukommen. Verständnis in der akuten Phase der Trauer ist wichtig und hilfreich. Dies konnte in zwei Studien gezeigt werden, aber auch, dass diese frühe Unterstützung kaum einen Einfluss auf die Langzeitsituation der Trauernden hat (Parkes 1980; Vachon et al. 1980).

Trauer und Trauerarbeit nehmen im Leben schwerkranker Patienten einen großen Raum ein. Trauer beeinträchtigt die Lebensqualität, führt zu Problemen in der Kommunikation und zu Symptomen, die evtl. falsch interpretiert oder behandelt werden. Trauer setzt auch Kräfte frei und hat eine Bedeutung, die bei Patienten und deren Angehörigen kaum überschätzt werden kann.

Wer gute Palliativmedizin vertreten möchte, muss fundierte Kenntnisse über Trauer und Trauerarbeit besitzen, damit zusätzlicher Schaden bei Patienten, Angehörigen, dem betreuenden Arzt und ihm selbst verhindert werden kann. Trauer dient dem Schutz des Individuums, sie unterdrücken oder »unsichtbar« machen zu wollen, wäre eine Verhaltensweise, die unmöglich und unsinnig ist.

5.4.3 Vorbereitende Trauer – Trauer vor dem Tod

Der sterbende Patient trauert in dem Maße, wie seine Krankheit fortschreitet. Eine große Anzahl möglicher Verluste steht bevor:

- Verlust der Kontrolle,
- Verlust der Unabhängigkeit,
- Verlust der Arbeitsfähigkeit,
- Verlust von Geborgenheit,
- Verlust von Körperfunktionen,
- Verlust der sozialen Funktion,

- Verlust von Integrität,
- Verlust der vertrauten Umgebung,
- Verlust von Perspektiven,
- Verlust der Freude,
- Verlust der Familie und Freunde,
- Verlust von Identität,
- Verlust von Sinn,
- Verlust der Hoffnung.

Es geht nicht nur um die Verluste der Gegenwart und Zukunft. Wir wissen, dass frühere Verluste und deren Folgen bei akuten Lebenskrisen in Erinnerung gerufen werden und oft einen Schlüssel zu dem jetzt bevorstehenden Trauerprozess darstellen. Ein solches Schlüsselerlebnis kann häufig zu einer Blockierung führen, wodurch ein Patient oder ein Angehöriger außer Stande gesetzt wird, die Situation, in der er sich befindet, zu erfassen. Die Folge ist häufig Verdrängung, der Betroffene bleibt in der ersten Phase der Trauer und ist nicht in der Lage, eine stufenweise Verarbeitung seiner Situation zuzulassen.

Die Trauer zulassen – ist es notwendig? Sollten wir nicht dem Kranken helfen, alles Traurige zu vergessen und zu verdrängen? Ist es nicht die Aufgabe des Arztes und der Schwestern, optimistisch zu bleiben, das Traurige zu übersehen, damit der Kranke zu seiner Fröhlichkeit zurückfindet?

So verhalten sich tatsächlich viele Kollegen. Dabei vergessen wir, dass Trauer wie Freude Eigenschaften sind, ohne die ein Menschenleben undenkbar ist. Indem wir einem Todkranken die Möglichkeit nehmen, sich offen in seiner Trauer zu verhalten, verhindern wir auch, dass er Freude zeigen kann. Ohne die Möglichkeit zur Trauer erlischt die Fähigkeit zur Freude. Oder, wie Mark Twain es ausdrückt: »Trauer, nicht Freude, ist die Grundlage von Humor.«

Die meisten Patienten mit chronisch-progressiver Krankheit erkennen früher oder später selbst, dass sie sterben werden, auch wenn dies der Arzt nicht direkt angesprochen hat (Kalish 1981).

Die vorbereitende Trauer, bedingt durch den stufenweisen Verlust von körperlichen und psychosozialen Funktionen und Beziehungen, ist für den Kranken und seine Angehörigen eine wichtige Vorbereitung auf den bevorstehenden Verlust des Lebens. Wenn der Kranke selbst stufenweise loslassen kann und die Angehörigen in diesen Prozess integriert werden, kann der Abschied eine psychische und seelische Bereicherung für alle Beteiligten sein.

Diese vorbereitende Trauer ist auch für den Lebenspartner und die Kinder von besonderer Bedeutung (Rando 1984). Rando findet in ihrer Studie über den Verlust eines Kindes, dass die vorbereitende Trauer sowohl bei zu kurzer als auch zu langer Dauer zu einer größeren Belastung werden kann. Sie konnte zeigen, dass bei einer Vorbereitungsphase zwischen 6 und 18 Monaten die Folgeprobleme am geringsten waren (Rando 1983).

Glick et al. (1974) zeigten in einer Studie, dass nur 3% der Witwen, die (z. T. tiefe) vorbereitende Trauerarbeit gemeinsam mit ihren verstorbenen Ehepartnern erlebten, nach dem Todesfall längere, schwere Trauerreaktionen zeigten, während dies bei Witwen, die nicht diese Gelegenheit einer vorbereitenden Trauerarbeit hatten, bei 23% der Fall war.

5.4.4 Pathologische Trauer – starke Trauer

Verlust bewirkt Trauer. Wenn der Verlust »unerwartet« entsteht, ist die Belastung größer und von längerer Dauer als wenn Vorbereitung möglich war. Der Verlust hat oft eine andere Bedeutung, wenn eine Urgroßmutter in der Mitte ihrer 80er Jahre stirbt, als wenn ein Vater, der 40 Jahre jünger ist, stirbt. Wir dürfen nicht daraus ableiten, es wäre einfach für ältere Menschen, Abschied vom Leben zu nehmen, aber die Trauerreaktionen sind meistens milder. Fulton (1970) spricht bei diesen zwei Typen der Trauer von »schwacher Trauer« (»low grief«) und »starker Trauer« (»high grief«). Dabei muss berücksichtigt werden, dass Trauerreaktionen natürlich individuell gesehen werden müssen.

Gibt es »pathologische« oder krankhafte Trauer, Trauerreaktionen, wo wir spezielle Hilfe und Unterstützung anbieten sollten?
Welu (1975) gibt sieben Merkmale der pathologischen Trauer an:

1. selbstzerstörerisches Verhalten (Suizidversuche, Alkohol, Medikamente),
2. Selbsttötungsgedanken,
3. psychische Probleme,
4. soziale Isolation,
5. schwere Depression mit klinischen Symptomen,
6. stationäre Aufnahme in der Psychiatrie,
7. die Einnahme von Psychotherapeutika.

Devaul u. Zisook (1976) unterstreichen, dass Trauer v. a. dann ein psychisches Dauerproblem werden kann, wenn die Trauerreaktion vorzeitig

abgebrochen wurde oder nicht stattgefunden hat. Die Folge davon sind Verhaltensweisen wie

- schmerzvolle Reaktion, wenn der Verstorbene erwähnt wird,
- die Angabe des Betroffenen über Probleme der Trauerverarbeitung,
- wiederholte, schwere depressive oder andere medizinische Reaktionen am Jahrestag des Verlustes.

Grundsätzlich ist es schwierig zu entscheiden, ab wann man von einer pathologischen Trauerreaktion sprechen sollte. Anthropologische Studien zeigen, dass einige der erwähnten Reaktionen in verschiedenen Kulturen als normal angesehen werden.

Drei besondere Merkmale treten als Hinweise für eine starke Trauerbelastung hervor:

- Fehlende Reaktion eines Individuums auf einen schweren Verlust.
- Extreme Trauerreaktion, die weit über die in dieser Kultur zu erwartende hinausgeht.
- Fehlende Entwicklung im Trauerprozess.

Diese starke Trauerbelastung sollte als eine Variante der »normalen« Reaktionsmuster bei Trauer angesehen werden. Der Begriff »pathologische« Trauer sollte durch »starke Trauer« ersetzt werden (Stephenson 1994).

Worden (1982) beschreibt folgende Faktoren, die zu starken Trauerreaktionen beitragen:

- Suizid.
- Tod eines Kindes.
- Der Verstorbene hinterlässt kleine Kinder.
- Plötzlicher, unerwarteter Todesfall.
- Der Hinterbliebene hat zuvor schwere Verluste erlebt.
- Schwere psychosoziale Probleme im Umfeld des Verstorbenen vor dem Todesfall.

In diesen Situationen, sagt Worden weiter, müssen wir mit verspäteten, verstärkten, verschleppten und unterdrückten Trauerreaktionen rechnen. In diesen Fällen muss es unsere Aufgabe sein, den Trauernden sowohl in der vorbereitenden Phase (wenn es Zeit zur Vorbereitung gibt) wie in der Zeit nach dem Verlust eine besondere Hilfe und Unterstützung anzubieten.

5.4.5 Trauerarbeit – Aufgaben für Ärzte und das Krankenpflegepersonal

Nach diesen Ausführungen stellt sich die Frage: Was ist die Aufgabe von Ärzten und Krankenschwestern bei der Begegnung mit Trauernden?

Die zentrale Aufgabe ist es, Trauer zu kennen, damit wir die Folgesymptome und Reaktionen verstehen, wenn sie auftreten. Andererseits wird uns eine gute Betreuung von sterbenden Patienten und ihrer Angehörigen nicht gelingen, wenn wir diese Trauer nicht erkennen und verstehen. Sich auf ein Gespräch einzulassen, Trauerreaktionen zuzulassen und darauf hinzuweisen, dass Trauer etwas Universelles ist und dass die Reaktionen, die Schlaflosigkeit, die Schuldgefühle, die Angst oder Depression etwas völlig Normales sind, kann eine große Hilfe sein.

Oder, wie eine Mutter bei dem Nachgespräch nach dem Tod ihrer Tochter zu mir sagte: »Ich schlafe nicht, ich esse nicht, ich wasche mir nicht mehr die Haare, ich bleibe im Bett liegen, wenn mein Mann weg ist; ich dachte, ich bin verrückt, ich muss Pillen nehmen, ich muss mich in der Psychiatrie einsperren lassen. Aber nach dem, was Sie sagen, bin ich ziemlich normal. Danke, dann kann ich ein bisschen weiterleben.«

! Wichtig

Keine Schlaf- oder Beruhigungsmittel verschreiben!

Trauerreaktionen, wie von dieser Frau beschrieben, sind notwendige Voraussetzungen für die Bearbeitung des Verlustes. Wachsamkeit ist geboten, wenn die Angehörigen nach einem Todesfall den Arzt um Verschreibung von Schlaf- oder Beruhigungsmitteln bitten. Wer als Folge eines Verlustes nicht schlafen kann oder Unruhe verspürt, hat gute Gründe dafür. Aus Erfahrungen auf diesem Gebiet wissen wir, dass diese Schlaflosigkeit oder Unruhe am besten dadurch behandelt wird, dass sie zugelassen wird. Die Aufgabe des Arztes ist es, dann ein oder mehrere Gespräche anzubieten, und nicht, diese Medikamente zu verschreiben.

Nicht weniger wichtig ist die Vorbereitung. Offene Gespräche mit den Betroffenen, in denen ihre Fragen und Sorgen bezüglich Diagnose, Prognose, Therapiemöglichkeiten und Entscheidungen zugelassen werden, sind fördernd für eine gemeinsame vorbereitende Trauerarbeit.

In den Situationen, wo starke oder verschleppte Trauer erwartet werden kann, sollte besondere Hilfe angeboten werden. In vielen Krankenhäusern gibt es Erfahrungen mit Nachgesprächen nach einem tragischen Todesfall.

Die Hinterbliebenen kommen ein- oder mehrmals zu Gesprächen mit dem Arzt, der Krankenschwester oder dem Seelsorger. Es hat sich bewährt, dass die Initiative zu dem Gespräch vom Therapeuten ausgeht und diese Termine direkt festgelegt werden. Wenn wir sagen: »Rufen Sie bitte an, wenn Sie uns brauchen«, wird sich derjenige, der die Hilfe besonders braucht, nicht melden. Wer sich in tiefer Trauer befindet, wird häufig keine Kraft haben, um selbst die Initiative zu solchen Kontakten zu ergreifen.

In Großbritannien, aber auch vielerorts in Deutschland, hat man gute Erfahrungen mit »Selbsterfahrungsgruppen« für Trauernde. In diesen Gruppen können Hinterbliebene über kürzere oder längere Zeit Rat und Unterstützung finden von anderen, die vergleichbare Verluste durchgemacht haben.

In Zweifelsfällen oder in Situationen, wo verstärkte Trauerreaktionen beobachtet werden, sollten die betreuenden Ärzte oder das Krankenpflegepersonal Rat und Hilfe bei geschultem Fachpersonal suchen. Dies kann ein Psychologe, Psychotherapeut oder ein Seelsorger sein. In vielen Fällen werden die Ärzte oder das Krankenpflegepersonal mit ein wenig Unterstützung weiterhin in der Lage sein, eine gute Hilfe für die Betroffenen anzubieten. Es gibt aber Situationen, da braucht der Trauernde für kürzere oder längere Zeit Unterstützung durch einen geschulten Psychotherapeuten.

Ärzte und das Krankenpflegepersonal müssen auch erkennen, dass sie selbst oft trauern und Trauerarbeit zu verrichten haben. Besonders, wenn Kinder oder jüngere Patienten sterben oder bei tragischen Todesfällen oder bei Patienten, die viel gelitten haben, wissen wir, wie stark die Trauerreaktionen des Personals sein können. In diesen Fällen muss Zeit, Raum, Verständnis und Kollegialität vorhanden sein, damit der Arzt oder die Krankenschwester ihre Trauer zulassen können. Besonders wichtig ist es, einen geeigneten Gesprächspartner zu haben, bei dem der einzelne und das Behandlungsteam über die berufliche und private Belastung durch die Arbeit sprechen dürfen. Die Voraussetzungen dafür fehlen leider sehr häufig (s. auch ► Kap. 9: »Die Rolle des Arztes«).

5.5 Die Rolle der Kinder

Die Erfahrungen aus vielen Ländern haben gezeigt, wie eine umfassende Betreuung Schwerkranker zu Hause organisiert und erreicht werden kann. Das wahrscheinlich wichtigste Argument, Sterbende zu Hause zu betreuen, sind die Kinder.

Wenn die Eltern der Kinder als Patienten im Krankenhaus betreut werden, führt dies zu erheblichen Belastungen im Alltag der Kinder. Die Rolle der Kinder bei schwerer Erkrankung eines Familienmitgliedes wird nur selten angesprochen. Dabei zeigt eine Reihe von Studien, wie sehr die Kinder leiden, wenn ein Todesfall die Familie erschüttert (Bifulco et al. 1987).

Etwa 20% der Tumorpatienten haben Kinder unter 20 Jahren. Jedes Jahr sterben etwa 7.000 Kinder unter 18 Jahren in Deutschland. Im gleichen Zeitraum erleben etwa 40.000 Kinder im gleichen Alter, dass ihre Mutter oder ihr Vater eine Krebsdiagnose bekommt. Wahrscheinlich verlieren mehr als 80.000 Kinder pro Jahr ihre Mutter oder ihren Vater. Wir hören erstaunlich wenig darüber, wie es den Kindern geht und wie wir uns zu den Kindern verhalten sollen, die mit der Erkrankung oder dem Verlust eines Elternteils zurechtkommen müssen.

Sollten die Kinder nicht vor dem Krankenhaus, vor den Untersuchungen und Behandlungen der Mutter oder des Vaters geschützt werden? Das Krankenhaus, die weißen Kittel, die vielen Geräte, Schläuche, Flaschen und Medikamente, lange, monotone Korridore, fremde Zimmer und Betten können die Kinder erschrecken. Verstärkt wird dieses Erlebnis durch geschäftige, fremde Erwachsene, die scheinbar alles beurteilen können und im Griff haben. Vor 20 Jahren waren die Kinder als Angehörige grundsätzlich, angeblich zu ihrem eigenen Schutz, im Krankenhaus ungern gesehen, und dann nur zu festen, vorgeschriebenen Zeiten. Langsam hat sich diese Haltung geändert. Wir haben inzwischen erkannt, dass die Kinder viel besser mit der Erkrankung ihrer Eltern zurechtkommen, wenn sie frei kommen und gehen können und sich mit dem Krankenhaus und den Menschen und Einrichtungen, die dort zu finden sind, vertraut machen dürfen (Gray 1987).

Damit Kinder ihre Fähigkeiten als Kinder entfalten können, müssen sie Informationen erhalten, die für ihr Alter verständlich sind. Durch den Umgang mit leukämiekranken Kindern wissen wir, wie gut sie mit Offenheit zurechtkommen. Ein 6-jähriges leukämiekrankes Kind sagte, als die Krankenschwester das Mittagessen brachte: »Fisch, spinnst du, ich kann keinen Fisch essen! Meine weißen (Blutkörper) sind doch viel zu niedrig!«

Untersuchungen über Erfahrungen von Kindern mit ernsten Erkrankungen und Lebenskrisen in der Umgebung des Kindes (Earls et al. 1988; Yule u. Williams 1990) haben gezeigt, dass die Erwachsenen unterschätzen, was Kinder sehen, hören, verstehen und fühlen und wie sie reagieren.

Das Ideal für viele Erwachsene ist der plötzliche Tod. »Ich möchte irgendwann einschlafen und von dem Schlaf niemals wieder aufwachen.« »Ich möchte beim Spazierengehen tot umfallen.« Die Liste kann beliebig verlängert werden. Für Kinder dieser Erwachsenen ist ein solcher plötzlicher, unerwarteter Tod eine Katastrophe, womit sie nur schwer im späteren Leben zurechtkommen können. Das Beste für Kinder wäre ein Prozess, wo sie sich gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem Vater auf die bevorstehende Trennung vorbereiten können. Das Schlimmste für Kinder ist, wenn sie von diesem Prozess ausgeschlossen werden.

Kinder kommen besser zurecht mit traurigen und belastenden Nachrichten, wenn sie frühzeitig in den Informationsprozess eingeschlossen werden. Sie kommen besser zurecht mit Reaktionen der Erwachsenen – Gefühle, Tränen, Wutausbrüche und stille Verzweiflung –, wenn sie die Ursachen für diese Reaktionen kennen. Womit sie nicht gut zurechtkommen, ist das Vakuum, in dem sie leben müssen, wenn die Erwachsenen ihre Gründe und Reaktionen für sich behalten wollen.

Beispiel aus der Praxis

Auf unserer Intensivabteilung lag ein 2-jähriges Kind. Die letzten Untersuchungen zeigten, dass das Kind hirntot sei. In einem Prozess, der drei Tage in Anspruch nahm, wurde es den Eltern verständlich, dass das Beste für ihr Kind und für sie das Abbrechen der Intensivtherapie sei. Das Kind hatte einen 5-jährigen Bruder, den die Eltern in dieser Situation zu Hause bei den Großeltern lassen wollten. Wir haben die Situation für den 5-jährigen Bruder mehrere Male gemeinsam besprochen.

Wie wird es für ihn sein, wenn die Eltern ohne seinen 2-jährigen Bruder nach Hause kommen? Welche Gelegenheit hat er, zu verstehen, dass sein Bruder jetzt sterben wird? Welche Möglichkeit hat er, die Reaktionen und Motive der Eltern kennenzulernen? Wo (oder wie?) kann er in dieser Situation am besten trösten und getröstet werden?

Die Eltern einigten sich dann, den 5-Jährigen zu holen. In den folgenden Tagen war er ein normales Familienmitglied wie zuvor, er nahm an allen Gesprächen teil und bekam die Möglichkeit, mit seinem sterbenden Bruder Zeit zu verbringen, bis dieser starb. Auf diese Weise hat er nicht nur Reaktionen und Gefühle der Eltern, Krankenschwestern und Ärzten erlebt, er hat auf seine Weise Erklärungen bekommen für den Tod seines Bruders. Er war dabei, als der Bruder starb, und bei einer Messe im Krankenhaus am nächsten Tag. Er konnte trösten und getröstet werden.

Die Alternative wäre, dass er mit den trauernden Eltern ohne diese gemeinsamen Erfahrungen konfrontiert würde. Bei einem Todesfall sehen wir, dass Kinder darunter leiden, wenn sie keine ausreichenden oder nur unvollständige Informationen erhalten.

Erschwerend ist es auch zusätzlich, wenn die Kinder bei den darauffolgenden Ritualen nicht teilnehmen dürfen, wie z. B. den Toten zu sehen oder zurechtzumachen, bei einer Messe oder bei dem Begräbnis (Weller et al. 1987). Oft versuchen die Eltern, aus guten aber fehlerhaften Motiven, die Kinder zu schützen, indem sie Teile der Geschehnisse verschweigen oder umschreiben. »Wie kann ich weinen«, sagte ein Kind, »wenn ich nie gesehen habe, dass ihr geweint habt?«

Die Kinder können auch erleben, dass die Eltern ihre ganze Aufmerksamkeit auf ihren Verlust richten und dabei wenig Aufmerksamkeit für sie übrig bleibt und sie sich längere Zeit selbst überlassen bleiben. »Meine Mutter sitzt auf dem Sofa und weint und weint. Ich gehe auf mein Zimmer und weine für mich allein…«

Ein Todesfall in der Familie führt oft zu Verdrängung. Es wird kaum oder gar nicht über den Verstorbenen gesprochen, die Gefühle, Orte und Erinnerungen werden vermieden, um nicht mit dem Verlust konfrontiert zu werden. Im schlimmsten Fall bricht die Kommunikation über den Verlust in der Familie zusammen, worunter Kinder besonders leiden. Die Maske, die Eltern sich in solchen Situationen aufsetzen – im guten Glauben, die Kinder schützen zu können – kompliziert die Trauerarbeit des Kindes.

Besondere Probleme müssen für weiterlebende Geschwister erwartet werden, wenn der Verstorbene ein Kind war. Das Familiensystem wird über längere Zeit extrem belastet, und Familienmitglieder, besonders Kinder, bekommen neue Rollen.

Auch in der sonstigen Umgebung der Kinder, z. B. bei Freunden und in der Schule, wird es vermieden, den Verlust zu erwähnen, weil die Umwelt unsicher ist und sich nicht traut, dieses sensible Thema anzusprechen. Von den Lehrern müssten wir allerdings Kompetenz erwarten können, aber das Gegenteil trifft zu. Die Schule und ihre Lehrer meiden die (lebens)wichtigen Themen Sterben, Tod, Rituale und Trauer im Unterricht.

Da kein Konzept existiert, kann auch kein gemeinsames Verständnis erarbeitet oder erwartet werden. In der Regel beobachten wir, dass der Verlust entweder verschwiegen oder nur oberflächlich erwähnt wird. Es ist ein Symp-

tom der Tabuisierung des Todes, dass dieses Thema nur ausnahmsweise oder überhaupt nicht in der Aus- und Weiterbildung der Lehrer zu finden ist.

5.5.1 Trauer bei Kindern

Nagy hat bereits 1948 beschrieben, dass die Vorstellungen der Kinder über den Tod altersabhängig sind. Vor dem 5. Lebensjahr halten sie den Tod für eine reversible Veränderung, wie das Schlafen. Im Alter zwischen fünf und neun Jahren wird der Tod mit Personen verknüpft. Mit neun Jahren fängt das Kind an zu verstehen, dass der Tod etwas Endgültiges ist. Dieser chronologische Verlauf variiert innerhalb verschiedener Kulturen.

Piaget hat eine wichtige Theorie zur Entwicklung des Intellekts (Piaget 1964) erarbeitet. Er weist dabei darauf hin, dass kleine Kinder (2–7 Jahre) zu magischen Vorstellungen, Träumen und Phantasien neigen, die sie kaum von Erlebnissen der realen Welt unterscheiden. Dies entspricht dem ersten Stadium bei Nagy. Vom zwölften Lebensjahr an verstehen und empfinden Kinder zunehmend wie Erwachsene und sind imstande, einen tieferen Sinn in dem, was passiert ist, zu suchen. Kinder entwickeln in diesem Alter Selbstständigkeit und beginnen mit der Loslösung von ihrem Elternhaus; dies kann zu besonderen Problemen bei der Trauerarbeit führen.

Im normalen Leben wird jedes Kind mit dem Tod konfrontiert: eine tote Fliege, eine tote Maus, ein toter Vogel oder der Tod eines geliebten Haustieres. Bei diesen Erfahrungen fragen die Kinder sich und andere: »Was ist passiert? Schläft das Tier? Kann es wieder wach werden?« In diesen Situationen werden die Kinder auch Antworten und Erklärungen von der Umgebung bekommen, von Freunden oder Erwachsenen, und ihre Vorstellungen von Tod und Sterben entwickeln sich aus ihren Erfahrungen.

Was sind die spezifischen Probleme bei der Trauerarbeit der Kinder?

- Das Fehlen einer Bezugsperson,
- mangelhafte Information,
- fehlende eigene Kontrolle,
- fehlende Reife,
- Schuldgefühle,
- Testen, ob jemand gestorben ist,
- die Reaktionen der Erwachsenen,
- die Reaktionen in der Schule.

Das Fehlen einer Bezugsperson

Wir haben bei trauernden Erwachsenen die Bedeutung der Tatsache beschrieben, ob sie in ihrer Nähe Personen haben, die erreichbar sind und zum richtigen Zeitpunkt ihre Unterstützung und Hilfe anbieten können. Was für Erwachsene wichtig ist, ist für Kinder von noch größerer Bedeutung. Erwachsene wissen, dass sie in verschiedenen Phasen des Lebens auch ohne die kontinuierliche Hilfe von anderen zurechtkommen können, eine Erfahrung, die Kinder nicht besitzen. Sollten Kinder aufgrund eines Todesfalls bei den Eltern nun über längere Zeit ohne elterliche Aufmerksamkeit leben müssen, können dabei große Probleme bei der Trauerarbeit des Kindes entstehen.

Mangelhafte Information

Viele Probleme entstehen durch die mangelhafte Information der Kinder. Die Erwachsenen sind oft vor, während und nach dem Todesfall anwesend, sie bekommen dabei Antworten auf die Fragen, die sie stellen, während das Kind auf die Weiterinformation durch die Erwachsenen angewiesen ist. Sie haben kaum Möglichkeiten, sich notwendige Informationen zu verschaffen, wenn die Erwachsenen sich entschließen sollten, die Tatsachen vor den Kindern zu verbergen.

Fehlende eigene Kontrolle

Erwachsene können selbst entscheiden, zu wem und zu welchem Zeitpunkt sie sich an jemanden wenden wollen, falls sie mit ihrem Leben nicht zurechtkommen. Kinder müssen sich weitgehend darauf verlassen, dass die Erwachsenen, dass heißt in der Regel der verbliebene Elternteil oder andere in der Familie oder Lehrer in der Schule, zum richtigen Zeitpunkt sehen, welche Hilfe das Kind braucht, um mit seinen Gedanken und seiner Trauer zurechtzukommen. Kinder kommen nicht an das Sterbebett oder zu dem Verstorbenen oder zu dem Begräbnis ohne Erlaubnis und Initiative der Erwachsenen. Alle diese »Plätze des Todes und der Trauer« würden mit großer Wahrscheinlichkeit dem Kind den notwendigen »Einstieg« zu seiner Trauerarbeit geben, aber die Erwachsenen haben den Schlüssel, den sie leider oft falsch benutzen, indem sie die Kinder fern halten.

Fehlende Reife

In den Fällen, in denen Kinder keine Einstellung zum Todesfall der Mutter oder des Vaters entwickeln können, liegt das Hauptproblem bei den Erwachsenen, die nicht in der Lage waren, in einer kindgerechten Sprache zu schildern, was passiert ist. Erwachsene neigen auch dazu, spielende oder fröhliche Kinder als nicht trauernde einzuschätzen. Sie übersehen dabei, dass Kinder – mehr als Erwachsene – einen intensiven Wechsel zwischen Trauer und Heiterkeit in ihrem Alltag erleben.

Schuldgefühle

Der erfahrene Psychologe Brice (1982) schreibt: »Ich kenne keinen einzigen Fall von Trauer bei Kindern, wo das Kind nicht geglaubt hat, es wäre mitverantwortlich für den Tod des Verstorbenen.« Es besteht Einigkeit darüber, dass Schuldgefühle ein wichtiges Merkmal der Trauer bei Kindern ist, besonders wenn eine Schwester oder ein Bruder gestorben ist.

Testen, ob jemand gestorben ist

Besonders bei kleineren Kindern spielt in ihren Gedankenabläufen Magie eine wichtige Rolle. Diese Kinder werden über längere Zeit nicht sicher sein, ob der Verstorbene wirklich tot ist. Sie werden aufmerksam die Äußerungen und das Verhalten der Erwachsenen beobachten, um zu erfahren, ob der Verstorbene bald wiederkommt oder warum er wirklich für immer weg ist. Bei Kindern haben die Wortwahl und die Erklärungen der Erwachsenen andere Auswirkungen, als sie von diesen gemeint waren. »Er ist eingeschlafen« kann dem Kind die Vorstellung geben, selbst auf keinen Fall einschlafen zu dürfen. »Sie ist im Himmel« kann für das Kind bedeuten, dass sie bald wiederkommt oder dass sie von den Vögeln aufgefressen werden könnte. Wir sollten mit solchen Metaphern, auch mit religiösem Inhalt, dem Kind gegenüber vorsichtig umgehen.

Die Reaktionen der Erwachsenen

Wenn jemand in der nächsten Umgebung stirbt, hängen Probleme der Kinder von den Reaktionen der Erwachsenen ab. Wir können in der Regel davon ausgehen, dass Kinder mit Verlusten zurechtkommen, wenn die Erwachsenen

damit zurechtkommen. In einer Befragung von 64 Geschwistern verstorbener Leukämiekinder fanden Stehbens u. Lascari (1974), dass 70% dieser Kinder diese Situation nach relativ kurzer Zeit sehr gut bewältigen konnten. Zwölf Kinder litten unter Problemen wie Enuresis, Bauchschmerzen, Depression, Schlafstörungen, aber diese Störungen waren nur von kurzer Dauer. Sieben hatten für einige Monate Schulprobleme. Aber nur bei zwei Kindern (3%) wurden längere Zeit emotionale Störungen nachgewiesen.

Die Reaktionen der Schule

Mit Entwicklung der modernen Gesellschaft hat die Schule Aufgaben übernommen, die früher in der Familie gelöst wurden. Die frühere Großfamilie ist durch die Kernfamilie ersetzt worden, wo es nur wenig »Reserven« gibt, wenn jemand stirbt. Wenn diese Familienreserven bei einem Todesfall oder einem Verlust zusammenbrechen, könnte der Lehrer mit wenig Aufwand viel retten. Sehr oft vergessen wir, dass Trauer bei Kindern bei jedem Verlust vorkommt. Das heißt, für Kinder besonders bei Scheidungen der Eltern. In einer viel zitierten Studie fanden Bendiksen u. Fulton (1975), dass die Belastung für Kinder nach der Ehescheidung der Eltern größer ist als nach einem Todesfall der beiden.

Die Schule verpasst eine große Chance, einen Beitrag zur Entwicklung ethischer und menschlicher Werte der Kinder und unserer zukünftigen Gesellschaft zu leisten, wenn sie nicht Tod und Trauer in ihre Aufgaben integriert und den Kindern Unterstützung anbietet. Die Konsequenzen für die Kinder können schwerwiegend sein.

5.5.2 Aufgaben der Ärzte und des Krankenpflegepersonals bei nicht heilbarer Krankheit oder beim Todesfall in der Familie mit Kindern

Offenes Krankenhaus

In einem offenen Krankenhaus haben die Kinder freien Zugang zu ihren erkrankten Eltern oder Geschwistern. Dies trägt zur Genesung von Kindern und Eltern bei und ist besonders wichtig bei erkrankten Geschwistern. Bisher sind unsere Krankenhäuser zu wenig auf diese Situation eingestellt, weil sie von grundsätzlich falschen Vorstellungen ausgehen.

Offene Information

Wie bereits mehrfach erwähnt, können Kinder mit Krisen in der Umgebung zurechtkommen, wenn sie ausreichende Informationen über die Ursache dieser Krise besitzen. Deshalb sollten wir frühzeitig die Frage stellen, welche Informationen die Eltern ihren Kindern über die Situation gegeben haben, und wir sollten die Eltern auffordern, sehr offen und sehr früh mit den Kindern zu sprechen. Wir können auch die Initiative zu einer Besprechung mit der gesamten Familie ergreifen. Diese Familiensitzungen haben sich sehr bewährt. Offene Information bedeutet auch, dass wir uns Gedanken machen, wer noch keine Informationen erhalten hat, wie z. B. die Lehrer und die Schule.

Angebot an die Eltern, über die Situation der Kinder zu sprechen

In der heutigen Zeit haben Eltern kaum Erfahrung, wie man mit Kindern kommunizieren soll, wenn eine Mutter, ein Vater, eine Schwester oder ein Bruder im Sterben liegt. Sie haben wenig Einblick in das Leben und die Probleme, die vor dem Tod entstehen können, und noch weniger darin, wie Kinder am besten mit der Krankheit, mit dem Todesfall und mit der Trauer überleben. Diese Eltern benötigen viel Information und Anteilnahme. Sie empfinden große Erleichterung, wenn die Fragen gestellt werden:

- Machen Sie sich Sorgen um Ihre Kinder?
- Brauchen Sie Hilfe, um mit Ihren Kindern zu sprechen?

Hausbesuch bei Patient und Kindern

Zu Hause erleben die Familienmitglieder in den meisten Fällen ein Höchstmaß an Autonomie und Integrität. Dies trifft besonders auf Kinder zu. Ich habe wiederholt erfahren müssen, dass Gespräche mit Kindern, die Angehörige sind, im Krankenhaus sehr schwierig sein können, auch wenn wir gute Absichten haben und gut vorbereitet sind. Wenn wir mit den gleichen Kindern zu Hause reden, ist es viel einfacher, ein offenes Gespräch zu führen.

5.5.3 Aufgaben der Eltern bei nicht heilbarer Krankheit und beim Todesfall in der Familie mit Kindern

Offenes Krankenhaus

Die Eltern sollten die Kinder mit zu ihrem Elternteil oder ihren Geschwistern ins Krankenhaus nehmen. Es trägt zur Genesung des Kindes und Elternteils bei. Wenn die Erwachsenen keine Angst vor der Krankenhausatmosphäre haben, haben auch die Kinder viel weniger Angst. Die Kinder kommen selbst gut mit Situationen und Dingen zurecht, die für sie bedrohlich erscheinen, wie z. B. Infusionen, technische Geräte, Blut, Monitore u. a. Die Kinder glauben aufgrund unseres Verhaltens, der Tod sei gefährlich. Wie sollen sie erfahren, dass der Tod zum Leben dazugehört, wenn nicht durch uns?

Offene Familie

In jeder Familie haben wir ganz eigene Familienmuster bezüglich Kommunikation, Rollenverteilung, Offenheit oder Verschlossenheit. Wenn Verschlossenheit ein ausgeprägtes Verhalten in der Familie ist, werden Kinder Probleme haben, sich in dieser Krise adäquat zu verhalten. Die Kinder sollten an Gesprächen über die Krankheit teilnehmen, auch beim Arzt. Die Eltern sollten dabei gut zuhören, welche Fragen die Kinder offen ansprechen, und überlegen, welche wichtigen Fragen sie nicht zu stellen in der Lage sind, wo sie auf ihre Hilfe angewiesen sind.

Suche nach Rat oder Hilfe beim Arzt, der Krankenschwester oder dem Lehrer, zu dem Vertrauen besteht

Das Wichtigste für das Kind ist die gesunde Familie. Wenn die Erwachsenen in einer schweren Lebenskrise leiden, leiden die Kinder mit. Es wird nur schwer gelingen, solchen Kinder zu helfen, wenn die Erwachsenen nicht die notwendige Unterstützung bekommen, um in ihrem Leben die Alltagsprobleme zu lösen. Oft ist nicht das Problem, dass keine Unterstützung da wäre, sondern dass der Betroffene selbst nicht in der Lage ist, sich an die naheliegenden Helfer zu wenden. Es zeigt sich wiederholt, dass die wichtigste Hilfe in der nächsten Umgebung zu finden ist. Für das Kind kann es besonders wichtig sein, dass die Helfer bekannt sind.

Die Kinder brauchen die Gefühle und Reaktionen der Erwachsenen

Wenn Kinder sehen, dass die Erwachsenen weinen und Trauer zeigen, trauen sich sich, ihre eigenen Gefühle und Reaktionen zuzulassen. Wenn Kinder sehen, dass die Erwachsenen kämpfen, um ihre Maske zu bewahren, glauben sie, es wäre auch ihre Aufgabe, alles, was schmerzt und weh tut, zu unterdrücken. Dabei wissen wir, dass genau das Gegenteil das Richtige ist.

5.5.4 Aufgaben der Schule bei nicht heilbarer Krankheit und beim Todesfall in der Familie eines Schülers

Tod und Trauer ist in der Lehrerweiterbildung eine hohe Priorität einzuräumen

Die Schule hat eine zentrale Rolle als Vermittler von Werten in der Gesellschaft. Lehrer haben, wie wir alle, Angst vor dem Tod. Ihr Umgang mit trauernden Kindern ist geprägt von Unsicherheit und fehlender Kompetenz. Diese Themen werden selten oder nie in ihrer Ausbildung angesprochen. Dabei muss jeder Lehrer ein Weiterbildungsangebot bekommen, um dieses Defizit abzubauen. Dadurch können die Kompetenz und das Bewusstsein in Bezug auf diese Fragen verbessert werden.

Unterricht über Tod, Trauer und Rituale

Kinder machen sich viele Gedanken über den Tod, denn sie haben durch Verluste Trauer erlebt. In jeder Klasse werden einige Kinder den Verlust ihrer Mutter oder ihres Vaters innerhalb der Schulzeit erleben. Deswegen müssen diese Themen in die Lehrpläne verschiedener Altersstufen integriert werden.

Tod in der Familie des Schülers

Anzustreben wäre, dass der Lehrer frühzeitig von der Ernsthaftigkeit einer Erkrankung oder vom bevorstehenden Tod informiert würde. Erst danach sollte die Klasse informiert werden.

Für die Mitschüler ist wichtig zu wissen, wie sie sich in der folgenden Zeit verhalten sollen, sei es, dass sie initiativ werden oder vorsichtig abwarten. Die Teilnahme am Begräbnis, wenn eine Mutter oder ein Vater (oder ein Kind) ge-

storben ist, hat hohen Symbolwert und wird hoch geschätzt. Die Schulleitung hat eine besondere Verantwortung gegenüber betroffenen Lehrern, denen auf jeden Fall ein Gesprächspartner (evtl. der Rektor) angeboten werden soll.

Ernsthafte Erkrankung oder Tod eines Schülers

Auf diese Situation sollte eine Schule vorbereitet sein. Besonderen Stellenwert nehmen die Informationen an die Klasse, die Erinnerung an den Verstorbenen und die Verabschiedung ein.

Während man bei einem chronischen Verlauf Vorbereitungen treffen kann, ist dies beim unerwarteten Tod nicht möglich. Hier ist es wichtig, sich Klarheit darüber zu verschaffen, was wirklich passiert ist. Folgende Fragen müssen beantwortet werden:

- Wann, wo und wie ist das Unglück oder der Todesfall passiert?
- Waren andere Schüler anwesend?
- Wo befindet sich der Verletzte oder Tote jetzt?

Beim Suizid ist die Belastung für die Hinterbliebenen extrem groß. Auch hier gilt für die Lehrer und Mitschüler, die Schmerzen und Trauerreaktionen zuzulassen und zu fördern.

Es ist nicht nachgewiesen, dass offene Information die Gefahr weiterer Suizide erhöhen kann, ganz im Gegenteil (Brent 1989).

Die Bedeutung der Rituale

Durch Rituale können wir gemeinsam mit anderen Gefühle und Gedanken ohne viele Worte zulassen (Oates 1993). Viele Rituale reduzieren Angst und unangenehme Phantasien. Die teilnehmende Gruppe kann daraus Kraft schöpfen. Folgende Rituale im Rahmen einer Gedenkfeier haben sich beim Tod eines Schülers oder Lehrers bewährt:

- Gedenkworte des Rektors,
- Gedenkworte des Lehrers,
- Schweigeminute,
- Gedicht oder Gruß, von einem Schüler gelesen,
- kurzes Musikstück (Lieblingsstück des Verstorbenen?),
- Schüler können den Raum mit Blumen, Kerzen, Bildern schmücken,
- Mitschüler, Freunde, Familie und andere können eingeladen werden.

5.6 Angst, Depression, delirantes Syndrom und Verwirrtheitszustände

In der Begegnung mit inkurablen Tumorpatienten fällt es auf, dass viele Patienten psychische Beschwerden haben. Diese Patientengruppe ist besonderen Belastungen ausgesetzt. Die Häufigkeit von Schmerzen, Depression und psychosozialen Problemen nimmt mit Fortschreiten der Erkrankung deutlich zu (Bukberg et al. 1984). Die Wahrscheinlichkeit, dass Tumorpatienten schwere psychische Probleme entwickeln, sind besonders zu erwarten bei jungen Patienten (40 Jahre und jünger), Frauen, in Fällen unsicherer Prognose und aggressiver Antitumortherapie oder wenn die Patienten wegen der Symptomkontrolle an das Krankenhaus gebunden sind (Casileth et al. 1985).

Aber sind diese Reaktionen auf diese Belastungen nicht grundsätzlich »normal«?

Bereits in ▶ Kap. 5.4: »Trauer« und in ▶ Kap. 3: »Kommunikation« haben wir über einige menschliche Reaktionen gesprochen, die bei einer ernsten Erkrankung zu erwarten sind. Wut und Angst, Isolation und Trauer, Schweigen und Aggressivität, Verdrängung und Verhandlung würden bei den meisten von uns zu finden sein, die mehr oder weniger offen oder versteckt ausgelebt werden.

Derogatis et al. (1983) wiesen in ihrer Studie nach, dass bei 47% der Tumorpatienten psychische Veränderungen gefunden werden konnten. Von den 272 Patienten litten 68% unter reaktiver Angst oder Depression, 13% unter schwerer Depression, und bei 8% konnte ein delirantes Syndrom nachgewiesen werden.

Eine wichtige Aufgabe des Arztes ist es, die Reaktionen und Gefühle dieser Patienten zu verstehen und zu wissen, wer Hilfe braucht und welche Unterstützung am besten helfen kann. Dabei sollte die Möglichkeit einer pharmakologischen Behandlung der Symptome zwar erwogen werden, aber nur zum Einsatz kommen, wenn der zu erwartende positive Effekt die zu erwartenden negativen Nebenwirkungen bei weitem übersteigt. Die wichtigste Hilfe wird immer in der menschlichen und fachlichen psychosozialen Betreuung liegen.

5.6.1 Angst

Viele schwerkranke Patienten haben Angst vor einem Fortschreiten der Erkrankung, davor, die Kontrolle über den Verlauf zu verlieren oder dass ihre Autonomie oder Integrität verletzt oder begrenzt wird. Diese Ängste verset-

zen uns in die Lage, eine Barriere aufzubauen, Distanz zu etablieren und Zeit zu gewinnen, damit die drohende Gefahr bekämpft werden kann.

Eine Betreuung dieser Patienten mit ihrer Angst setzt voraus, dass wir Kenntnisse über die Krankheitsentwicklung des Patienten und sein soziales Umfeld besitzen. Was ist das Hauptproblem:

- die Krankheitsentwicklung?
- mangelhafte Information?
- Symptome, die erkannt und behandelt werden müssen?
- Probleme in der Familie?
- Unsicherheit bezogen auf Diagnose, Prognose oder Behandlung?
- unerwünschte Nebenwirkungen der Behandlung?
- die Vorgeschichte des Patienten?

Die Angst dieser Patienten steht meist im Zusammenhang mit den medizinischen Problemen. Oft können diese Faktoren direkt angesprochen und dadurch eine Verminderung der Angst erreicht werden. Wir dürfen aber nicht die zusätzlichen psychischen Belastungen vergessen, denen diese Patienten ausgesetzt sind. Deswegen brauchen sie auch eine psychosoziale Betreuung. Sich Zeit zu nehmen, zuzuhören und Vertrauen zu entwickeln sind wichtige Grundlagen dieser Betreuung. Die Angehörigen benötigen immer wieder unsere Bestätigung, dass sie das Allerbeste für den Patienten getan haben.

Medikamentöse Therapie der Angst

Der Arzt wird immer wieder vor die Frage gestellt, ob eine medikamentöse Therapie der Angst durchgeführt werden soll (Twycross 1995). Wir wissen, dass die Gefahr der Medikamentenabhängigkeit in diesen Situationen äußerst gering ist. Medikamente der ersten Wahl sind Benzodiazepine, die wegen ihrer guten Verträglichkeit, geringen Nebenwirkungen und großen therapeutischen Breite vorgezogen werden.

Kurzwirkende Substanzen wie Lorazepam, Midazolam und Oxazepam sind bei diesen Patienten oft von Vorteil. Ein Nachteil dieser kurzwirkenden Medikamente ist, dass Angstzustände bereits wieder auftreten können, bevor die nächste Dosis eingenommen wird. Wenn dies der Fall ist, sollte zu langwirkenden Benzodiazepinen übergegangen werden, wie z. B. Diazepam oder Clonazepam.

Einige Palliativmediziner haben gute Erfahrungen mit der rektalen Gabe von Diazepam gemacht. Das wasserlösliche Midazolam ist besonders wertvoll beim Einsatz in den letzten Tagen der Patienten. Es kann gut subkutan verabreicht werden.

Auch Neuroleptika haben gute anxiolytische Eigenschaften (Massie 1989). Vor allem mit Haloperidol haben wir in der Palliativmedizin gute Erfahrung, besonders wenn der Patient zusätzlich unter Verwirrtheit oder Halluzinationen leidet. Trizyklische Antidepressiva haben ihren Stellenwert, wenn Angst verbunden ist mit Depression.

Wenn Angst durch Schmerzen oder Dyspnoe hervorgerufen wird, sollten zunächst diese Symptome mit Opioiden (z. B. Morphin) therapiert werden und die Patienten, falls nötig, zusätzlich Anxiolytika erhalten.

In ◘ Tab. 5.2 sind die wichtigsten Medikamente und Dosierungen wiedergegeben. Bei den meisten Patienten genügen niedrige Dosierungen. Die Dosierung der Medikamente sollte auf ein Minimum reduziert bleiben. Falls in diesem Prozess auch ein Absetzen der Anxiolytika (speziell der Benzodiazepine) erwogen wird, sollte dies stufenweise innerhalb von 2–3 Tagen erfolgen, um eine unangenehme Abstinenzreaktion zu verhindern.

◘ **Tab. 5.2.** Medikamentöse Therapie der Angst

Medikament	Tagesdosierung [mg]	Verabreichungsform
Diazepam	5(–50)	p.o., rektal
Midazolam	10(–100)	s.c., i.m., i.v., rektal
Lorazepam	2(–10)	p.o., s.l., i.v., i.m.,
Oxazepam	10(–60)	p.o.
Haloperidol	0,5(–10)	p.o., i.v., s.c., i.m.
Chlorpromazin	12,5(–200)	p.o., i.m., i.v.
Amitryptilin	10(–150)	p.o., i.m.

5.6.2 Depression

Depressionen sind bei Patienten, die unter Schmerzen leiden, etwa doppelt so häufig anzutreffen wie bei Patienten ohne Schmerzen. Bei einer fortgeschrittenen Krankheit und im höheren Alter ist noch häufiger damit zu rechnen. Eine englische Studie fand bei 6% der Patienten schwere Depressionen (Hinton 1980), während eine vergleichbare Studie aus den USA auf 22% kam (Mor 1986). Dieser Anteil stieg bei reduzierter Lebensqualität und fortschreitender Krankheitsentwicklung mit körperlichen Veränderungen bis auf 77% an (Bukberg et al. 1984).

Die Diagnostik einer Depression bei diesen Patienten ist problematisch, besonders weil kein Konsens über die diagnostischen Kriterien einer Depression bei somatischer Grunderkrankung vorliegt (Brown et al. 1986). Viele der vegetativen Symptome, die häufig bei einer Depression zu beobachten sind – Insomnia, Appetit- und Gewichtsverlust, Anorexie, Verlust der Konzentrationsfähigkeit und Energie, Hoffnungslosigkeit und Angst –, sind normale und zu erwartende Folgen einer lebensbedrohlichen Krankheit.

Die Diagnostik muss auf einer Gesamtbeurteilung der Situation beruhen, wobei der Arzt besonders den Kommunikationsprozess in seinen Überlegungen berücksichtigen muss. Die Frage, ob für diese Diagnostik ein Psychiater oder Neurologe hinzugezogen werden soll, muss aus der Situation heraus beurteilt werden. In den allermeisten Fällen wird der behandelnde und erfahrene Arzt, der seinen Patienten über längere Zeit kennt, selbst die besten Voraussetzungen für eine solche Beurteilung besitzen.

Wichtige Kriterien für das Vorliegen einer Depression, verbunden mit der Wahrscheinlichkeit eines guten Effekts von Antidepressiva, sind über längere Zeit bestehendes niedriges Selbstwertgefühl und Schuldgefühle (Stedeford 1984).

Ist die Indikation gegeben, dann sind trizyklische Antidepressiva die Medikamente der ersten Wahl (Massie u. Holland 1990). Die Dosierungen sollten niedrig gewählt werden (z. B. Amitriptylin 10–25 mg zur Nacht). Diese Dosierungen reichen oft aus, um einen guten Schlaf zu bewirken. Nebenwirkungen sind dabei kaum zu befürchten. Um eine Depression zu behandeln, muss die Dosis häufig auf 75–150 mg gesteigert werden, bevor ein antidepressiver Effekt erwartet werden kann. Höhere Dosierungen sind bei Tumorpatienten selten notwendig und können zu toxischen Nebenwirkungen führen. Es dauert 2–4 Wochen, bis ein antidepressiver Effekt erreicht wird.

Tab. 5.3. Antidepressiva

Medikament	Tagesdosierung [mg]	Verabreichungsform
Amitriptylin	10–150	p.o., i.m., rektal
Imipramin	12,5–150	p.o., i.m.
Bupropion	200–450	p.o.
Mapropilin	50–75	p.o.
Dextroamphetamin	5–40	p.o.
Lithium	600-1.200	p.o.

Unerwünschte Nebenwirkungen der Antidepressiva sind insbesondere die anticholinergen Effekte wie Mundtrockenheit und Müdigkeit.

Tab. 5.3 gibt einen Überblick über die wichtigsten Antidepressiva.

Grundsätzlich sollte hier festgehalten werden, dass in erster Linie die menschliche und psychosoziale Betreuung im Mittelpunkt stehen muss; die Angst vor Trennung und Isolation sollte nicht durch Antidepressiva bekämpft werden. Durch gezielte menschliche Hilfe erübrigt sich der Einsatz dieser Medikamente.

Im Spätstadium, den letzten Wochen oder Monaten vor dem Tod, ist der Nutzen von Antidepressiva begrenzt. Die Nebenwirkungen, v. a. Sedierung und Mundtrockenheit, sind jetzt dominanter und der Nutzen einer antidepressiven Therapie fraglich.

5.6.3 Delirantes Syndrom und Verwirrtheit bei Patienten mit fortgeschrittener Erkrankung

Beim Fortschreiten einer inkurablen Krankheit nehmen kognitive Probleme zu. Bei Sterbenden ist das regelmäßig zu beobachten, wobei Verwirrtheit, Verständnisprobleme, Bewusstseinsstörungen usw. besonders häufig vorkommen (Bruera et al. 1992).

Die internationale Diagnoseliste für mentale Störungen, DSM-III (Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders), beschreibt folgende Kategorien dieser organischen Störungen: Delirium, Demenz, Amnesie, organische

Halluzinose, organische Gefühlsstörungen, organische Angststörungen, organische Persönlichkeitsstörungen, Intoxikationen und Abstinenz.

Eine wesentliche mentale Störung ist das delirante Syndrom. Es ist charakterisiert durch eine unspezifische, globale zerebrale Dysfunktion mit Störungen des Bewusstseins, der Aufmerksamkeit, der Gedankenprozesse, der Wahrnehmung, der Erinnerung, der Gefühle und des Schlafes und auffälligem psychomotorischem Verhalten (Lipowski 1987).

Das delirante Syndrom ist im Gegensatz zur Demenz oft ein reversibler Zustand. Das Problem ist, dass zwar eine organische Ursache vermutet werden kann, aber diese ist multifaktoriell und kann nur in seltenen Fällen eindeutig festgestellt werden.

Eine Studie der Palliativabteilung der Universitätsklinik in Edmonton (Fainsinger et al. 1994) zeigte, dass ein delirantes Syndrom vor der Finalphase ein häufiges Problem ist; es wurde bei 83% der Patienten beobachtet, eine medizinische Behandlung war bei 40% indiziert, und durch Sedierung allein konnten die Symptome nur bei 10% der Patienten gelindert werden.

In einer prospektiven Studie fanden Bruera et al. (1992), dass bei 44% der Patienten eine Ursache festgestellt werden konnte. Die häufigsten Ursachen waren Medikamente (9%), Sepsis (6%) und Hirnmetastasen (6%). Bei 33% der Patienten konnte eine Verbesserung erreicht werden, sei es durch Änderung der Medikamente (9%), Behandlung einer Hyperkalzämie (3%) oder Sepsis (3%). Bei den meisten dieser Patienten konnte die Ursache der Besserung der Symptome nicht zugeordnet werden. Auch Fainsinger et al. (1994) konnten in ihrer Untersuchung bestätigen, dass Medikamente häufig Ursache des deliranten Syndroms sind; deswegen empfehlen sie als erste Maßnahme eine Änderung der Medikamente.

Die Untersuchungsgruppe von Fainsinger hat auch gute Erfahrungen mit dem Wechsel von einem Opioid zum anderen gemacht. Da auch eine Dehydrierung Ursache dieses Syndroms sein kann, sehen Fainsinger u. Bruera (1994) hier eine Indikation für die Rehydrierung schwerkranker Patienten.

Haloperidol ist Medikament der Wahl beim deliranten Syndrom, das verbunden ist mit Agitation und Hyperaktivität (Fainsinger et al. 1994). Initial werden 1–2 mg peroral oder subkutan 2-mal täglich gegeben, es kann bis 10 mg 3-mal täglich gesteigert werden. Bei unzureichender Wirkung kann die Gabe der mehr sedierenden Phenothiazine erwogen werden. Auch die Gabe von Midazolam (5–50 mg) hat sich in diesen Situationen als wirksam erwiesen. ◘ Tab. 5.4 gibt eine Übersicht über diese Medikamente.

Tab. 5.4. Medikamentöse Behandlung von delirantem Syndrom und Verwirrtheit bei schwerkranken Patienten

Medikament	Tagesdosierung [mg]	Verabreichungsform
Haloperidol	1–40	p.o., s.c., i.m.
Chlorpromazin	25–200	p.o., s.c., i.m.
Midazolam	5–50	s.c., i.m., i.v.

Bei sterbenden Patienten, d. h. in den letzten 2–3 Tagen des Lebens, sollte die Behandlung einer kognitiven Störung oder eines deliranten Syndroms anders beurteilt werden als in einem früheren Stadium. Viele werden sagen, dass es schwer vorauszusagen ist, wann dieses finale Stadium erreicht ist, aber in einigen Fällen ist es doch möglich anzunehmen, dass der Tod jetzt zu erwarten ist. In dieser Zeit sind kognitive Veränderungen das Normale und nicht die Ausnahme. Das Ziel darf hier nicht mehr eine aufwändige Diagnostik oder belastende Therapie sein. Die Aufgabe liegt v. a. darin, mit einem Minimum an klinischer Diagnostik und therapeutischen Maßnahmen dem Patienten und seinen Angehörigen ein Maximum an Autonomie und Integrität zu ermöglichen. Im Vordergrund stehen die Leidenslinderung und die Unterstützung der Angehörigen, damit sie bei dem Patienten bleiben können oder in der Lage sind, den Kranken zu Hause zu versorgen (▶ Kap. 5.10).

5.7 Suizid bei schwerkranken Patienten

Der Gedanke, sich das Leben zu nehmen, ist bei Menschen weit verbreitet. Fast jeder hat irgendwann in seinem Leben Suizidgedanken gehabt. Auch ist die Suizidrate in der westlichen Gesellschaft erschreckend hoch. Die Angaben schwanken zwischen 0,5% und 2,5% aller Todesfälle in jedem Jahr.

Praktisch jeder Arzt, der unheilbar Kranke behandelt, wird mit dem Problem suizidaler Gedanken und/oder aktiver Sterbehilfe konfrontiert. Ist wirksame Hilfe möglich, möchten diese Patienten wieder leben und ihr Leben gestalten.

Schwere Depression ist auslösende Ursache bei etwa 50% aller Selbsttötungen. Dies betrifft auch Krebspatienten (Guze u. Robins 1970). Selbsttö-

tung wird eher im fortgeschrittenen Stadium der Krankheit verübt. In einer Studie machte dies 86% der Selbsttötungen aus (Farberow et al. 1963). Eine Untersuchung von Hospizen in Kanada zeigte, dass 10 von 44 sterbenden Tumorpatienten suizidale Gedanken hatten oder sich eine Beschleunigung des Sterbeprozesses herbeiwünschten. Alle 10 litten unter schweren Depressionen (Brown et al. 1986). Suizidale Gedanken scheinen mit der Diagnose und mit der Ausbreitung der Erkrankung zusammenzuhängen. Dementsprechend wurden bei 146 Patientinnen mit Brustkrebs nur 3 Patientinnen mit suizidalen Gedanken gefunden (Silberfarb et al. 1980).

Selbsttötungsgedanken sind häufig bei Tumorpatienten mit weit fortgeschrittener inkurabler Erkrankung. Sie scheinen die Funktion eines Ventils zu haben: »Falls es zu schlimm wird, nehme ich mir das Leben.«

- Sollen diese Fragen angesprochen werden oder sollten wir diese Auseinandersetzung meiden?
- Wie soll der Arzt oder die Krankenschwester vorgehen, wenn ein schwerkranker Patient Selbsttötungsgedanken äußert?
- Sollen wir einen Psychiater rufen oder in die Psychiatrie einweisen?
- Können wir uns vorstellen, dass es Situationen gibt, wo der Arzt akzeptieren muss, dass sein Patient aus dem Leben scheidet?

Erfahrene Psychologen und Psychiater haben nachweisen können, dass wir das Leben einiger gefährdeter Patienten retten können, wenn wir das Problem eines Suizids zum richtigen Zeitpunkt ansprechen (Breitbart 1994). Wenn der Arzt aus Angst dieses Thema nicht anspricht, bedeutet dies für den Patienten eine zusätzliche Belastung, denn er kann seine Ängste mit seinem vertrauten »Fachmann« nicht teilen und er fühlt sich allein gelassen mit seinen Gedanken und Problemen.

Unsere Hauptaufgabe liegt darin, ein solches Gespräch zu fördern und zuzulassen und den Patienten offen darlegen zu lassen, welche Gedanken ihn bedrücken, warum er sich jetzt das Leben nehmen möchte. In einem solchen Gespräch gibt es immer die eine oder andere Frage, die ausführlich besprochen werden kann. Vielleicht kann eine Lösung gefunden werden, die Schmerztherapie kann verbessert werden, oder das, was im Leben als unerträglich oder unwürdig empfunden wird, kann gelindert werden. Häufig geben Patienten an, dass sie anderen nicht länger eine Last sein möchten; sie sehen, wie die Angehörigen unter dem Krankheitsverlauf leiden, und sie möchten als Lösung das eigene Leben beenden.

Bolund (1985) hat Suizidfälle bei Tumorpatienten in Schweden untersucht. 1974–1977 wurden unter diesen Patienten 88 Suizide gemeldet: 94% dieser Patienten litten unter ungelinderten Schmerzen, 62% der Patienten befanden sich im fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung und hatten eine infauste Prognose, 50% der Patienten litten unter schwerer Depression. Signifikant erhöht war die Wahrscheinlichkeit einer Selbsttötung bei Patienten mit früheren Suizidversuchen oder belastender Familienanamnese mit psychischen Problemen.

In Deutschland gibt es etwa 14.000 Suizide pro Jahr, das macht etwa 1,5% der Verstorbenen in der Gesamtbevölkerung aus. In Skandinavien finden wir vergleichbare Zahlen. Die Anzahl der Suizide in Schweden macht 0,1% der verstorbenen Krebspatienten in dieser Zeitperiode aus. Diese Untersuchung zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit einer tatsächlich vollzogenen Selbsttötung bei einer fortgeschrittenen inkurablen Tumorerkrankung abnimmt.

Im *Oxford Textbook of Palliative Medicine* schreibt der Psychiater Breitbart (1994):

> Es gibt Situationen, in denen der Arzt den Suizid nicht um jeden Preis verhindern sollte. Dabei muss er Alternativen und Unterstützung anbieten, damit Selbsttötung als Impulshandlung vorgebeugt werden kann. Bei diesen schwierigen Situationen sollte der Arzt auf jeden Fall folgende Fragen berücksichtigen:
> - Liegt ein klarer mentaler Prozess ohne psychologische Krankheit (z. B. Depression) vor?
> - Ist die Einschätzung der Situation (von Seiten des Patienten) realistisch?
> - Sind die Motive auch für Außenstehende klar und verständlich?

Siehe auch ▶ Kap. 2: »Ethik«, ▶ Kap. 2.3.4: »Ärztliche Beihilfe zum Suizid«.

5.8 Nähe – Distanz und Sexualität

Stellen Sie sich vor, Sie leiden an einer schweren lebensbedrohlichen Krankheit. Sie liegen in einem Krankenhaus. In den vergangenen Tagen haben sie einsehen müssen, dass Sie aufgrund der Krankheitsentwicklung die Ihnen verbleibende Zeit – Tage, Wochen oder Monate – im Krankenhaus verbringen müssen.

- Was wäre für Sie wichtig?
- Welche Personen möchten Sie in Ihrer Nähe haben?
- Was möchten Sie bis zuletzt selbst machen können?
- Wer soll Sie pflegen, wenn Sie selbst dazu nicht mehr in der Lage sind?
- Sollten Ihre Angehörigen einen Teil der Pflege übernehmen?
- Wäre es für Sie von Bedeutung, dass Sie allein und ungestört mit Ihren Angehörigen sein können?
- Wäre für Sie wichtig, Ihren Ehepartner allein in der Nacht bei sich zu haben?
- Übersteigt es Ihre Phantasie, dass Ihre sexuelle Beziehung noch wichtig ist?

5.8.1 Physische Nähe

Im beruflichen Alltag glauben wir, dass Fragen von menschlicher Nähe oder Sexualität Privatangelegenheiten sind. Wir dürfen nicht vergessen, in welcher Situation sich schwerkranke Patienten befinden. Ärzte und Krankenschwestern haben unendlich viel Macht. Die Patienten kommen zu uns, in eine für sie fremde Umgebung. Unsere Betten, Zimmer und das Personal sind für sie fremd. Unsere Konzepte, Diagnosen, Therapien, Pflegemaßnahmen und Behandlungen sind für sie eine fremde Welt. Meistens stellen wir die Fragen, und wir liefern die Grundlagen für die Antworten.

Für uns ist es selbstverständlich, mit Patienten umzugehen. Für den Patienten ist es keineswegs selbstverständlich, sich von Fremden waschen oder pflegen zu lassen oder dass andere für ihn wichtige Entscheidungen treffen.

Dabei geht es keineswegs nur um die Fragen »welche Operation?« oder »welche Therapie?«, es geht um Fragen der Intimsphäre, der Hygiene und der Nähe. Diese Fragen besprechen wir – wenn überhaupt – nur mit unseren Nächsten.

Im medizinischen Alltag erleben wir immer wieder, wie der Arzt oder eine Krankenschwester ohne zu fragen die Bettdecke wegnimmt, ohne darüber nachzudenken, wie der Patient dadurch bloßgestellt wird. Wir untersuchen, entkleiden, drehen oder waschen ohne eine vorherige Aufklärung oder Nachfrage bei dem betroffenen Patienten, ob dies für ihn in Ordnung sei.

Fragen der persönlichen Hygiene sind für jeden Menschen ein empfindliches Thema. Auch zu Hause schließen wir die Tür, bevor wir auf die Toilette

gehen. Für viele Menschen ist körperliche Berührung etwas kaum Erträgliches, außer unter ganz bestimmten, für sie privaten Umständen.

Bei der Behandlung, Untersuchung und Pflege von kranken Menschen ist Körperkontakt oft notwendig. Der angemessene Umgang mit der Notwendigkeit, in die Intimsphäre des Patienten einzudringen, setzt berufliches und ethisches Bewusstsein voraus (Randall u. Downie 1996; Barnard 1995).

Wenn Untersuchungen, Behandlung und Pflege notwendig sind, zeigen Patienten viel Geduld und Toleranz. Aber unser höfliches Benehmen ist geboten!

- Grüßen wir freundlich?
- Sagen wir grundsätzlich, wer wir sind?
- Wird unser Vorhaben verständlich erklärt?
- Wird anschließend höflich gefragt, ob der Patient mit unserem Vorhaben einverstanden ist?

Uns wurde selten vorgeführt, wie diese Aufgaben respektvoll ausgeführt werden können. Wenn Patienten vorsichtig protestieren, sind wir schnell verletzt. Dabei protestieren die meisten Patienten nicht. Sie beklagen sich fast nie. Dadurch werden wir zu der Annahme verleitet, dass alles in Ordnung ist. Bennet (1987) beschreibt eingehend, was und wieviel Menschen ertragen ohne zu klagen, wenn jemand einen weißen Kittel trägt.

Das Problem ist nicht, dass Ärzte, Krankenpflegepersonal oder Therapeuten viel Macht haben. Das Problem ist mehr das fehlende Bewusstsein über unsere Macht. Wir sollten nicht denken »Ich habe nichts Böses getan«, sondern uns fragen »Was habe ich Gutes getan?«

Diese spontane Berührung als normaler Bestandteil unserer Pflege oder Behandlung sollte nicht unterschätzt werden. Patienten bemerken, wie sie angefasst werden. Auch ein einfaches Puls- oder Blutdruckmessen sind Rituale, die für viele Ärzte und Pflegende Routine sind. Patienten empfinden es oft mit Aufmerksamkeit als Berührung.

Durch Berührungen kommunizieren wir mit ihnen, wir zeigen Interesse und Respekt oder das Gegenteil davon. In bestimmten Situationen ist Berührung eine Wohltat, ein Beitrag zur Heilung oder zu einer Erhöhung der Lebensqualität. Eine heilsame Berührung kann gezielt eingesetzt werden, wie z. B.:

- Fußmassage,
- Haare waschen,
- Baden und Trocknen,
- einen Arm als Gehstütze anbieten,

- Hände, die sich berühren,
- eine Umarmung.

Diese »therapeutische« Berührung kann geplant oder spontan sein. Wichtige Voraussetzung ist die Akzeptanz des Patienten und unsere fachliche Kompetenz. Wie die Berührung durchgeführt wird, das richtige Maß an Respekt oder Vorsicht, ist entscheidend für die Wirkung.

Die meisten Berührungen erfolgen unbewusst und spontan. Teils ist es kulturell bedingt, auf welche Weise die Mitglieder einer Gruppe sich begrüßen und berühren. Jeder von uns hat eine soziale Prägung, die viel über unsere Kindheit und die Muster, die wir dort gelernt haben, aussagt. Hier kommt der frühkindlichen Berührung durch Mutter und Vater eine besondere Bedeutung zu. Auch spätere Erfahrungen tragen zum persönlichen Berührungsstil bei. Es ist leicht zu beobachten, wie einige häufig und spontan, andere selten und zögernd die Initiative zur Berührung ergreifen.

Es sind immer zwei Personen, die sich berühren. Das heißt, bei der Berührung ist die eigene Empfindlichkeit gegenüber der Bereitschaft und Reaktion des anderen für das Ergebnis maßgebend. In unserer heutigen multikulturellen Gesellschaft muss die Besonderheit der Kultur des Einzelnen berücksichtigt werden. Obwohl diese Empfindlichkeit ein Teil unserer Persönlichkeit ist, zählt es zu unseren beruflichen Aufgaben, behutsam vorzugehen. Die Patient-Helfer-Beziehung setzt voraus, dass wir uns dessen bewusst sind, welche Bedeutung es für den anderen haben kann, berührt zu werden, und wo die Grenze zwischen Nähe und Distanz, Respekt und Integritätsverlust verläuft.

Die Perspektiven sollten in unserer beruflichen Ausbildung theoretisch wie praktisch berücksichtigt werden. In einigen Berufsgruppen (Psychologen, Krankenschwestern) finden wir z. T. ein hohes Bewusstsein und berufsspezifische Regeln, die die Grenze zwischen einer respektvollen und integritätsverletzenden Berührung aufzeigen. Andere Berufsgruppen im Gesundheitswesen haben sich zu diesen Themen wenig Gedanken gemacht.

5.8.2 Psychische Nähe

Im Umgang mit Schwerkranken ist die körperliche Pflege und die Linderung von Schmerzen und »physischer« Symptome eine wichtige Aufgabe. Meistens haben wir ein Mandat, diese Aufgaben wahrzunehmen. Wie weit wir in unse-

rem Bestreben gehen, um gute Linderung zu erreichen, ist aber nicht immer klar definiert.

Noch weniger definiert ist unser Verhalten gegenüber den psychosozialen Problemen unserer Patienten. Welche Fragen dürfen wir über ihr Privatleben stellen? Wir halten es für selbstverständlich, offene Auskunft über Problemgebiete wie Lebenserfahrungen, Familienverhältnisse, Beruf, finanzielle Probleme, persönliche Beziehungen und Konflikte, Trauererlebnisse, Sexualität zu erhalten.

Oft ist diese Information eine Voraussetzung, um respektvoll mit Problemen und Möglichkeiten des Patienten umzugehen. Dabei dürfen wir nicht übersehen, wie selektiv jeder Mensch für sich mit diesen Informationen umgeht.

Wenn überhaupt, sind wir nur gegenüber engsten Freunden und Angehörigen bereit, Wunden, Krisen und Niederlagen zu beleuchten. Wir wollen selbst entscheiden, wann und wo wir darüber sprechen.

Die Voraussetzung für Offenheit über persönliche Fragen ist eine persönliche Beziehung. Die Beziehung zwischen Arzt oder Schwester einerseits und Patient und Angehörigen andererseits muss auf einer professionellen Grundlage ruhen. Nur in Ausnahmefällen werden wir in der Lage sein, wirklich persönliche Beziehungen zu den Patienten aufzubauen, und wenn dies der Fall ist, ist es nicht immer unproblematisch.

Persönliche Beziehungen zwischen Ehepartnern, Freunden, innerhalb einer Familie beinhalten nicht nur eine große Offenheit, sondern auch eine große Verletzbarkeit. Innerhalb der vertrauten Umgebung fließen Informationen und Kommentare über den Alltag und die Welt. Wir zeigen auch Reaktionen gegenüber anderen Mitgliedern der Familie. Hier können eigene Gedanken und Gefühle gezeigt werden. Nur in diesem engsten Kreis trauen wir uns, Konflikte, Wut, Kritik und Auseinandersetzungen auszutragen.

Zu Hause oder unter Freunden sind wir darauf vorbereitet. Wir besitzen hier die notwendige Erfahrung und sind trotzdem gegenüber denjenigen, die am meisten für uns bedeuten, sehr verletzbar. Diese Nähe und diese Verletzbarkeit sind die Grundlagen für Offenheit und innere Reife.

Im Gegensatz dazu werden nur selten Gefühle und Ängste in fremder Umgebung gezeigt. Zorn, Wut und Verzweiflung werden im engen Familienkreis gehalten. Diese Reaktionen brauchen wir, um mit dem Alltag zurechtzukommen. Fehlt dieser Schutz, wie in einem fremden Krankenhaus, besteht große Gefahr, dass unsere Integrität gekränkt wird.

Die Bewältigung früher erlebter Krisen und Konflikte trägt zu Gesundheit oder Krankheit bei, aber:

- Wollen wir über diese »Wunden« sprechen?
- Kann eine kritische Situation verstärkt werden, wenn jemand von außen in diese Wunde hineindrängt?
- Ist die Krankenschwester oder der Arzt kompetent als »Psychotherapeut«?
- Haben sie Zeit und Kraft, sich zu kümmern und uns beizustehen, wenn die offen gelegte Wunde uns zu vernichten droht?
- Sind sie bereit, unsere Verzweiflung und unseren Zorn zu ertragen?

Viele gut gemeinte Versuche, Konflikte bei den Patienten und ihren Familien zu lösen, führen zu einer Verstärkung dieser Probleme, weil es im Behandlungs- und Pflegeteam an psychotherapeutischer Kompetenz und Erfahrung fehlt.

Mit Menschenverstand und Lebenserfahrung können wir für schwerkranke Patienten gute Zuhörer sein. Wir können, wenn darum gebeten, Rat und Hilfe geben. Schwerkranke Patienten brauchen Mitmenschen, die darauf vorbereitet sind, auch Gefühle und Ängste zu ertragen. Sie wünschen sich Partner, zu denen sie über Gedanken und Ideen sprechen dürfen, in der Gewissheit, nicht unvorbereitet empfindliche Fragen zu erhalten.

Gute palliative Behandlung und Pflege sind nicht möglich ohne diese Voraussetzungen (Randall 1994).

Wünschenswert ist die regelmäßige Anleitung und Weiterbildung des Personals. Wenigstens ein Teammitglied sollte Kompetenz und Ausbildung in der Psychotherapie haben. Viele haben gute Erfahrungen mit regelmäßiger externer Supervision des Teams, in der psychosoziale Aspekte der Betreuung angesprochen werden. Wichtige Aspekte im Umgang mit Nähe und Distanz, Offenheit und Respekt können zur Sprache kommen.

5.8.3 Sexualität

David Roy, Herausgeber des *Journal of Palliative Care* und Professor für medizinische Ethik, machte in einem Plenumsvortrag auf der Weltkonferenz für Palliativmedizin in Montreal (Kanada) 1986 vor mehr als 1.500 internationalen Zuhörern folgende Aussage:

> Wir sagen so oft: wir verstehen. Aber verstehen wir wirklich? Sehen wir, welche Fragen für die Patienten wichtig sind? Ist es für uns ein wichtiges Anliegen, auch empfindliche Fragen zuzulassen? Viele hier im Saal betreuen sterbende Aids-Patienten. Kann es sein, dass die Sexualität für diese Patienten eine wichtige Frage ist? In meinen Augen sollte derjenige, der von einem Patienten Folgendes gefragt wird: »Kann ich heute Nacht meinen homosexuellen Freund nackt bei mir im Bett haben?« und bei der Beantwortung der Frage mit den Augenbrauen zuckt, sich selbst folgende Frage stellen: »Ist es Zeit für mich, einen neuen Beruf zu suchen?«

Sexualität ist für jeden privat und schwer ansprechbar. Für viele ist das Thema so privat, dass wir auch zu Hause Probleme haben, mit dem Partner darüber zu reden. Aber ist es deswegen unwichtig? Warum fehlt uns scheinbar die Phantasie zu denken, dass unsere Patienten ein Sexualleben haben?

Viele sagen, Sexualität ist eine private Angelegenheit, und deshalb müssen wir es den Patienten überlassen, diese Frage anzusprechen.

Damit haben sie nicht ganz Unrecht. Es wäre eine Katastrophe, wenn wir vor jeder Operation oder Untersuchung den Patienten intime Fragen stellen würden. Aber bei chronischen oder lebensbedrohlichen Erkrankungen des Patienten wäre eine Bereitschaft, diese Fragestellung zuzulassen, sehr begrüßenswert.

Nur wenige Patienten oder Angehörige kämen von sich aus, ohne unsere aktive Unterstützung, auf den Gedanken, dass es erlaubt sein könnte zu fragen: »Kann ich heute Nacht meine Frau nackt bei mir im Bett haben?«

Wer bei seiner Arbeit niemals diese Frage gehört hat, darf dadurch nicht in den Irrglauben fallen, sie wäre unwichtig. Sie sollten sich lieber selbst fragen, ob nicht persönliche Sperren vorhanden sind. Nur außerordentliches Vertrauen wird den Kranken ermöglichen, diese Fragen anzusprechen.

Ist es denkbar, dass der Arzt oder die Krankenschwester sich zu den Patienten setzt und die Möglichkeiten einer ungestörten Nähe zu seinen Angehörigen erläutert?

5.9 Seelsorge

Die meisten Menschen stellen sich in verschiedenen Lebensabschnitten existenzielle Fragen. Viele haben eine Religion. Einige glauben fest an ein

Die Bewältigung früher erlebter Krisen und Konflikte trägt zu Gesundheit oder Krankheit bei, aber:

- Wollen wir über diese »Wunden« sprechen?
- Kann eine kritische Situation verstärkt werden, wenn jemand von außen in diese Wunde hineindrängt?
- Ist die Krankenschwester oder der Arzt kompetent als »Psychotherapeut«?
- Haben sie Zeit und Kraft, sich zu kümmern und uns beizustehen, wenn die offen gelegte Wunde uns zu vernichten droht?
- Sind sie bereit, unsere Verzweiflung und unseren Zorn zu ertragen?

Viele gut gemeinte Versuche, Konflikte bei den Patienten und ihren Familien zu lösen, führen zu einer Verstärkung dieser Probleme, weil es im Behandlungs- und Pflegeteam an psychotherapeutischer Kompetenz und Erfahrung fehlt.

Mit Menschenverstand und Lebenserfahrung können wir für schwerkranke Patienten gute Zuhörer sein. Wir können, wenn darum gebeten, Rat und Hilfe geben. Schwerkranke Patienten brauchen Mitmenschen, die darauf vorbereitet sind, auch Gefühle und Ängste zu ertragen. Sie wünschen sich Partner, zu denen sie über Gedanken und Ideen sprechen dürfen, in der Gewissheit, nicht unvorbereitet empfindliche Fragen zu erhalten.

Gute palliative Behandlung und Pflege sind nicht möglich ohne diese Voraussetzungen (Randall 1994).

Wünschenswert ist die regelmäßige Anleitung und Weiterbildung des Personals. Wenigstens ein Teammitglied sollte Kompetenz und Ausbildung in der Psychotherapie haben. Viele haben gute Erfahrungen mit regelmäßiger externer Supervision des Teams, in der psychosoziale Aspekte der Betreuung angesprochen werden. Wichtige Aspekte im Umgang mit Nähe und Distanz, Offenheit und Respekt können zur Sprache kommen.

5.8.3 Sexualität

David Roy, Herausgeber des *Journal of Palliative Care* und Professor für medizinische Ethik, machte in einem Plenumsvortrag auf der Weltkonferenz für Palliativmedizin in Montreal (Kanada) 1986 vor mehr als 1.500 internationalen Zuhörern folgende Aussage:

von Geborgenheit und Frieden, von Aufgehobensein in einer höheren Ordnung.

In dem Nachwort zu seinem Buch *Ich und Du* schreibt Martin Buber 1957 (Ausgabe 1994):

> Man muss sich aber überhaupt davor hüten, das Gespräch mit Gott, das Gespräch, von dem ich in diesem Buch und in fast allen die darauf folgten, zu reden hatte, als etwas lediglich neben oder über dem Alltag sich Begebendes zu verstehen. Gottes Sprache an die Menschen durchdringt das Geschehen in der Welt um uns her, alles Biographische und alles Geschichtliche, und macht es für dich und mich zu Weisung, zu Forderung, Ereignis um Ereignis, Situation um Situation ist durch die Personsprache befähigt und ermächtigt, von der menschlichen Person Standhalten und Entscheidung zu heischen. Wir meinen gar oft, es sei nicht zu vernehmen, und haben uns doch vorlängst selber Wachs in die Ohren gesteckt.
>
> Die Existenz der Mutualität zwischen Gott und Mensch ist unbeweisbar, wie die Existenz Gottes unbeweisbar ist. Wer dennoch von ihr zu reden wagt, legt Zeugnis ab und ruft das Zeugnis an, zu dem er redet, gegenwärtiges und zukünftiges Zeugnis.

Die Hospizbewegung hat von Anfang an Seelsorge als eine wichtige Aufgabe angesehen. Hierbei wurde Seelsorge nicht nur im religiösen oder existenziellen Sinne gesehen.

Den besten Zugang zu den Patienten haben diejenigen, die sich täglich um sie kümmern und für die Pflege und Behandlung verantwortlich sind. Das betrifft die Angehörigen ebenso wie das Krankenpflegepersonal und die Ärzte, die für den Patienten zuständig sind.

Unheilbar krank mit begrenzter Lebenserwartung zu sein heißt, Abschied von Menschen nehmen zu müssen, die einem viel bedeuten. Es heißt aber auch, Abschied zu nehmen von dem Leben, das gelebt worden ist und den Lebensinhalt gegeben hat, von Orten, Gegenständen, Erinnerungen, Gewohnheiten, Körperfunktionen und Tieren. Der Patient wird mit den Lebensaufgaben konfrontiert, die gelungen sind, und den Narben, die entstanden sind. Verluste, die im Leben durchlebt wurden, werden in der Erinnerung wachgerufen.

Sowohl die Patienten als auch die Angehörigen sind oft überfordert, wenn sie diese Eindrücke allein bearbeiten sollen. Wir müssen ihnen mit Verständnis und Vertrauen begegnen. Dieses Verständnis setzt nicht nur Fachkenntnisse voraus, sondern auch das Vermögen, sich mit Empathie in die Lage des Patienten versetzen zu können.

Viele haben keine Schwierigkeiten zu trennen zwischen der Seelsorge, die sich auf die religiösen Fragen, Gedanken und Traditionen der Patienten bezieht, und derjenigen, die sich zwischenmenschlich aus der Lebenssituation ergibt. Wenn der Patient es wünscht, kann der Krankenhausseelsorger oder ein anderer »professioneller« Seelsorger für die religiösen Fragen gerufen werden.

Aber *alle* Patienten haben in den Grenzsituationen des Lebens das Bedürfnis, Probleme, Fragen, Befürchtungen, Gefühle und Ängste mit jemandem zu teilen. Diesen Dingen Raum zu geben, ist eine Aufgabe für alle, die diese Patienten betreuen, und dies ist unabhängig von deren religiösen Einstellungen.

Die Aufgabe von Ärzten und Schwestern ist, durch gute Kommunikation und Unterstützung diesen Prozess innerhalb der Familie und des sozialen Umfelds des Patienten zu ermöglichen. Darüber hinaus werden sie selbst als Gesprächspartner gefordert und zum Abladen von Problemen benötigt. Arzt zu sein heißt hier auch Seelsorger zu sein.

Die Aufgabe der Ärzte ist auf diesem Gebiet größer und wichtiger, als es ihnen bewusst ist. Weil sie während des Krankheitsverlaufs der Patienten die Rolle des Vermittlers von schlechten und guten Nachrichten hatten, haben sie Zugang zu ihnen und Kenntnisse über sie, die kein anderer besitzt. Auch wenn es immer wieder Zeiten geben kann, wo das Verhältnis zwischen Arzt und Patient angespannt ist, wird der betreuende Arzt immer eine besondere Bedeutung für den Patienten haben.

Nur derjenige, der das Selbstbild des Patienten verletzt oder zerstört hat – das passiert häufig bei der Mitteilung »schlechter Nachrichten« –, ist in der Lage, es zurückzugeben. Von Ärzten wird leider häufig unterschätzt, wie wichtig sie für den Patienten sind. Sie verzeihen uns, dass die Krankheit trotz unserer Bemühungen fortschreitet. Aber sie verzeihen uns nicht, wenn sie von uns allein gelassen werden.

Die britische und sehr gläubige Ärztin Sheila Cassidy widmet sich seit vielen Jahren der Hospizarbeit. In ihrem Buch *Die Dunkelheit teilen* (1995) schreibt sie:

Psychologische Arbeit mit Todkranken hat vieles mit anderen Formen der Beratung und Psychotherapie gemeinsam, doch die Beziehung verändert sich durch zwei Faktoren: Der erste ist die kurze Lebenserwartung des Klienten, der andere das Ausmaß des Verlustes, den er erleidet. Nach meiner Erfahrung, und ich bin weder Psychotherapeut noch ausgebildete Beraterin, haben Menschen, die auf den Tod zugehen, ein besonderes und dringendes Bedürfnis nach menschlicher Wärme und ehrlicher, direkter Kommunikation. Mein persönlicher Stil hat sich im Laufe meiner Arbeit auf diesem Gebiet entwickelt und ist von einem Maß an Direktheit und Informalität gekennzeichnet, der in der normalen medizinischen Praxis ungewöhnlich ist. Im Laufe von zehn Jahren bin ich von einer großen Schüchternheit, was körperliche Kontakte angeht, dazu übergegangen, es als ganz natürlich zu empfinden, Patienten die Hand zu halten oder sie an meiner Schulter weinen zu lassen: Ich finde, dass dieser körperliche Aspekt des Tröstens wie selbstverständlich aus einer ehrlichen Kommunikation über schmerzliche Wahrheiten hervorgeht und keineswegs von der Dauer der Beziehung abhängig ist.

Langsam lerne ich im Laufe der Jahre die Bedeutung der Machtlosigkeit kennen. Ich erfahre sie in meinem eigenen Leben, und ich erlebe mehr in meiner Arbeit. Das Geheimnis liegt darin, sich nicht vor ihr zu fürchten – nicht davonzulaufen. Die Sterbenden wissen, dass wir nicht Gott sind. Sie nehmen es hin, dass wir das Fortschreiten des Krebses nicht aufhalten können, den unaufhaltsamen Marsch jener schrecklichen Armee, die einen menschlichen Körper wie eine Besatzungsmacht überzieht und ohne Rücksicht und ohne Erbarmen plündert, vergewaltigt und schändet.

Alles, was sie von uns erwarten, ist, dass wir sie nicht im Stich lassen: Dass wir unsere Stellung am Fuße des Kreuzes halten. In diesem Stadium der Reise da zu sein, einfach zu sein: Das ist in vieler Hinsicht das Schwerste.

Seelsorge für diese Patienten bedeutet keineswegs, dass wir immer eine Lösung für die Probleme der Patienten bereit haben müssen. Für die meisten bedeutet es sehr viel, wenn jemand sich ein wenig Zeit nimmt, um zuzuhören, oder Anteilnahme zeigt. Diese menschliche Zuwendung zum Kranken ist auch »Seelsorge«. Das fruchtbare gemeinsame Schweigen ist von größerer Bedeutung, als wir uns vorstellen: Das bis zum Ende faktisch gelebte Miteinander mit dem Sterbenden, die Möglichkeit, dessen Ängste, dessen Traurigkeit, dessen Verzweiflung, aber auch dessen Hoffnungen mit ihm zu teilen.

Cicely Saunders hat sich besonders hervorgetan, weil ihr die Sorge um das Seelenwohl ihrer Patienten immer wichtig war. Das St. Christopher's Hospice hat auf diesem Gebiet den Maßstab gesetzt. Patienten, die früher das Gefühl hatten, »aufgegeben« zu sein, geben deutlich zu verstehen, dass sie die medizinische Kompetenz, die Fürsorge, Geborgenheit und Seelsorge im St. Christopher's Hospice besonders schätzen.

Hier liegt ein Grundstein des Hospizkonzeptes. Als Fürsprecher der Leidenden bedeutet es, dass Krankheiten mit Worten erklärt werden, die sie verstehen können, und dass man die Behandlung mit ihnen abspricht. Die Wahrung der Würde der Person und der Kontrolle über ihr Leben sind weitere wichtige Bausteine des Konzeptes.

Den Patienten nicht allein zu lassen, nicht im Stich zu lassen, wenn »nichts mehr gemacht werden kann« und wenn der letzte Weg bevorsteht, sich nicht wieder dazu verleiten zu lassen, doch noch etwas zu machen, sondern sich hinzusetzen und die gemeinsame Ohnmacht zuzulassen, sind Merkmale hospizlicher Fürsorge.

5.10 Der Augenblick des Todes – und die Rechte der Sterbenden

Beispiel aus der Praxis

Vor einigen Jahren wurde ich zu einem Konsilium gerufen. Es ging um eine schwerkranke 78-jährige Frau, die innerhalb der letzten drei Jahre zwei schwere Herzinfarkte erlitten hatte. Sie war im letzten Jahr viermal wegen dekompensierter Herzinsuffizienz stationär aufgenommen worden. Es bestand die Frage, ob jetzt eine Beatmungstherapie durchgeführt werden sollte. Die Frau war im kardiogenen Schock, nicht ansprechbar. Zwei erfahrene Internisten, die diese Patientin gut kannten und jetzt die Verantwortung für weitere Therapiemaßnahmen hatten, stimmten mit mir überein, dass diese Frau im Sterben lag und dass die Respiratortherapie lediglich das Sterben verlängern würde. Wir beschlossen, sie nicht zu intubieren. Uns war bewusst, dass sie so innerhalb der nächsten Stunden sterben würde.

Vier Stunden später war ich wieder auf dieser Abteilung, um eine andere Patientin zu besuchen. Jetzt sah ich, wie dieselbe Patientin, die zuvor von Ärzten und Krankenschwestern umringt war, verlassen hinter einem Schirmbett ihre letzten Atemzüge machte. Keiner war bei ihr, sie war schweißgebadet, bei hoher Atemfrequenz war ihr Todesrasseln über eine große Entfernung zu hören.

Warum musste diese Frau, die zuvor medizinisch und menschlich kompetent betreut wurde, so qualvoll allein sterben? War sie für uns nur von Bedeutung, solange wir dachten, wir können den Krankheitsverlauf beeinflussen?

Über die Jahre habe ich erlebt, dass dies keineswegs ein Einzelfall ist. Norbert Elias hat in einem eindrucksvollen Essay die Einsamkeit der Sterbenden in der heutigen Zeit beschrieben (Elias 1982). Viele sterben allein, aufgegeben und verlassen. Dies ist nicht nur eine Frage, wie Krankenhäuser oder Ärzte mit dem Tod umgehen, es zeigt, welchen Stellenwert wir Tod und Leiden in unserer Gesellschaft einräumen.

Dieses Jahrhundert ist gekennzeichnet durch zuvor undenkbare Fortschritte der Medizin. Wo die Ärzte früher machtlos waren, können heute eine Reihe diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen angeboten werden. Krankheiten können unter Kontrolle gehalten werden, die früher als unheilbar galten. Die bedeutenden Fortschritte, v. a. auf naturwissenschaftlichem Gebiet, haben der modernen Medizin einen neuen Inhalt und neue Strukturen gegeben.

In der Bevölkerung ist weitgehend das Gefühl entstanden, jede Krankheit könne geheilt oder unter Kontrolle gehalten werden. Unter den Ärzten ist die Einstellung verbreitet, dass es unsere Pflicht ist, alles zu unternehmen, um die Krankheit des Patienten zu bekämpfen. Dabei nimmt der Kampf um ausreichend Personal und Geld einen immer größeren Raum ein.

Trotz aller Fortschritte können wir nicht hoffen, dass die moderne Medizin uns vor Alter, Krankheit, Sterben und Tod bewahren wird. Wir können hoffen, einen friedvollen und würdevollen Sterbeprozess zu erleben, wo Schmerzen und Leid im Hintergrund stehen.

Die wichtigste Quelle für den Hospizgedanken ist ohne Zweifel in der Begegnung mit dem Tod zu finden. In unserer Geschichte, für Schriftsteller, Künstler, Philosophen und jeden Einzelnen ist der Tod eine bleibende Quelle, die Grundlage für Kultur und Religion. Wie wir mit dem werdenden und scheidenden Leben umgehen, sagt viel aus über die Reife unserer Kultur.

Die enormen Fortschritte der Diagnostik und Behandlung haben zunächst zu einer Verschlechterung und zunehmenden Vereinsamung der Sterbenden geführt. Die Ärzte zogen sich von den Sterbenden zurück, ein Phänomen, das uns bekannt ist aus früheren Jahrhunderten. Im Mittelalter war es wichtig für die Ärzte, dass sie nicht in Verruf kamen, Sterbende zu betreuen (Condrau 1991). Natürlich war für den Menschen die Entdeckung, dass sein Ende bevorsteht, stets ein unangenehmer Augenblick. Die Einsamkeit der Sterbenden

spiegelt eine allgemeine Entwicklung in unserer Gesellschaft, wo Tod und Sterben entfremdet werden.

Veränderungen in unserer Gesellschaft wurden durch die Entwicklung der Antibiotika und der großen Fortschritte in der Diagnostik und Therapie verstärkt. Das naturwissenschaftliche Wissen und die medizinische Ausbildung wurden jedes Jahr von neuen Kenntnissen überflutet. Die ärztliche Kunst, wie wir mit Patienten umgehen und kommunizieren und wie wir uns um den Menschen kümmern, der unheilbar krank ist, ging zunehmend verloren und wird nur selten im Medizinstudium angesprochen.

In der Mitte der 1950er Jahre wurde einer kleinen Gruppe von Medizinern, Soziologen und Psychologen klar, dass die Sterbenden die Verlierer gewesen sind bei der Entwicklung der naturwissenschaftlich orientierten modernen Medizin. Die zunächst kleine, aber wachsende Gruppe entwickelte ein Betreuungs- und Behandlungskonzept für diese »aufgegebenen« Patienten, das sich als notwendige Ergänzung innerhalb der etablierten Schulmedizin erwies. Es kann gesagt werden, dass die Hospizidee und die moderne Palliativmedizin sich aus den Defiziten der modernen Medizin entwickelt haben.

Vor ein paar Jahren hielt ich an einer deutschen Universitätsklinik vor ca. 200 Kollegen ein Referat zu diesem Thema. In der Diskussion nach der Vorlesung fragte ich, welche Möglichkeiten es in dieser Klinik für Angehörige gäbe, mit dem Verstorbenen allein zu sein. Die Antwort war, dass es dazu kaum Möglichkeiten gäbe. Selbst für Angehörige, die großen Wert auf eine solche Möglichkeit legten, wäre es schwierig, dies zu realisieren, und es würde davon abhängen, wie die Krankenzimmer belegt seien; evtl. müsste das Badezimmer dafür herhalten. Es gab an diesem Universitätsklinikum kein einziges Zimmer, in dem die Angehörigen Abschied von dem Toten nehmen konnten. Manchmal wurden die Angehörigen mit in den Leichenkeller genommen!

Obwohl es Krankenhäuser gibt, die ein Verabschiedungszimmer haben, bestehen im Gesundheitswesen große Probleme im Umgang mit dem Tod und mit der Leiche.

Beispiel aus der Praxis

Als ein kleines Kind unerwartet starb, beobachteten wir, dass der Vater den Körper des Kindes an seine Brust drückte und mit sich herumtrug. Er schien, als wäre es für ihn nicht möglich, sich von dem Kind zu trennen. Da nach einigen Stunden die Situation noch unverändert war, ging ich in das Zimmer und

fragte die Eltern, ob sie ihr totes Kind mit nach Haus nehmen wollten. Nach kurzer Beratung stimmten sie zu.

Der Vater hat mir später erzählt, dass er fast die ganze Nacht das Kind in seinen Armen gehalten hat, bevor es für ihn möglich war, es aus den Armen zu legen. Die Mutter sagte, sie bügelte am nächsten Morgen viele Hemden, bevor ein Hemd für ihr Kind schön genug war. Sie haben gemeinsam mit den Geschwistern das Kind am nächsten Vormittag gebadet, gewaschen und zurechtgemacht. Es wurde für Freunde und Familie am gleichen Tag eine Messe gehalten. Vier Tage später war das tote Kind im offenen Sarg zum Begräbnis in der Kirche aufgebahrt.

In den Gesprächen in den nächsten Wochen und Monaten unterstrichen die Eltern immer wieder, wie wichtig es für die Familie war, dass sie ausreichend Zeit zum Abschied bekommen hatten. Die Mutter machte dabei folgende Aussage:

Auch in der zweiten Nacht nach dem Todesfall ging ich 4- bis 5-mal zu dem verstorbenen Kind, weil ich nicht glauben konnte, dass es wirklich tot war. Wir haben Zeit gebraucht, private Zeit. Es war unser Kind. Dass dieses Kind tot sein sollte, war für uns unverständlich und unbegreiflich. Erst in den darauf folgenden Tagen haben wir zunehmend begriffen, was passiert war. Dabei war das tote Kind greifbar nahe; die entscheidende Voraussetzung, um das zu begreifen, war das greifbar tote Kind.

Inzwischen ist in einigen Krankenhäusern eine Änderung dabei zu beobachten, wie Krankenschwestern und Ärzte mit Toten umgehen. Die Angehörigen werden häufiger gefragt, ob sie im Zimmer bleiben wollen und bei der Versorgung helfen möchten. Oft bekommen Angehörige die Möglichkeit, mit dem Verstorbenen allein im Zimmer zu bleiben. Leider ist die Zeit oft sehr kurz, um sich von einem nahestehenden Menschen zu verabschieden. Die Angehörigen sollten selbst entscheiden dürfen, wann sie ausreichend Zeit mit dem Toten verbracht haben. Jedes Krankenhaus sollte in Zukunft ein Verabschiedungszimmer haben, um den Angehörigen diese Möglichkeit einzuräumen.

Am 10. Oktober 1948 wurden die Menschenrechte in einer Deklaration der vereinten Nationen festgehalten. Der Europarat verfasste am 4. November 1950 eine weiter gehende »Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten«, die 1953 in Kraft trat und von allen Mitgliedstaaten ratifiziert wurde. Sie ist rechtsverbindlich. Schließlich legte

der Europarat zwei Dokumente vor mit dem Titel *Die Rechte des Kranken und des Sterbenden* (1967), in welchen das Selbstbestimmungsrecht des Patienten als »fundamentales Menschenrecht« festgehalten wird (Condrau 1991).

Zu den fünf Rechten möchten wir eines hinzufügen – das Recht des Patienten, nicht allein sterben zu müssen. In vielen Situationen werden die Sterbenden, wie im ersten Beispiel in diesem Abschnitt, weggeschoben und allein gelassen. Es muss als fundamentales Menschenrecht gesehen werden, dass die Sterbenden in der letzten Phase ihres Lebens nicht von uns im Stich gelassen werden. Zum einen muss es unser Bestreben sein, den Angehörigen die notwendige Unterstützung anzubieten, damit sie in der Lage sind, in der letzten Zeit bei ihrem sterbenden Verwandten zu bleiben. Wo dies nicht möglich ist, müssen wir diese Aufgabe übernehmen.

Aus Berichten bekannte Situationen in Pflegeheimen oder Krankenhäusern, wo aus Personalmangel keine Zeit da ist, um Sterbende auf ihrem letzten Leidensweg zu betreuen, sind unwürdig und dürfen nicht akzeptiert werden.

Die sechs Rechte der Kranken und Sterbenden

1. Das Recht auf Freiheit (Annahme oder Ablehnung einer medizinischen Behandlung).
2. Das Recht auf persönliche Würde und Integrität (Diskretion).
3. Das Recht auf Information (Diagnose, Therapie, Prognose).
4. Das Recht auf angemessene Behandlung (auch in der menschlichen Betreuung).
5. Das Recht, nicht leiden zu müssen.
6. Das Recht, nicht allein sterben zu müssen.

»Recht« ist eine Option. Der Einzelne kann selbst entscheiden, ob er dieses Recht in Anspruch nehmen will oder darauf verzichten möchte. Diese Rechte müssen auch im Zusammenhang betrachtet werden. Ohne Information wird z. B. der Patient kaum in der Lage sein zu beurteilen, ob er eine Behandlung ablehnen soll oder nicht.

Diese Rechte sind in allen unterzeichneten Mitgliedsstaaten (auch in Deutschland) rechtsverbindlich. Das heißt, jeder Bürger in diesen Staaten hat einen Anspruch auf diese Rechte.

Neben den Rechten der Patienten gibt es das Recht der Angehörigen, den Toten, auch wenn der Verstorbene im Krankenhaus gestorben ist, mit nach Hause zu nehmen und dort bis zu 36 Stunden aufzubahren (Tausch-Flammer u. Bickel 1995). Nur eine kleine Anzahl von Familien macht von dieser Möglichkeit Gebrauch. Eine Ursache kann darin liegen, dass nur in Ausnahmefällen gefragt wird, ob die Angehörigen den Wunsch haben, von dem Toten zu Hause Abschied zu nehmen.

- Wann haben Sie das letzte Mal einen Angehörigen gefragt, ob er den Verstorbenen zu Hause aufbahren will?
- Welche Gründe haben Sie, diese Frage nicht zu stellen?

Und hier schließt sich der Kreis. Heute sterben mehr als 80% der Menschen in Deutschland in Krankenhäusern, Alters- oder Pflegeheimen. Oft ist die Familie nicht anwesend. Früher fand der Tod in der Familie statt, und darunter waren sehr viele Kinder, vor 1920 mehr als 50%! Das heißt, dass damals jede Familie, jeder Erwachsene und jedes Kind, einen Sterbenden und einen Toten gesehen hatte.

Aus verschiedenen Gründen ist der Tod in unserem Jahrhundert unsichtbar gemacht worden.

Unsere Kinder erleben den Tod durch die Medien, wo die Katastrophen, Unfälle, Überfälle und Morde geschildert werden. Es gehört zu den Ausnahmen, dass sie dabei sind, wenn Angehörige sterben. Sie erleben dadurch nicht die letzte Zeit der Eltern, Großeltern oder anderer Verwandten als würdevoll und friedlich. Sie bekommen dabei nicht die Erfahrung, die sie brauchen, um uns ein würdevolles Sterben, falls möglich zu Hause, zu ermöglichen.

Welche Bedeutung diese scheinbar unüberbrückbare Distanz zum Tod für uns und unsere Verwandten haben kann, erleben wir täglich im Umgang mit den Hinterbliebenen.

»Ich verstehe nicht, warum keiner mit meinem Mann und mir darüber gesprochen hat, dass wir nur noch kurze Zeit hatten. Wir hatten noch so viel zu besprechen. Ich und die Kinder würden alles dafür geben, wenn er in seinen letzten Wochen von uns zu Hause gepflegt worden wäre, statt dieser Kälte im Krankenhaus. Als er tot war, wurde er fast mit Gewalt von uns gerissen und in den Keller geschoben, bevor wir Abschied nehmen konnten.«

Diese Worte einer Witwe sind symptomatisch für die Erfahrungen vieler Hinterbliebener.

Diese fehlende Wahrnehmung ist nicht nur ein Problem für die Angehörigen nach einem Todesfall. Die moralischen, ethischen, religiösen, menschlichen und kulturellen Grundwerte in unserer Gesellschaft bauen auf eine andauernde Auseinandersetzung mit der menschlichen Sterblichkeit auf. Wenn diese Auseinandersetzung ausbleibt, folgt schnell ein moralischer und sittlicher Verfall. Diese Entwicklung zu Materialismus ist in unseren Ländern im letzten Jahrhundert parallel zu einem zunehmenden Abstand zum Tod zu beobachten. Wurde der Tod verdrängt, um uns nicht in unserer von fehlenden Werten und materiellen Sammelmanien geprägten Existenz zu stören?

Abschied zu nehmen und sich von einem nahestehenden Menschen zu trennen, gehört zu den schwierigsten, aber großen und wertvollsten Aufgaben der Menschen. Sich Zeit zu geben, Gefühle und Schwächen zuzulassen und sich mit den Folgen des Todes eines Nahestehenden auseinanderzusetzen, sind Voraussetzungen, diesen Anforderungen gerecht zu werden.

Diese Aufgaben wurden von Anfang an von Cicely Saunders und ihren Kollegen in den Hospizen wahrgenommen. Der wiedergewonnene Blick für die Bedeutung des Todes und die Würde von Sterbenden ist der reiche Inhalt der Betreuungskonzepte und der Behandlungsphilosophie der Palliativmedizin.

Philipp Aries, der bedeutende französische Historiker und Soziologe, hat eine Studie zur Geschichte des Todes veröffentlicht (Aries 1981). Sein Schlusswort beendet er mit folgendem Kommentar:

> Was macht man dann mit dem Tod? Auf diese Frage gibt die Gesellschaft heute zwei Antworten, eine banale und eine aristokratische. Die erste ist ein massives Eingeständnis der Ohnmacht: nur ja nicht die Existenz eines Skandals zugeben, den man nicht hat verhindern können, lieber so tun, als gäbe es ihn gar nicht, und folglich die Umgebung der Sterbenden und der Toten mitleidlos zum Verstummen bringen. So hat sich ein dumpfes Schweigen über den Tod gebreitet. Wenn es gebrochen wird, wie heute gelegentlich in Nordamerika, so lediglich, um den Tod auf die Bedeutungslosigkeit eines beliebigen Ereignisses zu reduzieren, von dem man gleichgültig und unbeteiligt zu sprechen vorgibt. Das Resultat ist in beiden Fällen das gleiche:
>
> Weder das Individuum noch die Gemeinschaft sind stark und stabil genug, den Tod anzuerkennen.
>
> Gleichwohl hat diese Einstellung weder den Tod noch die Todesangst ausgelöscht. Im Gegenteil, sie hat, unter der Maske der medizinischen Tech-
>
> ▼

nik, die alten Wildheits- und Grausamkeitsvorstellungen unmerklich wieder Fuß fassen lassen. Der Tod im Krankenhaus, der bewusstlos an Schläuchen und Drähten hängende Moribunde wird heute immer mehr zum volkstümlichen Bild, das schreckenerregender ist als der »transi« oder das Skelett der makabren Rhetorik. Eine Korrelation zwischen der »Ausbürgerung« des Todes als dem letzten Schlupfwinkel des Bösen und der Rückkehr dieses wieder grausam gewordenen Todes beginnt sich abzuzeichnen. Und sie überrascht uns auch nicht mehr: Der Glaube an das Böse war notwendig gewesen, um den Tod zu zähmen. Die Abschaffung des Bösen hat den Tod in den Zustand der Wildheit zurückversetzt.

Dieser Widerspruch hat eine kleine Elite von Anthropologen mobilisiert, eher Psychologen und Soziologen als Mediziner und Geistliche. Sie schlagen vor, den Tod weniger zu »evakuieren« als, wie sie es nennen, zu »humanisieren«. Sie möchten festhalten an einem notwendigen Tod, der jedoch akzeptiert und nicht mehr schambesetzt sein soll. Auch wenn sie dabei auf alte Volksweisheiten Bezug nehmen, geht es ihnen keineswegs darum, in die Vergangenheit zurückzugreifen und das ein für allemal begrabene Böse wieder hervorzuholen. Man ist immer noch darauf aus, den Tod mit dem Glück zu versöhnen. Er soll lediglich zum diskreten, aber würdigen Ende eines befriedigten Lebens werden, zum Abschied von einer hilfreichen Gesellschaft, die nicht mehr zerrissen, noch allzu tief erschüttert wird von der Vorstellung eines biologischen Übergangs ohne Bedeutung, ohne Schmerz noch Leid und schließlich auch ohne Angst.

Die Betrachtungen von Aries sind auch heute zutreffend. Sie beschreiben deutlich die Kluft in der Gesellschaft und in der modernen Medizin gegenüber der Existenz des Todes. Sie sollte in Zukunft doch Hoffnung geben, weil sie eine geeignete Basis herstellt für die notwendige Diskussion, wie wir den Tod wieder sichtbar machen können in unserem Leben und wie wir im Gesundheitswesen uns dazu einstellen sollen.

Das Hauptproblem hierbei ist vielleicht weniger der Umgang der Ärzte und Krankenschwestern mit dem Tod, sondern wie wir in der Gesellschaft insgesamt diese Frage bewerten. Die oben beschriebene Universitätsklinik ohne Räumlichkeiten für Angehörige und Verstorbene nach einem Todesfall ist ein Armutszeugnis für die Gesellschaft. Wir wollten lange den Tod nicht und dachten möglicherweise, wir würden damit zurechtkommen können.

Wir im Gesundheitswesen müssen erkennen, wieviel Macht wir besitzen. Wir haben die Macht über Diagnostik, Therapie und Informationen, bis jemand gestorben ist. Nach dem Todesfall haben wir die Macht über Informationen und den Körper des Verstorbenen (die Leiche – dieses Wort verwenden wir nur ungern). Das Sterben und der Tod sind grundlegend keine Aufgabe für das Gesundheitswesen. Beim Sterben erlischt unsere Aufgabe gegenüber den Verstorbenen. Aber wir haben sehr häufig den Schlüssel zu der Situation, weil der Tote sich im Krankenhaus befindet (unser »Besitz« ist) und wir darüber entscheiden, wie, wo und wie lange die Angehörigen zu dem Verstorbenen Zugang haben. Der Beginn und das Ende des Lebens sind Schlüsselpunkte der menschlichen Existenz, für viele heilige Augenblicke.

Wir können zu den Angehörigen sagen:

»Ihre Mutter ist tot. Sie liegt hier in unserem Verabschiedungszimmer. Sie können bei ihr bleiben, so lange Sie wollen. Wir würden empfehlen, dass Sie Ihre anderen Angehörigen benachrichtigen, damit sie kommen können. Wir wissen aus Erfahrung, dass es auch für Kinder wichtig ist, diese Möglichkeit wahrzunehmen und Abschied zu nehmen.«

Meistens fehlt uns der Blick, um zu verstehen, wie »privat« das Sterben ist.

Beispiel aus der Praxis

Nach einem Busunglück in Norwegen, wo Schüler aus Schweden einen Klassenausflug nach Bergen machten, sind 13 Kinder und 3 erwachsene Begleiter gestorben. Wir standen im Krankenhaus nach dem Unglück vor der Frage, ob die aus Schweden anreisenden Angehörigen die toten und teils sehr verunstalteten Kinderleichen sehen sollten. Die Meinungen unter den »Fachleuten« gingen weit auseinander. Zuletzt wurde doch beschlossen, diese Entscheidung den Angehörigen selbst zu überlassen.

Eine Mutter hat mir nochmals zeigen können, wie begrenzt unser Horizont vor diesen Fragen sein kann. Ihre verstorbene Tochter, 12 Jahre alt, war vom Unglück sehr entstellt. Ich erklärte der Mutter, was sie zu erwarten habe, und beschrieb u. a. die schweren Kopfverletzungen. Dabei fragte ich, ob sie nicht lieber darauf verzichten wolle, sie anzusehen, und vielleicht nur die Hand der Tochter halten wolle. Sie sagte, es sei ihre Tochter, sie wolle sie sehen. In den darauf folgenden Minuten wurde mir zunächst klar, dass ich sie vor dieser Besichtigung hätte schützen sollen. Sie brach restlos zusammen. Nach etwa zehn Minuten drehte sie sich um und stellte mir folgende Frage:

»Siehst du, wie schön sie ist?«

Wieder musste ich einsehen: Ich hatte nicht die Voraussetzung verstehen zu können, wie schön dieses Mädchen war oder wie wichtig diese Minuten für die Mutter waren. Ich war nicht die Mutter.

Im Umgang mit Sterbenden, mit dem Tod, mit Verstorbenen und Hinterbliebenen ist es hilfreich, dass wir gute fachliche Voraussetzungen haben. Aber unsere Fachkompetenz ist nichts wert, wenn wir nicht gleichzeitig vor Augen haben, welche enorme Kraft und Bedeutung diese Fragen für die Betroffenen haben und dass sie, nicht wir, die Hauptpersonen sind. Hier ist v. a. die menschliche Kompetenz gefragt, die Fähigkeit, offen zu sein, wie oft nur Kinder es sein können.

Beispiel aus der Praxis

Vor einigen Jahren wurde ich von den Eltern eines schwerkranken Kindes angerufen. Die Mutter sagte: »Wir wissen, dass er nicht mehr lange leben wird, aber wir wagen nicht, dies anzusprechen.« Wir vereinbarten, dass ich am nächsten Abend vorbeikommen würde.

Der sterbende Junge war acht Jahre alt. Seine neurologische Grunderkrankung hatte dazu geführt, dass er seit mehreren Jahren bettlägerig und seit einem Jahr blind war.

Zuerst habe ich mit den Eltern im Wohnzimmer bei einer Tasse Kaffee zugehört und einige Fragen mit ihnen erörtert. Als wir zu dem Jungen gehen wollten, ging der vierjährige Bruder zuerst. Er setzte sich an die Bettkante, nahm die Hand des Kranken und sagte:

»Du, Nils, wenn der Jesus jetzt kommt, um dich zu holen, wie kommst du in den Himmel hinein? Hat er eine Leiter bei sich?«

Die beiden Brüder sprachen dann in unserer Anwesenheit mehrere Minuten. Sowohl der sterbende Junge als auch sein Bruder zeigten, dass sie nicht das erste Mal ein Gespräch über den bevorstehenden Tod führten. Wieder einmal hatten wir »Erwachsenen« die Möglichkeit, von Kindern zu lernen.

Die Fragen, die jeder von uns zulassen sollte, sind etwa:

- Wo und auf welche Weise können wir mit unseren Kindern das Leben der Alten, der Einsamen und der Sterbenden kennen lernen?
- Wo dürfen sie Abschied nehmen, wenn jemand gestorben ist?
- Wenn unsere Kinder es nicht von uns lernen, wie sollen sie sich dann um uns kümmern, wenn es soweit ist?
- Sollten wir nicht mit gutem Beispiel vorangehen?

- Ist es möglich, dass ich meine Mutter oder meinen Vater in der letzten Zeit zu Hause versorge?
- Wenn es nicht möglich ist, wie kann ich dazu beitragen, dass der Abschied von dem Kranken und von dem Verstorbenen würdevoll in Erinnerung bleibt?

Literatur

American Medical Association Council on Ethical and Judicial Affairs (1994) Ethical issues in health care system reform – The provision of adequate health care. JAMA 272: 1056–1062

Aries P (1981) Studien zur Geschichte des Todes. Deutscher Taschenbuch Verlag, München (Reihe Wissenschaft Nr. 4369)

Barinaga M (1989) Can psychotherapy delay cancer death? Science 246: 448–449

Barnard D (1988) Love and death: Existential dimensions of physicians' difficulties with moral problems. J Med Phil 13: 393–409

Barnard D (1995) The promise of intimacy and the fear of our own undoing. J Palliat Care 11: 22–26

Bates T et al. (1993) A statement of assumptions and principles concerning psychological care of dying persons and their families. J Palliat Care 9: 29–32

Beck-Friis B (1993) Hospital-based homecare of terminal ill cancer patients. The Motala Model. Uppsala University (Comprehensive summaries of Uppsala dissertations from the Faculty of Medicine 309)

Bendiksen R, Fulton R (1975) Death and the child: A retrospective test of the childhood bereavement and later behaviour disorder hypothesis. Omega 6: 45–59

Bennet G (1987) The wound and the doctor. Warburg, London

Bifulco AT, Brown GW, Harris TO (1987) Childhood loss of parent, lack of adequate parenteral care and adult depression: a replication. J Affect Disord 12: 115–128

Bolund C (1985) Suicide and cancer: II. Medical and care factors in suicide by cancer patients in Sweden 1973–1976. J Psychosoc Oncol 3: 17–30

Bowlby J (1980) Loss, anxiety and depression. Hogarth Press, London

Breitbart W, Passik S (1994) Psychiatric aspects of palliative care. In: Doyle D, Hanks J, MacDonald N (eds) Oxford Textbook of Palliative Medicine. Oxford Univ Press, Oxford, pp 609–626

Brent DA (1989) An outbreak of suicide and suicidal behaviour in a high school. J Am Acad Child Adol Psychiatry 28: 918–924

Brice CW (1982) Mourning throughout the life cycle. Am J Psychoanal 42: 315–325

Brown JH, Henteleff P, Barakat S, Rowe JR (1986) Is it normal for terminally ill patients to desire death? Am J Psychiatry 143: 208–211

Bruera E, Miller L et al. (1992) Cognitive failure in patients with terminal cancer; a prospective study. J Pain Symptom Manage 7: 192–195

Bruera E (1994) Ethical Issues in palliative care research. J Palliative Care 10/3: 7–9

Buber M (1965) The knowledge of man. Harper & Row, New York, p 85

Buber M (1994) Ich und Du. Reclam, Frankfurt am Main

Bukberg J, Penmann D, Holland J (1984) Depression in hospitalized cancer patients. Psychosom Med 43: 199–212
Callahan D (1991) Medical futility, medical necessity: the problem without a name. Hastings Center Report 21: 30–35
Casileth BR, Lusk EJ, Miller DS, Brown LL, Miller C (1985) Psychosocial correlates of survival in advanced malignant disease. N Engl J Med 312: 1551–1555
Cassell EJ (1982) The nature of suffering and the goals of medicine. N Engl J Med 306: 639–645
Cassidy S (1995) Die Dunkelheit teilen. Herder, Freiburg i. Br.
Condrau G (1991) Der Mensch und sein Tod. Kreuz, Zürich, S 413
de Conno F, Saita L, Ripamonti C, Ventafridda V (1993) On the »last days of life«. J Palliat Care 9: 47–49
Derogatis IR et al. (1983) The prevalence of psychiatric disorders among cancer patients. JAMA 249: 751–757
Devaul RA, Zisook S (1976) Unresolved grief. Postgrad Med 59: 267
Dyregrov A (1989) Sorg hos barn. En håndbok for voksne. Sigma, Bergen/Norway
Earls F, Smith E, Reich W, Jung KG (1988) Investigating psychopathological consequences of a disaster in children. J Am Acad Child Adol Psychiatry 27: 90–95
Elias N (1982) Über die Einsamkeit des Sterbenden. Suhrkamp, Frankfurt am Main (Bibliothek Suhrkamp)
Fainsinger R, Tapper M, Bruera E (1994) A perspective on the management of delirium in terminally ill patients on a palliative care unit. J Palliat Care 9/3: 4–8
Fainsinger R, Bruera E (1994) Management of dehydration in terminally ill patients. J Palliat Care 10: 55–59
Fallowfield L (1997) Truth sometimes hurts, but deceit hurts more. In: Surbone A, Zwitter M (eds) Communication with the cancer patient. Information and truth. Ann N Y Acad Sci 809: 525–537
Farberow NL, Schneidman ES, Leonard CV (1963) Suicide among general medical and surgical patients with malignant neoplasmas. US Veterans Adm., Washington/DC (Medical Bulletin 9)
Freud S (Ausg 1982) Trauer und Melancholie. In: Die Freud Studienausgabe 1969–1979, Bd III, S 193—213. Fischer Taschenbuchverlag, Frankfurt am Main
Fulton R (1970) Death, grief and social recuperation. Omega 1: 27
Ganz PA, Lee JJ, Siau J (1991) Quality of life assessment: an independent prognostic variable for survival in lung cancer. Cancer 67: 3131–3135
Glick IO, Weiss RS, Parkes CM (1974) The first year of bereavement. Wiley, New York, p 256
Goodwin JS, Hunt WC, Key CR, Samet JM (1987) The effect of marital status on stage, treatment, and survival of cancer patients. JAMA 258: 3125–3130
Gray RE (1987) Adolescent response to the death of a parent. J Youth Adol 16: 511–525
Guze S, Robins E (1970) Suicide and primary affective disorders. Br J Psych 117: 437–438
Häggmark C, Theorell T, Ek B (1987) Coping and social activity patterns among relatives of cancer patients. J Soc Sci Med 25: 1021–1025
Hinton J (1980) Whom do patients tell? BMJ 281: 1328-1330
Holland JC, Rowland J (eds) (1989) Handbook in psychooncology: Psychological care of the patient with cancer. Oxford Univ Press, New York

Husebø S (1997) Communication, autonomy and hope. How can we treat serious ill patients with respect? In: Surbone A, Zwitter M (eds) Communication with the cancer patient. Information and truth. Ann N Y Acad Sci 809: 440–460
Jecker NS, Pearlman RA (1992) Medical futility: Who decides? Arch Intern Med 152: 1140–1144
Johansson L (1991) Caring to the next of kin. On informal care of the elderly in Sweden. Uppsala Universitet (Akademiska Avhandling 330)
Kalish RA (1981) Death, grief and the caring relationships. Brooks/Cole, Monterey/CA
Kearney M (1992) Palliative medicine – just another specialty? Palliat Med 6: 39–46
Kovacs M, Beck AT, Weissman A (1975) Hopelessness: An indication of suicidal risk. Suicide 5: 98–103
Lamerton R (1991) Sterbenden Freund sein. Herder, Freiburg i. Br (Spektrum 4004)
Lichter I, Hunt E (1990) The last 48 hours of life. J Palliat Care 6: 7–15
Lichtman RR et al. (1984) Relations with children after breast cancer: the mother-daughter relationship at risk. J Psychosoc Oncol 2: 1–9
Lipowski ZJ (1987) Delirium (acute confusional states). JAMA 285: 1789–1792
MacDonald N (1995) Suffering and dying in cancer patients. Western J Med 163: 278–286
Massie MJ, Holland JC (1990) Depression and the cancer patient. J Clin Psych 51 (Suppl): 12–19
Massie MJ (1989) Anxiety, panic and phobias. In: Holland JC, Rowland J (eds). Handbook in psychooncology: Psychological care of the patient with cancer. Oxford Univ Press, New York, pp 300–309
Mor V (1986) Assessing patient outcomes in hospice: what to measure? In: Psychosocial assessment in terminal care. Haworth, New York
Mor V (1987) Cancer patients quality of life over the disease course: lessons from the real world. J Chronic Dis 40: 535–544
Mount B (1986) Dealing with our losses. J Clin Oncol 4: 1127–1134
Müller M, Schnegg M (2000) Unwiederbringlich – Vom Sinn der Trauer. 3. Auflage, Herder-Verlag, Freiburg
Nagy M (1948) The child's theories concerning death. J Genet Psychol 73: 3–27
Oates MD (1993) Death in a school community. A handbook for counselors, teachers and administrators. American Counseling Association, Alexandria/VA
Parkes CM (1972) Bereavement. Studies of grief in adult life. Tavistocks, London
Parkes CM (1980) Beravement counseling: Does it work? Br Med J 281: 3–6
Pera H (1995) Sterbende verstehen. Herder, Freiburg i. Br.
Piaget J (1964) Six études de psychologie. Gonthier, Paris
Randall F, Downie RS (1996) Palliative care ethics. A good companion. Oxford Medical Publ, Oxford
Rando TA (1983) An investigation of grief and adaption in parents whose children have died from cancer. J Pediatr Psychol 8: 3–20
Rando TA (1984) Grief, dying and death. Research Press, Champaign/IL
Rando TA (1986) The parenteral loss of a child. Research Press, Champaign/IL
Razavi D, Delvaux N, Farvacques C (1990) Screening for adjustment disorders and major depressive disorders in cancer in-patients. Br J Psychol 156: 79–83
Satir S (1972) Peoplemaking. Science & Behavior Books, Palo Alto/Ca

Soelle D (1975) Suffering. Philadelphia Fortress Press, Philadelphia, p 76
Silberfarb PM, Maurer LH, Cronthamel CS (1980) Psychosocial aspects of breast cancer patients during different treatment regimens. Am J Psychiatry 137: 450–455
Slevin M, Subbs L, Plant H et al. (1990) Attitudes to chemotherapy: comparing views of patients with cancer with those of doctors, nurses, and general public. Br Med J 300: 1458–1460
Smith GP (1995) Restructuring the principle of medical futility. J Palliat Med 11/3: 9–16
Spiegel D, Bloom JR, Kraemer HC, Gottheil E (1989) Effect of psycho-social treatment on survival of patients with metastatic breast cancer. Lancet II: 888–891
Spurrel MT, Creed FH (1993) Lymphocyte response in depressed patients and subjects anticipating bereavement. Br J Psychyatry 162: 60–64
Stedeford A (1984) Facing death: patients, families and professionals. Heinemann, London
Stehbens JA, Lascari AD (1974) Psychological follow up of families with childhood Leukemia. J Clin Psychol 30: 394–397
Stephenson JS (1994) Grief and mourning. In: Fulton R, Bendiksen R (eds) Death and identity. Charles Press, Philadelphia, pp 136–177
Stroebe W, Stroebe WS (1987) Bereavement and health. Cambridge Univ Press, Cambridge
Tausch-Flammer D, Bickel L (1995) Wenn ein Mensch gestorben ist – wie gehen wir mit dem Toten um? Herder, Freiburg i. Br.
Trijsburg RW, Knippenberg FCE, Rijpma SE (1992) Effects of psychosocial treatment on cancer patients: a critical review. J Psychosom Med 54: 489–517
Twycross R (1993) Symptom management. The problem areas. Palliat Med 7: 1–8
Twycross R (1995) Introducing palliative care. Radcliffe, Oxford
Younger SJ (1988) Who defines futility? JAMA 260: 2094–2095
Vachon MLS, Lyall WAL, Rogers J, Freeman SJJ (1980) A controlled study of self-help intervention for widows. Am J Psychiatry 137: 1384
Vachon MLS (1987) Occupational stress in the care of the critically ill, the dying and bereaved. Hemisphere Publ, New York
Vanier J (1970) Tears of silence. Griffen House, Toronto, p 40
Weisman AD, Worden JW (1976) The existential plight in cancer. Significance of the first 100 days. Int J Psychol Med 7: 1–15
Weisman AD (1989) Vulnerability and the psychological disturbances of cancer patients. Psychosomatics 30: 80–85
Weller EB, Weller RA, Fristad MA, Cain SE, Bowes JM (1987) Should children attend parents funeral? J Am Acad Child Adol Psychiatry 27: 559–562
Welu TC (1975) Presenting pathological bereavement. In: Schoenberg B et al. (eds) Bereavement: its psychological aspects. Columbia Press, New York
Wilber K (1988) On being a support person. J Transperson Psychol 20: 141–159
Wilson SA (1992) Family as caregivers. Hospice home care. Fam Commun Health 15: 74–77
Worden JW (1982) Grief counseling and grief therapy: A handbook for mental health practitioner. Springer, New York Berlin Heidelberg
Wortman CB (1984) Social support and the cancer patient. Cancer 53: 2339–2362
Younger SJ (1988) Who defines futility? YAMA 260: 2094–2095
Yule W, Williams RM (1990) Post traumatic and stress reactions in children. J Trauma Stress 3: 279–295

6 Palliativmedizin in der Geriatrie

Wie alte, schwerkranke Menschen leben und sterben

B. Sandgathe Husebø

Ich habe mich bewusst der Versorgung von
Tumorpatienten gewidmet.
Ich wusste, dass es mir nicht gelingt,
die Misere in der Versorgung unserer
alten Mitbürger aufzugreifen.
Das Problem ist mir zu groß gewesen.
(Cicely Saunders 1999)

6.1 Sterben im hohen Alter – früher und heute

In den anerkannten internationalen Lehrbüchern der Geriatrie und der Palliativmedizin ist ein zunehmendes Interesse an der Palliativversorgung alter Menschen zu verzeichnen. Diese erfreuliche Tendenz spiegelt sich ebenfalls in den Schwerpunkten internationaler Artikel wider. Die frühere Annahme, bei einem alten handele es sich in der Regel um einen »lebenssatten Menschen, der symptomarm und ohne lebensbedrohliche Erkrankung keiner palliativmedizinischen Betreuung bedürfe«,scheint weitgehend widerlegt (Wilmsen-Neumann et al. 2002, Husebø et al. 2005). Der erste Schritt eines noch sehr langen Weges ist getan. Erst jetzt beginnt die eigentliche Arbeit, durch engagierten und kompetenten Einsatz dazu beizutragen, dass alle alten Menschen einen guten Lebensabend erwarten dürfen.

Palliative Care oder Hospice Care entstanden als ein besonderer Betreuungsansatz für schwerkranke und sterbende Krebspatienten, deren Erkrankung nicht geheilt werden konnte. In den vergangenen Jahren wurde diese Beschränkung auf Krebspatienten in zahlreichen internationalen Gremien der Palliative Care diskutiert. Inzwischen herrscht Einigkeit darüber, dass die großen Fortschritte der Palliativmedizin nicht nur schwerkranken Tumorpatienten, sondern auch anderen Patientengruppen zugute kommen sollten.

> Warum musste Vater (und Mutter) unnötig und unendlich leiden? Glauben wir, dass Patienten mit Demenz keine Schmerzen haben, weil sie Schmerzen nicht beschreiben können?

Dies schrieb eine erfahrene britische Ärztin in der Zeitschrift *Palliative Medicine* (Asolon 1998), nachdem ihr Vater in einem Pflegeheim verstorben war. Auch in Großbritannien, dem Mutterland der Palliative Care, leiden alte Patienten unter fehlender palliativmedizinischer Versorgung, und medizinische Fachartikel warnen davor, dass die Beschränkung palliativmedizinischer Angebote auf bestimmte Patientengruppen die Probleme der Alten insgesamt verstärken kann. Alte Menschen, die wenig Hilfe von Angehörigen bekommen, sind oft zu einer Selbstversorgung nicht in der Lage. Im Vergleich zu Patienten, die in jüngeren Jahren sterben und daher seltener an chronischen Erkrankungen leiden, ist die Fürsorge für sie um ein Vielfaches schlechter und seltener ihren Bedürfnissen angemessen. Ihre Probleme werden zusätzlich durch die Angebote der Palliativmedizin verstärkt, die nur für andere gelten, für sie aber nicht aktuell sind (Anderson 1997).

Der Anteil alter Menschen in der Bevölkerung hat sich im letzten und in diesem Jahrhundert dramatisch verändert. Im Jahr 1920 lag das durchschnittliche Lebensalter in Nordeuropa bei 50 Jahren. Ein großer Teil derer, die starben, waren Kinder oder Jugendliche. Etwa 80% der Menschen starben zu Hause.

Noch deutlicher wird diese dramatische Änderung von Leben und Sterben in einer vergleichenden Berliner Statistik mit Daten von 1775 und 1975 (◘ Abb. 6.1; Winau et al. 1984). Die Situation in Berlin zeigt, wie sich die Altersverteilung und das Sterbealter in Europa in den letzten zwei Jahrhunderten entwickelt haben. 1775 waren 60% der Verstorbenen jünger als 10 Jahre, und nur 13% der Verstorbenen waren über 60 Jahre; 1975 waren 89% über 60 Jahre alt. In der heutigen Zeit können die meisten von uns erwarten, 80 Jahre oder älter zu werden, und die Mortalität bei Kindern und Jugendlichen beträgt weniger als 2% (United Nations Common Database). Es ist anzunehmen, dass in Europa bis zum Jahr 2050 der Anteil der Personen über 65 Jahre um 64% ansteigen wird, der Anteil der über 80-Jährigen um 100%, und der Anteil der über 90- bis 100-Jährigen wird sich mehr als verzehnfachen. In dieser Zeit wird die absolute Bevölkerungszahl stagnieren oder sich verringern. Mit einer Bevölkerungsreduktion von zu erwartenden 15–50% ab

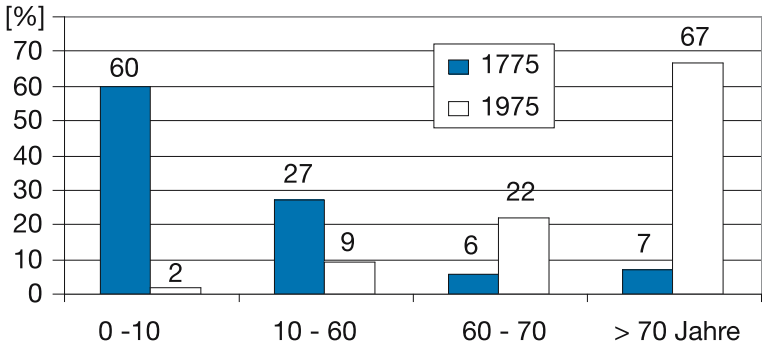


Abb. 6.1. Todesfälle – Altersverteilung in Berlin 1775 und 1975

dem Jahr 2020 werden die dramatischsten Prognosen für Süd- und Osteuropa ausgesprochen (Østby 2004).

Der Anteil berufstätiger Personen zwischen 55 und 65 Jahren ist am höchsten auf Island (91%) und in Norwegen (83%). Andere Länder haben weitaus weniger ältere Menschen in Arbeit, wie z. B. Deutschland (43%) und Österreich (34%). Kamen 1950 in Norwegen noch 7 Arbeitnehmer auf einen Rentner, so sind es in der heutigen Zeit noch 4,4. Lediglich noch 2,5 Arbeitnehmer pro Renter werden für das Jahr 2050 prognostiziert (Østby 2004).

Diese Entwicklung hat Konsequenzen für unsere Gesellschaft. Früher fanden Sterben und Tod in der Familie statt, ohne Hilfe oder Einwirkung der Öffentlichkeit. Bei einem Patienten, der nicht mehr essen und trinken konnte oder wollte oder die Medikamente verweigerte, wurde das Ende des Lebens akzeptiert.

Mit der gesellschaftlichen Entwicklung haben sich auch die ärztlichen Aufgaben verändert. Weit über das Mittelalter hinaus bestanden die ärztlichen Tätigkeiten darin (Loewy 1995),

- Schmerzen zu lindern,
- die natürlichen Kräfte des Patienten zu unterstützen, sodass er seine Gesundheit zurückerlangen konnte,
- die aktive Behandlung zu unterlassen, sobald die Erkrankung vom Arzt nicht mehr zu beeinflussen war.

Dem Arzt war es ausdrücklich untersagt, unheilbar Kranke aktiv zu behandeln. Es gab zahlreiche Gründe für diese Haltung. Einer der Gründe war darin zu sehen, dass ein Arzt nicht gern in Verbindung mit dem Sterben gebracht werden wollte. Wenn bekannt wurde, dass man Sterbende behandelte, lief man Gefahr, seine Patienten zu verlieren. Diese Haltung hat mit Sicherheit dazu beigetragen, dass viele Patienten in der letzten Lebensphase nicht die lindernde Hilfe erhielten, derer sie bedurften.

Auch im Jahr 2006 ist dies eine der größten Herausforderungen, denen unsere Gesellschaft und unser Gesundheitswesen gegenüberstehen. Inzwischen haben fast alle Länder Palliative-Care-Programme für Tumorpatienten etabliert. Alte Menschen, die die Mehrzahl der Sterbenden ausmachen, müssen in Zukunft einen Nutzen aus dieser Entwicklung ziehen.

Norwegen hat Europas höchsten Anteil an Pflegeplätzen im Verhältnis zur Einwohnerzahl (1%). In großen Bereichen Europas, Süd- und Osteuropa, beträgt dieser Anteil weniger als die Hälfte, da kaum Pflegeinstitutionen existieren. Bis zum Jahr 2050 wird mit der Zunahme von Demenzerkrankungen von jetzt 2% auf 4% gerechnet (Engedal 1993; Ott et al. 1995). Die durchschnittliche Kinderzahl pro Familie ist dramatisch gesunken, und es ist abzusehen, dass die Versicherungen die Finanzierung des zukünftigen Pflegebedarfs nicht mehr gewährleisten können. Viele Alte werden in ihrer letzten Lebenszeit weder ein Zuhause noch Angehörige haben, die ihnen die nötige Betreuung geben können.

Aufgrund begrenzter Ressourcen findet eine »Still-satt-und-sauber-Versorgung« in Pflegeheimen und durch ambulante Pflegedienste statt. In palliativmedizinischen und hospizlichen Einrichtungen legt man dagegen Wert auf eine ganzheitliche Begleitung mit Betonung der Lebensqualität (Wilmsen-Neumann et al. 2002).

In allen westlich-industrialisierten Staaten zeigt sich für die »Orte des Sterbens« eine deutliche Tendenz der Verlagerung in Institutionen (zwischen 60 und 80%). In Deutschland lebten 1999 über 13 Mio. Menschen, die älter als 65 Jahre waren; etwa 2 Mio. davon waren pflegebedürftig, und 28% der Pflegebedürftigen lebten in Pflegeheimen. Zurzeit finden sich ungefähr 650.000 Pflegeplätze in Deutschland (Vierter Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland 2002). Doch in den nächsten Jahren wird der Bedarf an Pflegeheimen rapide ansteigen, Schätzungen gehen von 10.000–20.000 Pflegeplätzen pro Jahr aus.

In den USA hat nur etwa 1% der Pflegeheimbewohner Zugang zu palliativmedizinischen Angeboten. Gleichzeitig leiden aber zwischen 25 und

50% aller zu Hause und 45–80% aller in Heimen wohnenden alten Menschen unter Schmerzen und anderen plagenden Symptomen (Zerzan et al. 2000). Nichts deutet darauf hin, dass die Situation in Deutschland besser ist. Der Vierte Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland fordert erstmals deutlich die Ausdehnung der Palliativmedizin auf die schwerkranken und sterbenden Alten.

Im Jahr 2002 starben in Norwegen 44.401 Personen, davon 17.867 in Krankenhäusern und 17.257 in Pflegeheimen (Statistisk sentralbyrå). Kein Land in Europa hat einen vergleichbar hohen Anteil an Pflegeheimbetten.

Ein aktuelles Dokument der norwegischen Ärztekammer: »Wenn du alt wirst – und niemand dich haben will« (Den Norske Legeforening 2002) gilt als Ausgangspunkt brisanter Beschreibungen der medizinischen und sozialen Ungerechtigkeit in der Behandlung alter Menschen. Ungefähr 13.700 Krankenhausbetten mit ca. 6700 Arztstellen (1 Arzt für 2 Patienten) stehen 37.000 Pflegeheimbetten mit 217 Ärzten (1 Arzt für 170 Patienten) gegenüber. Krankenhäuser verfügen über mehr als einen doppelt so hohen Pflegeschlüssel pro Patient. In einem Pflegeheim beträgt der durchschnittliche Pflegefaktor 0,8. In Norwegen ist jedoch die Anzahl des Pflegepersonals doppelt so hoch wie in Deutschland bei einem vergleichbaren nationalen Gesundheitsbudjet (World Bank Group). Dies lässt sich erklären mit einer höheren Anzahl von Krankenhausbetten im Vergleich zu den vorhandenen Pflegebetten in anderen Ländern.

Fachlich ist man sich darüber einig, dass das Durchschnittsalter, die Multimorbidität und der Pflegebedarf alter Patienten erheblich zugenommen haben. Das Durchschnittsalter dieser Patienten liegt zwischen 83 und 88 Jahren, und jeder Patient hat 5–7 teilweise ernste Diagnosen. In Norwegen werden nahezu alle Langzeitpatienten, die in Pflegeheimen leben, auch dort versterben. Eine Untersuchung des nationalen medizinischen Statistikbüros SINTEF (2003) gibt eine Übersicht über bestehenden Diagnosen von Pflegeheimbewohnern (n = 174; ◘ Tab. 6.1.) Jeder Patient hat durchschnittlich 7 medizinische Probleme.

Obwohl nur sehr wenige der norwegischen Geriater in einem Pflegeheim arbeiten, haben die meisten Ärzte an Fortbildungen in Palliative Care teilgenommen, und mehr als 90% des Pflegepersonals in norwegischen Pflegeheimen haben eine kompetente Berufsausbildung mit Fachabschluss. Bei steigendem Anteil ausländischer Mitarbeiter bestehen für die Implementierung palliativmedizinischer und hospizlich geprägter Haltungen und Kenntnisse entsprechende kulturelle und kommunikative Herausforderungen.

Tab. 6.1. Erkrankungen alter Menschen im Pflegeheim (n = 174). SINTEF-Rapport, 6/2003, Rote-Kreuz-Pflegeheim, Bergen (Norwegen)

Erkrankung	Häufigkeit [%]
Herz-Kreislauf-System	87
Demenz	77
Muskuloskelettäre Erkrankungen	76
Neurologische Erkrankungen	70
Schmerz	62
Psychiatrische Erkrankungen	60
Urologische/gynäkologische Erkrankungen	47
Gastroenterologische Erkrankungen	44
Tumorleiden	27

Nichts deutet darauf hin, dass die Situation in Deutschland besser ist, im Gegenteil. In Deutschland hat die Mehrzahl des Pflegepersonals in Alterseinrichtungen keine fachbezogene Berufsausbildung. Diese Einrichtungen haben nur selten fest angestellte Ärzte, und das Personal muss sich Behandlungsmaßgaben mehrerer Hausärzte anpassen. Es bleibt oft dem Zufall überlassen, ob schwerkranke und sterbende Patienten in der letzten Lebensphase kompetente Schmerztherapie und Symptomlinderung bekommen und sie und ihre Angehörigen notwendige Informationen erhalten.

Etwa 70% aller Menschen in Deutschland sterben im Krankenhaus. Es sind dies zum Großteil Patienten, die Hals über Kopf eingewiesen werden. Die Einweisung gilt als Auftrag für die Stelle, die einen unbekannten Patienten übernimmt, Leben zu retten. Eine Maschinerie wird in Gang gesetzt, die nur schwer zu unterbrechen ist (Meyer-Baumgartner 1995; Naumann u. Barnard 1998). Etwa die Hälfte der Bevölkerung wird über 80 Jahre alt. Mit 80 Jahren werden mehr als 20% in Altersinstitutionen versorgt. Mit 90 Jahren ist der Anteil größer als 50%.

Die Wahrscheinlichkeit, unsere letzte Lebensphase in einem Pflegeheim oder Krankenhaus zu verbringen, liegt heutzutage bei über 80%. Für alte Menschen hat dies ernste Konsequenzen, weil sie völlig von uns abhängig

sind. Falls *wir* alt oder krank werden, werden wir höchstwahrscheinlich weder in der Position sein noch die Kraft dazu haben, Protest zu erheben.

Die Alten haben eine große Geduld und eine Offenheit dem Gedanken gegenüber, dass das Sterben eine Befreiung sein kann, wenn die Zeit gekommen ist. Sowohl Ärzte, Pflegepersonal als auch Angehörige verfügen oft nicht über diese Reife und Einsicht. Wir bestimmen über ihren Alltag und darüber, ob sie weiterhin zu Hause wohnen können. Ihre Abhängigkeit wird noch größer, wenn sie in eine Institution kommen. Fremde bestimmen

- wann der Patient aufstehen soll,
- wann er sich hinlegen soll und wie lange,
- wann ein Toilettenbesuch möglich ist und das wöchentliche Bad,
- wann es möglich ist, Essen und Trinken zu bekommen,
- wie der Ablauf des Alltages auszusehen hat,
- welche Symptome und Leiden wichtig sind,
- welches Benehmen gewünscht wird oder auch nicht.

Wenn sich der alte Mensch dem Lebensende nähert, veranlassen wir Untersuchungen, Behandlungen und verabreichen Medikamente, die er nicht braucht, und gleichzeitig übersehen wir, welche medizinischen und menschlichen Bedürfnisse schwerkranke und sterbende Patienten haben. Das Problem ist bekannt, aber es ist nicht einfach, die entscheidenden Veränderungen auf den Weg zu bringen.

Wer ist für die notwendige Pflege, die Fürsorge, die Diagnostik und die Therapie zuständig? Wer bestimmt den Standard und die Qualität der Pflegeinstitutionen und der Pflegedienste? Wer trifft die wichtigen ethischen Entscheidungen und wer ist für eine adäquate Kommunikation zuständig? Und dürfen wir selbst demnächst in Pflegeinstitutionen so etwas wie Lebensqualität erhoffen oder erwarten?

6.2 Palliativmedizin für alte Menschen – ein Projekt in Norwegen

Mit 174 Patienten ist das Rote-Kreuz-Pflegeheim in Bergen das größte geriatrische Zentrum für Palliativmedizin in Skandinavien (Husebø 2004); 82% unserer Patienten sind Frauen. Das durchschnittliche Lebensalter beträgt 85,6 Jahre. Fast 90% unserer Patienten (ungefähr 160 Patienten jährlich) ster-

ben hier, 50% im Laufe des ersten Jahres nach Erhalt eines Platzes. Nur wenige von ihnen brauchen in dieser Zeit keine palliativmedizinische Behandlung. Dies gilt für die meisten Kranken- und Pflegeinstitutionen in Norwegen.

Die private Institution wird finanziell unterstützt von der Gemeinde Bergen. Auf 450 Angestellte sind 230 Stellen verteilt. In das multidisziplinäre Team sind neben dem Pflegepersonal und Ärzten folgende Mitarbeiter integriert: ein Seelsorger (80%), eine Sozialarbeiterin (100%), eine Psychologin (60%), vier Physiotherapeuten, zwei Ergotherapeuten und ein Musiktherapeut. Mehr als 70 Ehrenamtliche leisten einen bedeutenden Einsatz für die Patienten im gesamten Pflegeheim.

Mit sechs angestellten Ärzten bietet das Pflegeheim Kompetenz und Kontinuität, die auch für norwegische Verhältnisse ungewöhnlich sind. Sie sind Fachärzte aus den Bereichen Anästhesie, Allgemeinmedizin und Innere Medizin mit Geriatrie. Sie haben langjährige Erfahrung in Palliativmedizin und Schmerztherapie. Die Dienstbereitschaft sichert eine medizinische Versorgung rund um die Uhr. Nur so können die richtigen Maßnahmen ergriffen und unnötige Einweisungen ins Krankenhaus vermieden werden. Sowohl die Langzeitstationen als auch die Palliativstation arbeiten nach einem Standard für Palliative Care im Laufe der ersten 24 Stunden und über die gesamte Behandlungszeit hinaus. Ärzte haben die wichtige Rolle, die medizinische Kultur eines Pflegeheims mitzuprägen (Hjort 2002).

Durch die Differenzierung in Langzeit- und Kurzzeitabteilungen werden unterschiedliche Patientengruppen angesprochen. Die Institution hat 7 Stationen aufgeteilt in 16 Gruppen mit jeweils 8–12 Patienten. Zentrale Arbeitsbereiche sind die Diagnostik, die Therapie und die Behandlung internistischer und neurologischer Krankheitsbilder, die Rehabilitation nach Operationen oder Schlaganfällen und die Entlastung von Familien und Pflegediensten.

Der Kurzzeitbereich (22 Betten) bietet über den Zeitraum von 3–4 Wochen intensives Training, Anpassung von Hilfsmitteln und die Beurteilung der häuslichen Situation durch das multidisziplinäre Team an. Für zahlreiche Patienten wird dadurch die endgültige Einweisung in ein Pflegeheim überflüssig oder kann auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.

Die Palliativstation (8 Betten) ist ein Angebot auch für jüngere Tumorpatienten. Ebenso stehen 11 (Langzeit-)Hospizbetten zur Verfügung für Patienten, die aufgrund ihrer Tumorerkrankung eine spezialisierte Betreuung für mehr als 3–4 Wochen brauchen und wegen fehlenden sozialen Netzwerks nicht in ihrer häuslichen Umgebung leben können.

Drei Demenzstationen sind ein besonderes Angebot für Patienten mit M. Alzheimer und gerontopsychiatrischen Fragestellungen. Eine geriatrische Tagesklinik mit 45 Plätzen ist eine geschätzte und sichere Hilfe für viele, die weiterhin wünschen, zu Hause zu wohnen.

In den letzten 10–15 Jahren hat sich aufgrund neuer Routinen und kürzerer Liegezeiten in den Krankenhäusern ein Strukturwandel vollzogen. Waren früher die meisten Patienten bei Aufnahme im Pflegeheim noch gut zu Fuß, werden sie heutzutage im Rollstuhl oder bettlägerig eingewiesen.

Jede Woche sterben in unserer Einrichtung 2–3 Patienten. Das Sterben, das von den Alten häufig als eine Befreiung von Leiden empfunden wird, ist für sich hilflos fühlende Angehörige und das Personal oftmals keine unproblematische Erfahrung.

»Hospice Care und Palliativmedizin für alte Menschen«

Von 1998 bis 2003 wurde am Rote-Kreuz-Pflegeheim in Bergen ein fünfjähriges nationales Projekt durchgeführt: »Hospice Care und Palliativmedizin für alte Menschen« (Husebø 2003). Dieses Projekt wurde finanziert mit der Hilfe des norwegischen Sozialministeriums und des Norwegischen Roten Kreuzes. Das Hauptziel war, dazu beizutragen, dass unabhängig von Alter, Diagnose und Aufenthaltsort alle alten Menschen in Norwegen eine optimale lindernde Behandlung und Pflege in ihrer letzten Lebenszeit erfahren sollten. Durch gezielten Unterricht, Seminare und Konferenzen im ganzen Land wurden jährlich mehr als 6.000 Teilnehmer erreicht. Zahlreiche Publikationen in Artikel- und Buchform wurden zu diesem Thema in mehreren Sprachen herausgegeben.

In Zusammenarbeit mit Hochschulen und der Universität in Bergen können Studenten der Medizin, der Krankenpflegewissenschaft, Physiotherapie, Ergotherapie und der Sozialarbeit ihre praktische Ausbildungszeit an dieser Institution absolvieren. Aufgrund dieser Erfahrung wählen zahlreiche junge Mitarbeiter eine Fragestellung aus der Palliativmedizin als Thema ihrer Examensarbeit. Die Institution bietet nach Absprache die Möglichkeit zur Hospitation.

Die Ausrichtung nationaler und internationaler Kongresse waren wichtige Arbeitsbereiche des Projektes. Themen wie »Palliativmedizin für alte Menschen«, »Schutz der Rechte im Alter«, »Fehlbehandlung in medizinischen Institutionen«, »Liebe in der Medizin«, »Würde im Alter« haben in Skandinavien

häufig zu einer breiten gesellschaftspolitischen Diskussion Anlass gegeben. Durch die Kombination wissenschaftlicher Beiträge mit Kunst und Kultur wurden sowohl die Fachkreise als auch die Öffentlichkeit angesprochen.

Das Projekt hat im Jahr 2000 eine medizinische Gesellschaft für Pflegeheimmedizin gegründet, die auf nationaler Ebene für die Entwicklung von Unterrichtsangeboten, Dokumentation, Standards und Forschung eintritt. Bisher gibt es noch keine Facharztausbildung in Pflegeheimmedizin, wie dies in Holland der Fall ist. Allerdings werden diese Fragen derzeit in der norwegischen Ärztkammer diskutiert, und die geleistete Arbeitszeit in einem Pflegeheim soll später auf die Facharztausbildung angerechnet werden können.

Forschung

Die Integration von Forschung ist eine logische Konsequenz unserer Arbeit. »Dignity for the Frail Old« ist ein europäisches Projekt, das in Zusammenarbeit mit Vertretern aller Länder eine Übersicht über die Versorgungsbedingungen alter Menschen in ihrer letzten Lebenszeit in Europa geben soll. Drei weitere Promotionsprojekte sind mit folgenden Themen an das Pflegeheim angebunden:

- Musik als therapeutisches Werkzeug im Pflegeheim,
- Entwicklung und Validierung eines Fragebogens zur Erfassung von Schmerzverhalten bei Patienten mit weit fortgeschrittener Demenz,
- Bedeutung von M. Alzheimer in der Wissenschaft, der Politik und im alltäglichen Leben.

Die Öffnung für Forschung ist ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Kompetenz und des Selbstbewusstseins des Personals. In zunehmendem Maß haben die Mitarbeiter das Gefühl, eine wertvolle und wichtige Arbeit zu leisten. Die Integration von Forschung motiviert zur eigenen Fort- und Weiterbildung und rekrutiert Fachpersonal. Gleichzeitig finden die Problemstellungen deutlicher Gehör in öffentlichen Gremien und in der akademischen Fachwelt.

Multimedikation/Polymedikation

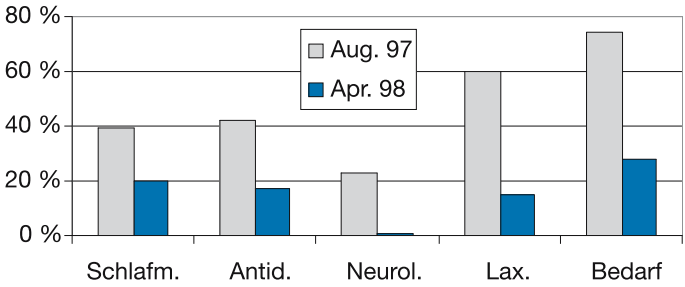
Alte Menschen haben einen hohen Bedarf und Verbrauch an Medikamenten, gleichzeitig sind sie den Nebenwirkungen von Arzneimitteln ausgesetzt. Mehrere Studien, die im Rahmen eines Forschungsprojekts in Pflegeheimen

in Bergen durchgeführt wurden, konnten in 76% der Fälle einen potenziell ungünstigen Medikamentengebrauch nachweisen. Psychopharmaka, speziell Antipsychotika, wurden am häufigsten als problematisch beschrieben. Nebenwirkungen und Interaktionen zeigten sich bei 47% der Patienten, die Psychopharmaka erhielten, bei 25% war die Behandlung ineffektiv, und bei 28% bestand keine eindeutige Indikation (Ruths et al. 2003).

Auch in unserer Instititution konnten wir zu Beginn unserer Arbeit (1997) einen bedeutenden Verbrauch an Schlafmitteln, Antidepressiva, Neuroleptika, Abführmitteln und Bedarfsmedikamenten beobachten. Im Rahmen der oben genannten Studie wurden die Probleme der Patienten mit Poly-/Multimedikation und die entsprechende Behandlung analysiert. Wie ◘ Abb. 6.2 zu entnehmen ist, wurden in diesen 9 Monaten mehr als die Hälfte der Medikamente reduziert (Husebø et al. 1998). Besonders die Medikamente, die häufig unkritisch und ohne Indikation bei Bedarf gegeben wurden, konnten deutlich reduziert werden.

Zahlreiche Patienten erhielten vor der Medikamentenreduktion 3–4 Psychopharmaka gleichzeitig, was zu motorischer Unruhe, Angstzuständen oder ausgeprägter Sedierung führte. Die meisten dieser Präparate haben eine obstipierende Wirkung, sodass nach ihrer Reduktion der Bedarf an Abführmitteln deutlich zurückging.

Selbstverständlich leiden auch alte Menschen an behandlungsbedürftigen Angst- und Unruhezuständen oder unter Depression und Zwangsvorstellungen. Ursache hierfür sind häufig mangelnder sozialer Kontakt, Nebenwir-



◘ **Abb. 6.2.** Verbrauch an Medikamenten August 1997 und April 1998 *(Schlafm.* Schlafmittel, *Antid.* Antidepressiva, *Neurol.* Neurologika, *Lax.* Laxanzien, *Bedarf* Bedarfsmedikation)

kungen von Medikamenten und fehlende Kompetenz des Personals. Dass Medikamente nicht unbedingt die vorrangige Lösung für eine suffiziente Symptombehandlung bieten, sollte in der Haltung der Behandelnden verankert sein. Vor jeder neuen Medikation müssen »alternative« Behandlungsangebote diskutiert werden. Hierzu bedarf es zunächst einer systematischen Schulung des Personals und der Leitung mit Kenntnissen in Milieutherapie, Musiktherapie und der Marte Meo Methode; Letztere befähigt das Personal dazu, anhand von Videoaufnahmen den Patienten in Interaktion mit dem Personal kritisch zu beobachten.

Falls Medikamente erforderlich sind, werden sie zumeist für eine begrenzte Zeitspanne und in der niedrigsten Dosierung gegeben.

Nach anfänglichen Bedenken des Pflegepersonals, Psychopharmaka und Schlafmittel zu reduzieren, sind sie nun selbst größte Anhänger von Aufmerksamkeit und Zuwendung. Sie erleben kommunikationsfähige Patienten mit einem klareren Bewusstsein, weniger Unfälle und weniger Nebenwirkungen.

Das reduzierte Schlafbedürfnis alter Menschen (nicht mehr als 5 Stunden) ist bekannt. Nach 2 Stunden Mittagspause genügen oft 4 Stunden Ruhe in der Nacht. Was geschieht mit den restlichen 8 Stunden, wenn erwartet wird, dass von 8.00 Uhr abends bis 8.00 Uhr morgens oder auch länger das Bett gehütet werden soll, um eine für das Personal machbare Pflege zu organisieren? Als Alternative zu einem kritiklosen Verbrauch von Schlafmitteln wird auf tägliche Aktivitäten gesetzt, und Patienten, die keinen Schlaf finden, haben das Recht aufzustehen, um gemeinsam mit dem Personal zu essen und zu trinken oder Musik zu hören.

Unfälle und Verletzungen

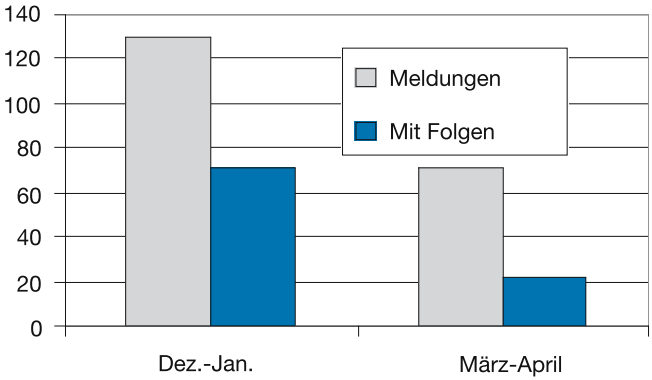
Die fünf großen Is in der Geriatrie: Ursachen der Abhängigkeit alter Menschen

- Instabilität
- Immobilität
- Intellektuelle Reduktion
- Inkontinenz und
- Iatrogenes

Schwindel, Gangunsicherheit und eine erhöhte Falltendenz sind Symptome, die im Alter zunehmen und zu Unsicherheit und Inaktivität beitragen. Ein Drittel der über 65-Jährigen hat mindestens ein Fallerlebnis pro Jahr. Die Hälfte derjenigen, die einmal gefallen sind, wird weitere Unfälle erleben. Das Risiko verdoppelt sich jenseits der 60 alle 7 Jahre und damit ebenso die Gefahr einer Fraktur. Eine chronische Falltendenz ist mit langem Leidensweg und kürzerer Lebenserwartung verbunden (Hunskår 1997).

Nur wenige norwegische Pflegeheime haben eine gute Dokumentation der Unfallverletzungen, die Patienten erleiden – etwas, das hingegen in einem Krankenhaus sehr ernst genommen wird. Im Rote-Kreuz-Pflegeheim hat man eine Meldepflicht für Unfälle eingeführt, nachdem täglich Patienten mit Verletzungen aller Art (Schürfwunden, Quetschungen, Frakturen, Platzwunden, Brandverletzungen etc.) beobachtet worden waren, die nicht nur auf das Alter zurückzuführen waren. Wie ◘ Abb. 6.3 zu entnehmen ist, korrelierte die Reduktion der Zahl der Verletzungen deutlich mit der Reduktion sedierender Medikamente, d. h. dem Gebrauch von Psychopharmaka und Schlafmitteln (Husebø et al. 1998).

Die Anzahl der Verletzungen mit Frakturen, Krankenhauseinweisungen, chirurgischer Wundversorgung u. a. wurde auf ein Drittel reduziert.



◘ **Abb. 6.3.** Registrierung von Unfällen und Verletzungen in der Zeit von Dezember 1997 bis Januar 1998 und März bis April 1998 nach der Medikamentenreduktion

Schutz der Rechte

Der Gebrauch von Zwang gegenüber alten Menschen ist ein schwieriges und sehr aktuelles Thema im Bereich der Altenpflege. Werden unsere Gesetze für die Alten in Institutionen beachtet? Oder wollen wir *Verstöße gegen diese Gesetze* nicht sehen? Tragen ökonomische Gründe und Mangel an Ressourcen zum Gebrauch von Zwang bei? In unserer Einrichtung legen wir auf die Einhaltung und den Schutz der Rechte alter Patienten großen Wert.

Was bedeutet Zwang?

Rechtlich unterscheiden wir fünf Haupttypen von Zwang:

- Physischer und mechanischer Zwang:
  Jemand wird gegen seinen Willen festgehalten oder durch die Anwendung von Gurten, Handschuhen, Riemen, Zwangsjacke in seiner Freiheit eingeschränkt.
- Isolation:
  Einsperren einer Person in einen Raum oder Haus, Verschließen einer Außentür.
- Pharmakologischer Zwang:
  Verabreichung sedierender Medikamente über längere Zeit, nachdem die notwendige Behandlung einer akuten Situation abgeschlossen ist. Auch die langfristige *prophylaktische* Behandlung von Unruhezuständen ist nicht gestattet.
- Psychischer Zwang:
  Verbale Androhungen, die zu Angst und Verunsicherung beitragen.

Es ist eine ethische Herausforderung, dass alte demente Menschen häufig ohne ihr Wissen und ohne erklärte Zustimmung in einer Pflegeinstitution untergebracht werden. Ehepaare müssen aus gesundheitlichen Gründen voneinander getrennt leben, die Möglichkeit eines gemeinsamen Lebensabends wird ihnen genommen. Den Rest des Lebens verbringen sie auf engstem Raum, der meistens mit einer anderen Person geteilt wird. Patienten in mental reduziertem Zustand werden hinter geschlossenen Türen gehalten. Als Argument wird häufig die »eigene Sicherheit« des Patienten

oder die seiner Mitpatienten ins Feld geführt. Sie werden auf Stühlen oder im Rollstuhl festgebunden, um Restaktivitäten zu verhindern. Das trägt dazu bei, dass alte Menschen Wochen, Monate und Jahre nicht an die frische Luft geführt werden.

Die eigentlichen Gründe allerdings sind Personalmangel, Mangel an Kompetenz, Mangel an Interesse und finanzielle Gesichtspunkte. Aufgrund des reduzierten Personalschlüssels können an den Wochenenden und Feiertagen die Alten nicht das Bett verlassen, oder sie werden nachmittags um 15.00 Uhr zur Nachtruhe gelegt. In Verbindung damit erhalten sie beruhigende Medikamente, um das Personal, die Mitpatienten oder die Angehörigen zu schonen. Alte Menschen erhalten Windeln oder wöchentlich festgelegte Abführtage, um den Zeitaufwand für einen regelmäßigen Toilettenbesuch einzusparen. Dies wird häufig als kränkend und schmerzhaft erlebt. In Eile wird gefüttert, anstatt ihnen beim Essen zu helfen und ihre noch vorhandenen Fähigkeiten des selbstständigen Essens zu stützen.

In Deutschland ergibt sich durch das großzügige Legen von Ernährungssonden eine ethische Frage besonderer Art. Viele Institutionen fordern diese Maßnahme vor der Aufnahme des Patienten, da aus Personalgründen die Zeit fehlt, diesen zu füttern, wenn er nicht mehr in der Lage ist, selbstständig zu essen. Aus finanziellen Gründen wird hier einem Menschen der Genuss der Mahlzeit genommen und durch Technik ersetzt. Gleichzeitig wird alten Menschen am Lebensende die Möglichkeit genommen, die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme nach eigenem Ermessen zu regulieren.

Obwohl auch die Rechtslage diesbezüglich eindeutig ist (Urteile des Deutschen Bundesgerichtshofs), stößt man doch immer wieder an praktische Grenzen, wenn es um die Beendigung der parenteralen Ernährung alter sterbender Patienten geht. Gründe hierfür sind mangelnde Kommunikation und die Angst, rechtlich belangt zu werden.

Selbstverständlich werden auch in Norwegen Ernährungssonden gelegt, um kurzfristig Schluckprobleme zu überbrücken, z.B. nach einem Schlaganfall. Wenn man allerdings erkennt, dass der Patient keine sinnvolle Lebensperspektive mehr hat oder er selbst diese Form der Behandlung ablehnt, wird die Beendigung dieser Maßnahmen offen diskutiert und die Konsequenz daraus gezogen. Unsere Strafgesetze sind deutlich. Niemand kann gegen seinen Willen eingesperrt oder behandelt werden, es darf keine Gewalt gegen andere ausgeübt werden ohne richterliche Begründung und Verfügung.

Gleichzeitig ist der Gebrauch von physischem, psychischem, sozialem und pharmakologischem Zwang in Altersinstitutionen alltäglich – ohne Dokumentation, fachliche Begründung und Rechtsgrundlage. Alle Pflegeheime unterliegen Rechtsvorschriften. Die Leitung der Institution ist dafür verantwortlich, dass diese Richtlinien beachtet werden und ausreichend kompetentes Personal zur Verfügung steht. Der Arzt hat die medizinische, die Pflegedienstleitung die pflegerische Verantwortung.

In den skandinavischen Ländern, in England und in den Niederlanden steht die Debatte über die Versorgung und Lebensqualität der ältesten Mitbürger wahrscheinlich an erster Stelle der Medienaufmerksamkeit. Alles deutet darauf hin, dass in diesen Ländern eine zunehmend bessere Betreuung dieser Patienten gefordert und geleistet wird, und der Schutz ihrer Rechte ist dabei ein zentrales Thema.

6.3 Palliativmedizin für alte Patienten – die Praxis

Die fachlich zentralen Gebiete und das Konzept der Palliativmedizin sind in diesem Buch umfassend beschrieben und können wie in der Übersicht gezeigt zusammengefasst werden.

Konzept der Palliativmedizin

- Schmerztherapie
- Akzeptanz von Leben und Tod
- Symptomkontrolle
- Psychosoziale Betreuung von Patient und Angehörigen
- Kommunikation
- Seelsorge
- Ethik
- Multidisziplinäre Teamarbeit

In unserer Klinik findet man nicht einen Patienten, der nicht all dies heute oder in naher Zukunft brauchen wird.

6.3.1 Schmerzerfassung bei Demenz

In einem Übersichtsartikel beschreiben Seale u. Cartwright (1994) die häufigsten Beschwerden und Symptome von Patienten in ihrem letzten Lebensjahr. Abb. 6.4 gibt die Probleme wieder, die bei sterbenden Patienten auftreten können. Die Untersuchung zeigt auch, dass Tumorpatienten häufiger über Schmerzen, Anorexie, Schlaflosigkeit, Obstipation und Erbrechen klagen als Nichttumorpatienten.

Eine weitere Untersuchung (Seale u. Cartwright 1994) gibt eine Übersicht über Symptome und Probleme (Abb. 6.5), die mit dem Alter zunehmen. Die Abhängigkeit des Patienten von anderen Personen steigt mit dem Grad der Verwirrtheit und dem Verlust von Hören und Sehen. Eindrucksvoll wird hier die im Alter zunehmende Schmerzproblematik deutlich. Gleichzeitig halten sich zahlreiche Mythen wie: Schmerzen sind in höherem Alter unvermeidlich, Alte tolerieren mehr Schmerzen, Alte sind weniger sensibel gegenüber Schmerzen.

Die Mehrheit der Pflegeheimpatienten leidet unter anhaltenden, nicht diagnostizierten und mangelhaft behandelten Schmerzen (AGS-Panel 1998; Weiner 1999; Teno et al. 2001; Frampton et al. 2003). Chronische Schmerzen bei alten dementen Patienten mit Kommunikationsproblemen werden häufig aufgrund mangelnder Evaluierungsinstrumente übersehen und nicht behandelt (Cavalieri 2002). Etwa 83% dieser Patienten erleben Schmerzen,

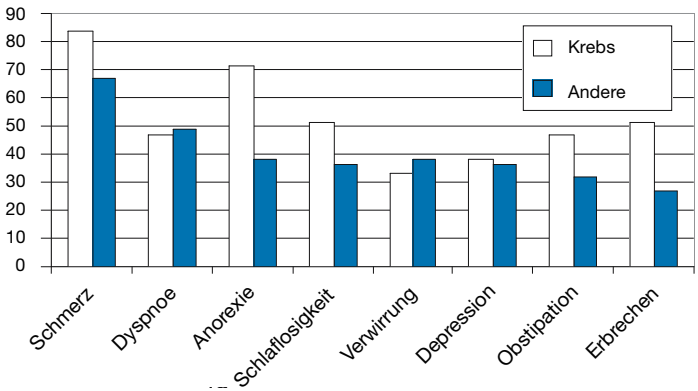


Abb. 6.4. Häufigeit von Symptomen im letzten Lebensjahr, unabhängig vom Alter und in Abhängigkeit von der Diagnose des Patienten. (NachSeale u. Cartwright 1994)

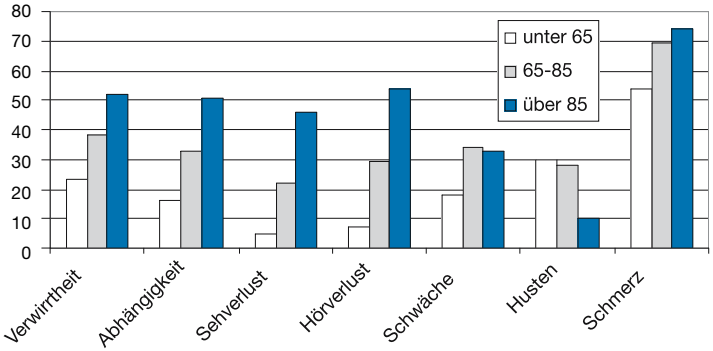


Abb. 6.5. Übersicht über Symptome und Probleme in Abhängigkeit vom Alter. (NachSeale u. Cartwright 1994)

die zu Inaktivität, Schlafstörungen, Angst, Depression, Verminderung der physischen, sozialen und mentalen Aktivitäten und Appetitlosigkeit führen können (Roy 1986; Ferrel et al. 1990, 1995).

Schmerz im Alter kann effektiv behandelt werden (Ferrel et al. 1995; Gagliese u. Melzack 1997). Untersuchungen zeigen allerdings, dass orientierte Patienten bei vergleichbaren Erkrankungen (Schenkelhalsfraktur, Zahnbehandlung) 2- bis 3-mal mehr Schmerzmedikamente erhalten als demente Patienten (Morrison et al. 2000; Cohen-Mansfield et al. 2002). Zunehmende Hilflosigkeit und Verstärkung sozialer Probleme sind die Folge, und dadurch steigen auch die Unkosten für Pflege und Fürsorge (Ferrell et al. 1990).

Als Goldstandard der Schmerzmessung gilt nach wie vor die Selbsteinschätzung des Patienten (Turk et al. 1999). Somit ist es eine Herausforderung, Schmerz ohne die genaue Beschreibung eines Patienten zu erfassen, der durch eine Demenz mental reduziert ist (Cohen-Mansfield et al. 2002; Lane et al. 2003). Zahlreiche Studien besagen, dass die bisher entwickelten Evaluieringsinstrumente geeignet sind für orientierte Patienten und Demente im Frühstadium. Bereits bei moderater Demenz, aber insbesonders bei weit fortgeschrittener Demenz, lassen sich anhand dieser Instrumente keine zuverlässigen Angaben ermitteln (Krulewitch et al. 2001; Wynne et al. 2000; Closs et al. 2004).

Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass ein zuverlässiges Instrument auf seine psychometrischen Parameter getestet sein muss und hierbei valide Resultate dokumentiert werden. Diese sollen sicherstellen, dass die

Ergebisse auch wirklich Schmerzen messen (Validität), dass unabhängige Personen zu dem gleichen Ergebnis kommen (Reliabilität) und dass das Instrument in der Lage ist, Veränderungen zu erfassen (Responsiveness). Derzeit liegt kein Schmerzerfassungsinstrument für Patienten mit fortgeschrittener Demenz vor, das diese Kriterien erfüllt (Stolee et al. 2005).

Die letzte Lebensphase sterbender Patienten kann ruhig und friedlich verlaufen (Doyle et al. 1998; Wall u. Melzack 1994). Voraussetzung dafür ist eine adäquate medizinische Behandlung und Pflege sowie die Identifizierung dessen, was Unbehagen, Angst oder Schmerzen hervorruft.

In norwegischen Pflegeheimen haben 50–70% der Patienten eine Demenz, ein Viertel davon eine weit fortgeschrittene, sodass eine Schmerzanamnese oft nicht erhoben werden kann. Deshalb ist eine genaue Beobachtung der Patienten maßgeblich, wenn man bedenkt, dass 70–80% aller Sterbenden unter Schmerzen oder anderen Symptomen leiden (Husebø Sandgathe u. Husebø 1998).

Schmerzen werden als chronisch bezeichnet, wenn sie die normale Zeit der Heilung überdauern oder länger als 3 Monate anhalten (Merskey et al. 1986). Eine kanadische Studie berichtet über eine Prevalenz von 5% für akute Schmerzen in allen Altersgruppen und 40% für chronische Schmerzen im Alter von 80 Jahren (Crook et al. 1984).

Auch in Pflegeinstitutionen ist die Frage nach *akuten* Schmerzen selten, obwohl diese doch relativ leicht zu erkennen wären. Wenn ein dementer oder bewusstseinsreduzierter Patient einen erhöhten Sympatikotonus zeigt und seine Atmung verändert ist, kann dies ein Zeichen für *akute* Schmerzen und den Bedarf an Analgetika (nicht Sedativa) sein. Eine Besserung der in der Übersicht genannten Symptome gilt als Hinweis dafür, dass der Patient einen Bedarf an regelmäßiger Weiterführung der symptomlindernden Maßnahmen hat.

Anzeichen für akute Schmerzen bei dementen oder bewusstseinsreduzierten Patienten

- Erhöhter Sympathikotonus
- Rasche, oberflächliche Atmung
- Rascher Puls
- Schwitzen oder Zentralisierung
- Angespannter Gesichtsausdruck

Die Erfassung *chronischer* Schmerzen bei dementen Patienten basiert außerdem auf der Beurteilung von Verhaltensveränderungen. Der Patient äußert sich mit Stöhnen oder Rufen, Unruhe, Abwehrbewegungen und verändertem Gesichtsausdruck. Verhaltensänderungen während des Krankheitsverlaufs und unter der Mobilisierung des Patienten haben oft Hinweischarakter in Bezug auf Schmerzen.

Anzeichen für chronische Schmerzen bei dementen oder bewusstseinsreduzierten Patienten

- Unkontrolliertes Stöhnen oder Rufen
- Unruhe oder Anspannung bei Ansprache
- Unkontrollierte Abwehrbewegungen
- Körperliche Unruhe bei bestimmter Lagerung
- Verstärkung dieser Mechanismen während der Pflege

Im Rahmen eines Forschungsprojekts entwickeln wir an der Universität in Bergen eine Evaluierungsmethode zur Erfassung chronischer Schmerzen bei fortgeschrittener Demenz. Das Instrument befindet sich in der Testphase, um sicherzustellen, dass es misst, was es messen soll. Außerdem muss gewährleistet sein, dass unterschiedliche Personen vergleichbare Resultate liefern. Personal aus dem Pflegeheim wird in diese Testserien integriert, denn diese Personen sind es, die später das Instrument, einen Fragebogen, benutzen sollen.

Sowohl bei häuslicher Versorgung des Patienten, im Krankenhaus als auch im Pflegeheim spielt das Pflegepersonal bei der Observation von Schmerzen eine zentrale Rolle. Pflegende sind es, die den engsten Kontakt besonders in der Pflegesituation und während der Mobilisation haben. Sie brauchen die »Erlaubnis«, Schmerzen erkennen zu dürfen, sie zu registrieren und die Information weiterzuvermitteln. Es muss eine psychische Belastung sein, Patienten mit Schmerzen zu pflegen, bei denen ärztlicherseits noch nicht einmal versucht wurde, die Schmerzen adäquat zu lindern. Dies kann zu einer ignoranten Haltung führen, um sich selbst vor der Belastung dieser Gewissheit zu schützen.

In diesem Buch wird an zahlreichen Stellen über die Schmerzbehandlung gesprochen. Alle Formen der Schmerztherapie gelten ebenfalls für alte und

sterbende Menschen. Gleichzeitig sollten die in der Übersicht genannten Punkte unterstrichen werden.

Gebrauch von Analgetika bei alten und dementen Patienten mit akuten oder chronischen Schmerzen

- In Abhängigkeit von Allgemeinzustand und physiologischem Alter wird mit der niedrigsten Dosierung gestartet.
- Die Analgetikatoleranz alter Menschen ist häufig deutlich reduziert! Niedrigere Dosierungen und seltenere Applikationen sind oft ausreichend.
- Aufgrund reduzierter Nieren- und Leberfunktion, reduziertem Fettgewebe und verminderter Kreislaufkapazität können Medikamente länger, stärker und unvorhersehbarer wirken.
- Schmerz, Angst, Unruhe hängen oft zusammen, aber auch das Sich-Zurückziehen eines Patienten kann Ausdruck für Schmerzen sein. Es ist keine gute Behandlung, Sedativa oder Antidepressiva anstelle einer adäquaten Schmerztherapie einzusetzen.
- Von trizlyklischen Antidepressiva ist bei alten Patienten wegen der Herz-Kreislauf-Nebenwirkungen abzuraten.

6.4 Palliative Care in einem Pflegeheim – eine Zweiklassenmedizin?

Eine medizinische Revolution hat dazu beigetragen,
das Lebensalter unserer ältesten Mitbürger zu verlängern,
ohne die Würde und die Sicherheit
in diesen späten Jahren zu bewahren.
(John F. Kennedy 1961)

Im Rahmen des 1998 gestarteten nationalen Projektes »Hospice Care und Palliativmedizin für alte Menschen« wurde in der Rote-Kreuz-Klinik Bergen im Juni 2000 die erste Palliativstation (8 Betten) in einem norwegischen Pflegeheim eröffnet. Der Aufenthalt ist auf 3–4 Wochen begrenzt, kann aber auf der Hospizstation (11 Betten) fortgesetzt werden, wenn der Patient nicht mehr in der Lage

ist, nach Hause zurückzukehren. Das Ziel ist es, schwerkranken und sterbenden Patienten in ihrer letzten Lebensphase kompetente Palliative Care anzubieten, unabhängig von ihrem Alter oder ihrer Diagnose. Der Pflegeschlüssel liegt bei 1,0; 70% des Pflegepersonals sind examinierte Krankenschwestern und 30% ausgebildete Pflegeschwestern. Das multidisziplinäre Team ist eine entscheidende Voraussetzung für die Abläufe auf der Palliativstation. Im Folgenden werden einige Daten der Patienten unserer Palliativstation präsentiert:

Demographische Daten

Durchschnittliches Alter: 75,6 Jahre (31–93), 35% sind jünger als 70 Jahre. Im Vergleich dazu beträgt das durchschnittliche Alter im Pflegeheim 88 Jahre. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer beträgt 19,2 Tage (1–87). Innerhalb kurzer Zeit (0–10 Tage) nach Aufnahme sterben 39% der Patienten, 20% haben einen Aufenthalt von 11–20 Tagen, 14% von 21–30 Tagen und 27% länger als 30 Tage. Usachen für die lange Aufenthaltsdauer sind Mangel an Pflegeheimplätzen, fehlendes soziales Netzwerk und schwierige Krankheitsverläufe. Der internationale Durchschnitt für die Aufenthaltsdauer auf einer Palliativstation beträgt 12–16 Tage.

Wohnsituation der Patienten

Allein wohnen 61% der Patienten, bevor sie in die Institution kommen, 34% wohnen gemeinsam mit ihrem Partner, 3% zusammen mit ihren Kindern. Die Auslastung der Bettenkapazität beträgt 94,2%. Von umliegenden Krankenhäusern/Universität direkt werden 84% der Patienten eingewiesen, 13% kommen von zu Hause. Die Patienten des Pflegeheims werden nicht innerhalb des Hauses auf die Palliativstation verlegt, da sie ihre gewohnte Umgebung nicht zu verlassen brauchen, betreut von vertrautem Personal, mit ebenfalls fachlicher Kompetenz in Palliative Care.

Diagnosen

Die Palliativstation soll ein Angebot sein für schwerkranke und sterbende Patienten, unabhängig von Alter und Diagnose. Dennoch haben die meisten (94%) eine Tumordiagnose mit durchschnittlich 7,2 tumorassoziierten Symptomen. Die folgenden Probleme werden am häufigsten bei der Einwei-

sung benannt: Schmerzen, andere belastende Symptome, Pflegebedürftigkeit, soziale Probleme, Notwendigkeit medizinischer Behandlung in der letzten Lebensphase, psychische Probleme.

Psychosozialer und seelischer Bedarf

In den ersten gemeinsamen Gesprächen mit Patient und Angehörigen ist ein wesentlicher Teil der Erfassung der psychosoziale und seelische Betreuungsbedarf des Patienten und seiner Angehörigen. Eine offene und vorbereitende Kommunikation mit dem Pflegepersonal und den Ärzten über den Krankheitsverlauf und die »Zukunft« wünschen 71% der Patienten und 73% der Angehörigen. Sie wünschen mehr Information über die Lebenserwartung, die eigentliche Sterbephase und möglicherweise auftretende Symptome wie Schmerz und Luftnot. »Der eigenen Familie nicht zur Last fallen« ist ein oft genanntes Thema. Rund 63% geben an, dass sie diese Art der Betreuung bei ihrem Krankenhausaufenthalt vermisst haben. Einsamkeit als eine besondere Belastung, der Wunsch, zum Sterben nach Hause entlassen zu werden, und das Gespräch mit dem Seelsorger sind wiederkehrende Themen.

Wie ist der weitere Verlauf?

Die meisten Patienten (74%) sterben auf der Palliativstation. Von unseren Patienten können sich 24% über kürzere oder längere Zeit zu Hause aufhalten, 18% haben einen oder mehrere Aufenthalte auf der Palliativstation, 14% sterben zu Hause, 10% erhalten nach initialer Behandlung auf der Palliativstation einen Langzeitplatz im Pflegeheim, 2% erhalten einen Platz in einer anderen Institution.

6.5 Palliativstation kontra Pflegeheim

In einer vergleichenden Studie wurden 2001–2002 Patienten von Langzeitstationen des Pflegeheims vor Projektstart 1998 (n = 107), 3 Jahre nach Projektstart (n = 179) und von der Palliativstation (n = 148) erfasst (Husebø et al. 2004). Retrospektiv wurden der Einsatz von Medikamenten in den letzten 24 Stunden vor Versterben des Patienten (Abb. 6.6) sowie die vorbereitende Kommunikation (Abb. 6.7) dokumentiert.

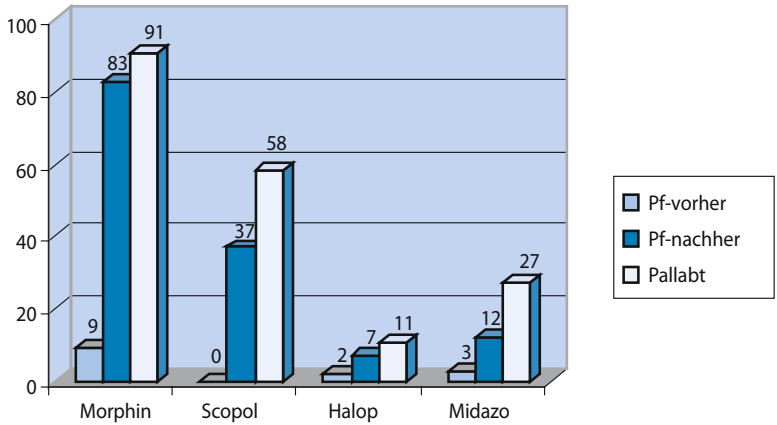


Abb. 6.6. Bedarf an Medikamenten in den letzten 24 Stunden in % für Morphin, Scopolamin *(Scopol)*, Haloperidol *(Halop)*, Midazolam *(Midazo)* im Pflegeheim vor Projektstart *(Pf-vorher)*, n = 107, nach Projektstart *(Pf-nacher)*, n = 179, auf der Palliativabteilung *(Pallabt)*, n = 148

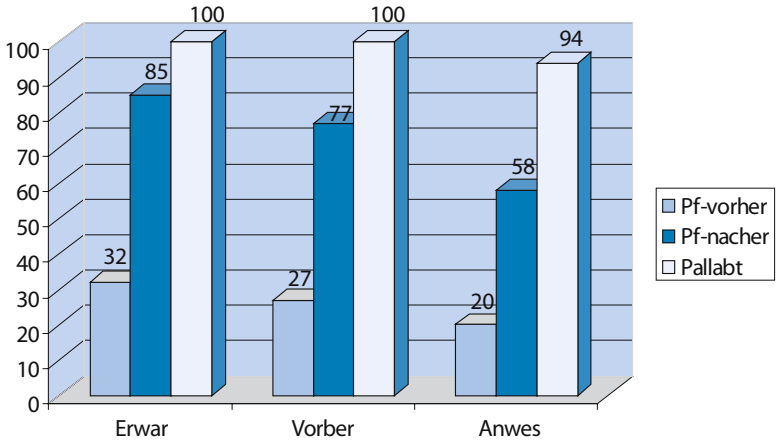


Abb. 6.7. Erwartete Todesfälle *(Erwart)*, vorbereitende Kommunikation *(Vorber)*, anwesende Angehörige bei Eintritt des Todes in % im Pflegeheim vor Projektstart *(Pf-vorher)*, n = 107, nach Projektstart *(Pf-nacher)*, n = 179, auf der Palliativabteilung *(Pallabt)*, n = 148

Patienten einer Palliativstation in einem Pflegeheim unterscheiden sich in einigen Aspekten von Patienten auf einer traditionellen Palliativstation. Ihr Durchschnittsalter ist höher (Durchschnitt 75,6 Jahre). Auf »gewöhnlichen« Palliativstationen liegt das Durchschnittsalter niedriger: 55–65 Jahre, und die meisten dieser Patienten (94%) haben eine Tumorerkrankung. Dies unterstreicht, dass eine Krebsdiagnose im Endstadium eine fachliche Herausforderung darstellt, unabhängig davon, ob der Patient sich im Krankenhaus, im Pflegeheim oder zu Hause befindet. Andererseits haben Patienten mit anderen schweren, chronischen Grunderkrankungen wie z.B. Herz-Kreislauf-Krankheiten, neurologischen Leiden, degenerativen Muskel- oder Skeletterkrankungen einen umfassenden Bedarf an Palliative Care in ihrer letzten Lebensphase.

Medikamentenbedarf in den letzten 24 Stunden

Abb. 6.6 und 6.7 zeigen eine deutliche Indikation dafür, dass auch alle Pflegeheimpatienten einer kompetenten palliativmedizinischen Behandlung und Betreuung bedürfen. Das beinhaltet den Einsatz von Morphin und anderen symptomlindernden Medikamenten in der letzten Lebensphase des Patienten. Die Abbildungen machen ebenso deutlich, dass – mit wenigen Ausnahmen – diese Patienten die notwendigen Maßnahmen *nicht* erhalten. Ärzte sind in den meisten Pflegeheimen *selten* anzutreffen, und deshalb erhalten sterbende Patienten nur selten Morphin, wenn sie es brauchen.

Vor Projektstart 1998 erhielten nur 9% der Sterbenden *Morphin,* jetzt sind es 83% der Patienten im Pflegeheim in ihren letzten 24 Stunden. Diese Behandlung ist eine Selbstverständlichkeit auf jeder Palliativstation. Entscheidend für den Einsatz von Opioiden ist nicht allein das Auftreten von Schmerzen. Die Hauptindikationen sind Herzinsuffizienz und begleitende Dyspnoe. Die meisten Patienten sterben an einer Herzschwäche und leiden intensiv unter akuter Luftnot mit rascher, oberflächlicher Respiration.

Der Einsatz von Scopolamin s.c., um das so genannte Todesrasseln zu lindern, ist geringer im Pflegeheim (27%) als auf der Palliativstation (58%). Aufgrund von Panik, Unruhe, Angst oder Krämpfen werden 12% (27%) der Patienten mit Midazolam (Dormicum) s.c. behandelt. Gegen Übelkeit oder Halluzinationen erhalten 7% (11%) der Patienten Haloperidol (Haldol). Um eine kontinuierliche Applikation, z. T. auch der Kombinationsgaben von Medikamenten zu gewährleisten, wird bei 68% der Patienten auf der Palli-

ativstation ein subkutanes Pumpensystem eingesetzt. Das ist im Pflegeheim nur selten der Fall.

Eine der entscheidenden Fragen ist, inwiefern das Projekt »Hospice Care und Palliativmedizin für alte Menschen« dazu beigetragen hat, die Versorgung der Alten auf den Langzeitstationen des Pflegeheims zu verbessern. Der Vergleich schmerz- und symptomlindernder Medikamente vor dem Start des Projekts (1998) mit dem Verbrauch 3 Jahre später (2001) zeigt eine Verzehnfachung des Morphinverbrauchs.

Die regelmäßige *Mundpflege* ist eine der wichtigsten Maßnahmen, die wir dem Sterbenden anbieten können (Twycross 1997; Husebø et al. 1998). Der Mund ist ein sensibles Organ. Lippen, Schleimhaut, Zunge, Rachen, Zähne oder Prothese müssen täglich inspiziert werden. Hier wird der Speichel produziert, die Verdauung von Essen und Trinken beginnt, und die Reflexe von Saugen, Husten, Trinken und Schlucken werden koordiniert. Wir brauchen den Mund, um uns verbal und nonverbal auszudrücken. Diese Funktionen ändern sich bei Schwerkranken und Sterbenden.

Häufig wechseln die Patienten mit fortschreitender Erkrankung von einer Nasenatmung zu einer offenen Mundatmung. Dies schafft zusätzliche Probleme mit Mundtrockenheit, Wunden und Infektionen (z. B. Candida albicans). Unerkannt und unbehandelt, ist dies eine häufige Ursache für Missempfindungen oder Schmerzen und fehlendes Interesse an Essen und Trinken. Falls Patienten nicht mehr trinken wollen oder können, ist es Zeit, mit einer regelmäßigen Mundpflege und der Befeuchtung von Mund und Rachen zu beginnen. Dies sollte 2– bis 4-mal in der Stunde durchgeführt werden. Die Auswahl der verwendeten Flüssigkeit ist individuell und richtet sich nach Wunsch und Gewohnheit des Patienten.

Zur Vermeidung von *Dekubitaluzera* und *Kontrakturen* arbeiten wir eng mit den Mitarbeitern der Ergo- und Physiotherapieabteilung zusammen. Ein immer wieder zentrales Thema ist die Mobilisation und Lagerung besonders schwacher Patienten und das prophylaktische Erkennen von Druckstellen an der Haut. Systematischer Unterricht, praktische Anleitung und regelmäßige Kontrollen haben dazu beigetragen, dass die Häufigkeit von Dekubitalulzera unter 1% liegt.

Ebenso zeigt die vergleichende Dokumentation, dass aufgrund der besseren Kommunikation mehr Angehörige informiert und zur Zeit des Todes anwesend waren. ◘ Abb. 6.7 zeigt, dass auf der Palliativstation bei allen Todesfällen der Eintritt in die Sterbephase frühzeitig erkannt wurde,

die Angehörigen informiert und zur Zeit des Todesfalls anwesend sind. Diese Bedingungen sind im Pflegeheim nicht zu erwarten. Obwohl plötzliche Todesfälle die Ausnahme sind, können nicht alle Angehörigen adäquat vorbereitet werden. Gründe hierfür sind, dass Angehörige nicht selten weit entfernt leben. Das führt dazu, dass Patienten nicht im Beisein ihrer Familie versterben. Dies hat auch Konsequenzen für das Personal. Pflegende übernehmen in solchen Fällen Familienfunktionen, wollen niemanden im Sterben allein lassen, was gleichzeitig eine psychische und eine organisatorische Herausforderung ist. Hintergrund für diese Haltung des Personals sind intensive Fortbildungsprogramme zu Symptomkontrolle, Kommunikation, Ethik und Seelsorge im Rahmen des Palliative-Care-Konzepts des Pflegeheims.

6.6 Ethische Entscheidungen am Lebensende

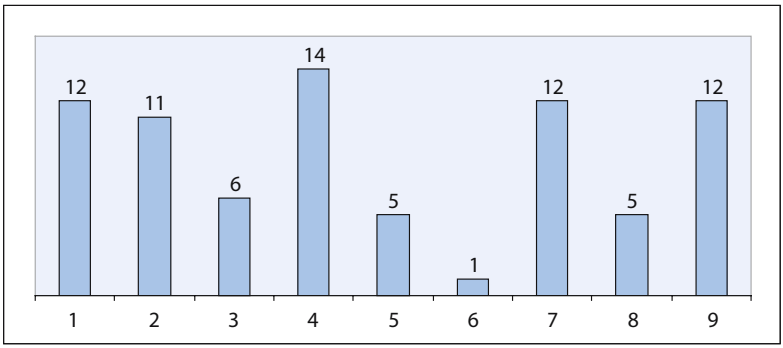
Im Jahr 2002 hat die Norwegische Ärztekammer in einem offiziellen Rundschreiben alle Ärzte in Krankenhäusern und Universitäten dazu aufgefordert, die ethischen Entscheidungen und die Verpflichtung zu palliativmedizinischer Behandlung schwerkranker und sterbender Patienten sehr ernst zu nehmen (Helsetilsynet 2002). Der Einsatz von Palliative Care, die Kommunikation mit dem Patienten und seinen Angehörigen und die Dokumentation der ethischen Entscheidung werden ausdrücklich gewünscht. Das Schreiben macht darauf aufmerksam, dass die alleinige Dokumentation von R– (keine Reanimation) eine nicht gültige Dokumentation darstellt. Obwohl in Norwegen 40% der Bevölkerung in Pflegeinstitutionen sterben, wurde dieses Schreiben nicht an diese Institutionen versandt.

Diese einseitige Fokusierung hat uns dazu veranlasst, die geltende Praxis in Bergener Pflegeheimen in einer offenen Untersuchung zu evaluieren (Husebø et al. 2004). Trotz der begrenzten Anzahl von befragten Institutionen haben wir Grund anzunehmen, dass die Ergebnisse repräsentativ für norwegische Pflegeheime in städtischen Regionen sind. Ärzte aus 15 Institutionen (83% der Pflegebetten in Bergen) mit insgesamt 1.782 Patienten beantworteten Fragebögen über ihre Routinen bezüglich Kommunikation, ethische Entscheidungen, Dokumentation und Palliative Care am Lebensende.

Die Ärzte gaben an, dass die Hauptverantwortung für Gespräche über ethisch relevante Fragen für die Behandlung und Betreuung mit dem Patien-

ten, den Angehörigen und dem Pflegepersonal bei ihnen läge. Diese Gespräche wurden selten bei Aufnahme geführt, sondern wenn der Patient schwer erkrankte. Von 15 Kollegen führten 13 Aufklärungsgespräche über Krankheit, Verlauf und gewünschte Behandlung (»informiertes Einverständnis«) und berücksichtigten den geäußerten oder mutmaßlichen Patientenwillen bei Bewusstlosigkeit oder Demenz. Gespräche zur Unterlassung von Wiederbelebungsmaßnahmen (Reanimation »minus«) wurden von zwei Dritteln der Kollegen geführt. Dennoch hatten lediglich 2 Institutionen schriftliche Richtlinien, obwohl die Mehrzahl der Ärzte sich explizit solche Richtlinien wünschen würde.

Der Abb. 6.8 ist zu entnehmen, dass 0,94% der Patienten eine Ernährungssonde hatten. Zwei Drittel der Ärzte benutzten Morphin bei Schmerzen und Dyspnoe. Die Behandlung von Todesrasseln war unzureichend. Und obwohl die meisten Ärzte mit der Versorgung sterbender Patienten zufrieden waren, gaben 4 von 5 an, in der letzten Lebensphase lebensverlängernde Maßnahmen mit Diuretika bei Lungenödem durchzuführen.



1. Morphin bei Schmerzen
2. Morphin bei Dyspnoe
3. Scopolamin bei Todesrasseln
4. Benzodiazepine bei Angst/Panik
5. Infusion
6. Ernährungssonde
7. Sauerstoff bei Dyspnoe
8. Antibiotika bei Pneumonie
9. Diuretika bei Dyspnoe/Lungenödem

Abb. 6.8. Einsatz von Medikamenten/Behandlung bei sterbenden Patienten im Pflegeheim (n = 15)

Die Frage der Reanimation und der lebenserhaltenden Maßnahmen ist eine nicht aktuelle Frage für Pflegeheimpatienten. Multimorbidität und Demenz erschweren es, ein informiertes Einverständnis einzuholen. Offene vorbereitende Gespräche mit Patient und Angehörigen sind im Vorfeld leider häufig versäumt worden (Allen et al. 2003). Diese Gespräche setzen eine medizinsche Kompetenz voraus, die das Pflegepersonal nicht hat. Etwa 60% der Sterbenden erleben Todesrasseln, das durch Schwäche und fehlenden Hustenreflex in der letzten Lebensphase entsteht (Ahmedzai et al. 1994). Anticholinergika wie Scopolamin können dieses Symptom lindern, diese sind allerdings wenig bekannt und werden selten eingesetzt (Husebo et al. 2004).

Ein Drittel der Ärzte in Bergener Pflegeheimen gab an, dass Patienten in ihrer letzten Lebensphase eine Infusion erhalten, wenn sie nicht mehr essen und trinken können. Patienten mit weit fortgeschrittener Demenz entwickeln häufig Essstörungen mit Gewichtsverlust. Der Einsatz von Ernährungssonden hat wenig Effekt bei Aspirationspneumonien, Dekubitus und Infektionen und trägt weder zur Lebensverlängerung noch zur Verbesserung des Funktionsstatus bei (Finucane et al. 1999). Intravenöse Infusionen bei sterbenden Patienten können bestehende Probleme bei Herzinsuffizienz und Lungenödem verstärken (Monteleoni et al. 2004). Für viele Patienten wird diese Maßnahme eine Intensivierung ihrer Leiden bedeuten, etwa im Hinblick auf die Entwicklung von Herzschwäche, Lungenödem, Dyspnoe, peripheren Ödemen und der Notwendigkeit einer Blasenkatheteranlage (Jones et al. 2001). Zusätzlich kann diese Maßnahme zur Verlängerung des Sterbeprozesses beitragen. Eine finnische Untersuchung zeigt, dass 17% der sterbenden Krebspatienten und 43% der sterbenden dementen Patienten lebensverlängernde Maßnahmen erhalten (Hinkka et al. 2002).

Antibiotika, Diuretika und die Gabe von Sauerstoff lindern nicht, oder nur vorübergehend, die Symptome sterbender Patienten. Ethische Entscheidungen am Lebensende alter Menschen setzen Kompetenz in Bezug auf Prognose, Behandlungsalternativen und Kommunikation voraus. Die Probleme müssen frühzeitig und deutlich angesprochen werden, bevor der Patient sterbend ist oder sich aufgrund einer Demenz nicht mehr an den entscheidenden Gesprächen beteiligen kann (Charatan 1999; Happ et al. 2002). Das Behandlungsteam muss einbezogen werden, um die Wünsche des Patienten und seiner Angehörigen zu koordinieren. Gleichzeitig gilt es, therapeutischen Nihilismus zu vermeiden. Bei unklaren medizinischen Fragen ist kompetenter Rat bei anderen Fachpersonen einzuholen.

6.7 Kommunikation

Ohne vorbereitende, offene Gespräche mit dem alten Patienten und seinen Angehörigen über die bevorstehende letzte Lebensphase sind Respekt vor Autonomie und Integrität eine Utopie. Diese Gespräche erfordern Kompetenz und Erfahrung, besonders in der Vermittlung schlechter Nachrichten. Die Fähigkeit zur Kommunikation hat eine zentrale Rolle im Rahmen der Palliativmedizin. Angehörige fragen häufig: »Wie lange wird es noch dauern, Doktor?« Diese Frage ist vielleicht eher ein Wunsch nach Kommunikation als nach einer konkreten Zeitangabe. Auch ohne dass eine Antwort über den genauen Zeitpunkt gegeben werden kann, ist es wichtig, dass diese Frage gestellt werden darf.

Als Hauptregel gilt, wichtige Beobachtungen nicht ohne den anwesenden (wachen) Patienten zu besprechen. Manchmal wünscht dieser aber ausdrücklich, nicht dabei zu sein. In diesem Fall ist es in Ordnung, wenn wir mit den Angehörigen sprechen, nachdem uns der Patient seine Erlaubnis dazu gegeben hat. Diese Überlegungen gelten auch für den alten Menschen. Keine Entscheidung darf über seinen Kopf hinweg getroffen werden; das Verstehen des Besprochenen wird nachhaltig positiv beeinflusst, wenn Angehörige bei solchen Gesprächen anwesend sind (Allen et al. 2003).

Schwieriger wird es, wenn ein Patient nicht mehr länger in der Lage ist, sich an wichtigen Überlegungen zu beteiligen und seine Zukunft zu bestimmen. Hier muss eine andere Person im Interesse des Betroffenen diese Aufgabe übernehmen. Dieser andere ist abhängig von der jeweiligen Situation. Einige alte Menschen haben Angehörige, die sehr kompetent wiedergeben können, was sich der Betroffene in dieser Situation gewünscht hätte. In anderen Fällen, in denen das Pflegepersonal und der Arzt allein zu einer Entscheidung kommen müssen, ist es besonders wichtig, dass sie über einen umfassenden Einblick in die Situation des Patienten verfügen.

Bei der Diskussion über medizinische Entscheidungen müssen wir differenzieren zwischen Erwägungen, die von dem Patienten oder von seinen Angehörigen getroffen werden können, und denen, für die der Arzt verantwortlich ist. Immer wieder sprechen wir über »schwierige« Patienten oder »schwierige« Angehörige. Damit meinen wir Patienten und Angehörige, die unsere angebotene Hilfe oder Therapievorschläge ablehnen oder eine medizinisch sinnlose Behandlung von uns fordern. Wir vergessen

häufig, dass die Patienten oder die Angehörigen von der Information abhängig sind, die sie erhalten. Wir können manipulieren durch die Art und Weise, wie wir Informationen weitergeben. Ziel ist es, die Aufklärung und die Information so verständlich zu vermitteln, dass der Patient oder die Angehörigen eine adäquate Wahl treffen können. Gleichzeitig müssen sie vor einer Wahl geschützt werden, deren Umsetzung in der Praxis nicht möglich ist.

Der anerkannte Medizinethiker Erich Loewy drückt die Frage nach dem anzunehmenden Patientenwunsch bewusstloser Patienten folgendermaßen aus (Loewy 1999):

> Es ist schwer zu wissen, was die Patienten wollen, wenn wir sie wegen ihrer Erkrankung nicht mehr fragen können. Erheblich leichter ist es jedoch, sich ein Bild darüber zu machen, was diese Patienten *nicht* wollen.

Diese alten, sterbenden Patienten wollen nicht unnötig leiden. Sie wollen nicht Therapieversuchen ausgesetzt werden, die nur das Leiden verlängern (Meier-Baumgartner 1995; Naumann u. Barnard 1998). Sie wollen mit Sicherheit nicht allein gelassen werden.

Die Erfordernisse an die aktive Behandlung, die Pflege und die Integration des alten Menschen werden nicht weniger, wenn der Tod naht – im Gegenteil. Sie vertiefen sich und werden intensiver. Die kurativen Maßnahmen sind nun überflüssig, die palliativen Maßnahmen treten in den Vordergrund. Die Erfahrung des Arztes macht es möglich, den bevorstehenden Tod des Patienten als einen Teil von dessen Leben zu akzeptieren und dies mit Offenheit und Kompetenz anzusprechen.

Doch wann können wir eine Behandlung abbrechen, die möglicherweise einen Sterbeprozess verlängert? Bleibt es nicht selbst für den erfahrenen Arzt und das erfahrene Pflegepersonal eine schwierige Aufgabe zu erkennen, dass ein Patient sterbend ist?

Diese Kompetenz hat wichtige Konsequenzen für den Patienten und seine Angehörigen. Bei deutlichen Signalen für ein Bevorstehen des Sterbens können notwendige Entscheidungen getroffen, kann die medizinische Behandlung angepasst werden. Viele, die Erfahrungen im Umgang mit Krebspatienten haben, können mit einem hohen Grad an Sicherheit voraussehen, dass ein Patient nicht mehr lange lebt. Die Situation ist schwieriger bei Patienten, die

unter chronischen Erkrankungen von Herz, Lunge, Haut und Nervensystem leiden. Gemeinsam mit einem Kollegen und dem Pflegepersonal wird über das Fortführen oder das Absetzen medizinischer Maßnahmen diskutiert, wenn sie allem Ermessen nach nur zur Verlängerung des Sterbeprozesses beitragen würden.

Beispiel aus der Praxis

Frau Berge war über lange Jahre Patientin in unserem Pflegeheim. In den letzten Jahren verstärkte sich ihre senile Demenz. Mit 90 Jahren starb sie ruhig und friedlich. Die Angehörigen waren anwesend, und gemeinsam nahmen wir Abschied von der Verstorbenen. Vor ihrer Zimmertür sah ich zufällig eine andere Patientin, Frau Brodal, zusammengesunken in ihrem Rollstuhl sitzen.

»Frau Brodal«, sagte ich, »was ist los mit Ihnen, Sie sehen so traurig aus?«

»Nein, nein ... nichts, alles ist in Ordnung.«

»Das sieht nicht so aus, aber Sie weinen ja! Ist es wegen Frau Berge?«

»Ja, sie war meine beste Freundin hier.«

»Sie ist ruhig und friedlich gestorben. Sie sieht sehr schön aus. Soll ich Sie in das Zimmer fahren und zusammen mit Ihnen Abschied nehmen?«

»Nein, nein. Das ist nicht nötig.«

»Vielleicht möchten Sie es dennoch. Ich glaube, für Frau Berge wäre es wichtig gewesen, dass Sie Abschied nehmen.«

Sie nickte, und ich fuhr sie in das Zimmer. Dieser stille Abschied zwischen zwei alten Freundinnen ist mir unvergesslich. Er war anrührend und tränenreich, ähnlich wie bei Kindern, die Abschied nehmen. Eine liebevolle Berührung der Hände, die Versicherung, dass die Verstorbene friedlich und schön aussehe, und die Bemerkung, dass sie selber, Frau Brodal, vielleicht die nächste sein könnte. Wenn ich jetzt Frau Brodal treffe, reden wir jedes Mal darüber, wie wichtig diese letzte Begegnung für sie war.

Auch für uns war diese Begebenheit von Bedeutung, indem wir nun häufiger darüber nachdenken, wer in einer solchen Situation einer Information bedarf und eventuell persönlich von dem Verstorbenen Abschied nehmen möchte. Ein wichtiger Indikator für unsere Offenheit und Reife gegenüber dem Tod sind unsere Routinen und Rituale, wenn ein Patient gestorben ist.

Über Jahrhunderte entstandene und gepflegte inhaltsreiche Rituale in Verbindung mit einem Trauerfall sind durch Einflussnahme des Gesund-

heitswesens im Laufe der letzten 60–70 Jahre abgeschafft worden. Doch an vielen Stellen sind noch weiterhin liebevolle Traditionen erhalten. In einer Institution ist der Ablauf einer solchen Situation häufig abhängig von den Diensthabenden, von ihrer Reife und Empfindsamkeit. Wir sollten nicht müde werden, diese wichtigen Fragen mit dem Personal immer wieder in Ruhe zu diskutieren, sodass unsere eigene Angst vor dem Tod nicht eine dominierende Rolle einnimmt, wenn ein Patient stirbt.

6.8 Aktive Lebenshilfe

> Die Prüfung eines Menschen ist, wie er sich gegenüber den Alten verhält. Es ist einfach, Kinder zu lieben. Selbst Tyrannen und Diktatoren schmücken sich mit ihrer Zuneigung zu Kindern. Aber die Aufmerksamkeit und Fürsorge für alte Menschen, für die Unheilbaren und für die Hilflosen, diese sind die wirkliche Goldgrube einer Kultur. (Roberts 1996)

Es war ein Schock, nach der Erfahrung großer fachlicher und menschlicher Aufmerksamkeit auf einer Anästhesie-, Intensiv- und Palliativabteilung eines deutschen Lehrkrankenhauses, mit allen denkbaren Möglichkeiten der Diagnostik und Behandlung, die Arbeit in einem norwegischen Pflegeheim aufzunehmen. Es war ebenso eine Überraschung, dass die sog. »Bewohner« ausschließlich Patienten mit einer oder mehreren chronischen oder akuten Erkrankungen sind. Die menschlichen und medizinischen Herausforderungen sind umfangreich, die fachlichen Erwartungen enorm. Beeindruckend ebenfalls die Begrenztheit der pflegerischen und ärztlichen Ressourcen und der Verantwortlichkeit. Der Personalmangel und die fehlende Kompetenz haben erhebliche Konsequenzen für den einzelnen Patienten. Die Schwäche der Alten, ihre Verletzbarkeit und Funktionsverluste machen sie fast immer wehrlos gegen Gleichgültigkeit, mangelnde Fürsorge und Fehlbehandlung.

Die letzte Lebensphase beinhaltet aber auch Würde, Fragen, Gefühle, Werte, Verlust, Trauer und Liebe. Diese Erfahrungen sind die Grundlage für zentrale und unersetzliche Werte innerhalb einer Gesellschaft und haben eine große Tragkraft für Kunst, Literatur, Musik und Philosophie. Viel oder das meiste geht verloren, wenn die letzte Lebensphase verdrängt wird. Diese Verdrängung ist eine unserer derzeit größten Herausforderungen.

Der schwedische Soziologe Tornstam (1996) beschreibt in einer Reihe von Publikationen, wie sich mit zunehmendem Alter die Lebensperspektive ändert. Er bezeichnet diese Entwicklung mit »Gero-Transzendenz« und hebt dabei folgende Punkte dieses Reifungsprozesses hervor:

- Die Beziehung zwischen Zeit und Raum verändert sich. Der Abstand zwischen Vergangenheit und Gegenwart nimmt ab.
- Das Verhältnis zu früheren Generationen entwickelt sich dahin gehend, dass man sich selbst als Teil einer gesamten Generation erlebt.
- Die Angst vor dem Tod nimmt ab, und die Auseinandersetzung mit dem Sterben als einem Teil des Lebens wird intensiver.
- Die Toleranz gegenüber Konflikten nimmt zu.
- Die Freude am und der Respekt vor dem Leben werden bewusster.

Dies wird durch Studien bestätigt, die die Einstellung alter Menschen zum Sterben hinterfragen. Ältere und Alte sind weitaus mehr mit Themen wie diesen beschäftigt als jüngere Menschen unter 60 Jahren (Cameron et al. 1973), und ihre Angst vor dem Tod ist bedeutend geringer (Marschall u. Levy. 1990; Ingebretsen u. Solem 1998).

Ein Pflegeheim soll ein Heim sein für denjenigen, der krank ist. Ein Zuhause mit Respekt vor dem Leben des Einzelnen – eine aktive Form der Lebenshilfe. Aktive Lebenshilfe beinhaltet Respekt vor dem Leben des Alten, seinen Träumen und Gedanken; sie ist eine Fokussierung auf die guten Seiten des Alltags: physisch, psychisch und sozial, vielleicht durch eine angebotene Hand, ein zurechtgelegtes Kissen oder das Begrüßen eines Menschen mit einer Freundlichkeit, die Respekt und Wertschätzung vermittelt.

Wenn die letzte Lebensphase bevorsteht, ist der Respekt gegenüber einer Person der Respekt gegenüber dem Leben, das sich dem Ende nähert – gleichsam einem Höhepunkt. Es ist an der Zeit, das Altern und unseren Umgang mit alten Menschen neu zu definieren. Wer genau hinsieht, entdeckt unerwartete Ressourcen, Lebenserfahrungen, Altersweisheiten, Reife und Schönheit. Von der Geduld, Dankbarkeit und Liebe der Alten können wir viel lernen, wie sie sich freuen über eine Aufmerksamkeit, Zuwendung oder Freundlichkeit. Oft haben sie keine Angehörigen, erhalten keinen Besuch, haben niemand, der sie in Schutz nimmt oder Erinnerungen teilt. Und hier, wo das Leben an seinen letzten geschwächten Strang geraten ist, können wir vielleicht am meisten lernen, wie z. B. von den dementen Patienten:

Beispiel aus der Praxis

Finn Hoem hat in den letzten Jahren auf unserer Demenzabteilung gewohnt. Er ist 72 Jahre alt und hat eine Alzheimer-Erkrankung. An den meisten Tagen sitzt er auf einem Stuhl auf dem Gang, betrachtet seine Schuhe oder das aufgeschlagene Buch über die norwegische Königsfamilie. Finn hat ein freundliches und offenes Wesen. Er reagiert mit Dankbarkeit auf ein liebes Wort, besonders wenn es von den Damen der Abteilung kommt. Das Personal scherzt gern mit ihm: »Finn, du liebst die Mädchen!« »Ja«, antwortet er und lacht. Aber alle wissen, am meisten liebt er Arnhild.

Finn Hoem steht häufig an seiner Zimmertür, wenn ich zur Visite komme. Er sagt dann:

»Kennst du sie?« Und ich antworte:

»Nein. Wen?«

»Arnhild! Ich warte auf sie.«

»Arnhild? Ist das deine Frau?«

»Ich weiß es nicht. Sie hat gesagt, dass sie kommt heute nachmittag – etwas später.«

»Du, Finn, Arnhild ist deine Frau. Du bist mit ihr verheiratet.«

»Ich bin verheiratet. Bin ich verheiratet? Das ist phantastisch – ich bin verheiratet!«

»Ja Finn, du bist verheiratet. Deine Frau heißt Arnhild. Ihr habt lange zusammen gewohnt, nicht weit von hier.«

»Wo?«

»Wenn du aus dem Fenster schaust, kannst du den Weg sehen, wo euer Haus steht; es ist der Weg direkt runter zum Meer.«

»Oh, das ist phantastisch – ich bin verheiratet!«

»Ja, Finn, und deine Frau heißt Arnhild.«

»Kennst du sie?«

»Wen?«

»Arnhild. Ich warte auf sie. Glaubst du, dass sie kommt?«

(Und wir wissen, Arnhild kommt jeden Tag zu Besuch.)

Literatur

American Geriatrics Society Panel on Chronic Pain in Older Persons (1998) The Management of Chronic Pain in Older Persons. J Am Geriatr Soc 46: 635–651

Anderson G (1997) Palliative care and the elderly. Rev Clin Gerontol 7: 265–72

Ahmedzai S. Palliation of respiratory symptoms (1993) In: Doyle D, Hanks J, MacDonald N (eds) Oxford Textbook of Palliative Medicine. Oxford University Press, Oxford, p 611

Allen RS, DeLaine SR, Chaplin WF (2003) Advance care planning in nursing homes: correlates of capacity and possession of advance directives. Gerontologist 43: 309–317

Asolon CM (1998) Why? Pall Med 12: 195–6

Cameron, Stewart, Z, Biber H (1973) Consciousness of death across the life span. J Geront 28: 92–95

Cavalieri TA (2002) Pain management in the elderly. J Am Osteopath Assoc 102: 481–485

Charatan F (1999) AMA issues guidelines on end of life care. BMJ 318: 690

Closs SJ, Barr B, Briggs M (2004) A comparison of five pain assessment scales for nursing home residents with varying degrees of cognitive impairment. J Pain Symptom Manage 27: 196–205

Cohen – Mansfield J, Lipson S (2002) The underdetection of pain of dental etiology in persons with dementia. Am J Alzheimers Dis Other Dement 17: 249-253

Cohen – Mansfield J, Lipson S (2002) Pain in cognitively impaired nursing home residents: How well are physicians diagnosing it? J Am Geriatr Soc 50: 1039-1044

Crook J, Rideout E, Brown G (1984) The prevalence of pain complaints in a general population. Pain 18: 299-314

Den Norske Legeforening (2002) Når du blir gammel og ingen vil ha deg. Oslo

Doyle D, Hanks J, MacDonald N (1998) Oxford Textbook of Palliative Medicine, 2nd edn. Oxford University Press, Oxford

Engedal K (1993) The prevalene of dementia in a sample of elderly Norwegians. Int J Geriatr Psychiatry 8: 565-570

Ferrel BA, Ferrel BR, Osterwell D (1990) Pain in the nursing home. J Am Geriatr Soc 38: 409–414

Ferrel BA, Ferrel BR, Rivera L (1995) Pain in cognitively impaired nursing home patients. J Pain Symptom Manag 10: 591–598

Finucane TE, Christmas C, Travis K (1999) Tube feeding in patients with advanced dementia: a review of the evidence. JAMA 282: 1365–1370

Frampton M (2003) Experience assessment and management of pain in people with dementia. Age Ageing 32: 248-251

Gagliese L, Melzack R (1997) Chronic pain in the elderly. Pain 70: 3–14

Happ MB, Capezuti E, Strumpf NE (2002) Advance care planning and end-of-life care for hospitalized nursing home residents. J Am Geriatr Soc 50: 829–825

Helsetilsynet (2002) Forhåndsvurdering ved unnlatelse av å gi hjerte-lunge-redning og journalføring av disse. IK-1/2002. Oslo: Statens helsetilsyn

Hinkka H, Kosunen E, Lammi EK (2002) Treatment decision en end-of-life scenarios involving a terminal cancer and a terminal dementia patient. Palliat Med 16: 195–204

Hirsch RD (1992) Gerontopsychiatrie. Bonn

Hjort PF (2002) Legens ansvar for kulturen i sykehjemmet. Tidsskr Nor Lægeforen 122: 1586–1588

Hunskår S (1997) Allmennmedisin. Universitetsforlaget, Oslo: 58–62
Husebø Sandgathe B, Husebø S (1998) De gamles siste timer og dager II – medikamentell behandling av plagsomme symptomer. Omsorg 2/3: 62–70
Husebø Sandgathe B, Husebø S (2001) Palliativmedizin – auch im hohen Alter? Der Schmerz 5: 350–57
Husebø Sandgathe B, Husebø S (2002) Die letzten Tage und Stunden. Medlex Verlag, Oslo (zu beziehen über die Firma Grünenthal, Aachen)
Husebø S (2003). Eldreomsorg i et nytt lys: Prosjektrapport - Hospice og palliativ care for gamle. Oslo: Norges Røde Kors
Husebø BS, Husebø SB (2004) Etiske avgjørelser ved livets slutt i sykehjem. Tidskr Nor Lægeforen 22: 2926–2927
Husebø SB (2004) Helfen am Ende des Lebens. In: Gronemeyer R (Hrsg) Palliative Care in Europa. Hospiz-Verlag, Wuppertal, S 10–15
Husebø BS, Husebø S, Hysing-Dahl B (2004) Old and given up for dying? Palliative care in nursing homes. Illness, loss and crisis 1: 75–89
Husebø BS, Husebø SB (2005) Sykehjemmene som arena for terminal omsorg - hvordan gjør vi det i praksis? Tidsskr Nor Lægeforen 125: 1352–1354
Husebø SB, Husebø BS (2005) Omsorg ved livets slutt eller aktiv dødshjelp? Tidsskr Nor Lægeforen 125: 1848–1849
Ingebretsen R, Solem PE (1998) Death, dying and bereavement. In: Nordhus IH, VandenBos GR, Berg S, Fromholt P (eds) Clinical geropsychologie. American Psychological Association, Washington DC
Jones AM, O'Connell JE, Gray CS (2003) Living and dying with congestive heart failure: addressing the needs of older congestive heart failure patients. Age Ageing 32: 566–568
Krulewitch H, London MR, Skakel VJ (2001) Assessment of pain in cognitively impaired older adults: comparision of pain assessment tools and their use by nonprofessional caregivers. J Am Geriatr Soc 49: 1397–1398
Lane P, Kuntupis M, MacDonald S (2003) A pain assessment tool for people with Alzheimer's and other progressive dementias. Home Healthc Nurse 21: 32–37
Loewy EH (1995) Ethische Fragen in der Medizin. Springer, Wien, S 12
Loewy E (1999) Persönliche Mitteilung, Wien
Marschall VW, Levy JA (1990) Aging and dying. In Binstock RH (ed) Handbook of aging and the social sciences. Academic Press, San Diego, pp 245–260
Meier-Baumgartner HP (1995) Der Geriater als Arzt zwischen Macht und Ohnmacht. Geriatr Praxis 6: 41–44
Merskey H, Lindblom U, Mumford JM, Nathan PW, Noordenbos, Sunderland S (1986) Classification of chronic pain syndromes. Pain Suppl 3
Monteleoni C, Clark E (2004) Using rapid-cycle quality improvement methodology to reduce feeding tubes in patients with advanced dementia. BMJ 329: 491–494
Morrison RS, Siu AL (2000) A comparison of pain and its treatment in advanced dementia and cognitively intact patients with hip fracture. J Pain Symptom Manage 19: 240–249
Naumann C, Barnard W (1999) Leben erhalten, sterben lassen – der geriatrische Patient im Akutkrankenhaus. Rheinisches Ärztebl 5: 23–26
Østby L (2004) Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli. Samfunnsspeilet 1: 2–17

Ott A, Breteler MMB, Vanharskamp F, Claus JJ, Vandercammen TJM, Grobbee DE, Hofman A (1995) Prevalence of Alzheimer's disease and vascular dementia – association with education – the Rotterdam study. BMJ 310: 970–973

Roberts DA (1996) Ask your ancestors and they will tell you. In: Morgan J (ed) Ethical issues in the care of the dying and the bereaved aged. Baywood, New York, pp 315–316

Roy R (1986) A psychosocial perspective on chronic pain and depression in the elderly. Soc Work Health Care 12: 27–36

Ruths S, Straand J, Nygaard HA (2003) Multidisciplinary medication review in nursing home residents: what are the most significant drug-related problems? Qual Safe Health Care 12: 176 – 180

Saunders C (1999) Persönliche Mitteilung. Conference on Love, Bergen 26.6.99

Seale C, Cartwright A (1994) The year before death. In: Brookfield VT. Ashgate Publishing Co, New York

Sintef Unimed (2003) Pasientkartlegging ved Bergen Røde Kors Sykehjem. STF78 A034507. Oslo: Sintef Unimed

Statistisk sentralbyrå (8.4.2005). www.ssb.no

Stolee P, Hillier LM, Esbaugh J, Bol N, McKellar L, Gauthier N (2005) Instruments for the assessment of pain in older persons with cognitive impairment. JAGS 53: 3219–326

Teno J, Weitzen S, Wetle T (2001) Persistent pain in nursing home residents. JAMA 285: 2081

Tornstam G (1996) Gerotranscendence. J Aging Identity 1: 37–50

Turk DC, Okifuji A (1999). Assessment of patients' reporting of pain: an integrated perspective. Lancet 353: 1784–1788

Twycross R (1997) Symptom management in advanced Cancer. Radcliffe Medical Press, Oxford, pp 148–157

United Nations Common Database (3.2.2005) United Nations Population Information Network. www.un.org/esa/socdev/ageing

Vierter Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland: Risiken, Lebensqualität und die Versorgung Hochaltriger – unter besonderer Berücksichtigung demenzieller Erkrankungen, 17.04.2002, nur online

Wall PD, Melzack R (eds) (1994) Textbook of pain. Churchill Livingstone, London

Weiner D, Peterson B, Keefe F (1999) Chronic pain-associated behaviours in the nursing home: resident versus caregivers perceptions. Pain 80: 577–588

Wilmsen-Neumann J, Husebø Sandgathe B (2002) Palliativmedizin auch für die sterbenden Alten! Klinikarzt, Stuttgart: 257–261

Winau R, Rosemeyer HP (1984) Tod und Sterben. Walter de Gruyter, Berlin 206

World Bank Group (3.2.2005) Data and statistics. world development indicators 2004. www.worldbank.org/data

Wynne CF, Ling SM, Rembsburg R (2000) Comparison of pain assessment instruments in cognitively intact and cognitively impaired nursing homes residents. Geriat Nurs 21: 19–23

Zerzan J, Stearns S, Hanson L (2000) Access to palliative care and hospice in nursing homes. JAMA 284: 2489–2494

7 Palliativmedizin im Kindesalter

B. Zernikow, S. Friedrichsdorf, W. Henkel

Die Autoren werden unterstützt durch die Vodafone Stiftung Deutschland, die Peter und Ruth Wirts-Stiftung (Schweiz), die Deutsche Kinderkrebsstiftung, und Eigenes Leben – Hilfen für Kinder mit Schmerzen oder lebensverkürzenden Erkrankungen e. V.

7.1 Einleitung

7.1.1 Geschichte der Palliativmedizin für Kinder

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts starben in deutschen Findelhäusern und allgemeinen Krankenhäusern häufig mehr als 90% aller stationär aufgenommenen Kinder. Dies führte vielfach zu einem Verbot, Kinder unter 8 Jahren stationär aufzunehmen. Daraufhin wurde 1830 an der Berliner Charité – und später auch in anderen deutschen Städten – eine Kinderabteilung eingerichtet. Von Beginn an leisteten diese Abteilungen auch eine Palliativversorgung. So beschrieb 1867 eine Kinderkrankenschwester am Bremer Kinderkrankenhaus den Tod von zahlreichen Kindern, die über Jahre stationär gepflegt worden waren [3].

Die Gründung des weltweit ersten Kinderhospizes »Helen House« im britischen Oxford bedeutete 1982 eine Zäsur für die pädiatrische Palliativmedizin: Die Gründerin Frances Domenica, Nonne und Krankenschwester, wurde durch ihre Freundschaft mit dem tumorkranken Mädchen Helen zur Einrichtung eines Hospizes für Kinder und Jugendliche inspiriert [22]. Inzwischen gibt es 31 britische Kinderhospize sowie zahlreiche Palliativeinrichtungen für Kinder in anderen Ländern. Einige Kinderhospize bieten Einrichtungen für

spezielle Altersgruppen an, so das Baby-Hospiz »Zoe's House« in Liverpool oder die Jugendabteilung von »Acorns Walsall« in Birmingham.

In Deutschland versorgen mittlerweile 8 Kinderhospize Kinder und ihre Familien in palliativen Sitationen. Seit 2003 besteht das bisher einzige Institut für Kinderschmerztherapie und Pädiatrische Palliativmedizin in Deutschland.

7.1.2 Definition der pädiatrischen Palliativmedizin

Eine pädiatrische palliative Versorgung gilt Kindern, die unter einer Erkrankung leiden, an der sie mit hoher Wahrscheinlichkeit vor dem 18. Lebensjahr sterben werden, und Kindern, die von einer potenziell tödlichen Krankheit betroffen sind, bei der eine Heilung möglich, aber unwahrscheinlich scheint. Eine pädiatrische Palliativversorgung kann sich über mehrere Jahre erstrecken.

Die in angelsächsischen Ländern gebräuchlichste Definition [5] beschreibt »paediatric palliative care« als *aktive und umfassende Versorgung, die physische, emotionale, soziale und spirituelle Bausteine miteinander verbindet. Der Schwerpunkt liegt auf der höchstmöglichen Lebensqualität für das Kind und auf der umfassenden Unterstützung für die Familie. Zur Versorgung gehört die Therapie belastender Symptome, das Vorhalten von Entlastungsangeboten und medizinisch-pflegerischer und psychosozialer Betreuung bis zum Tod und darüber hinaus während der nachfolgenden Trauerphase.*

Als Kinder sind hier Kinder und Jugendliche im Alter von 0–17 Jahren definiert. International herrscht aber Einverständnis darüber, dass Jugendliche, die gegen alle Erwartungen über das 18. Lebensjahr hinaus weiterleben, dann nicht von der pädiatrischen Palliativversorgung ausgeschlossen werden. Außerdem gibt es Krankheitsbilder (z. B. schwere Mehrfachbehinderungen oder die zystische Fibrose), bei denen gerade aufgrund einer guten pädiatrischen medizinisch-pflegerischen Versorgung die Lebenserwartung deutlich in das Erwachsenenalter ausgedehnt werden konnte.

Lebenslimitierende Erkrankungen sind Krankheiten, bei denen es keine realistische Hoffnung auf Heilung gibt und an denen die Kinder/Jugendlichen mutmaßlich vor Erreichen des Erwachsenenalters sterben werden.

Vier Gruppen lebenslimitierender Erkrankungen

- **Gruppe 1:**
  Lebensbedrohliche Erkrankungen, für die kurative Therapien existieren, wobei aber ein Therapieversagen wahrscheinlich ist. Eine palliative Versorgung kann während der Phase eines unklaren Therapieerfolges oder bei Therapieversagen notwendig sein.
  Kinder/Jugendliche in Langzeitremission oder nach erfolgreicher kurativer Therapie gehören nicht in diese Gruppe.
  Beispiele: Krebs, irreversibles Organversagen von Herz, Leber, Nieren
- **Gruppe 2:**
  Erkrankungen, bei denen lang andauernde intensive Behandlungen das Ziel haben, das Leben zu verlängern und die Teilnahme an normalen kindlichen Aktivitäten zu ermöglichen, bei denen aber ein vorzeitiger Tod wahrscheinlich ist.
  Beispiele: zystische Fibrose, Muskeldystrophie
- **Gruppe 3:**
  Fortschreitende Erkrankungen ohne therapeutische Optionen, bei denen häufig über viele Jahre eine ausschließlich palliative Therapie durchgeführt wird.
  Beispiele: Zeroidlipofuszinosen, Mukopolysaccharidosen
- **Gruppe 4:**
  Erkrankungen mit schweren neurologischen Behinderungen, die Schwäche und Anfälligkeit für gesundheitliche Komplikationen verursachen und sich unvorhergesehenerweise verschlechtern können, die aber üblicherweise nicht als fortschreitend angesehen werden.
  Beispiele: schwere Mehrfachbehinderungen wie z. B. bei Hirn- oder Rückenmarkerkrankungen (inklusive einiger Kinder mit schwerer Zerebralparese)

7.1.3 Die ACT-Charta für Kinder mit lebensbedrohlichen oder terminalen Erkrankungen und ihre Familien

Als international führende Stimme für Kinder mit lebenslimitierenden Erkrankungen hat sich ACT (*Association for Children with Life-Threatening or Terminal Conditions and their Families*) mit Sitz in Bristol, Großbritannien, etabliert. Die 1997 verabschiedete »ACT-Charta for Children with Life-Threatening or Terminal Conditions and their Families« [5] ist inzwischen international als Leitlinie für die Versorgung von sterbenden Kindern anerkannt.

ACT-Charta for Children with Life-Threatening or Terminal Conditions and their Families

1. Jedes Kind sollte mit Respekt behandelt werden, und ihm sollte unabhängig von körperlichen oder geistigen Fähigkeiten eine Privatsphäre zugestanden werden.
2. Es muss der Tatsache Rechnung getragen werden, dass Eltern den überwiegenden Teil der Versorgung ihres Kindes leisten. Eltern sollten daher als Partner angesehen und an allen ihr Kind betreffenden Entscheidungen beteiligt werden.
3. Abhängig von Alter und Entwicklungsstand sollte es jedem Kind ermöglicht werden, an Entscheidungen über seine Pflege und Versorgung mitzuwirken.
4. Jede Familie sollte die Möglichkeit haben, einen pädiatrischen Spezialisten für ihr Kind zu konsultieren.
5. Informationen sollten dem betroffenen Kind, seinen Eltern und Geschwistern sowie auf Wunsch weiteren Angehörigen verständlich sowie alters- und entwicklungsgemäß vermittelt werden.
6. Gespräche sollten einfühlsam, ehrlich und offen sowie dem Alter und der Entwicklung angemessen geführt werden.
7. Das häusliche Umfeld sollte, wo immer dies möglich erscheint, der Mittelpunkt der Pflege und Versorgung sein. Ergänzende Versorgungsmaßnahmen sollten durch pädiatrisches Fachpersonal in einer kindgerechten Umgebung durchgeführt werden.

▼

8. Jedes Kind sollte eine Schulbildung erhalten und in kindgerechte Aktivitäten integriert werden.
9. Jeder Familie sollte eine primäre Ansprechperson (»key worker« = Versorgungskoordinator) zur Verfügung stehen, die die Familie dabei unterstützt, ein Versorgungsnetzwerk zu knüpfen und dieses zu pflegen.
10. Häusliche oder kurzstationäre Entlastungsangebote mit angemessener pädiatrischer Pflege und medizinischer Unterstützung sollten von betroffenen Familien flexibel genutzt werden können.
11. Jede Familie muss eine häusliche pädiatrische Pflege in Anspruch nehmen können.
12. Die Inanspruchnahme möglicher praktischer und finanzieller Hilfen muss jeder Familie auf Wunsch durch Experten erläutert und vermittelt werden.
13. In Phasen extremer Belastung sollten jeder Familie Haushaltshilfen zur Verfügung stehen.
14. Eine Trauerbegleitung über den Tod des Kindes hinaus sollte die ganze Familie berücksichtigen und zeitlich nicht beschränkt sein.

7.1.4 Epidemiologie in der pädiatrischen Palliativmedizin

Im Erwachsenenalter sterben 3/4 aller Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie an Krebserkrankungen, meist nach längerer, häufig chronischer Erkrankung. Im Kindes- und Jugendalter sterben die meisten Kinder unmittelbar perinatal. An dritter Stelle folgen Unfälle und hier insbesondere Verkehrsunfälle, gefolgt vom plötzlichen Kindstod (SIDS). An fünfter Stelle steht der Selbstmord von Kindern und Jugendlichen.

Besonders die zweitgrößte Gruppe – Kinder und Jugendliche mit lebenslimitierenden und terminalen Erkrankungen – würde von einer organisierten Kinderpalliativmedizin profitieren.

In Deutschland leben gegenwärtig 15.640.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren [94]. Bei einer Morbidität von 12 : 10.000 [5] leben in Deutschland gegenwärtig mehr als 18.800 Kinder und Jugendliche mit einer lebenslimitierenden oder terminalen Erkrankung (Definitionen s. oben). Die durch eine lebenslimitierende Erkrankungen bedingte Mortalität beträgt in

Mitteleuropa für Kinder und Jugendliche 1,5–1,9 : 10.000 [5, 20]. Demnach sterben in Deutschland jährlich mehr als 3.000 Kinder und Jugendliche an einer lebensverkürzenden Krankheit, davon mehr als 500 an Krebs [47].

Eine US-amerikanische Untersuchung zeigt, dass jenseits des 1. Lebensjahres Krebs die häufigste Todesursache ist, gefolgt von kardiovaskulären (20%), neuromuskulären (18,5%) und genetischen (10%) Ursachen [26]. In deutschen Krankenhäusern starben 1998 insgesamt 2.753 Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Bei den 853 gestorbenen 1- bis 15-jährigen Kindern waren Krebs (23%), Verletzungen/Vergiftungen (19%) sowie kongenitale Anomalien und neuropädiatrische Erkrankungen (jeweils 10%) die häufigsten Todesursachen [94].

7.1.5 Ethik in der pädiatrischen Palliativmedizin

Obwohl der gewaltsame Tod in unseren Medien in Form von Nachrichten, Sensationsberichten, Krimis, Thrillern, Computerspielen allgegenwärtig ist, wird reales Sterben in der eigenen Umgebung so gut wie nicht wahrgenommen. Nach wie vor sind Sterben und Tod Themen, die an die professionellen Helfer (Ärzte, Pflegepersonal, Seelsorger, Bestatter) delegiert werden. Ein Grund für die Ausgrenzung des letzten Lebensabschnitts ist die Furcht vor dem eigenen Sterben [86]. Um diesem unangenehmen und Angst machenden Gefühl nicht zu begegnen, wird die Konfrontation mit Sterbenden und Trauernden vermieden.

Das drohende Lebensende von Kindern und jungen Menschen verschärft die Probleme für alle, die damit in Berührung kommen. Wenn ein alter Mensch stirbt, kann das noch als ein normales Ende eines gelebten Lebens betrachtet werden; der Tod von Kindern und jungen Menschen hingegen wird als völlig sinnlos erlebt. Da sich ein Großteil der Gesellschaft von den betroffenen Menschen abwendet, bleibt umso mehr für die professionellen Helfer zu tun. Sie wurden aber ebenso in unserer Gesellschaft sozialisiert, erleben die gleichen Ängste und mobilisieren die gleichen Abwehrmechanismen wie alle anderen [32].

Ein Mensch kann unmöglich parallel zu einer den Tod negierenden, abwehrenden Position eine positive Haltung den betroffenen Menschen gegenüber entwickeln [32]. Darum ist die Grundvoraussetzung einer professionellen palliativmedizinischen Betreuung, dass die Betreuer sich mit der

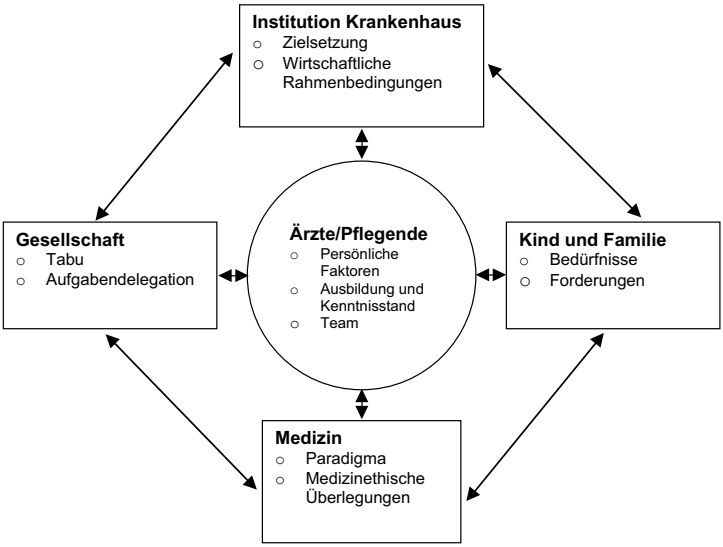


Abb. 7.1. Einflussfaktoren auf die Palliativversorgung von Kindern im Krankenhaus

Endlichkeit ihres eigenen Lebens intensiv auseinandergesetzt haben. In der Ausbildung von Ärzten findet dieser Themenbereich noch nicht ausreichenden Niederschlag, in der Ausbildung des Pflegepersonals ist erst seit der 1985 verabschiedeten Ausbildungs- und Prüfungsverordnung die Versorgung Sterbender als Bestandteil der Ausbildung verankert [57]. Daraus folgt zumindest für die Ärzte, dass die Auseinandersetzung mit dem Tod erst im Rahmen der alltäglichen Patientenversorgung erfolgt und die jungen Ärzte so ihre Position finden müssen (▶ Kap. 1 »Palliativmedizin«).

Durch das Studium und die Arbeit im Krankenhaus werden sie aber gleichzeitig auf das Handlungsziel, Menschen zu heilen, fixiert. Das Sterben eines Menschen wird immer noch als Versagen der Medizin betrachtet. Um Menschen palliativmedizinisch versorgen zu können, muss in diesem Bereich ein Paradigmenwechsel, sowohl auf der persönlichen Ebene als auch in dem Betrieb Krankenhaus und idealerweise auch in der Gesellschaft insgesamt stattfinden [101] (Abb. 7.1).

Besondere Problemstellungen in der palliativmedizinischen Versorgung betroffener Kinder sind:

- die Entscheidung, lebensverlängernde Maßnahmen nicht einzuleiten oder sie abzubrechen (»end-of-life-decision«),
- die Kommunikation mit dem betroffenen Kind und seinen Eltern,
- Konflikte mit den Eltern über weitere Behandlungsschritte.

End-of-life-decision

Die *Entscheidung, lebensverlängernde Maßnahmen nicht einzuleiten oder sie abzubrechen,* ist für den Kinderarzt wohl eine der größten Herausforderungen und stellt sich den Pädiatern in zunehmendem Maße. Ungeachtet des für jeden Menschen gültigen Rechts auf sein Leben gibt es Situationen, in denen sich die Frage stellt, ob das Recht auf ein würdiges Sterben höher zu bewerten ist. Um diese Entscheidung nicht im ethischen Vakuum zu fällen, benötigen die Kinderärzte Entscheidungshilfen. Es gibt einige wenige Anregungen. Die Medizinethikerin Ruth Baumann-Hölzle vom Institut Dialog-Ethik in Zürich hat mit ihrer Arbeitsgruppe das interdisziplinäre »Zürcher Modell« zur Urteilsbildung für medizin- und pflegeethische Fragestellungen in der neonatalen Intensivmedizin entwickelt, und die Arbeitsgruppe »Ethik« der Confederation of the European Specalists of Paediatrics (CESP) veröffentlichte 2001 ein Statement, in welchem Richtlinien als Entscheidungshilfen vorgestellt wurden und in dem die Ausgangssituation definiert wird [58].

Die *Richtlinien der Arbeitsgruppe »Ethik« der CESP* definieren zunächst *Situationen, in denen es denkbar ist, lebensverlängernde Maßnahmen nicht einzuleiten bzw. diese abzubrechen:*

- Das Kind wird durch unterstützende Maßnahmen unerträglich belastet.
- Lebensverlängernde Therapien stellen für das Kind unerträgliches Leiden dar, ohne dass eine Heilung oder eine deutliche Verminderung des Leidens erreichbar ist.

Situationen, in denen Pädiater ethisch verpflichtet sind, lebensverlängernde Maßnahmen nicht unter allen Umständen durch- bzw. weiterzuführen:

- Der Tod des Kindes ist ungeachtet einer optimalen Therapie unvermeidbar, und das Kind erlebt großes Leid.
- Das Kind kann nur mittels intensivmedizinischer Maßnahmen überleben, wodurch allerdings unerträgliches Leiden verlängert würde.

- Das Kind könnte zwar eine Zeitlang ohne intensivmedizinische Betreuung überleben, sein Leiden wird aber trotz adäquater palliativmedizinischer Versorgung vom Kind oder seinen Fürsprechern als unerträglich betrachtet.

Da es keine eindeutig definierbaren Grenzen zwischen der Verpflichtung gibt, die Behandlung weiterzuführen, und dem Zeitpunkt, an welchem die Behandlung eingestellt werden sollte, können die folgenden *Richtlinien* dem behandelnden Pädiater Entscheidungshilfen geben.

Grundsätzliche Vorüberlegungen

- Die Nichteinleitung oder Beendigung lebensverlängernder Maßnahmen darf nicht gegen den ausgesprochenen Willen des Kindes veranlasst werden.
- Tatsächliche oder mögliche körperliche/geistige Behinderung ist kein Grund, lebensverlängernde Maßnahmen nicht einzuleiten oder zu beenden.
- Finanzielle oder andere materielle Gründe dürfen die Entscheidung, lebensverlängernde Maßnahmen nicht einzuleiten oder zu beenden, nicht beeinflussen.
- Die Entscheidungen, lebensverlängernde Maßnahmen nicht einzuleiten oder sie zu beenden, sind ethisch gleichwertig und nach gleichen Maßstäben zu entscheiden.
- Die Entscheidung, lebensverlängernde Maßnahmen nicht einzuleiten oder sie zu beenden, darf nicht überstürzt getroffen werden.

Die konkrete Entscheidungssituation

- Wenn die Entscheidung, lebensverlängernde Maßnahmen nicht einzuleiten oder zu beenden, im Raum steht, sollten der behandelnde Pädiater, ein zweiter Gutachter und evtl. eine Ethikkommission auf der Basis des verfügbaren medizinischen Wissens zu dem Ergebnis kommen, dass eine Heilung ausgeschlossen ist. Vorher muss sichergestellt sein, dass Diagnose, Prognose und alternative Behandlungsmöglichkeiten sorgfältigst geprüft und im pädiatrischen Team diskutiert wurden. Der Pädiater ist zwar verantwortlich für die Entscheidung, sollte diese aber mit dem Kind, seinen Eltern /Erziehungsberechtigten und den Mitgliedern des Behandlungsteams gemeinsam treffen.

- Bei Unsicherheiten in der Bewertung der Situation des Kindes sollte das Kind weiterhin in seiner Fähigkeit zu leben unterstützt werden.
- Es können unterschiedliche Bewertungen der Situation des Kindes und unterschiedliche Auffassungen über das weitere Vorgehen bestehen, die es notwendig machen, einen Rechtsbeistand hinzuzuziehen.
- Jede Entscheidung eines Pädiaters, lebensverlängernde Maßnahmen nicht einzuleiten oder zu beenden, sollte ausführlich und vollständig dokumentiert sein und für Überprüfungen zur Verfügung stehen.

Nach der Entscheidung, lebensverlängernde Maßnahmen nicht einzuleiten oder zu beenden

- Die Entscheidung, lebensverlängernde Maßnahmen nicht einzuleiten oder zu beenden, muss mit optimaler palliativer Versorgung gekoppelt sein und die maximal erreichbare Lebensqualität ermöglichen. Das beinhaltet:
  - Betreuung in günstiger Umgebung – wenn eben möglich zu Hause im Kreis der Familie,
  - maximale medizinisch-pflegerische Versorgung, wodurch v. a. Leiden unter Durst, Hunger und Schmerzen unbedingt verhindert werden sollte,
  - psychosoziale und seelsorgerliche Betreuung,
  - Unterstützung des Kindes und seiner Familie in allen Lebensbereichen.
- Pädiater lehnen die intendierte Beendigung des Lebens eines Kindes durch die Verabreichung einer letalen Dosis eines Medikamentes ab. Therapien zur Minderung des Leidens oder zur Unterstützung des Erhalts der menschlichen Würde, die zu einer Lebensverkürzung führen können, werden akzeptiert, wenn die Intention eine Therapie des Kindes zu seinem Wohl ist und nicht die, das Ende des Lebens des Kindes herbeizuführen.
- Pädiater haben die Aufgabe, während des Sterbens und nach dem Tod des Kindes eine Trauerbegleitung und soziale Betreuung der Familie und v. a. der Geschwister sicherzustellen. Ebenso sollte der Pädiater danach für weitere Gespräche zur Verfügung stehen (Ergebnisse der Sektion, Sicherstellung der Trauerbegleitung und sonstigen Betreuung der Familie, z. B. in Selbsthilfegruppen).

Grundsätzlich wird gefordert, dass Pädiater und Kinderkrankenschwestern in der Betreuung betroffener Kinder und ihrer Familien sowie in der ethisch

fundierten Entscheidungsfindung in Bezug auf nicht einzuleitende oder zu beendende lebensverlängernde Maßnahmen geschult werden.

Das *interdisziplinäre »Zürcher Modell« zur Urteilsbildung für medizin- und pflegeethische Fragestellungen in der neonatalen Intensivmedizin* [69] siedelt die ethische Entscheidungsfindung in einem »inneren Kreis« an, dem die Ärzte und Pflegenden angehören, die das Kind betreuen. Ein »äußerer Kreis« (erfahrene Pflegende und Ärzte, evtl. zusätzliche Fachpersonen) hat beratende Funktion. Eltern und der Chefarzt sind durch entsprechende Gesprächsstrukturen eingebunden und verfügen über ein Vetorecht, wenn sie die Entscheidung des inneren Kreises nicht mittragen. Der Entscheidungsfindungsprozess ist in sieben Schritte gegliedert:

- Der medizinische und pflegerische Sachverhalt wird zusammengetragen.
- Der Lebenskontext des Kindes wird betrachtet.
- Das ethische Dilemma wird formuliert.
- Die ethische Güterabwägung erfolgt anhand von vier Fragen:
  - Wie groß sind die Überlebenschancen, wenn die Intensivmaßnahmen fortgesetzt oder unterlassen werden?
  - Wie belastend und schmerzhaft sind weitere lebenserhaltende Maßnahmen für das Kind?
  - Wann wird das Kind nicht mehr von medizinischen Maßnahmen abhängig sein, und: kann es von den Apparaten befreit werden?
  - Welche irreversiblen, langfristigen Schäden sind zu erwarten?
- Konsensfindung und Verhaltensentscheid.
- Festlegung der Elternbetreuung.
- Überprüfung der Entscheide mittels statistischer Auswertung und Evaluationsrunden mit anderen Klinikmitarbeitern sowie in ethischen Konferenzen.

7.1.6 Kommunikation in der pädiatrischen Palliativmedizin

Die Kommunikation mit palliativmedizinisch zu versorgenden Kindern und ihren Eltern stellt an die Gesprächsführungskompetenz aller professionellen Betreuer hohe Anforderungen. ◘ Abb. 7.2 zeigt personale Basisfaktoren der Interaktion Kind-Eltern-Klinikteam.

Kinder fordern entsprechend ihrem Alter und Entwicklungsstand ganz unterschiedliche Formen der Kommunikation, und die Eltern befinden sich

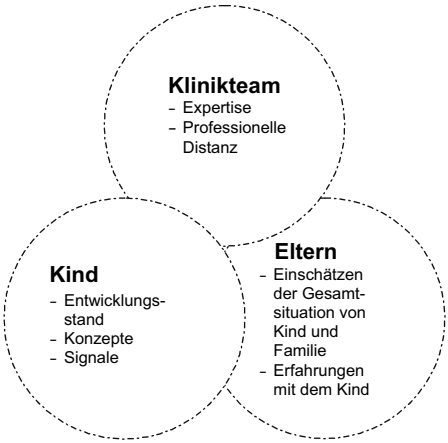


Abb. 7.2. Personale Basisfaktoren der Interaktion Kind-Eltern-Klinikteam

in einer persönlich sehr leidvollen Situation und haben oftmals unrealistische Vorstellungen bezogen auf die Heilung ihres Kindes [43]. Um eine gute Kooperation von Kindern und Eltern zu erreichen, müssen sie in ihrer Situation wahrgenommen und entsprechend den Bedürfnissen ganzheitlich betreut werden (▶ Kap. 7.1.3).

Ein individuelles Zugehen auf einen Menschen bedingt, dass alle bewusste Kategorienbildung in der Interaktion unterbleibt und nur der Mensch in seiner jetzigen Befindlichkeit und Bedürfnislage sowie die eigene Befindlichkeit und Bedürfnislage im Mittelpunkt der Kommunikation stehen. Die Vorstellung »Ich untersuche ein Kind, das bald sterben wird« behindert durch die enorme Anforderung, die die meisten in einer solchen Situation an sich stellen, eine authentische Begegnung mit dem Kind.

Die Beobachtung »Dieses große Schulkind, das weiß, dass sein Leben bedroht ist, hat Angst vor der Untersuchung, Mutter/Vater ist dabei, ist kooperativ und unterstützt das Kind wirkungsvoll, das Kind hat im Moment keine Schmerzen« macht ein viel offeneres und konkretes Miteinander möglich. Das Interesse gilt dem Patienten in der konkreten Situation und ermöglicht so adäquates Handeln.

Die besondere Konstellation: krankes Kind – Eltern – Kinderärzte und Kinderkrankenschwestern kann zu einer gestörten Interaktion der Beteiligten führen. Die Eltern sind in der Regel die ersten Ansprechpartner, lediglich bei

Jugendlichen kann – in enger Abstimmung mit den Eltern – auch das Kind der primäre Gesprächspartner sein.

Auch wenn Eltern Positionen beziehen, die von den professionellen Betreuern abgelehnt werden, müssen Ärzte und Schwestern immer berücksichtigen, dass die Beziehung zu den Eltern für das Kind existenziell wichtig ist und sie lediglich eine komplementäre Rolle ausfüllen. Konflikte können dann auftreten, wenn Eltern und die medizinisch-pflegerischen Betreuer des Kindes unterschiedliche Wege beschreiten wollen. Kinder spüren solche Auseinandersetzungen und müssen dann in der fremden Umgebung Krankenhaus eine Betreuung durch Ärzte und Schwestern hinnehmen, die andere Positionen als die Eltern vertreten und denen die Eltern kein Vertrauen oder Ablehnung entgegenbringen.

Anstatt das Gefühl vermittelt zu bekommen, alle seien an seinem Wohl interessiert, wird das Kind verunsichert. Dadurch wird eine Kettenreaktion ausgelöst: Unsicherheit – Angst – Anspannung/Stress – Schmerzen werden verstärkt – negative Auswirkungen auf die Gesamtbefindlichkeit. Zusätzlich befindet sich das Kind damit in einem Loyalitätskonflikt, der die Situation des Kindes zusätzlich erheblich erschwert.

Häufig ergibt sich ein solcher Konflikt, wenn die Eltern dem Kind verschweigen wollen, dass es lebensbedrohlich erkrankt ist, Kinderärzte und Kinderkrankenschwestern aber offen mit dem Kind kommunizieren wollen [29]. Wie Henkel in einer kleinen, nicht standardisierten Studie 1988 ermittelte, empfindet eine deutliche Mehrheit (20 von 32) der Kinderkrankenschwestern es als »unangenehm« bis »fürchterlich«, wenn ein offenes Gespräch mit dem Kind nicht möglich ist [40]. Zusätzlich zu der ohnehin belastenden Arbeit mit lebensbedrohlich erkrankten Kindern sehen sich die Betreuer noch daran gehindert, ehrlich mit den Kindern zu kommunizieren, und die Kinder sind mit ihren Ängsten auf sich allein gestellt [29]. Schon kleine Kinder können erspüren, dass ihr Leben bedroht ist, und sie brauchen die Gewissheit, mit jemand Vertrautem darüber reden zu können. [29, 53].

Jonathan (14 Jahre):

> Ich finde, man sollte Kindern sofort sagen, wenn sie sterben müssen. Man hat dann zwar Angst, aber man weiß dann, was los ist.

Kinder können – genau wie Erwachsene – aus der Gesamtsituation auf ihren bedrohlichen Zustand schließen: Sie werden/wurden, u. U. über einen langen

Zeitraum hinweg, immer wieder teilweise schmerzhaften Untersuchungen und therapeutischen Eingriffen unterzogen, erleiden/erlitten häufig Schmerzen, erlebten, dass andere Kinder mit gleichem oder ähnlichem Krankheitsbild starben, und registrieren in der Regel sehr genau die Veränderungen der Umwelt – v. a. der Familie – ihnen selbst gegenüber [51].

Natürlich möchten Eltern von ihrem Kind alles Negative fern halten, aber man muss mit ihnen gemeinsam klären, wie die beste Lösung für das Kind aussehen könnte.

Kreicbergs (2004) führte eine landesweite Befragung von Eltern verstorbener Kinder in Schweden durch. Eltern, die mit ihren Kindern über deren möglichen Tod gesprochen hatten, bereuten diese offene Kommunikation nicht. Fast 1/3 der Eltern, die mit ihren Kindern keine Gespräche über das mögliche Sterben geführt hatten, bedauerten das später [56].

Grundlegend zu berücksichtigen sind

- der allgemeine kognitive Entwicklungsstand des Kindes,
- seine Konzepte von »Gesundheit – Krankheit« und »Leben – Sterben – Tod«,
- Erfahrungen der Eltern mit dem Kind in bedrohlichen Situationen,
- Einschätzung der Gesamtsituation des Kindes durch die Eltern,
- Einschätzung der Gesamtsituation des Kindes durch professionelle Betreuer,
- Signale (Bilder, Verhalten, Andeutungen, Symbole) oder auch direkte Fragen des Kindes in Bezug auf seinen Zustand und seine Perspektive.

Eine ganz besondere Herausforderung für Ärzte und Pflegende stellen Eltern dar, die sich bewusst gegen eine mögliche wirksame Therapie entschieden haben und deren Kind sich nun in einer lebensbedrohlichen Situation befindet. Hier gibt es oftmals – ausgesprochen oder unterschwellig – Schuldzuweisungen an die Eltern, die auch für das Kind belastend sind (s. oben). Eine solche Situation kann nur durch erhebliche Anstrengungen und mit Hilfe von z. B. Psychologen und Seelsorgern zu einer für das Kind hilfreichen Lösung gebracht werden.

Die Fähigkeit der professionellen Betreuer zu einer offenen, personenzentrierten Interaktion mit den lebensbedrohlich erkrankten Kindern und ihren Eltern bzw. der Familie bildet die Grundvoraussetzung für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Eine gute Kooperation ist in Bezug auf die medizinisch-pflegerische Versorgung die Grundlage dafür, den Kindern und ihren Familien ein Höchstmaß an Lebensqualität zu ermöglichen.

7.1.7 Todesvorstellungen von Kindern und deren Bedeutung für die Kommunikation

Todeskonzepte von Kindern

Ein Problem in der Kommunikation mit Kindern stellt das oft nur unzureichende Wissen über die Fähigkeit von Kindern, die Welt zu begreifen, dar. Im Kontakt mit lebensbedrohlich erkrankten Kindern ist es sowohl für die Betreuer als auch für das Kind von großer Bedeutung, ob der Betreuer die Äußerungen des Kindes auf der Grundlage seiner kognitiven und emotionalen Entwicklung einordnen kann.

Der Begriff »Tod« ist wie alle anderen Begriffe zunächst lediglich eine Worthülse ohne Bedeutung – erst allmählich kann ein Kind dieses Wort kognitiv und emotional mit Inhalt füllen, also ein Konzept entwickeln (Abb. 7.3). Voraussetzung zur Entwicklung des Konzeptes »Tod« ist eine schon vorhandene Vorstellung von dem Begriff »Leben« [11].

Die Ergebnisse neuer empirischer Studien entwickeln ein *Zweistufenmodell zum Erwerb des Todeskonzeptes* [102]:

- Prämodernes Todeskonzept (4–10 Jahre), in dem die Subkonzepte »Universalität«, »Irreversibilität«, »Nonfunktionalität« und »Kausalität« erschlossen werden.
- Modernes Todeskonzept (>10 Jahre), in dem philosophische bzw. spirituelle Konzepte einer möglichen weiteren Existenz entwickelt werden.

Abb. 7.3. Entwicklung des Todeskonzeptes bei Kindern

Dennoch haben die älteren Modelle noch eine Bedeutung, weil sie durch ihre Anschaulichkeit einen einfacheren Transfer in die alltägliche Arbeit ermöglichen und deshalb weiterhin über eine praktische Relevanz verfügen. Diesen älteren Erkenntnissen liegen die Entwicklungstheorien von Sigmund Freud (emotionale Entwicklung) und Jean Piaget (kognitive Entwicklung) zugrunde. Die *Entwicklung des Todeskonzeptes* erfolgt hier in fünf Phasen und betrifft vier Subkonzepte. Dabei ist diese Einteilung lediglich als Orientierungshilfe und keinesfalls als starres Schema zu verstehen.

Einflussfaktoren auf das Todesverständnis sind der intellektuelle und emotionale Reifegrad, die eigene lebensbedrohende Erkrankung, das Miterleben von Sterben und Tod, Todeskonzepte der Primär- und Sekundärgruppen, Konfrontation mit Sterben und Tod in Gesprächen, Literatur, Medien und Unterricht, hoher Fernsehkonsum und häufiges Spielen von Computerspielen, in denen »Personen« »neutralisiert« werden müssen.

Todeskonzept von Kindern

- 0 bis etwa 1,5 Jahre

  Das Kind
  - erlebt sich als Einheit mit der Bezugsperson, wobei eine Vernachlässigung des Kindes den Aufbau des Urvertrauens stört. Es entwickelt das Gefühl bezogen auf die Primärmacht Tod basierend auf dem Urvertrauen.
  - kann zwischen belebten und unbelebten Objekten unterscheiden.
  - erlebt Verlust nur mittelbar durch die Gefühlsäußerungen der Bezugspersonen.
- 0 bis etwa 1,5 Jahre

  Das Kind
  - entwickelt sein Selbstverständnis, d. h. es begreift, dass es unabhängig von seiner Bezugsperson existiert.
  - lernt, dass Personen/Objekte auch dann existieren, wenn sie für das Kind selbst nicht sichtbar sind (Objekt-/Personpermanenz).
  - setzt Tod mit Unbeweglichkeit und Schlaf gleich.
  - definiert Tod als »nicht leben« im Sinne von: Der Mensch atmet nicht mehr etc.

▼

- 0 bis etwa 1,5 Jahre
  Das Kind
  - glaubt durch Allmachtsphantasien, den Tod für sich selbst und nahe Bezugspersonen verhindern zu können.
  - entwickelt ein Verständnis dafür, dass bestimmte Menschen (z. B. Alte oder Verletzte) sterben müssen.
  - erkennt Tod als Folge von äußerer Gewalteinwirkung.
  - hat die Vorstellung, Tod sei ein anderer Zustand der Existenz, z. B. einem Leben im Himmel.
- 0 bis etwa 1,5 Jahre
  Das Kind
  - kann die Endlichkeit von Zuständen erkennen.
  - versteht den Tod als irreversiblen Vorgang.
  - betrachtet Tod als endgültiges Ende aller Vitalfunktionen.
  - hat die Erkenntnis, dass der Tod universal ist.
  - kann innerorganische Todesursachen verstehen.
  - hat oft Verstümmelungsängste (vgl. [7]).
- 11 bis 14 Jahre
  Das Kind
  - versteht Tod als definitiven Abbruch aller menschlichen Beziehungen.
  - Kind erlebt eine Zeit, in der die Angst vor dem Tod am stärksten ausgeprägt ist, da es sich ohnehin schon in einer Phase der Loslösung und Neuorientierung befindet, die für sich genommen Unsicherheit und starke Ängste auslösen können.

Kinder, die lebensbedrohlich erkrankt sind, entwickeln häufig schon früher ein realistisches Verständnis vom Tod.

Bedeutung kindlicher Todeskonzepte für die Kommunikation mit ihnen

Um mit Kindern über Tod und Sterben kommunizieren zu können, braucht man zunächst Klarheit darüber, welche konzeptuellen Vorstellungen das Kind hat und in welcher emotionalen Grundbefindlichkeit das Kind lebt. Dieses Wissen hilft, adäquat auf die verbalen und nonverbalen Signale des Kindes

zu reagieren. Dabei ist die Haltung des Betreuers außerordentlich wichtig. Kinder spüren sehr schnell, wenn man kein echtes Interesse an ihnen hat, und werden dann unkooperativ oder sogar misstrauisch und verschlossen.

Kinder *bis ca. 1,5 Jahre* brauchen gemäß dem oben aufgezeigten Entwicklungsschema Bezugspersonen, die mit ihnen kuscheln, spielen und für sie da sind, um dem diffusen Angstgefühl ein Erleben von Geborgenheit und Sicherheit entgegenzusetzen. Die Kommunikation erfolgt überwiegend auf der non- oder präverbalen Ebene.

Kinder von etwa *1,5–3,5 Jahren* sind ebenfalls auf alle oben genannten Formen der Zuwendung angewiesen. Durch ihre Fähigkeit, Belebtes von Unbelebtem zu unterscheiden, können sie schon erkennen, ob z. B. das Familienhaustier oder ein anderes Tier gestorben ist. Ebenso vermissen sie Menschen aus dem nahen Umfeld, zu denen sie eine alltägliche Bindung hatten. Das kann, neben der Trauer über den Verlust des geliebten Menschen oder Tieres, durchaus auch zu Fragen nach dem Verstorbenen führen.

Diese Fragen kann jeder Betreuer nur aus seinem Verständnis von Leben und Tod beantworten. Aber grundsätzlich sollte man auch Kinder in diesem Alter nicht anlügen, um ihnen Kummer zu ersparen. Man muss Bilder finden, die die Kinder verstehen können. Auf keinen Fall sollte man die Euphemismen »Schlaf« oder »Er/sie ist auf eine lange Reise gegangen« für »Tod« verwenden, da Kinder dann erhebliche Schlafstörungen bzw. Ängste vor Reisen entwickeln können.

Angst kann sich bei Kindern ganz vielgestaltig zeigen. Sie kann sich in aggressivem, regressivem Verhalten oder in Rückzug und Misstrauen äußern. Gerade weil die Kinder dieser Altersgruppe sich nur sehr begrenzt verbal mitteilen können, kommt es darauf an, das Kind genau zu beobachten, um eine möglichst genaue Vorstellung von der Welt des Kindes zu erhalten und dem Kind möglichst sichere und zuverlässige äußere Umstände und Geborgenheit zu geben.

Mit *3,5–7 Jahren* leben Kinder in einer magischen Welt. In Kombination mit ihrer kindlichen Egozentrik haben sie die Vorstellung, alles sei möglich, und ihre eigenen Wünsche könnten den Tod von ihnen selbst und ihren Bezugspersonen verhindern oder verursachen. Kinder, die in diesem Alter den Verlust von Geschwistern, einem Elternteil oder anderen Bezugspersonen verschmerzen müssen, glauben häufig, sie seien schuld an dem Tod des Menschen, weil sie »nicht lieb« oder/und weil sie »böse auf den Menschen« waren. Darum ist es sehr wichtig, mit den Kindern im Kontakt und im Ge-

spräch zu bleiben und ihnen begreiflich zu machen, dass nicht sie für den Tod verantwortlich sind, sondern der Verstorbene an einer Krankheit etc. gestorben ist.

Kinder dieser Altersgruppe sind von einem unbändigen Forscherdrang beseelt und wollen wissen, wie z. B. ein toter Mensch aussieht oder wie ein Vogel jetzt aussieht, der einige Zeit vorher begraben wurde, und wo denn nun die Toten sind.

Beispiel aus der Praxis

Anna-Lena hat mit 6 Jahren ihren verstorbenen Opa im Aufbahrungsraum besucht. Im Gegensatz zu ihrem 2 Jahre älteren Bruder wollte sie mitgehen, um ihren Opa noch einmal zu sehen und sich von ihm zu verabschieden.

Über einen langen Zeitraum nach dieser direkten Konfrontation mit dem Tod vermied sie die Auseinandersetzung mit dem Thema. Sie wollte nicht darüber reden und auch keine Bilderbücher oder Filme dazu anschauen. Mit 12 Jahren sagt sie dazu: »Natürlich war das doof für mich, dass Opa tot war, aber es war gut, dass ich mitgegangen bin. Ich konnte ihn noch mal sehen und mich von ihm verabschieden.«

Kinder, die selbst lebensbedrohlich erkrankt sind, können das Bedürfnis haben, über den nahen Tod zu sprechen.

Beispiel aus der Praxis

Uwe (4,5 Jahre) hatte schon mehrere Rückfälle in seinem Kampf gegen die Leukämie. In den letzten Wochen fragte er viel über den Tod und wollte unbedingt wissen, ob er seinen Geburtstag noch erleben würde. [7]

Kinder von *7–10 Jahren* verfügen über ein mehr oder weniger realistisches Todeskonzept. Dieses Wissen um die eigene Vergänglichkeit und die Möglichkeit, jederzeit einen geliebten Menschen verlieren zu können, macht den Kindern Angst. Dazu kommt noch die gerade in diesem Alter ausgeprägte Verstümmelungsangst, die für Kinder mit lebensbedrohenden Erkrankungen bei all den notwendigen Eingriffen immer wieder neu erlebt wird:

Beispiel aus der Praxis

Maria, 7 Jahre alt, ein leukämiekrankes Kind, hatte eine ernsthafte Infektion an ihrem Daumen. Nachdem wir einige Minuten mit ihr darüber (ihre Angst – Anm. d. Verf.) gesprochen hatten, erklärte Maria, dass ihre Sorge darin bestehe, dass der Daumen ihr abgenommen werden könnte. [7]

Aus diesem Beispiel kann man schon erkennen, dass Kinder dieser Altersgruppe sowohl ein sicheres Umfeld (Bezugsperson, materielle Umwelt im Krankenhaus so ausstatten, dass das Kind sich wohl fühlen kann: Wohnlichkeit der Räume, Farbgestaltung, eigene Kuscheltiere/Spielzeug mitbringen können, Wunschkost, Beschäftigung des Kindes entsprechend seinen Wünschen und Vorlieben) als auch Gespräche über ihre Situation brauchen. Diese Gespräche richten sich nach den Bedürfnissen des Kindes und niemals nach den pädagogischen Überzeugungen des Betreuers (▶ Kap. 7.1.3).

Wichtig

Das Kind bestimmt den Gesprächspartner, das konkrete Gesprächsthema, den Grad der Offenheit, die Dauer usw.

Kinder von *10–14 Jahren* verfügen über ein realistisches Todeskonzept und beginnen mit der Entwicklung ihres philosophischen oder spirituellen Weltbildes. Das Thema »Gerechtigkeit«, ob bezogen auf konkrete Situationen im schulischen oder familiären Alltag oder aber auf soziale oder politische Fragen, spielt eine große Rolle. Für Kinder mit einer lebensbedrohlichen Krankheit bekommen solche Überlegungen noch eine ganz persönliche Dimension: Ist es gerecht, wenn ich todkrank bin, während andere ihr Leben weiterleben und genießen können? Natürlich ist es nicht gerecht, aber: Kann man für sich persönlich einen Sinn in der Erkrankung erkennen?

Beispiel aus der Praxis

Die Mutter eines 15-jährigen Mädchens, das an myeloischer Leukämie erkrankt ist, sagte dieser Tage zu mir: »Sie werden sich vielleicht wundern, dass wir so heiter sind, das Kind, mein Mann und ich. Wir glauben, dass Gott weiß, was gut für uns ist.« (Aus: [38])

In dem Buch »Tränen im Regenbogen« [54] sind Geschichten, Gedichte und Berichte von tumorkranken Kindern abgedruckt. Man bekommt einen direkten Einblick in die Erlebens- und Verständniswelt der Kinder. Alle Geschichten sind gekennzeichnet durch einen burschikosen, etwas distanzierten und leicht ironisierenden Ton. Besonders beeindruckend ist der Rückblick von Ingo Bruns [54], aber leider zu umfangreich für einen Abdruck an dieser Stelle.

Schwierige Gespräche zu führen ist eine hohe Kunst, die den Menschen in seiner Gesamtheit fordert. Das gilt in besonderem Maße für Gespräche über Tod und Sterben mit Kindern. Viele sehen die Ansprüche an die eigene

Kommunikationsfähigkeit als unerreichbar hoch an, sodass sie lieber gleich kapitulieren und schwierigen Gesprächen mit Kindern und Eltern ausweichen [32]. Dabei ist zu bedenken, dass Gesprächsführung erlernt werden kann (▶ Kap. 3). Für betroffene Kinder und ihre Familien ist nichts schwerer zu ertragen als eine Kontaktvermeidung. Sie fühlen sich dann als Person abgelehnt und können in den wenigsten Fällen erkennen, dass die Unsicherheit der Betreuer Grund für den Rückzug ist.

Immer wieder gibt es während der Betreuung von lebensbedrohlich erkrankten Kindern und ihren Familien Situationen, in denen ein Teammitglied eine Auszeit benötigt. Es ist für die persönliche Psychohygiene außerordentlich wichtig, über die Möglichkeit eines solchen Rückzuges zu verfügen. Eine Interaktion von Kind und Familie mit einem Betreuer, der für diese Kontakte im Moment keine seelische Kraft hat, zerstört möglicherweise aufgebautes Vertrauen. Günstiger ist es dann, ein anderes Teammitglied zu bitten, die Aufgabe zu übernehmen. Für die Ärzte und die Pflegenden ist die Arbeit mit lebensbedrohlich erkrankten Kindern auf Dauer nur in einem funktionierenden Team leistbar. Auch hier ist kommunikative Kompetenz gefragt, und die Offenheit und Vertrautheit im Team kann Sicherheit im Umgang mit schwierigen (Gesprächs-)Situationen fördern und eine wichtige und notwendige Unterstützung in solchen Situationen sein.

7.2 Status Quo der Palliativmedizin in der Pädiatrie

Bezogen auf die Betreuung sterbender Kinder in Deutschland gibt es keine prospektiven Therapiestudien. Ein bundesweites Dokumentationssystem zur Erfassung der Therapien und Nebenwirkungen in der Lebensendphase (KernPäp) befindet sich in der Erprobungsphase. In den Lehrplänen für medizinisches Fachpersonal findet die pädiatrische Palliativmedizin keine Berücksichtigung. Es gibt nur sehr wenig und fast ausnahmslos englischsprachige Literatur über die Behandlung von Symptomen und Therapienebenwirkungen sowie zur psychosozialen Versorgung von sterbenden Kindern. Zudem existieren keine Leitlinien zur Versorgung von palliativen Patienten. In einer von der Deutschen Krebsgesellschaft in Auftrag gegebenen Untersuchung heißt es 1998 zur Lage der Palliativmedizin bei Erwachsenen:

> Der gegenwärtige Stand der Palliativmedizin in Deutschland ist kümmerlich, miserabel, extrem schlecht, der Wissensstand der meisten Ärzte bescheiden. Die Öffentlichkeit schließlich hat überhaupt keine Ahnung, wer sollte ihr auch eine solche vermitteln. Es fehlen jedoch nicht nur diese eher organisatorischen Voraussetzungen, der Gedanke der Palliativmedizin ist als solcher im medizinisch-akademischen Betrieb nur schemenhaft präsent [87].

Dies gilt nach Erfahrungen der Autoren uneingeschränkt auch für die Palliativmedizin bei Kindern. In Deutschland gibt es eine positive Entwicklung durch die Etablierung von inzwischen 8 Kinderhospizen (Olpe, Gelsenkirchen, Wiesbaden, Berlin, Hamburg, Syke bei Bremen, Düsseldorf, Mannheim). Ein weiteres Kinderhospiz in Memmingen befindet sich im Bau. Der Schwerpunkt der Versorgung ist der einer Kurzpflegeeinrichtung (»Respite Care«). Nur einige Kinderhospize verfügen über ein Angebot einer umfassenden häuslichen medizinisch-pflegerischen palliativen Rund-um-die-Uhr-Versorgung sowie die fehlende kontinuierliche Zusammenarbeit von Spezialisten aus dem Bereich der Pädiatrie (Onkologie, Hämatologie, Neuropädiatrie, Kinderkardiologie, Kinderschmerztherapie etc.).

7.3 Umfassende Palliativversorgung

7.3.1 Anforderungen an ein Kinderhospiz/ Kinderpalliativzentrum

Im Gegensatz zur landläufigen Meinung handelt es sich bei einem Kinderhospiz nicht um ein Sterbehaus für Kinder und Jugendliche. Fast alle Länder, die etablierte Strukturen einer pädiatrischen Palliativversorgung aufweisen, respektieren den Wunsch der Kinder und ihrer Familien auf eine häusliche Versorgung.

Während das Warschauer Kinderhospiz eine ausschließlich häusliche Versorgung anbietet, bieten britische Kinderhospize für Kinder mit schon mutmaßlich vor dem Erreichen des Erwachsenenalters zum Tode führenden Erkrankungen eine Kurzpflege als Urlaub über einen Zeitraum von bis zu zwei Wochen an oder bei Bedarf eine längere Versorgung in der terminalen Phase. Von britischen Kinderhospizen versorgte Kinder und Jugendliche ster-

ben überwiegend zu Hause und nur im Ausnahmefall im Hospiz. International und auch in Deutschland verstehen sich Kinderhospize als Servicecenter, die eine häusliche medizinisch-pflegerische und psychosoziale Versorgung sowie Geschwisterarbeit und Trauerprogramme anbieten.

Folgende Mindestanforderungen stellen die Autoren an ein Kinderhospiz/Kinderpalliativzentrum:

- Schwerpunkt auf häusliche medizinisch-pflegerische und psychosoziale Betreuung,
- Angebot eines Kurzpflegeaufenthalts für das betroffene Kind (im Sinne von »Urlaub für das Kind« und Entlastung für die Eltern),
- differenzierte altersentsprechende Angebote für die verschiedenen Altersgruppen (Babys, Kleinkinder, Schulkinder, Jugendliche),
- Möglichkeit eines kurzen stationären Aufenthalts zur »palliativen Einstellung« bei im häuslichen Umfeld nicht beherrschbaren Symptomen,
- Einbeziehung von Spezialisten der entsprechenden pädiatrischen Subspezialität in die medizinische Versorgung,
- umfassende Geschwisterbetreuung,
- (im Ausnahmefall bei z. B. schwierigen Wohnverhältnissen) Sterbemöglichkeit innerhalb der Einrichtung, Möglichkeit der Aufbahrung,
- Trauerbegleitung für Eltern und Geschwister über den Tod des Kindes hinaus,
- eine spirituelle Betreuung nach den Wünschen der Familie,
- eine professionelle Supervision der ehrenamtlichen und professionellen Helfer (»Hilfe für die Helfer«).

7.4 Therapie von Symptomen in der Lebensendphase

7.4.1 Symptome in der Lebensendphase

Wolfe [103], Goldman [35] sowie Dangel [19, 20] erfassten die Symptome von 415 an lebenslimitierenden Erkrankungen gestorbenen Kindern und Jugendlichen. Demnach litten fast alle Kinder unter Schmerzen. Mehr als zwei Drittel der Kinder beklagten Appetitlosigkeit und Müdigkeit, über die Hälfte litt an Übelkeit und Erbrechen sowie Dyspnoe (Tab. 7.1). 46% der Kinder hatten Angst. Wolfe konnte in ihrer Untersuchung von krebskranken Kindern in der Lebensendphase zeigen, dass viele belastende Symptome von den be-

handelnden Ärzten nicht erkannt wurden, und falls die Symptome dann doch behandelt wurden, war die Therapie häufig ineffektiv (Abb. 7.4).

Tab. 7.1. Symptome von Kindern und Jugendlichen in der Palliativsituation nach Wolfe [103], Goldman [35] und Dangel [19, 20]

Symptom	Prävalenz [%]
Schmerzen	86
Appetitlosigkeit	75[a]
Müdigkeit	64
Erbrechen	59
Dyspnoe	54
Obstipation	49

[a] Symptom bei Dangel [19, 20] nicht erfasst, Prävalenz bezogen auf Wolfe [103] und Goldman [35]

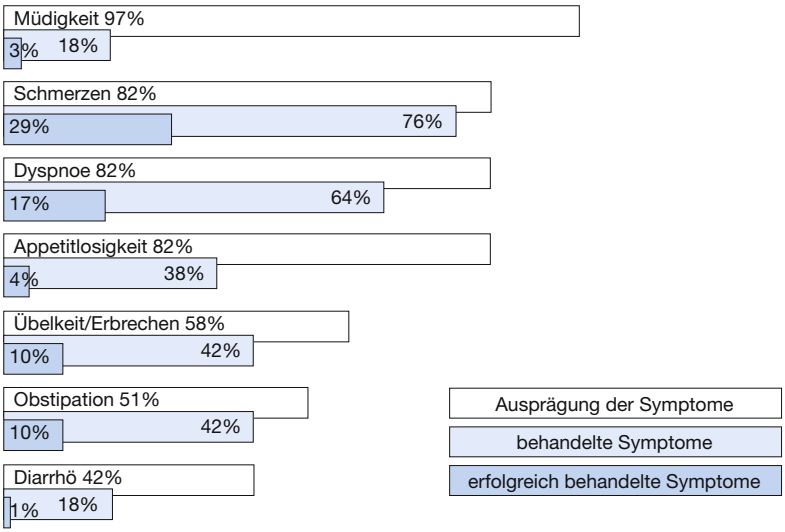


Abb. 7.4. Symptome von 92 Kindern mit Krebs im letzten Lebensmonat. (Nach [103])

7.4.2 Erfassung der Symptome und Bedürfnisse des Kindes

Die Daten von Wolfe et al. [103] führen uns eindrücklich vor Augen, wie wichtig eine Erfassung von Krankheitssymptomen auch in der Lebensendphase ist. Leider stehen hierfür in der Pädiatrie wenige validierte Instrumente zur Verfügung. Collins hat 2000 eine Memorial Symptom Assessment Scale (MSAS) erstellt [18], die 2002 ins Deutsche übersetzt wurde und über den Verein *Eigenes Leben – Hilfen für Kindern mit Schmerzen oder lebensverkürzenden Erkrankungen* (eigenes-leben-ev.de) zu beziehen ist. 30 Krankheitssymptome werden auf einer zweidimensionalen Skala erfasst: Zusätzlich zur Ausprägung des Symptoms wird die durch das Symptom verursachte Belastung erfragt. Die MSAS ist in ein Tagebuch integriert, das von den Kindern in palliativmedizinischer Betreuung ausgefüllt werden kann.

Momentan wird die für den Gebrauch in der Kinderheilkunde adaptierte und in ein Computerprogramm umgesetzte »Kerndokumentation für Palliativeinheiten« erprobt. Dieses Dokumentationssystem – KernPäp – wird derzeit schon an einigen Institutionen genutzt. Dies ist der erste Schritt hin zu einer klinikübergreifenden Qualitätskontrolle in der pädiatrischen Palliativmedizin.

7.4.3 Schmerztherapie

Status Quo

Nachdem Anfang der 1990er Jahre auf Betreiben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Konferenz zur Schmerztherapie in der Kinderonkologie stattfand, auf der Schmerztherapierichtlinien erarbeitet und Forschungsziele festgelegt wurden, dauerte es noch fast zehn Jahre, bis die WHO-Publikation *Cancer Pain Relief and Palliative Care in Children* auf den Markt kam und an deutsche Verhältnisse adaptiert wurde [88, 104, 110].

In der Palliativphase wird eine ausreichende Analgesie bei 28% der stationär und 12% der ambulant palliativ betreuten Kinder nur deshalb nicht erreicht, weil die Opioiddosis nicht konsequent gesteigert wird [91, 92].

Schmerzanamnese

Die therapeutisch wirksame Opioiddosis variiert ebenso wie das Ausmaß opioidspezifischer Nebenwirkungen interindividuell erheblich. Die anam-

nestisch erhobenen Vorerfahrungen mit Opioiden müssen bei der Auswahl und der Startdosis der Analgetika berücksichtigt werden. Der zu verordnende Applikationsmodus sollte nach der Schmerzanamnese mit dem Kind besprochen und dann individuell abgestimmt werden.

Die Frage nach den elterlichen und kindlichen Einstellungen bezüglich *Schmerz* und *Schmerztherapie* ist ein fester Bestandteil der Schmerzanamnese. Von außerordentlicher Wichtigkeit ist es, Vorbehalten starken Opioiden gegenüber begegnen zu können, um auf unbegründete Ängste eingehen zu können und letztlich ein erfolgreiches Analgetikakonzept zu entwickeln.

Schmerzmessung

Auch in der Palliativphase sollte möglichst auf Selbsteinschätzung von Schmerzen zurückgegriffen werden. Oft sind jedoch Schulkinder und Jugendliche hierzu nicht bereit. Trotz Schmerzen verweigern sie die Mitarbeit bei der Schmerzmessung. Dann sollte das Team Fremdeinschätzungsskalen verwenden, wie dies bei jüngeren oder retardierten Kindern geschieht. ◘ Abb. 7.5 enthält ein einfaches Schema zur Fremdeinschätzung bei tumorassoziierten Schmerzen. Dieses Schema ist in Anlehnung an die Empfehlung der Konsensuskonferenz der American Academy of Paediatrics von 1992 erstellt, aber bis dato nicht evaluiert worden [66, 67]. Für nicht wissenschaftliche Zwecke können bestehende Instrumente zur Schmerzeinschätzung individuell angepasst und im Rahmen einer Teamdiskussion validiert werden.

Cartoon-Schmerzgesichter können bei chronisch kranken Kindern, die in ihrer kognitiven Entwicklung häufig akzeleriert sind, ab einem Alter von ca. 3 Jahren eingesetzt werden [46]. Die Cartoon-Gesichter in ◘ Abb. 7.5 wurden modifiziert nach Pothmann [81].

Tagebücher und die Memorial Symptom Assessment Scale [18] erleichtern die Steuerung der Schmerz- und Palliativtherapie.

Medikamentöse Schmerztherapie

Die Prinzipien der medikamentösen Schmerztherapie sind sehr einfach. Nach neuesten Studien können 90% aller Schmerzen in der Palliativphase von Kindern erfolgreich behandelt werden.

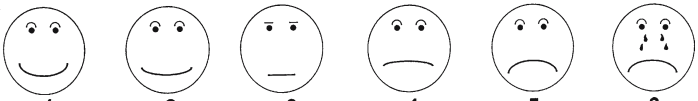
Die *Grundregeln der Schmerztherapie* in der Palliativphase sind für Kinder und Erwachsene gleich:

Schmerzmessung bei <2,5 Jahre alten Kindern

	Ja (1)	Nein (0)
Schreien/Weinen	1	0
Unruhig/Weinerlich	1	0
Grimassieren	1	0
Erwartungsangst	1	0
Lässt sich nicht leicht beruhigen	1	0
Schlafstörungen	1	0
Zieht sich zurück	1	0
Isst weniger	1	0
Spielt weniger	1	0
Ist weniger lange aufmerksam	1	0

⇒ Summe in Dokumentationsbogen eintragen

Schmerzmessung ab 2,5 Jahren



[0]-----[1]-----[2]-----[3]-----[4]-----[5]-----[6]-----[7]-----[8]-----[9]-----[10]

keine Schmerzen — stärkste vorstellbare Schmerzen

Abb. 7.5. Schmerzmesskarte für Kinder. (Smileys mod. nach Pothmann [81], Fremdeinschätzung mod. nach McGrath [67]. Die Abbildung darf zum eigenen Gebrauch kopiert werden. Copyright bei Boris Zernikow 1998]

- Bei der Auswahl der Analgetika sollte das WHO-Stufenschema berücksichtigt werden. Frühzeitig sollen Opioide zur Anwendung kommen. Keinesfalls soll das Kind von WHO-Stufe zu WHO-Stufe klettern müssen.
- Bei bestimmten Schmerzsyndromen (z. B. Knochenschmerzen) hat sich die Kombination aus Opioid und Nichtopioidanalgetikum bewährt.
- Der orale Applikationsweg ist zu bevorzugen. Er ist sicher und flexibel. Auch stärkste Schmerzen können suffizient oral behandelt werden.
- Analgetika werden zur Gabe nach der Uhr und zusätzlich für Schmerzspitzen nach Bedarf angeordnet.
- Die Obstipation als häufigste und regelmäßig auftretende Nebenwirkung einer Opioidanalgesie muss prophylaktisch behandelt werden. Andere weniger häufige Nebenwirkungen sollten vom Arzt antizipiert werden, um ggf. schnell und adäquat reagieren zu können.
- Eine qualitativ hochwertige Schmerztherapie ist nur durch die standardisierte Dokumentation von Effektivität und Nebenwirkungen zu gewährleisten.

- Erreicht man durch das Befolgen dieser Prinzipien keine adäquate Schmerzreduktion, so sollten Schmerztherapeuten oder Palliativmediziner konsultiert werden.

WHO-Stufenschema

Analgetika der WHO-Stufe I: Nichtopioidanalgetikum (± Adjuvans)

In der Kinderpalliativmedizin gebräuchliche Nichtopioidanalgetika sind Paracetamol, Metamizol, Ibuprofen, Indometacin und Naproxen (Dosierungen in ◘ Tab. 7.2). Pharmakologische Einzelheiten finden sich in ▶ Kap. 4.7 (◘ Abb. 4.3)

- Paracetamol (PCM)
  Paracetamol wird nach Aufnahme therapeutischer Dosen größtenteils mit Sulfaten oder Glucuronsäure konjugiert – die Sulfatierung dominiert bis zum 12. Lebensjahr. Wenn nach Einnahme toxischer Dosen Glucuronidierungs- und Sulfatierungsreaktion gesättigt sind, wird Paracetamol P-450-abhängig zu N-Acetyl-Benzoquinoline (NABQUI) biotransformiert, mit Glutathion konjugiert und als ungiftiger Metabolit ausgeschieden. Zum Leberzellschaden kommt es nur dann, wenn in der Leber nicht genügend Glutathion zur Verfügung steht. Dann bindet NABQUI an lebenswichtige Leberenzyme.
- In der Kinderonkologie kann die Entgiftungskapazität der Leber für Paracetamol durch wiederholte Einnahme, Fehlernährung im Rahmen einer toxischen Chemotherapie und antineoplastische Medikamente eingeschränkt sein. Es kann aber auch durch die gleichzeitige Gabe von P-450-Induktoren wie Carbamazepin, Phenytoin u. a. zu einer vermehrten Produktion des potenziell toxischen Metaboliten NABQUI kommen.

Unabhängig von der onkologischen Erkrankung existieren Polymorphismen der Cytochrom P-450-Expression (wie CYP2E1), die einzelne Kinder hinsichtlich hepatotoxischer Medikamente vulnerabler machen [4]. Somit ist die Toxizität von Paracetamol multifaktoriell. Dies erklärt das Auftreten erheblicher Leberschäden – bei einigen Kindern musste eine Lebertransplantation erfolgen – bei der Anwendung selbst therapeutischer Dosen lege artis (<100 mg/kgKG/Tag) über einen Zeitraum von nur 2–4 Tagen [42].

Für die Kinderpalliativmedizin gilt: Anhand postoperativer Daten gewonnene neue Erkenntnisse zur Paracetamoldosierung [2], die für die postopera-

Tab. 7.2. Analgetika der WHO-Stufe I (Auswahl; Einzelheiten in ▶ Kap. 4, Tab. 4.3)

Medikament (alphabetisch)	Tageshöchstdosierung [mg/kgKG/Tag]	Orale/rektale Tageshöchstdosierung bei Erwachsenen [mg]	Einzeldosierungen	Präparatebeispiele
Diclofenac	1–3	150	In 2 Dosen In 1 Dosis (Retard Tabletten)	z. B. Voltaren Tabletten (25 mg, 50 mg), Retard Tabletten (100 mg) Suppositorien (50 mg, 100 mg), Kindersuppositorien (25 mg), Kleinkindsuppositorien (12,5 mg), Injektionslösung (1 ml = 25 mg)
Ibuprofen[a]	30–40	2400	In 3–4 Dosen	Saft (z. B. Nurofen-Fiebersaft, Dolormin für Kinder 5 ml = 100 mg), Tabletten (Dolormin und Dolor min extra, 200 bzw. 400 mg), Suppositorien (Imbun 200 mg)
Indometacin	2–3	150	In 3 Dosen In 1 Dosis (Retard Tabletten)	(Brause-) Tablette (z. B. Indometacin AL 25 mg, 50 mg), Retard Tabletten (z. B. Indocotin 75 mg), Saft (z. B. (Indo-Paed), Zäpfchen (z. B. Indometacin BC 50 mg, 100 mg)
Metamizol[b]	60–75	6000	In 4–6 Dosen	Tabletten (z. B. Novalgin 500 mg), Tropfen (z. B. Novalgin 1 Tr = 25 mg, Injektionslösung (z. B. Novalgin 1 ml = 500 mg), Suppositorien (z. B. Novalgin 300 mg und 1000 mg)
Naproxen	10–15	1000	In 2 Dosen	Tabletten (z. B. Proxen 250, 500, 1000 mg), Saft (z. B. Proxen), Suppositorien (z. B. Proxen 500 mg)
Paracetamol	<2 Jahre: 60, >2 Jahre: 90	6000	In 4–6 Dosen	Tabletten (z. B. Ben-u-ron 500 mg), Saft (Ben-u-ron 1 ml = 40 mg), Suppositorien (Ben-u-ron 125, 250, 500, 1000 mg)

[a] Ibuprofen ist von allen NSAR mit dem geringsten Risiko gastrointestinaler Nebenwirkungen behaftet.
[b] Nicht in den ersten drei Lebensmonaten.

tive Schmerztherapie oder die analgetische Therapie bei Kopfschmerzen Gültigkeit haben, dürfen keinesfalls auf die Kinderpalliativmedizin übertragen werden. Wenn eine Langzeittherapie mit PCM für länger als 72 h vorgesehen ist, sollten regelmäßig S-GOT, S-GPT und Gerinnung sowie einmalig nach drei Therapietagen der Paracetamolspitzenspiegel bestimmt werden. Die toxische Tagesdosis bei protrahierter Gabe beträgt ca. 150 mg/kgKG/Tag, wenn keine weiteren Risikofaktoren vorliegen (s. oben).

Unter Paracetamolgabe kommt es extrem selten zu Überempfindlichkeitsreaktionen und zur Störung der Blutbildung bis hin zur Panzytopenie.

- Azetylsalizylsäure (ASS)
  Eine ASS-Behandlung von Begleitsymptomen und Schmerzen im Rahmen fieberhafter Infektionen im Kindesalter ist obsolet, da in diesen Situationen die Einnahme von ASS höchstwahrscheinlich ein Reye-Syndrom auslösen kann [45]. ASS führt zudem zu einer lang anhaltenden Störung der Blutgerinnung. Da viele Kinder auch in der Palliativsituation durch die vorangegangene hoch dosierte Chemotherapie anhaltend thrombozytopenisch sind, sollte ASS bei ihnen gar nicht und in der übrigen Pädiatrie nur mit strenger Indikationsstellung eingesetzt werden.
- Ibuprofen, Indometacin und Naproxen
  Von allen NSAR sollte zunächst Ibuprofen bevorzugt werden, da es mit dem geringsten Risiko gastrointestinaler Nebenwirkungen behaftet ist [93, 40].

Eine Dosisreduktion muss bei Nieren- oder Leberinsuffizienz erfolgen. Bei gleichzeitiger Gabe von NSAR mit Digoxin oder Methotrexat kommt es zur Serumspiegelerhöhung dieser beiden Medikamente.

Hauptnebenwirkungen von NSAR sind auch bei kurzen Therapiephasen gastrointestinale Schleimhautschäden, die häufiger bei gleichzeitiger Einnahme von Glukokortikoiden auftreten. Bei Langzeitgebrauch besteht die Gefahr der Nephrotoxizität. Alle NSAR können in seltenen Fällen eine Störung der Blutbildung bis hin zur Agranulozytose auslösen.

- Metamizol
  Spasmolytische Eigenschaften von Metamizol sind willkommen bei abdominellen Schmerzen. Die Latenz des Wirkungseintritts beträgt nach oraler Gabe ca. 30 min. Die Bioverfügbarkeit bei oraler Applikation ist 99%, die Wirkdauer 3–4 h. Knochenmarkschädigungen sind laut wissenschaftlicher Informationsbroschüre eine Kontraindikation für die

Anwendung von Metamizol, obwohl die Agranulozytose eine extrem seltene Nebenwirkung [59] und beim Einsatz von Nichtopioiden keinesfalls spezifisch für Metamizol ist.

Weitere wichtige Nebenwirkungen sind Überempfindlichkeitsreaktionen und Allergien. Diese können in Extremfällen und bei intravenöser Gabe zum Kreislaufschock führen. Insbesondere bei hohem Fieber sollte Metamizol nur kontinuierlich intravenös oder als Kurzinfusion und bei instabilen Kreislaufverhältnissen gar nicht verabreicht werden. Vorsicht ist geboten bei Patienten mit Asthma- bzw. Allergieanamnese.

Für die Kinderonkologie wichtige Arzneimittelinteraktionen weist Metamizol mit Cyclosporin auf: Bei gleichzeitiger Anwendung kann der Cyclosporinspiegel absinken.

WHO-Stufe II: Schwaches Opioid (± Nichtopioidanalgetikum, ± Adjuvans)

Auf der WHO-Stufe II (Tab. 7.3–7.5) kommen schwache Opioide zum Einsatz. Das Opioid wird gemäß individuellem Schmerzverlauf ausgewählt: Bestehen mittelstarke Schmerzen ohne zu erwartende Progredienz, wird ein schwaches Opioid eingesetzt; ist eine rasche Progredienz zu starken Schmerzen absehbar, startet die Therapie schon initial mit einem Opioid der WHO-Stufe III. So werden hohe Dosen eines schwachen Opioides, die oft mit mehr Nebenwirkungen vergesellschaftet sind als niedrige Dosen eines starken Opioids, und der Opioidwechsel vermieden.

- Tramadol
  In der deutschen Palliativmedizin bei Kindern wird von den schwachen Opioiden der WHO-Stufe II nahezu ausschließlich Tramadol eingesetzt [108, 109], häufig in Kombination mit Metamizol oder einem anderen Nichtopioid.

Postoperativ kann durch diese Kombination die verabreichte Opioidmenge reduziert werden, ohne dass hierdurch die Analgesie schlechter würde [85]. Tramadol ist ein reiner Opioidrezeptoragonist. Seine analgetische Wirkung wird gesteigert durch eine Zunahme der Serotoninsekretion sowie die Blockade der synaptischen Wiederaufnahme von Noradrenalin im ZNS. Die Bioverfügbarkeit erreicht kurz nach Beginn der enteralen Therapie 90–98%, sodass sich die intravenöse und die enterale Dosis entsprechen.

Tab. 7.3. Opioide mit kurzer Halbwertszeit. Dosierungsrichtlinien zur Opioidanalgesie für opioidnaive Patienten, mod. nach Cancer Pain Relief and Palliative Care in Children, WHO 1998 (Copyright der Tab. beim Autor). Bei allen Medikamenten, bei denen eine Unterscheidung in Kinder <50 kgKG und >50 kgKG vorgesehen ist, sollten die dosierungen für Kinder <50 kgKG in mg/kgKG und die »übliche Erwachsenendosis« für Kinder >50 kgKG verwendet werden. Wenn eine Umstellung auf ein Opioid mit kurzer Halbwertszeit bei einem schon opioidovrbehandelten Patienten vorgenommen wird, sollte das neue Medikament mit 50% der äquianalgetischen Dosis verabreicht werden (aufgrund inkompletter Kreuztoleranz) und nach Wirkung titriert werden. Bei Säuglingen, die jünger als 6 Monate sind, sollte die Startdosis 1/4–1/3 der vorgeschlagenen Dosis betragen und nach Wirkung titriert werden

Opioid (Präparatebeispiel)	Äquianalgetische Dosis[a]		Übliche Startdosis i.v.[b]		Dosisverhältnis i.v. zu p.o.	Übliche Startdosis p.o.[b]		Biologische Halbwertszeit [h]
	i.v.	p.o.	<50 kgKG	>50 kgKG		<50 kgKG	>50 kgKG	
Kodein[c]	130 mg	200 mg	n. e.	n. e.	1 : 1,5	0,5–1 mg/kgKG alle 3–4 h	30 mg alle 3–4 h	2,5–3
Fentanyl (z. B. Fentanyl Jansen)	100 µg Einzeldosis	–	0,5– 2 µg/kgKG pro h als DTI	25–75 µg stündlich	–	–	–	3
Hydromorphon (z. B. Dilaudid)	1,5 mg	4,5 mg	0,015 mg/kgKG alle 2–4 h, DTI: 0,005 mg/kgKG pro h	1–1,5 mg alle 2–4 h	1 : 3	–	–	2–3
Morphin (z. B. MSI, Sevredol)	10 mg	30 mg	Bolus: 0,05–0,1 mg/kgKG alle 2–4 h DTI: 0,03 mg/kgKG pro h	5–10 mg DTI: 1 mg/h	1 : 3	0,15–0,3 mg/kgKG alle 4 h	5–10 mg alle 4 h	2,5–3
Pethidin[d] (z. B. Dolantin)	75 mg	300 mg	0,75 mg/kgKG alle 2–4 h	25–100 mg alle 2–4 h	1 : 4	1–1,5 mg/kgKG alle 3–4 h	25–150 mg alle 3–4 h	3
Piritramid[e] (z. B. Dipidolor)	–	–	0,05–1 mg/kgKG alle 4–6 h	5–10 mg DTI: 1 mg/h	–	–	–	3–5

Tab. 7.3. *Fortsetzung*

Opioid (Präparatebeispiel)	Äquianalgetische Dosis[a]		Übliche Startdosis i.v.[b]		Dosisverhältnis i.v. zu p.o.	Übliche Startdosis p.o.[b]		Biologische Halbwertszeit [h]
	i.v.	p.o.	<50 kgKG	>50 kgKG		<50 kgKG	>50 kgKG	
Tilidin/Naloxon[f] (z. B. Valoron)	–	–	–	–	–	2.–14. Lebensjahr: 1 Trpf. pro Lebensjahr; mindestens 3 Trpf. alle 6 h	Ab dem 14. Lebensjahr 20–40 Trpf. alle 4–6 h	3–6
Tramadol (z. B. Tramundin)	100 mg	100 mg	1 mg/kgKG alle 3 h	50–100 mg	1 : 1	1 mg/kgKG alle 3–4 h	50–100 mg alle 3–4 h	2–4

n. e. nicht empfohlen; DT/Dauertropfinfusion.

[a] Äquianalgetische Dosen basieren auf Einmaldosisstudien bei Erwachsenen.

[b] Die übliche Startdosis ist die i. Allg. verwendete Standarddosis und basiert nicht immer auf äquianalgetischen Prinzipien.

[c] Statt Kodein wird in Deutschland überwiegend Tramadol eingesetzt. Kodein ist in Deutschland als Antitussivum oder in Kombinationspräparaten mit Pacacetamol verbreitet. Die Berücksichtigung von Kodein im WHO-Stufenschema basiert nicht auf Aussagen wissenschaftlicher Studien, sondern mehr auf der Tradition, Kodein zu verabreichen. Kodein hat einige pharmakokinetische und -dynamische Besonderheiten, die seinen Einsatz bei Kindern eher ungünstig erscheinen lassen: 1) Die Bioverfügbarkeit nach oraler Gabe schwankt stark (15 bis über 80%). 2) Kodein wirkt über seinen Metaboliten Morphin analgetisch. Die Verstoffwechselung zu Morphin ist abhängig von der Aktivität des Cytochrom-P450-Enzyms CYP2D6. Die Aktivität dieses Enzyms schwankt stark – je nach genetischer Ausstattung des Patienten. Vereinfacht werden Menschen in schlechte und gute Verstoffwechsler eingeteilt, wobei in Deutschland der Anteil ersterer – bei denen Kodein extrem schlecht analgetisch wirkt – ca. 10% beträgt. Zudem ist die Aktivität von CYP2D6 bei Kindern bis zum 5. Lebensjahr unvorhersehbar – sie kann die Aktivität des Erwachsenenalters erreichen, beträgt aber in dieser Altersgruppe meist nur bis zu 25% davon. Die CYP2D6-Aktivität und damit die Verstoffwechselung von Kodein zu Morphin kann durch Medikamente, die ebenfalls von der WHO empfohlen werden (Metoclopramid, Neuroleptika, Antidepressiva), weiter reduziert werden. 3) Bei Neugeborenen traten nach Gabe von Kodein z. T. schwere Atemstörungen auf.

[d] Pethidin wird aufgrund seiner langen Halbwertszeit und der möglichen Akkumulation toxischer Metaboliten nicht für eine Therapiedauer von über 24 h empfohlen.

[e] Piritramid ist mit vielen Infusionslösungen und Medikamenten nicht kompatibel. Die proklamierte bessere Kreislaufverträglichkeit von Piritramid im Vergleich zu Morphin ist noch nicht Gegenstand wissenschaftlicher Studien gewesen. Nach Studien an Erwachsenen verursacht Piritramid jedoch mehr Übelkeit, Erbrechen und Sedierung als Morphin.

[f] Informationen laut Produktinformation. Dosierungen pro kgKG liegen nicht vor. Euphorisierende Wirkung der nichtretardierten Form. Ceilingeffekt: maximale Tagesdosis 400 mg. Tilidin ist ein Pro-Drug. Der aktive Metabolit Nortilidin entsteht nach hepatischer Demethylierung von Tilidin. Naloxon ist zum Schutz des Medikamentes vor missbräuchlicher i.v.-Applikation zugesetzt. Nach oraler Gabe wird Naloxon schnell hepatisch inaktiviert.

Tab. 7.4. Opioide mit langer Halbwertszeit. Dosierungsrichtlinien zur Opioidanalgesie für opioidnaive Patienten mod. nach Cancer pain relief and palliative care in children, WHO 1998 (Copyright der Tabelle beim Autor) (Legende s. auch Tab. 7.3a)

Opioid (Präparatebeispiel)	Äquianalgetische Dosis[a]		Übliche Startdosis i.v.[b]		Dosisverhältnis i.v. zu p.o.	Übliche Startdosis p.o.[b]		Biologische Halbwertszeit [h]
	i.v.	p.o.	<50 kgKG	>50 kgKG		<50 kgKG	>50 kgKG	
Buprenorphin[c] (z. B. Temgesic)	0,16 mg	0,16 mg	0,003–0,006 mg/kgKG alle 6–8 h	0,2–0,4 mg alle 6–8 h	1 : 1	0,003–0,006 mg/kgKG alle 6–8 h	0,2–0,4 mg alle 6–8 h	6–8 h
Levomethadon[d] (z. B. Polamidon)	10 mg	20 mg	0,05 mg/kgKG alle 4–8 h	5 mg alle 4–8 h	1 : 2	0,1 mg/kgKG alle 4–8 h	10 mg alle 4–8 h	12–50

n. e. nicht empfohlen; DT/Dauertropfinfusion.

[a] Äquianalgetische Dosen basieren auf Einmaldosisstudien bei Erwachsenen.

[b] Die übliche Startdosis ist die i. Allg. verwendete Standarddosis und basiert nicht immer auf äquianalgetischen Prinzipien.

[c] Gemischter Agonist-Antagonist. Cave: Ceilingeffekt! Maximal 4 mg/Tag. Sublingualtabletten ab ca. 35 kgKG einsetzbar.

[d] Äußerste Vorsicht ist bei der Verwendung von Levomethadon wegen dessen extrem langer biologischer Halbwertszeit angebracht sowohl bei Therapiebeginn als auch bei Dosissteigerung. Einstellung im Kindesalter unter stationären Bedingungen.

Tab. 7.5. Retardierte Opioidzubereitungen. Dosierungsrichtlinien zur Opioidanalgesie für opioidnaive Patienten mod. nach Cancer pain relief and palliative care in children, WHO 1998 (Copyright der Tabelle beim Autor) (Legende s. auch Tab. 7.3)

Opioid (Präparatebeispiel)	Übliche Startdosis p.o.[a]		Biologische Halbwertszeit [h]
	<50 kgKG	>50 kgKG	
Dihydrokodein[b] retardiert (z. B. DHC)	2 mg/kgKG alle (8–) 12 h	60 mg alle 12 h	8–12
Hydromorphon retardiert (z. B. Palladon)	0,08 mg/kgKG alle 12 h	4 mg alle 12 h	8–12
Morphin retardiert[c] (z. B. MST-Retardgranulat)	0,5 mg/kgKG alle 12 h	30–60 mg alle 12 h	8–12
Oxycodon[d] retardiert (z. B. Oxygesic)	0,2 mg/kgKG alle 12 h	10 mg alle 12 h	8–12
Tilidin/Naloxon retardiert (z. B. Naloxon retard)	–	50–300 mg alle 8 –12 h	8–12
Tramadol retardiert[e] (z. B. Tramundin retard)	2 mg/kgKG alle 8–12 h	100–300 mg alle 8 –12 h	8–12

[a] Die übliche Startdosis ist die i. Allg. verwendete Standarddosis und basiert nicht immer auf äquianalgetischen Prinzipien.

[b] Bei Dihydrokodein beobachtet man keine Abhängigkeit des Metabolismus von CYP2D6. Keine Steigerung von Dihydrokodein über 4 mg/kgKG/Tag, da Zunahme der Nebenwirkungen ohne Zunahme der Wirkung erfolgt.

[c] Bei mehrfachbehinderten Kindern ist Morphin als Retardgranulat sehr gut geeignet.

[d] Nach Studien an Erwachsenen scheinen Halluzinationen weniger häufig aufzutreten als unter Therapie mit Morphin. Der Wirkungseintritt ist schnell (<1 h), die Wirkdauer dennoch 8–12 h.

[e] Tramundin retard ist teilbar, Tramal long nicht. Damit ist Tramundin retard ab einem Körpergewicht von 25 kg einsetzbar.

Die unerwünschten Wirkungen Übelkeit, Ebrechen und Atemdepression beobachten wir beim Einsatz von Tramadol in der Pädiatrie selten – auch weil bei Dosierungen von über 8 mg/kgKG in der Regel ein Wechsel auf Morphin vorgenommen wird.

- Dihydrokodein, Tilidin, Dextropropoxyphen
  Alle drei Analgetika werden bei Kindern in Deutschland nur sehr selten eingesetzt, wohl auch, weil für alle drei Opioide nur oral zu verabreichende Präparate zur Verfügung stehen [108, 109].

WHO-Stufe III: Starkes Opioid (± Nichtopioidanalgetikum, ± Adjuvans)

Der Einsatz starker Opioide am Beginn einer Schmerztherapie ist in der Kinderonkologie die Regel. Dabei werden in Deutschland die in ◘ Tab. 7.6 genannten Substanzen eingesetzt.

Dosierungen dieser starken Opioide finden sich in ◘ Tab. 7.3–7.5. In der Neugeborenen- und Säuglingsperiode muss mit sehr viel geringeren Opioiddosen begonnen werden [93, 49, 50]. Eine pulsoxymetrische Überwachung ist in der Einstellungsphase bei Kindern unter sechs Monaten unverzichtbar und bei intravenöser Opioidtherapie auch für alle anderen Alterstufen zu empfehlen. Die Anfangsdosis starker Opioide sollte am Schmerz titriert werden. Bei einer Anwendungsdauer <5 Tagen wird die Opioidmenge bei Therapieende langsam über 3–4 Tage ausgeschlichen. Bei längerer Anwendungsdauer reduziert man die Dosis anfangs um 20–40%/24 h, später um 10–20%/24 h. Die Entwöhnung kann bis zu zwei Wochen in Anspruch nehmen.

Beim Wechsel von einem starken Opioid auf ein anderes wird die neue Therapie mit der Hälfte der äquianalgetischen Dosis des neuen Opioids begonnen.

- Morphin
  Morphin ist ein reiner Opiatagonist [21]. Es existiert keine obere Dosisgrenze, die Morphindosis sollte generell am Effekt titriert werden. Nach oraler Gabe kommt es zu einer variablen Absorption, sodass die Bioverfügbarkeit ca. 30% beträgt. Wechselt man die Applikationswege von einer Gabe per os zu intravenös, beginnt man die intravenöse Therapie mit 1/3 der p.o.-Dosis, um einen äquianalgetischen Effekt zu erreichen [61, 89].

Die Halbwertszeit von nicht retardiertem Morphin ist altersabhängig: bei Frühgeborenen beträgt sie 9,0 (+ 3,4) h, bei reifen Neugeborenen 6,5 (+ 2,8) h

Tab. 7.6. Starke Opioide der WHO-Stufe III und ihre Anwendungsgebiete

Wirkstoff	Indikation
Morphin	Als Standardanalgetikum bei starken Schmerzen und bei Mukositis
Hydromorphon	Als Ersatzopioid bei individueller Unverträglichkeit und bei Leber- oder Niereninsuffizienz
Piritramid	Postoperativ
Levomethadon	Bei extrem starken Schmerzen und nicht ausreichender Wirkung von Morphin
Fentanylpflaster	Wenn die Einnahme von Tabletten verweigert wird und eine stabile Schmerzsituation vorliegt
Buprenorphin	Traditionell mit eher unklarer Indikation

und ab dem 11. Lebenstag 2,2 (+ 1,8) h [49]. Pharmakokinetische Parameter sind zudem vom Allgemeinzustand des Kindes abhängig [64].

Morphin wird primär hepatisch metabolisiert in Morphin-6- bzw. Morphin-3-Glucuronid. Morphin-6-Glucuronid hat eine analgetische, Morphin-3-Glucuronid eine antagonisierende Wirkung. Morphin und seine Metaboliten werden renal eliminiert. Die Startdosen bei Nierenversagen sind dementsprechend anzupassen. Ansonsten empfiehlt sich wie beim nierengesunden Patienten eine Titration am Effekt.

Da Morphin weniger lipophil ist als beispielsweise Fentanyl und Piritramid, beginnt bei intravenöser Applikation die Wirkung frühestens nach 5 min. Das Wirkmaximum ist nach 20 min erreicht. Die Wirkdauer von nicht retardiertem bzw. intravenös appliziertem Morphin beträgt jenseits der frühen Säuglingsphase 4 h, die von oralen retardierten Präparaten 8–12 h (die Wirkdauer ist abhängig vom Alter). Die Wirkung bei Gabe retardierter Morphinpräparate beginnt mit einer Latenz von 30–60 min.

Hat ein Kind eine Abneigung gegen Tabletten, treten Schluckstörungen auf oder beträgt das Körpergewicht weniger als 20 kg, bietet sich die Gabe von Morphin-Retardgranulat an. Es kann in Wasser aufgeschwemmt werden, ist daher auch für die Anwendung bei Säuglingen gut dosierbar und kann problemlos über sehr dünne Magen- bzw. PEG-Sonden appliziert werden. Wegen seines Himbeergeschmacks wird es von kleinen Kindern gut toleriert.

- Hydromorphon
  Kommt es im Verlaufe einer Morphintherapie zu nicht tolerablen oder nicht therapierbaren Nebenwirkungen, empfiehlt sich der Wechsel auf Hydromorphon. Hydromorphon hat keine aktiven Metaboliten. Dies ist besonderes wichtig für die Therapie bei Niereninsuffizienz, da hier Medikamente ohne aktive Metaboliten – die in der Regel unterschiedliche Eliminationsraten haben – besser steuerbar sind. Wie Morphin ist Hydromorphon ein reiner Opiatagonist.
- Piritramid
  Postoperativ wird in Deutschland traditionell Piritramid eingesetzt. Wegen seiner hohen Lipophilie tritt die Wirkung prompt ein, was die intravenöse Therapie gut steuerbar macht. Die Wirkstärke von Piritramid ist mit der von Morphin vergleichbar. Ein entscheidender Nachteil von Piritramid für die Palliativmedizin: Es lässt sich so gut wie gar nicht mit anderen Pharmaka oder Infusionslösungen mischen.
- Levomethadon
  Levomethadon ist ein synthetisches Opioid und wie Morphin ein reiner μ-Agonist. Es ist wegen der extrem langen, terminalen β-Halbwertzeit von 13–50 h schlecht steuerbar. Da Methadon und Levomethadon auch dann noch analgetisch wirken, wenn Morphin, Fentanyl oder Hydromorphon keine ausreichende Analgesie herbeiführen können, stellt sich im Alltag die Frage, wie ein Opioidwechsel durchgeführt werden kann. Hierfür existieren zwei mögliche Strategien:
  - Bis dato durchgeführte Opioidtherapie beenden. 10% der berechneten äquianalgetischen Dosis Levomethadon werden als Startdosis verabreicht, die gleich hohen Folgedosen werden bei Bedarf gegeben, bis das Kind anhaltend schmerzfrei ist und sich eine Einzeldosis mit entsprechendem Dosisintervall herausgestellt hat.
  - Bis dato durchgeführte Opioidtherapie beenden. An Tag 1 des Opioidwechsels 0,2 mg/kgKG (maximal 5–10 mg) Levomethadon p.o. (oder 0,1 mg/kgKG; maximal 5 mg i.v) alle 4 h und zusätzlich bei Bedarf bis stündlich verabreichen. An den Tagen 2–3 Dosis austitrieren, indem die Einzeldosis bis zu 30% gesteigert wird. Dosierungsintervalle beibehalten. An Tag 4 wird die jetzt austitrierte Einzeldosis nur noch alle 8 h fest und zusätzlich 3-stündlich bei Bedarf verabreicht. An den folgenden Tagen kann unter Beibehaltung des Dosisintervalls die Einzeldosis noch gesteigert werden [74].

- Pethidin
  Traditionell wird Pethidin in Deutschland bei schmerzhaften Eingriffen und auch international bei Sichelzellkrisen eingesetzt, obwohl Pethidin für beide Indikationen Nachteile und gegenüber anderen Opioiden keine die Nachteile aufwiegenden Vorteile bietet: Im Rahmen einer chronischen Erkrankung ist die Anwendung von Pethidin bei Kindern (und Erwachsenen) nicht zu empfehlen, da der Metabolit Norpethidin im Körper kumulieren und zu zerebralen Krampfanfällen führen kann [82, 78]. Die Halbwertszeit von Nor-Pethidin beträgt 20–85 h.

Pethidin ist ein synthetischer μ-Agonist und wird hepatisch metabolisiert in Pethidinsäure sowie Nor-Pethidin. Seine Halbwertszeit beträgt bei Früh- und Neugeborenen 10–23 h, bei bis zu zwei Monaten alten Säuglingen immerhin noch 8 h. Bei Kindern unterscheidet sich die Halbwertszeit nur unwesentlich von der des Morphins [75]. Bei Einsatz zusammen mit MAO-Hemmern – z. B. Moclobemid und Tranylcypromin (Psychopharmaka) – kann es zu lebensgefährlichen Komplikationen wie Hyperpyrexie, arterieller Hypo- oder Hypertonie, Delirium und zerebralen Krampfanfällen kommen [83].

- Fentanyl
  Fentanyl ist wie Morphin ein reiner Opiatagonist. Es ist sehr viel lipophiler als Morphin, sodass sowohl Wirkungen als auch Nebenwirkungen – insbesondere Atem- und Kreislaufdepression – bei intravenöser Applikation sehr schnell eintreten. Für die Analgesie bei schmerzhaften Eingriffen ist es sehr geeignet, da bei langsamer intravenöser Gabe gut an der Wirkung titriert werden kann.

Transdermal kann Fentanyl mit Hilfe eines speziellen Pflasters appliziert werden. Trotz beschränkter Erfahrungen bei Kindern wird transdermales Fentanyl von mindestens 12 der 76 kinderonkologischen Abteilungen in Deutschland eingesetzt [108]. Wie Analysen im Rahmen eines Qualitätssicherungsprojektes der Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie [109] zeigen, werden dabei die Indikationen nicht immer richtig gestellt. Das Pflaster soll nur bei stabiler Schmerzsituation eingesetzt werden und keinesfalls am Beginn einer Schmerztherapie.

Die Wirkung tritt mit einer Verzögerung von 12 h ein und hält dann 48–72 h an – eine Kinetik, die keine Titration auf Effekt erlaubt.

Wenn ein Fentanylpflaster eingesetzt wird, muss immer zusätzlich ein schnell wirksames starkes Opioid für Schmerzspitzen verordnet werden. Oft wird dabei auf Morphintropfen, -suppositorien oder -tabletten zurückgegriffen. In jeden Fall erhält das Kind dann zwei verschiedene starke Opioide, auf die es mit zwei unterschiedlichen Nebenwirkungsspektren reagieren kann.

Als Umrechnungsfaktor gilt in der Schmerztherapie bei Erwachsenen: Milligramm Morphin oral/Tag zu Milligramm Fentanyl transdermal/Tag = 100: 1. Ein Rechenbeispiel: Beträgt die orale Tagesdosis von Morphin 30 mg, so wählt man das kleinste erhältliche Fentanylpflaster (0,3 mg Fentanyl/Tag =12 µg/h). Bei einer medianen oralen Morphindosis von 1,5 mg/kgKG/Tag in der kinderonkologischen Schmerztherapie (Umrechnung nach ◘ Tab. 7.7) [111] käme das Pflaster also frühestens ab einem Körpergewicht von 20 kgKG zum Einsatz.

Die Einstellung auf transdermales Fentanyl sollte bei Kindern in jedem Fall stationär erfolgen. Todesfälle nach einer zu sorglosen Verabreichung von Fentanylpflastern sind beschrieben [55]. Auch nach Entfernen des Pflasters fällt der Fentanylblutspiegel nur langsam ab.

In einigen Studien betrug die minimale orale Tagesmorphindosis bei Umstellung auf TTS-Fentanyl 30 mg/kgKG/Tag (◘ Tab. 7.7).

Umstellung von oralem Morphin auf Fentanyl-TTS: Das Fentanyl-TTS sollte zeitgleich mit der letzten Gabe retardierten Morphins gegeben werden. Bestand die Schmerztherapie aus 4-stündlichen Gaben nichtretardierten Morphins, sollte nach Aufbringen des Fentanyl-TTS noch eine Gabe nichtretardierten Morphins verabreicht werden. Zusätzlich zum Fentanyl-TTS müssen immer schnell wirkende Fentanyl- (Fentanyl-Stick) oder Morphinzubereitungen (z. B. Sevredol-Tabletten) verordnet werden. Die Opioiddosis für Durchbruchschmerzen beträgt ca. 1/6 der Opioidtagesdosis und muss regelmäßig an einen steigenden Grundbedarf angepasst werden. Für Kinder würden die Autoren einen Wechsel des Fentanyl-TTS alle 48 h empfehlen.

Eine transbukkale Applikationsform von Fentanyl (Actiq Stick) ist seit 2002 in Deutschland auf den Markt. Ein Stick enthält wahlweise eine Einzeldosis von 200, 400, 600, 800, 1200 oder 1600 µg Fentanyl. Äquianalgetische Dosen anderer Opioide sind noch nicht etabliert. In Studien bei Erwachsenen wurde 200 µg Fentanyl als Stick mit 2 mg i.v. bzw. 15 mg p. o Morphin verglichen. Kinder erhielten im Rahmen der Wundversorgung 10–20 µg/kgKG und vor Knochenmarkpunktionen 15–20 µg/kgKG Fentanyl als Lutscher [90].

Tab. 7.7. Umstellung von oraler Morphintherapie auf TTS-Fentanyl bei Kindern. (Nach [44])

Tägliche orale Morphindosis	Fentanyldosis [µg/h]	Fentanyldosis [mg/Tag]	Pflastergröße [cm²]
30–60	12,5	0,3	5
60–135	25	0,6	10
135–224	50	1,2	20
225–314	75	1,8	30
315–404	100	2,4	40
405–494	125	3,0	50
495–584	150	3,6	60
Je weitere 60 mg/Tag	Weitere 25 µg/h	Weitere 0,6 mg/Tag	Weitere 10

- Buprenorphin
  Buprenorphin – ein partieller Agonist und ein gemischter Agonist-Antagonist – wird sublingual und i.v. appliziert. Die sehr starke Opioidrezeptorbindung erklärt die lange Wirkungs- und ggf. Nebenwirkungsdauer und das Fehlen der Reversibilität der Nebenwirkungen nach Gabe gewöhnlicher Dosen des Morphinantagonisten Naloxon. Wegen des Ceilingeffektes – durch weitere Dosissteigerung über das obere Dosislimit hinaus lässt sich keine Steigerung der Analgesie erzielen – sind die Einsatzmöglichkeiten von Buprenorphin begrenzt. Da Buprenorphin eine im Vergleich zu Morphin geringere obstipierende Wirkung zugeschrieben wird, die jedoch wissenschaftlich nicht bewiesen ist, wird es in praxi dann verordnet, wenn mittelstarke Schmerzen ohne Progredienz bestehen und eine Obstipation schon besteht oder unbedingt verhindert werden muss. Zudem wird es nahezu ausschließlich hepatisch metabilisiert – ein Vorteil bei Niereninsuffizienz.

Die Halbwertszeit beträgt bei Kindern 1 h (± 0,2 h), bei Erwachsenen 3,1 h (±0,6 h). Bei sublingaler Gabe schwankt die Bioverfügbarkeit zwischen 16 und 94%, weswegen sich die oralen und intravenösen Dosierungsempfehlun-

gen entsprechen. Kinder zwischen dem 5. und 8. Lebensjahr (Studienkollektiv) wiesen nach i.v.-Gabe von Buprenorphin eine im Vergleich zu Morphin stärkere Atemdepression auf (zit. nach [75]).

Nebenwirkungen der Analgetikatherapie

Das Nebenwirkungsprofil einzelner starken Opioide kann beim individuellen Patienten äußerst verschieden sein. Betrachtet man jedoch ein großes Kollektiv, unterscheiden sich die verschiedenen Opioide hinsichtlich Art und Ausmaß ihrer Nebenwirkungen kaum. Prophylaxe und Therapie häufiger Begleiteffekte werden gesondert besprochen. Selten und insbesondere bei intravenöser Applikation kann es zu arterieller Hypotonie, Urtikaria und bei Allergikern zu Asthmaanfällen kommen. Psychische Veränderungen (z. B. Euphorie) sowie Spasmen des Oddi-Sphinkters werden im klinischen Alltag selten gesehen.

Obstipation

Die Obstipation ist die häufigste und klinisch bedeutsamste Nebenwirkung einer Opioidtherapie in der Kinderpalliativmedizin. Im Rahmen der Grunderkrankung oder auch chemotherapieassoziiert essen und trinken die Kinder wenig, lehnen die Einnahme von Laxanzien häufig ab und bewegen sich kaum. Unter Umständen treten in dieser Situation unter Opioidtherapie (Sub-)ileuszustände auf. Besteht die Möglichkeit einer oralen Laxanzientherapie, weist nach eigenen Erfahrungen Lactulose, obwohl es in Einzelfällen zu Meteorismus und krampfartigen Bauchschmerzen führt, das Beste Wirkungs-Nebenwirkungs-Verhältnis auf (Tab. 7.8).

Zusätzlich werden Bisacodyl und Natriumpicosulfat sowie Paraffinöl eingesetzt, wenn die regelmäßige Lactuloseeinnahme nicht den erwünschten Erfolg zeigt. Eine manifeste Obstipation sollte vor der regelmäßigen oralen Laxanziengabe durch rektale Laxanziengabe beseitigt werden. Über Wirksamkeit und Verträglichkeit von Macrogol 3350 zur Obstipationsprophylaxe unter Opioiden im Kindesalter fehlen wissenschaftliche Daten [59].

Übelkeit und Erbrechen

Grundsätzlich treten im Kindesalter die gleichen unerwünschten Opiodwirkungen auf wie bei Erwachsenen. Es gibt jedoch Unterschiede in der Häufigkeit und Ausprägung. So reagieren ältere Kinder (>12 Jahre) häufiger

mit Übelkeit und Erbrechen als jüngere [112]. Bei Ersteren ist daher der prophylaktische Einsatz von Antiemetika gerechtfertigt (Tab. 7.7). Wie auch im Erwachsenenalter entwickelt sich bei Kindern typischerweise innerhalb einer Woche eine Toleranz gegen die emetische Wirkung von Opioiden.

Einige Kinder profitieren in der 1. Behandlungswoche von einem Dimenhydrinat-Kaugummi (10 mg und 20 mg). Da die Dimenhydrinatdosis des Kaugummis nur 15–50% der üblicherweise rektal verabreichten Dosis beträgt, tritt Müdigkeit als unerwünschter Nebeneffekt seltener auf [84]. Pädiatrische Studien zu diesem Themenkreis fehlen. Da das Kaugummi bis dato ohne unerwünschte Nebeneffekte zur Prophylaxe von Übelkeit und Erbrechen in der Frühschwangerschaft verordnet wurde, bestehen keine Bedenken hinsichtlich der Verträglichkeit bei Kindern.

35% der deutschen Kinderonkologien setzten als Reservemedikament 5-HT_3-Antagonisten zur Therapie und Prophylaxe von opioidinduzierter Übelkeit und Erbrechen ein, obwohl auch hier Studien fehlen (Tab. 7.8) [110, 77, 98].

Juckreiz

Unter der Therapie mit oral retardiertem Morphin klagt 1/4 der über 12-jährigen Patienten und 1/10 der jüngeren Kinder über Juckreiz [112]. Wenn möglich, wird diesem Symptom mit einer passageren Dosisreduktion begegnet. Ein Therapieversuch kann auch mit Clemastin oder juckreizstillenden Waschungen und erfolgen. Bleibt diese Therapie ohne Erfolg, ist ein Opioidwechsel, z. B. von Morphin auf Hydromorphon, sinnvoll.

Bei Erwachsenen und auch bei Kindern mit postoperativen Schmerzen reduzierte extrem niedrig dosiertes Naloxon (0,00025–0,0005 mg/kgKG/h i.v. als Dauertropfinfusion) den PCA-Morphinverbrauch und die Opioidnebenwirkungen Juckreiz, Übelkeit und Erbrechen [30, 65]. Laut Gan [30] und Wright [105] können Naloxon- und Morphinsulfat in der gleichen Spritze gemischt oder gemeinsam über einen intravenösen Zugang infundiert werden.

Harnverhalt

Harnverhalt ist jenseits der Neonatalphase eine sehr seltene Nebenwirkung einer Opioidtherapie, kann aber bei betroffenen Kindern Panik auslösen. Die Harnverhaltung ist oft schon durch beruhigende Worte, einen nassen Waschlappen, der auf die Haut über der Blasenregion gelegt wird, oder das Geräusch eines laufenden Wasserhahns zu beheben. Reichen diese Maßnahmen nicht

Tab. 7.8. Supportiva

Indikation	Medikament	Dosis	Applikations-modus
Prophylaktisch			
Obstipation	Lactulose (z. B. Bifiteral)	*<3 Jahre:* Startdosis: 3-mal 2 ml mittlere Dosis: 3-mal 5 ml	p.o.
		>3 Jahre: Startdosis: 3-mal 5 ml mittlere Dosis: 3-mal 10 ml	p.o.
Übelkeit	Ondansetron (z. B. Zofran) oder	5 mg/qm alle 12 h, *Höchstdosis:* 2-mal 8 mg	i.v./p.o.
	Dimenhydrinat (z. B. Vomex) oder	1–2 mg/kgKG alle 6–8 h 5 mg/kgKG alle 6–8 h, *maximale Tagesdosis bei p.o./Supp: 2–6 Jahre:* 75 mg *6–12 Jahre:* 150 mg	i.v. p.o./Supp.
	Domperidon (z. B. Motilium)	0,3 mg (=1 Trpf.)/kgKG Einzelhöchstdosis: 33 Trpf.=10 mg	p.o.
Therapeutisch			
Obstipation	Bisacodyl (z. B. Dulcolax)	*2–10 Jahre:* 5 mg/Tag	Supp.
		>10 Jahre: 10 mg/Tag	Supp.
		>10 Jahre: 10 mg/Tag	p.o. (nicht mit Milch einnehmen)
	Na-Picosulfat (z. B. Laxoberal)	*>4 Jahre:* 4–8 Trpf./24 h	p.o.
		>12 Jahre: 10 Trpf./24 h	p.o.
Übelkeit	Kombination der unter Prophylaxe angeführten Medikamente		
Juckreiz	Clemastin (z. B. Tavegil)	0,04 mg/kgKG alle 12–24 h	i.v.
		1–3 Jahre: 0,25–0,5 mg alle 12 h	p.o.
		4–6 Jahre: 0,5 mg alle 12 h	p.o
		7–12 Jahre: 0,5–1 mg alle 12 h	p.o
		>12 Jahre: 1 mg alle 12 h	p.o

Tab. 7.8. *Fortsetzung*

Indikation	Medikament	Dosis	Applikationsmodus
Harnverhalt	Carbachol (z. B. Doryl)	0,05–0,1 mg alle 12–24 h	s. c.
		0,5–1 mg alle 8–24 h	p.o.
Ulkus	Ranitidin (z. B. Sostril)	1–2 mg/kgKG alle 12 h bei Einmalgabe abends	p.o.
	Misoprostol (Arthotec)	2-mal 5 µg/kgKG, Höchstdosis 2-mal 200 µg/Tag	p.o.
Müdigkeit	Methylphenidat (Medikinet, Ritalin)	0,1 mg/kgKG 2-mal tgl. (morgens und mittags), damit es zu keiner Störung des nächtlichen Schlafs kommt	p.o.

aus, kann bei jugendlichen Patienten Carbachol verabreicht oder bei jüngeren Kindern eine Einmalkatheterisierung durchgeführt werden [4].

Atemdepression

Unter oraler Therapie mit retardiertem Morphin ist bei adäquater Dosierung keine Atemdepressionen zu befürchten [112]. Letztere tritt jedoch im Rahmen von schmerzhaften Eingriffen auf, wenn ein Opioid schnell intravenös appliziert wird oder bei Kombination mehrerer zentral dämpfender Medikamente. Die Mehrheit der deutschen Kinderonkologen befürworten eine maximale Schmerztherapie mit Opioiden, auch wenn es dabei in Palliativsituationen zu einer Atemdepression kommt.

Halluzinationen

Beim Auftreten seltener Nebenwirkungen wie Halluzinationen und Verwirrtheit sollte ein Opioidwechsel erfolgen.

Ulkusprophylaxe

Opioide scheinen auch bei Langzeittherapie keine Organtoxizität aufzuweisen. Werden sie jedoch in Kombination mit NSAR eingesetzt, kann es durch NSAR zu Magenbeschwerden und gastrointestinalen Läsionen kommen [24]. Zusätzliche Risikofaktoren bestehen in einer Steroidtherapie und der unregel-

mäßigen Nahrungsaufnahme. Bei Erwachsenen konnte eine prophylaktische Wirkung von gastrointestinalen Läsionen nur für Protonenpumpenblocker und Misoprostol (synthetisches Prostaglandinanalog E_1) bewiesen werden [9, 31, 72]. In der Kinderheilkunde werden traditionell für diese Indikation wegen des günstigen Nebenwirkungsprofils Antazida und Ranitidin eingesetzt [72].

Adjuvanzien des WHO-Stufenschemas

In der Palliativphase auftretende zusätzliche Symptome wie Schlaflosigkeit und Angst sowie spezielle Schmerzsyndrome (Knochenschmerzen, neurogene Schmerzen) können den Einsatz von Adjuvanzien erforderlich machen. Mögliche Nebenwirkungen und das Vorliegen nur beschränkter Erfahrungen im Kindesalter sollten vorab mit Eltern und Kindern besprochen werden (▣ Tab. 7.9).

Besondere Schmerzsyndrome

- **Neuropathische Schmerzen**
  Brennende, einschießende oder dysästhetische Schmerzen werden häufig durch Infiltration von Nervengewebe verursacht. Obwohl diese neuropathischen Schmerzen als relativ »opioidresistent« gelten, sollte eine adäquat dosierte Opioidtherapie erfolgen, bevor Adjuvanzien verordnet werden [13, 15, 22, 80]. Ergänzend zur Opioidtherapie werden Antikonvulsiva und/oder trizyklische Antidepressiva per os und, wo dies nicht möglich ist, auch intravenöse eingesetzt – bei der i.v.-Applikation von Amitriptylin muss die orale Dosis halbiert werden (▣ Tab. 7.9) [99, 68, 14]. Zusätzliche Therapieoptionen bestehen in regionalanästhetischen sowie strahlentherapeutischen Maßnahmen, der Ketamindauertropfinfusion und der Gabe von Glukokortikoiden bei Nervenkompressionen [15, 19, 97, 36, 73].
- **Knochenmetastasen**
  Bestehen Knochenschmerzen auch nach der Optimierung der Kombinationstherapie von starkem Opioid plus Nichtopioidanalgetikum gemäß WHO-Stufe III weiter, zeigt in Metaanalysen die Strahlentherapie – auch als Einmaldosis verabreicht – eine zusätzliche hohe analgetische Potenz [70]. Diese kann bei Schmerzen durch Knochenmetastasen eines Neuroblastoms auch durch Gabe von 131Jod-MIBG erfolgen [100]. Analgetische Potenz und Nebenwirkungsprofil von Bisphosphonaten im Kindesalter sind weitgehend ungeklärt. In Falldarstellungen wurde über ihre analgetische Wirkung bei Knochenmetastasen auch im Kindesalter berichtet [63, 76].

Tab. 7.9. Adjuvanzien

Stoff-gruppe	Medikament	Dosierung	Indikation	Bemerkung
Anästhe-tika	Ketamin (z. B. Ketanest)	1–3 mg/kgKG/Tag i.v. oder s. c.	Neuropathische Schmerzen, wenn Opi-oide keine ausreichen-de Wirkung zeigen	Ketamin kann mit Morphin sulfat in einer Spritze zur i.v.- oder s. c.-Applikation ge mischt werden; bei s. c.-Gabe empfiehlt es sich, die Lösung mit Natriumbicarbonat auf einen pH-Wert von ca. 5,5 einzustellen. Dieser pH-Wert sollte nicht über-schritten werden, da die Lösung sonst ausfällt
			Schmerzhafte Eingriffe, terminale Analgose-dierung	
Antikon-vulsiva	Carbamazepin (z. B. Timonil)	Startdosis: 2,5 mg/kgKG alle 12 h p.o.	Neuropathische Schmerzen, wenn Opi-oide keine ausreichen-de Wirkung zeigen	Einschleichende, titrierende Dosierung – wö-chentlich steigern bis zum gewünschten Erfolg; regelmäßig Plasmaspiegel bestimmen (Ziel: 4–12 mg/l) Kombination mit Antidepressivum möglich, Nebenwirkungen: Leuko- und Thrombo-zytopenie (bei 2% der Patienten), Anämie, Panzy-topenie, Ataxie, Doppelbildersehen, Sedierung, Serumelektrolytstörungen, Leberfunktionsstörun-gen und Osteopathien
	Gabapentin (z. B. Neurontin)	Schrittweise Aufdosierung auf 15–30 mg/kgKG/Tag in 3 Einzeldosen innerhalb von 3–7 Tagen je nach Schmerzstärke	Neuropathische Schmerzen, wenn Opi-oide keine ausreichen-de Wirkung zeigen	Im Allgemeinen sehr gut verträglich, jedoch in der Schmerztherapie wenig Erfahrungen bei Kin-dern. Häufigste Nebenwirkungen: Schläfrigkeit, Müdigkeit, Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit,

Tab. 7.9. *Fortsetzung*

Stoff-gruppe	Medikament	Dosierung	Indikation	Bemerkung
		und orientiert am Auftreten von Nebenwirkungen; Maximaldosis in Ausnahmefällen 60 mg/kgKG/Tag Maximale Tagesdosis bei Erwachsenen nicht über 3600 mg, verteilt auf 3 Einzelgaben. Dosis bei eingeschränkter Nierenfunktion reduzieren.		Erbrechen, Gewichtszunahme, Nervosität, Schlaflosigkeit, Ataxie, Nystagmus, Parästhesien, Appetitlosigkeit
Bisphosphonate	Pamidronat (z. B. Aredia)	1 mg/kgKG alle 4 Wochen i.v.; Infusion nach Packungsbeilage	Knochenschmerzen bei Knochenmetastasen	Häufige Nebenwirkung während der Infusion: passagere Pyrexie, grippeartige Symptome
Glukokortikoide	Dexamethason (z. B. Fortecortin)	Startdosis: 6–12 mg/qm/Tag p.o. oder i.v., danach langsam reduzieren	Infiltratives Tumorwachstum	Nicht reflektorisch bei Hirndruck in der palliativen Situation einsetzen: Das Tumorwachstum wird nicht aufgehalten, sondern nur kurzzeitig das Ödem verringert
			Nervenkompression	Nebenwirkungen bei längerer Applikationsdauer: Stimmungsschwankungen, massive Angstzustände, Cushing-Syndrom, Gewichtszunahme, muskuläre Hypotonie, Duodenal- und Magenulzera, Osteoporose, Glaukom, Katarakt, Natriumretention, Atrophie der Nebennierenrinde, klinisch relevante Immunsuppression, Thrombosen

			Ausgeprägte Knochenmetastasierung Kapselschmerzen Hirndruck	
Neuroleptika	Promethazin (z. B. Atosil)	Zur Sedierung 0,5 mg/kgKG p.o. oder i.v. alle 6 h	Starke Übelkeit und Erbrechen	Langsam ein- und ausschleichen
			Akute Agitiertheit	Extrapyramidale Symptome: akute Dystonie, Akathisie, Parkinsonismus, Dyskinesie; um ihnen vorzubeugen, kann in Einzelfällen eine prophylaktische Therapie mit Biperiden erwogen werden. Therapeutisch wird Biperiden bei schweren akuten extrapyramidalen Nebenwirkungen in folgender Dosierung gegeben: bis zu <1 Jahr: 1 mg i.v., 2–6 Jahre: 2 mg, >6 Jahre 3 mg. Diese Dosis kann bei Bedarf nach 30 min wiederholt werden
Spasmolytika	Butyl-Scopolamin (z. B. Buscopan)	<15 kgKG: 1/2 Supp. à 7,5 mg, >15 kgKG 1 Supp. à 7,5 mg rektal alle 6–8 h 0,5–1 mg/kgKG i.v. als Kurzinfusion, Höchstdosis 20 mg		
Sedativa	Midazolam (z. B. Dormicum)	Dauertropfinfusion: Starten mit 0,1 mg/kgKG/h	Terminale Sedierung	
	Lorazepam (z. B. Tavor)	Startdosis 2-mal 0,5 mg/Tag p.o., maximale Einzeldosis 0,05 mg/kgKG/Tag	Schlafstörungen	

Tab. 7.9. *Fortsetzung*

Stoff-gruppe	Medikament	Dosierung	Indikation	Bemerkung
Trizyklische Antidepressiva	Amitriptylin (z. B. Saroten)	Therapiebeginn mit 0,2 mg/kgKG/Tag p.o. abends	Neuropathische Schmerzen nach Vincristintherapie oder bei Tumorinvasion, wenn Opioide keine ausreichende Wirkung zeigen	Langsam ein- und ausschleichen
		Steigern über 2–3 Wochen (alle 2–3 Tage um 25%) Zieldosierung 1–2 mg/kgKG/Tag	Phantomschmerzen nach Amputationen Schmerzbedingte Schlafstörungen	Analgetische Wirkung unabhängig von antidepressivem Effekt
				Wirkeintritt nach 1–14 Tagen
				Nebenwirkungen: wie im Erwachsenenalter (▶ Kap. 4, S. 267) Gefährlichste Nebenwirkung ist eine Beeinträchtigung von Herzfunktion und Herzreizleitungssystem, deshalb regelmäßig EKG kontrollieren: bei persitierender Tachykardie, Reizleitungsstörungen oder QT-Zeiten von >450 ms erneute Risikoabwägung vornehmen. Schmale therapeutische Breite: Todesfälle sind ab einer Dosis von 8 mg/kgKG/Tag p.o. Amitryptilin berichtet.

- **Terminale Sedierung**
  1–2% der Kinder haben trotz adäquater Opioidtherapie in Kombination mit Nichtopioiden, Adjuvanzien, Regionalanästhesie und regionaler Strahlentherapie noch starke Schmerzen [15–17]. Hier muss mit den Eltern die Möglichkeit einer terminalen Sedierung ausführlich besprochen werden. Bei nicht anders beherrschbaren Schmerzzuständen können kontinuierliche Applikationen von Midazolam (Tab. 7.9), Barbituraten oder Propofol (Bolus 0,5 mg/kgKG; DTI mit 0,5 mg/kgKG/h) [96] in Kombination mit Opioiden in Ausnahmefällen indiziert sein.

Patientenkontrollierte Analgesie (PCA)

Die PCA bei Kindern in der Palliativphase weist im Gegensatz zur postoperativen PCA einige Besonderheiten auf:

- Bis zu einem Gewicht von 50 kg wird Morphin von Anfang an kontinuierlich mit 4 µg/kgKG/h infundiert, die Startdosis pro Bolus beträgt 0,02 mg/kgKG [91]. Ab einem Gewicht von 50 kgKG wird eine den Empfehlungen bei Erwachsenen entsprechende PCA-Anfangseinstellung vorgenommen (kontinuierliche Infusion 0,5 mg/h, Bolusgröße 1–2 mg Morphin, Sperrintervall 5–10 min).
- Schmerz ist ein nützliches Warnsymptom für Komplikationen der Analgetika- oder Antitumortherapie bzw. der Tumorkrankheit an sich. Durch die Selbstapplikation von Opioiden verliert der Schmerz seine Warnfunktion. Auf Therapiekomplikationen wie Harnretention, Frühzeichen einer Pankreatitis und einen – durch den Krankheitsverlauf nicht zu erklärenden – steigenden Opioidverbrauch ist deshalb besonders zu achten.

7.4.4 Therapie von nicht schmerzassoziierten Symptomen

Eine systematische Erfassung der Therapie von Symptomen in der Lebensendphase von Kindern findet nur in Ausnahmefällen statt, und es gibt keine prospektiven Therapiestudien, die den kurativen Therapie protokollen in der pädiatrischen Onkologie ähnlich sind. Die Literatur spiegelt in der Regel persönliche Erfahrungen der Autoren wider. Die nachfolgenden Empfehlungen zur Symptomkontrolle wurden z. T. schon auf deutsch veröffentlicht [34, 27, 107] oder sind aus dem angelsächsischen adaptiert [12, 25, 33, 62, 103, 106].

Wie auch in der Schmerztherapie muss das Vorhandensein von belastenden Symptomen engmaschig und dezidiert erfasst werden – jedes Symptom muss also einzeln abgefragt werden. Bei Fragen allgemeiner Natur über vorhandene Symptome (»Gibt es heute irgendwelche Probleme?«) besteht die Gefahr, dass Symptome nicht erkannt und damit auch nicht behandelt werden [6].

Wichtig

Die Erfahrung vieler Palliativmediziner, dass nämlich zahlreiche sterbende Kinder in der Lebensendphase ein Vielfaches der empfohlenen Höchstdosen von Analgetika, Neuroleptika und Antikonvulsiva benötigen, fand bisher keinen Eingang in die medizinische Literatur.

Gastrointestinale Probleme

Probleme der Nahrungsaufnahme

Insbesondere Kinder mit fortschreitenden degenerativen Erkrankungen haben im Verlauf ihrer Krankheit häufig Probleme mit der Nahrungsaufnahme. Der Lustgewinn durch Essen und Trinken sollte für das Kind im Mittelpunkt stehen. Das Ziel der Ernährung – die Verbesserung oder Erhaltung der Gesundheit – kann je nach Zustand des Kindes in den Hintergrund treten. Eine intensive Familienunterstützung sollte auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen und damit die Spannung und den Stress, der sich aufgrund der Ernährungsschwierigkeiten einstellt, abmildern. Häufige, kleine Mahlzeiten, die richtige Umgebung und Körperhaltung sowie eine individuell abgestimmte Darreichung von Nahrung (z. B. Püree) kann die Essensaufnahme erleichtern.

Viele Kinder und Jugendliche mit degenerativen Erkrankungen oder schweren Mehrfachbehinderungen werden im Verlauf ihrer Krankheit mit einer PEG-Sonde versehen, um eine adäquate Ernährung zu ermöglichen.

Appetitlosigkeit und Dehydratation

Schwer kranke Kinder zeigen in der Lebensendphase häufig wenig Interesse an fester Nahrung. Sie können dabei mit erstaunlich wenig Nahrung ohne größere Befindlichkeitsprobleme teilweise wochenlang überleben. Behandelbare Ursachen der Appetitlosigkeit, wie z. B. Übelkeit, Obstipation, Furcht vor Durchfall/Erbrechen, Mukositis, Depression oder die Darreichung von für das Kind unpassender und schlecht schmeckender Nahrung müssen angegangen werden.

Das Gestagen Megestrolazetat (z. B. Megestat; 5–10 mg/kgKG 1-mal tgl. p.o.) erhöht nach einigen Untersuchungen [34, 71] den Appetit von schwer kranken Kindern und führt zu einer Gewichtszunahme. Zu den Nebenwirkungen dieses Medikaments zählen Glukoseintoleranz und Nebennierensuppression. Die Gabe von Glukokortikoiden zur Appetitanregung kann im Kindesalter aufgrund der Nebenwirkungen (z. B. Stimmungsschwankungen, M. Cushing) nicht empfohlen werden [52].

Die Verweigerung der Flüssigkeitsaufnahme tritt in der Regel erst zu einem sehr späten Zeitpunkt auf. Unbehagen tritt dann lediglich durch Mundtrockenheit auf, welche durch Mundpflege und Anfeuchten des Mundes behandelt werden muss.

Übelkeit und Erbrechen

Übelkeit und Erbrechen sind häufige und das Kind stark belastende Symptome. Vor der richtigen Therapie steht die genaue Erfassung der Ursachen der gastrointestinalen Symptomatik. Hier kommen z. B. Medikamentennebenwirkungen, Elektrolytverschiebungen, Magenschleimhautirritationen, Stoffwechselstörungen, erhöhter intrakranieller Druck, Obstipation und ein wachsender Tumor in Frage. Die Therapie der opioidinduzierten Übelkeit ist weiter oben beschrieben. Wird ein Antiemetikum prophylaktisch verabreicht, kann nach etwa einer Woche ein Auslassversuch unternommen werden, da Patienten üblicherweise eine Toleranz gegen die emetische Opioidwirkung entwickeln.

Die Auswahl der Antiemetika muss entsprechend der Ursache der Übelkeit erfolgen. Eventuell hilft eine Kombination von Antiemetika mit unterschiedlichen Wirkmechanismen oder ein 5-HT_3-Serotoninrezeptorantagonist. Ondansetron oder Tropisetron (z. B. Navoban; 0,2 mg/kgKG i.v. 1-mal tgl.) zeigen bei Übelkeit und Erbrechen, evtl. kombiniert mit Dimenhydrinat, eine gute Wirkung (Dosen ◘ Tab. 7.8). Cyclizin ist in Deutschland nur über die internationale Apotheke erhältlich, wird aber in Großbritannien insbesondere bei Erbrechen aufgrund erhöhten intrakraniellen Drucks erfolgreich eingesetzt. Die kurzfristige Gabe von Glukokortikoiden kann bei erhöhtem intrakraniellem Druck in speziellen Situationen (z. B. Urlaub) indiziert sein, muss dann aber von einer Ulkusprophylaxe begleitet werden.

Stufenschemata der Antiemese, wie von Klaschik in ▶ Kap. 4.10.2 vorgestellt, existieren für die Pädiatrie nicht. Dystonische Reaktionen auf Metoclopramid und Haloperidol, selten auch auf Domperidon, treten im Kindesalter

häufiger als bei Erwachsenen auf und müssen dann mit Biperiden (z. B. Akineton; 1–2 mg/Einzeldosis i.v.) behandelt werden (Dosen ◘ Tab. 7.8 und 7.9).

Ulkusprophylaxe

Viele entwicklungsretardierte Kinder und solche mit degenerativen Erkrankungen entwickeln einen gastroösophagealen Reflux (GÖR) und haben ein erhöhtes Risiko, eine Ösophagitis oder ein Ulkus zu entwickeln. Auch die Gabe von nichtsteroidalen Antirheumatika wie Ibuprofen und Naproxen, Kortikosterioden sowie eine vorgeschädigte Schleimhaut oder unregelmäßige Nahrungsaufnahme rechtfertigen eine primäre Ulkusprophylaxe. Für Kinder liegen hierzu keine ausreichenden Daten vor. Traditionell kommt Ranitidin (◘ Tab. 7.8) zum Einsatz. Auch mit Misoprostol (◘ Tab. 7.8) und Omeprazol (z. B. Antra; 10–20 kgKG: 10 (–20] mg 1-mal tgl.; >20 kgKG: 20 (–40) mg 1-mal tgl. p.o.) liegen gute Erfahrungen vor. Das bei GÖR häufig eingesetzte Cisaprid (Propulsin) ist in Deutschland aufgrund arrhythmiebedingter Todesfälle gegenwärtig nicht zugelassen.

Obstipation

Viele terminal kranke Kinder leiden aufgrund der Grundkrankheit, Bewegungsmangel und verminderter Flüssigkeits- und Nahrungszufuhr unter Verstopfung. Insbesondere die opioidassoziierte Obstipation muss prophylaktisch mit ballaststoffreicher Diät, Erhöhung der Flüssigkeitszufuhr und Laxanzien behandelt werden. Bei manifester Obstipation sollte diese erst beseitigt werden (z. B. mit Natriumhydrogenphosphat-Klistier – Practo-Clyss – 1.–3. Lebensjahr: 60 ml rektal; ab dem 3. Lebensjahr: 120 ml rektal, oder Glycerol – Babylax– 0,5 mg für Säuglinge, 1 mg für Kleinkinder, 1,5 mg für Schulkinder rektal, ggf. wiederholen) und nachfolgend der Stuhlgang reguliert werden.

Die gebräuchlichen Laxanzien (◘ Tab. 7.8) zeigen an typischen Nebenwirkungen krampfartige Bauchschmerzen, Kolitis und Elektrolytstörungen. Bei längerem Gebrauch von Paraffinöl (z. B. Obstinol) muss mit Granulombildung und Malabsorption fettlöslicher Vitamine gerechnet werden. Obgleich keine vergleichenden Studien zu dieser Thematik vorliegen, scheint Laktulose (z. B. Bifiteral) die wenigsten Nebenwirkungen aufzuweisen, wenn auch hier Meteorismus und krampfartige Bauchschmerzen auftreten können (Dosierungen ◘ Tab. 7.8).

Leider tritt die Obstipation nicht selten in Situationen auf, in denen das Kind keine Nahrung zu sich nimmt und damit auch keine oralen Laxanzien

einnehmen kann. In diesem Fall wird in Deutschland häufig Dexpanthenol und Neostigmin eingesetzt, obwohl hierfür kein wissenschaftlicher Wirknachweis besteht (unter 30 kgKG: morgendliche Gabe von 1000 mg Dexpanthenol und 0,5 mg Neostigmin als 3-h-Kurzinfusion i.v.; über 30 kgKG morgendliche Gabe von 2000 mg Dexpanthenol und 1,0 mg Neostigmin als 3-h-Kurzinfusion i. v).

Diarrhö

Insbesondere bei Kindern mit HIV-/Aids-Infektionen stellt Durchfall ein großes Problem dar. Pharmakologische Ansätze müssen Hand in Hand mit der Ursachenbeseitigung der Diarrhö laufen. Loperamid (z. B. Imodium, 2–8 Jahre: 0,04 mg/kgKG/24 h p.o., >8 Jahre: 2 mg initial, 2 mg Wiederholungsgabe bei ungeformtem Stuhl, maximal 8 mg p.o.) hat sich als effektiv erwiesen, ebenso wie Morphin p.o. Falls eine orale Gabe von Medikamenten nicht möglich ist, empfiehlt sich (bei vorhandenem Zugang) eine intravenöse oder alternativ eine subkutane Gabe von Morphin, Diamorphin oder Hydromorphon.

Mukositis

Die Mundpflege stellt meistens ein großes Problem dar und bedarf häufig großer Überredungskünste von Seiten der Pflegenden. Candida-Infektionen sollten mit Nystatin oder Ketoconazol therapiert werden. Insbesondere während einer Chemotherapie sind schmerzhafte Ulzerationen häufig und bedürfen einer lokalen und ggf. systemischen Schmerztherapie (s. dort).

Dyspnoe

Die Behandlung der Atemnot in der Palliativsituation bleibt unbefriedigend, da die pathopysiologischen Grundlagen bei fehlendem Befall des respiratorischen Systems unklar sind. Häufig liegt der Atemnot keine primäre Ursache wie Lungenmetastasen, Pneumonien oder Bronchitiden zugrunde. Die Dyspnoe ist ein komplexes, multidimensionales und subjektives Symptom. Müdigkeit, Schwäche, Depression, Angst und Appetitlosigkeit scheinen wichtige Kofaktoren zu sein [1].

Zur Therapie [8] gehören pharmakologische (Opioide [10] und Sauerstoff sowie evtl. Benzodiazepine und Steroide) und nichtpharmakologische Ansätze (Krankengymnastik, Ernährung, Lagerung, CPAP-Beatmung, verhaltenstherapeutische Vorgehensweise, Bekämpfung der Angst). Die inhalative Gabe von

Opioiden ist bei Kindern noch nicht untersucht worden. Ein Ventilator, der Luft ins Gesicht bläst, vermag zahlreichen Kindern die Atemnot zu lindern.

Untersuchungen bei Erwachsenen haben gezeigt, dass bei Dyspnoe objektive Verfahren wie Lungenfunktionsmessungen, Blutgasanalysen und Sättigungsmessungen nicht mit dem subjektiv empfundenen Schweregrad der Atemnot des Patienten korrelieren [1, 8, 10]. Therapieziel darf also nicht die Modifizierung von Messwerten, sondern muss die Verbesserung der subjektiv empfundenen Dyspnoe sein.

Eine zunehmende Hypoxämie bei chronischen Lungenerkrankungen kann zahlreiche belastende Symptome wie Schwindel, Kopfschmerz, Übelkeit und Schlafschwierigkeiten verursachen. Eine Sauerstoffgabe über einen Trichter oder eine Nasensonde kann zu einer Erleichterung führen.
Kinder mit malignen Erkrankungen empfinden aber bei Dyspnoe in der Finalphase die Sauerstoffgabe häufig als störend.

Neurologische Komplikationen

Krampfanfälle können ein führendes Symptom im Verlauf einer lebenslimitierenden Erkrankung sein (z. B. bei neurodegenerativen Erkrankungen) oder sich erst in der Terminalphase (z. B. bei malignen Erkrankungen) entwickeln. Für Eltern ist ein Krampfanfall häufig ein sehr angsteinflößendes Ereignis, und sie müssen darauf vorbereitet werden. Der Nutzen einer krampfdurchbrechenden medikamentösen Therapie muss gegen den Stress abgewogen werden, den ein Kind effektiv durch das Krampfereignis erlebt. Gerade kurze gelegentliche Krampfanfälle bedürfen häufig keiner Therapie.

Zur akuten Durchbrechung eines Krampfanfalls hat sich Diazepam (bis 15 kgKG: 5 mg rektal, über 15 kgKG: 10 mg rektal, maximal zwei Wiederholungsgaben möglich) als sehr wirksam erwiesen. Clonazepam (0,01–0,05 mg/kgKG i.v.; maximal 1 mg) führt nach Ausreizung der Höchstdosis von Diazepam häufig zum Sistieren eines Anfalls.

Die antikonvulsive dauerhafte Einstellung bei Kindern und Jugendlichen mit häufigen Krampfereignissen sollte durch einen Neuropädiater erfolgen, um die optimale Balance zwischen guter Einstellung und minimalen Nebenwirkungen zu halten. Im Verlauf der Krankheit können häufige Dosisanpassungen notwendig sein. Gerade in der Lebensendphase benötigen einige Kinder ein Vielfaches der in der Literatur beschriebenen Höchstdosen von Antikonvulsiva zur Symptomkontrolle.

Hämatologische Probleme

Kinder mit einer Lebererkrankung und portaler Hypertension können durch Ösophagusvarizen unter schweren Blutungen leiden und u. U. von einer chirurgischen oder verödenden Intervention profitieren. Aus der Knochenmarkbeteiligung vieler kindlicher Tumoren, insbesondere der Leukämien und Neuroblastome, resultieren zahlreiche Probleme: Neben der Anämie und Thrombozytopenie kann es zu Infektionen und ausgeprägten Knochenschmerzen kommen. Die Gabe von Erythrozyten- und Thrombozytenkonzentraten kann während der Palliativphase zu einer Verbesserung der Lebensqualität führen. Allerdings mag im Verlauf der Lebensendphase ein Zeitpunkt kommen, an dem nach einer deutlichen Abnahme der Lebensqualität eine Transfusion von Blutprodukten nicht mehr hilfreich oder angemessen ist.

Hirntumorenassoziierte Probleme

Die Hirntumoren machen ein Fünftel aller kindlichen Malignome aus. Der Verlauf der Palliativphase ist häufig länger als der anderer Neoplasien. Zu den möglichen Symptomen gehören Kopfschmerz, Erbrechen und zerebrale Krampfanfälle. Zunehmende neurologische Probleme mit motorischen Ausfällen, Ernährungsschwierigkeiten und Kommunikationsproblemen können die Lebensendphase erheblich erschweren.

Depression und Angst

Zeigt ein Kind im Verlauf seiner Krankheit Zeichen der Angst, so reflektiert dies nicht selten das Bedürfnis, über die Umstände der Krankheit und des Sterbens sprechen zu wollen und ernst genommen zu werden. Gespräche, Spieltherapie und Geschichtenerzählen erweisen sich häufig als hilfreich. Unterstützt werden kann dies durch niedrige Dosen eines Anxiolytikums wie Diazepam (0,05–0,1 mg/kgKG p.o./i.v.; 0,3 mg/kgKG rektal 3-mal tgl.).

In der Präfinalphase verursacht ein Organversagen mitunter Agitation und Verwirrung. In diesem Fall sind Benzodiazepine Medikamente der 1. Wahl, z. B. Diazepam oder Midazolam (0,5–0,75 mg/kgKG p.o. oder 0,05–0,15 mg/kgKG i.v. als Einzeldosis). Haloperidol (z. B. Haldol 0,05–0,2 mg/kgKG p.o. 1- bis 3-mal tgl.) besitzt auch antiemetische Qualitäten.

7.5 Palliativmedizin für Kinder und Erwachsene im Vergleich

Das Recht auf bestmögliche medizinische Behandlung ist ein fundamentales Recht, insbesondere für Kinder (UNESCO). Sterbende Kinder sollten nicht in einem Erwachsenenhospiz, einer Erwachsenenpalliativstation oder einer anderen Erwachseneneinrichtung versorgt werden. Die durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstützte *Charta für Kinder im Krankenhaus* der *European Association for Children in Hospital* gilt hier analog (Auszüge):

- *Kinder sollen gemeinsam mit Kindern betreut werden, die von ihrer Entwicklung her ähnliche Bedürfnisse haben. Kinder sollen* nicht *in Erwachsenenstationen aufgenommen werden.*
- *Kinder haben das Recht auf eine Umgebung, die ihrem Alter und ihrem Zustand entspricht und die ihnen umfangreiche Möglichkeiten zum Spielen, zur Erholung und Schulbildung gibt. Die Umgebung soll für Kinder geplant, möbliert und mit Personal ausgestattet sein, das den Bedürfnissen von Kindern entspricht.*
- *Kinder sollen von Personal betreut werden, das durch Ausbildung und Einfühlungsvermögen befähigt ist, auf die körperlichen, seelischen und entwicklungsbedingten Bedürfnisse von Kindern und ihren Familien einzugehen.*

Spezifische Aspekte der pädiatrischen Palliativmedizin

- Krankheitsbezogene Unterschiede
  - Die Anzahl von sterbenden Kindern ist verglichen mit der Anzahl der Erwachsenen sehr gering.
  - Erwachsene leiden zumeist an langsam wachsenden, epithelialen, Kinder an schnell proliferierenden, mesenchymalen Tumoren. Die Palliativphase von Kindern ist deshalb gekennzeichnet durch einen sehr raschen Symptomwechsel, was hohe Ansprüche an die Versorgungsqualität stellt. In der Regel ist die Palliativphase in der Kinderonkologie kürzer als bei Erwachsenen mit Krebs.
  - Viele der Kinder haben sehr seltene Erkrankungen, welche nur im Kindesalter vorkommen (auch wenn das Kind manchmal bis in das frühe Erwachsenenalter überleben kann).

  - Viele Erkrankungen treten familiär gehäuft auf, daher kann es mehr als ein betroffenes Kind in der Familie geben, und eine genetische Beratung muss angeboten werden.
- Unterschiede hinsichtlich der psychosozialen Versorgung
  - Das Charakteristikum des Kindesalters ist die körperliche, emotionale und kognitive Entwicklung. Um Kindern ihrem Entwicklungsstand entsprechend begegnen zu können, müssen die Betreuer diese Entwicklungsstufen kennen.
  - Kinder entwickeln ihre Fähigkeit zur Kommunikation. Nur Betreuer, die die kindlichen Ausdrucksformen verstehen, können kindliche Aussagen zu Symptomen (z. B. Schmerz) oder Äußerungen zu Emotionen (Angst, Wut, Trauer usw.) richtig interpretieren.
  - Kinder lernen normalerweise ohne Zutun der Eltern jeden Tag etwas Neues hinzu. In der Palliativsituation machen Kinder in ihrer Entwicklung eher Rückschritte, was für die Eltern schwer zu ertragen ist.
  - Die Versorgung umfasst die ganze Familie; Eltern und Geschwister sind besonders verletzlich, und die Eltern sind durch die persönliche und pflegerische Versorgung sehr stark belastet.
  - Ab dem etwa 8. Lebensmonat erlauben viele Säuglinge und Kleinkinder überwiegend nur engste Bezugspersonen in ihrer unmittelbaren Umgebung. Das »Fremdeln« ist ein normales Verhalten in dieser Altersstufe.
  - Kleinere Kinder haben aufgrund ihres natürlich egozentrischen Verhaltens kein Verständnis für die limitierten Zeit- und Energiereserven bei Mutter/Vater/Geschwistern oder anderen Bezugspersonen.
  - Das Angebot der Kindergarten-/Vorschul-/Schulbildung ist absolut notwendig, und die Kinder haben ein Recht auf diese Angebote (Schulpflicht). Dies ist eine zusätzliche professionelle Komponente, welche zu der Komplexität der Versorgung beiträgt.
- Unterschiede in therapeutischen Aspekten
  - Viele notwendige Medikamente für Kinder in der Lebensendphase sind für die Altersgruppe nicht zugelassen, häufig nicht erforscht, und Dosisfindungsstudien sind ausgeblieben.
  - Die Einnahme von Tabletten ist oft problematisch.

- Die Dauertropfanlage zur Verabreichung von intravenösen Medikamenten oder Flüssigkeiten ist bei Kindern im Allgemeinen und bei sterbenden Kindern im Speziellen häufig sehr schwierig und bedarf einer guten und professionellen Vorbereitung.
- Invasive Schmerztherapieverfahren spielen bei Kindern in der Regel keine Rolle. Sind sie jedoch indiziert, werden sie wegen fehlender Erfahrung zu selten oder gar nicht eingesetzt.

Diese Unterschiede machen deutlich, dass es eines speziell ausgebildeten Kinderpalliativmediziners bedarf, der eng mit den pädiatrischen Subspezialitäten kooperiert. Diese Herausforderung einer optimalen Behandlung sterbender Kinder wird in Deutschland nur von wenigen Professionellen, jedoch von allen betroffenen Familien gesehen. Diesen betroffenen Familien wollen wir helfen, trotz lebensverkürzender Erkrankung eines Kindes *eigenes Leben* bis zum Lebensende zu leben.

Literatur

1. Allard P, Lamontagne C, Bernard P, Tremblay C (1999) How effective are supplementary doses of opioids for dyspnea in terminally ill cancer patients? A randomized continuous sequential clinical trial. J Pain Symptom Manage 17(4): 256–265
2. Anderson BJ, Holford NHG (1997) Rectal paracetamol dosing regimens: determination by computer simulation. Paediatr Anaesth 7: 451–455
3. Anonym (1988) Kinder-Krankenhaus Tagebuch 1867–1869. Bomhoff-Verlag, Bremen
4. Anundi I, Lahteenmaki T, Rundgren M, Moldeus P, Lindros KO (1993) Zonation of acetaminophen metabolism and cytochom P 450 2E1-mediated toxicity studied in isolated periportal and perivenous hepatocytes. Biochem Pharmacol 45: 1251–1259
5. Association for Children with Life-threatening or Terminal Conditions and their Families and the Royal College of Paediatrics and Child Health (1997; 2nd edn 2003) Report of a Joint Working Party of the Association for Children with Life-threatening or Terminal Conditions and their Families and the Royal College of Paediatrics and Child Health. A Guide to the Development of Children's Palliative Care Services. ACT, Bristol
6. Azcona C, Castro L, Crespo E, et al. (1996) Megestrol acetate therapy for anorexia and weight loss in children with malignant solid tumours. Aliment Pharmacol Ther 10(4): 577–586
7. Bammer K (1984) Leben mit dem krebskranken Kind – Rat und Hilfe für Eltern und Betreuer. Perimed Fachbuch-Verlagsgesellschaft, Erlangen
8. Booth S, Kelly MJ, Cox NP, Adams L, Guz A (1996) Does oxygen help dyspnea in patients with cancer? Am J Respir Crit Care Med 153(5): 1515–1518

9. Brauer HG, Fisch UW, Krause M, Lang F, Vergin H (1997) Prävention NSAR-bedingter Magenschleimhautschäden mit Misoprostol. Z Allg Med 73: 1265–1270
10. Bruera E, Neumann CM (1998) Management of specific symptom complexes in patients receiving palliative care. J Can Med Assoc 158(13): 1717–1726
11. Bürgin B (1981) Das Kind, die lebensbedrohende Krankheit und der Tod. Hans Huber, Bern
12. Children's International Project on Palliative/Hospice Services (ChIPPS) (2000) Compendium of Pediatric Palliative Care. National Hospice and Palliative Care Organization
13. Collins JJ, Grier HE, Kinney HC, Berde CB (1995) Control of severe pain in children with terminal malignancy. J Pediatr 126: 653–657
14. Collins JJ, Berde CB (1995) Intravenous amitryptiline in pediatrics. J Pain Symptom Manage 10: 471–475
15. Collins JJ (1996) Intractable pain in children with terminal cancer. J Palliat Care 12: 29–34
16. Collins JJ, Grier HE, Sethna NF, Wilder RT, Berde CB (1996) Regional anesthesia for pain associated with terminal malignancy. Pain 65: 63–69
17. Collins J (1998) Commentary: Symptom management in children at the end of life. J Pain Symptom Manage 15: 259–260
18. Collins J et al (2000) The measurement of symptoms in children with cancer. J Pain Symptom Manage 19: 363–377
19. Dangel T (1998) Chronic pain management in children. Part I: cancer and phantom pain. Ped Anaesth 8: 5–10
20. Dangel T (2001) Domowa opieka paliatywna nad dziecmi w Polsce. Department of Palliative Care – Institute for Mother and Child, Warsaw
21. Darsey EH, Outlaw AC (1994) Age-related considerations for the use of opiods in pediatric pain management. Pain Digest 4: 12–20
22. Dellemijn PLI, Vanneste JAL (1997) Randomised double-blind active-placebo-controlled crossover trial of intravenous fentanyl in neuropathic pain. Lancet 349: 753–758
23. Domenica F (1997) Just my reflections. Darton, Longman & Todd, London
24. Dowd JE, Cimaz R, Fink CW (1995) Nonsteroidal antiinflammatory drug-induced gastroduodenal injury in children. Arthritis Rheum 38: 1225–1231
25. Eubanks V, Koppersmith N, Wooldridge N, et al (2002) Effects of megastrol acetat on weight gain, body composition, and pulmonary function in patients with cystic fibrosis. J Pediatr 140(4): 439–444
26. Feudtner C, Hays RM, Haynes G, Geyer R, Neff JM, Koepsell TD (2001) Deaths attributed to pediatric complex chronic conditions: National trends and implications for supportive care services. Pediatrics 107: e99
27. Frager G, Shapiro B (1998) Pediatric palliative care and pain management, chap 78. In: Holland JC (ed) Psycho-oncology. Oxford Press, New York
28. Friedrichsdorf S, Brun S, Zernikow B (2003) Comprehensive care for dying children – The Warsaw Hospice for Children. Eur J Palliat Care (to be published)
29. Fuchs R (1984) Stationen der Hoffnung. Kreuz, Zürich
30. Gan TJ, Ginsberg B, Glass PSA, Fortney J, Jhaveri R, Perno R (1997) Opioid-sparing effects of low-dose infusion of naloxone in patient-administered morphine-sulfate. Anesthesiology 87: 1075–1081

31. Gazarian M, Berkovitsch M, Koren G, Silverman ED, Laxer RM (1995) Experience with misoprostol therapy for NSAID gastropathy in children. Ann Rheum Dis 54: 277–80
32. Glaser BG, Strauss AL (1995) Betreuung von Sterbenden. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen Zürich
33. Goldman A (1998) Care of the dying child, rev edn. University Press, Oxford
34. Goldman A (1999) Life threatening illnesses and symptom control in children. In: Oxford Textbook of Palliative Medicine, 2nd edn. University Press, Oxford
35. Goldmann A (2000) Symptoms and suffering at the end of life in children with cancer – correspondence. N Engl J Med 342: 1997–1999
36. Greenberg HS, Kim J, Posner JB (1980) Epidural spinal cord compression from metastatic tumor: results with a new treatment protocol. Ann Neurol 8: 361–366
37. Gualtieri CT (1977) Imipramine and children. A review and some speculations about the mechanism of drug action. Dis Nerv Syst 38: 368–375
38. Haas G (1981) Ich bin ja so allein – Kranke Kinder zeichnen und sprechen über ihre Ängste. Otto Maier, Ravensburg
39. Hagen NA, Babul N (1997) Comparative clinical efficacy and safety of a novel controlled-released oxycodone formulation and controlled released hydromorphone in the treatment of cancer pain. Cancer 79: 1428–1437
40. Henkel W (1988) Probleme von Pflegepersonal bei der Betreuung todkranker und sterbender Kinder. Verlag Krankenpflege, Frankfurt/Main
41. Henry D, Lim LL, Rodriguez LAG, Gutthann SP, Carson JL, Griffin M (1996) Variability in risk of gastrointestinal complications with individuel non-steroidal anti-inflammatory drugs: results of a collabarative meta-analysis. BMJ 66: 229–237
42. Heubi JE, Barbacci MB, Zimmerman HJ (1998) Therapeutic misadventure with acetaminophen: hepatotoxicity after multiple doses in children. J Pediatr 132: 22–27
43. Hilden JM, Ezekiel EJ, Fairclough DL et al. (2001) Attitudes and practices among pediatric oncologists regarding end-of-life care: results of the 1998 American Society of Clinical Survey, J Clin Oncol 19(1): 205–212
44. Hunt A, Goldman A, Devine T, Phillips M (2001) Transdermal fentanyl for pain relief in a paediatric palliative care population. Palliat Med 15: 405–412
45. Hurwitz ES (1989) Reye's syndrome. Epidemiol Rev 11: 249–253
46. Jakobs H, Rister M (1997) Die Fremdeinschätzung von Schmerzen bei Kindern. Klin Pädiatr 209: 384–88
47. Kaatsch P, Spix C, Michaelis J (2000) Jahresbericht 1999 – 20 Jahre Deutsches Kinderkrebsregister. Technischer Bericht des Instituts für Medizinische Statistik und Dokumentation, Universität Mainz
48. Kalso E, Vainio A (1988) Hallucinations during morphine but not during oxycodone treatment. Lancet ii: 912
49. Kant T, Christrup LL, Rasmussen M (1997) Recommended use of morphine in neonates, infants and children based on a literature review: Part I – pharmacokinetics. Pediat Anaesth 7: 5–11
50. Kant T, Christrup LL, Rasmussen M (1997) Recommended use of morphine in neonates, infants and children based on a literature review: Part II – clinical use. Pediat Anaesth 7: 93–101

51. Karlowicz, Dariusz (2001) Philosophy as preparation for death. In: 2nd European Course on Palliative Care for Children – Textbook. Warsaw Hospice for Children, Warsaw
52. Karwacki MW (2001) Dyspnea in terminally ill children: causes, managment and ethics. In: 2nd European Course on Palliative Care for Children – Textbook. Warsaw Hospice for Children, Warsaw, pp 27–37
53. Kelly PK (1986) Viel Liebe gegen Schmerzen – Krebs bei Kindern. Rowohlt, Reinbek
54. Klemm M, Hebeler G, Häcker W (1990) Tränen im Regenbogen – Phantastisches und Wirkliches – aufgeschrieben von Mädchen und Jungen der Kinderklinik Tübingen. Attempto, Tübingen
55. Kramer C, Tawney M (1998) A fatal overdose of transdermal administered fentanyl. J Am Osteopath Assoc 98: 385–386
56. Kreicbergs U, Valdimarsdottir U, Onelov E, Henter JI, Steineck G (2004) Talking about death with children who have severe malignant disease. N Engl J Med 351 (12): 1175–1186
57. Kurtenbach, Golombek, Siebers (1985) Krankenpflegegesetz mit Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Berufe in der Krankenpflege. Krankenhausrecht, Bd 5. Kohlhammer, Stuttgart
58. Kurz, Ronald et al (2001) Decision-making in extreme situations involving children: withholding or withdrawal of life supporting treatment in paediatric care. Statement of the ethics working group of the confederation of the European Specialists of Paediatrics (CESP) Eur J Pediatr 160: 214–216
59. Lemann M, Chaussade S, Halphen M, Floune B, Morcau J, Bommelaer G (1996) Attar A. Low-dose polyethylene glycol (PEG) in chronic obstipation: double-blind, placebo-controlled, crossover trial. Gastroenterology 110: A704
60. Levy M (1986) The international agranulocytosis and aplastic anemia study. Risks of agranulozytosis and aplastic anemia. A first report of their relation to drug use with special references to analgesics. JAMA 256: 1749–1757
61. Levy ME (1996) Pharmacologic treatment of cancer pain. N Engl J Med 335: 1124–1132
62. Loeb S, Hamilton HK, Blake GJ et al eds (1990) Handbook of pediatric drug therapy. Springhouse Cooperation, Springhouse, Pennsylvania
63. Lteif AN, Zimmerman D (1998) Bisphoshonates for treatment of childhood hypercalcemia. Pediatrics 102: 990–993
64. Lynn A, Nespeca MK, Bratton SL, Strauss S, Shen DD (1998) Clearance of morphine in postoperative infants during intravenous infusion: the influence of age and surgery. Anesth Analg 86: 958–963
65. Maxwell LG, Kaufmann SC, Bitzer S, Jackson EV Jr, McGready J, Kost-Byerly S, Kozlowski L, Rothmann Sk, Yaster M (2005) The effects of a small-dose naloxone infusion on opioid-induced side effects and analgesia in children and adolescents treated with intravenous patient-controlled analgesia: a double-blind, prospective, randomized, controlled study. Anesth Analg 100 (4) :953–958
66. McGrath P, Hsu E, Cappelli M, Luke B, Goodman J, Dunn-Geier J (1990) Pain from pediatric cancer: a survey of an outpatient oncology clinic. J Psychosoc Oncol 8: 109–124
67. McGrath PJ, Beyer J, Cleeland C, Eland J, McGrath PA, Portenoy R (1990) Report of the consensus conference on the management of pain in childhood cancer. Report of the

subcommittee on assessment and methodologic issues in the management of pain in childhood cancer. Pediatrics 5 (2 Suppl): 814–817
68. McQuay HJ, Tramer M, Nye BA, Carroll D, Wiffen PJ, Moore RA (1996) A systematic review of antidepressants in neuropathic pain. Pain 68: 217–227
69. Medizin-ethischer Arbeitskreis Neonatologie des Universitätsspital Zürich (2002) An der Schwelle zum eigenen Leben – Lebensentscheide am Lebensanfang bei zu früh geborenen, kranken und behinderten Kindern in der Neonatologie. Peter Lang, Bern
70. Mercadante S (1997) Malignant bone pain: pathophysiology and treatment. Pain 69: 1–18
71. Molen van der, B (1995) Dyspnoea: a study of measurement instruments for the assessment of dyspnea and the application for patients with advanced cancer. J Adv Nursing 22: 948–956
72. Mulberg AE, Linz C, Bern E, Tucker L, Verhave M, Grand RJ (1993) Identification of nonsteroidal antiinflammatory drug-induced gastroduodenal injury in children with juvenile rheumatoid arthritis. J Pediatr 122: 647–649
73. Mullan S (1973) Surgical management of pain in cancer of the head and neck. Surg Clin North Am 53: 203–10
74. Nauck F, Ostgathe C, Dickerson ED (2001) A German model for methadone conversion. Am J Hosp Palliat Care 18: 200–202
75. Olkkola KT, Hmunen K, Maunuksela EL (1995) Clinical pharmakokinetics and pharmacodynamics of opioid analgesia in infants and children. Clin Pharmacokinet 28: 385–404
76. Oliveri MB, Mautalen CA, Rodriguez Fuchs CA, Romanelli MC (1991) Vertebral compression fractures at the onset of acute lymphoblastic leukemia in a child. Henry Ford Hosp Med J 39: 45–8
77. Patel RI, Davis PJ, Orr RJ (1996) Single-dose ondansetron prevents postoperative vomiting in pediatric outpatients. Anesth Analg 85: 538–45
78. Pegelow CH (1992) Survey of pain management therapy provided for children with sickle cell disease. Clin Pediatr Philad 31: 211–4
79. Plieth m (2002) Kind und Tod – Zum Umgang mit kindlichen Schreckensvorstellungen und Hoffnungsbildern. Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn
80. Portenoy RK, Foley KM, Inturrisi CE (1990) The nature of opioid responsiveness and its implications for neuropathic pain: new hypotheses derived from studies of opioid infusions. Pain 43: 273–86
81. Pothmann R, Goepel R (1985) Comparison of the Visual Analog Scale (VAS) and a Smiley Analog Scale for the evaluation of pain in children. In: Fields HL, Dubner R, Cervero F (eds) Proceedings of the Fourth World Congress on Pain. Advances in Pain Research and Therapy, vol 9. Raven, New York
82. Pryle BJ, Grech H, Stoddart PA, Carson R, O'Mahoney TO, Reynolds F (1992) Toxicity of norpethidine in sickle cell crisis. BMJ 304: 1478–79
83. Ragg P (1997) Opioids in children. In: McKenzie IM, Gaukroger PB, Ragg PC, Brown TCK (eds) Manual of acute pain management in children. Churchill Livingston, New York, pp 25–38
84. Reimann J (1983) Kauend gegen Kinetosen. Dtsch Apotheker Z 123: 898–899
85. Reuben SS, Connelly NR, Lurie S, Klarr M, Gibson CS. Dose-response of ketorolac as an adjunct to patient-controlled analgesia morphine in patients after spinal fusion surgery. Anesth Analg 1998;87: 98–102

86. Richter HE (1992) Umgang mit Angst. Hoffmann & Campe, Hamburg
87. Röglin HC (1998) Menschenwürdiger Umgang mit dem Sterben aus Sicht praktizierender Onkologen. Forum DKG 13: 244–252
88. Schechter NL (1990) Report of the consensus conference on the management of pain in childhood cancer. Pediatrics 5 (Suppl 2): 813–834
89. Shannon M, Berde CB (1989) Pharmacologic Management of pain in children and adolescents. Pediatr Clin North Am 36: 855–871
90. Sharar SR, Bratton SL, Carrougher GJ (1998) A comparison of oral transmucosal fentanyl citrate and oral hydromorphone for inpatient pediatric burn wound care analgesia. J Burn Care Rehabil 19: 516–521
91. Sirkiä K, Saarinen UM, Ahlgren B, Hovi L (1997) Terminal care of the child with cancer at home. Acta Paediatr 86: 1125–30
92. Sirkiä K, Hovi L, Pouttu J, Saarinen-Pihkala UM (1998) Pain medication during terminal care of children with cancer . J Pain Symptom Manage 15: 220–26.
93. Southall D (1997) Prevention and control of pain in children. A manual for health care professionals. Royal College of Paediatrics and Child Health, BMJ Publishing Group, London
94. Statistisches Bundesamt (1999)
95. Student JC (2002) Sterbebegleitung – was ist aus dem Erwachsenenbereich auf Kinder übertragbar? Kinderkrankenschwester 21(4)139–144
96. Tobias JD, Martin LD, Wetzel RC (1990) Ketamine by continuous infusion for sedation in the pediatric intensive care unit. Crit Care Med 18: 819–821
97. Tobias JD (1997) Propofol sedation for the terminal care in a pediatric patient. Clin Pediatr 5: 291–93
98. Tramer MR, Reynolds JM, Moore RA, McQuay HJ (1997) Efficacy, dose-response, and safety of ondansetron in prevention of postoperative nausea and vomiting. Anesthesiology 87: 1277–1289
99. Vargas-Schaffer G. Pichard-Leandri E (1997) Neuropathic pain in young children with cancer. Eur J Palliat Care
100. Westlin JE, Letocha H, Jakobson A, Strang P, Martinsson U, Nilsson S (1995) Rapid, reproducible pain relief with 131Jod-MIBG in a boy with disseminated neuroblastoma. Pain 60: 111–114
101. Whittam, Elizabeth H (1993) terminal care of the dying child – psychosocial implications of care. Cancer 15, 71 (10 Suppl): 3450–3462
102. Wittkowski J (2002) Psychologie des Todes: Konzepte, Methoden, Ergebnisse. Verhaltensther Verhaltensmed 23 (1): 5–29
103. Wolfe J, Grier HE, Klar N (2000) et al.: Symptoms and suffering at the end of life in children with cancer. N Engl J Med 342: 326–333
104. World Health Organization (WHO) (1998) Cancer pain relief and palliative care in children. WHO, Genf
105. Wright PM, O'Toole DP, Barron DW (1993) The influence of naloxone infusion on the action of intrathecal diamorphine: low-dose naloxone and neuroendocrine response. Acta Anaesthesiol Scand 36: 230–233
106. Yaster M, Krane EJ, Kaplan RF, Coté CJ, Lappe DG (1997) Pediatric pain management and sedation handbook. In: Craven L, Buckwalter W (eds) Mosby-year book Mosby, St. Louis

107. Zernikow B (Hrsg)(2001) Schmerztherapie in der Kinderhämatoonkologie. In: Schmerztherapie bei Kindern. Springer, Berlin Heidelberg New York
108. Zernikow B, Bauer AB, Andler W (2000) STOP – A nationwide quality improvement program of pain control in pediatric oncology. 5th Internal Symposium on Paediatric Pain, 18–21.06.2000, London
109. Zernikow B, Bauer AB, Andler W (2001) Schmerztherapie in der pädiatrischen Onkologie – eine Bestandsaufnahme. Schmerz 16: 140–149
110. Zernikow B, Friedrichsdorf S, Wamsler C, Michel E (2002) Schmerztherapie und palliative Versorgung krebskranker Kinder. Vestische Kinderklinik Datteln, Datteln
111. Zernikow B, Grießinger N, Fengler R (1999) Praktische Schmerztherapie in der Kinderonkologie. Empfehlungen der Qualitätssicherungsgruppe der Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie (GPOH). Monatsschr Kinderheilkd 147: 438–56
112. Zernikow B, Lindena G (2001) Long acting morphine for pain control in paediatric oncology. Med Ped Oncol 36: 451–45

8 Palliativmedizin in den Entwicklungsländern

K.E. Clemens

Die Entwicklung der modernen Palliativmedizin begann in den späten 1960er Jahren in Großbritannien und wurde bald weltumfassend [2, 3]. Inzwischen sind in den meisten europäischen Ländern, in Nordamerika und in einigen Entwicklungsländern nationale Gesellschaften für Palliativmedizin gegründet worden. Zusätzlich sind einige internationale Gesellschaften wie die International Association of Hospice and Palliative Care (IAHPC), die European Association of Palliative Care (EAPC), die Pan American Health Organization (PAHO), die African Palliative Care Association (APCA) und die Latin American Palliative Care Association (ALCP/Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos) ins Leben gerufen worden.

Diese Organisationen haben bei der rapiden Weiterentwicklung der Palliativmedizin und der Verbesserung des Ausbildungsstands der Mitarbeiter im Gesundheitswesen weltweit eine große Rolle gespielt. Unter anderem wurde dies durch die Veranstaltung von Kongressen und eine Vielzahl von Publikationen in Bereich der Palliativmedizin erreicht. Nicht zuletzt haben die geradezu explosionsartige Ausbreitung von HIV und Aids und der daraus entstandene Bedarf an palliativmedizinischen und -pflegerischen (im Folgenden kurz Palliativdienste genannt) Diensten, v. a. in den Entwicklungsländern, die Entwicklung und Verbreitung der Palliativmedizin vorangetrieben.

Die vier wichtigsten Punkte im nationalen Cancer Control Program der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind Prävention, frühe Entdeckung der Erkrankung, Behandlung sowie palliative Versorgung [1]. Palliativmedizin hat sich als solider Teil der Basisversorgung von Patienten mit belastenden physischen und psychischen Symptomen und der Betreuung von deren Familien erwiesen. Diese palliativmedizinischen Interventionen sind einfach durchzuführen und kosteneffektiv.

Der Bedarf an Palliativmedizin und Palliativdiensten ist groß; allerdings ist der Zugang zu ihnen für Patienten – global betrachtet – leider immer noch sehr begrenzt. Während in Ländern wie Großbritannien [4], Kanada [5], Spanien [6, 7] und Deutschland [8] eine schnelle Zunahme und dynamische Entwicklung palliativmedizinischer und hospizlicher Dienste zu verzeichnen ist, sind dagegen die Einrichtung von Palliativstationen und die Durchführung von Ausbildungsprogrammen in den Entwicklungsländern bisher extrem limitiert und weit entfernt davon, eine zufrieden stellende Versorgung der Patienten gewährleisten zu können [9, 10].

Trotz aller Schwierigkeiten waren die letzten Jahre sehr spannend, interessant und nicht zuletzt überaus wichtig für die Entwicklung der Palliativmedizin und palliativmedizinischer und hospizlicher Dienste in den Entwicklungsländern. Auf internationalen Kongressen und in Publikationen sind eine Vielzahl von Problempunkten genannt worden, die als Barrieren für die Einrichtung von Palliativstationen und die Organisation bzw. Durchführung von Ausbildungsprogrammen in Entwicklungsländern gelten können.

Eine feste und falsche Meinung vieler leitender Verwaltungsangestellter, Ärzte, Lehrkräfte und Politiker in den Entwicklungsländern ist, dass Palliativmedizin ein Luxus sei, den man sich in den Ländern nicht leisten kann, in denen die Bevölkerung noch nicht einmal einen ausreichenden Zugang zu einer medizinischen Grundversorgung oder zu kurativen Interventionen hat.

Dieser Beitrag soll einen Überblick über die Probleme und den aktuellen Stand des Gesundheitswesens in einigen Entwicklungsländern geben und gleichzeitig zeigen, dass eine volle Integration der Palliativmedizin und der Palliativdienste in die Gesundheitssysteme und Ausbildungsprogramme der Entwicklungsländer genauso, wenn nicht sogar noch wichtiger ist als in den sog. entwickelten Ländern.

8.1 Lage des Gesundheits- und Sozialwesens in den Entwicklungsländern

Um den besonderen Bedarf an palliativmedizinischer Versorgung in den Entwicklungsländern verstehen zu können, muss man einen Einblick in die Lage und die spezifischen Gegebenheiten der Gesundheitssysteme dieser Länder haben.

Die große Mehrheit der Weltbevölkerung lebt in Entwicklungsländern. Diese Länder sind jedoch in Bezug auf geographische Gegebenheiten, ethnische Zusammensetzung und sozioökonomische Situation sehr verschieden. Dennoch, wie aus der Übersicht ersichtlich, ist eine Vielzahl von Problemen im Gesundheitswesen allen Entwicklungsländern dieser Welt gemeinsam [11–15].

Soziale, kulturelle und medizinische Herausforderungen für das Gesundheits- und Sozialwesen in den Entwicklungsländern

- Armut
- Hohe Bevölkerungszahl
- Arbeitslosigkeit
- Hungersnot/chronische Unterernährung
- Schlechter Ausbildungsstand
- Kulturelle und religiöse Unterschiede
- Hohe Morbidität und Mortalität infolge von Infektionserkrankungen
- Hohe Mortalität infolge von chronischen Erkrankungen
- Misstrauen in Bezug auf ausländischen Einfluss

Weltweit sterben jährlich mehr als 50 Mio. Menschen. Etwa 80% davon sterben in Entwicklungsländern, begleitet von Schmerz und anderen Symptomen [19]. Naturkatastrophen und kriegerische Auseinandersetzungen sind häufig die Ursachen für Hungersnot, Umsiedlung und/oder Tod vieler Menschen dieser Regionen. Dazu kommt, dass die einkommensschwache Bevölkerung an chronischer Unterernährung leidet, mit der Konsequenz langfristiger Folgen für den Gesundheitszustand. In Ländern, in denen Hungersnot herrscht, die politische Situation aber eher unauffällig ist, gibt es ein Sterben, das von der Weltgemeinschaft kaum wahrgenommen wird. Die Hilfen fließen spärlich und erreichen bislang viel zu wenige leidende und sterbende Menschen.

Der Großteil dieser Bevölkerungsgruppen hat keinen Zugang zu Schulbildung. So sind auch einfach geschriebene Informationen oft nur von begrenzter Effektivität, weil die meisten Menschen nicht lesen können. Weit verbreitete Missverständnisse und unrichtige Annahmen über Ursachen, Behandlung und Heilung von Krankheiten werden von Generation zu Generation weitergegeben, und manche traditionell begründeten Verhaltensweisen

und medizinischen Praktiken können und werden die Gesundheitsprobleme in diesen Ländern weiter verschlimmern.

In den einzelnen Entwicklungsländern leben unterschiedliche Gruppen mit einer jeweils starken eigenen kulturellen und religiösen Identität. Tradition spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle für das Verhalten und den Glauben der Bevölkerung in Bezug auf Gesundheit/Hygiene oder die Therapie von Krankheiten.

Der Versuch, die westliche Medizin mit den traditionellen Praktiken dieser Bevölkerungsgruppen zu vereinigen, misslingt häufig aufgrund eines Klimas des Misstrauens und aus Angst vor einem unangemessen großen ausländischen Einfluss auf die Modalitäten der Gesundheitsdienste, v. a. in den Ländern, die unter den Auswirkungen der Kolonialisierung sehr gelitten haben. Diese historische Hypothek hat – neben endogenen Faktoren – auf dem afrikanischen Kontinent deutliche Spuren hinterlassen und sowohl eine eigenständige als auch eine integrative Entwicklung weitgehend gehemmt.

Die bereits oben in der Übersicht aufgelisteten Probleme stellen enorme personelle wie auch finanzielle Herausforderungen für das Gesundheits- und Sozialwesen der Entwicklungsländer dar. Armut, ein immer größer werdendes und durchdringendes Problem der meisten Entwicklungsländer, bringt eine Vielzahl anderer, zzt. aus eigener Kraft nicht beherrschbarer Probleme mit sich.

Die große Mehrheit der Bevölkerung in vielen Regionen der Welt, einschließlich Lateinamerika und Afrika, hat keinen Zugang zu sozialer Sicherheit oder die Möglichkeit privater Versicherungen und ist deshalb abhängig von öffentlichen Gesundheitsdiensten, deren Logistik und Erreichbarkeit. Vielen Patienten und deren Familien fehlen schon die einfachsten Mittel für das tägliche Leben; das Geld für den Transport zu den medizinischen Einrichtungen oder für notwendige Medikamente können sie deshalb nicht aufbringen [9, 14].

In Entwicklungsländern sind Infektionskrankheiten eine viel häufigere Ursache für Morbidität und Mortalität als in den Industrie- und Schwellenländern (◘ Abb. 8.1 und 8.2) [16]. Während in Afrika ca. 61,7% der Todesfälle durch Infektionserkrankungen verursacht werden, sind es in Europa nur 5,4% oder in Nordamerika 6,3% [28]. Patienten sterben viel jünger und unter nicht kontrollierten Bedingungen an Krankheiten, die man in entwickelten Ländern kurativ oder gut symptomkontrolliert behandeln kann.

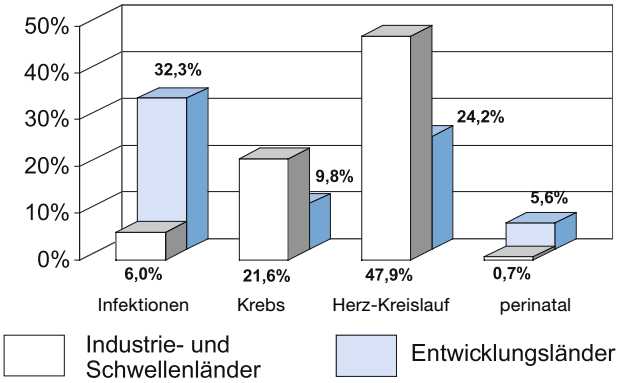


Abb. 8.1. Todesursachen weltweit 2000 [WHO (2001) World Health Report 2001].

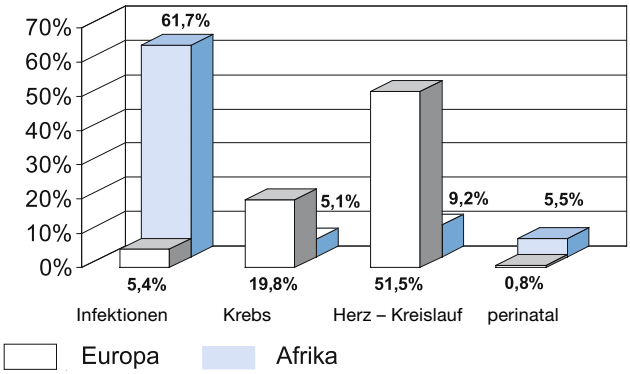


Abb. 8.2. Todesursachen in Europa und Afrika 2000 [WHO (2001) World Health Report 2001]

Weltweit sind seit dem Ausbruch von HIV/Aids mehr als 25 Mio. Menschen an Aids gestorben. Mehr als 42 Mio. Menschen sind mit HIV infiziert; 5 Mio. Menschen haben sich 2002 neu damit infiziert, 3,1 Mio. sind 2002 insgesamt daran gestorben. Brennpunkt sind die afrikanischen Länder südlich der Sahara (Tab. 8.1). Dort sind laut UNAIDS (Joint United Nations

Tab. 8.1. Anzahl der Waisenkinder in Afrika (2001). (Nach UNAIDS 2002 [35])

Land	Kinder 0–14 Jahre	Gesamtzahl der Waisen	Gesamtzahl der Waisen in %	Anteil der Aids-Waisen	Anteil der Aids-Waisen in %
Simbabwe	5.779.000	1.018.000	17,6	782.000	76,8
Sambia	4.961.000	874.000	17,6	572.000	65,4
Swaziland	388.000	59.000	15,2	35.000	58,8
Kenia	13.428.000	1.659.000	12,4	892.000	53,8
Uganda	11.852.000	1.731.000	14,6	884.000	51,1
Malawi	5.350.000	937.000	17,5	468.000	49,9
Namibia	780.000	97.000	12,4	47.000	48,5
Südafrika	14.773.000	1.528.000	10,3	662.000	43,3

Programme on HIV/Aids) 29,4 Mio. Täger des Virus [20]. Zum Beispiel sind in Namibia schätzungsweise 20–26% der 15- bis 49-Jährigen und in Botswana bereits 39% aller Erwachsenen mit HIV infiziert [12, 17, 20]. Tuberkulose ist die häufigste Todesursache bei HIV-positiven und -negativen Patienten [18,41]. Die meisten Patienten sterben jung und in einem produktiven Alter und hinterlassen ihre Familien in großer Armut.

Zu den bereits vorhandenen übertragbaren Krankheiten in den Entwicklungsländern ist in den letzten Jahren eine hohe Zunahme der Inzidenz der nicht übertragbaren Krankheiten gekommen [21,40]. Krebs- und chronische Erkrankungen sind in der Behandlung teurer als Infektionserkrankungen und werden deshalb bei der Bewilligung von Mitteln für das Gesundheitswesen weniger berücksichtigt. Im Falle der Krebserkrankungen beträgt die Mortalität in den Industrie- und Schwellenländern laut WHO schätzungsweise 50%, während sie in den Entwicklungsländern 70% bereits überschritten hat [19, 22]. Nach Schätzungen der WHO wird die Anzahl der Krebserkrankungen in Sub-Sahara-Afrika in den nächsten 50 Jahren über 400% wachsen. Etwa

80% dieser Patienten sind in einem weit fortgeschrittenen und inkurablen Tumorstadium bereits bei der Diagnosestellung [39].

Die hohe Zahl der Waisenkinder spiegelt in dramatischer Weise die verheerenden Auswirkungen von HIV und Aids in den Entwicklungsländern. Im Jahr 2001 gab es in Sub-Sahara-Afrika mehr als 34 Mio. Waisen, über ein Drittel (13.200.000) dieser Kinder verlor seine Eltern durch Aids. UNAIDS schätzt, dass 2010 der Zahl der Waisenkinder 44 Mio. erreicht haben wird [35]. Nur in den asiatischen Ländern liegt die Gesamtzahl der Waisenkinder noch höher. 65 Mio. Waisenkinder wurden im Jahr 2001 in Asien registriert, davon sind. ca. 2 Mio. Aids-Waisen. Weltweit haben mehr als 13,4 Mio. Kinder ihre Eltern durch Aids verloren [35]. Dies sind Zahlen, die nachdenklich machen und Fragen aufkommen lassen. Die traurige Realität ist, dass viele dieser Waisenkinder bereits bei der Geburt mit HIV infiziert sind und im ersten Lebensjahr sterben.

Rechtzeitig diagnostiziert und adäquat betreut, könnten ca. 67% der von einer Krebserkrankung betroffenen Kinder in den Industrieländern kurativ behandelt werden [36]. In Entwicklungsländern zeigt sich die Situation bei Krebserkrankungen ganz anders. Wie auch bei Erwachsenen ist die Erkrankung bei Diagnosestellung in der Regel bereits weit fortgeschritten und nicht mehr kurativ zu behandeln. Deshalb muss die Linderung von Schmerzen und anderen Symptomen einen wesentlichen Anteil in der Pädiatrie der Entwicklungsländer ausmachen. Aufgrund der weiterhin steigenden Anzahl Aids-infizierter Kinder wird die Palliativversorgung in der nahen Zukunft auch in der Pädiatrie sicher im Vordergrund stehen müssen.

Die Kindersterblichkeit in Afrika von Kindern unter fünf Jahren zeigt Abb. 8.3.

Unbehandelter Schmerz und nicht kontrollierte andere Symptome bedeuten für die Kinder und deren Familien eine enorme Belastung. Ein Erfolg der zur Verfügung stehenden Therapieoptionen wird durch unzureichende Schmerztherapie oder Symptomkontrolle zusätzlich erschwert. Nicht selten sind die Kinder ängstlich und haben Schlaf- und Essstörungen. Eltern leiden unter Schuld- und Ohnmachtsgefühlen, die sich nicht selten als Misstrauen oder Verärgerung gegenüber dem medizinischen Personal äußern. Ein krankes Kind ist immer schutzbedürftig und verlangt enorme Sensibilität und Einfühlungsvermögen von den Behandelnden und Pflegenden. Eltern hingegen brauchen eine umfassende Anleitung und Unterstützung, um mit der Erkrankung ihres Kindes und mit ihren eigenen Ängsten umgehen zu können.

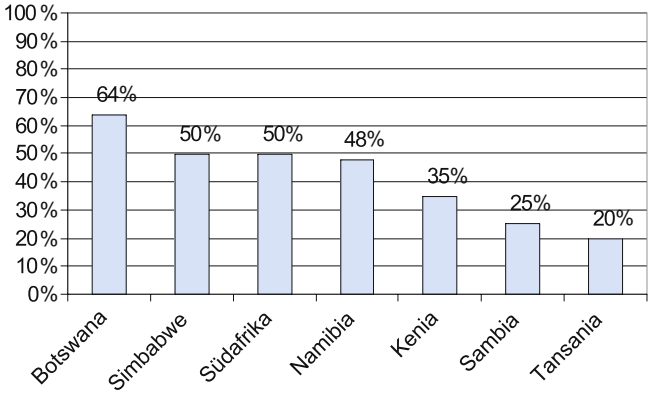


Abb. 8.3. Kindersterblichkeit in Afrika bei Kindern unter 5 Jahren in % (2000–2005). (Nach World Summit for Children [37])

Das ständige Bemühen um Schmerzlinderung oder Vermeidung des Leidens, dabei die richtige Balance zwischen Nutzen und Belastung durch eine kompetente Therapie zu finden, ist eines der wichtigsten Ziele der palliativmedizinischen Behandlung erkrankter Kinder.

8.2 Probleme der Gesundheitssysteme

Die Übersicht zeigt einige Haupthindernisse für den Zugang zu medizinischer Versorgung in Entwicklungsländern.

Probleme der Gesundheitssysteme

- Mangel an medizinischem Personal
- Große Entfernungen zu medizinischen Einrichtungen
- Mangel an Medikamenten
- Mangel an Technologie
- Limitierte oder fehlende Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Der Mangel an Ärzten und an Pflegepersonal ist eines der gravierendsten Probleme. Die Landbevölkerung ist aufgrund fehlender Transportsysteme noch häufiger als die Menschen aus städtischen Regionen mit Problemen wie z. B. mangelnder Erreichbarkeit und Zugang zu Gesundheitsdiensten konfrontiert [23]. In den abgelegenen Gebieten der Entwicklungsländer könnte die Versorgung mit ausgebildetem Krankenpflegepersonal, einem gut funktionierenden Telekommunikationssystem und regelmäßigen Transportgelegenheiten zu Kliniken und Ambulatorien eine mögliche Übergangslösung sein. Zumeist aber fehlen alle diese Ressourcen.

Die Situation wird dadurch noch verschlimmert, dass die Anzahl der Landbevölkerung im Vergleich zu den in den Städten lebenden Menschen sehr viel größer ist und die Entfernungen zu den Städten meistens mehrere hundert bis tausend Kilometer betragen. Trotzdem ist dieses Problem nicht nur auf die abgelegenen Gebiete beschränkt. Auch in den Städten fehlt es an Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten im medizinischen Bereich, an Ärzten, Pflegepersonal und Krankenhäusern, was meistens auf die Armut des jeweiligen Landes zurückzuführen ist.

Die bereits existierenden Gesundheitseinrichtungen sind nicht nur hoffnungslos überfüllt, sondern haben zudem nur einen limitierten Zugang zu Medikamenten und der notwendigen medizinischen Technologie. Die technischen Voraussetzungen zur Produktion von Medikamenten fehlen oder sind nicht ausreichend vorhanden. In den meisten Fällen werden die notwendigen Medikamente aus Industrieländern importiert. In Ländern, in denen noch nicht einmal die Mittel für eine ausreichende Versorgung mit Lebensmitteln vorhanden sind, ist es den Gesundheitsdiensten nicht möglich, der Bevölkerung auch nur die notwendigsten Medikamente kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Anderseits ist es bei den extrem niedrigen Einkommen den Patienten und deren Familien unmöglich, die Kosten für die Medikation selbst zu übernehmen [14, 15]. Hinzu kommt, dass häufig mehrere Familienmitglieder erkrankt sind und behandelt werden müssen.

Aus diversen komplexen und nicht nachvollziehbaren Gründen sind die Kosten für Analgetika in den Entwicklungsländern höher als in den westlichen Ländern [24]. Preise für Opioide können bis zu 30% des monatlichen Pro-Kopf-Einkommens betragen (Entwicklungsländer: 32% der untersuchten Medikamente; Industrieländer 3%). Bei 25% der Opioide betragen die Kosten in den Industrieländern 1% des monatlichen Pro-Kopf-Einkommens

oder weniger, in den Entwicklungsländern ist keines der Opioide zu diesem Preisniveau zu haben. Dafür kosten dort einige Opioide sogar mehr als das 1000fache des monatlichen Pro-Kopf-Einkommens [38]. Vollkommen unerschwinglich für die meisten Patienten sind Arzneimittel für die Behandlung von Aids [25].

Obwohl es schwierig ist, zuverlässige Zahlen aus den verschiedenen Entwicklungsländern zu erhalten, ist es unumstritten, dass große Defizite im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung für medizinisches Personal und Medizinstudenten existieren. Die rapide zunehmende Zahl der Aids-Erkrankungen – zusammen mit der Tatsache, dass der Anteil unheilbarer Tumorpatienten in den letzten Jahren auch in den Entwicklungsländern gestiegen ist – bedeutet eine ansteigende Zahl von Patienten, die eine palliativmedizinische Behandlung, Pflege und Begleitung benötigen. Weil Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote aber weitgehend fehlen, werden immer mehr Ärzte und Studenten ins Ausland gehen und nach Beendigung ihres Studiums nicht mehr in ihr Heimatland zurückkehren [26].

8.3 Die Rolle der Palliativmedizin

In den vorherigen Abschnitten wurden einige Hauptprobleme der Gesundheitsdienste in Entwicklungsländern zusammengefasst. Wegen dieser bisher ungelösten Probleme werden die meisten Entwicklungsländer ihre bisherige Gesundheitspolitik überdenken müssen. Dazu ist ein Umdenken und eine neue Anordnung der Prioritäten in der Gesundheitspolitik notwendig (◘ Abb. 8.4).

Palliativmedizin fokussiert auf eine exzellente Schmerz- und Symptomkontrolle von Patienten mit einer progressiven, nicht heilbaren Erkrankung und integriert die psychosozialen und spirituellen Bedürfnisse dieser Patienten sowie von deren Angehörigen [27].

Palliativmedizin ist dazu geeignet, die Lebensqualität von Patienten und deren Familien erheblich zu verbessern; effizient eingesetzt, kann sie eine Ersparnis auf dem Kostensektor der Gesundheitsdienste erreichen [27]. Deshalb ist eine erfolgreiche palliativmedizinische Versorgung der Patienten und von deren Angehörigen in den Entwicklungsländern ethisch unumgänglich und wirtschaftlich gesehen eine Notwendigkeit für das öffentliche Gesundheitswesen.

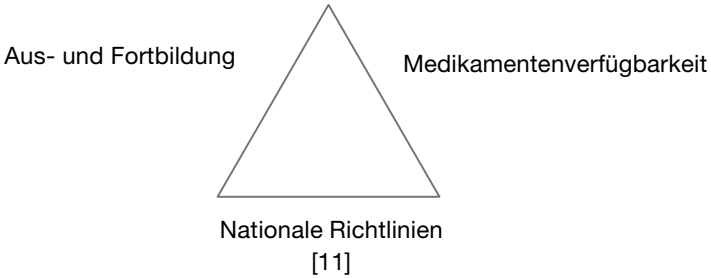


Abb. 8.4. Basis für erfolgreiche Palliativprogramme

Um in Entwicklungsländern die Ziele der Palliativmedizin jedoch erfolgreich umsetzen zu können, müssen sich die Programme signifikant von den Palliativprogrammen in den Industrie- und Schwellenländern unterscheiden und auf die Bedürfnisse der dort lebenden Menschen zugeschnitten sein, was jedoch bisher nur in wenigen spezializierten Zentren umgesetzt wurde und für einen Bruchteil der bedürftigen Menschen angeboten wird. Die Vielschichtigkeit der zu berücksichtigenden Faktoren im Zusammenhang mit den Bekämpfungs- und Behandlungsmöglichkeiten der Infektions- und Krebserkrankungen zeigt sich besonders dort, wo die schlechtesten Rahmenbedingungen für die Gesundheitsversorgung anzutreffen sind.

Als die Idealsituation für jede Krankheitsbekämpfung wird immer anzusehen sein, wenn ein Patient, der um seine Erkrankung weiß, von den Erfordernissen der Therapie überzeugt ist und sich in diesem Sinne auch aktiv an der Behandlung beteiligt sowie alle Möglichkeiten aufbietet und zur Verfügung gestellt bekommt, um den Genesungsprozess oder die Symptomkontrolle positiv zu beeinflussen. In den Entwicklungsländern können die meisten Fälle jedoch als »social disease« beschrieben werden, d. h. Leben unter ärmlichsten Verhältnissen, unter unzureichenden hygienischen Bedingungen und weiteren polykausalen Defiziten; in der Regel ist keiner der für die Idealsituation genannten Aspekte gegeben, und die Situation verhält sich diametral entgegengesetzt.

Die in Tab. 8.2 aufgeführten Punkte zeigen einige Unterschiede der gegebenen Voraussetzungen für Palliativprogramme in Entwicklungsländern im Vergleich zu den Industrie- bzw. Schwellenländern.

Tab. 8.2. Gegebene Voraussetzungen für Palliativprogramme

	Entwicklungsländer	Industrieländer
Sterbeort	Zu Hause	In medizinischen oder Pflegeeinrichtungen
Pflege	Angehörige	Professionelle Pflege
Infrastruktur	Fehlt	Gut
Krankenversicherungen	Keine	Gesetzliche oder private Versicherung
Gesundheits- und Hygiene-bewusstsein	Mangelhaft	Gut
Verfügbarkeit von Medikamenten	Mangelhaft	Gut
Medikamentenpreise (im Verhältnis zum Pro-Kopf-Einkommen)	Hoch	Niedrig
Ausbildungsstand des medizinischen Personals	Mangelhaft	Gut

Der Großteil der Patienten in Entwicklungsländern stirbt zu Hause, auf engstem Wohnraum, in provisorisch anmutenden Behausungen, in der eigenen Gemeinde, unter der Pflege der (Groß-)Familie und/oder Nachbarn, ohne ärztliche oder medizinische Versorgung. Mangelnde Trinkwasserversorgung und fehlende sanitäre Ausstattung sowie mangelnde Körper- und Sexualhygiene wie auch durch Hunger oder Alkoholismus bedingte Unter- und Fehlernährung bieten einen Keimboden für Infektionskrankheiten, ergänzt durch fehlendes Gesundheits- und Hygienebewusstsein.

Deshalb ist es besonders wichtig, die Bedeutung und die praktischen Möglichkeiten der Palliativmedizin gezielt dorthin zu überliefern. Mitarbeiter der Gesundheitsdienste und Nichtregierungsorganisationen (NGO) müssen Familienangehörige und Gemeindemitglieder an Ort und Stelle praxisorientiert palliativmedizinisch ausbilden und begleiten. Bei den für

die Bevölkerungszahl viel zu niedrigen Angeboten an Kliniken und medizinischem Personal kann die Hoffnung auf eine flächendeckende Versorgung Kranker – und insbesondere infizierter Patienten – nur verwirklicht werden durch die Bildung mehrerer kleiner Zentren bzw. Medikamentenstationen, die durch gezielt eingesetzte Kenntnis über die Problemsituationen v. a. eine angemessene palliativmedizinische Behandlung ermöglichen und dabei mit geringem Aufwand den größtmöglichen Nutzen für die Patienten erzielen können.

Die sozioökonomische Realität in den meisten Ländern macht es erforderlich, dass Palliativprogramme neben der Förderung von Ausbildung auch beinhalten, dass den Patienten und deren Familien Medikamente und pflegerische Betreuung sowie wünschenswerterweise auch Nahrungsmittel (zur Vermeidung möglicher medikamentös bedingter Nebenwirkungen) kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Nicht zuletzt zeigt sich aber die dringende Notwendigkeit zu einer Integration der kulturellen, religiösen und kommunikativen Praktiken in die »neue Medizin«. Unter den erschwerten Bedingungen und Verhältnissen in den Entwicklungsländern kann es bisweilen noch schwieriger als die Patientenaufklärung sein, Ärzte und Pflegepersonal von der Notwendigkeit einer dezentralisierten und normierten Palliativbehandlung zu überzeugen. So sehr auch der individuelle Patient mit seiner Infektions- oder nicht heilbaren Erkrankung im Zentrum der Therapie zu stehen hat, so wichtig sind auch zusätzliche Hilfen für die Erhaltung oder Wiederherstellung der sozialen Situation der Familie. Die ganze Familie leidet unter dem die Existenz bedrohenden Ausfall einer Arbeitskraft, unter dem Ansteckungsrisiko sowie unter dem aussichtlosen Kampf gegen den Tod eines ihrer Mitglieder.

Das größte Problem für die Etablierung der Palliativmedizin in den Entwicklungsländern liegt nicht in der Frage nach der grundsätzlichen Therapierbarkeit der Symptome, sondern in den beschränkten Möglichkeiten, die Behandlung überhaupt durchführen zu können, wenn die Bevölkerung der am stärksten betroffenen Entwicklungsländer erst dazu ermuntert werden muss, am Behandlungsplan aktiv teilzunehmen. Das beste Programm ist untauglich, wenn es seinen Adressaten nicht erreicht, weshalb auch auf diesem Gebiet Anstrengungen zu unternehmen sind.

Den Kern der Bemühungen stellt anstelle einer medizinischen Entwicklungshilfe »von außen und oben« eine Unterstützung »von innen und un-

ten« dar, die der sozialen Situation in Entwicklungsländern gerecht werden muss und erst dadurch eine effiziente palliative Versorgung der Patienten und von deren Angehörigen ermöglichen kann. Dabei sollte sich die Therapie als Gesamtkonzept möglichst in die bestehenden Rahmenbedingungen einfügen.

Unumgänglich ist die Aufklärung der Patienten und der Angehörigen über die Möglichkeiten der Palliativmedizin, z. B. dass

- palliative Versorgung (medizinisch und pflegerisch) die Lebensqualität der Patienten verbessert, auch wenn die Erkrankung selbst, etwa Krebs, nicht heilbar ist;
- es Behandlungsmethoden gibt, die Schmerzen und andere Symptome lindern können;
- Patienten nicht notwendigerweise unter unerträglichen Schmerzen oder anderen Besorgnis erregenden Symptomen, wie etwa Übelkeit oder Erbrechen, leiden müssen;
- keine Abhängigkeit durch die Einnahme von Opioiden entsteht [34].

Vielleicht eine der größten Herausforderungen für die erfolgreiche Integration der Palliativmedizin stellt die Tatsache dar, dass die Patienten in Entwicklungsländern häufiger an Krankheiten sterben, die in Industrie- und Schwellenländern nur selten vorkommen, wie beispielsweise

- Malaria,
- chronische Infektionserkrankungen oder
- Tollwut.

Auch die Krankheiten, die in den Industrie- und Schwellenländern auftreten, etwa:

- Tuberkulose,
- HIV/Aids oder
- Krebserkrankungen,

präsentieren sich in den Entwicklungsländern mit einem anderen und häufig schwereren Krankheitsbild – wegen der fehlenden präventiven oder kurativen Therapiemöglichkeiten oder wegen einer für viele Patienten zu späten Diagnosestellung. Für diese Patienten müssen passende und v. a. unter den jeweiligen Bedingungen durchführbare Therapiekonzepte für eine suffiziente Symptomkontrolle entwickelt werden.

8.4 Die Rolle der Aus- und Fortbildung

Die Weiterentwicklung der Palliativmedizin als solche und die Aus- und Weiterbildung im Bereich der Palliativmedizin sollte in den Entwicklungsländern neben der präventiven Aufklärung oberste Priorität für die nächsten Jahre und Jahrzehnte haben. Palliativmedizin ist kosteneffektiv, ethisch gerechtfertigt und gesellschaftlich notwendig sowie praktisch auch für große Bevölkerungsgruppen mit großem Wirkungspotenzial durchführbar. Ihre Anwendung erhöht die Lebensqualität der Patienten, reduziert psychosoziales Leid und kann den schmerzlichen Verlust für die Familien lindern. Zusätzlich setzt sie der drohenden Resignation unter den Mitarbeitern der Gesundheitsdienste ein motivierendes, sinnvolles und Erfolg versprechendes Handlungskonzept entgegen.

Weiterhin müssen die Curricula für Ärzte und Pflegekräfte ebenso wie die Therapiekonzepte für die palliative Versorgung selbst sich in den Entwicklungsländern signifikant von den Erfordernissen in den westlichen Ländern unterscheiden. Die Schwerpunkte müssen im Bereich der palliativen Hausbetreuung sowie der Sterbebegleitung liegen, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Hintergründe der Pflegenden (Familienmitglied, Nachbar oder ehrenamtliche Helfer bzw. professionelle Helfer) sowie der Art der Intervention (wenig aufwändige und orale, subkutane oder rektal applizierbare Medikation, Beratung der Patienten und Angehörigen). Genauso wichtig ist die Beachtung der psychosozialen Aspekte unter Berücksichtigung der gegebenen kulturellen und religiösen Anschauungen.

In den letzten 15 Jahren hat sich in den westlichen Ländern die Palliativmedizin zunehmend neben der kurativen Medizin etablieren können und ist auf dem Weg, sich als eine gleichwertige Disziplin durchzusetzen.

Wie aus dem Modell der WHO für Palliative and Terminal Care (palliativmedizinische Behandlung und Betreuung terminal kranker Patienten; ◘ Abb. 8.5) für die Entwicklungsländer im Vergleich mit den Industrie- und Schwellenländern ersichtlich ist, muss die Palliativversorgung der Patienten und Angehörigen zu einem viel früheren Zeitpunkt beginnen als in den Industrie- und Schwellenländern, und zwar v. a. deshalb, weil diese Länder nur über sehr begrenzte finanzielle und therapeutische Ressourcen für die kausale Krebstherapie verfügen.

Diesem Modell folgend und in Kenntnis der aktuellen Probleme in den Entwicklungsländern kann man davon ausgehen, dass für die meisten Ent-

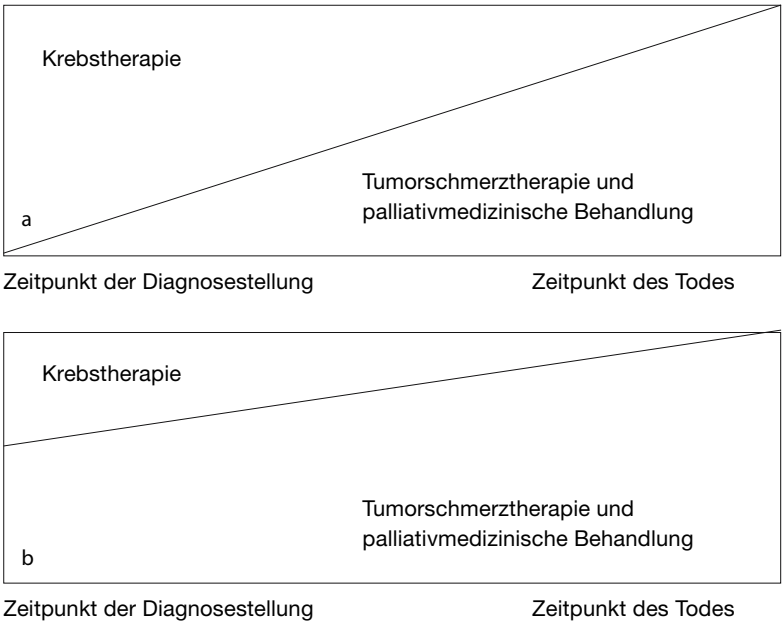


Abb. 8.5a, b. WHO-Modell für die palliativmedizinische Behandlung und Betreuung terminal kranker Patienten: *a* empfohlene Zuteilung der Ressourcen für die Krebsbehandlung in den Industrieländern; *b* in den Entwicklungsländern

wicklungsländer die palliativmedizinische Versorgung der Patienten und ihrer Angehörigen in den nächsten Jahren eine größere Komponente des Gesundheitssystems darstellen wird als die kurative Versorgung. Dies ist allein schon deshalb zu erwarten, weil es voraussichtlich eine mehrere Generationen umfassende Periode dauern wird, bis die präventiven Maßnahmen, die erst in jüngster Zeit ernsthaft ergriffen worden sind, wie z. B. Aufklärungsarbeit der Gesundheitsbehörden und kostenlose Verteilung von Kondomen, eine positive Wirkung zeigen können.

Grundsätzlich könnte man die Behandlung lebensbedrohlicher Erkrankungen in den Entwicklungsländern insgesamt eher als palliative Behandlung einordnen, da kurative Ansätze praktisch so gut wie nicht existieren.

Die Aus-, Fort- und Weiterbildung in Palliativmedizin und -pflege ist klinisch und ethisch notwendig und bedeutet zudem eine kosteneffektive, global sinnvolle Investition in medizinische Fakultäten und Einrichtungen sowie in die Effizienz des medizinischen Personals. Für viele einkommensschwache Länder wird aufgrund des oben Dargestellten die palliativmedizinische Ausbildung von ganz besonders großer Bedeutung sein.

Daher sind Palliativmedizin und palliativmedizinische Ausbildung ein wichtiger und effektiver Bereich der modernen medizinischen Entwicklungshilfe, denn sie garantieren eine lang anhaltende positive Folgewirkung, die weit mehr Aspekte umfasst als Leidenslinderung und Verbesserung der Lebensqualität.

8.5 Stand und Stellenwert der Palliativmedizin in den Entwicklungsländern

Neben den geschilderten schwer wiegenden Problemen gibt es aber auch durchaus positive Entwicklungen, die Hoffnung auf eine weitere Entwicklung palliativmedizinischer und hospizlicher Dienste geben können. In den vergangenen Jahren haben in vielen Ländern des afrikanischen Kontinents trotz ungünstiger Rahmenbedingungen gesundheitspolitische Veränderungen in Richtung einer Demokratisierung bislang autoritärer Systeme und in Hinblick auf die Wahrung der Menschenrechte stattgefunden. Die neue Generation politischer Eliten zeigt sich deutlich werte- und entwicklungsorientierter. Eine ernsthafte und lebhafte Diskussion sowie die beginnende Umsetzung dieser neuen Haltung auf gesundheitspolitischer Ebene sind zu beobachten und zeigen eindrucksvoll, dass erhebliche Fortschritte machbar geworden sind.

8.5.1 Sub-Sahara-Afrika

Das erste Hospiz in dieser Region wurde bereits 1977 in Simbabwe gegründet. Erst 1990 folgte das zweite Hospiz in Nairobi [29]. In Uganda wurde im Jahr 1993 mit sehr wenigen und bescheidenen Mitteln ein Hospiz eröffnet, das für die anderen afrikanischen Länder als Modellprojekt gilt und mit dem gezeigt werden sollte, dass sowohl die Hospizphilosophie als auch pflegerische und medizinische Palliativbetreuung kulturell und ökonomisch an die afrikani-

sche Gesamtsituation angepasst werden können. Uganda hat eine Population von ca. 20 Millionen und eine Krebsinzidenz von 20.000 statistisch erfassten neuen Fällen pro Jahr. Die Zahl der tatsächlichen Neuerkrankungen wird mit Sicherheit im sechsstelligen Bereich liegen. Die Aids-Prävalenz im Jahr 1997 betrug 658.000 [31].

Uganda war bisher das einzige afrikanische Land mit einem Fünfjahresstrategieplan (2000–2005) für Palliativmedizin. Regierung und Gesundheitsbehörden bemühen sich, eine flächendeckende Palliativversorgung für alle Distrikte zu erreichen und eine zumindest zu Beginn der Behandlung kostenlose Versorgung mit Morphin zu ermöglichen. Im Jahr 2001 wurde dies in 14 der 56 Distrikte erreicht.

Im Hospiz Uganda werden Patienten mit Krebs- oder anderen Erkrankungen, z. B. Aids, TBC im Terminalstadium, behandelt. Schätzungsweise 75% der Krebspatienten haben auch Aids [30]. Allein bis 2002 wurden ca. 3.500 Patienten versorgt. Zusätzlich konnten durch das mobile Hospiz Mbarara 1300 weitere Patienten erreicht werden [30].

1999 wurde die Palliative Care Association of Uganda gegründet, die heute etwa 80–100 Fördermitglieder hat. Viermal jährlich erscheint eine Fachzeitschrift. Palliativmedizin und -pflege werden an der Universität Makerere seit 1993 und an der Medical School in Mbarara seit 1998 unterrichtet. Im 4. Jahr ihrer Ausbildung erhalten Studenten etwa 10 Stunden Unterricht in Palliativmedizin und müssen ein einwöchiges Praktikum im Hospiz Uganda absolvieren. Unterrichtsinhalte sind u. a. Schmerztherapie, Symptomkontrolle, Kommunikation, Spiritualität und Ethik. Einen Lehrstuhl für Palliativmedizin gibt es in den afrikanischen Ländern bisher nicht, in Uganda wird derzeit aber die Einrichtung einer Professur für Palliativmedizin diskutiert.

Für Unterrichtszwecke gibt es das Lehrbuch »Palliative Medicine, Pain and Symptom Control in the Cancer and/or Aids Patient in Uganda and other African Countries« (Palliativmedizin, Schmerztherapie und Symptomkontrolle bei Krebs-und/oder Aids-Patienten in Uganda und anderen afrikanischen Ländern) sowie ein Handbuch »Palliative Care Training Manual for Health Professionals« (Handbuch für die Ausbildung von Mitarbeitern des Gesundheitswesens in Palliativmedizin und -pflege). Seit April 2002 bietet die Universität Makerere zusätzlich ein dreisemestriges Fernstudium mit dem Diplomabschluss »Palliative Care for Africa« an. Dieser Kurs beinhaltet zwei Vor-Ort-Unterrichtseinheiten im Hospiz Uganda. Die Finanzierung der Hospize erfolgt durch Spenden aus dem In- und Ausland [30].

Auch in Südafrika ist eine erfreuliche Entwicklung der Palliativmedizin und palliativer Dienste, v. a. im Bereich der Ausbildung, zu verzeichnen. Seit 2001 bietet die Universität Cape Town ein Palliative Medicine Diploma and Masters Degree an. Bis dahin wurden nur Kurzlehrgänge für Krankenschwestern veranstaltet.

Die Zunahme der Aids-Erkrankungen neben der hohen Inzidenz an fortgeschrittenen Krebserkrankungen hat auch in Südafrika die Entwicklung neuer Therapiekonzepte für die Schwerkranken im Terminalstadium notwendig gemacht. Die Hospice Association of South Africa (HASA) entwickelt Therapie- und Pflegestandards sowie Pflegeprotokolle für die Dokumentation.

Im Hospiz Witwatersrand ist 2001 das Centre for Palliative Learning eröffnet worden. Ein multiprofessionelles Team unterrichtet Ärzte, Pflegekräfte und andere Mitarbeiter des Gesundheitswesens. HASA plant, weitere Ausbildungszentren in Südafrika zu eröffnen mit dem Ziel der Vernetzung aller südafrikanischen Länder.

Weitere Hospiz- und Palliativprogramme gibt es u. a. in Malawi, Botswana, Äthiopien und Namibia.

8.5.2 Lateinamerika

Im März 1990 haben sich Ärzte, Vertreter des Gesundheitswesens und Regierungsmitglieder der lateinamerikanischen Länder erstmalig in San Nicolas, Argentinien, getroffen, um Probleme der Palliativversorgung zu identifizieren und Lösungsmöglichkeiten zu finden. Als Resultat konnte man verzeichnen, das sechs Länder von Brasilien die Methode der parenteralen Hydratation übernommen haben und einige Länder das argentinische Modell zur Niedrigpreisproduktion von oralen und parenteralen Opioiden.

Obwohl es mehrere Palliativprogramme gab, verfügten im Jahr 1998 aber nur sechs der 36 öffentlichen Krankenhäuser in Buenos Aires tatsächlich über ein einsatzfähiges Palliativteam.

In Lateinamerika und in der Karibik hat die praktische Umsetzung von Palliativmedizin und -pflege in den letzten Jahren erfreulicherweise deutlich zugenommen. So genannte Bus Rounds zur Aus- und Fortbildung der Ärzte und Pflegekräfte im Bereich der Palliativmedizin und Palliativpflege werden seit mehreren Jahren nach dem Model der Universität Ed-

monton/Kanada mit großem Erfolg veranstaltet. Die Teilnehmer machen gemeinsame Hausbesuche und lernen aus der realen Situation zu Hause beim Patienten. Vorlesungen und Diskussionen finden auf den Hin- und Rückfahrten statt.

8.5.3 Südostasien

Die Herausforderungen in Bezug auf Palliativmedizin sind in dieser Region der Welt nicht anders als in anderen Entwicklungsländern: fehlende medizinische Infrastruktur, fehlende finanzielle Ressourcen und mangelnde Kenntnisse über Palliativmedizin, aufwändige bürokratische Prozeduren für die Verschreibung von Morphin sowie in weit abgelegenen Gebieten verstreute Patienten mit weit fortgeschrittenen nicht heilbaren Erkrankungen.

Das Calicut Palliative Care Programme in Kalkutta, Indien, begann 1990 mit dem Ziel, bei minimalen Kosten eine maximale Anzahl von Patienten zu erreichen. Prof. M.R. Rajagobal, Anästhesist in einem staatlichen Krankenhaus, begann mit einem weiteren Arzt (Teilzeit) und einem ehrenamtlichen Helfer mit der palliativen Versorgung schwer kranker Patienten. Im Jahr 2000 bereits war die Anzahl der Mitarbeiter der Pain and Palliative Care Clinic, Medical College, auf sechs Ärzte (Vollzeit), zwei Krankenschwestern, zwei Helfer und über 30 ehrenamtliche Helfer gestiegen [32]. 1994 wurden in der Calicut Clinic 386 Patienten und im Jahr 1999 2205 Patienten palliativmedizinisch behandelt [33].

Morphin ist verfügbar, die Verschreibung steht aber unter strengen staatlichen Vorschriften. Mehr als 60% der Patienten sind arm oder sehr arm und erhalten die Analgetika für ihre Behandlung kostenlos. Die Finanzierung des Projekts läuft über NGO; ein Teil wird vom Cancer Relief India und einer britischen Entwicklungshilfeagentur übernommen.

Um die Versorgung der in ländlichen Gebieten lebenden Patienten zu sichern, sind über 20 »Satellitenkliniken« errichtet worden, in denen wöchentlich mehr als 600 Patienten palliativmedizinisch ambulant behandelt werden [33]. Palliativ-Hausbetreuungsdienste versorgen ebenfalls eine große Anzahl Patienten. Zusätzlich werden Angehörige und Gemeindemitglieder in der häuslichen Betreuung angeleitet [32].

Das Calicut Pain and Palliative Care Center wurde von der WHO 1995 zum Modell- und Vorzeigeprojekt ernannt. Die Prinzipien der gut funktio-

nierenden praxisorientierten palliativmedizinischen Versorgung sind weltweit anerkannt und haben sich bewährt, aber die Wege, diese auch den Patienten und deren Familien zugänglich zu machen, sind sehr unterschiedlich und teilweise sogar abenteuerlich. Nirgendwo ist dies besser zu beobachten als in den Entwicklungsländern. Die Grenzen des Machbaren sind zunächst schnell erreicht. Improvisations- und Anpassungsfähigkeit sowie Ausdauer und Geduld der Ärzte und Pflegekräfte sind hier mehr als irgendwo anders gefragt.

Zusammenfassung

Der Großteil der medizinischen Ressourcen der Welt, auch für die Schmerztherapie und Symptomkontrolle, steht bis zur heutigen Zeit nur einer Minderheit von Menschen zur Verfügung. Diese Minderheit ist nicht in den Entwicklungsländern zu finden. Schmerz und andere belastende Symptome sind bis auf wenige Ausnahmen subjektiv, immer unangenehm und eine komplexe emotionale Erfahrung. Schmerz und damit eng verbundenes Leiden werden durch andere Faktoren wie soziales Umfeld, Psyche, Familie und Kultur enorm beeinflusst.

Palliativmedizinische Betreuung bedeutet aktive und umfassende Versorgung der Patienten und deren Familien. Sie muss bereits bei der Diagnosestellung einer nicht heilbaren Erkrankung ansetzen, ggf. sogar beginnen, da – wie bereits erwähnt – in den Entwicklungsländern die Diagnosestellung häufig erst in einem sehr fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung erfolgt. Bei Kindern ist die allererste Voraussetzung für eine adäquate Behandlung, dass deren Schmerz und Leid erkannt und ernst genommen werden.

Für viele Patienten mit einer fortgeschrittenen nicht heilbaren Erkrankung ist eine palliativmedizinische Versorgung die einzige realistische Therapieoption. Deshalb räumt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) der Palliativmedizin in Entwicklungsländern auch die höchste Priorität ein [34].

Um dies besser umsetzen zu können, ist eine sinnvolle Umverteilung der bisher hauptsächlich für die kurative Versorgung zur Verfügung gestellten Mittel dringend notwendig, ebenso die weitere Förderung und der Ausbau der erfolgreich laufenden medizinischen Projekte, die eine palliativmedizinische Betreuung oder Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen anbieten.

Literatur

1. National Cancer Control Programmes (2002) Policies and Managerial Guidelines, 2nd edn. WHO, pp 23
2. Doyle D, Hanks G, MacDonald N (1998) Introduction. Oxford Textbook of Palliative Medicine, 2nd edn. Oxford Univ Press, Oxford, New York, pp 3–8
3. Klaschik E (2000) Entwicklung und Stand der Palliativmedizin in Europa. Palliativmedizin. Springer, Berlin, Heidelberg, New York, Tokio, S 4–5.
4. Higginson IJ, Astin P, Dolan S (1998) Where do cancer patients die? Ten year trends in the place of death of cancer patients in England. Palliat Med Sep 12 (5): 353–363
5. Brenneis C, Bruera E (2001) Models for the delivery of palliative care: The Canadian model. In: Bruera E, Portenoy RK (eds) Topics in palliative care, vol 5; Oxford University Press, New York, pp 3–23
6. Centeno C, Gomez-Sancho M (2001) Models for the delivery of palliative care. The Spanish model. In: Bruera E, Portenoy RK (eds) Topics in palliative care, vol 5; Oxford University Press, New York, pp 25–28
7. Klaschik E (2000) Entwicklung und Stand der Palliativmedizin in Europa, Spanien. In: Husebø S, Klaschik E. Palliativmedizin. 2. Auflage, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, Tokio, S 14–16
8. Klaschik E (2000) Entwicklung und Stand der Palliativmedizin in Europa, Deutschland. In: Husebø S, Klaschik E. Palliativmedizin. 2. Auflage, Springer, Berlin Heidelberg, New York, Tokio, S 6–8
9. Wenk R, Bertolino M. Models for the Delivery of Palliative Care in Developing Countries: The Argentine Model. In: Bruera E, Portenoy RK (eds) Topics in palliative care, vol 5; Oxford University Press, New York, pp 39–51
10. Bruera E, Sweeny C (2002) Palliative care models: International perspective. J Palliat Med 5 (2): 319–343
11. Stjernswärd J, Pampallona S (1998) Palliative medicine – a global perspective. In: Doyle D, Hanks GWC, MacDonald N (eds) Oxford Textbook of Palliative Medicine, 2nd edn. Oxford Univ Press, Oxford, New York, Tokyo, pp 7–1245
12. Bootsma E (1999) Aids Treatment »a human right«. South African correspondent. The 13th International Aids Conference, Durban, South Africa
13. Clemens KE (2000) Das globale Wiederaufleben der Tuberkulose. Ursachenforschung und Bekämpfungsmöglichkeiten am Beispiel der Situation in Namibia. Inaugural-Dissertation, Univ Freiburg
14. Stjernswärd J, Bruera E, Joranson D, Allende S, Montejo G, Quesada Tristan L, Castillo G, Schoeller T, Rico Pazos MA, Wenk R (1994) Opioid availability in Latin America: The Declaration of Florianopolis. J Palliat Care 10 (4): 11–14
15. DeLima L, Bruera E, Joranson D et al. (1997) Opioid availability in Latin America: The Santo Domingo Report, Progress since the Declaration of Florianopolis. J Pain Symptom Manage 13: 213–219
16. World Health Organization. Report on infectious diseases. Retrieved from the internet in URL http:/www.who.int/infectious-disease-report/index.html.
17. DFG-Research-Project (2001) The social Impact of Aids in Southern Africa (Botswana, Namibia). http://www.uni-giessen.de/palaver/projekt/Aids.htm; downloaded 18.11.2001

18. Study of prime causes of death in HIV-positive patients (1996) »TB-groups at risk«. WHO-Report on the Tuberculosis Epidemic, WHO
19. Ramsay S (2001) Raising the profile of palliative care for Africa. Lancet 358 (Sept): 734
20. UNAIDS-Jahresbericht (2001) www.unaids.org/epidemic_update/report_deco1/index.html
21. DeLima L (2001) Advances in palliative care in Latin America and the Caribbean: Ongoing projects of the Pan American Health Organization (PAHO). J Pallia Med 4 (2): 228–231
22. World Health Organization (1995) National Cancer Control Programmes: Policies and Managerial Guidelines. Geneva: World Health Organization
23. De Lima L, Sweeny C, Palmer I, Bruera E (2004) Potent analgesics are more expensive for patients in developing countries: A comparative study. Health Policy. J Pain Palliat Care Pharmacother 18(1): 59–70
24. McNeil Jr. DG (2000) Prices for medicine are exorbitant in Africa, study says. New York Times, June 17: sect A: 6 col 3
25. Aranda S (1999) Global perspectives on palliative care. Cancer Nursing 22 (1): 33–39
26. Clemens KE (12/2001) IAHPC Homepage: www.hospicecare.org
27. Taboada P, Bruera E (2001) Ethical decision-making on communication in palliative cancer care: a personalist approach. Support Care Cancer 9: 335–343
28. WHO (2002) National Cancer Control Programmes, Policies and Managerial Guidelines, 2nd edn., WHO, Geneva pp 17–22
29. Merriman A (2002) Hospice Africa To Help Hospice Initiation in Africa. Hospice Uganda: The Model Hospice for Hospice Africa, pp 1–8
30. Merriman A (2002) Some Facts about Hospice Uganda; information material
31. Merriman A (1997) Teaching palliative medicine in Sub-Saharan Africa: a challenge in Uganda, downloaded from the Internet 7/4/02 at http://www.whocancerpain.wisc.edu/eng/10_3/uganda.html
32. Rajagopal MR, Sureshkumar K (1997) Organisation of a palliative care service. The Calicut experience. Indian J Palliat Care 3: 15–19
33. Burn G (2001) A personal initiative to improve palliative care in India: 10 years on. Palliat Med 15: 159–162
34. Stjernswärd J, Teoh N (1990) Palliative care – WHO priority. Palliat Med 4: 71–72
35. UNAIDS (2002) UNAIDS Press Release 10.07.02: Joint Report Details Escalating Global Orphans Crisis Due to Aids; 1–4/Appendix I: Statistical tables
36. WHO (1998) Cancer pain relief and palliative care in children. WHO, Geneva, pp 1–3
37. Kofi Annan (2002) The »good« and the »bad« of children's experiences, the HIV/Aids pandemic. Extracts. Communicating Globally III/No. 33, pp 9–12
38. DeLima L et al. Comparing opioid prices in 12 countries: a descriptive study (submitted)
39. Harding R, Higginson IJ. Palliative care in Sub-Saharan Africa: an appraisal 2004
40. Clemens KE, Klaschik E (2004) Palliative care delivery in southern Africa. Eur J Palliat Care 11 (4): 164–166
41. Clemens KE (2004) Tuberculosis. In: Bruera E, DeLima L, Wenk R, Farr W (eds): Palliative Care in the Developing World. Principles and Practice. IAHPC. IAHPC Press, Houston, USA; pp 187–205

9 Die Rolle des Arztes

S. Husebø

9.1 Wenn Ärzte an ihre Grenzen stoßen

An der täglichen Morgenbesprechung in der Anästhesie- und Intensivabteilung nehmen alle Ärzte teil. Es wird über Patienten gesprochen und Situationen, die in den letzten 24 Stunden außergewöhnlich waren oder von der Routine abwichen, werden analysiert.

Beispiel aus der Praxis

Die Oberärztin, die für den Dienst am Abend und in der Nacht die Verantwortung getragen hatte, gab ihren Bericht. Sie erzählte dabei, dass ein 6-jähriges Kind nach einem Verkehrsunfall schwer verletzt in der Nacht aufgenommen worden sei.

Trotz massiven Therapieeinsatzes nach der Aufnahme starb das Kind nach vier Stunden. Zu diesen und anderen Teilen ihres Berichtes hatten einige Kollegen eine Frage oder einen Kommentar. Die Besprechung dauerte insgesamt wie gewöhnlich etwa 15 Minuten. Als die Ärztin fertig war, war es selbstverständlich, der Kollegin folgende Frage zu stellen: »Und wie war es für dich, als das Kind starb?«

Die junge, aber erfahrene Oberärztin zeigte eine Reaktion, die zwar gut verständlich war, die aber alle Anwesende zutiefst betroffen machte. Sie schluckte einige Sekunden. Dann konnte sie die Gefühle und den Schmerz nicht mehr verbergen und brach in Tränen aus. Es fiel uns an diesem Morgen schwer, die Sitzung zu beenden.

Eine Stunde später saß sie allein bei mir.

»Ich war fertig und erschöpft«, sagte sie. »Die Eltern waren angekommen, ich hatte kurz mit ihnen gesprochen. Für kurze Zeit war es möglich, den

Kreislauf des Kindes zu stabilisieren. Dann kam es zu einer dramatischen Verschlechterung, die nicht mehr therapiert werden konnte. Ich musste zu den Eltern gehen und sagen, das Kind sei tot. Meine Tochter ist im gleichen Alter. Sie sagten nichts, nichts.

Und ich? Die ganze Zeit denke ich: Was habe ich falsch gemacht? Warum passiert es gerade mir?

Heute morgen war es nicht leicht für mich, den Ablauf zu beschreiben, und es wurde nicht besser durch die Fragen und Kommentare der Kollegen. Als du dann gefragt hast, wie es mir geht, konnte ich die Fassung nicht mehr wahren. Ich denke: Ich möchte nie wieder Dienst machen. Ich suche mir einen anderen Beruf…

Wir halten uns selbst für stark und nicht hilfsbedürftig. Wir werden nicht krank, wir bekommen kein Burnout, wir fallen nicht auf die Schnauze. Es ist schwer für uns zu erkennen, dass wir in Problemen stecken, und noch schwerer, dieses vor uns selbst zuzugeben.«

Ein besonderer und seltener Fall? Eine außergewöhnliche Geschichte, die nicht häufig vorkommt? Gespräche zu diesem Thema mit vielen Kollegen haben mich vom Gegenteil überzeugt.

Ein Freund und Kollege, gynäkologischer Oberarzt, nahm sich unter tragischen Umständen das Leben. Der Kollege war anerkannt und gewissenhaft in seinem Arbeitsalltag. Seine Kollegen berichteten, dass er sich in den letzten Monaten wiederholt Vorwürfe machte, unter anderem deshalb, weil ein Kind bei einer spät gestellten Indikation zur Sectio gestorben war.

Was kostet es uns, Patienten beizustehen, wenn ihr Leben nicht mehr zu retten ist? Wie kommen wir mit dem Gedanken zurecht, dass wir eine Diagnose vielleicht früher hätten erkennen müssen oder früher eine suffiziente Therapie hätten durchführen können? Wie ist das Verhalten der Kollegen bei solchen Problemen?

Dies ist keineswegs ein isoliertes Problem, das sich nur bei der Behandlung schwer kranker Patienten ergibt. Zwischen Arzt und Patient entstehen immer Gefühle, Bindungen, Freude und Trauer. Der Arzt trauert um seinen unheilbar kranken oder gestorbenen Patienten. Der Arzt leidet, wenn die Behandlung keinen Erfolg hat. Nicht selten werden wir von Emotionen überwältigt, weil das Schicksal des Patienten für uns eine Niederlage bedeutet. Gleichzeitig wird von uns erwartet:

- Wir dürfen keine Fehler machen.
- Eigene gefühlsmäßige Reaktionen sind zu verbergen.
- Wir halten es für unsere Pflicht, in allen Situationen den Überblick zu bewahren und eine Lösung bereit zu haben.

Sind wir uns darüber im Klaren, wie viel uns das kostet? Sprechen wir darüber?

9.2 Der ärztliche Alltag

Zum Beruf des Arztes gehört es, wie zu anderen Berufen auch, dass der Tagesablauf nicht immer vorhersehbar ist. Manchmal sind es Kleinigkeiten: Die Arbeitszeit dauert oft länger als geplant. Eine Mittagspause gibt es wegen der Arbeitsbelastung nicht. Schon auf diesem Gebiet gibt es Besonderheiten, die sich von den meisten anderen Berufen unterscheiden.

Dabei haben Ärzte zusätzliche berufsspezifische Belastungen. Nach sieben und mehr Jahren Berufsausbildung werden wir über viele Jahre verpflichtet, regelmäßig Dienste zu leisten: abends, in der Nacht und an Wochenenden. Unsere Arbeitstage sind oft länger als geplant, meist ohne eine entsprechende Vergütung. Die Anzahl der Überstunden kann in einer Woche 20, 30, 40 oder mehr betragen. Für viele ist es eine Ausnahmesituation zu wissen, wann sie abends nach Hause kommen. Wir müssen uns lebenslang weiterbilden und an Unterricht und Fortbildung teilnehmen.

Unsere Auftraggeber sind Patienten, Menschen, die häufig mit ihrer Gesundheit und mit ihrem Leben nicht zurechtkommen. Von uns wird Verständnis, Behandlung und Heilung erwartet, Erwartungen, die häufig nicht erfüllt werden können. In den letzten Jahrzehnten haben wir Ärzte selbst dazu beigetragen, dass Patienten mit unrealistischen Vorstellungen und Hoffnungen über die Möglichkeiten unserer Heilkunst zu uns kommen. Menschliche Enttäuschungen und Tragödien gehören zu unserem Alltag.

Im Gegensatz zu einer Autowerkstatt werden die Diagnose und die Therapie dadurch erschwert, dass wir keine Maschinen vor uns haben, sondern Menschen. Wenn wir keinen Erfolg haben oder Fehler begehen, ist die Folge eine menschliche Tragödie. Nicht selten werden wir für das Übersehen einer Diagnose oder das Versagen einer Therapie verantwortlich gemacht. Häufiger machen wir uns aus diesen Anlässen selbst Vorwürfe.

Von vornherein sind wir eine besonders belastete Berufsgruppe. Wir »nehmen unsere Patienten mit nach Hause«. Gedanken und Reaktionen als Folge dieser Menschenschicksale aus unserer Berufspraxis werden zu einem Teil unseres Privatlebens. Einige von uns finden Verständnis und Trost in der Familie. Andere schweigen, weil es schwerfällt, darüber zu sprechen, oder weil sie die Familie nicht belasten wollen.

Häufig müssen wir und unsere nächsten Angehörigen einen Preis dafür zahlen:

> Ärzte, die in Bezug auf ihren beruflichen Stress vorwiegend auf die Unterstützung und das Verständnis der eigenen Familie bauen, werden nicht selten herausfinden, dass die Familie sich von dieser Belastung abwendet, gerade wenn sie am meisten benötigt wird. Dies kann den Arzt vereinsamen lassen und tragische Konsequenzen oder auch Selbstmord zur Folge haben (Sargent 1977).

Margaretha Andrae, eine schwedische Gynäkologin und Psychiaterin, hat in ihrer Habilitation prospektiv die Probleme und Reaktionen ihrer ärztlichen Kollegen untersucht (Andrae 1994). 3 Jahre begleitete sie 20 Kollegen, die alle eine größere Anzahl schwerkranker Tumorpatienten betreuten. Andrae hat selbst langjährige Erfahrung als Fachärztin für gynäkologische Onkologie.

Jeder Arzt führte regelmäßig Gespräche mit Andrae, ergänzt durch eine Reihe von Persönlichkeitstests. Von 20 Kollegen fanden 18 es schwer, mit den Patienten zu kommunizieren, besonders wenn deutlicher wurde, dass eine kurative Therapie nicht mehr möglich war. Noch schwieriger war es für sie, mit den Reaktionen der Patienten zurechtzukommen. Eine besondere Belastung war es für viele, während der Nacht- und Wochenenddienstzeit schwer kranke Patienten betreuen zu müssen, die sie vorher nicht kannten.

Die Studie zeigte, dass die Ärzte selbst das Gefühl hatten, über ausreichendes medizinisches Wissen für die Behandlung der Früh- und Spätstadien einer Krankheit zu verfügen. Große Probleme wurden erlebt, wenn die Therapie nicht den erwarteten Erfolg hatte. Fast sämtliche (17) Kollegen empfanden es als eine große Belastung, wenn der Patient selbst das Versagen der Therapie und das Fortschreiten der Krankheit nicht akzeptieren konnte. Diese Ärzte gaben an, sie würden die Therapie fortsetzen, obwohl sie wüss-

ten, dass es dafür keine Indikation gäbe. Einige gaben offen zu, dadurch ihre eigenen Ängste zu therapieren. Die Hälfte der Ärzte fanden sogar Zeiten der Remission belastend, weil sie den Optimismus mit den Patienten teilen mussten, obwohl sie aus Erfahrung wussten, dass diese Phase der scheinbaren Besserung nur von kurzer Dauer sein würde.

Obwohl organisatorische Mängel im klinischen Alltag die Belastungen verstärkten (zu viele Patienten, zu wenig Zeit, fehlende Kollegialität), standen für die Ärzte Probleme mit den eigenen Reaktionen im Vordergrund. Die 20 Ärzte zeigten unterschiedliche Verhaltensweisen, um mit der beruflichen Belastung und den Konflikten überleben zu können. Einige (8) mieden den Kontakt zu den Patienten oder verdrängten das Fortschreiten der Erkrankung. Es war nicht überraschend, dass alle Ärzte der Meinung waren, sie müssten immer eine kompetente Lösung für die Probleme und Konflikte des Patienten anbieten können.

9.3 Der hilflose Helfer

Es gibt nur wenige Publikationen zu diesen Themenkomplex. Extrem selten ist er Gegenstand von Fachtagungen oder Fachgesprächen. Wer kennt einen Klinikchef, der diese Themen regelmäßig und verständnisvoll im klinischen Alltag angesprochen hat? Es gibt so gut wie keinen Arbeitgeber im Gesundheitswesen, der eine Strategie zur Vorbeugung des Verschleißes der menschlichen Reserven in solchen Situationen durchgesetzt hat.

Eine Ausnahme stellt der englische Arzt Glin Bennet dar. Früher war er erfolgreicher Neurochirurg. Dann wechselte er aus persönlichen Gründen zur Psychiatrie. Er ist Verfasser zahlreicher Publikationen zu diesen Themen. In seinem Buch *Der Arzt und die Wunde* (*The Wound and the Doctor,* Bennet 1987) beschreibt er das Leben, Leiden und Sterben der Ärzte. Bennets Hauptbotschaft an uns ist, dass unsere persönliche Verwundbarkeit zu großem Leiden als Arzt beitragen kann.

Viele entwickeln einen besonderen Lebensstil, um sich zu schützen und mit diesen Belastungen fertig zu werden. Im typischen Arzt-Patient-Gespräch sitzt der Arzt hinter einem großen Schreibtisch, umgeben von Dokumenten und Röntgenbildern, oder er steht mit Kollegen und Schwestern oberhalb des im Bett liegenden Patienten. Dabei setzt der Arzt eine soziale Barriere zwischen sich und den Patienten.

> Der medizinische Beruf verleiht Macht. Auch der einzelne Arzt übt Macht aus; vor seinen Patienten tritt er in einer Weise auf, die es ihm ermöglicht, Macht zu entfalten und eigene Ängste zu verbergen. Es ist den Ärzten dabei weitgehend nicht bewusst, wie sie ihre Herrschaft über diejenigen ausüben, die sie gerufen haben, ihnen zu helfen (Bennet 1987).

McCue (1982) beschreibt, wie Arzt und Patient gemeinsame Interessen verfolgen, um sich vor den Unsicherheiten, der Vielfalt, den Begrenzungen der therapeutischen Möglichkeiten und den daraus resultierenden Tragödien zu schützen. Eine Myriade von Labortests und diagnostischen Maßnahmen werden zum Schutz gegen Angst und Unsicherheit angeordnet. Sinnlose Therapieversuche werden durchgeführt, um unangenehme Fragen und Gespräche zu umgehen (Søderstrøm 1990).

McCue beschreibt auch, wie der Arzt seine Sprache und seine Barrieren entwickelt:

> Ärzte umgeben sich mit einer zynischen und gefühllosen Sprache, die für den Patienten unverständlich ist und dazu dient, sich selbst vor den eigenen Reaktionen und Gefühlen zu schützen. Der Prozess des Sichzurückziehens beginnt im Medizinstudium und weitet sich schließlich so weit aus, dass alle Situationen, die mit den Beruf nicht im Zusammenhang stehen, vermieden werden.

Eine typische Schutzreaktion des Arztes ist, sich gefühlsmäßig zurückzuziehen. Eine seelische Verarmung kann die Folge sein (Seravelli 1989). Angst vor Fehlern und davor, von Kollegen kritisiert zu werden, veranlasst viele Ärzte, viel Zeit am Arbeitsplatz zu verbringen und nicht nach Hause zu gehen.

Der britische Psychiater Peter Maguire, der über viele Jahre Unterrichtsprogramme zur Kommunikation für Kollegen, die in der Palliativmedizin tätig sind, durchgeführt hat, beschreibt, welche Technik die Ärzte verwenden, um zu verhindern, dass sie vom psychischen Unbehagen ihrer Patienten belastet werden (Maguire 1989). Typische Verhaltensweisen, so Maguire, sind gefälschte positive Botschaften und eine Gesprächsführung, die Themen vermeidet, die zu Angst und Unsicherheit führen können. Weitere Studien zu den Themen Schuld, Versagen, Trauer, Leugnen (Fain et al. 1989)

und zu Impotenz, Frust, Isolation und niedrigem Selbstwertgefühl (Gorlin et al. 1983) bestätigen diese Aussagen.

Eine Aufstellung von zuverlässigen Daten über die seelische Verfassung des Arztes ist problematisch (Tishelman 1993). Die wenigen Publikationen bestätigen jedoch, dass wir einen außergewöhnlichen Beruf haben. Murray (1977) zeigte in einer Studie, dass Ärzte in Schottland häufig psychiatrische Behandlung aufsuchen. Ärzte wurden wegen Psychosen 1,8mal, Neurosen 3,1mal, Alkoholismus 3,3mal, Medikamentabhängigkeit 10,8mal häufiger behandelt als andere in einer vergleichbaren Kontrollgruppe.

Ein ähnliches Bild zeigt eine prospektive amerikanische Studie (Vaillant et al. 1972): 268 Studenten wurden über einen längeren Zeitraum begleitet. 25 Jahre nach der ersten Befragung ergab der Vergleich zwischen Ärzten und anderen Akademikern die in ◘ Tab. 9.1 aufgeführten Daten.

Interessant ist, dass die große Mehrheit der Ärzte ihre Gesundheit als »besser« beurteilt, obwohl sie mehr Probleme als die anderen Akademiker hat.

Der deutsche Psychologe und Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer hat in einer Reihe von Publikationen die Probleme der Helferberufe dargestellt. Er beschreibt, wie das Berufsleben der Ärzte von Omnipotenz und Sich-verantwortlich-Fühlen geprägt wird. Die Folgen sind umfassend: Sich entziehen, Angst vor Nähe, Angst vor Schwäche, Angst vor Mitgefühl, Angst vor Liebe, hoher Alkoholkonsum und Suizid (Schmidbauer 1994, 1995). Schmidbauer gibt eine grundlegende Analyse, beleuchtet durch viele Fallbeispiele die Ursachen und Hintergründe des »Helfersyndroms« und zeigt, wie wir damit zurechtkommen können.

Alle diese Wissenschaftler sind der Überzeugung, dass die beschriebenen Verhaltensformen wohletablierte Überlebensstrategien der Ärzte darstel-

◘ **Tab. 9.1.** Langzeitkontrollergebnisse des Vergleichs von Ärzten und anderen Akademikern (in %)

	Ärzte	Kontrolle
Gesundheit	besser	schlechter
Schlechte Ehe/Scheidung	47	32
Alkohol/Medikamente	36	22
Beim Psychiater	34	19

len. Wenn die Ärzte vor beruflichem Stress, vor Wunden und Niederlagen stehen, werden kompensatorische Schutzmechanismen aktiviert. Das kann bewusst oder unbewusst sein. Diese Mechanismen werden entsprechend der Persönlichkeit des Arztes geprägt und von der beruflichen Ausbildung und den Strukturen am Arbeitsplatz verstärkt. Wichtiger ist, dass sie folgenschwere Konsequenzen für den Arzt, seine Patienten und seine Familie haben. Dies können sein: Reizbarkeit, Müdigkeit, Erschöpfung, Schlaflosigkeit, Unzufriedenheit oder das Gefühl, nicht zu genügen (Whippen 1991; Stedeford 1994).

Noch verhängnisvoller sind in solchen Fällen oft die seelischen und psychischen Belastungen in der näheren Umgebung des Arztes. Wie viele zerstörte eheliche Beziehungen und wie viele gestörte Eltern-Kinder-Beziehungen sind nicht auf solche Mechanismen zurückzuführen (Jacyk 1989)? Nicht selten wird die Gesundheit geschädigt. Wenn die gesundheitlichen Schäden entdeckt werden, werden sie meist nicht im Zusammenhang mit der eigentlichen Ursache gesehen. Es ist häufig sehr spät für entsprechende Gegenmaßnahmen oder Therapien. Eine entsprechende berufliche oder therapeutische Maßnahme, wie eine längere Krankmeldung oder eine Pause innerhalb oder außerhalb des Berufes, kann die Gesundheit des Arztes fördern. Der legendäre kanadische Pulmologe Sir William Osler äußerte sich diesbezüglich: »Es ist manchmal gesund, krank zu sein« (Osler 1904).

9.4 Quantität oder Qualität – das falsche Konzept?

Im Alltagsleben sprechen wir von »guter« Qualität und »schlechter« Qualität. Im allgemeinen meinen wir dabei oft den Zustand des Hemdes, des Autos, des Urlaubs, des Essens, der Schulzeugnisse der Kinder oder wie wir mit dem Ehegatten zufrieden sind. Wir wollen zunehmend »qualitätsbewusst« sein. Geld spielt eine wesentliche Rolle dabei. Auch in der Entwicklung der medizinischen Behandlung wird immer deutlicher, dass eine bessere Versorgung mit steigenden Kosten verbunden ist. Das zeigt sich etwa bei den Kosten für eine moderne Krebsbehandlung oder für eine Behandlung auf einer Intensivstation.

Aber hängt Qualität nur vom Geld ab? Das Wort Lebensqualität setzt sich zusammen aus »Leben« und »Qualität«. Ist Qualität in unserem Leben allein abhängig von materiellen Werten? Bedeutet nicht unser Wohlergehen, das

Wohlergehen unserer Kinder oder Lebenspartner, von nahen Freunden oder Verwandten vielmehr, dass sie sich zurechtfinden im Leben, in der Schule, in Ausbildung und Beruf, dass ihre Gesundheit und ihre Beziehungen in Ordnung sind? Ändern sich nicht unsere Qualitätskriterien, sobald wir in eine Lebenskrise geraten?

In den letzten Jahren hat der Begriff »Lebensqualität« einen immer größeren Raum eingenommen. In den Medien wie in den Reden der Politiker wird er häufig erwähnt. Immer öfter finden wir »Lebensqualität« auch als Thema in der medizinischen Literatur. In der Palliativmedizin hat der Begriff einen besonderen Stellenwert (Clinch u. Schipper 1994).

Fragen, die früher kaum berücksichtigt wurden, gewinnen jetzt an Bedeutung:

- Welche Folgen hat die Behandlung für den Patienten?
- Und für den Angehörigen?
- Wie geht es dem Patienten im Alltag?
- Welche Gedanken, welche Gefühle hat er?
- Was bedeutet »Lebensqualität« für ihn?

Publikationen beschreiben, was Lebensqualität ist und wie sie statistisch erfasst werden kann. Fragebögen ermitteln das subjektive Wohlergehen der Patienten und alles, was eine Belastung ist oder werden kann. Fragebogenstandards wurden für verschiedene Kulturen und Sprachen erstellt. Dabei geht es um so unterschiedliche und schwierig zu beschreibende Begriffe wie Schmerz, Übelkeit, Appetit, Schlaf, Aktivität, Angst, Freude, Glück, Depression, Trauer, Glaube, Hoffnung oder Liebe.

Wenn wir über die Qualität der medizinischen Behandlung sprechen, wollen wir genaue Definitionen und Beschreibungen. In der Schulmedizin gilt eine Behandlung als gut, wenn ihre Wirkung »wissenschaftlich geprüft« ist. Die Patienten sehen Behandlungsqualität oft anders. Für sie ist eine Behandlung gut, die zu einer Abnahme des subjektiven Krankheitsgefühls führt.

Zahlreiche, recht widersprüchliche Definitionen von Gesundheit zeigen uns noch deutlicher, wie schwierig es ist, im Bereich der Medizin mit dem Begriff der Qualität umzugehen. Wir müssen uns aber grundsätzlich fragen, wie wir jemals erwarten können, Klarheit über die Lebensqualität schwerkranker Patienten zu gewinnen, wenn die grundlegenden Begriffe von Krankheit, Gesundheit und Therapieerfolg noch ungeklärt sind?

Eine schnelle Einigung kann darüber erreicht werden, dass Qualität etwas Subjektives ist. Allein diese Tatsache führt dazu, dass viele Kollegen das Interesse verlieren. Nicht wenige Mediziner leben in dem festen Glauben, nur was dokumentiert und statistisch erfassbar sei, nur dieses sog. »objektive Wissen« sei richtungsweisend und gültig für die Behandlung von Patienten und Krankheiten. Hier soll nur festgehalten werden, dass diese Einstellung falsch ist und dass nur ein kleiner Teil von dem, was in der Schulmedizin praktiziert wird, »objektiv« zu beweisen ist.

Unser Ziel darf es nicht sein, nur Tumore, Infektionen, Sehstörungen und Immunschwächen zu behandeln. Wir behandeln Menschen, die unsere Hilfe wegen ihrer Tumore, Infektionen, Sehstörungen und Immunschwächen suchen. Diese Menschen haben alle eine sehr persönliche Biographie. Sie haben *alle* sehr unterschiedliche Gedanken, Gefühle, Wünsche, Wahrnehmungen, Ängste, Glauben oder Vorstellungen, und sie wollen auch bei »kritischer« oder »aussichtsloser« medizinischer Prognose noch etwas entwickeln, unternehmen oder erledigen. Wenn unsere Patienten ernsthaft erkranken und vor dem Lebensende stehen, gewinnen diese »subjektiven« Qualitäten an Bedeutung. Es wird für viele deutlich, dass sie zum zentralen Lebensinhalt gehören. Zusätzlich rückt für sehr viele die Frage nach dem Sinn des Lebens in den Mittelpunkt.

Die wesentlichen Inhalte der Palliativmedizin wurden in ▶ Kap. 1 beschrieben. Die Bestandteile – Symptomkontrolle, psychische, soziale und seelische Betreuung, Kommunikation und Ethik, Akzeptanz des Todes – sind eine eindeutige Absage an den Irrglauben, dass Medizin nur Naturwissenschaft ist und dass Probleme in der Betreuung sterbender Menschen nur mit den Methoden der Naturwissenschaft gelöst werden können.

Diese Frage – »Was bedeutet Leben und was bedeutet Qualität?« – hat nicht nur weit reichende Konsequenzen für das Konzept der Palliativmedizin. Hohe Kosten entstehen für Patienten und Gesellschaft, wenn das, was der Patient braucht, um seine Integrität zu bewahren und mit maximaler Gesundheit leben zu können, weit entfernt ist von dem, was wir glauben behandeln zu müssen oder behandeln können. Diese Kosten bedeuten auch eine große Belastung des Arztes, besonders wenn die Krankheitsentwicklung einen negativen Verlauf nimmt und wenn die Gefühle und Reaktionen der Patienten sich gegen den notorisch »optimistischen« Arzt wenden.

Patienten und Angehörige werden immer individuell auf eine Erkrankung reagieren. Manche können in schweren Lebenskrisen mit Verstand zu

innerer Ruhe finden. Andere werden ein unerschöpfliches Repertoire von Schutzmechanismen entwickeln. Zwischen diesen beiden Extremen befinden sich die meisten, mal im Chaos, mal in Gelassenheit.

So ist es auch mit den Ärzten. Wir werden in manchen Patientensituationen menschliche und fachliche Reaktionen zeigen, die den Patienten und ihren Angehörigen ermöglichen, ihre besten Eigenschaften und Möglichkeiten zu entdecken. In anderen Situationen können wir durch gelernte oder unbedachte Reaktionsmuster die Krankheits- und Lebenskrise verschärfen.

Zur ärztlichen Kompetenz gehört nicht nur, eine Diagnose zu stellen und eine adäquate Behandlung einzuleiten. Eine genauso grundlegende Kompetenz ist das Wissen, wann eine weitere Diagnostik und Therapie nicht mehr angebracht ist und wie darüber kommuniziert werden kann. Umgekehrt haben Ärzte, die nicht Augen und Ohren und kommunikative Fähigkeiten haben, auch keinen Sinn für Qualität. Sie können auch bei Diagnose und Therapie Fehler machen. In Zukunft muss ein Teil unserer beruflichen Kompetenz darin liegen, dass wir im Studium und Berufsleben einen besseren Einblick in die eigenen menschlichen Reaktionen in für uns schwierigen Situationen gewinnen.

Ein schwerkranker Tumorpatient erzählte, dass sein Chirurg seit der letzten Operation nur sehr selten zu ihm zur Visite kommt. Er drückte es so aus:

> Ich verstehe, dass er nicht in der Lage war, den Tumor zu entfernen. Er ist auch nur ein Mensch. Ich habe auch Verständnis dafür, dass er es als eine Niederlage empfindet und dass es ihm schwerfällt, zu mir hineinzukommen. Aber ich brauche ihn jetzt mehr als zuvor.

Wie in vielen Untersuchungen bestätigt (Andrae 1994; McCue 1982; Bennet 1987), gehört es zum strategischen Verhalten der Ärzte, dass sie »immer glauben, eine Lösung bereit zu haben«. Wir übersehen, dass wir uns auf Lösungen der Probleme konzentrieren, die für uns im Mittelpunkt stehen. Der Patient hat sich durch seinen Reifungsprozess zu einer anderen Lösung durchgekämpft.

Obwohl wir uns für Qualität interessieren, ist unser Verständnis und Wissen dafür noch begrenzt. Die negativen Qualitäten wie Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Schlaflosigkeit, Angst, Depression, Verlust von Integrität

usw. haben bisher im Mittelpunkt vieler Studien über Lebensqualität gestanden. Solange der Patient z. B. mit unerträglichen Schmerzen lebt, ist selbstverständlich die Behandlung dieses Symptoms unsere zentrale Aufgabe.

Wenn diese Belastungen gelindert sind, treten andere Perspektiven von Qualität in den Vordergrund. Die positiven Aspekte von Leben und Qualität haben weit reichende Inhalte. Ohne eine Geschichte, Vergangenheit und Zukunft, ohne Biographie und Erfahrungen, ohne soziale Beziehungen, ohne Liebe und Nähe ist es für die meisten undenkbar zu leben. Die Begriffe Hoffnung, Biographie, Vergangenheit, Zukunft, Nähe, Distanz, Gefühle, Liebe, Glaube, Autonomie, Integrität und Lebenssinn werden sehr selten oder nicht in der medizinischen Fachliteratur beschrieben oder angesprochen.

Diese »Qualitäten« bringen uns an die Grenze dessen, was empirisch erfassbar ist. Mit unseren traditionellen naturwissenschaftlichen Methoden erfahren wir nicht, welche Biographie der Patient hat oder welche Zukunft, welche Hoffnung vorhanden ist oder was noch erreicht werden kann. Hierbei ist die Intuition gefragt, die Empfindsamkeit des Augenblicks und die Erfahrung des sensiblen Auges und Ohres. Der Arzt als Künstler ist gefragt (Husebø 1992).

Lebensqualität, »negativ« gesehen

- Schmerz
- Durst/Hunger
- Immobilität
- Inkontinenz
- Übelkeit
- Schlaflosigkeit
- Angst
- Depression
- Isolation
- Integritätsverlust
- Atemnot
- Verwirrtheit
- Unruhe

Lebensqualität, »positiv« gesehen

- Gesundheit
- Gedanken
- Humor
- Heute
- Bett
- Biographie
- Arbeit
- Kinder
- Freunde
- Musik
- Literatur
- Natur
- Stille
- Glaube
- Hoffnung
- Liebe

Qualität kann empirisch beschrieben werden, dann aber eher mit den Methoden der Soziologen, Psychologen und Anthropologen, z. B. mit der »teilnehmenden Observation«. Vorgefertigte Fragen können hier eher die Observation verhindern als unterstützen, falls sie und der Kontext, in dem sie vermittelt werden, nicht sehr gründlich durchdacht sind.

Besonders auf dem Gebiet der Palliativmedizin wird deutlich, wie wichtig die Frage nach Lebensqualität ist. Diese Frage kann aber nicht beantwortet werden, ohne den Patienten und sein Umfeld besser kennen zu lernen (Stedeford 1994). Eine weitere Voraussetzung ist, dass wir erkennen und verstehen, welche Qualitäten für den einzelnen Patienten wichtig sind.

Es gibt wohl kaum ein Gebiet, wo wir so viel über Qualität lernen können wie bei Künstlern: in der Literatur oder der Philosophie, bei den Malern, Musikern oder Schauspielern. Eine schöne Beschreibung über diese Voraussetzungen finden wir bei dem russischen Arzt und Literaten Anton Tschechow:

Das ist die gemeinste Faulheit: die des Denkens.
Ich bin kein Liberaler, kein Konservativer, kein Reformanhänger, kein Mönch, kein Indifferenter. Ich möchte ein freier Künstler sein und nichts weiter, und ich bedauere nur, dass Gott mir nicht die Kraft gegeben hat, einer zu sein. Ich hasse Lüge und Gewalt in all ihren Erscheinungsformen, und Konsiliarsekretäre sind mir gleichermaßen zuwider wie N. und G. Pharisäertum, Stumpfsinn und Willkür herrschen nicht allein in Kaufmannshäusern und Gefängnissen; ich sehe sie in der Wissenschaft, in der Literatur, unter der Jugend… Darum hege ich gleichermaßen geringe Vorliebe für Gendarmen, für Fleischer, für Gelehrte, für Schriftsteller, für die Jugend. Firma und Etikett halte ich für ein Vorurteil. Mein Allerheiligstes sind – der menschliche Körper, Gesundheit, Geist, Talent, Begeisterung, Liebe und absolute Freiheit von Gewalt und Lüge, worin sich die beiden Letzteren auch äußern mögen. Das ist das Programm, an das ich mich halten würde, wenn ich ein großer Künstler wäre (4.10.1888).

9.5 Empathie und Menschlichkeit

Empathie kann am besten beschrieben werden als »Einfühlung«, das Gefühl, wenn »du *und* ich« sich ändert in »ich bin du«. Einige werden mit Recht dagegen einwenden, dass es niemals gelingen kann, sich ganz in eine andere Person zu verwandeln. Eine wichtige Voraussetzung bleibt aber die ständige Bereitschaft, sich so gut wie möglich in die Lage des anderen zu versetzen; ähnlich wie: »Ich könnte mich in deiner Situation befinden.« Wir sehen, fühlen, reagieren und verstehen, als wären wir in der Tat die andere Person.

Interessanterweise war es ein Deutscher, Theodor Lipps, der 1903 den Begriff »Empathie« als erster prägte. Lipps, der ein besonderes Interesse an Psychologie und Ästhetik hatte, beschrieb einen Prozess des »Hineinfühlens« in eine andere Person, wie wir uns in ein Stück Musik hineinfühlen. Er legte besonderen Wert auf die Projektion der eigenen Persönlichkeit in ein Kunstwerk eines anderen und übersetzte »Einfühlen« in einem englischsprachigen Artikel mit »Empathie« (Hunsdahl 1967).

Heute findet der Begriff »Empathie« weltweit Verwendung. Der Psychologe Katz beschreibt Empathie wie folgt:

> Wenn wir Empathie erleben, fühlen wir es, als würden wir die Gefühle eines anderen als unsere eigenen erleben. Wir sehen, fühlen, reagieren und verstehen, als wären wir in der Tat diese andere Person« (Katz 1963).

»Ist das notwendig?«, werden einige sich fragen. Die Grundlage für eine erfolgreiche Behandlung ist eine gründliche Diagnostik. Diagnostik bedeutet, differenzieren zu können zwischen Faktoren mit und ohne Bedeutung für die Erkrankung des Patienten. Die Krankengeschichte ist unsere wichtigste Informationsquelle über den Patienten. Ohne Empathie des Arztes wird wichtige Information übersehen. Und ohne Empathie wird bei der Therapie viel verloren gehen.

Was kann der Arzt durch Empathie erreichen?

- Verbessertes Verständnis für die grundlegenden und komplexen Hintergründe von Krankheit
- Erhöhte Aufmerksamkeit und gesteigertes Observationsvermögen gegenüber den physischen, sozialen und emotionalen Problemen und Stärken des Kranken
- Gefühlsmäßige Teilnahme an den Leiden des Patienten
- Voraussetzungen für eine Begleitung der Patienten auf dem Weg durch ihre Krankheit
- Persönliche Reife

Die »klinische« oder »medizinische« Empathie benötigt eine andere Voraussetzung als ursprünglich von Lipps und Katz beschrieben. Die Medizin hat – falls möglich – die Heilung des Patienten zum Ziel. Klinische Empathie bedeutet, ein besseres Verständnis dafür zu gewinnen, was der Patient fühlt und erlebt. Es ist hier mehr die Projektion des Erlebten auf einen teilnehmenden Beobachter gefragt, der dann sein Verständnis und »Einfühlungsvermögen« für die Gesundheit des Patienten einsetzt.

Die Behandlung von Patienten kann problematisch werden, wenn Empathie und Sympathie vermischt werden. Mit der Sympathie zeigen wir unsere eigenen Gefühle, indem wir die Position und Gefühle des anderen anerkennen. Unsere Sympathie kann für viele Patienten sehr wichtig sein. Auf der anderen Seite muss der Arzt wichtige Entscheidungen treffen, um die Gesundheit des Patienten zu fördern, die durch eine starke Sympathie belastet werden können (Osler 1904; Peabody 1984; Rabin et al. 1984). In diesen Situationen muss der Arzt, um die richtigen Ratschläge geben und mit dem Patienten die richtigen Entscheidungen treffen zu können, seine Sympathien und Antipathien reflektieren. Nur durch ein bewusstes Verhältnis zu den eigenen Gefühlen kann er die Interessen der Patienten folgerichtig vertreten.

Eine Voraussetzung für Empathie ist die Neugier. Der neugierige Arzt, der in der Begegnung mit Patienten freundlich ist und menschlich gut zuhören kann, besitzt die wichtigsten Voraussetzungen für Empathie. Empathie ist aber mehr. Wie wir bei Musik oder Kunst unser Erlebnis durch Erfahrung und Bildung vertiefen können, kann auch unser »Einfühlungsvermögen« geübt werden (Spiro 1993).

Auf diese Weise kann der Bogen gespannt werden zwischen »klinischer Empathie« und Empathie im ursprünglichen Sinne, wie sie von Lipps beschrieben wurde.

Die Praxis der Medizin ist eine auf wissenschaftlichen Erkenntnissen ruhende Kunst (Husebø 1992). In der Ausübung dieser Praxis können wir Ärzte viel von Kunst und Künstlern lernen.

> Es gibt nichts Sichtbares ohne Licht.
> Es gibt nichts Sichtbares ohne ein durchsichtiges Medium.
> Es gibt nichts Sichtbares ohne Form.
> Es gibt nichts Sichtbares ohne Farbe.
> Es gibt nichts Sichtbares ohne Abstand oder Entfernung.
> Es gibt nichts Sichtbares ohne Werkzeug des Sehens.
> (Nicolas Poussin, Rom, 1665)

- Poussin vermittelt in diesem Gedicht eine wesentliche Voraussetzung, um Medizin zu praktizieren. Wir müssen zuerst sehen lernen, um zu erkennen, wer unsere Hilfe sucht und wie wir dem Hilfesuchenden am besten zur Hilfe kommen können.

Die Herausforderung liegt darin, dass wir die wichtigen wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse fortwährend in eine empathische Beziehung zwischen Arzt und Patient integrieren (Holm 1991; Spiro 1992). Selbstverständlich ist es nicht ausreichend, wenn der Arzt nur tiefe Gefühle für seinen Patienten empfindet. Der Arzt muss Informationen sammeln, Hypothesen über die Krankheit und deren Ursachen aufstellen, Therapievorschläge mit dem Patienten besprechen und ununterbrochen überprüfen, ob seine Vorstellungen mit den Problemen seines Patienten und den wissenschaftlich erprobten Diagnose- und Therapieverfahren übereinstimmen. Der kranke Mensch ist dabei keine Flüssigkeit, die mit sicheren Methoden im Labor getestet werden kann. Krankheit trifft Patienten mit Gefühlen, Ängsten, Phantasien und Vorstellungen – wichtige Voraussetzungen in der schwierigen Landschaft der Therapie.

9.6 Weg aus der Misere – die Gesundheit des Arztes

Wenn Ärzte mit menschlichen Krisen konfrontiert werden, und welcher Arzt wird das nicht, werden sie sowohl fachlich wie menschlich herausgefordert. Beide Vorraussetzungen sind gefragt. Das Übersehen einer der beiden kann ausreichen, um die Krise zu vertiefen oder den Patienten Schaden zuzufügen.

Die Rolle des Arztes

- Fachliche Kompetenz
- Eigene Reaktionen und Gefühle verstehen und zulassen
- Die eigene Verwundbarkeit
- Empathie
- Die eigene Sterblichkeit

Weg aus der Misere

- Kollegialität
- Zuhause
- Das Leben
- Liebe
- Hoffnung

9.6.1 Fachliche Kompetenz

Fachliche Kompetenz ist eine wichtige Voraussetzung für die ärztliche Tätigkeit.

In der Palliativmedizin gehören zur fachlichen Kompetenz exquisite Kenntnisse in der Schmerztherapie. Darüber hinaus gehören aber Verständnis und Fachwissen auf allen Gebieten der Palliativmedizin, insbesondere in Bezug auf Ethik und Kommunikation, zu den erforderlichen fachlichen Voraussetzungen.

Medizin ist ohne fachliche Kompetenz in Bezug auf Daten und Fakten – das theoretische Wissen –, ohne fachliche Kompetenz in Bezug auf menschliche Voraussetzungen – das Verstehen – oder ohne die Fähigkeit, diese Voraussetzungen in der Praxis anzuwenden – das Können – sinnlos, kostspielig und gefährlich. Das Problem bleibt, dass die medizinische Ausbildung sich heute vorwiegend auf die Aufzählung von Daten und Fakten konzentriert, ohne gleichzeitig die ethischen, menschlichen und praktischen Voraussetzungen für eine Tätigkeit als Arzt zu vermitteln.

Zu der notwendigen fachlichen Kompetenz in der Palliativmedizin gehört insbesondere die Erkenntnis, dass der Tod ein Teil des Lebens ist, und die Vermeidung von das Sterben verlängernden Maßnahmen bei bereits sterbenden Patienten.

9.6.2 Eigene Reaktionen und Gefühle verstehen und zulassen

Viele, die über ärztliche Reaktionen und Schutzmechanismen geschrieben haben, zeigen auch, dass es möglich ist, mehr über eigene Reaktionen zu erfahren. Wenn Gefühle und Probleme identifiziert und uns deren Ursachen bekannt sind, ist es auch möglich, mit ihnen zu leben und zurechtzukommen (Gorlin et al. 1983; Bennet 1987; McCue 1982; Vachon 1987; Schmidbauer 1995; Andrae 1994).

Auch für die Patienten ist es von Vorteil, wenn Ärzte ein offenes Verhältnis und Interesse für ihren normalen Alltag entwickeln. Sie interessieren sich für Qualität und Wohlergehen. Zunehmend werden Patienten und Angehörige selbst gefragt und in den Mittelpunkt gestellt.

Es geht nicht nur um das Erkennen von Gefühlen und Reaktionen im Umgang mit schwer kranken Patienten. Die wahrscheinlich schwierigere

Aufgabe ist zu bemerken, wenn Gefühle nicht mehr da sind und ein früher vorhandenes berufliches Engagement nicht mehr existiert. Schmidbauer und andere sprechen vom Helfersyndrom. Wichtigstes Merkmal des Helfersyndroms ist das Helfen als Abwehr anderer Beziehungsformen und Gefühle.

> Aus unbewussten Motiven heraus ist für den »hilflosen Helfer« die Kontaktaufnahme mit einem bedürftigen Schützling zu einer Art Droge geworden. Dass ihn andere brauchen, wird zum Suchtmittel, auf das er nicht mehr verzichten kann. Die hohen Dosen, die sich der Helfer auf diese Weise verschaffen kann, führen zu einer Abstumpfung, die in der amerikanischen Sozialforschung als Ausbrennen (burnout) anschaulich beschrieben wird (Whippen 1991; Ullrich et al. 1990). Der »ausgebrannte« Süchtige hat keinen Lustgewinn mehr, wenn er seine Droge nimmt. Aber der Entzug ist noch unerträglicher, noch unangenehmer. Diesem Konflikt gleicht die Situation des hilflosen Helfers, der für andere dasein muss, aber gerade deswegen selbst verarmt und innerlich, hinter seiner Dienstleistungsfassade, immer bedürftiger und kümmerlicher wird (Schmidbauer 1994).

Die zitierten Untersuchungen geben uns Informationen über Leid und Leben der Patienten und Ärzte. Wir erhalten Grundlagen, die uns helfen können, Inhalt und Schwerpunkt der Behandlung, Forschung und Lehre zu ändern. Dabei wird es besonders deutlich, wie mangelhaft Grund- und Weiterbildung von Studenten und Ärzten heute sind. Wichtige Gebiete wie Schmerz- und Symptomkontrolle haben erst in den letzten Jahren einen bescheidenen Platz im Studentenunterricht bekommen. In anderen für die Patienten lebenswichtigen Gebieten, wie Kommunikation, Trauerreaktionen und Ethik, findet Unterricht nur fragmentarisch statt (Klaschik u. Husebø 1997). Und wer hat in der Ausbildung schon etwas über die beruflichen und seelischen Belastungen des Arztes erfahren? Es bleibt viel nachzuholen.

9.6.3 Die eigene Verwundbarkeit – und Empathie

Und wie sollen wir Ärzte vorgehen, um mit unserer Verwundbarkeit zurechtzukommen? Wie Bennet und andere (Andrae 1994; Gorlin et al. 1983; Kalra et al. 1987) unterstreichen, können Wunden und Niederlagen eine Herausforderung sein. Wir können sie übersehen und verdrängen, wodurch

diese traumatischen Erlebnisse die gefühlsmäßige Verarmung des Arztes verstärken können.

Wunden entstehen durch Verluste, Krisen, Konflikte oder Erlebnisse, die als Niederlagen aufgefasst werden. Auf diesen Gebieten ist der Arzt besonderen Belastungen ausgesetzt. Im beruflichen und privaten Leben können diese Erlebnisse den Arzt in einen Abgrund stürzen. Sie können aber auch eine Stärke sein. Die Wunden können auch zu Wachstum und persönlicher Reife beitragen. Bennet beschreibt, wie der Arzt sich zu seinen Wunden und Erfahrungen verhält und welche Wege beschritten werden können, um mit diesen Belastungen zurechtzukommen (Supple et al. 1992).

Hin und wieder ist es erlaubt, »Nein« zu sagen. Es gibt Strategien, wie wir mit Patienten auf eine positive Weise umgehen können, auch in Situationen, wo sie für uns »unsympathisch«, »lästig« oder »schwierig« erscheinen. Aber wir dürfen hin und wieder auch einen Patienten an einen Kollegen überweisen oder zeigen, dass wir mit dem gezeigten Verhalten nicht einverstanden sind (Liaschenko 1994).

»Mein Leiden ist mein Lehrer gewesen«, sagt Herodot. Eine lange Reihe von Künstlern und Schriftstellern, u. a. Shakespeare, Tschechow, Camus, Ibsen, Rilke, Tolstoj, Kafka, bestätigt diese Aussage. Empirische Empathie, wie eine schmerzvolle Erfahrung zu einer persönlichen Reife führen kann, ist in der Weltliteratur kaum eindrucksvoller geschildert worden als in *König Lear*. Der König verliert unter dramatischen Umständen alles. Er ist aber klüger geworden und wird in die Lage versetzt, früher nicht vorhandene Menschlichkeit und Gefühle zu zeigen. Die Kosten für ihn sind dabei so überwältigend, dass er sein Reich, seine Familie, seinen Verstand und sein Leben verliert.

In *Abteilung 6* stellt Tschechow Dr. Ragin vor. Für Dr. Ragin existieren Schmerzen nur in der Phantasie, die Schmerzen seiner Patienten sind eine lästige Bürde, wofür die Patienten selbst die Verantwortung tragen. Aber dann wird Dr. Ragin selbst krank.

Es war unheimlich. Andrej Efimyc lag da und hielt den Atem an; mit Schrecken erwartete er, man würde ihn nochmal schlagen. Ihm war es, als habe man eine Sichel genommen, zugestochen und mehrere Male in seiner Brust und den Gedärmen umgedreht. Vor Schmerz biss er in das Kissen, er presste die Zähne zusammen, und plötzlich schoss ihm inmitten dieses Chaos

▼

> deutlich ein furchtbarer unerträglicher Gedanke durch den Kopf: Genau den gleichen Schmerz mussten jahrelang, tagaus, tagein die Menschen ertragen, die jetzt im Mondschein wie schwarze Schatten aussahen. Wie konnte es sein, dass er über zwanzig Jahre nichts gewusst hatte und auch nichts wissen wollte? Er wusste nichts, hatte keine Vorstellung von Schmerz, folglich war er auch nicht schuldig, aber sein Gewissen, genauso halsstarrig und grob wie Nikita, ließ ihn vom Scheitel bis zur Sohle vor Kälte erstarren.

Wenn Ärzte selbst erkranken, lernen sie Empathie zu schätzen (Mandell u. Spiro 1987).

9.6.4 Die eigene Sterblichkeit

Feifel (1969) hatte in einer viel zitierten Studie die Einstellung von Ärzten zu Sterben und Tod mit der Einstellung von Angehörigen und dem Krankenhauspersonal verglichen. Die Studie zeigt, dass Ärzte mehr Angst vor dem Tod haben und sich weniger mit Fragen der Todesproblematik beschäftigten als die genannten anderen Gruppen.

Auch Bennet (1987), Vachon (1987), Steffens et al. (1989) und Andrae (1994) haben sich mit diesem Thema beschäftigt. Es scheint, dass gerade wir Ärzte besondere Probleme im Umgang mit dem Tod von anderen und mit unserer eigenen Sterblichkeit haben. Für einige spielt die eigene Todesangst eine Rolle bei der Berufswahl.

Wie können Ärzte, die selber ein problematisches Verhältnis zu ihrem Tod haben, sterbenden Patienten die notwendige Hilfe geben?

Der Schweizer Arzt und Psychoanalytiker Gion Condrau hat in seinem Buch *Der Mensch und sein Tod* (1991) diese Probleme sowohl aus Sicht der Geschichte als auch aus Sicht der Psychoanalyse beschrieben. Das provozierende Fragen, Hinterfragen und In-Frage-Stellen regt zum Nachdenken über eigene Standpunkte unseres eigenen Lebens an.

Auf der einen Seite kann niemand gezwungen werden, der eigenen Sterblichkeit und dem eigenen Tod mit Offenheit zu begegnen. Andererseits müssen Ärzte Patienten betreuen, die sterbend sind und ohne Offenheit und Wahrhaftigkeit des Arztes zusätzliches Leid erfahren. Deswegen muss sich jeder Arzt möglichst schon im Studium mit diesem Thema auseinandersetzen.

9.6.5 Kollegialität

Das Problem des »kranken Doktors« hat über die letzten 20 Jahre die Ärzteschaft zunehmend interessiert. Nach all diesen Ausführungen denkt der eine oder andere Leser, dass ein negatives Bild von den Ärzten gezeichnet wurde. Wir sehen das nicht so. Auch in den zitierten Untersuchungen werden Ärzte als eine Gruppe von Menschen mit außergewöhnlichen Eigenschaften dargestellt (Bennet 1987; Brody 1992). Eine kollektive »Ärztekrankheit« gibt es nicht. Ärzte sind Menschen, die außergewöhnlichen beruflichen Belastungen ausgesetzt sind. Bei der Aufgabe, die Gesundheit der Patienten zu fördern und gleichzeitig mit dem eigenen Leben zurechtzukommen, kann Einsicht und Verständnis für die Rolle des Arztes einen großen Gewinn bedeuten (Guze 1979).

Einige Kollegen kommen in Situationen, in denen Hilfe von einem Seelsorger oder Psychotherapeuten angebracht ist. Andere sind überarbeitet und brauchen eine Pause, um wieder mit den beruflichen und privaten Beziehungen zurechtzukommen. Diejenigen, die nicht in der Lage sind, ihre eigenen Fehler, Gefühle und Wunden zuzulassen, werden auch nicht in der Lage sein, die Fehler, Wunden und Gefühle von anderen zu akzeptieren.

Die wichtige Aufgabe besteht darin, die Hindernisse und Belastungen sichtbar zu machen, damit sie mit kollegialer, organisatorischer und menschlicher Unterstützung überwunden werden können (Vachon 1987).

Der Beruf des Arztes, kranken Menschen zu helfen, gibt uns einen hohen Status. Das Einkommen und die soziale Sicherheit sind meistens gut. Es gibt kaum eine andere Berufsgruppe in der Bevölkerung mit so guten Möglichkeiten für ein zufrieden stellendes und reifes Leben. Der Preis dafür ist die mentale und körperliche Bereitschaft, »rund um die Uhr« an die Bettkante kranker Menschen zu eilen. Wenn wir einsehen, wie hoch der Preis für diese lebenslange Bereitschaft für uns und unsere Umgebung ist, können wir auch etwas unternehmen, um die Folgen zu mildern (Ajemian 1994; Hill 1991).

Diese Probleme scheinen auch eine Generationsfrage zu sein. Ärzte, die nach 1975 ausgebildet wurden, besitzen eine größere Offenheit in Fragen, die mit Gefühlen und Empathie zusammenhängen, als ihre älteren Kollegen. In den in ► Kap. 5.2 angeführten Studien wurden überwiegend männliche Kollegen befragt. Eine größere Anzahl der jüngeren Kollegen sind Frauen, die an-

dere Voraussetzungen für den Beruf mitbringen. Ärztinnen haben einen ganz anderen Kontakt mit ihrem Gefühlsleben als ihre männlichen Kollegen. Ihre Fähigkeiten zu Kommunikation und Empathie, ihre soziale Einstellung und ihre Gefühle tragen auf wertvolle Weise zu einer Veränderung des Berufsklimas und des Berufsethos bei. Sie wollen weder auf Kinder noch auf den Beruf verzichten. Gleichzeitig stellen sie Forderungen an ihre männlichen Kollegen. Sie sind nicht mehr bereit, 60–80 Stunden pro Woche im Beruf zu verbringen, und erwarten dafür Verständnis.

Einige Studien, wie die von Vachon (1987) und Andrae (1994), zeigen, dass eine bessere Kollegialität und ein besseres Arbeitsklima erwartet werden kann, wenn die Anzahl der weiblichen und männlichen Ärzte in einer Abteilung im Gleichgewicht ist. Zukünftige Untersuchungen über die Rolle des Arztes lassen erwarten, dass diese beruflichen Veränderungen auch Einfluss auf die Belastungen im klinischen Alltag und die Lösungen der angesprochenen Probleme haben werden. Diese Änderungen sind auch wichtige Beiträge zu einer verbesserten Kollegialität.

Seit Ende der 1950er Jahre haben Ärzte gegenseitige kollegiale Unterstützung organisiert und gute Erfahrungen in Gruppen (Balint-Gruppen) oder von Arzt zu Arzt gemacht. Hier besteht die Möglichkeit, mit den Kollegen mehr über sich selbst, seine Frustrationen, Kränkungen, Enttäuschungen und Gefühle zu lernen.

Ärzte sind lernfähig. Dies trifft auch für ältere und erfahrene Kollegen zu. Für diese Kollegen ist es besonders wichtig, lernen zu können, weil sie zentrale Funktionen im Unterricht, in der Anleitung und als Vorbilder für jüngere Kollegen und Studenten haben. Besonders vermieden werden muss die Vermittlung eines elitären und robusten Ärztebildes, das die normalen menschlichen Grenzen sprengt.

Ärzte müssen trotz der großen Lern- und Berufsbelastung leben können, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben oder sich als persönliche Versager zu fühlen, wenn sie das Krankenhaus oder die Patienten nach dem Arbeitstag verlassen. Wenn sie von der Arbeit erschöpft sind, brauchen sie Abstand von Not und Leiden ihrer Patienten.

In der Palliativmedizin wurde von Anfang an starkes Gewicht auf eine multidisziplinäre Teamarbeit gelegt (Vachon 1987; Ajemian 1994). Im Zentrum dieses Teams stehen, wie zu erwarten, der Patient und seine Angehörigen. Bei schwerer, lebensbedrohlicher Krankheit sind die Integrität und die Autonomie des Kranken wichtiger als jemals sonst.

Aber die Reserven und Eigenschaften der einzelnen Patienten sind individuell sehr verschieden, und daher ist der Bedarf an Hilfe und Unterstützung unterschiedlich groß. Der Arzt und das Pflegepersonal sind als Teamarbeiter gefordert, mit der Aufgabe, auch andere Teamarbeiter zu integrieren und zu fördern; es kann der Hausarzt oder die Sozialstation sein, der Hausbetreuungsdienst oder der Seelsorger, der Krankengymnast oder der Sozialarbeiter, der Nachbar oder ein ehrenamtlicher Helfer.

Diese Teamarbeit stellt eine große fachliche und menschliche Herausforderung dar. Sie gibt aber auch die Möglichkeit der kollegialen Unterstützung innerhalb des Teams, indem mögliche und vorhandene Konflikte und Belastungen regelmäßig im Teamgespräch mit oder ohne einen Supervisor angesprochen werden (Ajemian 1994).

Die wichtigste Form der Kollegialität liegt in der direkten Beziehung zweier Kollegen. Es ist erlaubt, einem Arbeitskollegen zu zeigen, dass man Rücksicht nehmen kann oder dass man sich kümmert. So mancher Kollege würde sich freuen, wenn wir, mit einem Blumenstrauß, einem Buch oder einer Flasche Wein ausgestattet, an einem Abend ohne viel Vorbereitung bei ihm zu Hause vorbeikämen.

9.6.6 Zu Hause – Das Leben – Liebe

Wir müssen uns selbstverständlich darum kümmern, dass wir im Studium mehr über Menschen, Leben und Tod aufnehmen und dass unsere Lehrer selbst auf diesem Gebiet Qualität im Leben und in der Lehre demonstrieren. Wir müssen unser Interesse für Menschen, Kunst, Literatur und das Leben pflegen und entwickeln. Vor allem müssen wir uns um uns selbst kümmern, darum, wie wir zurechtkommen mit dem Leben.

Die vielen Aufgaben und Erwartungen an die Ärzte im Beruf und im Privatleben zwingen jeden Arzt, Prioritäten zu setzen. Es ist nicht möglich, immer eine große Anzahl von Patienten mit hoher Qualität zu betreuen, in Forschung und Lehre tätig zu sein, sich um ein gutes Arbeitsklima zu kümmern und gleichzeitig die notwendigen Reserven für sich selbst und die eigene Familie zu bewahren.

Den Ärzten wird es nicht leicht gemacht, wenn sie nicht bereit sind, das eigene Leben, die eigenen Interessen und die Familie zu opfern. Wer mit einem Arzt am Anfang seiner Karriere eine Familie gründet, muss entweder

bereit sein, zeitweilig die eigene berufliche Entwicklung zur Seite zu stellen, oder in Kauf nehmen, dass diese die Kinder und die Partnerbeziehung belastet.

Dabei sind das Privatleben und das soziale Umfeld des Arztes, sein Zuhause, der Ort, an dem psychische und soziale Energien aufgetankt werden sollten. Die Mechanismen sind bekannt. Der Arzt kommt später und seltener nach Hause, erschöpft und eingenommen von seiner Arbeit. Am Anfang können noch Geduld und Bewunderung für ihn von Bedeutung sein. Aber Beziehungen brauchen Nahrung und Aufmerksamkeit, Zeit und Geduld, um überleben zu können. So mancher Arzt wird allmählich merken, wie seine Lebensgefährtin und seine Kinder nicht mehr da sind, wenn er sie am meisten braucht, weil er nicht da war, als sie ihn brauchten (McCue 1982; Mawardi 1979).

Wir können nur hoffen, dass es doch vielen gelingt, eine liebevolle Beziehung aufzubauen, eine Familie zu gründen und zu erhalten. Bei der heutigen Gesellschaftsentwicklung können wir nicht erwarten, dass unsere wertvollen weiblichen Kollegen bereit sind, auf ihren Beruf zu verzichten. So bleibt es eine wichtige Aufgabe für uns, die Arbeitsbedingungen des Arztes zu ändern. Mit steigender Arbeitslosigkeit in der Bevölkerung sind Arbeitspläne unsolidarisch, die eine unbezahlte Mehrarbeit der Ärzte voraussetzen. In Zukunft muss es möglich sein, vollwertiger Arzt und vollwertiges Familienmitglied zugleich zu sein, damit Energie und Freude erhalten bleiben, um auf beiden Gebieten – zu Hause und im Beruf – zu lernen und zu geben.

Ohne Liebe und Empathie gibt es keine Beziehungen. Liebe zu geben und zu bekommen ist eine ewige Bewegung zwischen Nähe und Abstand: Man nimmt nicht Abstand, man *gibt* ihn, man fordert nicht Nähe, man *gibt* sie. Auf diese Weise wird es dem anderen möglich gemacht, in Gleichwertigkeit auch zu geben. Wenn ich zu einem anderen sagen kann: »Ich liebe dich«, muss ich auch sagen können: »Ich liebe in dir auch alle anderen, ich liebe durch dich die ganze Welt, ich liebe in dir auch mich selbst« (Fromm 1984).

Die sozialen und menschlichen Voraussetzungen für das Leben sind in ständiger Wandlung. Dies prägt auch das Berufsbild und den Alltag des Arztes. Wo früher erwartet wurde, dass der Arzt ohne Rücksicht auf Verluste seine Privatsphäre und Familie hinter den Ruf des Berufes setzte (Osler 1904), sehen wir heute, wie folgenschwer solche Prioritäten für den Arzt, seine Pa-

tienten und seine medizinischen und menschlichen Kompetenzen gewesen sind. Heute ist ein neuer Arzt gefragt: kompetent, aufgeschlossen, kommunikativ, ein geschätzter Teamarbeiter, in der Lage, pünktlich nach Hause zu gehen, um erfüllt und motiviert pünktlich am nächsten Tag wieder im Beruf zu erscheinen.

Daraus darf man nicht schließen, dass die Ärzte über ihrer Selbstpflege vergessen dürfen, dass die Patienten ihre beruflichen Auftraggeber sind. Selbstverständlich müssen wir uns um das Wohlergehen der Patienten kümmern.

Können wir aber sagen, dass der Hauptgrund der Vernachlässigung der Familie immer zu einer besseren Gesundheit unserer Patienten führe?

Ist nicht die zentrale Voraussetzung im Bestreben, Gesundheit zu fördern, die Einsicht des Arztes, dass dies nicht nur fachliche, sondern noch mehr menschliche Qualitäten von ihm fordert?

Sind nicht ein reifer Verstand und eine heile Seele unsere wichtigsten Instrumente (Mandell u. Spiro 1987; Mullan 1985)?

Oder, wie wir es, vor 2.200 Jahren geschrieben, auf dem Grabstein eines Arztes in Athen finden:

> Das ist die wichtigste Aufgabe des Arztes: Zuerst die eigene Seele zu heilen und sich um sich selbst zu kümmern, bevor er versucht, anderen zu helfen…

9.7 Hoffnung

Die meisten Menschen hängen sehr am Leben. Wir können traumatische Lebensphasen durchmachen, wir mögen zeitweilig deprimiert oder traurig sein oder schwere Herausforderungen vor uns sehen, es bleibt bei den meisten wohl der starke Wunsch, doch weiterzuleben. Der Gedanke an das Sterben ist einmal mit Vorstellungen des Qualvollen verbunden – zum anderen ist der Tod wegen seiner Endgültigkeit beängstigend.

In der Kulturgeschichte gibt es zahlreiche Darstellungen, das Ausweglose des Sterbens, des Todes zu bewältigen, indem in irgendeiner Form ein Weiterleben nach dem Tode angenommen wird. In der christlichen Welt ist es die Vorstellung von der Unsterblichkeit der Seele und ihrer Errettung durch

einen gütigen Gott, die aus der Ausweglosigkeit herausführt. Nun ist von dem deutschen Historiker Franz Borkenau zu Recht unsere Zeit als postchristlich bezeichnet worden (Borkenau 1965). Damit hat er auch einen Wandel in der Haltung vieler Menschen zum Tode beschrieben. Wenn ihnen früher der Glaube an die Unsterblichkeit der Seele über die Härten des Lebens und den Gedanken an den Tod hinweghalf, so schließt nach der Vorstellung des modernen Menschen das Leben, das es ausgiebig zu genießen gilt, mit dem Tode endgültig ab.

Eine weitere Änderung ist in unserer Gesellschaft zu erkennen. Im Jahr 1920 waren mehr als 50% der Verstorbenen jünger als 20 Jahre, und die durchschnittliche Lebenserwartung war geringer als 49 Jahre. Heute kann ein deutscher Durchschnittsbürger erwarten, 80 Jahre alt zu werden. Mehr als drei Viertel aller Menschen sterben in Pflegeheimen, Altersinstitutionen oder Krankenhäusern, in den Städten mehr als 90%; 1920 starben mehr als 80% zu Hause (Fulton u. Bendiksen 1994). Seit 1920 hat sich die Anzahl der Krankenhausbetten versiebenfacht. Der Tod findet außerhalb der Familie statt, oft kann man das Gefühl bekommen, er findet überhaupt nicht statt.

Umso größer sind die Probleme, die auftreten, wenn ein Mensch mit einer ernsten, inkurablen Erkrankung konfrontiert wird. Der Gedanke an den Tod ruft dann nicht nur bei dem Sterbenden und den Angehörigen Trauer, Schock, Wut, Verdrängung und eine Reihe negativer Gefühle hervor. Auch die behandelnden Ärzte und das Pflegepersonal werden nicht selten von ähnlichen Empfindungen betroffen. Das führt zu Verhaltensweisen, die häufig zu beobachten sind (Stedeford 1994):

- Sterbende Patienten und ihre Angehörigen werden mit ihren Ängsten und Gefühlen allein gelassen.
- Patienten werden nicht auf liebevolle Weise und mit Behutsamkeit auf den bevorstehenden Tod vorbereitet.
- Es wird ihnen nicht ermöglicht, individuell Abschied zu nehmen und würdig an dem von ihnen gewünschten Ort zu sterben.
- Die moderne Medizin behandelt mit ihren nahezu unbegrenzten Therapiemöglichkeiten Patienten selbst dann Tage, Wochen und Monate lang weiter, wenn das Sterben nicht aufzuhalten ist.
- Es wird den Patienten nicht ermöglicht, so offen wie für sie möglich, Abschied zu nehmen und so würdig, an dem von ihnen selbst gewünschten Ort, wie sie es selbst wünschen, zu sterben.

- Die Angehörigen bekommen kaum die Möglichkeit, von dem Patienten Abschied zu nehmen, die entstehenden Gefühle zu teilen und noch notwendige menschliche und praktische Fragen zu klären.

Dieser Problemkreis geht uns alle an. Es geht dabei nicht nur um die Frage, wie wir unsere Patienten behandeln und aufklären sollen – oder wie unsere Angehörigen einmal sterben werden. Es geht v. a. auch darum, wie wir selbst sterben werden: möglicherweise allein gelassen, isoliert in einem Krankenhausbett, umgeben von Menschen, die nicht wissen, wie sie sich angesichts unseres bevorstehenden Todes verhalten sollen und lediglich ein »Es wird schon gutgehen!« hervorbringen können.

Wie kann diese Gefühlsarmut und Ratlosigkeit unterbunden werden?

Zuerst sollten wir uns selbst besinnen, unser eigenes Verhältnis zum Leben und zum Tod zu überdenken, solange wir uns mitten im Leben befinden. Wir werden alle sterben, eine Hoffnung, dass wir auf dieser Welt überleben, gibt es nicht.

- Wie und wo möchte *ich* meine letzten Tage verbringen?
- Wenn es keine Hoffnung auf ein Überleben auf dieser Welt gibt, welche Hoffnung gibt es dann für mich?

9.7.1 Heute hat Ihr Arzt Ihnen vermittelt, dass Sie schwer krank sind

Machen wir ein Gedankenexperiment

Sie sind heute bei Ihrem Arzt gewesen. Die letzten Untersuchungen haben ergeben, dass Sie eine unheilbare Erkrankung haben. Die verbleibende Zeit ist begrenzt, und es bleiben wahrscheinlich nur Monate. Sie haben dem Gespräch entnommen, dass für diese Krankheit keine Heilungsmöglichkeit besteht.

- Was würden Sie tun? Was bleibt Ihnen vom Leben?
- Welche Werte, welche Möglichkeiten, welche Hoffnung gibt es noch für Sie?
- Würden Sie alles daran setzen, doch noch einen Strohhalm zu finden, eine bisher unbekannte Therapie zu entdecken und bei ihnen versuchsweise durchführen zu lassen?
- Auch wenn sie dabei viel Geld zahlen müssten?

- Wie denken Sie jetzt über Ihren Arzt?
  - Sind Sie böse auf ihn?
  - Ist es richtig von ihm gewesen, so offen und direkt über Ihre Aussichten zu sprechen?
  - Hätten Sie es lieber, wenn diese Nachricht verschleiert geblieben wäre?
  - Auch wenn er Sie dabei hinters Licht geführt hätte?

Tatsache ist, dass viele Ärzte bei lebensbedrohlichen Erkrankungen sowohl über den Krankheitszustand wie auch über die Konsequenzen nicht offen reden, weil sie meinen, den Kranken vor der Wahrheit in Schutz nehmen zu müssen. Solche Gedanken können angebracht sein. Sie dienen freilich oft nur dem Schutz des Arztes, der nicht vorbereitet ist, möglichen Reaktionen des Patienten oder seiner Angehörigen zu begegnen.

- Was würden Sie Ihrer Familie erzählen?
- Wäre für Sie ein offenes Vertrauensverhältnis wichtig, oder würden Sie zu Hause, dem Ehepartner, den Kindern gegenüber diese Nachricht verheimlichen?

Aus Erfahrung wissen wir, dass viele Patienten Hilfe und Offenheit gegenüber ihrer Familie brauchen. Wir wissen aber auch, dass es für die Angehörigen und besonders für die Kinder am besten ist, wenn ein gemeinsames Verständnis über die Erkrankung und deren Folgen vorhanden ist.

Es ist also nicht nur der Arzt, der oft glaubt, andere vor der »Wahrheit« in Schutz nehmen zu müssen. Auch die Angehörigen versuchen häufig, sich selbst vor Empfindungen und Gedanken zu schützen, die ihnen unangenehm sind. Nichts ist charakteristischer für die gegenwärtige Einstellung zum Tod als die Scheu der Erwachsenen, sich mit Kindern offen über den Tod auseinanderzusetzen, und dies, obwohl wir wissen, dass diese Auseinandersetzung für Kinder, die den Verlust eines nahen Familienangehörigen miterleben, heilsam ist.

Aber zurück zu Ihrer Hoffnung.

- Haben Sie tatsächlich gedacht, dass Sie unsterblich sind?
- Oder ist es bloß eine Frage, auf die Sie jetzt, in diesem Moment, unvorbereitet sind?
- Und jetzt, da sie von Ihrem Arzt erfahren haben, dass Sie nicht mehr lange leben werden, was bleibt Ihnen?
- Besteht noch Hoffnung?

9.7.2 Ein Beispiel

Beispiel aus der Praxis

Lars hatte scheinbar alles verloren. Seine erste Frau war vor vier Jahren an Krebs gestorben. Vor einem Jahr hat er wieder geheiratet. Aus der ersten Ehe hat er zwei Kinder, jetzt 9 und 14 Jahre alt. Mit seiner neuen Frau hat er ein Kind, jetzt sechs Monate alt. Lars hat erfahren, dass seine Krebserkrankung unheilbar ist und dass ihm nur noch Monate bleiben.

Lars ist sehr religiös. Er hat eine Familie, die ihn braucht und ihn liebt. Er ist im Beruf erfolgreich, er schätzt sehr sein schönes Haus und das Landhaus am Meer. Er hat gute Freunde.

Ich war sein Arzt in seinen letzten Monaten. Man kann sagen, dass ihm durch diese Nachricht der Boden unter den Füßen weggerissen wurde. Er hat in dieser Zeit wiederholt gesagt, dass ihm nichts bliebe, sogar sein Glaube an Gott habe ihn verlassen. Und er sei schwer getroffen. Seine beiden Kinder aus erster Ehe werden jetzt elternlos. Nach langer Zeit der Trauer hatte er langsam wieder Mut bekommen und glaubte an eine Zukunft mit seiner neuen Frau, die er jetzt mit seinem einjährigen Kind verlassen muss.

Hoffnung? Ich hatte in dieser Zeit nicht das Gefühl, dass Hoffnung ein großes Thema war, weder für ihn noch für seine Familie. Das Gefühl, von Gott verraten worden zu sein, war für ihn besonders schwierig zu ertragen.

Als ich ihn besuchte, kurz bevor er starb, war etwas geschehen. Ich sprach ihn darauf an, worauf er antwortete: »Heute Nacht habe ich Gott angebrüllt, es hat gut getan…« »Und was antwortete er?«, fragte ich. »Er sagte: – Warum hast du so lange gewartet…?«

Etwas später sagte er dann: »Ich habe heute morgen einen schönen Traum gehabt. Ich war am Strand. Überall waren Blumen. Es war ein traumhaft schöner Frühlingstag. Alle waren da: Meine Kinder, meine Frau, meine Eltern, auch Anne, meine verstorbene Frau.«

Und darauf: »Ich träume mehr und mehr jetzt. Ich glaube, wenn ich jetzt sterbe, verbleibe ich in meinen Träumen und werde nicht mehr wach…«

Was sagt uns diese Geschichte? Der Tod beendet oft ein Leben auf tragische Weise. Allzu oft haben wir im Leben Konflikte, Ängste und Verluste hingenommen oder beiseite geschoben, weil sie zu belastend waren oder weil wir glaubten, uns vor den eigenen Gedanken und Gefühlen schützen zu müssen. Und dann, wenn das Ende näher kommt, geraten wir in Zeitnot und werden von einer ungeheuren Einsamkeit überwältigt.

Wenn die Hoffnung auf ein Weiterleben genommen wird, was bleibt uns dann?

Die Frage ist, ob wir dieses verbleibende Leben ablehnen wollen. Viele tun es: Konflikte werden weiterhin nicht angesprochen, Ängste nicht ausgedrückt. Die Einsamkeit kann unüberwindbar werden, falls es nicht gelingt, eine Brücke zu schlagen, die Offenheit und Vertrautheit zulässt. Dies trifft für den Kranken wie für die Angehörigen zu.

Lars hatte gute und schlechte Voraussetzungen. Er hatte bereits viel verloren, viel war unbewältigt. Jetzt standen ihm noch weitere Verluste bevor. In seinen ihm verbleibenden Monaten hatte er eine ungeheure Trauerarbeit bewältigt. Es konnte nicht erwartet werden, dass diese Trauerarbeit hätte abgeschlossen werden können, bevor er starb.

Aber er war nicht allein. Die Familie hat mit ihm getrauert. Seine Frau hat es hinterher deutlich ausgedrückt:

> Wir haben am Anfang schwer gelitten. Schock, Verschwiegenheit, Verzweiflung, Trauer, Tränen, Wut und offene Konflikte waren unser Alltag. Die Kinder haben sich zurückgezogen. Aber nach und nach ist es anders geworden. Lars hat sich zum Schluss sehr geändert.
>
> Aus dem hart nehmenden Geschäftsmann ist ein empfindsamer Vater und Ehemann geworden. Obwohl wir schwer gelitten haben, haben wir Tage und Abende verbracht, die für uns alle unvergesslich in Erinnerung bleiben werden. So herzlich haben wir uns über Kleinigkeiten gefreut und gelacht!
>
> Als Lars zu Hause starb, waren wir alle in seinem Zimmer. Er war in den letzten Tagen ganz ruhig. Besonders für die Kinder waren diese Tage von einprägsamer Bedeutung. Seitdem haben wir ein Zusammenwachsen der Familie gespürt. Die Kinder sprechen es jetzt noch gerne an, auch wie er tot da lag hinterher, und wie schön sie es fanden, dass wir ihn selbst zurechtgemacht und ihm seinen Lieblingsanzug angezogen haben.
>
> Ich verstehe jetzt, dass Lars ein ungeheures Bedürfnis zum Trauern gehabt hat. Es ist unmöglich für mich zu beschreiben, welche Bedeutung es hat, dass diese Trauerarbeit von allen zusammen geteilt wurde…
>
> Wir dachten alle, jetzt besteht keine Hoffnung mehr. Nach und nach haben Lars und ich doch ein anderes Verständnis darüber gewonnen.
>
> ▼

Zuerst die kleinen Hoffnungen. Hoffnung auf einen guten Tag und einen guten Schlaf. Hoffnung, dass wir es schaffen, noch einmal fischen zu fahren. Hoffnung, dass die Medikamente die Schmerzen und die Übelkeit unter Kontrolle halten werden.

Dann kamen größere Hoffnungen. Dass es den Kindern gut gehen wird oder dass ich ohne Lars überlebe. Lars freute sich, dass es für uns möglich war, nach seinem Tode in unserem Haus weiterzuwohnen.

Zuletzt haben wir eingesehen, dass es für uns immer noch ganz große Hoffnung und Freude gibt:

die Tage die wir gemeinsam verbringen durften, und ein Leben miteinander,

dass Lars in Frieden zu Hause sterben würde,

dass wir es geschafft haben, ein gemeinsames Kind zu bekommen,

und die Liebe.

Lars hat in den letzten Tagen gesagt, er glaubt, wenn die Menschen tot sind, gibt es eine Liebe, die von uns übrigbleibt und weiterlebt. In der Familie sprechen wir jetzt oft darüber: Die Liebe von Lars, die in uns weiterlebt.

Ich hoffe auch, dass ihr in dem Gesundheitswesen Verständnis dafür entwickelt, um einzusehen, dass der Kranke im Krankenhaus entfremdet und von der Familie gerissen wird und dass besonders Kinder darunter leiden. Obwohl die Botschaft, dass Lars jetzt sterben würde, einen ungeheuren Schlag für uns bedeutete, war es die gemeinsame Einsicht und Bearbeitung dessen, die es uns ermöglichte, Kräfte und Ausdauer zu mobilisieren und Lars zu Hause durch die letzte Zeit zu pflegen. Diese gemeinsame Zeit zu Hause gab uns etwas, was im Krankenhaus nie möglich gewesen wäre…

Es gab für mich, für Lars und für die Kinder nie eine Zeit mit mehr Hoffnung als in den letzten Wochen zusammen…«

- Müssen *wir* in schwere Lebenskrisen geraten, um zu erfahren, was Hoffnung ist?
- Geht Hoffnung in Krankenhäusern und Pflegeheimen leicht verloren?
- Gibt es, wenn alles verloren scheint, vielleicht mehr Grund zu hoffen als jemals zuvor?

Wie oft habe ich von Hinterbliebenen den Kommentar gehört: »Ich verstehe nicht, warum keiner es uns ermöglicht hat, offen darüber zu sprechen

und Abschied zu nehmen. Ich habe so unendlich viel, was ich noch sagen wollte…«

Wir haben deswegen die große Aufgabe, dass wir in unserem Alltag weder vor uns selbst noch vor unseren Nächsten noch in der Gesellschaft den Tod verstecken dürfen (Randall u. Downie 1996). Falls dies geschieht, falls ein Mensch im Sterben fühlen muss, dass er kaum noch Bedeutung für die ihn umgebenden Menschen besitzt, dann ist er wirklich einsam, dann ist er gestorben, bevor er tot ist.

Der Tod selbst ist kaum schrecklich. Man fällt ins Träumen, und die Welt verschwindet, wenn es gutgeht. Schrecklich können Schmerzen oder ungelinderte Symptome sein, aber dagegen kann heute viel unternommen werden. Schrecklich ist oft der Verlust der Lebenden, wenn ein geliebter oder befreundeter Mensch unvorbereitet stirbt. Schrecklich sind auch die großen kollektiven und individuellen Phantasien, die den Tod in unserer Gesellschaft umgeben.

Die Ärzte sollten eine wichtige Aufgabe darin sehen, jedem Menschen seinen eigenen Tod zu ermöglichen. Es muss vom Arzt die Einsicht erwartet werden können, dass der Tod für Schwerkranke eine Erlösung sein kann.

Ein Weitertherapieren »um jeden Preis«, weil der Arzt sich vor schwierigen Entscheidungen drückt, ist unethisches und unärztliches Benehmen. In der medizinischen Praxis wird häufig sowohl den Patienten als auch den Angehörigen dadurch eine unnötige und folgenschwere Verlängerung des Leidens zugefügt.

Das Sterben ist ein Teil des Lebens, weder das Leben noch der Tod sind eine Krankheit. Ich möchte aus diesem Leben nicht als Patient scheiden, sondern als freier Mensch. Ich will nicht unnötigerweise an ein Krankenhaus oder eine medizinische Behandlung gebunden werden, wenn das, was ich am meisten brauche, die Bewahrung meiner Integrität ist und ein Signal, dass ich in Frieden sterben darf, umgeben von Menschen, die sich nicht um meine Krankheit kümmern, sondern um mich.

Dies bedeutet, dass der Arzt imstande sein muss, den Patienten und seinen Angehörigen die Konsequenzen der Erkrankung mit Empathie und Sensibilität darzustellen (Pacheco 1989; Husebø 1997). Wahrheit am Krankenbett bedeutet aber nicht eine Ankündigung des Sterbens, sondern einen Prozess, der die Sinnerschließung des Sterbens beinhaltet. Voraussetzung dafür, dass der Patient diese Information verarbeitet, ist, dass er sie annimmt. Die Klarheit über den eigenen Zustand kann dem Patienten eine ungeahnte seelische

Kraft erschließen. Die meisten Menschen besitzen mehr Mut und Vitalität, als sie sich selbst zutrauen und als von ihnen erwartet wird.

Es bedeutet aber auch, dass der Arzt als Mitmensch eine Pflicht hat, den Patienten und Angehörigen beizustehen, wenn die Einsamkeit, die Wut, die Trauer oder die Schmerzen den Betroffenen zu vernichten drohen (Jankovic et al. 1989; Kastenbaum 1976).

Nicht zuletzt muss der Arzt gerade dann Respekt, Vertrauen und Offenheit gegenüber alternativen Hoffnungen vermitteln, wenn die Hoffnung auf Überleben schwindet und der Patient und die Angehörigen eine für sie tiefere Hoffnung suchen (Le Bourdais 1989).

Und wir, die wir uns mitten im Leben meinen, was können wir tun? Vielleicht sollten wir, bevor es ernst wird, über unsere Unzulänglichkeiten nachdenken. Es liegt noch der Rest unseres Lebens vor uns. Wie, mit wem, auf welche Weise wollen wir ihn verbringen? Was können wir noch für die Patienten, unsere Kinder, den Lebenspartner oder uns selbst tun? Was bedeuten für uns das Leben und der Tod? Gibt es Hoffnung?

Literatur

Ajemian I (1994) The interdisciplinary team. In: Doyle D, Hanks J, Macdonald N (eds) Oxford Textbook of Palliative Medicine, pp 17–28

Andrae M (1994) Facing death. Physicians' difficulties and coping strategies in cancer care. Med. Dissertation No 395, Umeå University

Bennet G (1987) The Wound and the Doctor. Warburg, London

Borkenau F (1965) The concept of death. In: Fulton R (ed) Death and identity. Wiley, New York

Brody H (1992) The healer's power. Yale Univ Press, New Haven London

Tschechow A (Ausg. 1992) Tagebücher, Notizbücher. Diogenes, Zürich

Tschechow A (1994) Krankenzimmer Nr. 6. In: Meistererzählungen. Diogenes, Zürich, dtb-Klassiker Nr. 21702, S 172

Clinch JJ, Schipper H (1994) Quality of life assessment in palliative care. In: Doyle D, Hanks J, Macdonald N (eds) Oxford Textbook of Palliative Medicine, pp 61–70

Condrau G (1991). Der Mensch und sein Tod. Kreuz, Zürich

Fain RM et al. (1989) Disaster, stress and the doctor. Med Educat 23: 91–96

Feigenberg L (1977) Terminalvård. En metod for psykologisk vård av döende cancerpatienter. Med. Dissertation. Karolinska Institutet, Stockholm. Lund, Liber

Feifel H (1969) Attitudes towards death. J Consult Clin Psychol 33/3: 292–295

Fromm E (1984) Die Kunst des Liebens. Ullstein, Frankfurt am Main (Ullstein-Buch Nr. 35258)

Fulton R, Bendiksen R (eds) (1994) Death and Identity. Charles Press, Philadelphia

Gorlin R. et al. (1983) Physicians reactions to patients. N Engl J Med 308:1059–1063

Guze S (1979) Can the practice of medicine be fun for a lifetime. JAMA 241: 2021–2030

Hill D (1991) Point and counterpoint: Relationships in oncology care. J Psych Oncol 9: 112
Holm U (1991) Can we measure empathy? Socialmedisinsk Tidsskrift 9–10: 427–432
Hunsdahl J (1967) Concerning Einfühlung (empathy): a concept of its origin and early development. J History Behav Sci 3: 180–191
Husebø S (ed) (1992) Medisin – kunst eller vitenskap. Ad Notam Gyldendal, Oslo
Husebø S (1997) Communication, autonomy and hope. How can we treat serious ill patients with respect? In: Surbone A, Zwitter M (eds) Communication with the cancer patient. Information and truth. Ann N Y Acad Sci 809: 440–460
Jankovic M et al. (1989) Meetings with parents after the death of their child from leukemia. Ped Haem Oncol 6: 155–160
Jacyk W (1989) Impaired physicians: They are not the only ones at risk. Can Med Assoc J 141: 147–148
Kalra J et al. (1987) Emotional strain on physicians caring for cancer patients. In: Shapiro S (ed) Psychosocial aspects of chemotherapy. Haworth Press, New York
Kastenbaum R (1976) The psychology of death. Springer, New York Berlin Heidelberg
Katz RL (1963) Empathy: Its natures and uses. Free Press, New York
Klaschik E, Husebø S (1997) Palliativmedizin. Anaesthesist 46: 177–185
Le Bourdais E (1989) Hopelessness and helplessness: Treating the doctors who treat AIDS patients. Can Med Assoc J 140: 440–443
Liaschenko J (1994) Making a bridge: the moral work with patients we do not like. J Palliat Care 10: 83–89
Maguire P (1989) Barriers to a psychological care of the dying. Br Med J 291: 907–909
Mandell H, Spiro H (1987) When doctors get sick. Plenum Press, New York
Mawardi BH (1979) Satisfactions, dissatisfactions and causes of stress in medical practice. JAMA 241: 1483–1486
McCue J (1982) The effects of stress on physicians and their medical practice. N Engl J Med 306: 458–463
Mullan F (1985) Seasons of survival: Reflections of a physician with cancer. N Eng J Med 313: 270–273
Murray RM (1977) Psychiatric illness in male doctors and controls. Br J Psychiatry 131: 1–10
Osler W (1904) Aequanimitas with other adresses to medical students, nurses and prationers. Keynes, London
Pacheco R (1989) Attitudes of medical personnel (doctors and nurses) toward informing terminal ill patients. Med Law 8: 243–248
Peabody FW (1984) The care of the patient. JAMA 252: 813–818
Rabin PR et al. (1984) The care of the patient. Francis Peabody revised. JAMA 252: 819–820
Randall F, Downie RS (1996) Palliative care ethics. A good companion. Oxford Medical Publ, Oxford
Sargent DA, Jenson VW, Petty TA, Raskin H (1977) Preventing physician suicide. JAMA 237: 143–145
Schmidbauer W (1994) Helfen als Beruf. Rowohlt, Reinbek (Rowohlt-Taschenbuch 1290–9157)
Schmidbauer W (1995) Hilflose Helfer. Rowohlt, Reinbek (Rowohlt-Taschenbuch 1290–9196)
Seravalli E (1989) The dying patient, the physician and the fear of death. N Eng J Med 319: 1728–1730

Seravalli E (1989) Correspondence, the physician and the dying patient. N Eng J Med 320: 1557–1558
Spiro H (1992) What is empathy and can it be taught? Ann Intern Med 116: 843–846
Spiro H (1993) Empathy and the practice of medicine. Yale Univ Press, London
Steffens W, Kächele H (1989) Abwehr und Bewältigung – Vorschläge zu einer integrativen Sichtweise. Psychother Psychosom Med Psychol 38: 3–7
Stedeford A (1994) Facing death: Patients, families and professionals. Sobell, Oxford
Supple F, Diaz AJ et al. (1992) Factors affecting survival and satisfaction: Navigating a career in oncology social work. J Psychosoc Oncol 10: 111–130
Søderstrøm U (1990) Om maktrelation i läkar-patient-mötet. Lidandet och makten. In: Andersson SO (ed) Lidandet och makten. Gothia, Stockholm, pp 41–52
Tishelman C (1993) Making sense of sickness experience. Doctoral Dissertation. Karolinska Institutet, Stockholm (Departement of ICAR)
Ullrich A et al. (1990) Stress experienced by physicians and nurses in cancer ward. Social Sci Med 31: 1013–1022
Vachon M (1987) Occupational stress in the care of the critically ill, the dying and the bereaved. Hemisphere Publ, Washington/DC
Vaillant GE, Sobowale N, McArthur C (1972) Some psychologic vulnerabilities of physicians. N Engl J Med 287: 372–375
Whippen D (1991) Burnout syndrome in the practice of oncology: Results of a random survey of 1000 oncologists. J Clin Oncol 9: 1916–1920

Empfohlene Literatur

Englisch/Französisch

Adair J (1987) Effective teambuilding. Gower, London

Andrae M (1994) Facing death. Physicians' difficulties and coping strategies in cancer care. Umeå University Medical Dissertations, No 395, Umeå, Sveden

Beck-Friis B (1993) Hospital based homecare of terminal ill cancer patients. The Motala model. Uppsala University: Comprehensive summaries of Uppsala dissertations from the Faculty of Medicine, Uppsala, Sweden

Bennet G (1987) The wound and the doctor. Warburg, London

Borck D (1993) Life and death. Philosophical essays in medical ethics. Cambridge Univ Press, Cambridge

Bowlby J (1980) Loss, anxiety and depression. Hogarth, London

Brody H (1992) The healer's power. Yale Univ Press, New Haven London

Buchanan AE, Brock DW (1989) Deciding for others. Cambridge Univ Press, Cambridge

Buckman R 1993. How to break bad news. Macmillan, London

Cartwright Z, Hockey L, Anderson F (eds) (1973) Life before death. Kegan & Paul, London

Cassel EJ (1991) The nature of suffering and the goals of medicine. Oxford Univ Press, Oxford

Cohen S (ed) (1989) Casebook on the termination of life sustaining treatment and the care of the dying. Indiana Univ Press, Indiana/IN

Doyle D (1987) Domiciliary terminal care. Churchill Livingstone, London

Doyle D (1994) Caring for a dying relative: A guide for families. Oxford Univ Press, Oxford

Doyle D, Hanks J, Macdonald N (1994; 1999) Oxford Textbook of Palliative Medicine. Oxford Univ Press, Oxford

Downie RS, Calman KC (1994) Healthy respect: Ethics in health care. Oxford Univ Press, Oxford

Downie RS, Charlton B (1992) The making of a doctor. Oxford Univ Press, Oxford

Dunstan GR, Shinebourne EA (eds) (1989) Doctor's decisions: Ethical conflicts in medical practice. Oxford Univ Press, Oxford

Fulton R, Bendiksen R (1994) Death and identity. Charles Press Publ, Philadelphia/PA

Goleman D (1995) Emotional intelligence. Bantam, New York

Hinton J (1972) Dying. Penguin Books, Middlesex/UK

Holland JC, Rowland J (eds) (1989) Handbook of psychooncology: Psychological care of the patient with cancer. Oxford Univ Press, Oxford New York

Hull R, Ellis M, Sargent V (1989) Teamwork in palliative care. Radcliffe, Oxford

Lynn J (ed) (1986) By no extraordinary means. Indiana Univ Press, Bloomington/IN

MacDonald N (ed) (1998) Palliative Medicine. A case-based manual. Oxford Univ Press, Oxford
Mandell H, Spiro H (1987) When doctors get sick. Plenum, New York
Morgan JD (ed) (1996) Ethical issues in the care of the dying and the bereaved aged. Baywood, New York
Oates MD (1993) Death in a school community. A handbook for counselors, teachers and administrators. American Counseling Association, Alexandria/VA
Parkes CM (1972) Bereavement. Studies of grief in adult life. Tavistocks, London
Pellegrino ED, Thomasma DC (1988) For the patients good. The return of benefience to health care. Oxford Univ Press, Oxford
Pellegrino ED, Thomasma DC (1994) The virtues in medical practice. Oxford Univ Press, Oxford
Piaget J (1964) Six études de psychologie. Gauthier, Paris
Randall F, Downie RS (1996) Palliative care ethics. A good companion. Oxford Medical Publ, Oxford
Rando TA (1984) Grief, dying and death. Research Press Company, Champaign/IL
Rando TA (1986) The parenteral loss of a child. Research Press, Champaign/IL
Rogers C (1969) On becoming a person: A therapists view of psychotherapy. Constabe, London
Saunders C, Sykes N (1993) The management of terminal malignant disease. E. Arnold, London
Sontag S (1987) Illness as metaphor. Anchor & Doubleday, London
Spiro H (1993 Empathy and the practice of medicine. Yale Univ Press, London
Stedeford A (1994) Facing death: Patients, families and professionals. Sobell, Oxford
Simpson MA (1980) Clinical psycholinguistics: The language of illness and healing. Irvington, New York
Singer P (1995) Rethinking life and death: The collaps of our traditional ethics. St. Martins, New York
Stroebe W, Stroebe WS (1987) Bereavement and health. Cambridge Univ Press, Cambridge
Surbone A, Zwitter M (1997) Communication with the cancer patient. Information and truth. Annals of the New York Academy of Sciences, New York
Twycross R (1986) Relief of alimentary symptoms in advanced cancer. Churchill Livingstone, London
Twycross R (1994) Pain relief in advanced cancer. Churchill Livingstone, London
Twycross R (1995) Introducing palliative care. Radcliffe, Oxford
Vachon M (1987) Occupational stress in the care of the critically ill, the dying and the bereaved. Hemisphere Publ, Washington
Wall PD, Melzack R (eds) (1994) Textbook of pain. Churchill Livingstone, London
Worden JW (1982) Grief counseling and grief therapy: A handbook for mental health practioners. Springer, Berlin Heidelberg New York

Deutsch

Aries P (1981) Studien zur Geschichte des Todes. Deutscher Taschenbuch-Verlag, Berlin (dtb Wissenschaft Nr. 4369)
Aries P (1984) Bilder zur Geschichte des Todes. Hanser, München
Aulbert E (Hrsg) (1993) Bewältigungshilfe für den Krebskranken. Thieme, Stuttgart
Aulbert E, Zech D (1997) Lehrbuch der Palliativmedizin. Schattauer, Stuttgart

Aulbert E, Niederle N (eds) (1990) Die Lebensqualität der chronisch Krebskranken. Thieme, Stuttgart
Barloewen C von (Hrsg) (1996) Der Tod in den Weltkulturen und Weltreligionen. Diederich, München
Bausewein C, Roller S, Voltz R (2003) Leitfaden Palliativmedizin, 2. Auflage. Urban & Fischer, München Jena
Beck H, Martin E, Motsch J, Schulte am Esch J (Hrsg) Schmerztherapie. Thieme, Stuttgart New York
Beck R (Hrsg) (1995) Der Tod – Ein Lesebuch von den letzten Dingen. Beck, München
Bierce A (1966) Des Teufels Wörterbuch. Haffmann, Zürich (btb 72055)
Bräutigam W, Mehrwein F (Hrsg) (1990) Das therapeutische Gespräch mit Krebskranken, Fortschritte der Psychoonkologie. Huber, Bern
Brune K, Beyer A, Schäfer M (Hrsg) (2001) Schmerz. Pathophysiologie, Pharmakologie, Therapie. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokio
Buber M (1994) Ich und Du. Reclam, Leipzig
Buber M (1992) Das dialogische Prinzip. Lambert Schneider, Tübingen
Cassidy S (1995) Die Dunkelheit teilen. Herder, Freiburg i. Br.
Cechov A (1989) Meistererzählungen. Diogenes, Zürich (detebe Klassiker 21702)
Cermak I (1972) Ich klage nicht. Wien
Condrau G (1991) Der Mensch und sein Tod. Kreuz, Zürich
Diener HC, Maier C (Hrsg) (2003) Das Schmerztherapiebuch. Medikamentös, - interventionell – psychologisch. 2. Auflage. Urban & Fischer, München Jena
Ebell H, Beyer A (1992) Die Schmerzbehandlung von Tumorpatienten. Thieme, Stuttgart
Eberbach WH (1984) Die Aufklärung des Patienten vor dem Hintergrund der Einstellung zum Tode. Stuttgart (Medizinrecht 6)
Egle UT, Hoffman SO, Lehmann KA, Nix WA (Hrsg) (2003) Handbuch Chronischer Schmerz. Grundlagen, Pathogenese, Klinik und Therapie aus bio-psycho-sozialer Sicht. Schattauer, Stuttgart
Egle UT, Hoffmann SO (1993) Der Schmerzkranke. Grundlagen, Pathogenese, Klinik und Therapie chronischer Schmerzsyndrome aus bio-psycho-sozialer Sicht. Schattauer, Stuttgart
Elias N (1982) Über die Einsamkeit der Sterbenden. Suhrkamp, Frankfurt am Main (Bibliothek Suhrkamp)
Eser A et al. (1992) Lexikon Medizin – Ethik – Recht. Herder, Freiburg i. Br.
Fischer H (1995) Käthe Kollwitz. Meisterwerke der Zeichnung. Du Mont, Köln
Frankl VE (1975) Anthropologische Grundlagen der Psychotherapie. Huber, Bern
Fromm E (1984) Die Kunst des Liebens. Ullstein, Frankfurt am Main (Ullstein-Buch Nr. 35258)
Hankemeier U, Schüle-Hein K, Krizanits (Hrsg) (2001) Tumorschmerztherapie. 2., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokio
Heller A, Heimerl K, Husebø S (1999) Wenn nichts mehr zu machen ist, ist noch viel zu tun. Lambertus, Freiburg i. Br.
Husebø S (1999) Was bei Schmerzen hilft. Herder, Freiburg i. Br.
Jage J (1991) Medikamente gegen Krebsschmerzen. Edition Medizin, Weinheim
Jens W, Küng H (1995) Menschenwürdig sterben. Piper, München
Kahlke W, Reither-Theil S (1995) Ethik in der Medizin. Enke, Stuttgart

Keizer B (1995) Das ist das Letzte. Erfahrungen eines Artzes [in den Niederlanden] mit Sterben und Tod. Argon, Berlin
Knupp B, Stille W (1996) Sterben und Tod in der Medizin. Wiss Verlagsges, Stuttgart
Kübler-Ross E (1969) Interviews mit Sterbenden. Kreuz, Stuttgart
Kübler-Ross E (1979) Leben bis wir Abschied nehmen. Kreuz, Stuttgart
Laager J (1995) Ars moriendi. Die Kunst gut zu leben und gut zu sterben. Texte von Cicero bis Luther. Manesse, Zürich
Lamerton R (1991) Sterbenden Freund sein. Herder, Freiburg i. Br. (Spektrum 4004)
Landauer G (1977) Der werdende Mensch. Martin Buber (Hrsg). Büchse der Pandora
Larbig W, Fallert B, de Maddalena H (2002) Tumorschmerz. Interdisziplinäre Therapiekonzepte. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Schattauer, Stuttgart
Lehmann KA (2002) Analgetische Therapie mit Opioiden. UNI-MED Verlag, Bremen Boston London
Lewis CS (1982) Über die Trauer. Benzinger, Zürich
Likar R, Sittl R (2002) Praxis der transdermalen Schmerztherapie. UNI-MED Verlag, Bremen Boston London
Loewy EH (1995) Ethische Fragen in der Medizin. Springer, Wien
Meerwein F (Hrsg) (1985) Einführung in die Psychoonkologie. Huber, Bern
Minois G (1996) Geschichte des Selbstmordes. Artemis & Winkler, Düsseldorf
Mischke M (1996) Der Umgang mit dem Tod. Vom Wandel in der abendländischen Geschichte. Reimer, Berlin
Müller M, Schnegg M (2000) Unwiderbringlich – Vom Sinn der Trauer. 3. Aufl. Herder, Freiburg i. Br.
Nauck F, Klaschik E (2002) Schmerztherapie. Konpendium für Ausbildung und Praxis. Wiss Verlagsges, Stuttgart
Noll P (1987) Diktate über Sterben und Tod. Mit der Totenrede von Max Frisch. Piper, München
Nuland SB (1994) Wie wir sterben. Ein Ende in Würde. Kindler, München
Pera H (1995) Sterbende verstehen. Herder, Freiburg i. Br.
Oehmichen M (Hrsg) (1996) Lebensverkürzung, Tötung und Serientötung – eine interdisziplinäre Analyse der »Euthanasie«. Schmidt Römhild, Lübeck
Saunders C, Baines M (1991) Leben mit dem Sterben. Betreuung und medizinische Behandlung todkranker Menschen. Huber, Bern
Singer P (1993) Praktische Ethik. Reclam, Stuttgart
Schmähl D, Erhart H (Hrsg) (1987) Ethik in der Behandlung Krebskranker. Zuckschwerdt, München
Schmidbauer W (1992) Hilflose Helfer. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg (Rowohlt-Taschenbuch 1290-9196)
Schmidbauer W (1994) Helfen als Beruf. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg (Rowohlt-Taschenbuch 1290-9157)
Sporken P (Hrsg) (1982) Was Sterbende brauchen. Herder, Freiburg i. Br.
Tausch-Flammer D, Bickel L (1995) Wenn ein Mensch gestorben ist – wie gehen wir mit dem Toten um? Herder, Freiburg i. Br.
Tolstoj LN (1975) Der Tod des Iwan Iljitsch. Insel, Frankfurt am Main (Insel-Taschenbuch 18)
Verres R (1994) Die Kunst zu leben – Krebsrisiko und Psyche. Piper, München

Walter R (1995) Leben ist mehr. Das Lebenswissen der Religionen und die Frage nach dem Sinn des Lebens. Herder, Freiburg i. Br. (Spektrum 4470)
Weber M et al. (Hrsg) (1995) Sterben in Würde. Bischöfliches Ordinariat, Mainz
Zenz M, Donner B (Hrsg) (2002) Schmerz bei Tumorerkrankungen. Interdisziplinäre Diagnostik und Therapie. Wiss Verlagsges, Stuttgart
Zenz M, Jurna I (Hrsg) (2001)Lehrbuch der Schmerztherapie. Grundlagen, Theorie und Praxis für Aus- und Weiterbildung. 2., neu bearbeitete Auflage. Wiss Verlagsges, Stuttgart
Zernikow B (Hrsg) (2003) Schmerztherapie bei Kindern. 2. Auflage. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokio

Stichwortverzeichnis

A

Abhängigkeit
– physische 231
– psychische 231, 240
ACT-Charta 420
ACT (Association for Children with Life-Threatening or Terminal Conditions and their Families) 420
Adjuvanzien 259
African Palliative Care Association (APCA) 483
Aktive Sterbehilfe (Euthanasie) s. Sterbehilfe, aktive
Ambulante Dienste 23, 24
– Ambulante Hospizgruppen 24
– Ambulanter Hospiz- und Palliativberatungsdienst (AHPD) 24
– Ambulanter Hospiz- und Palliativpflegedienst (AHPP) 24
– Ambulanter Palliativdienst (APD) 24
– Hausarzt 23
Amidotrizoesäure (Gastrografin) 286
Amitriptylin 267, 466
Analgetika 219, 399
– Kosten 491
– nichtsaure, antipyretische 221, 223
– saure, antiphlogistisch-antipyretische 220, 224
Angehörige 134, 136
Angst 346
– medikamentöse Therapie 347
Antiarrhythmika 269
Anticholinergika
– Domperidon 260
– Metoclopramid 260
– Scopolamin 260
Antidepressiva 265, 466
– Amitriptylin 267
– Doxepin 267
Antiemese, Stufenschema 284
Antiemetika 259
– Cannabis 261
– Cyclizin 260, 283
– Dexamethason 261
– Dimenhydrinat 260
– Domperidon 283
– Haloperidol 260, 283
– Hyoscin 283
– Levomepromazin 260, 283
– Lorazepam 261
– Metoclopramid 283
– Ondansetron 261, 283
– Promethazin 283
– Wirkung 282
Antikonvulsiva 265
– Carbamazepin 267

– Clonazepam 267
– Gabapentin 267
– Phenytoin 267
Antizipation 209
Anzahl der Waisenkinder in Afrika 488
Appleton Consensus 73, 74
Arzneimittelgabe 252
– Applikation 209
– intranasale 212
– intravenöse 213
– intraventrikuläre 216
– orale 209
– peridurale 214, 215
– per inhalationem 212
– rektale 212
– subkutane 213
– sublinguale 211
– transdermale 212, 240, 244, 248
Ärztliche Beihilfe zum Suizid (ärztlich assistierter Suizid) 68, 105, 110
Atemdepression 227, 231, 255, 256
Atemnot 276
Aufklärung 22, 145
– Angehörige 314, 316
– Umfrage 151
Autonomie 43, 49, 58, 68, 292, 319
Azetylsalizylsäure 220, 222, 224

B

Behandlungsabbruch 63
– technischer 79, 80
Behandlungsqualität 515
Benzodiazepine 267
Betreuungsverfügung 127, 128
Bisacodyl 262, 460
Bisphosphonate 270, 464
Bittersalz 261
Brechzentrum 280
Bromazepam 268
Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz (BAG) 24
Buprenorphin 244, 450
Butylscopolamin 295, 465

C

Cancer Control Program der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 483
Carbachol 461
Carbamazepin 267, 463
Ceilingeffekt 244, 246
Celecoxib 221
Cetobemidon 230
Chemorezeptoren-Triggerzone 280, 282
Chemotherapie 3, 208, 317
Chordotomie 219
Clemastin 460
Clodronsäure 271
Clonazepam 267, 268

D

Dachverband Hospiz Österreich 15
Death Rattle (Lungenrasseln, Todesrasseln) 279, 295
Delirantes Syndrom 350

Depression
– Diagnostik 349
– Therapie 349
Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) 2, 7, 25
Dextropropoxyphen 237
Diarrhö 471
Diazepam 268
Diclofenac 220, 224, 225, 445
Dihydrokodein 236, 451
Dikaliumchlorazepat 268
Dimenhydrinat 460
Docusat-Natrium 262
Domperidon 280, 460
Doxepin 267
DRG-System 31, 32
Dyspnoe 276
– Finalphase 278, 295
– irreversibel 278
– Rehabilitationsphase 278
– reversibel 278
– Sauerstoff 279
– Therapie 278
– Ursachen 277

E

Ehrenamtliche 25
Einläufe 287
Einverständnis 137
Einwilligungsfähigkeit 64
Empathie 163, 520, 521, 522, 525
End-of-life-decision 424
Enquete-Kommission »Ethik und Recht der modernen Medizin« 9, 39, 60
Entwicklungsländer 483
Erbrechen 233, 279
Ethik 22, 45
– Autonomie 43
– der Palliativmedizin 44
– in der pädiatrischen Palliativmedizin 422
– Paternalismus 43
Ethische Entscheidungen am Lebensende 405
European Association for Palliative Care (EAPC) 5, 34, 68, 483
Euthanasie (siehe Sterbehilfe, aktive)

F

Familienhospizkarenz 16
Familiensysteme
– geschlossene 311, 312
– offene 311, 312, 343
Fentanyl 248, 448
Flunitrazepam 268, 296
Flupirtin 221, 222, 225
Flurazepam 268
Flüssigkeitssubstitution 77, 290
– Finalphase 290
Friedvoll 113, 115
Futility 320

G

Gabapentin 267, 463
Gesundheitsbevollmächtigter 64

Glaubersalz 261
Glukokortikoide 263, 464
Grundsätze der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung – 2004 123

H

Halluzinationen 233
Haloperidol 260, 269
Hausarzt 23, 24
– Fort- und Weiterbildung 24
Hausbetreuungsdienste 24, 25
– ambulanter Palliativdienst (APD) 24
– ambulante Hospizdienste (AHD) 24
– ambulanter Hospiz- und Palliativberatungsdienst (AHPD) 24
– ambulanter Hospiz- und Palliativpflegedienst (AHPP) 24
Helsinki-Konvention 321
Heroin 249
Hilfeleistung, unterlassene 73
Hilflose Helfer 511, 525
HIV/Aids 488
Hoffnung 319, 532
Hospital-Support-Teams 33
Hospiz 6, 11, 15, 16, 20, 27, 29, 121
– Aufnahmekriterien für amerikanische Hospize 28
– Aufnahmekriterien für britische Hospize 28
– Aufnahmekriterien in Deutschland 28
– High-Care-Hospiz 12
– Kinder 418, 438
– Low-Care-Hospiz 12
Hospizbewegung 2, 30, 362
Hospizidee 2, 23
Humor 158
Hydromorphon 246, 254, 448
Hyperkalzämie, Therapie 293

I

Ibandronsäure 270
Ibuprofen 220, 445
Indischer Flohsamen 261
Indometacin 220, 445
informed consent 129, 131, 133
Informiertes Einverständnis (informed consent) 49, 56, 57, 129, 131, 133, 137
International Association for Hospice and Palliative Care (IAHPC) 21, 483
International Narcotics Control Bord (INCB) 250
International Oberservatory on End of Life Care 5

K

Kant, Immanuel 46, 51
Kathetertechnik 214
Ketamin 463
Kinder 418
– Angst 473
– Appetitlosigkeit 468

– Atemdepression 461
– Dehydratation 468
– Dyspnoe 471
– Erbrechen 458, 469
– Halluzinationen 461
– Harnverhalt 459
– Hospiz 438
– Juckreiz 459
– medikamentöse Schmerztherapie 442
– Obstipation 458, 470
– Palliativzentrum 438
– Schmerzanamnese 441
– Schmerzmessung 442, 443
– Schmerztherapie 441
– Symptome in der Lebensendphase 439
– Symptomkontrolle 458
– terminale Sedierung 467
– Übelkeit 458, 469
– Ulkusprophylaxe 461, 470
Kindersterblichkeit in Afrika 490
Klysmen 287
Kodein 236, 448
Kollegialität 528
Kommunikation 22, 48, 57, 58, 78, 143, 408
– Angehörige 170
– Ausbildung 144, 159
– Belastung 154
– Rahmen 168
– Fragen 172
– in der pädiatrischen Palliativmedizin 427
– Kinder 196
– Kommunikationsprozess 165
– mit Sterbenden 2
– Offenheit 150, 174, 195
– Probleme 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185
– Problemgebiete 144
– verbale/nonverbale 167
– Wiederholung 175, 197
– Zeit 169
– Zuhören 171
Konsiliarteam 32
Krebsinzidenz 1
Kübler-Ross, Elisabeth 2, 156, 157
– Phasenmodell 156

L

Lactulose 262, 286, 460
Lateinamerika 501
Latin American Palliative Care Association (ALCP/Asociación Latino-americana de Cuidados Paliativos) 483
Laxanzien 234, 263, 285
– antiresorptiv und hydragog wirkende 262, 286
– Gleitmittel 262, 287
– mit Wirkung auf den Defäkationsreflex 262, 287
– osmotisch wirksame 261, 286
– Quellstoffe 261, 285
– Stufenschema 235
Lebensalter, durchschnittliches 380
Lebensqualität 4, 514, 515, 518, 519
Leiden 98, 99
Levomepromazin 269, 296
Levomethadon 450

Lorazepam 268, 279, 465
Lormetazepam 268
Lungenrasseln (Death Rattle, Todesrasseln) 279

M

Macrogol 262
Mannit/Mannitol 261
Medikamentenbedarf in den letzten 24 Stunden 403
Menschlichkeit 520
Metamizol 221, 222, 223, 445
Methadon 245
Methylphenidat 461
Metoclopramid 280
Midazolam 254, 268, 465
Mill, John Stewart 46, 51
Misoprostol 461
Moral 45
Morphin 213, 238, 239, 241, 278, 448
– Alternativen 244
– Alter und Morphinbedarf 239
– Äquivalenzdosen 239
– Dosierungsrichtlinien 243
– Kinder 243, 448
– Umrechnung 213
– Verschreibungsbedarf 252
Morphin-3-Glukuronid (M-3-G) 238
Morphin-6-Glukuronid (M-6-G) 238
Morphin-Retardtablette 254
Morphinbedarf 252
Morphinlösung 254, 255
– Rezeptur 242
Morphinsulfat-Retardtabletten 255
Morphinsulfat-Tabletten 254, 255
Morphinverbrauch 250, 251, 252
Motala-Modell 17, 323
Motilium 260
Mukositis 471

N

Nähe 354
– physische 355
– psychische 357
Naloxon 237
Naproxen 220, 445
Natriumpicosulfat 262, 268, 460
Nefopam 221, 225
Neurocil 260
Neuroleptika 269
Neurolytische Blockaden 218
Nichtopioidanalgetika 219
Niereninsuffizienz 244, 246, 256
Nitrazepam 268
NSAID 224

O

Obstipation 233, 263, 284
– bei Tumorpatienten 285
– Prophylaxe 234
– Therapie 285
– Ursachen 284
Obstruktion
– gastrointestinale 288

– Ileus 288
– Therapie 290
Octreotid 289
Ondansetron 460
Operative Therapie 3
Opioide/Opioidanalgetika
– Abhängigkeit 207
– – physische 231
– – psychische 231
– Anpassung 254
– Atemdepression 227, 231
– Buprenorphin 229
– Dextropropoxyphen 230
– Dihydrokodein 229
– Fahrtüchtigkeit 258
– Fentanyl 229, 230
– Hydrocodon 229
– Hydromorphon 229
– Kodein 228
– Levomethadon 230
– Morphin 228
– Nebenwirkungen 216, 227, 235, 259
– Oxycodon 229
– Pentazocin 229
– Pethidin 230
– Piritramid 230
– Therapiebeginn 254
– Tilidin 230
– Toleranz 232, 257
– Toleranzentwicklung 207
– Tramadol 230
– Verordnung 206, 253
– Wirkung 226
Opioidverfügbarkeit und Verschreibung 250
Opioidwechsel 245
Österreichische Palliativgesellschaft 15
Oxazepam 268
Oxycodon 246, 451

P

Palliativmedizin 1, 23, 62
– aktive Lebenshilfe 120, 411
– Aufgabe und Ziel 4
– Ausbildung 33
– – Approbationsordnung 7, 35
– – Lehrstuhl 7, 36
– – Weiterbildungsordnung 8
– – Zusatzweiterbildung 8
– Curricula 34
– Definition 2
– Deutschland 5
– Entwicklung 4, 38, 122
– Entwicklungsländer 483
– – Aus-, Fort- und Weiterbildung 492, 496
– – HIV/Aids 487
– – Stand und Stellenwert 499
– Frankreich 9
– für alte Patienten 394
– Großbritannien 11
– in der Geriatrie 379
– Niederlande 12
– Norwegen 13
– Österreich 15
– pädiatrische 417, 437
– Polen 16
– Schweden 17
– Schweiz 18

– Spanien 19
– Stand und Stellenwert 499
Palliativprogramm, Entwicklungsländer 495
Palliativstation 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 30, 121, 386
Pamidronsäure 270
Pan American Health Organization (PAHO) 483
Paracetamol 221, 222, 223, 445
Paspertin 260
Paternalismus 43, 49, 52
– Definition 147
Patient
– entscheidungsfähiger 63
– nichteinwilligungsfähiger 68
– nichtentscheidungsfähiger 63
Patientenkontrollierte Analgesie (PCA) 467
Patientenverfügung 60, 61, 67, 127
Patientenvertreter 64
Patientenwille
– Ermittlung 65, 126
– mutmaßlicher 65, 68, 131, 133, 137
PEG-Sonde 214
Pethidin 448
Pflegeheim 382, 384, 412
– Multimedikation/Polymedikation 388
– Unfälle und Verletzungen 390
Pflichten der Ärzte 321
Phenytoin 267
Physician-assisted suicide 101, 105
Physiotherapeutische Maßnahmen 212
Piritra mid 448
Point of no return 72
Polyethylenglykole 286
Probleme, psychosoziale 310
– Angst 346
Prognose 186, 322
Prokinetika 287
Promethazin 465
Psyquil 260

R

Ranitidin 461
Rechte der Angehörigen 370
Rechte des Patienten 147, 320, 321, 392
Rechte des Sterbenden 365
Rechte des Kranken und des Sterbenden 369
Recht des Patienten auf Selbstbestimmung 51, 85
Rizinusöl 262

S

Salinische Laxanzien 261
Saunders, Cicely 2
Schmerzdiagnose 206
Schmerzen 98, 99
– neuropathische 205, 462
– – Brennschmerz 273
– nozizeptive 205
– Pathophysiologie 205
– Schmerzmesskarte für Kinder 443

– somatische Nozizeptorschmerzen 205
– therapiebedingte 204
– tumorassoziierte 204
– tumorbedingte 204
– tumorunabhängige 204
– Ursachen 203, 207
– viszerale Nozizeptorschmerzen 205
Schmerzmessung 208
– bei Demenz 395
– Intensität 207, 208
– Kinder 443
– Ursache 207
Schmerztherapie 121, 276
– bei Sterbenden 293
– destruktive Methoden 217
– invasive Verfahren 213
– kausale 208
– Nervenblockaden 216
– nichtinvasive Verfahren 209
– symptomatische 209
Schweizerische Gesellschaft für Palliative Medizin, Pflege und Begleitung (SGPMPB) 18
Scopoderm TTS 260
Sedierung 232
Seelsorge 360
Selbstbestimmung 71
Selbstbestimmungsrecht des Patienten 109, 118, 147
Sennosid B 262
Sexualität 359
Sorbit 261
Sorbit Glycerol 262
Spanische Palliativgesellschaft 20
Stationäre Einrichtungen 27
Sterbehilfe
– aktive (Euthanasie) 68, 84, 88, 89, 118
– Belgien 96
– – Neugeborene 97
– Definition 84
– indirekte 68, 104, 107
– – Urteil des BGH, 1996 109
– Niederlande 90, 92, 95, 98
– – Neugeborene 96
– passive 55, 68, 69, 104
– – Urteil des BGH 1991 82
– – Urteil des BGH 1994 83
Sterben, Akzeptanz 3
Sterbeorte 382, 384
Sterblichkeit 527
Still-satt-und-sauber-Versorgung 382
Strahlentherapie 3, 208, 276
Stufenschema der Antiemese 284
Stufenschema der Laxanzientherapie 263
Stufenschema der Laxanzientherapie bei Opioidgabe 235
Sub-Sahara-Afrika 499
Südafrika 501
Südostasien 502
Suizid
– ärztliche Beihilfe zum 68, 101, 105, 110
– Beihilfe zum 19
– schwerkranke Patienten 352
Sympathie 522
Symptomkontrolle 3, 121, 276
– bei Sterbenden 293
– Kinder 458

T

Tageshospiz 26, 27
Team, interdisziplinäres 31
Temazepam 268
Terminale Agitation 296
Tetrazepam 268
Therapie
– Einfrieren 75, 76
– Einstellung 72, 74, 75
– – lebensverlängernde 128
– – Nichteinleiten 128
– – Urteil des BGH 2003 83
– lebenserhaltende 67
– – Beschluss des BGH 2005 83
– lebensverlängernde Maßnahmen 426
– Sterbeverlängerung 74
Therapieabbruch 66, 70
– Demenz 66
– künstliche Ernährung 66
– Wachkomapatienten 66
Therapieplan, exemplarischer 271
Tilidin 237, 449
Tod 62, 344, 371, 539
Todeskonzepte von Kindern 431
Todesrasseln (Death Rattle, Lungenrasseln) 279, 295
Todesursachen in Europa und Afrika 487
Todesursachen weltweit 2000 487
Toleranzentwicklung 207, 232
Tötung auf Verlangen 87
Tramadol 236, 449
Transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS) 212, 217
Trauer 325
– Charakteristika nach Freud 326
– Kinder 334, 338
– pathologische 331
– Rituale 345
– Schule 344
– starke 331
– Vierstufenschema 326
– vier Hauptaufgaben nach Worden 329
– vorbereitende 329
Trauerarbeit 333
Triazolam 268
Tumorschmerzen (s. a. Schmerzen) 203
– Ursachen 203
Tumorschmerztherapie 206

U

Übelkeit 233, 279
Übelkeit und Erbrechen
– Therapie 281
– Ursachen 281
Unerträglich 113, 115, 155
Unterstützung, psychosoziale 310
Unwürdig 113, 115

V

Verlängerung des Sterbens 59, 70, 74
Verwirrtheit 233, 350
Vestibularapparat 282

Vomex-A 260
Vormundschaftsgericht 67
Vorsorgevollmacht 127
– Bevollmächtigte 64

W

Wahrheit am Krankenbett 190, 539
Wertvorstellung 53
WHO-Stufenplan/-schema 210, 211, 444
Würde 89, 98, 99, 100, 101, 104, 118, 119, 153

Z

Zopiclon 268
Zuckeralkohole 261
Zürcher Modell 424
Zuteilung der Ressourcen für die Krebsbehandlung 498